

Онкология и радиология Казахстана

№3-4 (16-17) 2010

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
Ж.А. Арзыкулов,
профессор

Редакционная коллегия
Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Баишева С.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б.,
Имангалиева Н.Т. (патентовед), Кайрбаев М.Р. (административный редактор),
Ким В.Б., Монахов Б.В., Нургалиев Н.С., Савхатов Д.Х. (зам.главного редактора),
Сейтказина Г.Д., Филиппенко В.И., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь
Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов
Аязбаев Н.Б., Галушкин М.А., Утельбаева А.Е.

Адрес редакции
г. Алматы, 480091, пр. Абая, 91
НИИ онкологии и радиологии МЗ РК
Тел. (327) 292 10 63
«Онкология и радиология Казахстана», №3,4 (16-17), 2010 г.
Собственник - РГКП «НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»
Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.
Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39
Тираж 500 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Тезисы
международной юбилейной конференции
«Достижения и перспективы развития
современной онкологии и радиологии»,
посвященной 50-летию
Казахского научно-исследовательского
института радиологии и онкологии
(КазНИИОиР)

Разделы сборника:

- Эпидемиология - стр. 2
- Вопросы диагностики - стр. 17
- Хирургическое лечение - стр. 59
- Химиотерапия - стр. 92
- Лучевая терапия - 112
- Цитология - 127
- Онкогематология- стр. 143
- Разное - стр. 150

Содержание - стр. 174

Индекс авторов (кириллица) - стр. 179

Индекс авторов (латиницв) - стр. 183

Эпидемиология

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА ПО

Г. АЛМАТЫ

Калиева Ж.Ж., Игисинов С.И.,

Бегимбаева Р.С., Джарылкасымова Ж.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Актуальность. Рак пищевода (РП) занимает 6 место в структуре смертности от злокачественных опухолей в мире. География и в некоторой степени принадлежность больного к той или иной этнической группе влияет на показатели заболеваемости РП. А в общем числе опухолей, встречающихся у человека, удельный вес РП колеблется от 10 до 20% и по частоте распространенности в некоторых регионах мира занимает 2-3 место. При этом установлено, что заболеваемость данной формой рака в Казахстане сравнительно высокая (12,8‰) в г.Алматы, по отношению к другим городам (М; ГЭОТАР-МЕД, 2007.).

Цель работы. Анализировать особенности распространения РП в г. Алматы

Материалы и методы. В процессе исследований обработаны данные всех зарегистрированных больных РП в г. Алматы с 1989 по 2000 гг. Приведены учетно-отчетные материалы онкологических учреждений г. Алматы, с впервые в жизни установленным и аргументированным диагнозом РП. Использованы статистические данные Департамента по делам статистики и демографии при Совете министров Республики Казахстана о численности, половозрастном и национальном составе населения по районам г. Алматы. При стандартизации показателей заболеваемости использован прямой метод и применен мировой состав населения.

Результаты и выводы. Всего за 1989-2000 гг. было зарегистрировано 1009 больных РП, что составляет 13,8% в структуре злокачественных опухолей ЖКТ, и по рангу занимает второе место. Из них мужчин – 536 (53,1%) и женщин – 473 (46,9%) больных РП. Заболеваемость РП всего населения – 7,4±0,8‰, а стандартизованные (мировой) – 6,6±0,8‰.

Распределение больных РП по возрастным группам имеет унимодальный характер роста с пиком в возрастной группе 70 лет и старше (48,1%). Средний возраст больных РП – 66,8±5,2 года, а в динамике увеличивается в сторону увеличения возраста.

Высокие показатели заболеваемости РП у городского населения установлена среди лиц 60-69 лет – 33,3±6,4‰, а также у лиц 50-59 лет – 13,1±3,6‰. Средний возраст больных из всего населения города был равен 66,8±5,2 год, в том числе мужчин – 65,0±6,4 и женщин – 68,9±7,1 года, и в динамике имели тенденции в сторону старения среднего возраста.

Интенсивные возрастные показатели заболеваемости РП по полу оказались неодинаковыми. Высокая максимальная заболеваемость РП у мужчин зарегистрирована среди лиц 70 лет и старше (99,8±19,2‰), которая в 1,8 раза выше, чем у женщин (55,5±11,4‰), аналогичные закономерности сохраняются в отношении других возрастных групп населения.

Заболеваемость РП у казахов – 9,8±1,7‰ (стандартизованные показатели – 8,7±1,5‰), у мужчин – 8,4±0,7‰, а у женщин – 11,1±1,0‰. Частота РП у казашек в 1,3 раза выше, чем у мужчин. Заболеваемость РП русского населения – 8,5±1,4‰ (стандартизованные – 14,6±1,7‰), у мужчин – 10,6±2,3‰, а у женщин – 6,4±1,8‰.

Таким образом, заболеваемость РП всего населения г.

Алматы остается высокой, но имеет тенденции к снижению. Уровень заболеваемости мужского населения в 1,3 раза выше, чем у женского. Выявлена высокая заболеваемость РП среди женщин-казашек. У русского населения заболеваемость имеет тенденции к росту, при этом частота у мужчин в 1,7 раза выше, чем женского населения.

Эти выявленные эпидемиологические особенности распространения РП среди жителей г.Алматы обусловлены демографическими, возрастными-половыми и этническими факторами населения. Полученные результаты позволяют проведение целенаправленной организации противораковой борьбы в г. Алматы.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В Г.АЛМАТЫ

ЗА 2005-2009 ГГ.

Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В.,

Иманкулов А.Ж., Югай Т.А.

ГККП «Городской онкологический диспансер» г. Алматы

Онкологические заболевания остаются одной из самых актуальных проблем современной медицины Казахстана. В структуре смертности в г.Алматы онкологические заболевания на протяжении 5 последних лет занимают 3 место.

За период с 2005 по 2009 год отмечено незначительное снижение онкологической заболеваемости с 239,0 до 234,6 на 100 тысяч населения, однако данный показатель превышает среднереспубликанский по Казахстану на 29%. За счет улучшения ранней диагностики, снижения смертности и увеличения пятилетней выживаемости, вырос показатель болезненности с 1198,5 (15088 онкологических больных – 2005г.) до 1369,7, на 100 тыс. нас. (18806 – 2009г.).

За аналогичный период времени, смертность от онкологических заболеваний с тенденцией к снижению, с 124,1 до 120,1 на 100 тысяч населения, однако показатель одно-годовой летальности вырос с 25,4% в 2005 году до 26,7% в 2009 году.

Также отмечено улучшение показатели ранней диагностики с 46,2% в 2005 году до 55,1% в 2009 году и снижение доли запущенных форм злокачественных заболеваний в IV стадии с 9,8% до 7,9%.

За отчетный период показатель пятилетней выживаемости увеличился с 43,3% до 50,8%, он наиболее отчетливо характеризует работу онкологической службы г.Алматы и указывает на качество организации онкологической службы, т.е. качество лечения, охват лечением и диспансеризацией, а показатель ранней диагностики злокачественных новообразований в большей степени отражают деятельность врачей поликлиник и семейных амбулаторий.

Таким образом, только слаженная работа всех подразделений здравоохранения, позволяет улучшить все показатели онкологической службы и значительно улучшить качество жизни онкологических больных.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЛЕГКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

Бекмухамбетов Е.Ж., Сабыр К.К., Кузденбаев М.С.,

Муканов М.К., Туржанов К.Т.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, МЦ ЗКГМУ им. М. Оспанова г.Актобе.

Актуальность. За последние десятилетия заболеваемость

раком легкого возросла во многих странах мира и в настоящее время для развитых государств является самой распространенной онкологической патологией у мужчин и остается одной из важнейших как медицинских, так и социально-экономических проблем. По статистическим данным ежегодно в мире регистрируется около 13 млн. новых случаев рака легкого, из них 60% приходится на развитые государства. Заболеваемость населения Республика Казахстан раком легкого также остается на высоком уровне.

Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости и смертности от рака легкого населения Актыбинской области Республики Казахстан.

Материал и методы исследования. В анализе представлены данные заболеваемости и смертности от рака легкого населения Актыбинской области за 2005-2009 гг. При анализе полученных данных установлено, что рак легкого, не смотря на снижение заболеваемости в 2009 году 19,6 на 100 000 (РК 22,4) остается лидером среди злокачественных новообразований и занимает первое место. Не смотря на снижение уровня заболеваемости населения области, которая в 2009 году составила 19,6 на 100 000, тогда как в 2005 данный показатель равнялся 25,4, показатели смертности неуклонно растут, достигнув в 2009 году цифры 17,7 (2005 – 16,2). На высоких цифрах остаются показатели поздней диагностики, которые в в 2009 году составили 23,9%, тогда как в 2005 данный показатель равнялся 23,0%. Факторы риска для данной категории больных являются как эндогенные так и экзогенные, которые присутствуют в Актыбинской области. Частота заболеваемости у мужчин выше, чем у женщин.

Выводы. Таким образом, при анализе заболеваемости и смертности населения Актыбинской области необходимо отметить, что имеется снижение заболеваемости раком легкого, но в то же время остаются высокими и даже нарастают показатели поздней диагностики и смертности от данной патологии. В популяции вновь заболевших уровень выше у мужчин, чем у женщин.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ АКТЫБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Бекмухамбетов Е.Ж., Койшыбаев А.К., Симбатов Т.К.,
Уразбаева Н.И., Уразбаев О.Н.,*

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.

Актуальность. Анализ заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований играет огромное значение для определения потребностей населения страны в онкологической помощи и разработки перспективных планов технического и лекарственного обеспечения, подготовки кадров и планирования всего комплекса противораковых мероприятий. В связи с чем профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных новообразований является одним из важных и сложных разделов современной медицины, которая определяется их сложностью, масштабностью и социальной значимостью.

Цель. Анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Актыбинской области.

Материал и методы исследования. При анализе результатов исследования установлено, что в течении последних 5 лет отмечались своеобразные колебания в структуре заболеваемости. Если в 2007 году отмечалось снижение показателей заболеваемости, то в 2008 году отмечалось его повышение, а в 2009 году вновь снижение. В структуре онкопатологии лидирующую позицию занимает рак легкого, составляя 19,6 на 100 000 населения (РК 20,5), на втором месте рак молочной железы 18,7 (РК 20,5) и на 3 месте остается рак желудка,

заболеваемость которого равна 17,1 (РК 17,4). Наивысшие показатели заболеваемости отмечались в регионах области, где существуют экологические факторы риска. В структуре смертности 50% занимают рак легкого, желудка, пищевода и гемобластозы.

Выводы: 1. За последние 5 лет в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями по Актыбинской области отмечается снижение уровня заболеваемости на 8,9 % в 2009 году в сравнении с 2005 годом, показатель смертности снизился на 4,5 %.

2. При изучении факторов риска в регионах области с высоким уровнем заболеваемости присутствуют, как экзогенные, так и эндогенные, что говорит о необходимости проведения как первичных, так и вторичных профилактических мероприятий.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жұмағалиев Д.Ж.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, сүт безі рагі (СБР) әйелдердегі қатерлі ісік аурулары арасында алғашқы орындарды алады. Солтүстік Америка және Европа елдерінде әйелдер өлімінің 5/1-і СБР, ал Қазақстан Республикасында әйелдердегі кездесетін қатерлі ісік ауруларының құрылымында бірінші орынды СБР (19,5%) құрайды. Республика көлемінде жылына 3 мыңнан астам әйел алғаш рет сүт безі рагімен анықталса, оның 30 пайыздан астамы 3-4 сатысындағы асқынған түрімен тіркелуде. Өкініштісі, сырт көріністі мүшелер қатарына жатқанына қарамастан науқастардың 5 жыл өмір сүруі төмен пайызды көрсетуде. Сондықтан, қазіргі таңда ғылыми сарапталған жаңа әдістері сүт безінің ісік алды және ісік ауруларының алдын алуда маңызды орын алуы тиіс.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша сүт безі рагінің аурушандық жағдайын зерделеу

Зерттеу материалы: ОҚО 2005-2009 жылдар аралығында алғашқы рет сүт безі рагімен тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35,7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы санитарлық статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде сүт безі рагімен 258 әйел кісі тіркеліп, бірінші орынға шықты. Аурушандық деңгейі кейінгі жылдарда өсіп келеді, атап айтқанда 2005–2009 жылдар 100 000 халыққа шаққанда да 10,2 ден 11,0 өскен, ең жоғарғы көрсеткіш облыс көлемінде Арыс ауданында 14,4, Шымкент қаласында 13,8, Мақтарал ауданында 12,5, Сарыағаш ауданында 12,0 болған, ал төмен көрсеткіштер Ордабасы ауданында 5,3, Байдыбек ауданында 5,5, Қазығұрт ауданында 5,9 болған. Бұл айырмашылық кенттенуі жоғары елді мекендерде байқалуда.

Сүт безі рагімен анықталған әйелдерді жасына қарап бөлсе, онда 2005 жылы 15-50 жас аралығында 119 науқас 49,5 пайыз, ал 2009 жылы 99 науқас 38,3 пайыз, бұл да осы жастағылар аралығында 11,2 пайызға азайған. Ал 2005 жылы 50 жастан жоғары 121 науқас 50,4 пайыз, 2009 жылы 159 науқас 61,6 пайыз, демек 11,2 пайызға өскен.

Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2005 жылы 70,0 пайыздан 2009 жылы 79,8 пайызға өскен. Бұл елімізде жүріп жатқан скринингті профилактикалық тексерудің оң нәтижесі, атап айтқанда профилактикалық тексеру кезеңінде 2005 жылы 4,9 пайыз сүт безі рагі анықталса, ал 2009 жылы 10,3 пайыз болған. Ал асқынған түрі 2005 жылы

22,1 пайыздан, 2009 жылы 19,3 пайызға төмендеген.

Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2005 жылы 23,0 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2009 жылы 28,9 өскен. Бір жылдық өлім жатыр мойны рагінен 2005 жылы 5,4 пайыздан 2009 жылы 12,7 пайызға өскен, әліде жоғары деңгейде. Сондықтан сүт безі рагінен жалпы өлімде азаймай отыр, бұл көрсеткіш 2005 жылы 100 000 халыққа шаққанда 3,3 болса, ал 2009 жылы 5,4 болған.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 385 науқас 36,8 пайыз болса, ал 2009 жылы 635 науқас 40,0 пайызға өскен, бірақ бұл төмен көрсеткіш.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, ОҚО бойынша 50 жастан жоғары әйелдер арасында кеңінен таралуы заңдылық болғанымен, сапалы көрсеткіштердің жақсарғанына қарамастан, бірінші орынға шығуы, әліде болса өлім саны көптігі, науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі төмендігі ойландырады. Бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде сүт безі рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға, 5 жыл және одан артық өмір сүруін арттыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан ҚР ДСМ № 607 15.10.07 ж. және № 685 10.11.09 ж. бұйрықтарының іске асырылуы, бұл өмір талабы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ В ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Джумағалиев Д.Д., Оспанова Г.А., Джаханова Л.А.,
Тажимаева К.Н., Асанова К.К.*

Южно-казахстанской областной онкодиспансер

Актуальность проблемы: В мире ежегодно регистрируется около 190 000 новых случаев рака почки и около 90 000 смертей от данного заболевания. При этом заболеваемость колеблется примерно от 2,0 до 12,0 на 100 000 населения, что составляет 1-3% всех злокачественных новообразований. Более высокие показатели характерны для развитых стран Америки и Европы, низкие – для Азии, включая Японию. Заболеваемость раком почки в России в 2006 году составила 11,25 на 100 000 населения. В 2008 году в Республике Казахстан на учет взято 820 больных раком почки с впервые установленным диагнозом, что составляет 5,2 на 100 000 населения.

Злокачественное новообразование почки является заболеванием, которое долгое время может протекать бессимптомно, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью и негативно сказывается на результатах лечения.

Цель исследования: изучение состояния заболеваемости раком почки (РП) в Южно-Казахстанской области (ЮКО).

Материалы исследования. В исследование включены больные с раком почки, состоящие на диспансерном учете в областном онкологическом диспансере ЮКО с 2005 по 2009 гг.

Результаты: В ЮКО в 2005 году на учет взято 2345 больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, из них 53 больных РП (2,2%). Уровень заболеваемости раком почки повысился с 2,2% в 2005 году до 2,7% в 2009 году. Выявленных больных с раком почки в работоспособном возрасте до 60 лет в 2005 году 18 больных 33,9%, а в 2009 году 41 больных 64,06%.

Показатели болезненности по ЮКО в динамике с 2005 г. имеют тенденцию к увеличению (от 7,0 на 100 000 населения в 2005 году, 7,9 в 2006 году и в 2009 году 10,6).

Количество выявленных случаев рака почки в ранних стадиях повысилось с 33,9% в 2005 году и 40,4% в 2006 году до 56,2% в 2009 году.

Динамика показателей выявленных больных с запущенными стадиями рака почки имеет тенденцию к снижению с 20,7% в 2005 году до 6,2 в 2009 году.

Снижается показатель одногодичной летальности по 2006-2007 годами, когда этот показатель были 36,1% - 47,3%, а в 2009 году снизился до 24,0%, но смертность не снижается (в 2006 году 1,3 на 100 000 населения, а в 2009 году 1,2).

В ЮКО повысился показатель пятилетней выживаемости от 31,3% в 2005 году до 39,2% в 2009 году.

Выводы. Несмотря на незначительные успехи, не снижается смертность и увеличивается доля больных в работоспособном возрасте. Поэтому в целях профилактики рака почки следует вести пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, своевременно лечить неопухолевые и хронические заболевания почек. Кроме этого, считаем целесообразным проводить ультразвуковое исследование почек у практически здоровых людей после 40 лет, поскольку появление симптомов свидетельствует чаще всего о запущенности опухолевого процесса. Также следует проводить динамическое наблюдение за пациентами из групп повышенного онкологического риска.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

*Жұмағалиев Д.Ж., Орманов Н.К.,
Бимағанбетова Н.Б., Кабылов А.Б.*

*Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы
диспансері*

Мәселенің маңыздылығы: Халықаралық ракты зерттеу (IARC) агентінің мәлімдемесі бойынша дүниежүзінде 1400 әйелдер күн сайын жатыр мойны рагіне шалдыққандығын білсе, ал шамамен 750 осы дерттен қайтыс болады. Бұл әр 2 минутта 1 әйел қайтыс болатындығын көрсетеді. Жыл сайын дүниежүзінде 500 000 жаңадан жатыр мойны рагі анықталса, ал 270 000 астамы қайтыс болады. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі бойынша 2050 жылы болжамен 1000 000 жатыр мойны рагімен тіркеледі, онда шамамен 600 000 әйел қайтыс болады. Өйткені, іргесін жаңа қалап келе-жатқан мемлекеттерде, осы аурудан өлім 80 пайыздан кем болмай отыр.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша жатыр мойны рагінің аурушандық жағдайын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО қатерлі ісікке қарсы диспансерінің 2005-2009 ж. аралығындағы жатыр мойны рагімен диспансерлік есептегі науқастар зерттелген.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде жатыр мойны рагімен 135 әйел кісі тіркелген. Аурушандық деңгейі кейінгі жылдарда өсіп келеді, атап айтқанда 2005–2009 жылдар аралығында 4,6 пайыздан 5,7 пайызға, ал 100 000 халыққа шаққанда да 5,0 ден 5,7 өскен. Жатыр мойны рагімен анықталған әйелдерді жасына қарап бөлсе, онда 2005 жылы 15-50 жас аралығында 50 науқас 45,8 пайыз, ал 2009 жылы 96 науқас 71,1 пайыз, бұл да осы жастағылар аралығында да 25,3 пайызға өскендігін көрсетеді.

Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2006 жылы 76,8 пайыздан 2009 жылы 87,4 пайызға өскен. Бұл елімізде жүріп жатқан скринингті профилактикалық тексерудің оң нәтижесі, атап айтқанда профилактикалық тексеру кезеңінде 2006 жылы 4,6 пайыз жатыр мойны рагі анықталса, ал 2009 жылы 10,3 пайыз болған. Ал асқынған түрі 2006 жылы 23,1 пайыздан, 2009 жылы 12,4 пайызға төмендеген.

Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2005 жылы 23,0 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2009 жылы 28,9 өскен. Бір жылдық өлім жатыр мойны рагінен 2006 жылы 32,6 пайыздан 2009 жылы 21,2 пайызға азайғанына қарамастан, әліде жоғары

деңгейде. Сондықтан жатыр мойны рагінен жалпы өлімде азаймай отыр, бұл көрсеткіш 2009 жылы 100 000 халыққа шаққанда 3,6 болса, ал 2005 жылы 2,8 болған.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 209 науқас 41,7 пайыз болса, ал 2009 жылы 356 науқас 52,1 пайызға өскен.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, осы жатыр мойны рагі ОҚО бойынша туу жасындағы әйелдер арасында кеңінен таралуда, демек аурушандығы да өсіп келеді. Сапалы көрсеткіштердің жақсарғанына қарамастан, әліде болса өлім саны көптеу, бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде жатыр мойны рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан ҚР ДСМ № 607 15.10.07 ж және де №685 10.11.09 ж бұйрықтарының іске асырылуы, бұл өмір талабы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Темирғалиев Г.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак щитовидной железы - наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль эндокринных органов. Диагностика и лечение пациентов по поводу рака щитовидной железы является весьма вариabельным, а определение тактики лечения и дальнейшего ведения и наблюдения больного иногда представляет большую сложность.

Цель работы: анализ и изучение статистических показателей рака щитовидной железы в Павлодарской области.

Материалы и методы: статистический анализ учётных и отчётных форм.

Рак щитовидной железы составляет в среднем 1-1,5% от всех злокачественных новообразований, однако отмечается тенденция к увеличению частоты данного заболевания особенно в зонах мультифакторного загрязнения окружающей среды.

Болезнь часто поражает людей молодого, трудоспособного возраста. В большинстве случаев щитовидная железа поражается дифференциальными формами опухоли, при правильном лечении которых врачи могут добиваться вполне удовлетворительных результатов. Однако больше раком щитовидной железы часто обращаются к врачам различных специальностей (хирургам, эндокринологам, терапевтам, ЛОР), которые не знают особенностей и своеобразие клинического лечения данной патологии, имеющей особые биологические свойства. В связи с этим применяются различные, а подчас неадекватные данному заболеванию методы диагностики и лечения. Нами проанализированы амбулаторные карты больных раком щитовидной железы взятых на диспансерный учет в Павлодарском онкодиспансере за период с 2002-2005гг. В структуре онкологического заболевания данная патология в Павлодарской области занимает 18 место (1,5%). В динамике отмечается прирост заболевания на 56% с 23 случаев в 2002 до 36 случаев в 2005г. соотношение женщин и мужчин составило 8:1. Подъем заболеваемости наступает на 4 десятилетия. В области пик заболеваемости приходится на возраст 50-59 лет. Частота РЩЖ от общего числа хирургической патологии этого органа составило в Павлодарской области 6,8%, в Восточно-казахстанской области 8,7%. Чаще болеют городские жители (70%), люди трудоспособного возраста (87%), что, скорее всего связано с большей численностью населения в городах и состоянием окружающей

среды, среди которого особое место занимает ионизирующее излучение, обладающее blastomatoznым действием на щитовидную железу.

При морфологическом изучении операционного материала выявлено, что наиболее часто встречается дифференцированная форма рака: папиллярный рак- 69,2%; фолликулярный рак-26,9%; смешанная форма-3,8%. Одногодичная выживаемость после радикального хирургического лечения -98,3%. Пятилетняя выживаемость 65,5%, связана с тем, что значительное количество больных оперируется в неонкологических отделениях, что приводит к неадекватному по объему операции (т.е. энуклеация узла, резекция доли, гемитиреоидэктомия без перешейка и т.д.).

Результаты и выводы: разработка и внедрение в практику новых методов диагностики и усовершенствование существующих методов лечения рака щитовидной железы является актуальной задачей онкологии.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2000-2009 ГГ.

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы

В сравнении с частотой других заболеваний детского возраста, злокачественные новообразования (ЗН) у детей встречаются редко, однако по своей значимости в структуре детской инвалидизации и смертности эти заболевания занимают одно из первых мест.

Заболеваемость детей ЗН в различных странах приблизительно одинаковы, но бывают и исключения. Частота возникновения злокачественных опухолей относительно небольшая по сравнению с взрослыми, так в США ежегодно заболевают около 8000 детей, а в странах Европы около 21000, в России более 7000, в республике Казахстан более 300 детей до 15 лет ежегодно.

В общей структуре заболеваемости всего населения на долю заболеваемости ЗН в детском возрасте в мире колеблется от 0,5 до 4,0%.

За период 2000-2009 гг. в РК было выявлено 2956 новых случаев ЗН у детей. Заболеваемость детей с ЗН в РК на 100000 детского населения в 2000 году составила - 7,4 (303 детей), в 2005 году - 8,4 (310 детей), в 2009 году - 7,5 (283 детей). Контингент в 2000 году - 568, в 2005 году - 948, в 2009 году - 1114 детей.

5-летняя выживаемость детей от ЗН составила в 2000 году - 25,4%, в 2005 году - 25,5%, в 2009 году - 29,7%.

Одногодичная летальность детей от ЗН составили в 2000 году - 18,5%, в 2005 году - 25,0%, в 2009 году - 24,4%.

Удельный вес онкологических больных детей с IV стадией заболевания составили в 2000 году - 9,2%, в 2005 году - 8,2% и в 2009 году - 7,4%.

Смертность от ЗН на 100000 детского населения в 2000 году составила - 3,0, в 2005 году - 3,7, в 2009 году - 3,8.

В структуре онкологической заболеваемости детского населения в РК, в 2009 году солидные опухоли составили 66,7%, лейкозы - 22,5% и лимфомы - 10,9%. Первое место занимают лейкозы (до 25%), далее следует опухоли ЦНС - 20,2%, лимфомы - до 11,0%, опухоли мягких тканей - 9,7%, опухоли почек и костей - по 7,2%, ретинобластома - 5,8%, нейробластома - 3,4%, и другие редкие опухоли - 2,2%.

За период 2000-2009 гг. заболеваемость детей ЗН в Республике Казахстан характеризуется стабильностью и отмечается прирост контингентов.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПИЩЕВОДА В
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-2009 ГОДЫ)***Кравчук В.А., Сулейменов М.К.**КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: рак пищевода является одним из наиболее часто встречающихся и тяжело протекающих заболеваний. В Республике Казахстан заболеваемость рака пищевода так же неоднородна, Павлодарская область входит в число регионов с низкой заболеваемостью, но из-за этого проблема не становится менее актуальной.

Цель исследования: анализ и изучение статистических показателей рака легкого в Павлодарской области в 1990-2009 годах.

Материалы и методы исследования: статистические отчеты КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», конъюнктурный обзор деятельности.

За период с 1970 по 1990 годы заболеваемость пищевода в Павлодарской области снизилась почти в 2 раза с 19,4 до 9,7. В 90-х годах прошлого столетия заболеваемость была стабильной, хотя подвергалась некоторым колебаниям, но их можно считать не существенными. Заболеваемость в разные годы подвергалась колебаниям от 6,3 до 10,4, стандартизованный показатель в 2000 году составил 7,8, а к концу 10-летия 7,3. Достоверно изменились соотношения стадий, так I-II стадия увеличилась с 20,5 до 34,8, а IV стадия уменьшилась с 39,7 до 15,2. Смертность при этом снизилась незначительно с 7,0 до 6,0. Что объясняется высоким уровнем пациентов старших возрастов. По нашим наблюдениям доля больных в возрасте до 60 лет составила 24,2%, 60-64 года – 20,2%, 65-69 лет – 15,2%, старше 70 лет – 40,4%, стандартизованный показатель составил соответственно до 60 лет – 2,24, 60-64 года – 34,4, 65-69 лет – 47,2, а в возрасте старше 70 лет – 79,9. Практически все онкологи отмечают, что рак пищевода это болезнь старческого возраста.

Болезненность за последние 10 лет практически не изменялась и составила 13. Процент верификации за счет увеличения финансирования здравоохранения, внедрения стандартов диагностики и лечения увеличился с 75 до 86%. Увеличился несколько процент получивших специальное лечение с 34,5 до 41,8%. Снизилась годовая летальность с 66 до 63,4% (в связи с малыми цифрами проведен анализ стандартизованных показателей).

Результаты и выводы: в Павлодарской области одна из самых низких заболеваемости злокачественными опухолями пищевода. Отмечается такая же как и в других регионах высокая смертность от рака пищевода. Повышение процента населения старших возрастов, ослабление первичной медико-санитарной помощи привели к росту запущенности. Но с внедрением протоколов диагностики и лечения, улучшением финансирования здравоохранения отмечаются и некоторые положительные подвижки (увеличился процент верификации, процент получивших специальное лечение, несколько снизилась годовая летальность).

**О ГЕНЕЗЕ РАКА КОЖИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА***Каримов М.А.**КазНИИОур, Алматы*

Ультрафиолетовая часть солнечного спектра как этиологический фактор рака кожи признана подавляющим большинством сообщества онкологов мира. По нашему мнению, для возникновения рака кожи этого не всегда достаточно. Так, например, чем объяснить, что заболеваемость раком кожи в Южно-Казахстанской области (ЮКО), где изобилие солнца, была равна 10,3‰ в 2004 г, снизилась до 7,3‰ в 2008 г, тогда как в Северо-Казахстанской области (СКО), где солнца

мало, она в этот же период составляла 19,4-: 18,7‰? Солнечных дней и долгота светового дня в 2 раза меньше, а заболеваемости раком кожи в 2 раза больше. Далее в одной из областей Южного региона - Жамбылской : за эти годы заболеваемость раком кожи составляла 11,7 - 8,8‰, тогда как в Павлодарской области, расположенной почти на уровне СКО, она была равна 24,3 - 27,4‰, т.е. 2-3 раза больше. Ведь солнца в Жамбылской области гораздо больше, чем в Павлодарской. Все эти области «перешеголяла» Восточно-Казахстанская область (ВКО), где заболеваемость раком кожи была самой высокой в Республике и составляла 44,8 - 36,0‰, т.е. она (заболеваемость) была в 4-5 раз выше, чем в южных регионах. Отрицаем ли мы роль ультрафиолетовой радиации? Отнюдь. Ведь, в ВКО, как теперь уже известно, производились «урановые таблетки», а это дополнительный лучевой фактор. Доказательством служит более высокий показатель заболеваемости раком кожи в г.Усть-Каменогорск (80,0- 65,7‰), где производилось «Урановое топливо». В воде оз.Зайсан, Зайсанского и Ульбинского водохранилищ, реки Иртыш, Ульба, Уба, Граматуха, Шарафка и др., выявлено высокое содержание бенз(а)пирена (БП)- от 0,010мкг/л до 0,036 мкг/л, что соответствует 2-7 ПДК и тяжелых металлов (ТМ) - кадмия, никеля, свинца, в дозах превышающих ПДК в 2-10 раз. Население купается в этой воде. Следовательно, возможно суммационное, синергическое действие трех канцерогенов. Как нам представляется, эта мысль подтверждается фактом повышенной заболеваемости раком кожи в Павлодарской области, где она ниже, чем в ВКО, но выше, чем в Жамбылской и ЮКО. В Павлодарской области нет «урановых таблеток», но вода Иртыша больше загрязнена канцерогенами, выявлено загрязнение пляжей, где купаются люди. Отмечается загрязнение этими канцерогенами и подземных, грунтовых вод. Содержание БП порой превышало ПДК в 60-70 раз и содержание ТМ - Cd, Ni, Pb, превышало ПДК в 17-23 раза.

На заболеваемость раком кожи могло сказаться и иметь определенное значение также число населения разных национальностей. В ЮКО и Жамбылской области казахского населения больше. Казахи, веками проживающие в этих регионах, адаптировались к действию солнечных лучей, у них выработалась определенная толерантность к канцерогенному действию ультрафиолетовой части солнечного спектра. Это обстоятельство нельзя не учитывать. Однако в Восточном регионе ВКО число казахов не больше, чем в Павлодарской области, а заболеваемость раком кожи выше. Не изучен вопрос, какой из этих факторов играет роль инициатора канцерогенеза, а какой-промотора. Мнение, что свинец может играть роль промотора при комбинированном действии на легочный эпителий с другими канцерогенами может иметь место и при действии на эпителий кожи.

**СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РАЙОНАХ СЕВ.-КАЗ. ОБЛАСТИ***Абдримов Е.Г., Байясунов Э.А., Магзумов А.Б.**КГКП «Областной онкологический диспансер», г.**Петропавловск*

Актуальность. Медиана пика онкозаболеваемости в России в период 1998 - 2008 г. г. приходилась на возраст 61 - 63 лет, а в Европе 65 - 69 лет. По данным ВОЗ, если в структуре населения лица 60 лет и старше превышает 7 %, тогда страна относится со стареющим населением и нужно ожидать роста онкозаболеваемости.

Цель. Изучить структуру населения области в разрезе районов в контексте с уровнем онкозаболеваемости в этих регионах в 2005 - 2009 г. г.

Материалы и методы. Представлены средняя заболеваемость ЗНО (медиана) в 2005 - 2009 годах в разрезе районов, а также определены доля лиц 60 лет и старше в структуре

населения области в выше указанный период. В таблице приведены показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в разрезе районов Сев.-Каз. обл. и стандартизованные показатели.

Онкозаболеваемость и структура населения области в разрезе районов

	Средний показатель (медиана) за 2005-2009 г.г.		
Наименование районов	Онкозабол. на 100 тыс. населения («грубый» показатель)	Стандартиз. показатель заболеваемости	Доля лиц 60 лет и старше в структуре населения в %
Айыртауский	163,6	130,5	13,9
Ақжарский	107,3	107,6	9,6
Аққайынский	243,8	195,5	13,35
Есильский	237,4	188,2	13,85
Жамбылский	194,0	157,9	12,81
М. Жумабаев ЕЛ	208,4	161,9	14,0
Қызылжарский	230,5	180,9	14,6
	239,3	180,9	14,2
Г. Мусрепова	162,1	133,1	12,15
Тайышшинский	168,7	145,3	11,98
Тимирязевский	151,8	159,8	10,55
Уалихановский	93,0	104,6	8,52
Шал - Ақына	199,5	152,0	14,9
г. Петропавловск	373,9	249,7	15,45
Сев.-Каз. область	245,1	160,5	13,2

Результаты. По уровню заболеваемости ЗНО районы области были разделены на 3 группы. В группу районов с высокой онкозаболеваемостью, т. е. - 200 ‰ и выше вошли г. Петропавловска и пять районов (Аққайынский, Есильский, М.Жумабаева, Қызылжарский, Мамлютский), а со средним от 160 ‰ до 200 ‰ (Г.Мусрепова, Тайышшинский, Жамбылский, Айыртауский, Шал - Ақынекий) и низкими показателями ниже 160 ‰ (Уалихановский, Ақжарский, Тимирязевский). В группе районов с относительно низким уровнем онкозаболеваемости наблюдалась более низкая доля лиц 60 лет и старше (8,52%, 9,6% и 10,5% соответственно), что ниже среднеобластного показателя на 28,1 %. В районах с высокими уровнями онкозаболеваемости отмечается и более высокая доля лиц пожилого возраста (13,35%, 13,85%, 14,0%, 14,6%, 14,2% соответственно) или средний их показатель выше областного на 8,4%.

Выводы. В области доля лиц старше 60 лет превышает рекомендуемой ВОЗ 7 ‰ почти в 2 раз. В районах с высоким уровнем онкозаболеваемости в структуре населения доля лиц старше 60 лет превышает областной показатель на 8,4%, а в районах относительно низким уровнем онкозаболеваемости, доля пожилых людей ниже областного показателя на 28,1%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ПИЩЕВОДА В КАЗАХСТАНЕ

Игисинов С.И., Кайдаров Б.К., Есенкулов А.Е.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Рак пищевода (РП) является одним из самых распространенных злокачественных заболеваний в земном шаре, особенно характерно для Средней Азии и Казахстана, что требует проведение дальнейших углубленных эпидемиологических исследований и поэтому данная работа посвящена изучению региональной особенности рака данной патологии

в республике. Материалом исследования послужили данные за 1989-2006 годы, касающиеся РП, со использованием общепринятых методов санитарной статистики. РП в Казахстане в среднем составил 15,2‰, и в динамике снизился с 15,5‰ до 9,3‰, а по отдельным регионам распространено неравномерно. В Восточном регионе заболеваемость РП снизилась с 10,1‰ (1996 г.) до 9,2‰ в 2006 году, аналогично и в Северном регионе - с 9,6‰ до 7,8‰, соответственно. Для Южного региона характерным оказался, то, что во всех областях РП была выше и самая высокая - в Кызылординской (46,0‰) области, что в 3 раза выше, чем по республике, однако в динамике РП снижался с 41,8‰ до 24,1‰. В Западном регионе - самый низкий РП установлено в Западно-Казахстанской (10,4‰), а в остальных - в Актыбинской (19,7‰) и Мангыстауской (23,9‰) и Атырауской (35,6‰) областях были высокими, чем по республике. Самый высокий показатель РП выявлено в Атырауской области, где частота рака в 2,3 раза были выше по сравнению с данными по Казахстану. Установлено, что ниже среднереспубликанских показателей заболеваемости РП (15,2‰), располагались 8 областей и 2 городов с частотой с 5,6 до 12,1‰, а выше - 9 областей с 17,0 до 46,0‰. Причем первое место занимает Кызылординская (46,0‰), второе - Атырауская (35,6‰) и третье - Мангыстауская (23,9‰) области. За этот период РП в республике снизился на 5,7‰ больных или на 36,8%, а темп снижения оказались ощутимой ($T = -0,32\%$) и снижение угла тренды заболеваемости $tg(a)$ приближается к 30°, что свидетельствует о истинном снижении РП в Казахстане. Подобный факт, обусловлено, с тем, что социально-экономическое положение населения улучшилось и изменилась экологическая ситуация в стране, в связи с ликвидацией Семипалатинских и Азгирских ядерных полигонов. А так же изменением характера питания с меньшим содержанием предшественников нитрозаминов (нитритов, нитратов и аммиака) и др. Кроме того, изменилась возрастная состав населения республики, уменьшился когорты людей, подверженных воздействию продуктами ядерных взрывов, проведенных в Казахстане. Выявленное региональное особенности распространение РП на территории Казахстана, позволяет определить приоритетное направление по проблеме РП и позволять организовать целенаправленных противо-раковых мер в отдельных регионах Казахстана.

ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 50 ЛЕТ

В.Н. Полешко

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: в течение последних десятилетий отмечается неуклонный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в Павлодарской области. С точки зрения эпидемиологии – рак нельзя рассматривать как отдельное заболевание, здесь необходимо отметить наличие связей между раком и широким спектром социально-экономических особенностей региона, экологических факторов, наследственности, бытовых привычек населения.

Цель работы: проведение анализа онкологической заболеваемости и смертности злокачественными новообразованиями в Павлодарской области за последние 50 лет.

Материалы и методы: статистические отчеты за 1958 – 2008 годы.

Показатель заболеваемости в области вырос с 88,0 на 100000 нас. в 1958г. до 265,3 в 2008г. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Казахстане в 1958 году составила 76,5 на 100.000 населения. Ежегодный прирост заболеваемости 4,1%. Увеличение показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями населения

Павлодарской области за последние 50 лет в 3 раза прежде всего следует объяснить улучшением регистрации и учета онкологических больных, совершенствованием работы областного онкологического диспансера, увеличением средней продолжительности жизни населения. Ежегодный прирост составил 6,2%. Однако необходимо отметить и действительный рост частоты онкологических заболеваний, почти по всем локализациям. Заметный прирост заболеваемости значительно повлиял на структуру заболеваемости злокачественными новообразованиями в области. Последние 15 лет на первом месте находится рак легкого, рак молочной железы и рак желудка занимают с 1998 года второе – третье место. На четвертом месте стоит рак кожи. Число заболевших раком достигает своего максимума у обоих полов примерно в возрасте 60 - 69 лет. Смертность от злокачественных новообразований имеет неуклонный рост. В 1958г. показатель составил 46,7 на 100000 нас., в 2008г. – 162,9. Ежегодный прирост 5,1%.

Выводы и результаты: представленный анализ заболеваемости и смертности злокачественными новообразованиями Павлодарской области за 50 лет позволяет сделать следующие выводы:

1. Увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями по Павлодарской области в три раза связано не только с положительными сдвигами в организации онкологической помощи, но также и значительным истинным ростом заболеваемости за этот период.
2. Прошло значительное изменение структуры заболеваемости.
3. Наиболее подверженный раку возраст 60 - 69 лет, который с 1990 годов одинаково часто поражает оба пола.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В Г.АСТАНА

Тулетаев М.Е., Жумагазин Ж.Д.,
Мустафина Б.К., Жуков Ю.В.

Городской онкологический диспансер г.Астана

Актуальность проблемы: Из 1247 случаев онкологических заболеваний, выявленных в 2009г на долю онкоурологических приходится 115 (9,2%). Количество больных с каждым годом возрастает. Ранняя диагностика – важнейшее условие, позволяющее улучшить результаты лечения.

Цель работы: проанализировать статистические данные по онкоурологическим заболеваниям в г.Астана за 2009г.

Материалы и методы: В 2009г было выявлено 49 случаев рака почки, что составило 41,7% от всех онкоурологических заболеваний. Мужчин было 28, женщин 21. I- II ст. заболевания установлена у 21 пациента, III ст. у 21, IV ст. - у 6. В возрасте 40-60 лет было 15 больных (30,6%), старше 60-30 (61,2%). 16 (32,6%) поступили в экстренном порядке с явлениями макрогематурии, тампонады мочевого пузыря, клиникой почечной колики, острого пиелонефрита. Заболеваемость по г.Астана-7,2 на 100 тыс, смертность-2,4 на 100 тыс. пятилетняя выживаемость 38%.

В 2009г. рак мочевого пузыря был выявлен у 23 (20%) пациентов. Мужчин было 17, женщин 6. I-II ст. установлена у 19, III ст. у 4 пациентов. В возрасте 40-60 лет-8 больных, старше 60 лет-15. 8(34,8%), пациентов поступили в экстренном порядке с явлениями макрогематурии и тампонады мочевого пузыря. Заболеваемость по г.Астане 4,5 на 10 тыс, смертность 1,0 на 100 тыс., пятилетняя выживаемость 44,6%.

Рак яичка выявлен в 2009г выявлен в 7 случаях(6%). Возраст всех больных до 30 лет. I-II-я стадия заболевания установлена 6 больным, IV- одному. Заболеваемость по г.Астане 1,2 на 10 тыс. Пятилетняя выживаемость 44,8%

Рак предстательной железы в 2009г выявлен у 40 пациентов- (34,7%) от всех онкоурологических заболеваний. I-II ст. установлена у 18 пациентов, III ст. - у 16, IV-у 4-х. 36 (90%)

больных были старше 60 лет. 14(35%) пациентов поступили в экстренном порядке с явлениями ОЗМ. Заболеваемость по г.Астане-3,2 на 100 тыс, смертность-1,6 на 100 тыс, пятилетняя выживаемость 27,5%

Результаты и выводы:

1. 33% онкоурологических больных были госпитализированы в экстренном порядке.
2. Симптомы, позволяющие заподозрить онкоурологическое заболевание отмечались на протяжении от нескольких месяцев до года и более у большинства больных
3. С целью улучшения ранней диагностики онкоурологических заболеваний необходимо повышать санитарную грамотность населения.
4. Для раннего выявления рака предстательной железы мужчинам старше 50 лет следует рекомендовать ежегодное определение уровня ПСА.
5. По данным литературы УЗИ позволяет поставить диагноз рака почки в 75-93% случаев поэтому это обследование должно быть обязательным при проведении профосмотров.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕРМЕН КҮРЕСУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ

Толеутайұлы К.

Облыстық онкология орталығы, Қызылорда

Соңғы жылдары қатерлі ісіктермен аурушандықтың және өлім-жітімнің құрылымының өзгеруі орын алуда. Оның өзі біріншіден денсаулық сақтау саласының жеңісіне, екіншіден халықтың тұрмысының жақсаруына және адам жасының орташа ұзақтығының ұзаруына тікелей байланысты.

Мақсаты 2005-2009 жж. аралығында қатерлі ісік аурушандығына баға беру, оның бағытын анықтау.

Материалдары және әдістері. Соңғы жылдары онкология мекемелерін республикалық және жергілікті бюджеттерден құрал-саймандар алынды, медициналық көмектің сапасымен мәдениетін арттыруға жағдай жасалды.

Онкология орталығында қазіргі - 4398 науқас есепте тұрады, оны 100 000 тұрғынға есептегенде 685,5. Жыл сайын 5 жылдан астам онкологиялық науқастың өмір сүруі артуда (49,6% ; ҚР – 50,2%).

Қатерлі ісіктермен науқастардың аздап болса да төмендеу тенденциясы байқалады. Атап айтқанда, 2005 жылы 100 000 тұрғынға 154,5 болса, 2009 жылы 143,3 құрайды, яғни 7,2% төмендеп отыр (ҚР – 182,6%ооо).

Қатерлі ісік ауруларын жынысына және жасына қарай талдағанда әйелдердің аурушандығы 76,8%ооо, ер адамдардың – 67,5%ооо.

Соңғы жылдары қатерлі ісікпен аурушандықты жынысына және жасына қарай талдағанда нақты заңдылық байқалады: әйелдер мен ер адамдар арасында өңеш және өкпе қатерлі ісіктерінің төмендеуі орын алса, әйелдер мен ер адамдар арасында асқазан және лимфа, қан тамырлары жүйесінің қатерлі дерттерінің ұлғаю тенденциясы орын алып отыр.

Сонымен қатар әйелдер арасында сүт безі және жатыр мойны қатерлі ісіктері көбеюде. Ол елімізде жүріп жатқан профилактикалық тексерудің, яғни маммографиялық және цитологиялық тексерулердің нәтижесі.

Қатерлі ісік дертімен ауырған адамдардың құрылымында бірінші орынға- асқазан(12,4%) шықса, екінші-өңеш (12,1%), үшінші- өкпе (11,9%), төртінші орында сүт безі қатерлі ісігі (9,2%).

Әйелдер арасында онкологиялық аурулардың құрлымын зерттегенде сүт безі қатерлі ісігі бірінші орынға шығып отыр (16,8%). Сүт безі қатерлі ісігімен ауырған әйелдердің жас ерекшеліктерін талдағанда жиі кездесуі 81,2%ооо 60-69 жас аралығында.

Соңғы 5 жылда өңеш қатерлі ісігі 100 000 тұрғынға есептегенде облыс көлемінде 25,9%ооо –дан 17,3%ооо –ке, яғни

33,2 % төмендеп отыр. Оның себебі біріншіден қатерлі ісік алдындағы ауруларды емдеу жақсарса, екіншіден халықтың әлеуметтік жағдайы, сонымен қатар таза сумен қамтамасыз ету жақсаруда.

Соңғы бес жыл көлемінде қатерлі ісік салдарынан өлім-жітім 100 000 тұрғынға есптегенде 110,9-дан 105,6 дейін төмендеп отыр.

Жыл сайын қатерлі ісіктерді I-II сатысында анықтау жақсаруда. Мысалы, 2009 ж. қатерлі ісікпен ауырған науқастардың 40,9% I-II сатысында анықталса, ол көрсеткіш 2005 жылы 36,4% құраған болатын.

Жаңалықтарды енгізу: Папаниколау зерттеу әдісі, бауырға (гемигепатэктомия және біріктірілген бірнеше дене мүшелеріне) оташылдық ем жасау, құралас сәуле емі (жатыр мойнына, өңешке, несеп жолдарына жаңа технологиямен емдеу) әдістері іске асты. Цифрлы маммография әдісі енгізіліп, маммографиялық қор жасауға мүмкіндік туды.

Өкінішке орай, онкологиялық ауруларды асқынған IY сатысында жалпы емдеу мекемелері симптоматикалық ем жасауға алмайды, сол себепті де онкологиялық төсек орынды көбейту, немесе хоспис ашу бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Қорыта айтқанда, облыс көлемінде қатерлі ісіктермен белсенді күресуге жағдай жасалған. Оны жақсартуға маманданған онкология саласымен алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін мекемелерінің өзара тығыз байланысы мүмкіндік береді.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Толеутай У.К.

Высшая школа общественного здравоохранения

Рак молочной железы у женщин является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований. В структуре онкологической заболеваемости женского населения в Кызылординской области до 2008 года он занимал 2-е место, следуя после рака пищевода. Однако высокий темп прироста заболеваемости и смертности от рака молочной железы, опережающий большинство других опухолей, выдвигает эту проблему на ведущее место в противораковой борьбе.

Целью исследования было изучение этнических особенностей заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) жительниц Приаралья.

Материалы и методы исследования. Исследование охватывает 10 лет (2000-2009). Источниками исследования были учетно-отчетные документы Кызылординского областного онкологического центра, где взяты на «Д» учет больные с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ. Вычислены экстенсивные, грубые, стандартизованные и возрастные показатели заболеваемости РМЖ по общепринятым методом санитарной статистики.

В структуре онкологической заболеваемости населения за 2009 год РМЖ занимает 4-е место. С 2009 года в структуре онкологической заболеваемости среди женского населения Кызылординской области РМЖ занимает 1-е место.

В структуре населения Кызылординской области по данным переписи населения 2009г. преобладают лица казахской национальности и составляют 95,8%; русской - 1,9%; корейской - 1,2%; других национальностей - 1,1%.

За 10 лет (2000-2009) в области было зарегистрировано 626 – женщин с РМЖ, из них 515 (82,2%) женщин казахской национальности, 69 (11%) – русских и 24 (3,8%) – корейок, 16 (2,8%) – женщины других национальностей. Основную группу больных (98,8%) составили женщины казахской, русской и корейской национальностей.

Принимая сумму показателей заболеваемости за десятилетний период за 100% (в абсолютных числах - 626), опреде-

лен удельный вес каждой национальности раком молочной железы. Основную группу больных из 626 женщин с раком молочной железы составили женщины казахской, русской и корейской национальностей (608-97,13%). При оценке процентного распределения абсолютного числа впервые выявленных больных РМЖ за 10 летний период наиболее высокую долю составили казашки, а при вычислении частоты заболеваемости на 100 000 населения каждой национальности, также за последний 10-летний период, высокий интенсивный показатель наблюдался среди русской (50,2), корейской (29,5) и других (24,2) национальностей, тогда как среди казашек грубый показатель (8,8) отмечался на низком уровне.

За 10-летний период РМЖ у казашек увеличился в 1,7 раз, у русских в 2,2 раза и корейок в 2,8 раз. Динамика роста заболеваемости РМЖ у казашек носит постепенный, а у русских и корейок волнообразный характер.

Таким образом, анализ заболеваемости РМЖ показал, что во всех этнических группах отмечается тенденция к росту. Следует обратить внимание об особенностях распространения рака молочной железы в Кызылординской области, что в дальнейшем должно лечь в основу планируемых мероприятий на местах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Ерубаев С.Ж.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: меланома – это чрезвычайно злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих специфический полипептид меланин. Характерным для меланомы является скопление меланина в клетках опухоли, хотя встречаются так называемые беспигментные меланомы. Ежегодно на учёт в Павлодарской области берётся до 30 человек. В структуре первичной заболеваемости меланома кожи составляет 0,5%.

Цель работы: проанализировать динамику эпидемиологических показателей меланомы кожи за 2000 – 2004 годы в Павлодарской области.

Материалы и методы: истории болезни, амбулаторные карты пациентов, взятых на учёт в 2000 – 2004 годах, статистические отчёты.

Основные показатели по меланоме кожи за 2000 – 2004 годы

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004
Взято на учёт	22	20	26	17	28
В т.ч.					
Мужчины	10	7	11	5	14
Женщины	12	13	15	12	14
Город	22	20	26	10	28
Село				7	
По стадиям:					
I-II	20	18	21	12	22
III			5	4	4
IV	2	2		1	2
Заболеваемость на 100000 нас.	2,8	2,6	3,4	2,3	3,7
Умерло	3	8	5	11	8
Смертность на 100000 нас.	0,4	1,0	0,7	1,5	1,1
Ранняя диагностика	90,9%	90%	80,8%	70,6%	78,6%
Запущенность (IV)	9,1%	10%	0	5,9%	7,1%
Запущенность с учётом III стадии	9,1%	10%	19,2%	29,4%	21,4%
Одногодичная летальность	15%	13,6%	10%	0	11,5%
Состоит на учёте	109	129	148	149	168

Пятилетняя выживаемость	55%	53,5%	47,9%	51,7%	53,6%
----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

Результаты и выводы. Меланома чаще встречается у лиц женского пола и у жителей города.

Заболеваемость за 5 лет повысилась на 32%. Среднегодовой прирост 8%.

Ранняя диагностика понизилась за счёт роста удельного веса заболевания, выявленного в III стадии.

Запущенность (IV ст.) понизилась за 5 лет на 2%.

Пятилетняя выживаемость чуть выше 50%, что свидетельствует о чрезвычайной злокачественности меланомы.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2009г. В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мукушева А.Х.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак шейки матки прочно занимает 2 место в структуре онкозаболеваемости женского населения области. За последние 5 лет наметилась тенденция к увеличению заболеваемости раком шейки матки, которая в 2009г. составила 9,3 на 100 тыс.нас. Смертность от рака шейки матки за последнее 5-летие существенно не изменилась и составила в 2009г. 5,3 на 100000 нас. при Республиканском показателе 4,4. Показатель ранней диагностики увеличился по сравнению с 2005г. на 15,3% и составил 62,9%. Показатель поздней диагностики за 2009г. понизился по сравнению с 2008г. на 3,2%. С учётом III стадии показатель понизился с 41,9 % в 2005г. до 37,1% в 2009г. Проведение цитологического скрининга с целью раннего выявления рака шейки матки в ранних стадиях его развития является единственным шансом улучшить онкологическую ситуацию по этой нозологии.

Материалы и методы: годовые статистические отчёты, отчёты цитологической лаборатории за 2009 год.

Цель работы: проанализировать эффективность проводимого в области профилактического осмотра в целях раннего выявления рака шейки матки путём цитологического скрининга.

В 2009г. цитологический скрининг в Павлодарской области проведён 21175 женщинам в возрасте 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет и 86533 женщинам других возрастов. Обследовано 101019 женщин с профилактической целью и 6689 с диагностической целью. Всего выявлено 29867 случаев патологии, что составляет 27,7% от общего количества обследованных. 3 случая рака шейки матки выявлены при профилактическом цитологическом скрининге в рамках Республиканской программы по ранней диагностике рака шейки матки, 11 – у женщин других возрастов. Кроме того, выявлено дисплазий лёгкой степени 4799, средней степени – 769, тяжёлой степени – 104, эрозий шейки матки – 632, инфекций, передающихся половым путём – 760, воспалительных заболеваний шейки матки – 22789. При анализе запущенных случаев рака шейки матки выявлено, что 64% запущенных случаев регистрируются в возрастной группе женщин старше 50 лет. Цитологическое исследование цервикальных мазков по Папаниколау остается основным методом скрининга заболеваний шейки матки. Метод дает возможность оценить структуру и клеточный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток. Основной целью цитологического исследования является выявление морфологических особенностей клеток, характеризующих конкретный процесс. Учитываются клеточные, структурные и

функциональные признаки злокачественного перерождения клеток. Ложноотрицательные ответы гораздо чаще связаны не с погрешностями работы цитоморфолога, а с нарушениями техники сбора и обработки цитологического материала. При этом выявилась зависимость качества мазков от характера используемых инструментов. Мы добиваемся, чтобы техника забора Пап – мазков была строго регламентирована. Лучшим методом сбора клеток признано использование комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки. Такая комбинация может способствовать более эффективному выявлению атипичного эпителия.

Результаты и выводы: в связи с высоким уровнем заболеваемости раком шейки матки цитологический метод занимает главенствующую роль в ранней диагностике, позволяя повысить выявляемость рака шейки матки на ранних стадиях, увеличить число больных с 5-летней выживаемостью до 90% и снизить смертность от этого заболевания. Необходимо более активно проводить цитологический скрининг женщинам в возрасте старше 50 лет.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЖЕЛУДКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2003-2007 ГГ.

Ассесорова Ю.Ю., Киреев Г.В.

Несмотря на снижение частоты заболеваемости раком желудка (РЖ), имеющее место в последние десятилетия, эта патология продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО). В Республике Узбекистан доля РЖ в структуре заболеваемости ЗНО составляет 9,6%, а в структуре заболеваемости ЗНО органов пищеварения – 35,5%.

Анализ первичных данных за период 2003-2007 гг. позволил установить, что средний многолетний уровень заболеваемости РЖ в Республике Узбекистан составил $6,7 \pm 0,07$ на 100 тыс. населения. Среди административно-территориальных единиц Республики Узбекистан самый высокий уровень заболеваемости РЖ ежегодно регистрируется в г.Ташкенте: среднее пятилетнее значение составило $12,1 \pm 0,89$ на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза превышает данный показатель по Республике в целом. Высокий уровень заболеваемости РЖ отмечается также в Андижанской области ($9,7 \pm 0,41$ на 100 000 населения), Республике Каракалпакстан ($8,4 \pm 0,39$) и Ташкентской области ($8,1 \pm 0,27$). Самые низкие уровни заболеваемости данной формой онкопатологии зарегистрированы в Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Джизакской областях (соответственно, $4,2 \pm 0,26$; $4,5 \pm 0,29$; $4,9 \pm 0,15$; $4,9 \pm 0,27$ на 100 тыс. населения).

Изучение динамики заболеваемости РЖ в отдельных регионах Узбекистана за период 2003-2007 гг. показало, что в Наманганской, Самаркандской, Навоийской, Андижанской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан имела место тенденция к снижению заболеваемости данной формой онкопатологии. В Ферганской и Сырдарьинской областях заболеваемость РЖ возросла в 1,2 раза, в Кашкадарьинской и Бухарской областях – в 1,3 раза, в Джизакской области – в 1,7 раза.

Средний многолетний уровень заболеваемости РЖ среди мужского населения в целом по РУз составляет $8,6 \pm 0,10$ на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза выше заболеваемости среди женского населения ($4,8 \pm 0,06$). В отдельных регионах количество мужчин с впервые установленным диагнозом РЖ еще более значительно. Так, в Джизакской и Хорезмской областях соотношение заболевших женщин и мужчин составляло 1:2; в Навоийской, Ташкентской областях и Республике Каракалпакстан – 1:2,1; в Сырдарьинской области – 1:2,2.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г. Алматы

Проблема диагностики и лечения злокачественных новообразований яичников является одной из наиболее актуальных в современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируются 165000 больных раком яичников и 101000 из них погибают от прогрессирования заболевания. Проведенный анализ заболеваемости раком яичников за три года по г. Алматы показал, что уровень заболеваемости остается относительно стабильным. Однако за последнее десятилетие отмечено некоторое снижение заболеваемости раком яичников. По городу Алматы показатель заболеваемости в 2008 году составил 6,5 на 100 тыс. женского населения (6,7 на 100 тыс. женского населения в 2007 году). Учитывая клинические особенности течения рака яичников, даже такая динамика снижения заболеваемости не улучшает онкоситуацию в целом.

Проблема своевременной диагностики рака яичников является весьма актуальной. До настоящего времени у 75% больных раком яичников заболевание выявляется на поздних стадиях с 5-летней выживаемостью не более 15-20%. Большинство больных поступают в онкологические учреждения с запущенными стадиями опухолевого процесса яичников – в среднем 46,5% больных со злокачественными опухолями яичников с III стадией и 21% больных с IV стадией заболевания. Причины позднего выявления опухолей были обусловлены как бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, так и врачебными ошибками в диагностики из-за недостаточного знания семиотики злокачественных опухолей, длительного наблюдения за больными без уточненного диагноза, недостаточного использования всего возможного арсенала диагностических методов.

Грозным признаком недостаточной онконастороженности врачей общей лечебной сети являются участвовавшие случаи поступления в отделение онкогинекологии женщин с нерадикальным объемом операции их в ЛПУ города. Как правило, прогноз течения заболевания этих пациенток неблагоприятен, ввиду обширного интраоперационного обсеменения рака. Участились случаи нерадикальных операций, проводимых лапароскопическим методом, хотя малейшее подозрение на рак яичников является абсолютным противопоказанием к лапароскопической хирургии.

Учитывая объективные трудности дифференцированной диагностики рака яичников (отсутствие патогномоничных признаков), при появлении жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, наличие асцита, болей в животе неопределенного характера, пальпируемых образований в брюшной полости, необходимо исключить рак яичников.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Ажмагамбетова А.Е., Оспанов М.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Северный регион РК включает три области: Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую области.

Изучены особенности распространения рака легкого в северном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 7924 больных раком легкого (РЛ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели заболеваемости.

В Акмолинской области в первый временной период (2000-

2002 гг) заболеваемость РЛ по среднегодовым ИП снизилась незначительно с 43,8 до 41,0‰. Отмечается соответственно снижение по СП - с 30,1 до 28,6‰. Заболеваемость РЛ среди мужского населения со значительным снижением с 76,4 ‰ до 72,5‰ (СП 63,8-60,4‰). РЛ женского населения стабилен: ИП 13,2‰, СП - 8,2‰. Среднегодовые ИП по РЛ во второй период в динамике показали дальнейшее снижение заболеваемости с 41,0 до 39,1‰ в 2005 году и СП от 27,9 до 26,3‰. Во второй период среди мужского населения заболеваемость РЛ продолжает снижаться до 66,7‰, СП – до 55,2‰. У женского населения показатели РЛ с незначительным ростом на 0,2‰ при стабильном СП (8,2‰). В третий временной период заболеваемость РЛ имеет тенденцию к снижению с 37,2 до 35,4‰, СП с 25,6 до 24,1‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется: ИП 64,8-60,9‰, среди женщин – незначительный рост до 13,6‰, СП - 8,0‰.

В Костанайской области в 2000-2002 г. заболеваемость РЛ находится на одном уровне: 34,5-34,2‰. Среди мужского населения РЛ стабилен: 59,9‰, у женщин – ИП снизились от 11,3 до 10,5‰. Среднегодовые ИП по РЛ за 2003-2005 г. составили 33,8-33,3‰. Среди мужского населения заболеваемость на одном уровне 59,8‰, среди женского – незначительное снижение ИП 10,3-9,4‰. Среднегодовые показатели по РЛ в третий период с постепенным снижением с 33,0 до 32,6‰. Среди мужского населения ИП на 0,1‰ ниже, среди женского – на 0,8‰ к 2008 году.

В Северо-Казахстанской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция снижения заболеваемости РЛ всего населения с 42,3 до 40,9‰, среди мужского населения: с 75,1 до 73,0‰, среди женского – с 11,7 до 11,1‰. В 2003-2005 гг дальнейшее снижение заболеваемости РЛ с 40,2 до 38,8‰, среди мужчин ИП снизились с 71,9 до 69,8, среди женщин – с 10,8 до 10,2‰. Среднегодовые ИП по РЛ в третий период были в пределах 38,1-36,8‰, среди мужского населения отмечается медленный спад заболеваемости с 68,7 до 66,6‰, среди женщин – с 9,9 до 9,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по северному региону Республики показал при ранжировании большую распространенность РЛ в Северо-Казахстанской области, затем в Акмолинской и Костанайской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Ажмагамбетова А.Е.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Восточный регион РК включает две большие области: Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую. Центральный регион представлен Карагандинской областью. Изучены особенности распространения рака легкого (РЛ) в них за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 11211 больных РЛ. Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Восточно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РЛ по интенсивным показателям была с небольшим спадом от 41,8 до 40,7‰. Заболеваемость РЛ среди мужского населения области высокая и в 2000 году составила 71,9‰, но постепенно снизилась до 70,5‰. Соответственно СП были 73,2-72,9‰. Заболеваемость РЛ среди женского населения была почти в 5 раз ниже, чем среди мужского. ИП в 2000 году была 14,4‰, к 2002 году она стала 13,5‰.

ИП по РЛ среди всего населения во второй период продолжают снижаться со 40,1‰ до 39,0‰. У мужчин эти показатели соответственно 69,9-68,5‰, среди женского населения – 13,1-12,2‰. В 2006 году ИП в области по

РЛ составили 38,4‰ с постепенным понижением до 37,3‰. Среди мужского и женского населения тенденция сохраняется: у мужчин – 67,9‰, у женщин – 11,7‰. В 2008 году соответственно 60,6 и 10,9‰.

В Павлодарской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ составила 32,4‰, но имеется рост в течение указанного периода до 33,4‰ у всего населения области. Среди мужчин отмечается рост ИП – с 55,8 до 58,0‰, среди женщин отмечается стабильный ИП 11,2‰. Заболеваемость во второй временной период имеет тенденцию к небольшому росту до 34,9‰, среди мужчин – с 59,1 до 61,2‰, среди женщин – небольшой рост ИП до 11,4‰. В третий временной период заболеваемость всего населения постепенно растет с 35,4 до 36,5‰. У мужчин эти показатели – 62,3 – 64,4‰, среди женского населения отмечается стабилизация заболеваемости с ИП 11,5‰.

В Карагандинской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ с 33,7 снизилась до 32,3‰. Среди мужского населения отмечается также спад ИП с 58,1 до 55,6‰, и медленное снижение заболеваемости у женского населения – с 11,8 до 11,3‰. В 2003-2005 гг отмечается снижение заболеваемости РЛ в целом по области с 31,5‰ до 30,0‰. Среди мужского населения – с 54,3 до 51,7‰, у женщин – с 11,1 до 10,7‰. В третий временной период заболеваемость РЛ продолжает уменьшаться в 2006 году с 29,3‰ до 27,8‰ в 2008 году. ИП заболеваемости РЛ у мужчин составили 50,4‰, и в конце периода – 47,8‰. Заболеваемость по РЛ среди женского населения с медленным темпом снижения с 10,5 до 10,1‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по восточному и центральному региону Республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Восточно-Казахстанской, затем в Павлодарской и Карагандинской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Жапарова Д.Д.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Южный регион РК включает четыре области: Южно-Казахстанскую (ЮКО), Кызылординскую (КЗО), Жамбылскую и Алматинскую. Изучены особенности распространения рака легкого (РЛ) в южном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 6940 больных РЛ. Методами санитарной статистики рассчитаны показатели заболеваемости.

В Южно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РЛ была в пределах 12,4-11,5‰. Среди мужского населения отмечается тенденция снижения: ИП с 18,4 до 16,8‰, у женщин – спад заболеваемости значительно медленнее: 6,0-5,6‰. Во второй период заболеваемость в области РЛ снизилась с 11,0 до 10,1‰ в 2005 г, среди мужчин – с 16,0 до 14,4‰, и значительно меньше среди женского населения: 6,4-5,0‰. В 2006-08 гг заболеваемость РЛ продолжает снижаться с 9,6 до 8,6‰, среди мужского населения с 13,6 до 12,1‰, среди женщин – с 4,7 до 4,3‰.

В Кызылординской области в 2000-2002 гг заболеваемость РЛ была с постепенным снижением с 21,2 до 20,6‰. Среди мужского населения отмечается спад с 30,9 до 30,1‰, среди женщин – с 10,9 до 10,6‰. Во второй временной период в динамике имеется снижение заболеваемости в области с 20,3 до 19,7‰, у мужчин – с 29,7 до 28,9‰, у женщин с 10,9-10,6‰. Заболеваемость РЛ в 2006-2008 гг продолжает снижаться с 19,4 до 18,8‰, среди мужского населения – с 28,5 до 20,6‰, среди женского – с 10,4 до 10,0‰.

В Жамбылской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция к значительному спаду заболеваемости РЛ всего населения – с 17,2 до 16,6‰, и среди мужчин: с 28,6 до 27,4‰. У женщин показатели РЛ стабильны 6,5‰. В 2003-2005 гг продолжается спад заболеваемости с 16,2 до 15,5‰, среди мужского населения с 26,8 до 25,6‰, у женщин показатели с незначительным изменением: 6,3‰. В третий период заболеваемость РЛ продолжает снижаться с 15,2 до 14,5‰. Более значительный спад показателей среди мужского населения с 25,0 до 23,8‰, и слабое понижение с 6,3 до 6,2‰ у женщин.

В Алматинской области заболеваемость РЛ постепенно снижается с 18,3 до 17,3‰ за 2000-2002 гг. Среди мужского населения заболеваемость снизилась с 30,9 до 29,1‰, среди женского с 6,3 до 6,0‰. Во второй временной период темп постепенного снижения продолжается с 16,8 до 15,9‰, у мужчин с 28,3 до 26,6‰, у женщин с 5,9 до 5,6‰. Заболеваемость РЛ в третий временной период тенденция снижения сохраняется, составив 15,4 в 2006 году, дойдя до 14,4‰ в 2008 году. Среди мужчин показатели понизились с 25,4 до 24,0‰, у женского населения – незначительное снижение: с 5,4 до 5,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по южному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Кызылординской, в Алматинской, затем в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Жапарова Д.Д., Аймагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Западный регион включает четыре области: Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангистаускую.

Изучены особенности распространения рака легкого в западном регионе Республики Казахстан за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 4422 больных раком легкого (РЛ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Актюбинской области в первые три изучаемых года (2000-2002 гг.) заболеваемость РЛ относительно на одном уровне с небольшим снижением 24,6-23,8‰, СП – 21,2-20,5‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется с ИП – 42,2-40,7‰, СП – 43,7-42,5‰, у женщин незначительное снижение заболеваемости: ИП – 8,2-8,0‰, СП – 6,3-6,1‰. В 2003-2005 гг. ИП по РЛ в динамике продолжается постепенное снижение до 22,5‰, СП – до 19,4‰. Среди мужского населения ИП снизились с 40,0 до 38,5‰, при СП – 41,9-41,8‰. У женщин заболеваемость по ИП – 7,8-7,6‰, СП – 6,0-5,7‰. В третьем периоде заболеваемость РЛ снижается до 21,2‰, у мужчин – до 38,5‰ (ИП), СП – до 40,8‰. Среди женского населения ИП были 7,4-7,2‰, СП – 5,6-5,4‰.

В Западно-Казахстанской области в начальном периоде наблюдается относительный уровень стабильности заболеваемости 33,9-33,3‰. Среди мужского населения показатели в пределах 62,2-59,3‰. У женского населения отмечается небольшой рост заболеваемости – 7,4-7,7‰. В 2003-2005 гг. заболеваемость постепенно снижается с 32,1 до 30,8‰, среди мужчин – с 57,9 до 56,0‰. У женщин заболеваемость выросла с 7,9 до 8,3‰. В третьем периоде тенденция снижения продолжается у всего населения – с 30,2 до 29,0‰, также и среди мужчин – 53,5 до 50,6‰. Среди женщин отмечается небольшой рост с 8,5 до 8,8‰.

В Атырауской области заболеваемость РЛ за 2000-2002 гг

медленно снизилась с 20,5 до 20,2‰. Среди мужского населения тенденция снижения сохраняется: ИП 35,7-35,0‰, СП 44,9-44,3‰; заболеваемость РЛ у женщин с медленным ростом ИП 6,0-6,1‰, СП 5,1-5,2‰. Во втором периоде намечается постепенное снижение заболеваемости с 20,1 до 19,8‰, среди мужского населения: ИП снизились с 34,6 до 33,8‰, СП – с 44,1 до 43,5‰. У женского населения тенденция роста сохраняется: ИП 6,2-6,3‰, СП 5,3-5,4‰. В третий период ИП по РЛ относительно стабильны 19,6-19,3‰. Несколько выражен спад среди мужского населения: ИП 33,4-32,6‰, СП 43,2-42,7‰. У женщин наблюдается медленное повышение заболеваемости: ИП 6,4-6,5‰, СП 5,6-5,7‰.

В Мангыстауской области в первый период заболеваемость РЛ была в пределах 16,3-15,4‰. Среди мужского населения наблюдается снижение показателей с 25,0 до 23,1‰, среди женщин показатели стабильны: 5,0‰. В следующие годы наметилась тенденция постепенного снижения заболеваемости с 14,9 до 14,0‰. В 2006-2008 гг. снижение уровня заболеваемости РЛ продолжается с 13,5 до 12,6‰. Среди мужчин снижение с 22,2 до 20,3‰ при стабильных показателях у женского населения 5,0‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком легкого по западному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РЛ в Западно-Казахстанской, затем в Актыбинской, Атырауской и Мангыстауской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

*Игисинов С.И., Сейсенбаева Г.Т.,
Имангалиева Н.Т., Петухов А.В.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Западный регион включает четыре области: Актыбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангыстаускую.

Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в западном регионе Республики Казахстан за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 1345 больных РШМ и 769 больных раком тела матки (РТМ).

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Актыбинской области в первые три изучаемых года (2000-2002 гг.) заболеваемость РШМ относительно на одном уровне, в среднем составив 12,8‰. Заболеваемость по интенсивным показателям РТМ снизилась с 9,2 до 7,0‰, по СП – с 8,6 до 7,0‰.

В 2003-2005 гг. ИП по РШМ составил 15,1‰, в динамике намечается тенденция роста с 13,3 до 16,7‰, а также и по РТМ – с 6,4 до 7,9‰ при СП 6,2-7,8‰.

Среднегодовой ИП по РШМ за 2006-2008 гг. на прежнем уровне 15,3‰. Заболеваемость была понижена в начальном периоде – 13,7‰, затем отмечен рост до 16,1‰. ИП по РТМ снижается с 9,5 до 8,5‰ при более стабильных стандартизованных показателях 8,9-8,2‰.

В Западно-Казахстанской области в 2000-2002 гг. наблюдается в динамике тенденция роста РШМ с 9,9 до 12,2‰. Заболеваемость РТМ составила в среднем 11,3‰, при снижении СП с 10,9 до 9,8‰. В 2003-2005 гг. уровень заболеваемости РШМ сохраняется в пределах с 12,8 до 12,1‰, а РТМ в пределах 11,3 и 11,2‰ при снижении СП с 10,9 до 9,8‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2006-2008 гг. составил 14,9‰ и при этом вырос на 2,2‰ по сравнению с прошлым периодом. В целом по заболеваемости РТМ в этот период в области отмечается постепенное снижение с 13,6 до 10,0‰, при соответствующем СП – 11,5-7,9‰.

В Атырауской области заболеваемость РШМ за 2000-2002 г. составила 13,2 - 13,5‰ и по РТМ – 3,5-6,9‰.

Среднегодовой ИП заболеваемости РШМ в 2003-2005 гг. вырос до 20,4‰, показатели по РТМ в это период выросли с 6,9 до 8,4‰ с более высокими СП 7,6-9,5‰. В третий период ИП по РШМ выросли с 16 до 20,1‰. Заболеваемость по РТМ снижается с 7,4 до 4,7‰, соответственно СП – 7,9-5,6‰.

В Мангыстауской области в первый период заболеваемость РШМ была 6,9‰, отмечалась тенденция спада с 9,9 до 4,2‰. ИП по РТМ выросли с 6,8 до 7,7‰ при достаточно высоких СП 9,9-9,5‰. В следующие годы среднегодовой ИП по РШМ составил 9,9‰, при этом показатель вырос на 3‰ по сравнению с предыдущим периодом. Заболеваемость по РТМ стала снижаться с 8,1 до 6,5‰ при более стабильных СП 8,6-8,2‰. Среднегодовой ИП по РШМ в 2006-2008 гг. составил 9,1‰. Заболеваемость РТМ в области в последние годы была в пределах 5,7-4,7‰ при более высоких и стабильных СП 6,5-5,9‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по западному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Атырауской, затем в Актыбинской, Западно-Казахстанской и Мангыстауской областях.

Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Западно-Казахстанской, затем в Актыбинской, Атырауской и Мангыстауской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Петухов А.В., Садык М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Южный регион РК включает четыре области: Южно-Казахстанскую (ЮКО), Кызылординскую (КЗО), Жамбылскую и Алматинскую. Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в южном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в регионе 1779 больных РШМ и 668 раком тела матки (РТМ). Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Южно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг.) заболеваемость РШМ по среднегодовым интенсивным показателям снижалась с 8,8 до 6,8‰. ИП заболеваемости по РТМ на одном уровне: 3,0-3,2‰, но с постепенным ростом СП – с 3,2 до 4,3‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 10,1‰, в динамике – рост с 10,5 до 11‰ в 2005 г. По РТМ заболеваемость в области была с постепенным ростом в первые два года, составив 4,0-3,6‰. Однако в 2005 году наблюдается резкий спад до 2,0‰ соответственные показатели по СП – 5-4,7 и 2,4‰. В 2006-08 гг. заболеваемость РШМ имеет тенденцию к росту с 8,2 до 11,1‰. Показатель заболеваемости по РТМ высокий в 2006 году – 4,7‰, к 2008 году снизился до 3,6‰. Одновременно эта тенденция отмечена у СП: 6,1-4,5‰.

В Кызылординской области в 2000-2002 гг. заболеваемость РШМ составила 8,8‰, но имеется рост в течение указанного периода с 5,6 до 8,3‰. Заболеваемость по РТМ в пределах 3,6-4,0‰ при достаточно высоких СП – 4,6-5,2‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 гг. составил 10,4‰. Однако необходимо отметить, что в динамике имеется спад заболеваемости в области с 10,5 до 6,8‰ в 2003-2005 гг., что немного ниже данных предыдущего периода. ИП заболеваемости по РТМ постепенно снижается с 4,3 до 3,9‰, соответственно СП – с 5,1 до 4,4‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 гг. составил 12‰. По сравнению с предыдущим периодом ИП увеличился на 1,6‰. Заболеваемость по РТМ снизилась с 4,2 до 2,8‰, СП – с 5,0 до 3,3‰.

В Жамбылской области в 2000-2002 гг. отмечается тенден-

ция к значительному спаду заболеваемости РШМ – с 14,9 до 9,9‰ со среднегодовым ИП 11,8‰. ИП заболеваемости по РТМ были высокими в первые годы периода – 5,8-8,5‰. Однако в 2002 году спад заболеваемости до 2,6‰. При этом СП в пределах 6,2 и 2,7‰. В 2003-2005 гг характерна тенденция роста РШМ с 9,1 до 12,7‰. Заболеваемость по РТМ постепенно выросла с 3,8 до 5,1‰, соответственно СП с 3,9 до 5,4‰. В третий период ИП по РШМ в среднем 12,7‰ при стабильных годовых показателях последние два года – 13,2-13,4‰. Заболеваемость по РТМ высокая в 2006-2007 гг, составившая 6,2‰ с небольшим снижением в 2008 году – 4,7‰. СП на таком же уровне, как и ИП.

В Алматинской области заболеваемость РШМ колеблется с 13,6 до 15,8‰ за 2000-2002 гг. Заболеваемость по РТМ снижается с 5,8 до 3,3‰, соответственно СП остается на том же уровне – 6,1-3,3‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 гг составляет 15,5‰, имея тенденцию к небольшому спаду. По РТМ заболеваемость растет с 4,5 до 6‰, одновременно с СП с 4,2 до 6,0‰. Заболеваемость РШМ за 2006-2008 г. имеет тенденцию снижения с 20,5 до 16,2‰. Она сохраняется по РТМ, составив ИП 7,8-5,4‰, и соответственно СП – 7,4-5,2‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по южному региону республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Алматинской области, затем в Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Алматинской, затем в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Сейтказина Г.Д., Чингисова Ж.К.,
Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Восточный регион РК включает две большие области: Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую. Центральный регион представлен Карагандинской областью. Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки в них за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 4562 больных РШМ и 2616 раком тела матки (РТМ). Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели.

В Восточно-Казахстанской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по интенсивным показателям выросла с 12,8 до 18,5‰, в среднем составив 15,3‰. ИП заболеваемости по РТМ вырос с 12,3 до 14,1‰. Заболеваемость по РТМ была с темпом снижения с 13,1 до 10,9‰ при СП 10,3-8,8‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 17,1‰, со стабильными показателями все три года. По РТМ заболеваемость в области только в 2004 году выросла до 15,3‰, в начале и конце временного периода оставалась на одном уровне – 14,3‰. Однако СП продолжали постепенно расти с 8,8 до 11,5‰. В 2006-08 гг заболеваемость РШМ с тенденцией снижения с 20,3 до 17,0‰, со средними данными 18,9‰. В 2006 году ИП по РТМ были низкими – 10,7‰, затем отмечается рост до 14,9‰. Соответственно СП выросли с 7,3 до 11,0‰.

В Павлодарской области в 2000-2002 гг заболеваемость РШМ составила 16,3‰, но имеется рост в течение указанного периода с 14,6 до 17,9‰. ИП по РТМ относительно стабилен в пределах 16,8-16,9‰, но с постепенным снижением СП с 14,5 до 13,9‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 г. составил 14,6‰. Необходимо отметить, что

постепенный рост показателей отмечался в течение трех лет с 13,7 до 15,6‰. Заболеваемость по РТМ в этот период снижается с 19,3 до 16,1‰. Следует отметить эту тенденцию по СП – с 16,0 до 12,6‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 г. составил 19,5‰. Весь период исследования данные были на одном уровне (19,3-19,7‰). Заболеваемость по РТМ по данным ИП в области высокая в 2006 году – 19,6‰ со снижением до 17,2‰. Такие же показатели СП – 15,0-15,2‰.

В Карагандинской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция роста заболеваемости РШМ – с 13,2 до 17,8‰ со среднегодовым ИП 14,9‰. По РТМ отмечается постепенный рост заболеваемости с 17,5 до 19,7‰. Однако СП на одном уровне – 15,2-15,7‰. В 2003-2005 гг отмечается рост заболеваемости РШМ с 17,1‰ до 18,2‰ со средними показателями 17,6‰. Заболеваемость по РТМ в этот период на одном уровне: 15,8 - 16,8‰ при постепенном снижении СП с 13,6-до 10,6‰. В третий временной период заболеваемость РШМ несколько повысилась в 2007 году до 17,3‰. Средние показатели составили 16,9‰. Заболеваемость по РТМ с медленным темпом роста 15,8-16,8‰ и соответствующим СП – 12,2 – 12,7‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по восточному и центральному региону Республики при ранжировании показал большую распространенность РШМ в Павлодарской области, затем Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Павлодарской, затем в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Сейтказина Г.Д., Оспанов М.А.,
Чингисова Ж.К., Сейсенбаева Г.Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы РК

Северный регион РК включает три области: Акмолинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую области.

Изучены особенности распространения рака шейки (РШМ) и тела матки (РТМ) в северном регионе за 2000-2008 годы по трехлетним периодам. За указанный период зарегистрировано в этих областях 1863 больных РШМ и 1583 раком тела матки.

Методами санитарной статистики рассчитаны интенсивные (ИП) и стандартизованные (СП) показатели заболеваемости.

В Акмолинской области в первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по среднегодовым интенсивным показателям снизилась с 18,6 до 15,2‰, а также ИП заболеваемости по РТМ стали ниже с 17,2 до 13,1‰, стандартизованные показатели составили 14,8-11,0‰. Среднегодовые ИП по РШМ во второй период составили 19,3‰, в динамике наблюдается рост показателей с 15,8 до 24,0‰ в 2005 году. По заболеваемости РТМ в области интенсивные показатели выросли с 11,1 до 16,0‰ и по СП – с 8,3-18,3‰. Заболеваемость РШМ имеет тенденцию к снижению с 19,1 до 16,3‰ в 2006-08 гг, со средними данными ИП 17,4‰, по РТМ они выросли до 11,7‰, и его СП составил 9,4‰.

В Костанайской области в 2000-2002 г. заболеваемость РШМ составила 15,6‰, но имеется рост в течение указанного периода с 14,8 до 17,3‰. Показатели ИП по РТМ в этот период снизились с 14,0 до 12,5‰, по СП – с 11,5 до 9,1‰. Среднегодовой ИП по РШМ за 2003-2005 г. составил 18,3‰. Однако необходимо отметить, что динамика волнообразна, и заболеваемость в 2004 году была низкой 15,5‰, в 2005 году вновь отмечается рост до 19,7‰, как и в 2003 году. ИП заболеваемости по РТМ также с тен-

денцией роста с 14 до 15,6‰, при этом СП -10,3‰ – 11,0‰. Среднегодовой показатель по РШМ за 2006-2008 г. составил 19,7‰. По сравнению с предыдущим периодом ИП увеличился на 1,4‰. Для динамики ИП характерен постепенный рост заболеваемости РТМ в области с 15,6‰ до 17,4‰, СП – в пределах 11,6-13,6‰.

В Северо-Казахстанской области в 2000-2002 гг отмечается тенденция роста заболеваемости РШМ – с 12,8 до 15,4‰ со среднегодовым ИП 13,1‰. ИП по РТМ растет с 13,1 до 19,6‰, по СП – с 10,4 до 14,9‰. В динамике заболеваемость росла, затем был спад с 4,8 до 3,8‰ к 2003 году. В 2003-2005 гг отмечается снижение заболеваемости РШМ с 17,6 до 13,8‰ со средними показателями 15,6‰ и рост ИП по РТМ с 12,2 до 15,1‰, СП – в

пределах 8,9-11,5‰. Среднегодовой ИП по РШМ в третий период составил 14,4‰, динамика заболеваемости как по РШМ, так и по РТМ была не стабильной: 18,6 и 12,2‰ в 2006 году, соответственно, в следующем году – спад по РШМ до 11,7‰ и рост по РТМ до 14,1‰ и вновь спад интенсивных показателей РТМ до 10,9‰, при этом СП в среднем 8,6‰.

Таким образом, анализ заболеваемости раком шейки и тела матки по северному региону Республики показал при ранжировании большую распространенность РШМ в Костанайской, затем в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Заболеваемость по РТМ была первой по рангу в Костанайской, затем в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Вопросы диагностики

ИММУНОКОМПЕТЕНТТИ ЖАСУШАЛАРДЫҢ (ИКЖ) ЖӘНЕ ЦИТОКИНДЕРДІҢ МӨЛШЕРІН ИММУНОЕМІНЕН КЕЙІН ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІМЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІНДЕГІ РЕГРЕССИОНДЫҚ АНАЛИЗІ

Аубакирова А.Т.

Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Қатерлі ісікке қарсы әр түрлі тәсіл емдерінен кейін иммундық жүйенің қызмет атқаруын білу үшін, қатерлі ісікке қарсы иммунитеттің көрсеткіштерімен цитокиндердің деңгейін зерттеу екені бәрімізге белгілі, бірақ олардың жекеленген мөлшері кең вариабельді маңызына толық сипаттама бере алмайтынын білеміз. Жұмыстың мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауратын науқастардың адьюванты химиоэмдеумен және иммунохимиоэмдеуден кейін иммундық жүйенің қызмет атқаруын ерекше қадағалау үшін иммунитеттің көрсеткіштерімен цитокиндердің мөлшеріне регрессиондық статистикалық анализ жасау.

Құралдар мен әдістер: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың (ӨҚІАН) қанында CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD19+, CD3+/CD(16+56) және ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α мөлшері зерттелінді. Регрессиондық анализ жасау үшін Eviews статистикалық пакеті қолданылды. Регрессиондық моделдің ішінде құбылмалы мәндерін бағалау кезінде Eviews шығаратын «t» статистикасымен «p» мүмкіндік көрсеткіштері пайдаланылды. Құбылмалы dummy негізін беретін Eviewstің ішікі қызметі көрсетілді.

Химиемінен (ХЕ) және иммунохимиоэмдеудің (ИХЕ) ықпалы арқылы әр түрлі жолдармен иммундық жүйенің қызмет жасауын куәландырған бүгінгі таңдағы цитокиндермен иммунитеттің көрсеткіштерінің бір-бірімен корреляциялық байланысқа түскенін регрессиондық анализ арқылы ерекше бақылау сипаттамасы есептеліп көрсетілді. ӨҚІАН химиоэмдеуден кейін корреляциондық белгілерінің бөлектенген теріс нәтижесі мен корреляциондық байланыстардың былыққан күрделі құрылымы табылды, ал иммунохимиоэмнен кейін маңызды корреляциондық қозғалыстардың жоғарғы дәрежелі интеграциялық көрсеткіштерінің болуы байқалды, ол Беталейкинмен жасалған имуноемінің иммунитет жүйесіне жақсы әсер бергенін дәлелдеді. Емдеудің екі әдістернен: ХЕ және ИХЕ кейін корреляциондық байланыстар иммундық жүйенің әр түрлі жолдармен қызмет жасайтынын көрсетті. ИЕ кейін жақсы әсер еткенін байқап және ол цитокиндердің ИКЖ корреляциондық байланыстардың автономизациялық шектеулі нәтижесінің көрінісін байқасақ, ал ХЕ кейінгі ИЛ-1β, ИЛ-6 мен ФНО-α және ИКЖ арасындғы кері байланыстар байқалып табылды.

Қорытынды: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың иммунитетті (имунокомпетентті жасушалар мен цитокиндер) имуноемі күшейтті, осы жағдайда жоғарғы дәрежелі интеграциялық белгілер көрінісі табылды. Химиемінен кейін корреляциондық байланыстар күрделі былыққан құрылым құрағанын, осы емнің улы әсері екенін қарастырып көрсеттік. Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастар иммунохимия және химиоемінен кейін көптік регрессиондық анализ жасау арқылы корреляциондық бір бірімен байланысқа түскен цитокиндер мөлшері мен имунокомпетентті жасушалардың иммундық жүйенің әр түлі жолдармен қызмет жасайтынын дәлелдей алдық.

ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ТЕКСЕРІЛГЕН ИММУНИТЕТ ПЕН ЦИТОКИНДЕР КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУДЫҢ АҒЫНУ БОЛЖАМЫМЕН АУТОЦИТОКИН ЕМІНІҢ ӘСЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ АНАЛИЗ БЕРУ

Аубакирова А.Т., Баишева С.А., Баймухаметов Э.Т., Нуетпаева О.В., Карасаев М.И., Аязбаев Н.Б., Куркебаева Г.Б.
Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Онкология және медицина да өкпе қатерлі ісігі ең өзекті мәселе, өйткені ауру-сырқаушылығы өте жоғары да, және емдердің әсерінің жетіспеушілігінде. Бүгінгі таңда осы ісікке қарсы адьюванты химиоемінің қолданылуымен бірге құрамдастырылған ем түрінің әсері бар ма екен деген сұрақтар әдеми кітаптарда жиі талқыланады. Бірақ, химиоемі миелосупрессиямен қоса қатты улы әсер береді. Химиоемінің (ХЕ) әсерін жақсартатын және миелосупрессияны болдырмайтын жолдардың бірі, цитокинтүзүін эндогенді ынталандыру, бұл жағдайда қолданған емдердің нәтижесімен және канцерогенезге қарсы ықпал жасайды. Өрқашанда емнің әсерінің бір бөлігі, ол ағзаның аутоактивациясының мүмкіншілігі. Осы жағдай да, қатерлі ісікке қарсы агенттер, бұл тыстан енгізілген цитокиндер емес, аутоцитокиндер болып табылады.

II – IIIa стадиялы өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастарға адьювантты Беталейкин (интерлейкин - 1β) қолданған деректер ұсылынады. Химиемімен бірге жаңа тәсіл арқылы Беталейкин аутоқандәрісімен бірге егіледі. Науқастың ағзасына тура бағытталған ex vivo имунокомпетентті жасушалар ынталандырылып, олар қатты әсер беретін эндогендік цитокиндерді шығарады, бұл аутоцитокинемін жасайды да, иммунитеттің функционалдық жүйесін жақсартып, сандық және функционалды қорғауын және қатерлі ісікке қарсы түзу бағытталған әсерін күшейтеді.

Тексерілген иммунитет көрсеткіштері мен цитокиндер мөлшерінің деректерін салыстырып, өкпе қатерлі ісігіне аутоцитокин емінен кейінгі әсерін және клиникалық аурудың ағыну болжауын білуге болады. 88 өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастарды екі топқа бөлдік, I-ші топ – бақылау тобы, оған 57 науқас (операция + ХЕ) енді, ал II-ші топ – сынақталатын – негізгі топ, оған 31 науқас кірді (операция + имунохимиоемі (ИХЕ)).

Ағынды цитофлуориметр арқылы CD3+ (Т-лимфоциттер); CD4+ (Т-хелперлер); CD8+ (Т-цитотоксикалық Т-лимфоциттер); CD56+ (табиғи киллерлер); CD19+ (В-лимфоциттер) CD3+/CD(16+56) (барлық табиғи киллерлердің жасушалары) фенотип жасалды, имуноферменттік анализ арқылы ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α цитокин мөлшерлерін анықталды.

Негізгі топтағы науқастардың Беталейкинмен бірге аутоқанимуноемінен кейін иммундық көрсеткіштер анық жоғарлап, цитокиндердің мөлшері көтерілді.

I-ші топ – бақылау тобы 57 науқа адьювантты химиоемін алды. 57 науқастардың ішінен 48-нің имунореактивтері орташа алғанда 45% төмендеді, ал цитокин көрсеткіштері азайды, бірақ ИФН-γ мөлшері аздап жоғарлады. Қалған 9 науқастардың адьюванттық химиоемі уақытша тоқтатылды, өйткені иммунитет көрсеткіштері сыншылдық бағанасынан да төмендеген (15,7%).

Өкпе қатерлі ісігімен ауырған 31 науқасқа адьювантты Беталейкинмен бірге имунохимиоемі жүргізілді. 31 науқастың ішіндегі 17-сінің иммунитет көрсеткіштері жоғарлады (54,8%) және осы науқастардың имунокомпетентті жасушалары Бе-

талейкин әрекетімен жоғары ынталандыру қабілетін көрсетті. Осы науқастардың клиникалық аурудың ағыну болжамы жақсарылды және рецидивтер кезеңінің қайталанбауы 12 айға созылды. 17 науқастың ішіндегі, 2 жыл 7 ай бойы қадағаланғанда рецидивтер қайталанбады.

Адьюванттық кестеде иммунохимия емінен кейін (Беталейкин + стандарттық ХЕ) өкпе қатерлі ісігімен ауратын науқастардың рецидивтер кезеңінің қайталанбауы 11±2,0 айға созылды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ РЕВЕРТАНТОВ SALMONELLA TYPHIMURIUM

*Баймухамедова М.Х., Доскеева Р.А., Койшекенова А.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, Алматы*

Вклад микробиологии в онкологию имеет различные аспекты, развиваемые во всем мире, в частности микроорганизмы используются для выявления канцерогенности-мутагенности различных объектов окружающей среды в первичном скрининге. Поскольку, по данным многочисленных исследований, такие процессы как канцерогенез и мутагенез тесно связаны между собой (85% канцерогенов являются мутагенами) то, используя ускоренный метод определения мутагенности химических соединений (тест Эймса), выявляли один из этапов, имеющих ключевое значение для злокачественных превращений клетки. В связи с этим становится очевидным важность исследований, направленных на определение канцерогенности объектов окружающей среды.

Целью настоящей работы было тестирование на мутагенность (канцерогенность) объектов окружающей среды (воды, почвы и растений) Акмолинской области и г.Астаны на индикаторных штаммах *Salmonella typhimurium* (TA100 и TA98), полученных исходно из дикого типа LT2 Эймсом, в генотип которых были введены некоторые добавочные маркеры для повышения чувствительности этих штаммов к химическим мутагенам. Мутационный тест на микроорганизмах *Salmonella typhimurium* (тест Эймса) является бактериальной тест системой для учета мутаций от аутокотрофности к прототрофности по гистидину при действии канцерогенных веществ, индуцирующих мутации типа замены пар оснований или сдвига рамки считывания в геноме этого организма. Штамм *Salmonella typhimurium* (TA 100) регистрирует действие мутагенов индуцирующих мутации типа замены пар оснований, а штамм TA 98 – мутации типа сдвига рамки считывания (генетического кода) ДНК. Эти штаммы сальмонелл нами были проверены на аутокотрофность по гистидину, чувствительность к кристаллическому фиолетовому и устойчивость к ампицилину. Тесторные штаммы имели уровень спонтанных ревертантов в пределах ожидаемого на основании литературных данных.

Тестируемыми пробами являлись пробы воды (14), пробы почвы (6) и 13 проб растений: из них -овощей (моркови, картофеля, свеклы); ягод (листья и ягоды черемухи), трав (камыш, осока, полынь, ранетка, разнотравье), отобранных с территорий поселков (Кегенжар, Мичурино, Интернационал, Бошан, Кегенжар, Солёная Балка). В опыте использовались бензольные вытяжки почвы, трав и овощных культур и пробы питьевой, сточных вод и реки Ишим. В качестве позитивных контролей использовали мутагены прямого действия N-нитрозометилмочевину (НММ), вызывающие мутации замены пар оснований и 2,7 диамино-4,9 диокси-4,5,9,1 тетрагидро 5,9 диазопирен (ДДДТДП), индуцирующий мутации по типу сдвига рамки считывания

Результаты всех экспериментов позволяют считать, что из 14 проб воды, отобранных из различных водоисточников г.Астаны и близлежащих поселков Акмолинской области, только одна проба сточной воды поселка Бошан показала слабую канцерогенную активность по количеству ревертантов

как на штамме *Salmonella typhimurium* TA100, так и на штамме TA98. Превышение спонтанного фона составило -2,0 раза на штамме TA100 и 2,2 раза на штамме TA98. В то время, как травы (камыш) и овощные культуры, выросшие на территории поселка Бошан, мутагенную (канцерогенную) активность в тесте Эймса не проявили. Во всех пробах растений и почвы количество ревертантов находилось в пределах контроля на исследуемых штаммах сальмонелл, что свидетельствует об отсутствии канцерогенности.

Вывод. Полученные результаты демонстрируют специфичность мутационного воздействия по гистидину на этих штаммах, обусловленные различием типа мутаций.

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Астапкевич С.Г.

Лечебно-диагностический центр г. Астана

Для развития аденокарциномы пищевода важное значение имеет гастро-эзофагальный рефлюкс, а возрастающая актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с ростом числа больных с этой патологией во всем мире. В настоящее время эзофагит Барретта рассматривается как предраковое состояние. Основными задачами исследования явилось определение морфологических изменений в зоне поражения слизистой пищевода при эзофагитах различной степени выраженности и определение динамики изменений слизистой пищевода после проведения медикаментозной терапии.

Материал и методы. За период с января 2008 до сентября 2010 года в лечебно-диагностическом центре частной формы собственности г. Астаны проведено 2852 видеогастроскопических исследования. Патология слизистой пищевода выявлена у 262 пациентов и составила 9,2 % в общей популяции. С целью улучшения визуализации измененных участков слизистой пищевода использовали хромоэндоскопию. Степень выраженности эзофагита оценивалась по классификация Savary-Miller, 1977. У всех больных проводилось цитоморфологическое исследование биоптатов пищевода. Вариантами заключения являлись разные степени воспаления, воспалительно-дистрофические изменения, метапластические изменения, дисплазия эпителия и пищевод Барретта. При первичной эндоскопии степень выраженности эзофагита распределилась следующим образом: Степень I - 224 (85,5%), II - 16 (6,1%), III-IV - 14 (5,3%). Пищевод Барретта - 8 (3,1%). Всем пациентам проводилась терапия ингибиторами протонной помпы, прокинетиками, Н – блокаторами. Основной курс лечения составлял 4 недели. В группе с выраженными эрозивными эзофагитами, а так же пищеводом Барретта в комплексе лечения включали иммуномодуляторы. Контрольное эндоскопическое исследование проводилось на 4-й неделе, затем на 12-й неделе с биопсией пищевода и обязательным цито- и морфологическим исследованием. Ни в одном случае трансформации дисплазии в аденокарциному не выявлено. У пациентов через 4 недели во 2-й группе полное заживление эрозивных изменений слизистой пищевода произошло у 11 (68,8%), в 3-й группе — у 8 (57,1%) и в 4-й группе отмечали явную положительную динамику эндоскопических и морфологических критериев оценки состояния слизистой оболочки пищевода (у 5 пациентов легкая дисплазия, у 3 отмечена умеренная метаплазия, воспаление выраженной степени стало слабым). При контрольной эзофагогастроскопии на 12-й неделе ликвидировались эндоскопические признаки эзофагита у всех пациентов 2-й группы, сохранялась эндоскопическая картина «эрозивного эзофагита 1» у 3 (21,4%) пациентов 3-й группы. В 4-й группе дисплазия низкой степени присутствовала у 1 пациента после проксимальной резекции желудка по

поводу «малигнизированной» язвы субкардиального отдела желудка.

Заключение: Динамическая видеоэндоскопия с прицельной биопсией остается клиническим стандартом для ведения пациентов с эрозивными формами ГЭРБ и пищеводом Барретта для контроля эффективности терапии и выявления ранних форм рака пищевода онкопрофилактики и лечении дисплазии пищевода эпителия.

ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНЕН КЕЙІНГІ ИММУНОЕМІ, ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ ҚАРСЫ ИММУНИТЕТ ЖӘНЕ ЖАСУШАНЫҢ ІШІНДЕГІ ЦИТОКИНДЕР.

Баишева. С.А., Бейсебаев А.А., Аубакирова А.Т
Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу
институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Бүгінгі заманда жаңа өскен қатерлі ісіктерге цитокиндерді пайдалану болашағы бар бағыт болып табылады, бұл емнің ерекше әсері өзіндік қан препараттарымен бірге екенде жақсы белсенділік танытады. Цитокиндерді иммуноинталандыру үшін иммунокомпетенттік жасушаларды *ex vivo* арқылы термостаттың ішінде цитокиндердің түзілуіне жағдай жасайды да, науқастың бұлшық етіне қайта егу арқылы жүзеге асырылады. Иммунокомпетенттік жасушалар цитокиндерді түзіп шығарғанда, ісік жасушаларымен өзара олар әрекет жасайды және олардың апоптозға түсуіне көмектеседі. Осы кезде цитокиндердің мөлшері иммунокомпетентті жасушалардың көрсеткіштерін функционалды белсенді екенін байқатады.

Иммунокомпетенттік жасушаларды: CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD19+, CD3+/CD(16+56) және цитокиндерді: ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α EpiX XI (Beckman Coulter) атты ағынды цитофлюориметр аспабымен зерттеуден өткіздік. Бұл зерттеулер Циклоферонмен жүргізген иммуноемінің алдында және иммуноемінен кейін көрсеткіштерді тіркеді. Цитокиндердің мөлшерін қан сары суында екі сағат ішінде екі рет тексеруден өткізілді, өйткені оның шығару уақыты өте қысқа және цитокиндерді кодировать ететін мРНКСының интернализациясы тұрақты емес. Цитокиндердің көрсеткіштері маңызды айырмашылық танытпады, бұл жоғарыда айтылған препараттардың арқасында күшейген цитокиндердің қосымша мөлшерін тұрақты алып отырғанына байланысты.

Иммунокомпетенттік жасушалардың көрсеткіштері мен цитокиндердің мөлшері ынталандырылған әсері анық белгіленді және осы деректер маңызды көрсеткіштердің ең төмен анық айрмасы болуын байқатты. Иммуноемінің клиникалық рөлі аурудың қайталану ұзақтық кезеңі 8-10-12 айға жоғарлаты.

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ХИМИО-ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

Баспаева М.Б., Поляков В.И., Кубенова К.И., Туржанов К.Т.
Медицинский Центр ЗКГМУ им. М. Оспанова, Актөбе

Введение: Влияние химио-лучевой терапии на функциональное состояние регионарных лимфоузлов остается малоизученным.

Цель исследования: Проводилось изучение иммунологических показателей периферической крови и иммунофункциональное состояние регионарных лимфоузлов 32 больных РМЖ, получавших неoadъювантное лечение. Состояние 173 удаленных лимфоузлов оценивали методом локального гемолиза, который включал определение общего количества лимфоидных клеток (ОКЛК), количество живых лимфоидных клеток (ЖЛК), процент жизнеспособности лимфоидных клеток, а также количество антителобразующих клеток (АОК).

Результаты: При изучении иммунологических показателей периферической крови выявлены следующие закономер-

ности. По мере прогрессирования опухолевого процесса отмечается снижение количества CD 4+, CD 16+ и отмечается недостоверное увеличение количества CD 8+. При проведении химио-лучевой терапии отмечается усугубление иммунологического дисбаланса, при этом иммунологические показатели более чувствительны к химиотерапии и менее – к лучевой терапии. Отмечается снижение иммунофункциональных показателей лимфоузлов при проведении неoadъювантной химио-лучевой терапии. При этом, химиотерапия приводит к умеренному снижению, а лучевая терапия (особенно в СОД=70Гр), приводит к резкому уменьшению ОКЛК, ЖЛК и АОК.

Выводы: Проводимые предоперационные методы лечения вызывают развитие иммунологического дисбаланса. К химиотерапии более чувствительны иммунологические клетки периферической крови, проведение лучевой терапии больше влияет на иммунофункциональные показатели регионарного лимфоколлектора.

ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОМ.

Акшолов Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.
Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей г. Алматы.

Атерома образуется в результате задержки секрета сальных желез. Располагается на лице, волосистой части головы, туловища и т.д. Атеромы могут достигать значительных размеров. Они бывают единичными и множественными. Опухоль округлой формы, мягко-эластической консистенции. Цвет кожи обычно не изменен, но при нагноении атеромы появляются гиперемия кожи и отечность окружающих тканей.

Под нашим наблюдением находились 6 больных обратившихся к хирургу поликлинику центральной городской клинической больницы г. Алматы. Больные жаловались на наличие опухолевидного образования в различных участках тела: Двое больных с наличием образования в около сосковой области справа, волосистой части головы 2 и в области основания 4 пальца правой кисти. Зачастую, больные обращались при возникновении осложнения атеромы. Чаще всего нагноительный процесс. На коже определяется опухолевидное образование с покраснением кожи над опухолью, появляется болезненность при пальпации, что вынуждает обратиться больному за медицинской помощью.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование поверхностным датчиком с частотой от 7 до 12 МГц в поперечных и продольных проекциях. При этом атерома выявляется виде гипозоногенного образования, размерами от 0,5 до 3,0см. Глубина залегания на нашем материале не превышает 1-1,5см. Ультразвуковое исследование позволило выявить экзогенность образования. Не осложненная атерома чаще выглядит средней экзогенности образованием, довольно правильной формы, с четкими ровными контурами. По мере возникновения воспалительных и нагноительных процессов меняется размеры атером в сторону увеличения, экзогенность снижается, контуры становятся неровными. Вокруг атеромы возникает признаки воспалительной инфильтрации. При возникновении гнойного процесса в центре или по одному из контуров возникает анэхогенный участок с неровными и нечеткими контурами. Могут формироваться гнойные карманы, которые при ультразвуковом исследовании определяется виде затеков в толще мягких тканей или виде свища направленное к поверхности кожи.

Таким образом, сонографическая диагностика атером является информативным и объективным методом неинвазивной диагностики атером, как при наличии осложнения и без него.

Параганглиома представляет собой редкую нейро-

эндокринную неоплазму, которая может развиваться в разных частях тела (включая голову, шею, грудную и брюшную полости). Примерно 97% доброкачественные. Параганглиомы происходят из хромафин-негативных гломусных клеток, происходящих из эмбрионального нервного гребешка, функционирующих в качестве части симпатической нервной системы. Эти клетки обычно действуют в виде хеморецепторов, расположенных вдоль кровеносных сосудов, в частности в каротидных телах (на бифуркации общей каротидной артерии на шее) и в аортальных телах (вблизи аортальной дуги). Большинство параганглиом либо бессимптомны, либо представляют собой безболезненную массу. Хотя все они содержат нейросекреторные гранулы, только в 1-3% случаев секретируют гормоны, таких как катехоламины, бывает достаточно высокой, чтобы вызвать клинические симптомы, и в таком случае клинические проявления зачастую напоминают феохромоцитомы.

Под нашим наблюдением находились двое больных опухолью у которых по данным ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии нами установлен диагноз хемодектомы. У обоих больных параганглиома располагалась в области бифуркации общей каротидной артерий на шее. При УЗИ и МРТ хемодектома определялась в виде тканевого образования средней и повышенной плотности, расположенной в области бифуркации.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшолоков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

*Алматинский институт усовершенствования врачей
г. Алматы*

Гигромы - Кистозная лимфангиома (гигрома) — гамартома, развивающаяся из лимфатических сосудов, не сообщающихся с лимфатической системой, что приводит к скоплению лимфы в многочисленных расширенных сосудах. Гигрома имеет вид безболезненного куполообразного образования тестоватой консистенции. Кожа над кистой не изменена. Дермоидная киста растёт медленно, но может превышать 5 см в диаметре. Дермоидную кисту отличают от эпидермоидной отсутствие придатков кожи, в частности волосяных фолликулов, сальных и потовых желёз, в фиброзной стенке. Полость кисты выполнена роговым веществом и кожным салом, которые и обуславливают её тестоватую консистенцию и невозможность аспирации при пункции. Гигрома может формироваться в области суставов в результате скопления жидкости в влагалище сухожилия и отсутствии связи с полостью влагалища сухожилия за счет спаечного процесса. Лечение заключается в удалении кисты. Многие патологические образования мягких тканей имеют идентичную клиническую картину и затрудняет диагностику опухолевидных образований мягких тканей.

На данном этапе диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей применяются следующие методы: ультразвуковая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Нами поставлена задача изучить диагностические возможности лучевых методов исследования. При этом акцентировали внимание на неинвазивном ультразвуковом исследовании.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 34 больных, мужчин было 6, женщин 28, возрасте до 20 лет 5 человек, 20-29 лет 9 человек, 30-39 лет 5 больных, 40-49 лет 6 человек, 50-59 лет 5 больных и 60 и более лет 4 больных. Гигрома располагалась в предплечье у 2 больных, в области луче-запястного сустава 7, кисти 13, коленный сустав 3, голень 1, голеностопный сустав 3, стопа 4, паховой области 1. Длительность заболевания составила от одного месяца до десяти лет.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование

с использованием датчиков частотой 7,5 до 12 МГц.

По данным ультразвукового исследования преимущественной локализацией т.е. глубина залегания в подкожной жировой клетчатке у 34 100%. Форма гигромы была округлой у 2 больных, овальной формы у 26 и неправильной формы у 6 больных. При установлении форм учитывались данные, полученные при полипозиционном исследовании, в одной проекции гиroma может иметь округлую форму, а в другой овальную то форма образования овальная, если форма в двух взаимно перпендикулярных проекциях округлая, то и образование имеет округлую форму. Размеры гигром колебались в пределах от 0,5-4,0 см. сонография позволила измерить не только линейные, но и объём опухоли.

При ультразвуковом исследовании гиroma в основном выявляется в виде анэхогенного образования с дорзальным эхоусилением. Дорзальное эхоусиление за гигромой нередко решает дифференциальную диагностическую задачу. При ультразвуковой инструментальной пальпации датчиком аппарата опухоль имеет плотно-эластичную консистенцию. По данным сонографии опухоль чаще имеет однородную структуру (у 26 больных), однородность структуры образования указывает на то, что содержимое жидкостное. В то же время органическое содержимое гиromы со временем имеет способность становится более густым и приобретает желеобразную консистенцию, т.е. становится более экзогенной, вплоть до смешанной экзогенности. Возможно появление линейных гиперэхогенных структур за счет плотных участков. Для гиrom характерно наличие капсулы, окружающих опухоль и при сонографии капсула выявляется почти в 100%.

Таким образом, сонография является методом выбора при диагностике доброкачественной опухоли типа гиrom, она позволяет уточнить размеры опухоли, глубина залегания, структуру образования, его экзогенность, длительность существования и т.д. После хирургического лечения позволяет оценить эффективность лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшолоков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей

Гемангиома — наиболее распространённая опухоль головы и шеи у детей. Поражение обычно единичное. Гемангиомы делятся на капиллярные и кавернозные.

Артериовенозные гемангиомы возникают исключительно у взрослых. Инвазивные гемангиомы расположены в глубоких подкожных тканях, фасциальных прослойках и мышцах. Выглядят как инфильтраты. Имеют тенденцию к рецидивированию после удаления, но не метастазируют. Внутримышечные гемангиомы обычно обнаруживают в юношеском возрасте. При пальпации они подвижные и плотные. Как правило, над ними нет шума и пульсации. Часто возникает болевой синдром вследствие сдавления близлежащих структур. Часто спаяны с кожей.

При кажущейся простоте диагностики гематом мягких тканей по данным клинического обследования многие характеристики образования требуют своего уточнения с применением инструментальных методов исследования. Методами радикального лечения являются хирургическое удаление опухоли, обнадёживающие результаты даёт лазерная терапия и криодеструкция. Появились сообщения о суперселективной эмболизация питающих гемангиому сосудов и последующая терапия сверхвысокочастотными токами, результаты оценены как обнадёживающими. Для предотвращения рецидивов данной опухоли при любом виде лечения необходимо полное ее удаление, а это возможно, только когда до вмешательства хирург имеет исчерпывающие данные о характере роста этой опухоли.

Для диагностики опухолей мягких тканей на современном этапе широко используются ультразвукография и магнитно-резонансная томография.

Под нашим наблюдением находились семь больных, из них мужчин было 3 и женщин 4 человек. У всех больных гемангиома была одиночная. Гемангиома локализовалась в коже и подкожной жировой клетчатке у 5 больных и у 2 больных межмышечно-межфасциально. По анатомическим областям опухоль локализовалась в области бедра, голени, голеностопного сустава, лучезапястном суставе и в области спины.

Для визуализации гемангиом нами в начальных этапах исследования использовалась ультразвукография с доплерографией образования. При необходимости прибегали к магнитно-резонансной томографии. Ультрасонография проводилась датчиками с частотой от 7,5 до 12 МГц, по стандартной методике в продольной и поперечной проекциях. В силу наличия различия по отражающей способности опухоли и окружающих мягких тканей возникает дифференцированная визуализация изучаемых объектов. Результате сонографии получены следующие характеристики сосудистой опухоли. Форма опухоли была округлая у 2 больных, овальная у 2 больных и у 3 больных установлена неправильная форма. Сонография позволяет установить размеры сосудистой опухоли, у исследуемых больных размеры опухоли составляли от одного до 5-6 см. Структура опухоли по данным сонографии однородная у 1 больного и у остальных неоднородная. Неоднородность структуры обусловлено наличием анэхогенных, гипэхогенных образований. Стенки сосудов, соединительная ткань визуализировались в виде гиперэхогенных линейных структур в толще опухоли. Контур опухоли были четкими и ровными у 3 больных и неровными у 4 больных. Эхогенность была пониженной у 3 больных и остальных была смешанной. Наличие капсулы установлена у 3 больных, у 4 больных четко установить наличие капсулы не удалось. У больных с сосудистыми опухолями обязательным компонентом исследования является проведение доплерографии сосудов. Допплерография позволила выявить наличие сосудистой сети в опухоли, установить наличие кровотока, его скорость и направление, что позволило провести дифференциальную диагностику. Важным моментом диагностики сосудистых опухолей является диагностика рецидива. Под нашим наблюдением находились две больных с рецидивом опухоли, соно-доплерография позволили установить рецидив опухоли. Таким образом, при диагностике сосудистых опухолей мягких тканей методы сонографии играют решающую роль как в диагностике, дифференциальной диагностике и выборе объема хирургического вмешательства.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОНОСКОПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Кленин В.В.

Центр авторской медицины, г. Алматы

Ценность колоноскопии в диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний толстой кишки не вызывает сомнения. На фоне урбанизации и старения населения мира отмечается значительный рост заболеваемости колоректальным раком. В связи с этим, колоноскопия, как метод диагностики предраковой патологии, неспецифической патологии кишечника и рака имеет неоспоримые объективные преимущества перед другими диагностическими методами (Никифоров Н.Н. и соавт., 2000г.).

Показанием к колоноскопии служат появление и манифестация клинических признаков, прямо или косвенно указывающих на поражение толстой кишки, а также наличие известных факторов риска по развитию злокачественных заболеваний, включающих, помимо прочих, возраст больных, превышающий 50 лет. Однако, ограничению внедрения колоноскопии в

амбулаторную практику препятствовали относительная техническая сложность проведения манипуляции и возможность развития тяжелых побочных эффектов и осложнений.

В Центре авторской медицины г.Алматы, мы проводим колоноскопическое исследование амбулаторным пациентам с 2007 года. Подготовку кишечника к олоноскопии проводим лаважным методом с применением препарата «Фортранс». Благодаря макроголю, который не метаболизируется и не всасывается в кишечнике, достигается эффективный лаваж при пероральном приеме, не сопровождающийся существенными побочными явлениями. Опыт апробации препарата, при которой к исследованию готовились пациенты с различными формами поражения толстой кишки, включая воспалительные заболевания и опухоли, подтвердил его высокую эффективность, позволяющую полностью обследовать всех пациентов и получить хороший и отличный результат в 90% случаев. При этом развития метаболических нарушений и ухудшения состояния пациентов отмечено не было. «Фортранс» является средством выбора для подготовки к колоноскопии и эндоскопическим операциям и широко применяется в повседневной практике, пользуясь доверием врачей и больных.

Медикаментозное сопровождение колоноскопии в большинстве случаев не проводится. При необходимости коррекции психологического дискомфорта, возникающего у пациентов в связи с этой процедурой перед процедурой части больных назначается спазмолитические и обезболивающие препараты (например, но-шпа, кетонал).

За 3 года (май 2007- август 2010 г.г.) нами проведено 210 исследований толстой кишки. Возраст пациентов был различным – от 18 до 75 лет. Преобладали мужчины – 162 (77,1%).

В результате анализа полученных данных полипы и полиповидные образования толстой кишки выявлены у 38 пациентов (18,1%), рак толстой кишки у 8 (3,8%), НЯК и болезнь Крона у 11 (5,2%). У мужчин и женщин полипы были обнаружены в 47% и 18% случаев соответственно. Вероятность выявления полипов возрастала от 15% в возрастной группе до 50 лет до 48% у лиц старше 70 лет, средний возраст больных составлял 64,2 года.

Таким образом, амбулаторная колоноскопия является важным методом в диагностике заболеваний толстой кишки, выявления предраковой патологии и рака прямой и ободочной кишки и имеет перспективы внедрения в поликлинические учреждения РК.

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС.

Хан О.Р., Сагиндыков ГА, Насипов Б.А.

НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы

Несмотря на многочисленные исследования в области влияния малых доз радиации, до настоящего времени нет четкого понимания процессов происходящих в организме и дальнейших последствиях данного воздействия. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения, учитывая широкое применение источников ионизирующего излучения в медицине, что приводит к дополнительному облучению, практически всего населения страны. В этой связи представляют научный интерес данные по изменению биохимических показателей в крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Целью настоящего исследования являлось изучение биохимического статуса при воздействии малых доз ионизирующего излучения в отдаленные сроки у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, их зависимость от различных дозообразующих факторов.

Материал и методы: в Республиканском госпитале инвалидов Отечественной войны (РГИОВ) проводилось обследование 129 ЛПА на ЧАЭС, которые были разделены на 2 группы в зависимости от расстояния до реактора, от времени

пребывания в зоне аварии на ЧАЭС. Возраст обследованных в момент обследования был в пределах 30-50 лет. У всех ликвидаторов исследовали сыворотку крови по следующим биохимическим показателям: общий белок, белковые фракции, активность ферментов (щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), гамма-глутамилтранспептидазы (γ -ГТП)). Исследования проводились по общепринятым методикам с использованием биохимического анализатора "Спектр" фирмы Abbot.

Результаты и выводы: анализ биохимических данных у обследуемых лиц в зависимости от расстояния до реактора показал, что концентрация общего белка и альбумино-глобулиновый (а/г) коэффициент не менялись, отмечается достоверное и стойкое повышение концентрации α -1, α -2, β -, γ -глобулинов во всех обследуемых группах относительно контрольных величин ($p < 0,05$ - $0,001$).

Исследование активности ферментов у ликвидаторов Чернобыльской АЭС показало достоверное повышение активности ЩФ в сыворотке крови по сравнению с контрольным уровнем. В зависимости от расстояния до реактора ферментативная активность АЛТ и γ -ГТП практически не отличается от контроля. Наблюдается достоверное повышение α -1, α -2, β -, γ -глобулиновых фракций ($p < 0,01$ - $0,001$) во всех группах облученных лиц.

Отмечается достоверное повышение активности ЩФ ($p < 0,01$ - $0,001$) и угнетение активности АСТ в группах с экспозицией свыше 1 мес. ($p < 0,01$ - $0,001$).

Таким образом, исследование биохимических показателей крови у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в зависимости от расстояния до реактора и времени экспозиции показали, что, несмотря на нормальные концентрации белка, альбумина и глобулинов, в целом отмечается диспротеинемия, характеризующаяся увеличением в основном содержания α -1, α -2-глобулинов в сыворотке крови, в то время как, β и γ -фракции глобулинов повышаются в меньшей степени. Полученные нами данные позволяют заключить, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС имеются определенные признаки дизадаптации биохимических процессов, которые обусловлены влиянием малых доз радиации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПРОЦЕССАХ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Махмудова Н.Э., Нигманова Н.А., Туйжанова Х.Х., Ходжаева Х.В.

*Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)*

Актуальность работы. Онкологические заболевания являются наиболее привлекательной и в то же время сложной областью изучения и применения цитокинов в качестве иммунотерапевтических средств. Многообразие биологических эффектов цитокинов, их ключевая роль как медиаторов взаимодействий в поддержании гомеостаза предполагают участие их во многих патологических процессах, в том числе и при злокачественных новообразованиях. Известно, что патогенез многих патологических процессов обусловлен нарушением баланса в системе цитокинов. Учитывая различного рода сведения о значительной роли цитокинов в развитии патологических процессов организма, представляется целесообразным исследование изменений цитокинового спектра при онкологических процессах.

Материал и методы исследования. Нами исследованы образцы сывороток периферической крови 54 женщин с раком молочной железы (РМЖ) со средним возрастом $54,2 \pm 4,5$ лет

с гистологически верифицированными злокачественными новообразованиями молочных желез, и 20 практически здоровых женщин аналогичного возраста. Сбор материала осуществлялся до проведения оперативных вмешательств, химио- и лучевой терапии. Все женщины РМЖ находились на III стадии заболевания.

Изучение цитокинового спектра в сыворотке периферической крови, включающий определение провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, а также интерферонов проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест», Россия, Новосибирск 2005-2009гг. Тест-системы основаны на сэндвич-методе твердофазного иммуноферментного анализа с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. Количественная оценка результатов проводилась с использованием программы на Excel 2008, отражающих зависимость оптической плотности от концентрации для стандартного антигена. Чувствительность метода при использовании данных тест-систем – $2-30$ пг/мл.

Наборы реагентов для определения TNF- α , ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и IFN- γ представляют собой комплект, основными реагентами которого являются моноклональные антитела к исследуемым цитокинам, сорбированные на поверхности лунок разборного полистирольного планшета. Наборы предназначены для количественного определения человеческих цитокинов в сыворотке периферической крови, плазме и в биологических жидкостях. Измерение оптической плотности в каждой лунке проводили с использованием автоматического фотометра для микропланшета при длине волны 450 нм.

Полученные результаты и их обсуждение.

Исследование уровней провоспалительных цитокинов у больных РМЖ выявило достоверное повышение концентрации TNF- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6 в сыворотке периферической крови. Значение TNF- α при РМЖ составило $26,44 \pm 3,50$ пг/мл, что было в 4,85 раза выше контрольных значений ($p < 0,001$).

Концентрация ИЛ-1 β в среднем у больных РМЖ составила $17,5 \pm 2,96$ пг/мл, тогда как в контрольной группе – $9,05 \pm 1,35$ пг/мл, что достоверно различалось между собой ($p < 0,05$). При этом, содержание ИЛ-1 β в группе больных РМЖ было повышено в 1,9 раза по сравнению с данными контрольной группы. Сывороточный уровень ИЛ-6 был повышен в группе больных РМЖ в 7,4 раза в сравнении со значением контрольной группы. Сывороточный уровень ИЛ-6 в группе больных РМЖ составил $32,8 \pm 2,90$ пг/мл, что достоверно различалось с данными контрольной группы, который составил $4,46 \pm 0,83$ пг/мл. Уровень IFN- γ в группе женщин РМЖ составил $6,30 \pm 0,82$ пг/мл, тогда как в группе контроля – $3,52 \pm 1,4$ пг/мл ($p > 0,05$).

Таким образом, выявлена активация провоспалительных цитокинов, причем достоверные различия между исследуемыми группами выявлены по содержанию ИЛ-1 β , TNF- α и ИЛ-6, которые идентифицируются в повышенных концентрациях в сыворотке периферической крови больных РМЖ.

Анализ противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови женщин РМЖ показал, что уровень ИЛ-4 в группе женщин РМЖ составил $6,55 \pm 1,68$ пг/мл, тогда как в группе контроля – $3,86 \pm 1,15$ пг/мл.

Так же, показано, что опухолевые клетки сами могут продуцировать такие цитокины как ИЛ-6, ИЛ-10 и TNF- α , которые являются ростовыми факторами, обуславливающими иммунорезистентность опухолевой ткани.

У женщин РМЖ уровень ИЛ-10 составил $14,85 \pm 2,04$ пг/мл, что достоверно различалось от значения нормы, которая составила $8,22 \pm 1,50$ пг/мл.

Таким образом, нами выявлен определенный дисбаланс в содержании про- и противовоспалительных цитокинов при РМЖ. Выявлены повышенные концентрации TNF- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6 в сыворотке периферической крови на фоне достоверного изменения уровня IFN- γ . По данным литературы известно, что активация выработки ИЛ-6 и TNF- α приводит

к супрессии Т-клеточное звено иммунитета, что клинически выражается иммунодефицитом

Анализ противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови больных РМЖ выявил достоверное повышение обоих цитокинов, вырабатываемых Тх2-клетками. Таким образом, баланс между про- и противовоспалительными цитокинами рассматривается как важнейший фактор, определяющий иммунопатогенез.

РОЛЬ МАРКЕРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э., Халимов Д.Ж. Арифходжаева М.Т.

*Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)*

Актуальность работы. За последние годы одним из наиболее перспективных направлений современной онкологии является изучение роли иммунной системы в патогенезе злокачественных опухолей и возможности применения иммунологических методов для их диагностики и лечения.

Материал и методы исследования. Нами обследованы 48 женщин раком молочной железы (РМЖ) со средним возрастом 52,7±6,6 лет. Все женщины были обследованы и госпитализированы в РОНЦ МЗ РУз в отделении маммологии. Сбор материала осуществлялся до проведения оперативных вмешательств, химио- и лучевой терапии. Все женщины РМЖ находились на III стадии заболевания.

Иммунологические исследования были проведены в лаборатории иммуноцитокринов Института иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан. Определение клеточного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ и CD56+), а также идентификация активационных маркеров лимфоцитов (CD23+, CD25+, CD38+ и CD95+) проводилась с использованием моноклональных антител в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Институтом иммунологии МЗ РФ и Институтом иммунологии АН РУз (2001г.) [5, 30].

Гуморальное звено иммунитета оценивали путем определения основных сывороточных иммуноглобулинов IgG, IgA и IgM методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини (1969) с помощью набора моноспецифических сывороток против IgG, IgA, IgM производства НИИ ЭМИЗ им. Гамалея (РФ, Москва).

Результаты исследования и обсуждение. Экспрессию Т-клеточных маркеров лимфоцитов определяли по относительному числу CD3+ Т-лимфоцитов, CD4+ Т-хелперов/индукторов и CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов, а также по значению соотношения CD4+/CD8+ (иммунорегуляторный индекс – ИРИ).

Количество лейкоцитов в группе больных РМЖ составило 5275,8±236,5 кл/мкл, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 6500±295,0 кл/мкл ($p<0,05$).

К фенотипическим маркерам Т-лимфоцитов относятся CD3+, CD4+, CD8+ рецепторы.

Анализ Т-клеточного звена иммунитета показал, что число CD3+Т-лимфоцитов в группе больных РМЖ составило 47,66±1,83% против 59,4±1,48% значения нормы ($p<0,05$).

Соотношение CD4+/CD8+ (ИРИ) было достоверно подавлено в сравнении со значением контрольной группы в 1,8 раза ($p<0,05$). Размах индивидуальных значений ИРИ у больных РМЖ колебался от 0,4 до 1,14, но у большей части пациентов ИРИ составило ниже 1,0. Далее, нами изучена количественная характеристика циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке периферической крови больных РМЖ, который позволил выявить достоверное повышение 4% ЦИК, оказывающих патогенное влияние на сосуды и

ткани организма. Так, 3% ЦИК и 4% ЦИК были повышены в 1,8 и 2,99 раза относительно данных контрольной группы.

Из маркеров активации лимфоцитов, нами изучена экспрессия CD23+, CD25+, CD95+ FAS/APO-1 и CD38+ на лимфоцитах.

Экспрессия CD25+ на лимфоцитах у больных РМЖ отличалась в 1,1 раза от данных контроля.

Экспрессия CD95+ на активированных лимфоцитах у больных РМЖ была достоверно повышена по сравнению со значением контрольной группы ($p<0,05$). Экспрессия активационных маркеров CD38+ на лимфоцитах в группе больных РМЖ характеризовалась достоверным повышением против показателей группы контроля.

Таким образом, клеточный иммунитет у больных РМЖ характеризовался некоторыми особенностями: выраженный Т-клеточный иммунодефицит, который проявился дефицитом CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне повышенного числа CD8+Т-лимфоцитов. Естественные факторы защиты характеризовались повышенной активностью экспрессии CD16+ и CD56+ на натуральных киллерах. Маркеры активации лимфоцитов характеризовались повышением экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РМЖ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э., Джахангирова М.О., Мирзаева Н.Т.

*Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)*

Актуальность работы. Установлено, что любые патологические процессы в организме в первую очередь, затрагивают мембраны клеток, вызывая нарушения их биофизических параметров. Изменение липидного состава мембран клеток, в частности клеток иммунной системы, ведет к изменению экспрессии рецепторов, к активации или ингибции функций иммунокомпетентных клеток. Использование флуоресцентных зондов позволяет исследовать некоторые физические параметры поверхностных мембран лимфоцитов.

Материал и методы исследования. Нами были проведены исследования по изучению микровязкости и заряда поверхностных мембран лимфоцитов у больных РМЖ. Исследования проводились с помощью мембранного флуоресцентного зонда 1,8-АНС 1-N-фениламино-нафтил сульфоната фирмы "Serva" Германия.

Изучены поверхностные мембраны лимфоцитов периферической крови у 22 больных РМЖ и 20 здоровых лиц аналогичного возраста и пола.

Микровязкость и заряд поверхностной мембраны лимфоцитов оценивали по величине максимальной флуоресценции с помощью флуоресцентного зонда 1,8-АНС. Увеличившийся по сравнению с контролем уровень максимальной флуоресценции АНС, свидетельствовал о снижении поверхностного заряда мембран лимфоцитов, выделенных из периферической крови больных. Снижение максимальной флуоресценции указывало на повышение суммарного отрицательного заряда поверхностной мембраны лимфоцитов. Сдвиг максимума в спектре флуоресценции АНС в длинноволновую область свидетельствовал о снижении микровязкости поверхностной мембраны лимфоцитов.

Результаты исследования и обсуждение. В группе здоровых высота максимальной флуоресценции составила 85,2±8,11, тогда как у больных данный показатель был равен 42,4±5,30, что достоверно различалось между собой. Высота максимальной флуоресценции у больных РМЖ была в 2 раза снижена от значения нормы. Так, исследование

заряда поверхностных мембран лимфоцитов выявило, что суммарный отрицательный заряд на мембране лимфоцитов был значительно увеличен у больных РМЖ. У здоровых лиц микровязкость мембран лимфоцитов составила $474,5 \pm 1,01$ нГ, тогда как в группе больных РМЖ этот показатель составил $463,2 \pm 1,27$ нГ, что достоверно различалось с данными контрольной группы ($p < 0,001$).

Таким образом, отклонение длины волны максимальной флуоресценции в коротковолновом диапазоне указывало на повышение микровязкости поверхностных мембран лимфоцитов крови, что свидетельствовало о приобретении ими более жестких и менее пластических свойств. Жесткость мембраны лимфоцитов крови указывало на угасание метаболических процессов в мембране клетки, тем самым, затрудняя активацию иммунокомпетентных клеток, процессы распознавания ими своих или чужих клеточных рецепторов, что, в конечном итоге, приводило к формированию неадекватного иммунного ответа.

Флуоресцентные зонды могут выявлять дефекты, локализующиеся на уровне функционирования мембранных структур клеток. С их помощью можно выявить нарушение нормальной реакции лимфоцитов на уровне барьерной, транспортной, рецепторной, ферментативной систем. С помощью зондов АНС можно изучить физико-химическое состояние мембран лимфоцитов при параллельном изучении их поверхностного фенотипа. Было установлено, что эффективный суммарный поверхностный заряд мембраны, образуя электрическое поле, служит барьером для проникновения в клетку анионов и одновременно влияет на способность поверхностной клеточной мембраны принимать участие во всевозможных взаимодействиях. Следовательно, использование флуоресцентных зондов представляет большой интерес, так как дает возможность диагностировать нарушения в иммунной системе на уровне тонких биофизических процессов, происходящих в клеточной мембране иммунокомпетентных клеток при злокачественных новообразованиях. Кроме того, оценка поверхностного заряда и микровязкости мембран лимфоцитов периферической крови могут быть использованы для определения иммунодефицитного состояния при РМЖ и установления степени тяжести, а также прогрессирования заболевания.

Таким образом, нами выявлены статистически значимые изменения биофизических параметров поверхностных мембран лимфоцитов, характеризующиеся усилением электрического поля и повышением микровязкости, очевидно приводящие к исчезновению или ослаблению межклеточных взаимодействий.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Иембергенов А.И., Сатыбалдина Р.М., Наинбаева М.С.,
Алмагамбетова К.А., Каргабаев С.Х.*

В диагностическом центре г.Алматы начиная с 2001 г. по август месяц 2010 года обратилась за помощью 12704 женщины с заболеваниями молочной железы т.е. клинически с разными формами фиброзно-кистозной болезнью, из них у 494 женщин диагностировано фиброаденома, а у 153 женщин рак молочной железы. Рак молочной железы установлен путем применения УЗ-исследования, маммография с пункционной биопсией опухоли с морфологическим исследованием. Больные с установленным диагнозом рак молочной железы были направлены на лечение в онкологический диспансер.

В противораковой борьбе наряду с ранней диагностикой злокачественных опухолей не меньшее значение имеет своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний молочных желез у женщин.

К предопухолевым заболеваниям молочных желез прежде всего относятся различные варианты дисплазии молочных желез, более известная как, фиброзно-кистозная мастопатия и является одним из основных заболеваний молочных желез,

относящихся к потенциальным источникам развития рака молочной железы. По определению ВОЗ (1984 г.) она представляет собой комплекс процессов, характеризующихся широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений фиброзного, кистозного, пролиферативного характера. Различают непролиферативную и пролиферативную форму фиброзно-кистозной болезни. При этом риск малигнизации при непролиферативной болезни форме составляет 0,86 %, при умеренной пролиферации – 2,34 %, при резко выраженной пролиферации – 31, 4 %. По данным гистологических исследований операционного материала, рак молочной железы сочетается с фиброзно-кистозной болезнью в 46 % случаев.

Общепризнано, что фиброзно-кистозная болезнь является следствием дисгормональных расстройств в организме женщины.

Клинически фиброзно-кистозная болезнь подразделяется на диффузную, диффузно-узловую, фиброзно-кистозную и узловую формы, которые по сути являются разными этапами одного процесса.

Диагностика заболеваний молочной железы основывается на осмотре молочных желез, их пальпации, маммографии, УЗИ, пункции узловых образований, подозрительных участков и цитологическом исследовании пунктата.

Прежде чем приступить к исследованию молочных желез у женщин в детородном возрасте, необходимо уточнить, в какой фазе менструального цикла они находятся и поэтому, целесообразно исследовать молочные железы в 1 фазе цикла – на 2-3-й день после окончания менструации, т.к. во 2 фазе из-за нагрубания желез велика вероятность диагностических ошибок.

Для диагностики заболеваний молочных желез у женщин немаловажное значение имеет осмотр и пальпация молочных желез, сначала в положении больной стоя, а затем лежа на спине. Одновременно пальпируются подмышечные, подключичные и надключичные лимфатические пути. Врач оценивает внешний вид желез, обращая внимания на все проявления асимметрии (контуры, окраски кожи, положения сосков и т.д.).

Результаты УЗ-исследования молочных желез зависят от уровня квалификации врача и технических параметров используемого УЗ-сканера и УЗ-датчиков. УЗ-исследования широко применяются на практике. Этот метод безвреден и хорошие данные получены при исследовании молочных желез у молодых женщин, а также в выявлении кист, в том числе и мелких (диаметром 2—3мм) и помогает дифференциальную диагностику между кистами и фиброаденомами. Тем не менее, ультразвуковой метод диагностики имеет ряд недостатков, не позволяющих использовать его как единственный или первичный метод исследования, т.к. примерно 30% раков не выявляются при ультразвуковом обследовании.

В настоящее время кроме УЗ-исследования наиболее распространенным методом является – маммография. Достоверность его высокая, на снимках можно определить около – 81-96% всех патологических изменений, а при раке молочных желез она достигает 95%, причем этот метод позволяет выявлять доклинические т.е. непальпируемые (менее 1см в диаметре) опухоли.

Рентгенологическое исследование молочных желез проводится в специальном кабинете на рентгеновской установке – маммографе с биопсийной приставкой Alpha ST, производство Финляндия, 2004 года выпуска. Данный рентгеновский аппарат функционирует в диагностическом центре начиная с 2006 года. За это время в центре рентгенологическое исследование молочных желез произведено у 2716 женщин.

Огромное внимание уделяется качеству производства снимков, что позволяет получить высококачественные снимки.

Рентгенологические изображения молочной железы чрез-

вычайно вариабельно и многогранно. Прямыми рентгеновскими признаками рака молочных желез являются наличие тени самой опухоли и характерных для злокачественного заболевания кальцинатов.

Симптом лучистой тени хорошо известен и его интерпретация обычно не представляет сложностей. Чаще всего такая тень отражает инфильтративное распространение злокачественной опухоли. Обызвествление при раке молочной железы напротив, отражает внутривнутри протоковый неинфильтративный рост раковых клеток, в связи с чем интерпретации характера кальцинатов придается все большее значение.

В случае, если подозрительная тень, определяемая на маммограмме, не пальпируется и не выявляется при ультразвуковом исследовании и соответственно диагноз не может быть верифицирован морфологически при пункции под ультразвуковым контролем, выполняется пункционная биопсия под рентгенологическим контролем – так называемая стереотоксическая приставка для пункционной биопсии.

Маммография обладает высокой чувствительностью и она не заменима при диагностике не пальпируемых форм рака молочной железы. За это время пяти случаях нам удалось во время маммографии диагностировать рак молочной железы при отсутствии клинического проявления. Рентгеновскими признаками были наличие тени образования с неровными лучистыми контурами и хаотично расположенными микрокальцинатами внутри. У большинства из них патология выявлялась на фоне имевшей место фиброзно-кистозной мастопатии. Эти больные в течение 3 лет наблюдались у маммолога и ограничивались только УЗ-исследованиями молочных желез, они получили лечение по поводу диффузно фиброзно-кистозной мастопатии. Для уточнения диагноза им произведена пункционная биопсия с последующим морфологическим исследованием пунктата с образования. Они затем продолжали лечение в условиях онкологического диспансера. Таким образом, маммография является эффективным методом позволяющим повысить диагностическую точность опухолей молочных желез в сочетании с другими методами комплексного исследования.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКСОМ СЕРДЦА

Енин Е. А., Адильгиреева Л. Х.,
Решетина Н. В., Елеубаева Ж. Б., Баталова К. С.
Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А. Н. Сызганова.

Цель: миксомы сердца относятся к редкой онкопатологии. Диагностика первичных доброкачественных новообразований сердца до настоящего времени представляет интересную и трудную задачу. Выявляемость их у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет, что связано с улучшением дооперационной диагностики. Клинически опухоли сердца диагностируются у 5-10 % (Wengen N. 1978) больных. Среди доброкачественных образований сердца наиболее часто встречаются миксомы (75-80%).

Материалом: для исследования послужили 24 случая миксом сердца находившихся на лечении в ННЦХ им. А. Н. Сызганова с 2006 по 2010 гг.

Материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). Кусочки заливались в парафин. Парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрон. Стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция

Для электронномикроскопического исследования кусочки миксомы фиксировались в 2,5% растворе глутаральдегида с

посфиксацией в 1% растворе четырехоксида осмия. Проводку материала выполняли по общепринятой методике и заключили в ЭПОН-812, полутонкие и ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме «Reichert» (Австрия). Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольду и просматривали с помощью электронного микроскопа ЭВМ-100Л при ускоряющем направлении 75 кВТ.

Результаты: мужчин было 10 (41,6%), женщин 14 (58,3%). Возраст больных колебался от 8 лет до 70 лет. В 19 (79,2%) случаях миксомы располагались в левом предсердии, а в 4 (16,6%) случаях – в правом предсердии. В желудочках сердца они встретились только в 1 (4,2%) случае. Миксомы исходили из стенок межпредсердной перегородки, ушка левого предсердия и области овальной ямки. Макроскопически опухоли имели округлую, овоидную или дольчатую форму. В зависимости от консистенции миксомы были плотными или мягкими, желеобразными. Размеры их колебались от 2 см до 8 см. Вес достигал 81,2 г. На разрезе цвет варьировал от желтовато-бурого до красного. При микроскопическом исследовании миксом на фоне бесструктурной аморфной массы располагались опухолевые клетки звездчатой, полигональной или вытянутой формы с удлинённым ядром. В ней встречались сосуды капиллярного типа, поля фиброза, очаги кальциноза. Электронно-микроскопическое исследование выявило эндотелиальную природу и выраженный структурный полиморфизм, связанный с макроскопической формой и стадийностью развития опухоли. При этом несомненный интерес представляла ультраструктурная характеристика цитодифференцировки эндотелиальных клеток в миксомах, а также особенности секреторного процесса в единичных, симпластических и сосудистых формах миксомальных клеток.

Выводы: Проведенные исследования показали, что наиболее часто среди доброкачественных опухолей сердца встречаются миксомы (100%), которые в 79,2% располагались в левом предсердии.

ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Енин Е. А., Адильгиреева Л. Х.,
Елеубаева Ж. Б., Решетина Н. В.

Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А. Н. Сызганова

Цель: гистологическое исследование биоптатов печени имеет большое значение, так как при многих заболеваниях оно не только устанавливает диагноз, но и позволяет судить об этиологии заболевания, его активности, эффективности лечения и прогнозе.

Материалы и методы исследования: нами была изучена эффективность чрезкожной пункции печени под ультразвуковым контролем за период с 2006 по 2010 гг. В клинике наблюдалось 125 больных с различными поражениями печени. Из них мужчин было 65 (52%), женщин 60 (48%). Взятый материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). В проводке кусочки заливались в парафин. Готовые парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрон. Готовые стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция. Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином (С. Humphrey, F. Pittman, 1974). Препараты просматривались на световом микроскопе «Leica» DMLS 4000B с цифровой камерой Leica DFC 320 (Германия).

Результаты: возраст больных колебался от 14 до 73 лет. В 79 (63,2%) случаях нами были выявлены хронические гепатиты вирусной этиологии, альвеококкоз и хронический абсцесс (0,8%), цирроз печени в 4 (3,2%) случаях, тесарисомы (бо-

лезнь Кори и Гирке) в 2 (1,6%) и доброкачественные опухоли печени (кавернозные гемангиомы) в 3 (2,4%) случаях.

Злокачественные опухоли печени были обнаружены в 28 (23,2%) случаях. Средний возраст больных со злокачественными опухолями печени составил 59 лет. Среди них женщин было 11 (39,3%), мужчин 17 (60,7%). Первичный гепатоцеллюлярный рак относится к наиболее распространенным злокачественным опухолям. Он встретился у нас в 11 (39,3%) случаев, холангицеллюлярная высококодифференцированная аденокарцинома была обнаружена в 3 (10,7%) случаях. В остальных 14 (50%) случаях мы обнаружили метастазы опухолей в ткани печени из почек, надпочечника, желудка и поджелудочной железы. При микроскопическом исследовании гепатоцеллюлярного рака выявлены трабекулярный и солидный тип строения опухоли. Доброкачественные сосудистые опухоли мы обнаружили в 3 (2,4%) случаях у женщин, при этом были выявлены капиллярные гемангиомы. Во всех случаях среди этиологических и патогенетических факторов гепатоцеллюлярного рака наибольшего внимания заслуживают вирусные гепатиты, алкоголизм, цирроз печени, нарушения метаболизма. Изменения подобного характера нами обнаружены в 86 (68,8%) случаях. Из 79 случаев хронического гепатита в крови больных вирус В был обнаружен в 3 (3,8%) случаях, и вирусный гепатит С в 3 (3,8%) случаях. Неинформативный материал был получен только в 5 (4%) случаях.

Выводы: наши наблюдения показали, что пункции печени под УЗИ контролем позволяет показать возможность клинической морфологии в диагностики заболеваний печени. Метод является малотравматичным и позволяет установить точный диагноз.

О НАРУШЕНИЯХ В СИСТЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТочНОГО ЦИКЛА И ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕВОГО ФЕНОТИПА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Ермекова С.А.
Каз. НИИ ОиР МЗ РК*

Молекулярно-генетические исследования нарушений генов регуляции клеточного деления позволяют выявлять мутационные изменения в онкогенах и супрессорах опухолевого роста и в настоящее время используются для диагностики и прогнозирования течения злокачественного процесса при некоторых локализациях у онкобольных.

Целью исследования было выявление особенностей мутационных изменений в некоторых генах или продуктах их экспрессии при плоскоклеточном раке легкого.

Объектом исследования являлись опухолевые и прилегающие к ним нормальные ткани в послеоперационном материале, взятом от больных с плоскоклеточным раком легких человека. Применялись методы очистки ДНК и мРНК, ПЦР-амплификация фрагментов гена p53, критических локусов Ha-ras, ревертазная реакция для синтеза кДНК на мРНК, рестрикционный анализ нуклеотидных замен в ПЦР-продуктах фрагментов некоторых генов.

Экспрессия гена p53 в виде мРНК выявляется с помощью ПЦР с той же частотой, с какой обнаружены 5-6 экзон-интронные фрагменты этого гена в ДНК плоскоклеточного рака легкого, а именно: в 57 % образцов, а в прилегающих к опухоли тканях эти фрагменты мРНК обнаружены лишь в 28,6% образцов. Дополнительным рестрикционным анализом во всех амплифицированных образцах мРНК p53 из плоскоклеточного рака легкого обнаружили миссенс-мутации с Pst1 и EcoR1-узнаваемыми сайтами. Таким образом, с помощью ПЦР и рестрикции в 100% образцов плоскоклеточного рака выявлены те или другие мутации в последовательности мРНК p53. В прилегающих к опухоли тканях мутации в мРНК

гена p53 (с подавлением экспрессии гена p53 в 71% и без подавления в 14,7%) обнаружены в 85,7% исследованных образцов по негативной ПЦР или после рестрикции полученных ПЦР-продуктов. Фрагмент гена Ha-ras с 12 кодоном мутировал в 100% исследованных опухолей, из которых в 28,6% образцов мутации выявлены по негативной ПЦР и в 71,4% - рестрикционным анализом. Фрагмент гена Ha-ras с кодоном 61 мутировал в 85% образцов опухолей и в 66,7% образцов прилегающей ткани по результатам ПЦР, рестрикционный анализ ПЦР-продуктов не обнаружил Pst1- и EcoR1- миссенс-мутаций. Значительный процент мутационных нарушений во фрагментах гена Ha-ras с 12 и 61 кодонами (100% и 85%) позволяет говорить о причастности их к опухолевой трансформации клеток эпителия легкого. Обнаружены мутации мРНК MDM2 во всех образцах плоскоклеточного рака, из них: в 16,7% опухолей – по негативной ПЦР и в 83,3% - после рестрикции с помощью Pst1 и EcoR1 рестриктаз. С помощью ревертазной ПЦР в половине образцов плоскоклеточного рака легкого и в 20% прилегающих к нему тканей обнаружена индукция экспрессии гена p21WAF1, последующий рестрикционный анализ с помощью Pst1 и EcoR1 не выявил миссенс мутаций.

Таким образом обнаруженные мутации в центральном домене гена p53, во фрагментах гена Ha-ras с 12 и 61 кодонами и показатели индукции экспрессии мРНК генов p53, MDM2 и p21WAF1 дают нам достаточно точную информацию о нарушениях системы регуляции клеточного цикла и причинах возникновения опухолевого фенотипа, что имеет большое диагностическое и прогностическое значение при выборе тактики лечения и дальнейшем наблюдении за состоянием пациента по сдвигам этих показателей в образцах тканей, мазках, биоптатах, крови и другом материале, взятом у пациентов после лечения.

МУТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ГЕНАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ЭКСПРЕССИИ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЛЕГКОГО

*Ермекова С.А., Кабиева А.О.
Каз. НИИ ОиР МЗ РК*

Мутационные нарушения в генах регуляции клеточного деления могут приводить к опухолевой трансформации в клетках различных тканей и органов. Молекулярно-генетические методы исследования позволяют выявить такого рода изменения в протоонкогенах и супрессорах опухолевого роста и в настоящее время используются для диагностики и прогнозирования течения злокачественного процесса при некоторых локализациях у онкобольных.

Целью исследования было выявление особенностей мутационных изменений в некоторых генах или продуктах их экспрессии при аденокарциномах легкого. Объектом исследования являлись опухолевые и прилегающие к ним нормальные ткани в послеоперационном материале, взятом от больных с аденокарциномой легких. Применялись методы выделения, очистки ДНК и мРНК, ПЦР для амплификации фрагментов гена p53, критических локусов Ha-ras, ревертазная реакция для синтеза кДНК на мРНК, метод электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном геле, компьютерный анализ видеокопий электрофореграмм ПЦР-продуктов ДНК, рестрикционный анализ нуклеотидных замен в ПЦР-продуктах фрагментов некоторых генов.

В 75% образцов ДНК аденокарцином легкого обнаружили мутации во фрагментах гена Ha-ras с 12 кодоном и в 50% образцов – мутации во фрагментах с 61 кодоном гена Ha-ras. Большая часть мутаций в аденокарциномах была связана с появлением Pst1 или EcoR1-узнаваемых сайтов во фрагментах с 12 кодоном гена Ha-ras, тогда как фрагмент с 61 кодоном гена Ha-ras в большинстве образцов был делегирован, что выражалось в отсутствии ПЦР-продукта. мРНК

p53 и p21WAF1 выявлялась только в 50% образцов аденокарцином легкого и в 75% образцов прилегающих тканей, а мРНК MDM2 определялась в 75% образцов опухолей легкого и в 25% образцов прилегающих к ним тканей. Миссенс-мутации с заменой оснований в мРНК p53 и p21WAF1 обнаруживались в 25% образцов аденокарцином легкого и прилегающих к ним тканей по результатам рестрикционного анализа. Таким образом, индукция синтеза мРНК гена MDM2 наблюдалась чаще в аденокарциномах, чем в прилегающих тканях, а индукция экспрессии генов p53 и p21WAF1 - чаще в прилегающих тканях, что указывает на связывание белка p53 с его ингибитором, белком MDM2, которое приводит к разрушению белка p53 и подавлению экспрессии p21 WAF1. Белок p53 является транскрипционным фактором, стимулирующим активность ряда генов, в том числе активность гена белка p21 WAF1 – ингибитора комплексов циклинов с циклин-зависимыми киназами при повреждениях ДНК, что останавливает клеточный цикл до репарации повреждений ДНК или приводит к апоптозной гибели клетки. Кроме того, белок p21 WAF1, связываясь с белком PCNA, подавляет репликацию ДНК, тому же способствует и активация ряда других генов, находящихся под контролем белка p53, такими как ген GADD45. Мутации в генах p53 и p21 WAF1 чаще приводили к подавлению их экспрессии в аденокарциномах, чем в прилегающих тканях, повышенная экспрессия гена белка MDM2 еще больше усугубляла положение, снижая уровень белка p53, и тем самым способствуя бесконтрольному размножению клеток опухоли с мутационными повреждениями в отдельных участках ДНК. Стимуляция клеточного деления в аденокарциномах легкого также была обусловлена мутациями в отдельных кодонах гена Ha-ras. Мутантная форма белка Ha-ras постоянно находится в активном состоянии из-за утраты ГТФазной активности, это приводит к передаче сигнала на каскады митогенактивируемых протеинкиназ независимо от уровня регуляторной активности ростовых факторов или протеинкиназы C. В заключение следует подчеркнуть, что определение мутаций в ДНК фрагментах генов Ha-ras и p53, а также изучение экспрессионной активности некоторых генов - регуляторов клеточного деления (p53, p21WAF1 и MDM2) позволяет оценить уровень нарушений регуляции клеточного деления, что может быть полезным для установления причин опухолевой трансформации клеток.

УЗ-ДИАГНОСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Есмамбетова А.Г.

Центральная клиническая больница Управления делами
Президента РК г.Алматы.

Деформирующий остеоартроз коленных суставов является одной из наиболее частых форм дегенеративно-дистрофического поражения [1]. Причиной их развития являются такие факторы, как естественное старение организма, нарушение обмена веществ, наличие избыточной нагрузки (перегрузки) на сустав, а также травматическое повреждение.

Целью нашего исследования явилось выявление ранних УЗИ признаков дегенеративных изменений коленного сустава. Нами были обследованы 50 пациентов с различными стадиями развития деформирующего остеоартроза от 30 до 72 лет, из них было женщин 30 и 20 мужчин. Причинами развития поражения в 15 случаях были инволютивные изменения в сочетании с повышенной физической нагрузкой, в 20 - избыточная масса тела, у остальных 15 пациентов в анамнезе была травма.

Исследования проводились на ультразвуковом сканере по стандартной методике линейными датчиками 7,5-10 МГц

в В-режиме, а также доплерография для дифференциации субстрата поражения. Оценивались суставная щель, покровный хрящ на всем протяжении, связочный аппарат, суставная сумка, мениски, суставные завороты, синовиальная оболочка и подколенная ямка.

В начальных стадиях гонартроза ультразвуковое исследование (УЗИ) выявляло отчетливые признаки деформации суставного хряща и субхондральной пластины на ограниченных либо более обширных участках, прослеживалось неравномерное сужение суставной щели, в 28 случаях синовиальная оболочка была диффузно либо локально утолщена от 1,5 до 8 мм, а в заворотах лоцировалось небольшое количество свободной жидкости. При ультразвуковой доплерографии лоцировалась повышенная васкуляризация в утолщенной синовиальной оболочке. Прослеживалась очевидная связь между длительностью поражения и изменениями менисков, которые были деформированы, уплощены. При наличии в анамнезе травмы ультразвуковые признаки изменения суставной поверхности, как правило, сочетались с повреждениями менисков [2-3]. У 13 больных выявились кисты Беккера, локализованные в подколенной ямке чаще с внутренней стороны в виде выпячивания утолщенной и ригидной синовиальной оболочки. У некоторых пациентов кисты были многокамерными. В 8 случаях обнаруживалась суставная «мышь» в виде подвижной экзогенной тени в проекции суставной щели.

Резюме.

Таким образом, методика УЗИ сканирования позволяет быстро и достоверно определять не только ранние признаки деформирующего остеоартроза, но и существенно расширяет диагностические возможности при изменениях мягкотканых элементов сустава. Ультразвуковая сонография обеспечивает распознавание дегенеративного поражения в начальной стадии развития, что делает лечение своевременным и эффективным.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Жумашева А.В., Кубенова Г.И., Дюсембеков С.Т.,
Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет им. М. Оспанова, кафедра онкологии с
курсом лучевой терапии и лучевой диагностики и ЛОР-
болезней, г.Актобе.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) сохраняет лидирующее положение среди всех злокачественных опухолей у женщин. К 2010 г. прогнозируется рост заболевания до 1,45 млн. человек [1]. В Республике Казахстан данная патология занимает I место, составляя 19,6 на 100 000 женского населения, II место среди всех злокачественных опухолей и III место в структуре смертности от них. В настоящий момент одним из перспективных прогностических факторов является определение уровня экспрессии в опухоли онкогена HER2/neu, который отвечает за продукцию трансмембранного протеина HER2 с рецепторными функциями. Гиперэкспрессия HER2/neu в ткани рака молочной железы обнаруживается у 25-30% больных и является независимым прогностическим маркером течения болезни и эффективности проводимого лечения. Гиперэкспрессия этого онкогена у больных раком молочной железы ассоциируется с плохим прогнозом и малой чувствительностью к тамоксифену.

Цель. Изучение содержания биологических маркеров в тканях опухоли больных раком молочной железы иммуногистохимическим методом с целью проведения лекарственной терапии и дальнейшего прогнозирования.

Материалы и методы обследования. С августа 2008 года в ЗКГМУ им. Марата Оспанова начала работу иммуноги-

стохимическая лаборатория по определению маркеров при раке молочной железы. Основу исследования составили 48 женщин с морфологически верифицированным первичным диагнозом рак молочной железы в возрасте от 23 до 78 лет, из них у 5 больных исследовали результаты лечения после проведенной неоадьювантной полихимиотерапии.

При анализе результатов исследования видно, что отрицательный герцептин статус обнаружен в 18 (37,5%) случаях и больше всего в возрасте 50 - 59 лет. В 17 (35,4%) случаях выявлены 2+ в возрасте 40-49 и 50-59 лет. Высокая гиперэкспрессия белка Her-2(neu)(+++), наиболее выражена у больных в возрасте 40-49, 50-59 лет и составила 10 (20,8%) больных, что сопоставимо с данными литературы. Высокая экспрессия РЭ и РП также выражена в данных возрастных группах, что отмечено в 18 (37,5%) случаях.

Заключение. Таким образом, благодаря введению в клиническую практику методов иммуногистохимического определения биологических маркеров, появилась возможность определения прогноза течения рака молочной железы и проведения таргетной терапии Герцептином (транстузумаб), что способно в значительной степени улучшить результаты лечения и увеличить безрецидивный период жизни больных. Присутствие же в опухолевой ткани больных раком молочной железы рецепторов эстрогена и прогестерона является важным фактором, так как указывает о чувствительности к гормонотерапии и принадлежности к высокодифференцированной опухоли и о низком риске метастазирования. Результаты лечения будут доложены в последующих публикациях.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ РЕТРОГРАДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Меньшикова И.Л., Арзыкулов Ж.А.,
Коростелева О.В. Жакенова Ж.К., Лашкул С.В.
КазНИИОиР

Диагностика рака поджелудочной железы и на сегодняшний день остается сложной проблемой. Широкодоступным и достаточно информативным является ультразвуковое исследование. Наиболее распространенным методом в настоящее время является компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Однако наиболее точным и информативным методом в отношении диагностики рака поджелудочной железы остается рентгенэндооскопическое исследование – ретроградная холангиопанкреатография.

Цель исследования: Улучшить диагностику и дифференциальную диагностику рака поджелудочной железы по данным ЭРХПГ с морфологической верификацией рака поджелудочной железы путем цитологического исследования аспирата сока поджелудочной железы.

Материал и методы исследования: Нами произведено сочетанное рентгенэндооскопическое исследование 92 пациентам с подозрением на опухоль поджелудочной железы.

Результаты: При этом успешная канюляция устья БДС была достигнута в 87 случаях (94,6%). У 4 больных введение катетера в Фатеров сосок было невозможным в связи с распространением и прорастанием опухоли в 12-перстную кишку и область папиллы, поэтому им была произведена биопсия для гистологического исследования. Во всех случаях морфологическое заключение – аденокарцинома. У 1 больного БДС располагался внутри дивертикула, в связи, с чем попытки катетеризации закончились безуспешно.

В остальных 87 наблюдениях нами успешно произведена катетеризация с контрастированием. Учитывая, что все пациенты были с подозрением на заболевание поджелудочной железы, основной задачей было контрастирование протоковой системы панкреас. В результате, визуализация обеих протоковых систем (желчевыводящих протоков и Вирсунгова

протока с ветвями) была достигнута у 76 пациентов (87,4%), только поджелудочной железы – у 11 (12,6%).

Для морфологической верификации нами произведен забор сока из протоков поджелудочной железы у 62 больных с последующим цитологическим исследованием. При этом, опухолевые клетки обнаружены в 21 (33,9%) случаях.

В результате анализа рентгенограмм, выделены следующие клинические формы рака поджелудочной железы:

1. Рак головки – 64 (73,5%)
2. Рак тела – 12 (13,8%)
3. Рак хвоста – 5 (5,8%)
4. Тотальное – у 6 (6,9%) пациентов.

На ретроградных рентгенограммах были выделены четыре основных вида изменений:

1. Блокада главного панкреатического протока;
2. Стенозирование протока, сочетающееся с патологическим супрастенотическим расширением;
3. Неровность контуров и сужение протока;
4. Аномальное строение ветвей панкреатического протока.

Заключение: Ретроградная холангиопанкреатография с аспирационной биопсией является высокоинформативным диагностическим методом, позволяющим установить точную локализацию, протяженность опухоли при раке поджелудочной железы, а во многих случаях путем взятия аспирата из панкреатического протока верифицировать диагноз.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЛИМОНИДИН В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

Наряду с поиском новых противоопухолевых препаратов активно разрабатываются подходы к модификации фармакологических эффектов уже известных лекарственных веществ. Препараты из растительного сырья, обладая широким спектром свойств, могут оказывать действие на различные звенья онкопатогенеза, а также являться модификаторами химио- и лучевой терапии.

Отечественный фитопрепарат Лимонидин представляет биологически активный комплекс из корней кермека Гмелина, содержит полифлаваны, флавоноиды, полисахариды, витамины, аминокислоты, фенольные кислоты, микроэлементы, получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Разработаны две жидкие лекарственные формы – «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп, выпущенные промышленным способом АО «Химфарм», г. Шымкент. Ранее нами были изучены противоопухолевые свойства субстанции лимонидина и комбинации ее с цитостатиками.

Цель исследования: изучить химиомодифицирующие свойства лекарственных форм фитопрепарата Лимонидин при сочетании с известными цитостатиками.

Материалы и методы.

Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных крысах (массой 120-160 г) и мышах белых беспородных и линии СВА (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосфамид вводили внутривенно, лимонидин – per os, использовали различные дозы и режимы введения препаратов. Противоопухолевая активность изучена по общепринятой методике на трансплантируемых опухолевых штаммах (опухоль Эрлиха, лимфосаркома Глисса, саркома 45). Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили изменение поведенческой реакции животных, гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

Результаты. Было показано, что лекарственные формы

лимонидина не проявляют значимого противоопухолевого действия (торможение роста опухоли от 14,4% до 33,2%), но они не вызывают стимуляцию роста экспериментальных опухолей, что является необходимым условием для модификаторов. При изучении комбинации лимонидина с известными цитостатиками на различных моделях перевиваемых опухолей выявлено, что исследуемые лекарственные формы лимонидина увеличивают противоопухолевый эффект 5-фторурацила на 12,4-28,2%, доксорубина – на 8,5-14,4%, циклофосамида – на 3-23,6%. В токсикологических исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимонидина и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонидина, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонидина до и после введения цитостатика. Наблюдается уменьшение гибели животных на 10-30%, при этом отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, нормализация показателя селезеночного коэффициента, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови.

Выводы. Лекарственные формы фитопрепарата из кермека Гмелина - «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп обладают потенцирующим действием при сочетании с цитостатиками (5-фторурацилом, доксорубином, циклофосамидом) на животных с экспериментальными опухолями, увеличивая противоопухолевый эффект. Применение настойки лимонидина снижает токсическое действие 5-фторурацила и доксорубина.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИМОНИДИНА КАК ПРОТЕКТОРА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О., Чичуа Н.А., Смагулова К.К.,

Аяпбергенова Г.О., Жусупова Г.Е.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

В настоящее время широко проводятся исследования по оптимизации действия противоопухолевых препаратов, коррекции их токсических проявлений. В этом плане широким спектром свойств обладают растительные препараты. Лимонидин - комплексный препарат получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби из корней кермека Гмелина - *Limonium Gmelinii* (Willd.) сем. *Plumbaginaceae*. Обладает противовоспалительным, противовирусным, гепатопротекторным действием. Две жидкие лекарственные формы - сироп и настойка лимонида производства АО «Химфарм» разрешены Фармкомитетом РК для клинического применения в качестве противовоспалительного средства в гастроэнтерологической практике.

Цель исследования: изучение возможности использования лимонида в качестве протектора, снижающего токсичность химиотерапии.

Материалы и методы. Токсикологические исследования проведены на белых беспородных мышах (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосамид вводили внутривенно, лимонидин – per os. Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

В клиническое исследование вошли 26 больных раком молочной железы, которым проводилось лечение в отделении химиотерапии КазНИИОиР. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа – больные, которым проводилась полихимиотерапия на фоне приема настойки лимонида – основная (14 больных), 2 группа – больные, получавшие стандартные курсы полихимиотерапии - контрольная (12 больных). В схемы лечения входили следующие цитостатики: цисплатин, 5-фторурацил, доксорубин, циклофосамид.

Результаты. В экспериментальных исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимонида и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика (уменьшение гибели животных на 10-30%, отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови).

Было проанализировано влияние лимонида на частоту токсических проявлений полихимиотерапии со стороны желудочно-кишечного тракта (наличие эметического синдрома) и гематотоксичности. При проведении полихимиотерапии у больных на фоне приема настойки лимонида эметический синдром встречался в 35,7% случаев, в то время как среди пациентов 2-й группы, получивших химиотерапию без лимонида, этот вид осложнения наблюдался гораздо чаще – в 66,7%, то есть применение лимонида у больных во время химиотерапии способствовало снижению гастроинтестинальной токсичности в 1,8 раз по сравнению с контрольной группой. Показатель гематологической токсичности в 1-й группе больных составил 42,9%. Во 2-й группе больных лейкопения наблюдалась у 5 (41,6%) пациентов. Степень токсичности в обеих группах была примерно одинаковой.

Выводы. В условиях эксперимента происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика. Применение лимонида у больных во время химиотерапии способствует снижению гастроинтестинальной токсичности.

СОЧЕТАННАЯ ИММУНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кенбаева Д.К., Макишев А.К., Манамбаева З.А.

Городской онкологический диспансер, г.Астана,

Государственный медицинский университет г.Семей

Актуальность: использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов лечения больных с различными злокачественными новообразованиями. По нашему мнению, одним из подходов к улучшению результатов применения данного метода может служить его использование на фоне неспецифической иммуностимуляции.

Цель: анализ клинических результатов применения сочетанной иммунотропной терапии у больных раком шейки матки.

Материалы и методы: всего обследовано 117 больных раком шейки матки, подвергавшихся специфической противоопухолевой терапии. В первую группу включены пациенты, получавшие только сочетанную лучевую терапию (СЛТ), во вторую – больные, получавшие сочетание СЛТ и специфической иммунотерапии (СИТ) по разработанной методике. В третью группу вошли больные, получавшие сочетание СЛТ, СИТ и неспецифической иммуномодуляции, заключавшейся в курсе системной энзимотерапии продолжительностью 1 мес. (препарат флогэнзим в дозе 3 таблетки 3 раза в день).

Результаты исследования: степень регрессии опухоли в значительной степени зависела от проводимого лечения. Так, наибольшее относительное число больных с наименьшей степенью регрессии (менее 50%) было выявлено при проведении только СЛТ, а регрессия объема более 75% наблюдалась только в 1/3 случаев против 75,0% - при сочетанной иммунотерапии и иммунокоррекции ($p < 0,05$). У больных III клин. стадии отмечалась аналогичная картина

– в одинаковом числе случаев наблюдалось уменьшение объема опухоли на 50% и 50-75%, и только 23,8% пришлось на максимальную степень клинической эффективности СЛТ. При дополнительном применении СИТ степень регрессии увеличивалась незначительно и статистически недостоверно, однако в большей части случаев отмечалась максимальная степень (более 75%) уменьшения объема опухоли и ее полная редукция. Еще более значительные изменения выявлены при сочетанной терапии с использованием сочетания СЛТ, СИТ и ИМТ. Минимальная степень регрессии была выявлена только в 17,6% случаев, а максимальная эффективность отмечалась в 58,8% (различия с группой СЛТ достоверны, $p < 0,05$).

Таким образом, дополнительное использование способов лечения, влияющих на состояние специфического иммунитета и неспецифические механизмы иммунной системы, позволило добиться улучшения непосредственных результатов проведения специфической противоопухолевой терапии у больных раком шейки матки.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЯИЧНИКОВ

Манамбаева З.А., Макишев А.К., Кенбаева Д.К.

*Городской онкологический диспансер, г.Астана,
Государственный медицинский университет г.Семей*

Актуальность: Давно установлено, что развитие злокачественных новообразований происходит на фоне снижения численных и функциональных показателей иммунной системы. Даже использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов лечения больных с различными злокачественными новообразованиями.

Цель: анализ клинических результатов применения сочетанной иммунотропной терапии у больных раком яичников.

Материалы и методы: обследовано 105 больных раком яичников, подвергавшихся специфической противоопухолевой терапии. В первую группу включены пациенты, получавшие только полихимиотерапию, во вторую – больные, получавшие сочетание ПХТ и специфической иммунотерапии (СИТ) по разработанной методике. В третью группу вошли больные, получавшие сочетание ПХТ, СИТ и неспецифической иммуномодуляции, заключавшейся в курсе системной энзимотерапии продолжительностью 1 мес. (препарат флогэнзим в дозе 3 таблетки 3 раза в день).

Результаты исследования: была выявлена зависимость степени регрессии от проводимого лечения. Так, у пациенток с раком яичников III клин. стадии уменьшение числа случаев минимальной регрессии первичной опухоли (более чем вдвое – в подгруппе сочетанного применения СИТ и ИМТ). Степень регрессии от 25-50% примерно в равном числе случаев наблюдалась при проведении ПХТ и его сочетания с СИТ. В подгруппе ПХТ+СИТ+ИМТ частота данной динамики снижалась почти в 1,5 раза. Соответственно в последней группе значительно и достоверно по отношению к традиционной терапии возрастало число случаев со значительным более чем 50% уменьшением объема первичной опухоли. Весьма значительные различия наблюдались также в структуре больных раком яичников IV ст. по показателю регрессии первичной опухоли в зависимости от проведенной терапии. Несмотря на то, что при данной стадии развития злокачественного новообразования степень регрессии во всех случаях была меньшей, чем при более ранних стадиях, отмечались различия между группами, достигающие 40% в подгруппе минимальной регрессии между традиционной терапией и ПХТ+СИТ+ИМТ, а также

трехкратного размера – по численности группы максимальной регрессии опухоли при проведении ПХТ+СИТ и почти четырехкратного – ПХТ+СИТ+ИМТ.

Таким образом, дополнительное использование способов лечения, влияющих на состояние специфического иммунитета и неспецифические механизмы иммунной системы, позволило добиться улучшения непосредственных результатов проведения специфической противоопухолевой терапии у больных раком яичников.

КЛЕТОЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Манамбаева З.А., Сандыбаев М.Н.,

Макишев А.К., Кенбаева Д.К.

*Городской онкологический диспансер, г.Астана,
Государственный медицинский университет г.Семей*

Актуальность: специфическая иммунотерапия – один из активно развивающихся современных способов лечения злокачественных новообразований, применение в сочетании с другими методами во многих случаях позволяет резко улучшить непосредственные отдаленные результаты, увеличить среднюю продолжительность жизни больных злокачественными новообразованиями различных локализаций.

Цель: разработка способа специфической иммунотерапии больных раком шейки матки и оценка его эффективности при осуществлении после сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы: осуществлено комплексное клинко-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет. Определены показатели клеточного иммунитета в крови в динамике комплексного лечения, включающего применение сочетанной лучевой терапии и разработанной методики специфической иммунотерапии (СИТ).

Результаты исследования: содержание лейкоцитов в крови у больных группы СИТ оставался сниженным по отношению к контролю (на 39,0%, $p < 0,01$). В динамике была выявлена только тенденция к повышению CD3+CD4+ клеток в группе проведения СИТ. Различия с контролем достоверны (снижение на 18,0%, $p < 0,05$). Отмечалось только умеренное и недостоверное повышение натуральных киллеров (CD3-CD56+CD16+). По абсолютному показателю превышение над группой СЛТ составило 20,9%, по относительному 24,3%. По относительной величине, выявлен высокодостоверный рост на 56,0% ($p < 0,01$). Тем не менее, различия с группой практически здоровых лиц составила 26,4% и также было достоверным ($p < 0,05$). Не было существенных особенностей в зависимости от проводимой терапии по содержанию CD19+. Различия по абсолютному значению с контролем составили 41,7%, по относительному – 21,9% ($p < 0,05$ в обоих случаях). Отмечена тенденция к превышению активированных лимфоцитов у больных группы СЛТ+СИТ по отношению к СЛТ. Отмечались достоверные различия с контролем данного показателя ($p < 0,05$, $p < 0,01$). Недостоверная тенденция к превышению уровня индекса активации никак не повлияло на степень достоверности различий по данному показателю с контрольной группой при проведении СИТ. Они составили 54,2% ($p < 0,01$). Также отмечалось резко превышение средней величины ИТМЛ, достигавшее 66,5%.

Выводы: развившаяся при проведении СИТ нормализация исследованных показателей не обеспечила нормализации, сохранялись достоверные различия с контрольной группой, что требует использования дополнительных методов коррекции.

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕОАДЪВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кереева Н.М., Туржанов К.Т., Байзаков Б.Т., Асанова Н.У.
Западно-Казахстанский медицинский университет имени
Марата Оспанова. г. Актобе.

Исследование Т-клеточного звена иммунитета у больных раком молочной железы (РМЖ), получивших химиолучевую терапию на фоне применения фитопрепаратов, выявило повышение показателя CD3, количество цитотоксических субпопуляций Т-лимфоцитов и снижение супрессорных субпопуляций. В первой основной группе больных РМЖ с применением препарата «Масло солодки» получили неоадъювантную терапию 65 пациентов. Во второй основной группе с применением препарата «Масло корня лопуха», неоадъювантную терапию получили 67 больных. В контрольной группе 74 пациентов получили химиолучевую терапию без применения фитопрепаратов.

Применение препарата «Масло солодки» больными РМЖ приводит к повышению CD3 на 23%, CD4 - на 8%, CD16 - на 16%. ИРИ при применении препарата «Масло солодки» повышается на 1,6. Анализ влияния препарата «Масло корня лопуха» выявил повышение CD3 на 14%, CD4 - на 6%, CD16 - на 12%. При этом отмечено снижение супрессорной субпопуляции CD8, что приводит к повышению ИРИ до 1,2. При этом установлено уменьшение популяции CD8 на 20% при I-II стадиях РМЖ и на 12% - при III-IV стадиях РМЖ.

Назначение препарата «Масло корня лопуха» оказывает менее выраженное влияние на показатели, снижение CD8 на 10% при I-II стадиях РМЖ и на 6% - при III-IV стадиях РМЖ. Препарат «Масло солодки» приводит к значительному увеличению CD 20 как при I-II стадиях (18,9%), так и при III-IV РМЖ (12%) в сравнении с назначением препарата «Масло корня лопуха» (на 8,3% и 4,2% соответственно).

Уровень CD4 в контрольной группе составляет 0,84, в группе больных с применением препарата «Масло солодки» показатель CD4 повышается до 0,9, в группе с приемом препарата «Масло корня лопуха» 0,86. Данные CD16 в контрольной группе установлены в пределах 80% от нормы (0,3), в группе больных первой основной группы CD16 выявлен в 90% от нормы, во второй основной группе - в 86% от нормы. Уровень CD8 является повышенным во всех группах больных и при проведении ХЛТ изменяется незначительно.

Вывод: Применение препарата «Масло солодки» оказывает иммуномодулирующее действие, вызывает повышение иммунологического статуса организма.

ПЭТ-КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ

Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К., Скакова Г.А.,
Рыскулова Г.О., Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр»

Актуальность: радиоизотопные методы исследования с применением ультракороткоживущих радиофармпрепаратов широко развиваются во всем мире. Впервые позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с радиофармпрепаратом 18F-ФДГ (фтордезоксиглюкоза) введена в эксплуатацию Аббасом Алави в августе 1976 года в Университете Пенсильвании, США. Сочетанная ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография) была внедрена в 2000 году докторами Таунсэнд и Натт в Англии. Такой аппарат имеет гораздо более высокую чувствительность и специфичность, чем только ПЭТ, так как позволяет точно определить локализацию патологического процесса на ранних стадиях развития.

Цель работы: выявить впервые в Казахстане эффективность ПЭТ-КТ исследования в диагностике онкологических заболеваний.

Материалы и методы: с 26 марта по 1 сентября 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 180 ПЭТ-КТ исследований на аппарате "Philips" Gemini GXL. Основными локализациями являлись: рак молочной железы, рак ЖКТ, лимфомы Ходжкинские и не-Ходжкинские, меланома, рак без первичного очага, опухоли мозга и т.д.

Результаты и выводы: ПЭТ-КТ дает возможность оценить функциональное состояние исследуемых органов и тканей «in vivo», определить степень и природу их поражения.

Выявлена высокая чувствительность и специфичность ПЭТ-КТ исследований в оценке эффективности лечения, распространенности процесса, дифференциальной диагностики онкологических и неонкологических процессов – злокачественные, доброкачественные, системные заболевания, радионекроз, остеолитические и остеобластические поражения костей злокачественной и не злокачественной природы и т.п.

Роль ПЭТ-КТ значительно выше, чем у других методов диагностики: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика в выявлении первичной опухоли при наличии метастазов без первичного очага.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К.,
Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдалённых метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы "Philips."

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ.

Куркебаева Г.М., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Гематологические исследования предоставляют клиницистам важнейшую информацию, так как характеризуют физиологическое состояние организма, изменяющееся под воздействием различных внешних и внутренних факторов. Для подсчета клеток крови используют ручные микроскопические методы и гематологические счетчики разного уровня автоматизации. За последние 15-20 лет произошли существенные изменения технологии и аппаратуры для автоматического исследования клеток на принципе проточной цитометрии. Во многих странах мира автоматический анализ крови полностью заменил ручные и полуавтоматические методы. На точность результатов оказывают влияние техники взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, скарификаторы), а также пробирки, в которых берется кровь, а в последующем хранится и транспортируется. В нашей лаборатории используется автоматический анализатор крови. Во избежание случаев несовместимости реагентов следует использовать изотонический раствор и гемолизик от одного производителя. При эксплуатации гематологических анализаторов важную роль играет качество электрической сети и заземления. Внезапное отключение электропитания приводит к сбоям в работе приборов. В том числе, если электропитание пропадает в момент забора пробы или анализе и появляется спустя несколько часов, может выйти из строя гидравлика, засоряется сгустками крови капиллярные трубки, апертура, поэтому прибор должен работать с источником бесперебойного питания, который позволяет закончить анализ и провести промывку прибора. Периодически необходимо проводить калибровку по стандартным материалам или контрольной крови, так как электронные и механические компоненты прибора со временем изнашиваются и меняют свои технические параметры.

Приобретение гематологического анализатора позволило нам сократить сроки выполнения общего анализа крови. Гематологические анализаторы удобны в работе, можно использовать для анализа цельную кровь в объеме 12 мкл. Дозирующие устройства приборов основаны на использовании мембранных насосов и поршневых систем. Весь цикл исследования крови осуществляется автоматически. Производительность прибора 40-45 циклов исследований в один час. Измерительный цикл длится 90 секунд, результат исследования отображается на дисплее и распечатывается на отдельном принтере. Сообщение об ошибках появляется на дисплее. Разведение пробы крови для анализа осуществляется автоматически, используя минимальный объем реагентов на одно исследование 6,04 мл реактива для разведения и 0,56 мл лизирующего реагента. Для работы используются три раствора: реактив для разведения, лизирующий раствор и очиститель. Прибор имеет два канала для детекции сигналов: один для эритроцитов и тромбоцитов, другой для лейкоцитов и гемоглобина. В канале для подсчета лейкоцитов установлена кювета для колориметрического определения гемоглобина цианметгемиглобиновым методом. Подсчет эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов проводится по принципу электрического импеданса. Недостатком является то, что для подсчета тромбоцитов необходимо предварительное осаждение эритроцитов. Поскольку подсчет тромбоцитов осуществляется в эритроцитарном канале, очень мелкие эритроциты (микроциты), а также фрагменты эритроцитов (шизоциты) могут привести к завышению результатов подсчета количества тромбоцитов.

Агглютинация эритроцитов ведет к завышению гематокрита, VCHC, MCV, MCH. При высоком количестве лейко-

цитов искажается результат счета эритроцитов, особенно при низких концентрациях последних. При неполном лизисе эритроцитов наблюдается ложное повышение количества лейкоцитов. Высокое количество лейкоцитов может быть вызвано преципитацией белков. Гиперпротеинемии, повышенная концентрация липидов (молочный цвет сыворотки крови), гипербилирубинемия завышают значение концентрации гемоглобина.

Для КДЛ лечебно-профилактических учреждений лучше приобретать 18-параметровые автоматические гематологические счетчики. Имея их, можно без проблем проводить диспансеризацию работающего населения.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУТАЙНЕРОВ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ.

Куркебаева Г.М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Результаты лабораторного анализа определяются не только корректностью его выполнения в лаборатории, но и многими факторами преаналитического этапа. Одним из условий предотвращения гемолиза и лизиса других элементов крови, а также гарантией обеспечения безопасности медицинского персонала является использование так называемых «закрытых» систем – вакутайнеров для взятия крови.

Новые технологии позволяют производить взятие крови, предотвращают контакт персонала с кровью пациента на преаналитическом, но и на аналитическом этапе поскольку возможно использование пробирок практически во всех анализаторах по технологии

Длительное сдавливание вены, взятие крови шприцем, использование игл с узким внутренним просветом разрушению клеток и искажению результатов исследования. Активность многих ферментов, содержащихся в форменных элементах крови, может превышать активность этих ферментов в плазме (сыворотке). Поэтому лизис клеток может повлечь существенное повышение активности лактатдегидрогеназы, аминотрансфераз, кислой фосфатазы, креатинкиназы. При длительном контакте плазмы/сыворотки с клетками эти различия могут быть более выраженными.

«Закрытая» система вакутайнеров позволяет облегчить и стандартизировать процесс получения образцов венозной крови. Конструкция иглы позволяет забирать кровь последовательно в несколько пробирок, предназначенных для различных видов исследований. Наружное и внутреннее силиконовое покрытие иглы исключает контакт клеток крови с поверхностью металла, особая форма рабочего среза иглы уменьшает болезненные ощущения и меньше травмирует стенку сосуда.

Взятие венозной крови в пробирку - вакутайнер для различных исследований, включая гематологические, биохимические, коагулологические и иммунологические является стандартной процедурой, так как пробирки конструктивно мало отличаются.

Дозированный объем, и заданное количество антикоагулянта обеспечивает попадание в пробирку строго определенного объема крови и обеспечивает постоянное соотношение крови/антикоагулянт. Герметичная крышка способствует равномерному перемешиванию содержимого пробирки. Силиконовые покрытие иглы и стенок пробирок вакутайнер предотвращает агрегацию эритроцитов и гемолиз образца. Система вакутайнер может использоваться для широкого спектра исследований, благодаря наличию пробирок разного объема, содержащих реактивы и полимерные добавки в зависимости от задач. Использование различных антикоагулянтов – цитрата натрия, солей гепарина, ЭДТА, ингибиторов гликолиза, активаторов свертывания крови, ингибиторов протеолиза обеспечивает получение более

надежных результатов по сравнению с традиционными методами забора крови. Пробирки, содержащие полимерные добавки, позволяют надежно отделить жидкую часть крови от форменных элементов крови. Использование подобных пробирок удлиняет срок хранения в них до одной недели, а также замораживание образца в самой пробирке – вакутайнер.

Вывод. Таким образом, цветовая кодировка пробок и удобные этикетки облегчают идентификацию пробирок в соответствии с видом исследования способствуют уменьшению ошибок. Переход лаборатории на закрытые системы – вакутайнер приводит к удорожанию исследования всего на 30%, так как при этом резко снижаются потребности лаборатории в моющих средствах, дезинфектантах и электроэнергии.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Балтабеков Н.Т., Абисатов Х.А.

*Алматинский городской онкологический диспансер,
Казахстанско – Российский медицинский университет*

Актуальность. Несмотря на то, меланома кожи относится к визуально доступным локализациям опухоли, среди впервые выявленных больных удельный вес поздних стадии (III – IV) колеблется в пределах 30 – 47% (Арзыкулов Ж.А. с соавт., 2007, Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008.). Поэтому совершенствование существующих и разработка новых методов диагностики ее является актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить состояние диагностики меланомы кожи в поликлиниках г.Алматы по отчетам 2004 года. Внедрить в практику современных методов уточняющей диагностики, таких как дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы «Менард» (Япония), газоразрядная визуализация (электронно – полевой топоческой томографии, определение иммунного статуса больных).

Методы исследования. Материалом для исследования послужили данные о 633 больных, которым наряду с рутинными методами применялись вышеуказанные методы диагностики. Так, дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» применялись у 308 пациентов, газоразрядная визуализация – у 85, иммунологические исследования – у 122 пациентов, кроме того среди врачей поликлиник г.Алматы в 2005г прочитаны 37 лекций по современным методам диагностики, через 3 месяца совместно с сотрудниками кафедры онкологии проведена аттестация врачей поликлиник на знание «симптомов тревоги» при подозрении на наличие меланомы кожи.

Результаты исследования.

- Состояние ранней диагностики меланомы кожи в 2004г было неудовлетворительным, так как у 39,2+_{6,8}% пациентов диагноз установлена в III и IV стадии опухолевого процесса. Повышение онкологической настороженности врачей общей лечебной сети путем чтения регулярных лекций и обязательной последующей аттестацией на знание ранних симптомов меланомы кожи позволяет снизить уровень поздней диагностики в 2006 году с 39,2+_{6,8}% до 20,5+_{6,7}% ($P<0,05$).

- Применение дерматоскопии аппаратом «Скиноскоп» позволяет увеличить эффективность выявления внутрикожных метастазов (сателлитов) с 28,0+_{3,4}% при визуальном осмотре до 75,0+_{4,1}% ($P<0,001$) и правильно выбрать объем оперативного вмешательства.

- Использование газоразрядной визуализации (ГРВ) перед началом лечения меланомы кожи помогает определить субклинические метастазы во внутренние органы. Частота совпадений диагнозов ГРВ в последующих гистологических исследованиях составила 88,9%, а с рентгеновским исследованием – 71,4%.

- Уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором. При рецидиве кожи в 98,2 2,3% случаев доклинически определяемого рецидива отмечается снижение основных показателей Т-клеточного иммунитета, включая СД3, СД4, СД8 и СД4/СД8 более чем на 30%от исходного.

ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ

Ниемпаева О.В., Умбетбаева Э.Н.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Для диагностики различных форм гемобластозов в клиничко-диагностической лаборатории КазНИИ онкологии и радиологии были внедрены цитохимические исследования, позволяющие изучить ферментативную активность, содержание различных веществ в клетках крови, костного мозга, выявить направленность дифференцировки кроветворных клеток. Особенно велика их роль в верификации острых миелоидных лейкозов, где результатов морфологического и цитохимического исследования в большинстве случаев бывает достаточно для постановки диагноза и выбора схемы лечения.

Цитохимические методы представляют собой достаточно простые, хорошо воспроизводимые, не требующие сложной аппаратуры методики, которые могут быть налажены в любой лаборатории, где есть в этом необходимость. В настоящее время выпускаются готовые коммерческие наборы (фирма «Абрис+»), что значительно упрощает выполнение методик и позволяет получить хорошие результаты.

Мы использовали стандартную панель цитохимических методов МПО (миелопероксидаза), липидов, PAS-реакций (гликоген), реакции на неспецифическую эстеразу, что достаточно в большинстве случаев для выявления линейной принадлежности опухолевых клеток, определения варианта острых лейкозов и бластных кризов при хроническом миелолейкозе. Цитохимическими маркерами бластов гранулоцитарного ряда являются МПО, липиды, гликоген и неспецифическая эстераза. Для диагностики монобластных лейкозов главную роль играет определение неспецифической эстеразы, подавляющей фторидом натрия. Для лимфобластов характерно наличие двух признаков: отрицательной МПО, положительной PAS-реакции в гранулярной форме.

С учетом ФАБ - классификации острых лейкозов, где утверждены возможные характеристики цитохимических реакций при соответствующих типах и вариантах.

В КазНИИ онкологии и радиологии за последние 3 года в отделении гемобластозов были диагностированы основные формы острых лейкозов:

- острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) – 54%;
- острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 46%.

У пациентов с острым миелобластным лейкозом были выявлены варианты:

- M0 – 6%;
- M1 – 7%;
- M2 – 26%;
- M3 – 4%;
- M4 – 7%;
- M5 – 4%.

В группе с острым лимфобластным лейкозом:

- L1 – 35%;
- L2 – 11%.

Таким образом, частота заболеваемости острым лимфобластным лейкозом значительно выросла и приближается к показателям заболеваемости острым миелобластного лейкоза.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И МОРФОЛОГИИ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ.

Умбетбаева Э.Н., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Известно, что диагноз острого лейкоза может быть установлен только морфологически – по обнаружению несомненно бластных опухолевых клеток в крови и костном мозге.

Гематологическая картина при остром лейкозе может быть разного рода: при выходе бластных клеток в кровь в ней встречаются молодые клетки – бластные и зрелые гранулоциты, лейкоциты, миелоциты, лимфоциты. Содержание промиелоцитов и миелоцитов может быть невелико и имеется «провал» в формуле между молодыми и зрелыми клетками. Если бластные клетки не обрели способность к выходу из костного мозга в кровь, то их достаточно много в костном мозге. При этом, как правило, будут: лейкопения, анемия, тромбоцитопения. Следует считать обязательным пункционное исследование костного мозга во всех случаях цитопений неизвестного генеза. При остром лейкозе костный мозг практически всегда содержит десятки процентов бластных клеток, если в крови обнаруживается цитопения. Обязательным для диагностики является установление классической структуры ядра бластных клеток – нежнхроматиновой, тонкосетчатой с равномерной окраской и размером нитей хроматина.

В некоторых случаях острый миелобластный лейкоз начинается с повышения в крови уровня всех молодых клеток: и бластных, и промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов. В таком случае нужно дифференцировать острый лейкоз от хронического миелолейкоза, сразу приобретшего черты терминальной стадии - бластного криза. В данном случае проводятся иммунофенотипирование и цитогенетические исследования.

Острый лейкоз дифференцируют с острым иммунным гемолизом, который сопровождается резким увеличением уровня ретикулоцитарных клеток в костном мозге до 10-20%, которые иногда ошибочно принимают за бласты, хотя они всегда имеют грубую структуру хроматина и крупные синие нуклеолы. Кроме того, при анализе в костном мозге резко повышен уровень эритрокариоцитов, а в крови – высокий ретикулоцитоз.

В начале острого лейкоза наблюдается анемия нормохромного или гиперхромного характера, количество тромбоцитов чаще всего снижено или нормальное, крайне редко встречаются острые лейкозы с высоким тромбоцитозом.

Количество лейкоцитов вначале заболевания чаще всего снижено, но встречаются случаи, когда первичным клиническим проявлением болезни наблюдается высокий тромбоцитоз с преобладанием бластных клеток.

При остром лейкозе довольно часто в периферической крови можно увидеть единичные эритрокариоциты. В отдельных, очень редких случаях отмечается эритроцитоз, который предшествует развернутой картине острого лейкоза. Скорость оседания эритроцитов в большинстве случаев увеличена, но может быть и нормальной. Данная картина крови связана с самим лейкозным процессом, она не одинакова при различных формах острого лейкоза.

При морфологическом исследовании в пунктате костного мозга при остром лейкозе чаще отмечается увеличение бластных клеток более 30% при сужении нормальных ростков гемопоэза, которое сопровождается угнетением элементов эритропоэза и тромбопоэза. По морфологии не всегда можно различить миелобласт от лимфобласта и монобласта. Установить природу этих клеток можно только с помощью цитохимических исследований.

Особая форма бластных клеток характерна для острого промиелоцитарного лейкоза. Выражен полиморфизм клеток,

которые часто имеют цитоплазматические выросты, напоминающие псевдоподии. Цитоплазма этих клеток базофильная, густо заполнена крупной полиморфной фиолетовой зернистостью.

Таким образом, при помощи морфологических и цитохимических исследований можно диагностировать острые лейкозы и их варианты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА.

Ниемпаева О.В., Умбетбаева Э.Н., Куркебаева Г.М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Точность и информативность лабораторного исследования в большой степени зависит от преаналитического этапа работы.

Этот этап имеет критическую значимость для обеспечения качества исследований, поскольку здесь допускается около 80% ошибок при организации и проведении исследования системы гемостаза.

Для качественной диагностики пациента, кроме обычных указаний (Ф.И.О., возраст и др.) направление на обследование должно включать:

- время забора крови для исследования;
- клинический диагноз, цель обследования;
- указания о наличии геморрагических и/или тромботических проявлений;
- информацию о проводимом лечении, способном оказать влияние на параметры гемостаза (антикоагулянты, тромболитики) сроки последнего введения.

Основные факторы преаналитического этапа, влияющие на качество диагностики нарушений гемостаза .

1. Необоснованное или малоинформативное направление на исследование (экономические потери);
2. Дефекты взятия, хранения и подготовки крови для исследования; пренебрежение патологическими отклонениями гематокрита крови; «внутрипробирочное» свертывание крови и другие дефекты (гемолиз, сгустки).

Использование вакутейнеров, предназначенных для получения венозной крови, стабилизированной цитратом в соотношении 3:1 имеет большие преимущества перед пробирками из-за хорошей стандартизации процедуры и соответствия санитарным нормам, но является малопримлемым в случае существенных отклонений гематокрита у больных с заболеваниями крови, при анемии или полицитемии.

Лишь при нормальном гематокритном показателе раствор цитрата остается в плазме и не проникает в клетки крови. Поэтому при высоком гематокрите (свыше 70%) в плазме крови создается избыточная концентрация цитрата, приводящая к «ложной» гипокоагуляции. Напротив, при снижении гематокрита (ниже 35%), например при анемии 70г/л обнаруживается «ложная» гиперкоагуляция кровь может свернуться в пробирке еще до исследования. Перерасчет объема стабилизатора в соответствии позволяет избежать это ошибки.

ИЗУЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА РАКА ЭНДОМЕТРИЯ.

Нишанов Д. А., Махкамов У.У., Уморов М. Х.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент

Задачи исследований: Определить иммуногистохимическим методом гормонозависимость опухолевых клеток.

Материалы и методы исследования: Нами исследовано 32 биопсийных материала с раком тела матки. В биопсийном материале составило 16 высокодифференцированных аденокарцином, 11 случаев умеренно дифференцированных аденокарцином и остальные низкодифференцированные

аденокарциномы. Материалы фиксировали формалином, заливали парафином, приготовили парафиновые блоки. Для определения гормонозависимости проводили иммуногистохимические тесты (фирма Dako citomation, 2010г.). В этих целях мы использовали онкорепцепторы эстрогена и прогестерона. Результат иммуногистохимических реакций оценивали по трех балльной системе.

Результаты исследования: Исследования показали, что при высокодифференцированной аденокарциноме позитивные эстрогены (3+) 7 случаев, это составляет 43,7% и прогестерон позитивные 4 случая (25%). При умеренно дифференцированной аденокарциноме эстроген позитивные 3 (27,2%) случая, прогестерон позитивный 1 (11%) случай. При низко дифференцированной аденокарциноме позитивные реакции на эстроген один случай, что составляет 5%.

Заключение: Исходя из выше изложенного, наши исследования показали, что эстроген больше влияет на опухолевую ткань, чем прогестерон.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Нишанов Д. А., Уморов М. Х., Махкамов У. У.
Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз
г. Ташкент

Задачи исследований: Иммуногистохимическим методом определить онкобелки Ki-67, P53.

Материалы и методы исследования: В этих целях исследовали 23 биопсийных материала с мастопатий молочной железы. Для определений использовали онкомаркеры Ki-67, p53. Характер иммуногистохимических реакций оценивали визуально по 3-х балльной системе.

Результаты исследования: исследования показали, что при мастопатии Ki-67 позитивные (3+) что составляет 36% случаев, в 48% случаях наблюдалось (2+) и p53, в остальных 16% случаях.

Заключение: Результаты исследования показали, что при мастопатии - индекс пролиферации выше.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Нурғалиева А. Т.
Восточно-Казахстанский областной онкологический
диспансер г. Усть-Каменогорск

Рак шейки матки (РШМ) является одной из немногих нозологических форм злокачественных новообразований, которые удовлетворяют всем требованиям для проведения популяционного скрининга. Цель скрининга – выявить предраковые изменения шейки матки.

Скрининг будет эффективным только в том случае, если хорошо организовано наблюдение и лечение за обследованным контингентом женщин.

В настоящее время хорошо зарекомендовавшим себя на практике при обследовании больших групп населения является цитологическое исследование по Папаниколу (Пап-тест), опыт применения которого насчитывает уже более 40 лет. Этот метод позволяет хорошо улавливать способность цитоплазмы клеток окрашиваться различными красителями и различить детали ядра. Интерпретация полученных результатов производится по Терминологической системе Бетезда (TBS). Следует помнить, что определения в TBS не являются диагнозом, а только интерпретацией цитологической картины. TBS позволяет стандартизировать постановку диагноза, тактику лечения и наблюдения за пациентами.

Таблица №1. Результаты Пап-теста за 2008-09 гг. по ВК области.

Годы	Кол-о подлежащих женщин.	Кол-во прошедших Пап-тест.	Неудовлетв. для оценки ст.препар.
2008	52308	47753 (91.3%)	1669 (3,5%)

2009	48339	47947 (99.2%)	1120 (2,3%)
Всего	100647	95700	2789

В сравнении с 2008 годом в 2009 году процент выявляемости раков вырос с 0,05 до 0,07. Все исследования выполнялись по методу Папаниколау, что еще раз подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Необходимо отметить большой процент не информативного и недостаточно информативного материала, что может быть причиной ложноотрицательных результатов и делает скрининг менее информативным. По результатам проведенного скрининга выявлено за 2 года 75 раков РШМ., что составило 0,08 процентов из просмотренных 95700 стеклопрепаратов.

Цитологическое исследование мазков позволяет выявить внутриэпителиальные поражения на разных стадиях: благодаря лечению предопухолевых состояний и ранних форм рака (где хорошо отработаны программы массового скрининга) значительно снижается смертность от рака шейки матки.

Выводы:

Заболеваемость рака шейки матки занимает по ВК региону 8-е, по области 7-ое место среди злокачественных новообразований. Имеет тенденцию роста заболеваемости.

Наиболее часто возникающая форма рака в шейке матки – плоскоклеточный ороговевающий рак. Аденокарцинома шейки матки наблюдается в 5% случаев. По результатам скрининг – программы 2008-09гг. наибольшее количество раков выявлено у женщин возраста 35 – 40 лет.

3. Наибольшее количество раков выявлено у жительниц г. Усть-Каменогорска и г. Семей.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ФИБРОМИОМЫ МАТКИ

Манамбаева З.А., Мукашева С.А.
Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: до настоящего времени около 50% больных миомой матки в гинекологических стационарах подвергаются оперативному лечению. Это приводит к необратимому бесплодию, утрате менструальной функции, выраженным гормональным нарушениям, вегетососудистым и психосоматическим расстройствам.

Цель: изучение механизмов развития доброкачественного опухолевого процесса в миометрии.

Результаты: одной из значимых причин возникновения и роста опухоли в миометрии традиционно считается гиперэстрогения (в том числе локальная), ановуляция и, как следствие, прогестероновая недостаточность. Между тем, существуют клинические наблюдения, показывающие значимую роль прогестерона в реализации аутокринных и паракринных влияний на развитие миомы матки. К факторам, регулирующим процессы пролиферации и апоптоза в ткани миометрия, а также влияющим на процессы ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса, следует отнести и факторы роста, являющиеся медиаторами действия половых стероидов. В последние годы внимание исследователей привлечено к изучению изменений функции клеток иммунной системы при миоме матки. Однако состояние локального иммунитета, а именно – иммунные процессы, протекающие в тканях опухоли, в перитонеальной жидкости и интактном миометрии, у этих пациенток остается малоизученным. Данные о представленности различных субпопуляций лимфоцитов у больных миомой матки противоречивы.

Согласно психосоматической концепции миомы матки, дисгормонемия, является следствием синдрома психосоматического напряжения, в результате которого развиваются нарушения функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Дальнейшее изучение психосоматического статуса, индивидуальных особенностей личности

больных миомой матки с различными вариантами клинического течения позволит оптимизировать лечебный процесс, поставить задачи для разработки психотерапевтического воздействия с целью улучшения качества социальной адаптации женщин, страдающих этим заболеванием.

Выявление новых звеньев патогенеза миомы матки, комплексная оценка факторов риска развития симптомного течения опухолевого процесса для составления прогноза заболевания, в том числе быстрого роста миоматозных узлов, позволят совершенствовать методы патогенетической терапии, сократить частоту клинически активных форм миомы и, таким образом, в дальнейшем снизить оперативную активность лечения этой группы больных.

Таким образом, в настоящее время активно развиваются направления консервативной терапии, в частности, связанное с учетом и коррекцией иммунных механизмов в патогенезе заболевания предопухолевых заболеваний гормонально-зависимых органов женской репродуктивной системы, на основе негормонального блокирования опухолевого роста.

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ

Пироженко О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Одной из важнейших задач современной онкологии является адъювантное лечение рака молочной железы, направленное на достижение максимального эффекта при минимальных токсических воздействиях. До сих пор выбор адъювантного лечения основывался на учете степени местно-регионарного распространения опухоли (система TNM), уровня экспрессии рецепторов к стероидным гормонам и репродуктивном статусе (или, чаще, возрасте) больных. Современная диагностика опухолей включает не только верификацию гистологического варианта и степени дифференцировки, но и оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли (морфофункциональной характеристики новообразования). Основными иммуногистохимическими маркерами, отражающими функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы, являются пролиферативная активность, экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона и экспрессия онкопротеина HER2/neu (c-erbB-2). По данным O'Malley F.P. et al (2001) гиперэкспрессия HER2/neu обнаружена в 20–30% инвазивного протокового рака молочной железы, а в случаях неинвазивного рака эта величина достигает 90%. Гиперэкспрессия HER2 указывает на усиленное деление опухолевых клеток, повышение кровоснабжения опухоли, высокий риск развития метастазирования и резистентность к проводимой химиотерапии. Знание состояния гена HER2/neu и уровня экспрессии белка HER2/neu имеет важное значение для определения прогноза у больных инвазивным раком молочной железы и для отбора пациентов с наличием гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu для дальнейшего лечения. Все большее значение приобретают точные, прямые и стандартные методы определения наличия гиперэкспрессии и/или амплификации HER2/neu. По данным Завалишина Л.Э. и др. (2006) в настоящее время существует несколько методов выявления гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu: иммуногистохимический (ИГХ), гибридизация in situ (флюоресцентная и хромогенная), полимеразная цепная реакция. Однако на практике доминирующее положение занимает ИГХ-метод определения HER2-статуса рака молочной железы. При неопределенном иммуногистохимическом HER2-статусе (2+) требуется исследование, выявляющее наличие или отсутствие ампли-

фикации. Такими методами являются флюоресцентная in situ гибридизация (FISH) и хромогенная in situ гибридизация гена (CISH). Метод FISH является более чувствительным, так как позволяет напрямую оценивать наличие (или отсутствие) амплификации, но и гораздо более дорогостоящим, чем ИГХ. Метод CISH позволяет выявлять амплификацию гена HER2 под световым микроскопом и учитывать морфологическую картину ткани. Недостатками методики является ее новизна и наличие «мертвой зоны» при оценке результатов исследований, так же как и при ИГХ-исследовании. Оба метода выполняются на срезах с того же образца (блока), на котором проводилось ИГХ-исследование. Конкордантность методов FISH с использованием двухцветных зондов (на участки центромеры 17-й хромосомы и гена HER2) и CISH с использованием монохромного зонда, комплиментарного только участку HER2, составляет 85%.

Следовательно, для окончательной диагностики наличия амплификации гена HER2 целесообразно использовать метод FISH, так как получаемые с его помощью результаты более точно отражают истинный HER2-статус пациентки, что крайне важно для назначения таргетной терапии. Метод CISH позволяет с высокой вероятностью выделять группу опухолей с высокой амплификацией и может использоваться в отделениях патологической анатомии, не имеющих оборудования для флюоресцентного исследования. Образцы опухолей с низкой амплификацией гена должны в обязательном порядке повторно исследоваться с помощью метода FISH.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ В-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМ

Пироженко О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Гематопатология стала предметом повышенного интереса специалистов во многих странах. Особенности этой группы новообразований состоит в многообразии нозологических форм, близости гистологических проявлений отдельных вариантов лимфом, морфологическом сходстве некоторых реактивных процессов и опухолей лимфоидной ткани и цитологическом сходстве нормальных и опухолевых лимфоцитов. При диагностике лимфом более, чем в других разделах гематопатологии, особенно важно определение иммунофенотипа клеток опухоли, осуществляемое различными методами (проточная цитометрия, иммуноцитохимическое или иммуногистохимическое (ИГХ) исследование).

Для лейкоцитарных антигенов, выявляемых различными антителами разработана CD-классификация (кластер дифференцировки). Кластер дифференцировки включает группу антител, реагирующих с одним или разными эпитопами определенного антигена. К настоящему времени получены данные по 247 кластерам. По данным Криволапова Ю.А. и др. (2006) в диагностике В-клеточных лимфом используют следующие основные маркеры: CD20 (L26) – пан-В-клеточный антиген, маркер нормальных и опухолевых В-клеток, фолликулярных дендритических клеток, экспрессируется примерно в 50% случаев В-лимфобластных лимфом/лейкозов и в большинство случаев зрелоклеточных лимфом/лейкозов В-клеточного происхождения, не является идеальным маркером, т.к. не экспрессируется на самых ранних стадиях дифференцировки и исчезает при дифференцировке в плазмциты; CD79a – пан-В-клеточный антиген, является почти идеальным маркером линии В-клеток, экспрессия CD79a возникает на стадии предшественников В-лимфоцитов и сохраняется до стадии плазматических клеток, однако его экспрессирует 50% Т-лимфобластных лимфом. Для объективизации реакций, используются и другие маркеры: CD5 – пан-Т-клеточный антиген, слабо экспрессирует на В-клетках при В-клеточном хроническом лимфоцитарном лейкозе/лимфоцитарной бластоме

и лимфоме из клеток мантийной зоны; CD10 - В-клеточный антиген, экспрессирует на клетках В-лимфобластных лимфом, некоторых Т-лимфобластных и ангиоиммунобластных Т-клеточных лимфом, большинстве фолликулярных лимфом, клетки лимфомы Беркитта оказываются позитивными, так же как и часть (30%) диффузных крупноклеточных В-лимфом; CD23 - В-клеточный антиген, экспрессируется при В-клеточных лимфоцитарных лимфомах и не экспрессируется при других лимфомах, включая лимфому из клеток мантийной зоны; BCL-1 (циклин D1) – регулятор клеточного цикла, ответственный за прохождение S – фазы митоза, избыточная продукция белка циклина D1 в ядрах опухолевых клеток обнаружена в большинстве случаев лимфомы из клеток мантийной зоны и является специфическим диагностическим признаком этой лимфомы; BCL-2 – белок – супрессор апоптоза, В-клетки в реактивных тканях являются BCL-2 негативными, а 85% фолликулярных лимфом являются позитивными, это и определяет его дифференциально-диагностическую ценность; BCL-6 – регуляторный протеин, кодируемый протоонкогеном, BCL-6 позитивными являются большинство фолликулярных лимфом, клетки лимфомы Беркитта; CD45RA – ранее использовались в качестве маркеров В-клеток, но в последующем были вытеснены более надежными и специфическими антителами CD20 и CD79a.

Таким образом, морфологический диагноз опухоли лимфоидной ткани должен основываться на гистологическом и иммуногистохимическом исследовании биоптата, полученного при эксцизионной или инцизионной биопсии лимфатического узла. Иммуные реакции не только позволяют определить тип лимфоцитов – В или Т, но также стадию дифференцировки опухолевой клетки, и во многих случаях выделение того или иного типа лимфом базируется именно на специфическом иммунном профиле.

МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ

Полатова Д.Ш.

*Республиканский Онкологический Научный Центр,
Узбекистан, Ташкент*

Задача исследования. определение экспрессии p53 и bcl-2 в опухолевых клетках а также изучение спектра aberrаций хромосом в мононуклеарах периферической крови больных с остеогенной саркомой.

Материал и методы. Было проведено обследование цитогенетическим методом 22 пациентов в возрасте от 14 до 20 лет (13 юношей, 9 девушек). Экспрессию белков p53 и bcl-2 изучали с использованием моноклональных антител к p53 (клон ДО-7) «Дако» и к bcl-2 (NCL-bcl-2 -486) «Novocastra». До проведения исследования лечение пациенты не получали.

Результаты. Наличие aberrаций хромосом от 9,0 до 19,1% отмечено у всех больных. Цитогенетический анализ типов aberrаций хромосом показал наличие видимых делеций хромосомы 22 (22 p-) в 9 случаях (у 6 юношей и 3 девушек), у 2 больного были обнаружены множественные микрофрагменты, у остальных больных (6 юношей и 5 девушек) в кариотипе лимфоцитов стимулированных ФГА, обнаружены делеции 4, 13, 18 и X- хромосом, а также фрагменты различной величины и малые двойные хромосомы. Результаты иммуногистохимического анализа, особенностей экспрессии белков p53 и bcl-2 в опухолевых клетках, свидетельствуют о том, что положительная реакция определялась не во всех клетках, не у всех больных. Белковый продукт мутантного гена апоптоза p53 выявлен в ядрах опухолевых клеток у 15 больных (9 юношей и 6 девушек), в относительных случаях результаты иммуногистохимической реакции были отрицательными. Количество

p-53 – положительных опухолевых клеток колебалось от 25 до 50% у 4/6 больных юношей и у всех девушек, а от 50 до 98% у остальных 4/7 юношей. Экспрессия, которая кодирует белок-экспрессор апоптоза, выявлен у 6 больных юношей и 6 девушек. Количество bcl-2- положительных клеток было высоким (до 90%) только у одной больной девушки, а в остальных случаях положительная реакция наблюдалась только в 50% клеток и ниже, при этом реакция на мутантный p53 (mtp53) ген имела отрицательный характер.

Выводы. Потеря хромосомного материала приводит к снижению экспрессии гена или даже к полной потере белкового продукта. Определение спектра молекулярно-генетических повреждений, характерных для остеогенной саркомы позволит использовать их в качестве маркеров для диагностики и прогноза этого заболевания, а также выработки тактики лечения.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМОЙ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ.

Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунов М.А., Гельдиева М.С.

*Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,
г.Ташкент, Узбекистан*

Цель исследования: Цитогенетические изменения в лимфоцитах периферической крови у больных остеогенной саркомой до лечения и в оценке эффективности лечения.

Материал и методы: Обследовано 90 больных с остеогенной саркомой в возрасте от 10 до 45 лет. В 46 (51,2%) случаев опухоль локализовалась в бедренной кости, в 28 (30,3%) - в большеберцовой кости и в 16 (18,5%) в малоберцовой кости.

Для сравнения показателей цитогенетических изменений проведено исследование 20 практически здоровых людей, соответствующего возраста.

Анализ хромосомных нарушений, как структуры, так и геномных, проводился в соответствии с Международной системой цитогенетической номенклатуры.

Больным проведено лечение с применением схем: цисплатин 100 мг/м², доксорубин 50 мг/м², циклофосфан 600 мг/м² или метотрексат 50 мг/м², цисплатин 100 мг/м² внутриаартериально в течении 72 часов до 4 курсов. Интервал между курсами 3-4 недели.

Результаты: При цитогенетическом исследовании практически здоровых лиц было определено, что средний уровень хромосомных нарушений составил 1,6-+0,4%, а среднее количество лимфоцитов с хромосомными нарушениями было 1,2-+0,3%. До проведения лечения остеогенной саркомы выявлены специфические и неспецифические хромосомные нарушения в виде увеличения количества гипо-, гиперануплоидных и полиплоидных клеток, а также клеток с мелкими двойными хромосомами и генами которые классифицируются как нестабильные хромосомные нарушения.

В группу больных с полным эффектом (19% больных) от лечения фоновый уровень хромосомных нарушений в 2,6 раза превышал средний уровень хромосомных нарушений здоровых людей, при частичном эффекте (78% больных), средний уровень хромосомных нарушений был выше в 3,9 раза, а при отсутствии эффекта (3% больных) хромосомных нарушений были выше в 7,9 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Заключение: При отсутствии эффекта от проведенного лечения фоновые показатели хромосомных нарушений значительно больше, чем у лиц с хорошим клиническим эффектом. Проведенное исследование можно использовать в прогнозировании терапевтического эффекта при остеогенной саркоме трубчатых костей.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРОВИ ПРИ НЕИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Раев Г.Б., Куркебаева Г.М., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК.

В настоящее время в онкохирургической и урологической практике для общей анестезии все больше используется внутривенные анестетики. В связи с этим возникает интерес к воздействию внутривенных анестетиков на состояние свертывающей системы крови.

Мы обобщили опыт ведения анестезии при 52 операциях у больных с аденомой предстательной железы в возрасте от 55 до 80 лет.

Мочекаменная болезнь произведена у 47-ой, а нефрэктомия у 5 мужчин.

В 4 случаях операция проводилась в экстренном порядке, в остальных случаях больные были подготовлены к оперативному вмешательству.

Премедикация проводилась стандартно, вводили холинолитики, наркотические анальгетики, антигистаминные препараты. Вводный наркоз осуществляли 2% раствором тиопентала и калипсолом.

В зависимости от применяемого анестетика для поддержания наркоза мы выделили 2 группы больных.

У 32 мужчин первой группы анестезия проведена калипсолом, который вводили фракционно по ходу операции, в среднем 450-500 мг при ее длительности 2-2,5 часа.

У 20 больных второй группы наркоз проведен оксibuтиратом натрия из расчета 85-100 мг/кг с фракционным введением фентонила в среднем 0,5 мг за операцию.

Искусственную вентиляцию легких поддерживали в режиме умеренной гипервентиляции с подачей кислорода 3-5 л/мин. Мышечная релаксация достигалась применением 0,2-0,3 мг/кг ардуана. Из инфузионных средств применяли сбалансированный электролитный раствор СЭР, раствор Рингера-Локка.

Коагулограмма определялась до начала наркоза, после окончания наркоза, а также на первые, третьи и седьмые сутки послеоперационного периода.

Кровь брали из вены, в вакутайнер содержащий 3,8% оксалат натрия. Определялись следующие показатели времени свертывания крови, протромбиновый индекс, время рекальцификации плазмы, толерантность плазмы к гепарину, общий фибриноген, фибриноген В, активность фибриназы, тромботест.

Анализ течения анестезии показал, что у больных первой группы после введения первоначальной дозы калипсолом из расчета 2 мг/кг наблюдалось повышение артериального давления на 20-30 мм рт.ст., тахикардия. Повторные дозы калипсолом соответствовали 2/3 первоначальной дозы и повторялись через 20-30 минут.

К концу операции восстанавливалось адекватное дыхание, восстановление сознания было через 20-30 минут, но отмечалась некоторая заторможенность. В послеоперационном периоде длительно сохранялась анальгезия.

Данные коагулограммы показали, что у большинства больных обеих групп перед операцией отмечалась умеренная склонность к гиперкоагуляции. Это может быть обусловлено повышенной психоэмоциональной реакцией. Во время анестезии калипсолом склонность к гиперкоагуляции более выражена, а реакция фибринолиза угнетена.

У больных второй группы оксibuтират натрия вводился капельно сразу после индукции. При этом артериальное давление у больных повышалось на 10-20 мм рт.ст. введение фентонила соответствовало травматичным моментам.

Выход из наркоза у больных этой группы несколько замедлен, менее активно восстанавливалось самостоятельное дыхание, долго удерживалась релаксация дыхательной мускулатуры, часто наблюдалась двигательное возбуждение, быстро восстанавливалась болевая чувствительность.

Тесты коагулограммы показали, что данный вид анестезии почти не оказывает влияния на систему гемостаза крови, умеренно активируется фибринолитическая активность.

Вывод: Таким образом, у больных с онкохирургической и урологической патологией применять при операциях неингаляционные анестетики наиболее целесообразно.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин

Г.К.Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.

АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдаленных метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы «Philips».

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ ОТ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА

Сайдахметов А.С., Манамбаева З.А.

Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: одним из универсальных процессов повреждения клеток, субклеточных структур и биологических макромолекул является процесс свободно-радикального окисления. Наличие активации СРО было выявлено при исследовании множества патологических процессов, начиная от инфекционных заболеваний и заканчивая атеросклерозом, ИБС, бронхиальной астмой и других. Однако роль СРО в структуре патогенетических механизмов онкологического процесса остается спорной.

Цель: изучение нарушений процессов перекисного окисления липидов при наличии злокачественного процесса легких II, III и IV клинических стадий.

Материалы и методы: проанализированы результаты клинического и биохимического обследования у 148 больных раком легких. При биохимическом анализе определялись уровни диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и шиф-

фовых оснований.

Результаты: полученные нами данные свидетельствуют об активации процессов липопероксидации при злокачественных новообразованиях легких, который взаимосвязан со стадией опухолевого процесса. Значительного уровня достигают нарушения при II клинической стадии процесса. Так, отмечается повышение концентрации ДК на 67,8% ($p < 0,05$); МДА – на 145,5% ($p < 0,01$); ШО – на 83,3% ($p < 0,01$). Состояние липопероксидации при II стадии рака легких характеризуется выраженной активацией процессов ПОЛ, частично скомпенсированной антиоксидантными механизмами. При III клинической стадии опухолевого процесса уровень наблюдающихся нарушений резко возрастает. Повышение концентрации ДК достигает 85,8% относительно показателей контрольной группы ($p < 0,01$); МДА превышает уровень у здоровых лиц в 3,55 раза ($p < 0,001$). Отмечается резкое увеличение содержания в крови ШО (в 3,0 раза, $p < 0,001$), что свидетельствует о выходе процессов липопероксидации из-под контроля АОС. Максимальный уровень нарушений процессов липопероксидации наблюдается у больных с IV клинической стадией. Так, степень превышения концентрации ДК над показателями контрольной группы достигает 142,2%; МДА увеличивается в 6,5 раза, ШО – в 4,67 раза ($p < 0,01$).

Выводы: таким образом, анализ уровня нарушений состояния липопероксидации при злокачественных новообразованиях легких показывает, что по мере прогрессирования опухолевого процесса изменения в данных системах прогрессируют. Это, вероятно, связано с прямой активацией процессов ПОЛ в ткани опухоли, особенно выраженной при IV клинической стадии, при развитии процессов распада, и нарушениями функционирования иммунной системы, в особенности механизмов неспецифического иммунитета, непосредственно связанных с процессами липопероксидации.

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Астапкевич С.Г.

Лечебно-диагностический центр г. Астана

Для развития аденокарциномы пищевода важное значение имеет гастро-эзофагальный рефлюкс, а возрастающая актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с ростом числа больных с этой патологией во всем мире. В настоящее время эзофагит Барретта рассматривается как предраковое состояние. Основными задачами исследования явилось определение морфологических изменений в зоне поражения слизистой пищевода при эзофагитах различной степени выраженности и определение динамики изменений слизистой пищевода после проведения медикаментозной терапии.

Материал и методы. За период с января 2008 до сентября 2010 года в лечебно-диагностическом центре частной формы собственности г. Астаны проведено 2852 видеогастроскопических исследования. Патология слизистой пищевода выявлена у 262 пациентов и составила 9,2 % в общей популяции. С целью улучшения визуализации измененных участков слизистой пищевода использовали хромоэндоскопию. Степень выраженности эзофагита оценивалась по классификации Savary-Miller, 1977. У всех больных проводилось цитоморфологическое исследование биоптатов пищевода. Вариантами заключения являлись разные степени воспаления, воспалительно-дистрофические изменения, метапластические изменения, дисплазия эпителия и пищевод Барретта. При первичной эндоскопии степень выраженности эзофагита распределилась следующим образом: Степень I - 224 (85,5%), II - 16 (6,1%), III-IV - 14 (5,3%), Пищевод Барретта - 8 (3,1%). Всем пациентам проводилась терапия ингибиторами протонной помпы, прокинетики, Н₂-блокаторами. Основной курс лечения составлял 4 недели. В группе с выраженными эрозивными эзофагитами, а так же пищеводом

Барретта в комплекс лечения включали иммуномодуляторы. Контрольное эндоскопическое исследование проводилось на 4-й неделе, затем на 12-й неделе с биопсией пищевода и обязательным цито- и морфологическим исследованием. Ни в одном случае трансформации дисплазии в аденокарциному не выявлено. У пациентов через 4 недели во 2-й группе полное заживление эрозивных изменений слизистой пищевода произошло у 11 (68,8%), в 3-й группе — у 8 (57,1%) и в 4-й группе отмечали явную положительную динамику эндоскопических и морфологических критериев оценки состояния слизистой оболочки пищевода (у 5 пациентов легкая дисплазия, у 3 отмечена умеренная метаплазия, воспаление выраженной степени стало слабым). При контрольной эзофагогастроскопии на 12-й неделе ликвидировались эндоскопические признаки эзофагита у всех пациентов 2-й группы, сохранялась эндоскопическая картина «эрозивного эзофагита 1» у 3 (21,4%) пациентов 3-й группы. В 4-й группе дисплазия низкой степени присутствовала у 1 пациента после проксимальной резекции желудка по поводу «малигнизированной» язвы субкардиального отдела желудка.

Заключение: Динамическая видеоэндоскопия с прицельной биопсией остается клиническим стандартом для ведения пациентов с эрозивными формами ГЭРБ и пищеводом Барретта для контроля эффективности терапии и выявления ранних форм рака пищевода онкопрофилактики и лечения дисплазии пищевода эпителия.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ

Манамбаева З.А., Сандыбаев М.Н.,

Сайдахметов А.С., Жетписбаев Б.А.

*Государственный медицинский университет г. Семей
Региональный онкологический диспансер, г. Семей*

Актуальность: Исследование активности систем АОЗ (ферментативной и неферментативной) в злокачественных опухолях представляет большой интерес в плане изучения механизмов действия данной системы и определяющей роли того или иного ее звена. В литературе нет единого мнения об активности ферментов АОЗ в опухолях и в тканях организма при злокачественном росте.

Цель: изучение нарушений ферментативной активности антиоксидантной системы при наличии злокачественного процесса легких II, III и IV клинических стадий.

Материалы и методы: проанализированы результаты клинического и биохимического обследования у 148 больных раком легких, обследование которых, лечение и последующее наблюдение больных в стационарных и амбулаторных условиях проводилось в онкологическом диспансере г. Семипалатинска в течение 2005-2009 гг. При биохимическом анализе определялись уровни глутатионпероксидазы, сукцинатдегидрогеназы, тиолсульфидного соотношения.

Результаты: Значительного уровня достигают нарушения у больных при II клинической стадии процесса. Проявляется угнетение антиоксидантных механизмов, что проявляется снижением активности ГПО на 9,8% относительно показателей группы сравнения и достоверным ($p < 0,05$) падением уровня ТДС на 36,7%. При III клинической стадии опухолевого процесса уровень наблюдающихся нарушений резко возрастает. Снижение активности антиоксидантных ферментов становится достоверным и достигает по ГПО – 30,7% ($p < 0,05$), а по СОД – 35,2% ($p < 0,05$). Аналогичная динамика прослеживается и в отношении ТДС (снижение на 57,8% относительно контрольной группы, $p < 0,01$). Максимальный уровень нарушений процессов активности антиоксидантных механизмов наблюдается у больных с IV клинической стадией. Резко падает активность ферментов АОС в крови (ГПО – на 48,5%, СОД – на 45,7%, $p < 0,01$ в обоих случаях). Наконец, степень снижения уровня ТДС составляет 86,4% ($p < 0,001$).

Выводы: таким образом, анализ уровня нарушений со-

стояния АОЗ у пациентов со злокачественными новообразованиями легких показывает, что по мере прогрессирования опухолевого процесса изменения со стороны данной системы прогрессируют. Это, вероятно, связано с прямой активацией процессов ПОЛ в ткани опухоли, особенно выраженной при IV клинической стадии, при развитии процессов распада, а также с нарушениями функционирования иммунной системы, в особенности механизмов неспецифического иммунитета, непосредственно связанных с процессами липопероксидации.

ГИПОТЕЗЫ О РОЛИ МИТОХОНДРИЙ В РАЗВИТИИ И РЕГУЛЯЦИИ УРОВНЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В НОРМЕ И ПРИ КЛЕТОЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Б.И. Исмаилов*, М.Б.Лю**, С.Б.Исмаилов**
АО «Медицинский университет Астана»*
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», **Алматы

Изменение состояния количественно-качественных параметров митохондрий клеток рассматривается как ключевой механизм регуляции в них уровня окислительного стресса – содержания активных форм кислорода и перекисных продуктов. Некоторые из этих агентов как сигнальные молекулы прямо или опосредованно модифицируют регуляторные и синтетические процессы в клетке, влияя тем самым на ее пролиферацию, дифференцировку и на другие фундаментальные клеточные функции. Аргументирована связь смены состояния клеток, в том числе эмбриональных (ЭСК) и региональных стволовых клеток (РСК), от нормального до различных патологических форм со степенью возрастания в них дисбаланса между его прооксидантными (ПО) и антиоксидантными (АО) составляющими. Ниже на рис. приведена структурно-функциональная блок-схема митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции канцерогенеза (Лю Б.Н., 2003).

Впервые выдвинуто представление о том, что одним из необходимых условий для обратного развития клеток, в частности опухолевых, является снижение в них указанного дис-

баланса до определенных уровней под влиянием различных индукторов реверсии (Исмаилов Б.И., Лю Б.Н., 2006, 2007). С «митохондриальных позиций» объясняется относительно повышенная малигнизируемость и обратная ревертируемость ЭСК и РСК.

Анализ и обобщение многих известных фактов позволило нам с учетом исходных «эволюционных» положений сформулировать ряд приоритетных гипотез в области биологии и связанных с ней медицинских проблем (см. журнал Medical Hypotheses. 2007. V. 69, №1, P.186-194).

Гипотеза 1: Возникновение в ходе эволюции и проявление в клетках последовательности «специализированных» дисбалансов $\Delta(PO-AO)$.

Гипотеза 2: Изменение количественно-качественных параметров митохондрий как действенный механизм регуляции уровня окислительного стресса (содержания ROS, продуктов перекисного окисления) и зависимых от него нормальных и патологических процессов в клетке.

Гипотеза 3: Повышение мощности и активности митохондриального дыхания может, в зависимости от степени снижения дисбаланса $\Delta(PO-AO)$, вызывать обратное развитие (реверсию) клетки в одно из предшествующих ее «специализированных» состояний.

Гипотеза 4: Повышенные спонтанная и индуцированная малигнизируемость эмбриональных и стволовых клеток, а также их обратная ревертируемость в нормальное состояние определяются преимущественно малым числом митохондрий и/или их дефектностью и соответственно изначально повышенным уровнем в указанных клетках «пролиферативного» дисбаланса $\Delta P(PO-AO)$.

Чтобы проверить правильность выдвинутых гипотез, необходимо, прежде всего, уметь стимулировать и, наоборот, замедлять процесс биогенеза митохондрий в различных (эмбриональных, стволовых, раковых, стареющих) клетках. Регулируя уровень окислительного стресса (т.е. про- и антиоксидантного дисбаланса) можно управлять процессами пролиферации и дифференцировки клеток. Следовательно, открывается реальная возможность разработать метод лечения злокачественных опухолей путем реверсии (возвращения) раковых клеток в исходное нормальное состояние, а в случае клеточной терапии различных дегенеративных заболеваний (как, например, инсульт мозга, инфаркт миокарда, сахарный диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера и др.) – разработать методы направленной дифференцировки трансплантируемых стволовых клеток в зоне поражения органов-мишеней.

ОНКОЛОГИЯДАҒЫ ИММУНОМОДУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕМ.

Балтабеков Н.Т., Аманбеков Н.А.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Алматы қалалық онкологиялық диспансер.

Өзектілігі: Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарға көмек көрсету Қазақстан Республикасындағы медицинаның және халық денсаулығын сақтау саласының ең күрделі мәселелерінің бірі болып отыр (Арзықұлов Ж.Ө. 2002 ж.).

Қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың емінің тиімділігі көптеген факторларға байланысты. Ең маңыздылары – ісіктің даму сатылары, гистологиялық құрылымы, науқастың жалпы жағдайы, бұған қоса өмірлік маңызды ағзалар жағынан қосымша ауруының болуы. (Абисатов Х.А. 2007).

Онкологиялық ауруларды емдеудің негізгі әдістері хирургиялық, сәулелік, химиотерапиялық, ісіктің кейбір түрлерінде гормондық және имунотерапиялық әдістер де қолданылады.

Қазіргі таңда имундық терапия онкология саласында бүйрек рагы және тері меланомасы кезінде кеңінен қолданылады.

Ісіктің III-IV даму сатысына сәйкес келетін клиникалық дамыған түрінде имунотерапияның мүмкіндіктері төмен

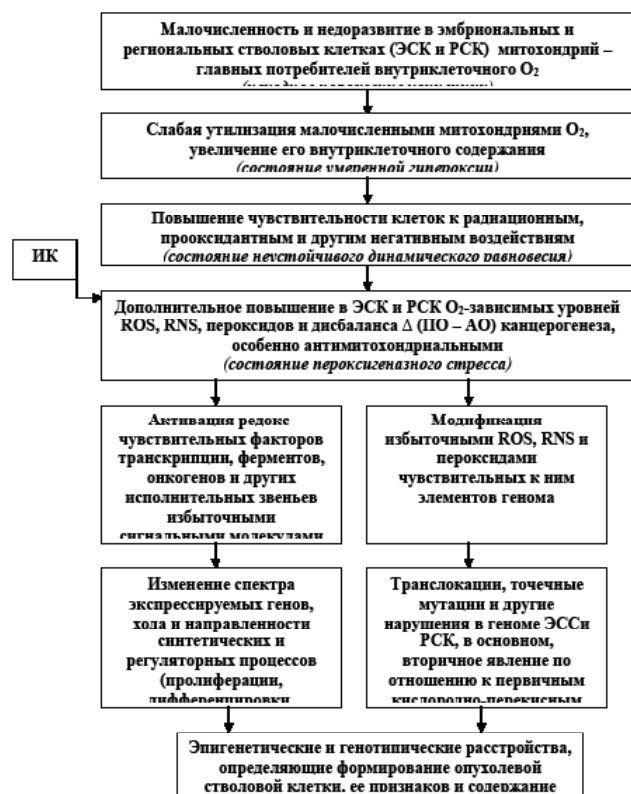


Рис. Структурно-функциональная блок-схема митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции канцерогенеза. ИК – индукторы канцерогенеза; ROS – активные формы кислорода; RNS – активные формы азота.

екендігін иммуномодуляцияны қолданудың әлемдік тәжірибесі көрсетіп отыр.

Бұл біріншілік ісіктің имуносупрессивтік әсерімен (ісіктің көлемі ұлғайған сайын имуносупрессия мен имундық тапшылық айқын білінеді), сонымен қатар, өмірлік маңызды ағзалардың қызметінің бұзылысымен және жалпы организмнің имунитетінің төмендеуімен түсіндіріледі.

Біздің ойымызша онкологиядағы иммуномодуляциялық емнің болашағы бар бағыты болып:

- Оны хирургиялық әдіспен қабаттастырып қолдану. Ісіктің негізгі бөлігі алынып тасталғанда имунитетті көтеруге мүмкіндік бірден жоғарылайды.

- Цитостатиктермен сәулелік емнің имундық тапшылық тудыру әсеріне қарсы күрес жүргізу мақсатымен ісікке қарсы қолданылатын базисті химиотерапияның курстарының арасында имундық реттеу.

- Ісіктік процессті тұрақтандыру және IV даму сатысындағы науқастардың өмір сапасын жақсарту мақсатымен ісіктің асқынып кеткен даму сатысында имундық реттеу

- Имундық реттеуші ем жүргізген кезде міндетті түрде емге дейін, емдеу барысында және емнен кейін науқастардың имундық статусын анықтау.

- Иммуномодуляцияны жүргізген кезде индукциялаушы және орынбасушы қызмет атқаратын дәрілер қабаттастырылуы керек.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОУРОЛОГИИ

Тажединов И.Т., Исмаилова Г.Н., Кайназаров Ч.
Казахский НИИ онкологии и радиологии,

Современная радионуклидная диагностика обладает комплексом методов исследования онкоурологических больных, которым без исключения показана скintiграфия почек. У больных раком предстательной железы, мочевого пузыря и почек проведена динамическая скintiграфия почек и мочевых путей на гамма-камере Philips Forte (Германия) с ^{99m}Tc -ДТПА и «Натрий о-йодгиппурат, ^{131}I раствор для инъекций», разработанный ИЯФ НЯЦ РК. Ежегодно количество исследований возрастает. Динамическая скintiграфия почек проведена 76 и скintiграфия скелета у 136 больных. Специфический маркер определен у 38 больных раком предстательной железы.

При раке почки по скintiграмме можно определить характер поражения, объем функционирующей паренхимы и также состояние секреторно-экскреторной функции, что немаловажно при планировании органосохраняющих операций. При тотальном поражении изображение отсутствует с афункциональным типом кривой в виде «немой почки». Динамическая скintiграфия позволяет оценить функцию и противоположной почки. По показателю клиренса можно оценить суммарную выделительную функцию почек. Этот показатель может установить степень почечной недостаточности. Опухолевое образование почки часто сопровождается ее смещением. При сдавлении извне возможно смещение почки с незначительной деформацией без существенных уменьшений объема функционирующих нефронов по сравнению со здоровой почкой. При прорастании опухоли извне в почку в зависимости от степени вовлечения процесса объем функционирующих нефронов будет меньше, чем в интактной противоположной почке.

Нарушение экскреции наблюдалось при раке мочевого пузыря, при поражении устьев мочеточника. Визуально на стороне поражения на фоне изображения почки определяется очаг скопления радиоактивности в лоханке и силуэт мочеточника. При длительной блокаде мочеточника со стороны поражения определяются нарушения секреторно-экскреторной функции вплоть до афункционального типа кривой и «немой почки». При раке простаты степень нарушения секреторно-экскреторной функции почек прямо зависят от местной распространенности процесса.

Для диагностики, оценки эффективности лечения, установления рецидивов и метастазов рака простаты в сыворотке крови определяют методом радиоиммунного анализа специфический антиген простаты (ПСА). ПСА является гликопротеином с молекулярной массой 34 кДа, который на 90% представляет собой простую полипептидную цепь из 238 аминокислот и содержит 10% углеводородных остатков. Относится к группе капикренинов. Показано, что он является специфическим продуктом как здоровой, так и опухолевой ткани. ПСА присутствует в простатической жидкости, семенной жидкости, здоровой, гиперплазированной и злокачественно трансформированной ткани простаты, а также метастазах простатического происхождения. ПСА продуцируется парауретральными железами и повышается при раке простаты. Значения нормы 0-4 нг/мл, пограничные 4-10 нг/мл, патологии 10 нг/мл и выше. Существует возрастная норма.

При раке простаты и раке почки для выявления метастазов в костях производится скintiграфия скелета с ^{99m}Tc -технефором. На скintiграммах метастазы в костях проявляются в виде гиперфиксации остеотропного препарата на фоне нормального изображения скелета. ^{99m}Tc -технефор выводится с мочой, и при запущенном раке простаты из-за задержки мочи четко визуализируются расширенные чашечки, лоханки, мочеточники и мочевого пузыря. Их степень расширения прямо пропорциональны размерам образования и длительности процесса.

С помощью радионуклидного метода можно получить высокоточные результаты, необходимые в диагностике, планировании лечения и оценке ее результатов, а также наблюдении за больными с опухолями почки, мочевого пузыря, простаты.

Радионуклидные исследования отличаются высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике и оценке эффективности новых инновационных методов лечения онкоурологических заболеваний, а также в анализе результатов научных исследований.

МЕТИЛИРОВАНИЕ CpG-ОСТРОВКОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ УЧАСТКОВ ГЕНА. CHN2 В НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА.

Ермекова С.А., Тулеева Л.Н., Маншарипова Б.Т.
КазНИИОР, МЗ РК

Рядом авторов, согласно литературным данным, отмечено, что характер метилирования в неопластических клетках значительно изменяется по сравнению с нормальными клетками, причем тотальное деметилирование генома сопровождается увеличением активности метилтрансферазы и локальным гиперметилированием CpG-островков. Гиперметилирование CpG-островков приводит к стабильной инактивации прилежащего гена. Это происходит в результате возникновения стерических препятствий к связыванию транскрипционных факторов или гетерохроматинизации, опосредованной метилцитозин-связывающими белками. Аберрантное метилирование CpG-островков является ранним событием в процессе возникновения опухоли. Доказанным является тот факт, что инактивация гена супрессора опухолевого роста или гена репарации может привести к неконтролируемой пролиферации.

Целью являлось определение уровня метилирования CpG-островков промоторной области гена CHN2 в низкодифференцированных аденокарциномах желудка.

Для исследований брали биопсийный материал и кровь до лечения больных и послеоперационный материал после лечения. Выделяли ДНК и проводили МС-ПЦР-амплификацию CpG-островков гена CHN2.

В большинстве случаев метилированные и частично ме-

тилированные аллели промотора гена *CHK2* были обнаружены в опухолях, тогда как в контрольных прилегающих тканях метилированные цитозины выявлялись в незначительном количестве или не обнаруживались совсем. Такое гиперметилирование приводит к инактивации гена и тем самым нарушает контроль за повреждениями в клетках с высокой пролиферативной активностью из-за отсутствия белка *CHK2*. Основной функцией которого является выявление повреждений в ДНК и остановка синтеза ДНК до репарации повреждений. Отсутствие контроля приводит к размножению клеток с измененным геномом и быстрому росту опухоли. Таким образом, данный полиморфизм промоторной области гена *CHK2*, выявленный в результате проведения метил-специфической ПЦР, свидетельствует о наличии глубоких поломок в системе регуляции клеточного цикла в опухоли и может являться предсказательным критерием в диагностике и прогнозе злокачественных опухолей желудка.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНА *BRCA1* У БОЛЬНЫХ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА.

Тулеева Л.Н., Маншарипова Б.Т., Еремкова С.А.
Каз.НИИОуР, МЗ РК

Одним из важных опухолевых супрессоров является ген *BRCA1*, участвующий в р53-зависимом и р53-независимом сигнальных путях регуляции клеточного цикла. Известна взаимосвязь между наследственными мутациями гена *BRCA1* и возникновением и прогрессией рака молочной железы в 80%, рака яичников в 20-50% случаев. У индивидуумов с мутациями в этом гене также наблюдается высокий риск развития рака желудка, толстого кишечника и простаты. В клетках с дефектным *BRCA1* наблюдается сильная генетическая нестабильность, т.е. повышение частоты возникновения спонтанных или индуцированных мутагенами генетических изменений – генных мутаций, хромосомных транслокаций, анеуплоидии и т.д.

Целью исследования явилось выявление важных для онкогенеза полиморфизмов онкосупрессора *BRCA1* при раке желудка.

Материалом исследования был биопсийный материал, взятый от 21 больного раком желудка до проведения комбинированного лечения, кровь и послеоперационный материал (опухоль, прилегающие к ней нормальные ткани), взятые после проведения комбинированного лечения, а также послеоперационный материал и кровь от 11 больных раком желудка, получивших только хирургическое лечение. Выделяли ДНК и проводили ПЦР-амплификацию отдельных локусов гена *BRCA1*. Далее мы изучили полиморфизм трех участков гена *BRCA1*. Первым был исследован полиморфный локус, содержащий кодон 356. Нами было показано, что данный участок гена отличается высоким полиморфизмом и в равной степени представлен во всех тканях в пределах одного организма, но варьирует у разных пациентов. В результате проведенного анализа было выявлено три генотипа: гетерозиготный генотип RQ, два гомозиготных генотипа по аллелю дикого типа RR и мутантному аллелю QQ. Частота каждого генотипа составила 0,05; 0,24 и 0,71 для RR, RQ и QQ, соответственно. Распределение частот аллелей составило 0,18 и 0,72 для аллелей R и Q, соответственно. Это указывает на то, что в результате единичной нуклеотидной замены в синтезируемом белке происходит замена аминокислоты аргинина на глутамин. Аллель R, соответствующий белку, содержащему аргинин при ПЦР реакции формирует ампликон размером в 211 п.н. В результате замены нуклеотида формируется сайт для рестриктазы *AluN1*, таким образом при наличии данной точковой мутации после обработки рестриктазой формируется два фрагмента в 134 п.н. и 77 п.н., что соответствует аллелю Q. Таким образом, в исследуемом кодоне в большинстве образцов тка-

ней, взятых от больных, обнаруживалась мутация с заменой основания в обоих аллелях, что может быть использовано для диагностики и лечения таких больных. Кроме того, нами были проанализированы два локуса, несущих делеционный полиморфизм в 11 экзоне, кодон 502, порядковый нуклеотид 1623, мутантный аллель включал делецию пяти нуклеотидов и в 16 экзоне, кодон 1655, нуклеотидная позиция 5083, мутантный аллель включал делецию девятнадцати нуклеотидов. В результате проведенного анализа выявили, что частота мутантного аллеля полиморфных локусов гена *BRCA1* в 11 экзоне составила 0,053, в 16 экзоне соответственно 0,073. Не наблюдалось различий в распределении частот аллелей в разных тканях в пределах одного организма. Таким образом, изученные нами полиморфные локусы гена *BRCA1* являются представителями общего популяционного полиморфизма и могут выступать в качестве эффективных генетических маркеров при определении предрасположенности и риска развития онкологических заболеваний в популяционных исследованиях и при семейном анализе, но не могут быть использованы в качестве маркеров эффективности проводимой терапии.

ТИП ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Мукашьева С.А.

Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: общность патогенетических механизмов данных патологий эндометрия определяет дальнейшие перспективы для установления наиболее ранних принципов диагностики и изучения биологических особенностей рака эндометрия с целью раскрытия сущности внутриклеточных процессов при предопухолевых и опухолевых состояниях эндометрия. В модуляции пролиферативной активности эндометрия, помимо гормонов, могут играть роль и другие биологически активные соединения, такие как цитокины, тесно связанные с иммунной системой.

Цель: изучение экспрессии цитокинов в перитонеальной жидкости при миоме матки.

Материалы и методы: было проведено клиническое обследование 27 пациенток: 20 женщин, имевших миому матки (основная группа) и семи – не имевших миомы матки (группа сравнения), которым проводилась диагностическая лапароскопия в связи с трубной формой бесплодия.

Результаты: уровень IL-10 у пациенток с миомой повышен. Уровень цитокинов у пациенток с миомой проанализирован в зависимости от клинических вариантов. Выявлены повышенные уровни IL-10, GM-CSF, IFN- γ и TNF- α при длительности течения заболевания более 5 лет чем при миоме матки менее 5 лет. Обнаружен повышенный уровень IL-10 при растущей опухоли, при наличии аденомиоза. При размере матки, менее 8 недель, уровень IFN- γ выше, чем в группе более 8 недель. IFN- γ в перитонеальной жидкости при миоме матки обратно коррелировало с размером матки. Повышение уровня IL-5 у пациенток с единичными узлами (менее 5) в сопоставлении с большими, имевшими множественные узлы (5 и более). Интрамуральная и субсерозная локализация узлов характеризовалась повышенным IL-5. Выявлена сдерживающая роль Th1-типа иммунного ответа в прогрессировании миомы. Подтверждением этому является отрицательная корреляция между размером опухоли и IFN- γ . Длительно существующий пролиферативный процесс вызывает активацию иммунитета по Th1 пути, на что указывает увеличение IL-10, GM-CSF, IFN- γ и TNF- α в перитонеальной жидкости больных миомой. Отмечено относительное увеличение Т-хелперов и NK-клеток при развитии опухоли больших размеров и многоузловых форм миомы.

Таким образом, недостаточность клеточного звена иммунитета является одной из предпосылок быстрого развития миомы. Увеличение экспрессии IL-10, отмеченное при ра-

ствующей миоме, может свидетельствовать о неблагоприятной роли Th2-типа иммунного ответа в развитии опухоли.

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ В ОНКОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ РАДИОИММУННОГО АНАЛИЗА

Хан О.Г., Тажединов И.Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Опухолевыми маркерами называются соединения, которые продуцируются клетками или организмом в ответ на развитие опухоли. Опухолевые маркеры – это вещества, в связи с измененным метаболизмом злокачественно трансформированной клетки, а потому при возникновении опухоли их уровни повышаются. Определение опухолевых маркеров возможно проводить в гистологическом материале или в биологических жидкостях (сыворотка крови, слюна и т.д.). В настоящее время измерение уровней опухолевых маркеров широко используется в диагностике, лечении и при наблюдении за состоянием онкологических больных. Позволяют дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли, своевременно выявлять и диагностировать рецидив заболевания, и следовательно измерение уровня соответствующего маркера может решающим образом повлиять на ход и эффективность лечения.

Для радиометрии используется автоматизированный 12-ти канальный настольный медицинский гамма-счетчик «PC-RIA Mab strates» производства Германия, предназначенный для количественного определения опухолевых маркеров, гормонов и биологически активных веществ радиоиммунологическим методом исследования. Гамма-счетчик открытого типа, работает на реактивах любых производителей, количество стандартов неограниченно.

В лаборатории КазНИИОиР проводят исследования по определению специфичных опухолевых маркеров: СА 15-3 для опухолей молочных желез, СА 125 – рака гинекологической локализации, СА 19-9 – рака желудочно-кишечного тракта, ПСА – рака простаты и универсального раковоэмбрионального антигена РЭА. Ежегодно количество исследований возрастает. Так, в 2009 году оно составило 636, напротив 300 исследований 2008 года.

РЭА – раковоэмбриональный антиген является гликопротеином с молекулярной массой 180 кДа, состоящим на 55% из полисахаридов, а на 45 % из белк. РЭА является онкофетальным белком, который обнаруживается в эпителиальных клетках пищеварительного тракта и бронхов. У взрослых людей РЭА продуцируется в очень ограниченном количестве эпителиальными клетками бронхов, молочной железы и кишечного тракта. РЭА метаболизируется в печени. РЭА повышается при раке ЖКТ, легких, молочных желез, яичников и матки, простаты. Значения нормы 0-5 нг/мл, пограничные 5-8 нг/мл, патологии 8 нг/мл и выше.

Специфический антиген СА 15-3 является опухолевым маркером, открытым с помощью моноклональных антител, имеет мукогликопротеиновую структуру с молекулярной массой 300-450 кДа и относится к онкофетальным белкам. СА 15-3 повышается при раке молочных желез. Значения нормы 0-22 МЕ/мл, пограничные 22-30 МЕ/мл, патологии 30 МЕ/мл и выше.

СА 125 является специфичным маркером, обнаруженным с помощью моноклональных антител., имеет мукогликопротеиновую структуру с молекулярной массой около 200 кДа и относится к онкофетальным маркерам. СА 125 повышается при раке яичников, матки, эндометрия. Значения нормы 0-30 МЕ/мл, пограничные 30-40 МЕ/мл, патологии 40 МЕ/мл и выше.

СА 19-9 является муцин-сиало-гликолипидом с молекулярной массой более 500 кДа, относится к онкофетальным опухолевым маркерам, открытым с помощью монокло-

нальных антител. СА 19-9 повышается при раке желудка поджелудочной железы, желчного пузыря и желчных путей, раке печени и метастазах выше перечисленных карцином. Значения нормы 0-30 МЕ/мл, пограничные 30-40 МЕ/мл, патологии 40 МЕ/мл и выше.

Специфический антиген простаты ПСА является гликопротеином с молекулярной массой 34 кДа, который на 90% представляет собой простую полипептидную цепь из 238 аминокислот и содержит 10% углеводородных остатков. Относится к группе капикренинов. Показано, что он является специфическим продуктом, как здоровой, так и опухолевой ткани. ПСА присутствует в простатической жидкости, семенной жидкости, здоровой, гиперплазированной и злокачественно трансформированной ткани простаты, а также метастазах простатического происхождения. ПСА продуцируется парауретральными железами. ПСА повышается при раке простаты. Значения нормы 0-4 нг/мл, пограничные 4-10 нг/мл, патологии 10 нг/мл и выше.

Таким образом, появление высокого уровня специфических антигенов в организме настораживает о возможном прогрессировании развития опухоли, нарушении регуляции опухолевых клеток и в целом плохой прогноз. Все указанное свидетельствует об обязательной необходимости проведения данных диагностических радиоиммунных исследований.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Сейдуалиева Б.С., Сарсебеков Е.К.

Центральная клиническая больница Управления делами
Президента РК, г.Алматы

Сочетанное определение нескольких специфических онкомаркеров позволяет повысить эффективность диагностики новообразований.

Цель выполнения этой работы — своевременное обнаружение злокачественных опухолей на фоне хронических заболеваний и неопластических процессов.

Материалы и методы. Оценивалась диагностическая и прогностическая значимость определения концентрации трех онкомаркеров: СА 125, РЭА и СА 19-9 у женщин с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями в органах репродуктивной системы. Для определения концентрации онкомаркеров применялись диагностические тест-системы «Roche Diagnostics» (Швейцария). Определения проводились на автоматическом анализаторе Elecsys 2010 той же фирмы. СА 125, РЭА и СА 19-9 определяли в образцах сыворотки крови, полученной от 54 женщин разного возраста. У всех пациенток проводили определение концентрации СА 125 до операции. У больных, имеющих уровень этого антигена более 10 МЕ/мл, определяли также содержание РЭА и СА 19-9. В зависимости от клинического диагноза пациентки были разделены на 5 групп: 1-я группа — контрольная — гинекологически здоровые женщины, нуждающиеся в пластических операциях гениталий (n=8); 2-я группа — с воспалительными заболеваниями (n=6); 3-я группа — с миомой матки (n=10); 4-я группа — с доброкачественными опухолями яичников (n=11); 5-я группа — с эндометриозом (n=14); 5-я группа — со злокачественными опухолями яичников, в том числе аденокарциномой яичников (n=5).

Полученные результаты свидетельствуют о достоверных различиях в содержании антигенов СА 125, РЭА и СА 19-9 у пациенток контрольной группы и гинекологических больных, причем наиболее выраженные изменения наблюдались у больных эндометриозом яичников и пациенток со злокачественными опухолями. Уровень СА 125 выше 35 МЕ/мл обнаружен у 9 пациенток из 54. При этом только у 5 из них имелись онкологические заболевания: у 5 диагностирована аденокарцинома яичника (уровень СА 125 составил 81,

82, 133, 261 и 401 МЕ/мл). Доля пациенток с повышенным уровнем СА 125 среди обследованных больных составила 17%, что превышает опубликованные данные (6%) об этом показателе в 2,4 раза. Следует обратить особое внимание на то, что доля пациенток с повышенным уровнем СА 125 варьирует в зависимости от заболевания. Так, при миоме матки количество таких больных 8%, а при ретроцервикальном эндометриозе — 23%. Эндометриоз различной локализации занимает второе место после злокачественных образований по количеству больных, у которых концентрация СА 125 превышает критическое значение (СА 125 более 35 МЕ/мл). Среди больных аденокарциномой яичника повышенный уровень СА 125 отмечен в 100% случаев. Наибольшая доля пациенток с повышенным уровнем РЭА отмечалась среди больных эндометриозом яичников, а повышенный уровень СА 19-9 практически одинаково часто встречался у пациенток с эндометриозом яичников и злокачественными опухолями органов репродуктивной системы.

Выводы. Результаты проведенной работы свидетельствуют об относительно высокой диагностической ценности определения СА 125 у гинекологических больных, особенно у пациенток с эндометриозом, поскольку практически у каждой четвертой из них уровень СА 125 превышает критическое значение (35 МЕ/мл). Одновременное определение в сыворотке крови гинекологических больных трех маркеров СА 125, РЭА и СА 19-9 дает дополнительную информацию и позволяет проводить дифференциальную диагностику эндометриоза и злокачественных опухолей яичников.

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Сарсебеков Е.К., Сейдуалиева Б.С.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК, г.Алматы

Онкозаболевания, как причины смертности, стоят на втором месте после сердечно-сосудистой патологии. Среди злокачественных новообразований наиболее часто встречаются рак легкого — 27%, рак молочной железы — 18%, колоректальные опухоли — 12%. Затраты на лечения таких больных могут неоправданно возрасти за счет несвоевременной диагностики (в основном позднего выявления в неоперабельных стадиях) и отсутствия послеоперационного мониторинга эффективности лечения.

Для решения этой задачи широко используется лабораторный анализ — определение в крови онкомаркеров методами иммуноферментного (ИФА), иммунолюминесцентного (ИЛА) и радиоиммунного (РИА) анализа, что позволяет:

- своевременно отобрать для детального обследования больных группы повышенного риска;
- не подвергать тяжелой, дорогостоящей и бесполезной операции больных с отдаленными метастазами, которые далеко не всегда выявляются методами визуализации;
- задолго (за 4-6 месяцев) до появления клинических признаков выявить локальные рецидивы и определить характер метастазирования у прооперированных больных, что позволит принять правильное решение по тактике лечения и тем самым снизить расходы на него.

Стоимость определения онкомаркеров составляет всего около 10 у.е., но она многократно окупается экономией на расходах при хирургическом и послеоперационном лечении за счет обоснованного отбора больных.

Онкомаркеры — это специфические белки, продуцируемые опухолевыми клетками, содержание которых в крови коррелирует с наличием или прогрессирующим ростом злокачественной опухоли. В настоящее время нет «идеального» маркера со 100% специфичностью (т.е. не обнаруживающегося у здоровых) и 100% чувствительностью (т.е. обязательно

выявляемого у всех больных даже в начальной стадии рака). Поэтому они ни в коем случае не должны определяться при массовых обследованиях бессимптомных пациентов в качестве скрининга на выявление злокачественного роста. Тем не менее, существуют маркеры с достаточно высокими специфичностью и чувствительностью, позволяющие применять их и для первичной диагностики в группах риска или у имеющих симптоматику рака пациентов.

Ценность цитологических методов диагностики рака не подлежит сомнению, но в 10-20% случаев биопсий не удается получить материал, содержащий опухолевые клетки при наличии злокачественной опухоли. Недоступность ЯМР-томографии как массового метода диагностики для большинства пациентов не позволяет визуализировать опухоли внутренних органов и метастазы размером до 0.5-1 см. В таких случаях только определение онкомаркеров дает возможность решить диагностические проблемы, особенно при определении их в динамике: прирост уровня онкомаркера за 1-2 месяца вдвое даже при исходно нормальном уровне — явный признак роста опухоли.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Дарменов О.К., Оразбеков Н.И.,

Избасаров Р.Ж., Дарменов Е.О.

Кафедра хирургии с курсом кардиохирургии, анестезиологии-реанимации и УЗ-диагностики, КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы

В диагностике опухолевого процесса, наряду с имеющимися традиционными методами, в последние годы наиболее широкое распространение получили ультразвукография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Примененные эндовидеолапароскопические исследования с подозрением на опухолевый процесс проводились, как правило, в качестве окончательного этапа диагностики, когда разрешающая способность остальных использованных методов была исчерпана. С другой стороны, возможность визуальной оценки состояния внутренних органов с наличием предполагаемого опухолевого процесса предполагает так же и определение степени его распространенности, наличие или отсутствие метастатической диссеминации по брюшной полости в программе предоперационного обследования больных.

Из 56 пациентов, обследованных с подозрением на опухолевый процесс в брюшной полости, у которых другие методы были малоинформативными, подтверждение диагноза получено у 12 (21,4%) больных, отвергнуто — у 26 (46,4%) пациентов, а в 18 (32,2%) случаях выявлены признаки иной патологии. Ошибочный диагноз установлен у 7 больных (12,5%). Осложнений и летальных исходов не было.

Применение видеолапароскопического оборудования и эндохирургического инструментария расширило горизонты использования технологии, дополняя в полной мере имеющиеся методы диагностики. Исследования применяли для определения стадийности опухолевого процесса, наличия метастазирования (регионарного и отдаленного) уже диагностированного заболевания и для оценки возможности проведения радикальной операции на основе использования видеотехнологии и эндохирургического инструментария, позволяющего визуализировать труднодоступные для осмотра анатомические зоны и производить забор материала для гистологического анализа.

Исследования выполняли в плановом порядке со стандартной методикой введения оптики и инструментов в брюшную полость. Из 12 проведенных видеолапароскопических исследований у пациентов с подозрением на опухолевый процесс, у 4 выявлены признаки распространенности зло-

качественного роста, не диагностированные при других исследованиях: канцероматоз брюшины – у 2 больных, мелкие метастазы печени – у 1, прорастание опухоли в соседние органы – у 1. Данные подтверждены результатами биопсии, что предопределило проведение эксплоративной лапаротомии. В 8 случаях при имеющихся исходных данных об онкологическом заболевании у больных при тщательной эндоскопической ревизии признаков метастазирования опухоли не было выявлено, что послужило проводом для проведения радикального оперативного вмешательства. В одном случае (у больного с опухолью желудка) при видеолaparоскопии метастатический процесс не был распознан, но при лапаротомии определено поражение парааортальных лимфоузлов (диагноз признан ложноотрицательным), что послужило поводом для проведения паллиативной субтотальной резекции желудка.

Таким образом, эндовидеолaparоскопия является важным дополнением к комплексу диагностических исследований, проводимых больным с опухолевидными заболеваниями органов брюшной полости. Накопленный опыт видеолaparоскопических вмешательств позволяет сделать вывод о высокой эффективности данного метода, и целесообразности их широкого применения в онкологической клинике.

ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Баймаханов Б.Б., Толеутайұлы К., Байкадамов А.Х.,
Оспанов Ш.Е., Тулеутаева С.Ж., Кашаков Б.С.,
Ербошаев С.Е., Толеутай У.К.*

Кызылординский областной онкологический центр

В рамках выполнения приказа МЗРК №16 от 11.01.2005 г. «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров женщин репродуктивного возраста за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета» и №607 от 15.10.2007г. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения» в области начата профилактическая маммография. Маммографическому скринингу предшествовала активная просветительная работа с использованием СМИ (телевидение, областные и районные газеты, календары женского здоровья).

Целью исследования явилось изучение возможностей маммографического скрининга в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы.

Материалы и методы: был проведен анализ 77 430 маммографических исследований с 2006-2009 гг.

В области имеются 7 маммографических установок, 3 из них в областном центре и в 4-х районных центрах. С 2006 по 2009 гг. проведено 77 430 маммографических исследований, из них 15 852 (20,5%) в условиях областного онкологического центра. При этом выявлены следующие патологические процессы: подозрение на рак молочной железы у 334 женщин (0,4%), рак у 163 (0,2%), фиброаденома молочной железы у 1468 (1,8%) и другие формы мастопатии у 21 276 (27,4%). Из 15 852 исследований проведенных в условиях онкологического центра профилактическая маммография проведена 14 979 (94,5%), а 873 (5,5%) женщинам диагностическая маммография.

В период с 2005 по 2009 гг. В Приаралье имело место рост заболеваемости рака молочной железы. Если показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2005 году составлял 9,4, то аналогичный показатель в 2009 году составил 12,8. (по РК – 20,5 на 100 тыс. населения).

Хотя показатель РМЖ в Кызылординской области был ниже, чем в РК, однако на протяжении всего периода отмечался интенсивный рост заболеваемости РМЖ в Кызылор-

динской области, особенно после внедрения маммографического скрининга.

Нами проанализированы данные по запущенным стадиям РМЖ в регионе за пятилетний период.

Высокие показатели запущенности в III или IV стадии заболевания имело место в 2005 году, когда он достигал 34,4% от общего числа выявленных случаев. После внедрения профилактической маммографии процент выявления РМЖ в поздней стадии снизился до 26,5% и улучшились показатели ранней диагностики рака молочной железы с 65,0 до 73,5%.

В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной профилактики, т.е. выявления опухолей молочной железы в той стадии, когда она может быть излечена существующими методами лечения. существующая организация, техническая оснащенность и методология обследования не могут обеспечить раннее выявление РМЖ. Внедрение современного маммографического скрининга с 2006 года существенно уменьшил процент запущенности РМЖ. Однако, имеющаяся сеть маммографов в области все еще недостаточно для полноценного обследования, особенно жителей села. Для дальнейшего улучшения ранней диагностики РМЖ необходимо: адекватное финансирование программы, кадровое обеспечение, достаточное обеспечение современными маммографическими оборудованностями районов области и пропаганда целесообразности ранней диагностики.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

*Иембергенов А.И., Сатыбалдина Р.М., Наинбаева М.С.,
Алмагамбетова К.А., Каргабаев С.Х.*

В диагностическом центре г.Алматы начиная с 2001 г. по август месяц 2010 года обратилась за помощью 12704 женщин с заболеваниями молочной железы т.е. клинически с разными формами фиброзно-кистозной болезнью, из них у 494 женщин диагностировано фиброаденома, а у 153 женщин рак молочной железы. Рак молочной железы установлен путем применения УЗ-исследования, маммография с пункционной биопсией опухоли с морфологическим исследованием. Больные с установленным диагнозом рак молочной железы были направлены на лечение в онкологический диспансер.

Диагностика заболеваний молочной железы основывается на осмотре молочных желез, их пальпации, маммографии, УЗИ, пункции узловых образований, подозрительных участков и цитологическом исследовании пунктата.

В настоящее время кроме УЗ-исследования наиболее распространенным методом является – маммография. Достоверность его высокая, на снимках можно определить около – 81-96% всех патологических изменений, а при раке молочных желез она достигает 95%, причем этот метод позволяет выявлять доклинические т.е. непальпируемые (менее 1см в диаметре) опухоли.

Рентгенологическое исследование молочных желез проводится в специальном кабинете на рентгеновской установке – маммографе с биопсийной приставкой Alpha ST, производство Финляндия, 2004 года выпуска. Данный рентгеновский аппарат функционирует в диагностическом центре начиная с 2006 года, за это время в центре рентгенологическое исследование молочных желез произведено у 2716 женщин.

Огромное внимание уделяется качеству производства снимков, что позволяет получить высококачественные снимки.

Маммография обладает высокой чувствительностью и она не заменяема при диагностике не пальпируемых форм рака молочной железы. За это время пяти случаях нам удалось во время маммографии диагностировать рак молочной железы при отсутствии клинического проявления. Рентгеновскими признаками были наличие тени образования с неровными лучистыми контурами и хаотично расположенными микро-

кальцинатами внутри. У большинства из них патология выявлялась на фоне имевшей место фиброзно-кистозной мастопатии. Эти больные в течение 3 лет наблюдались у маммолога и ограничивались только УЗ-исследованиями молочных желез, они получили лечение по поводу диффузно фиброзно-кистозной мастопатии. Для уточнения диагноза им произведена пункционная биопсия с последующим морфологическим исследованием пунктата с образования. Они затем продолжали лечение в условиях онкологического диспансера. Таким образом, маммография является эффективным методом позволяющим повысить диагностическую точность опухолей молочных желез в сочетании с другими методами комплексного исследования.

ПРИЧИНЫ НЕТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

Параклинические методы диагностики (УЗИ, маммография, цитология и гистология) всегда дополняют результаты клинического способа идентификации болезни. Они не лишены недостатков – в среднем до 25-30%. Их заключение бывает ошибочным, если применено в единой системе диагностики. Комбинированное и комплексное использование их повышает процент достоверности диагноза до 90-92% случаев.

Причинами неточности диагноза при параклинических методах диагностики являются:

- Технические погрешности в методиках выполнения (4-10%)
- Низкая квалификация врача и недоучет факторов, характеризующих биологические особенности организма больной и опухоли (30-35%)
- Несопоставление данных клиники с данными параклинических методов диагностики (20%)
- Глубина расположения и размеры первичного опухолевого очага в молочной железе (10,0%)
- Не обозначение этапности нахождения удаленных лимфоузлов (15%)
- Объективная несостоятельность диагностических способов и идентификации болезни (20,0%)

Следующие факторы прямо или косвенно оказывают влияние на постановку неверного диагноза или возможность объективно оценить стадийность развития онкопроцесса:

- Агрессивное течение болезни (в $5,0 \pm 0,9\%$ случаях)
- Глубина расположения опухолевого очага ($10,0 \pm 1,3\%$)
- Немаркировка этапности или места нахождения лимфоузлов, удаленных во время операции ($15,0 \pm 1,5\%$)
- Несостоятельность существующих методов диагностики ($20,0 \pm 1,7\%$)
- Вариативность течения болезни и низкая квалификация врача ($50,0 \pm 1,7\%$)
- Знание врачами причин диагностических неточностей дает основание своевременно ликвидировать их и тем самым создает условие для повышения эффективности медицинских мероприятий.

СОСТАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

План лечения и его реализация будет наиболее эффективным тогда, когда он обеспечивает наибольшую пятилетнюю выживаемость больных. Последнюю можно достичь, если учитываются следующие факторы:

I Стадия распространения опухоли непосредственно оказывает влияние на 5-летнюю выживаемость: при I стадии она равна $94,0 \pm 1,0\%$; при II стадии – $80,0 \pm 1,7\%$; III

стадии – $60,0 \pm 2,0\%$; IV стадии- трехлетняя выживаемость составляет $37,8 \pm 2,0\%$.

II Клиническая форма заболевания также связана с отделенными результатами лечения: при узловой форме 5-летняя выживаемость равна $68,0 \pm 1,9\%$, а при диффузной – $32,0 \pm 1,9\%$. III Анатомическую форму опухоли истинно можно установить только на удаленном макропрепарате больной – хирург при этом иссекает и рассекает первичный опухолевый очаг и осматривает очаг на глаз, лучше, конечно, с лупой. Если имеются четкие границы (контуры) опухолевого узла, то в $80,0 \pm 1,71\%$ случаях можно достичь 5-летний уровень жизни, а при нечетких контурах опухоли последний показатель падает до $37,0 \pm 2,0\%$ ($P < 0,001$). Смешанные контуры опухоли дают чуть лучшие результаты – $42,0 \pm 2,0\%$ 5-летней выживаемости

IV Морфологическая структура опухоли – главный прогностический фактор. Она бывает инфильтрирующей (инвазивной) в $88,2 \pm 1,4\%$ случаев, неинфильтрирующей (неинвазивной) – $12,3 \pm 3,0\%$.

V Прогноз течения и исход болезни обычно плохой у молодых пациенток до 55 лет- в среднем женщины в этом возрасте пятилетний рубеж доживают $40,2 \pm 2,0\%$, тогда как такой показатель у больных старше 55 лет составляет $81,0 \pm 1,6\%$ ($P < 0,05$)

VI Несомненно, на состояние здоровья пациенток оказывает влияние иммунно-эндокринологический статус опухоли и организма больных, например, если иммунный статус положительный, то у $90,2 \pm 1,4\%$ больных болезнь протекает благоприятно. Если иммунный статус отрицательный, указанное число падает до $46,2 \pm 1,4\%$ ($P < 0,001$). Такая же закономерность выявляется при изучении эндокринологического статуса организма больных: выживаемость в целом лучше у пациенток с менопаузой ($72,4 \pm 1,9\%$), чем у женщин с пременопаузой ($34,2 \pm 2,0\%$) и с климаксом ($61,3 \pm 2,0\%$).

Определение уровня гормонорецепторов опухоли – решающий признак гормоночувствительности болезни, при его положительном уровне $69,2 \pm 2,0\%$ пациентки доживают пятилетний срок, а в случае отрицательного гормонорецептора последний снижается до $31,3 \pm 1,9\%$ ($P < 0,05$).

VII Исключительно важным является определение генного статуса организма больных и опухолевой ткани. Наличие положительного онкомаркера в крови ухудшает прогноз до $48,4 \pm 2,0\%$, а в отсутствии этого гена, наоборот, опухоль лучше поддается лечению – $71,3 \pm 2,0\%$ пятилетнего результата.

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

Повсеместный и динамичный рост заболеваемости опухолями молочной железы как доброкачественного, так и злокачественного характера ставит перед медицинской наукой и практическим здравоохранением очень важную задачу не допускать диагностических и тактических ошибок врачей-маммологов, онкологов в их практической деятельности.

В соответствии с задачами мы сопоставили данные анамнеза (1124), осмотра (1124), пальпации (1124) с данными морфологического исследования (550) у первичных больных раком молочной железы, при этом рассмотрен вопрос о ценности каждого клинического метода диагностики в отдельности и в комбинированном, комплексном их применении.

Было установлено, что один только собранный анамнез больной поможет врачу установить верный диагноз лишь в $50,0 \pm 2,4\%$ случаях, а осмотр – в $55,0 \pm 2,1\%$, пальпация органа – у $60,0 \pm 2,0\%$ пациенток. А когда применяются все эти методы комплексно, то удельный вес больных с правильным диагнозом увеличивается до $70,0 \pm 1,9\%$.

Причины возможных ошибок при каждом методе разные

и в основном они сводятся к следующему:

- Неумение врачей контактировать с больными (25%) из-за этого
- Анамнез собирается поверхностно (10%)
- Не выясняется роль каждой функции женского организма (менструальной, детородной и лактационной) в генезе патологии, в отдельности и в совокупности (5,0%)
- Не уточняется вопрос – имеет ли место в организме женщины наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, почек, наследственно-обменных процессов (7,0%)
- Отмечается ли сопутствующий иммунно-эндокринологический негативный фон в организме больной женщины (5-10%)
- Пациентки технически неправильно осматриваются (помещение плохо освещено из-за чего кожные симптомы болезни остаются не замеченными) или пальпируются (методика осуществляется грубо с применением силы) = 3,0%
- Не сопоставляются данные каждого метода исследования друг с другом (20%)
- Не объективно или ошибочно расцениваются данные клиники в результате недостаточных знаний и низкой квалификации врачей (15-20%).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОНКОМАММОЛОГИИ

Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

В онкологической и маммологической практике часто применяются параклинические методы (УЗИ, маммография, цитология, гистология исследования для постановки диагноза, без них невозможно определить характер заболевания. Однако их ценность – каждого из них в отдельности и в совокупности – не определены до настоящего времени; в литературе нет подобных сообщений о них., поэтому мы хотим поделиться практическим опытом по данному вопросу.

Цель. Изучить диагностическую возможность УЗИ. Маммографии, цитологии и гистологии в онкомаммологической практике.

За 10 летний период (2000-2010 гг.) прошли параклинические методы (УЗИ, маммография, аспирационная и эксцизионная биопсии) исследований 1124 больных раком молочной железы из них у 550 известны цитологические и морфологические результаты. С последними сопоставлены – сравнены - заключения УЗИ, маммографии, цитологии и гистологии

Оказалось, что когда применяется только одно ультразвуковое исследование, то оно в $25,0 \pm 1,8\%$ случаях сопровождается диагностической ошибкой а одна маммография – у $20,0 \pm 1,7\%$ больных. Пункция опухоли с последующим цитологическим исследованием мазков дает верный диагноз у $81,0 \pm 1,6\%$ пациенток, т.е. в 19% случаях регистрируется ошибка. Гистологическую структуру новообразования подробно удается узнать только у $87,0 \pm 1,4\%$ больных, т.е. ошибка находится в пределах 12-13% случаях. А когда все эти методы используются в комплексной схеме, то в $90,0-92,0 \pm 1,5\%$ случаях достигается правильный диагноз, т.е. ошибка бывает минимальной – в пределах 8-10%. Эти данные свидетельствуют о ценности комплексного применения современных методов диагностики опухолей молочной железы.

Главным источником диагностической ошибки является недоучет особенностей организма больной и ее болезни (40%). Это чаще происходит тогда, когда результаты диагностических мер не сопоставляются с данными клиники.

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Возможными причинами неэффективности лечения рака молочной железы являются:

- Неправильное определение стадии развития опухоли, этот фактор в онкомаммологической практике в среднем встречается в $15,0 \pm 1,5\%$ случаях
- Недоучет или неполноценный сбор данных опухоли, организма больной и на этой основе неправильно составляется генеральный план лечения (в $15,5 \pm 1,5\%$ наблюдений)
- Отсутствие радикализма, абластики и антибластики во время операции, это регистрируется в среднем у $10,0 \pm 1,7\%$, оперированных
- Неадекватная схема лечения в соответствии с биологическими параметрами, характеризующими особенности организма больной и опухоли $5,0 \pm 0,9\%$
- Устойчивость или природная первичная резистентность опухоли к лучевой и лекарственной терапии ($5,0 \pm 0,9\%$)
- Иммунно-эндокринологическая негативность и положительный генный статус организма больной и опухоли ($32,0 \pm 1,9\%$)
- Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение патологии и осложнений после терапевтических воздействий, отсутствие динамического контроля лечащего врача за больной ($18 \pm 1,7\%$). Последние два фактора являются одними из решающих в прогностическом отношении. Это надо учесть каждому врачу-маммологу, онкологу.
- Очень важным является правильно составленный генеральный план лечения больных раком молочной железы, для чего необходимо знать биологические параметры опухоли (ее стадия, клинко-анатомическая, морфологическая и патогенетическая формы) и организма больной (возраст, иммунно-эндокринологический и генный статус).
- Причины неэффективности предпринимаемых методов лечения множественные, в основном они бывают в результате недоучета или неполного сбора прогностических факторов опухоли и организма больных.
- Повышение уровня профессионального знания и квалификации врача-маммолога, онколога должно проводиться постоянно и регулярно под контролем администрации учреждений медицинской науки, практики и Вуза.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К.Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью

в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдалённых метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы «Philips».

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНО- МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Савицкий С.Э., Бобко Ю.И., Бобко И. Н.

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность исследования: Наследственные формы рака составляют 5-7% злокачественных новообразований. Ввиду высокой стоимости лабораторного скрининга, наследственный характер опухоли можно предположить по ряду косвенных признаков, в число которых входит первично-множественный характер опухоли.

Цель: Оценить особенности развития опухолевого процесса у больных первично-множественным раком молочной железы и яичников.

Материалы и методы: Исследование носило ретроспективный характер. Анализировались данные о 45 больных, лечившихся в 1989-2007г. в Гродненском ОД.

Результаты: Средний возраст больных составил 49,7 лет. У 15 заболевших процесс носил синхронный характер, в 30 случаях метакронный. В 38 случаях первой опухолью являлся рак молочной железы, в 7 – рак яичников.

Интервал между появлением опухолей составил в среднем 5,7 лет. У 38 больных вторые опухоли возникли в первые десять лет, в 7 случаях от 11 до 25 лет. На первом году от возникновения первичной опухоли умерло 4 больных (14%), от года до 5 лет - 5 (17%). Остальные 36 человек (69%) прожили от 5 до 25 лет.

Продолжительность жизни снижалась после появления второй опухоли. На первом году погибло 15 женщин, от года до 5 лет умерли 11, три пациентки прожили более 5 лет.

Средняя продолжительность жизни этих больных составила 24,7 месяца, период до прогрессирования 18,1 месяца. 29 пациенток (64,5%) погибли в течение года.

Выводы: 1. В большинстве случаев первично-множественного рака молочной железы и яичников первичной является опухоль молочной железы (84%) и преобладает метакронный характер процесса (67%)

2. Выявлена высокая пятилетняя летальность больных первично-множественным раком молочной железы и яичников (90%) от момента выявления второй опухоли.

3. Целесообразным представляется проведение этим больных для лабораторного скрининга наследственной предрасположенности.

4. Ввиду высокого риска раннего возврата заболевания,

больные этой группы должны подвергаться более агрессивному лечению, по сравнению с пациентами, страдающими солитарными опухолями аналогичных локализаций.

РОЛЬ СА-125 В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ

Сатенова Ж.К., Зайцева Л.С.,

Койшыбаев А.К., Баспаева М.Б.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г.Актобе.

Актуальность: Рак яичников занимает ведущее место в структуре причин смертности от злокачественных новообразований. Заболеваемость злокачественными опухолями яичников (ОЯ) в Казахстане достигает 5,1, занимая 4 место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями женской репродуктивной системы, а летальность — 3,1 на 100 000 человек женского населения. Поэтому разработка эффективных методов ранней диагностики рака яичников является актуальной задачей. Наиболее широко используемым для диагностики и мониторинга рака яичников маркером является опухолеассоциированный антиген СА-125.

Цель исследования: анализ изучения уровня опухолеассоциированного антигена СА-125 у больных раком яичников различных стадий до оперативного лечения, в процессе проведения курса химиотерапии и динамическом контроле уровня антигена после завершения лечения.

Материалы и методы исследования: По данным клиники МЦ ЗКГМУ с 2006 по 2008 гг. впервые выявленные больные со злокачественными новообразованиями яичника составили 93 случая (I-II -35, III -56, IV -2). Проводилось изучение уровня опухолеассоциированного антигена СА-125 у больных раком яичников различных стадий до лечения, в процессе проведения курса химиотерапии и динамический контроль уровня антигена по завершению лечения.

Целью следующего этапа исследования было использование маркера СА-125 в качестве прогностического показателя вероятности рецидива заболевания у больных раком яичников после проведения неoadъювантной (предоперационной) и адъювантной (профилактической или дополняющей) химиотерапии.

Больные были разделены на две группы. Первая группа обследуемых состояла из 23 женщин, которым сначала проводили предоперационную химиотерапию. Исходная концентрация СА-125 в сыворотке крови больных этой группы варьировала от 108 до 1200 Ед/мл, а ее среднее значение составляло 120±50 Ед/мл. Во второй группе, включающей 70 пациенток, которым была проведена циторедуктивная операция (удаление первичной опухоли с метастазами или без них), а затем химиотерапия, этот показатель был ниже, составляя от 210 до 3000 Ед/мл, среднее значение — 800±120 Ед/мл.

Выводы: Таким образом, результаты наших исследований показывают, что определение уровня опухолевого маркера СА-125 у больных до, во время и после лечения является предиктором продолжительности безрецидивного периода, отражая стабилизацию опухолевого процесса в виде «плато» маркера во время мониторинга. Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при концентрации СА-125 более 30 Ед/мл для больных правомерна постановка диагноза «Маркерный рецидив рака яичников».

Если пациентам в этот момент не проведены курсы химиотерапии, то в течение последующих 2–8 месяцев начинают появляться клинические признаки рецидива заболевания. Поэтому в качестве верхнего предела нормальной концентрации СА-125 в сыворотке у больных при ремиссии рака яичников мы рекомендуем использовать значение 30 Ед/мл.

СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ*Рахимжанова Р.И., Майер К.М.**Национальный научный центр материнства и детства,
г. Астана РК*

Маммографическая диагностика — один из ведущих методов выявления рака молочной железы. Основным достоинством его является возможность диагностики относительно ранних форм заболевания, включая минимальные и непальпируемые. Чувствительность маммографии составляет 77-95%, специфичность 94-97%.

В Астане маммографический скрининг проводится с 2006 года. Результаты маммографии нами интерпретировались с использованием Системы данных и описания обследования молочных желез Американской коллегии радиологов (American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System [BI-RADS]). BI-RADS.

Нами обследовано 3830 женщин в возрасте от 35 до 49 лет. Все женщины прошли рентгеномаммографию с профилактической целью в двух проекциях на цифровом маммографе. Из 3830 обследованных (35-44 л) составляли 2550 (66,6%) женщины; (45-49 л) - 1280 (33,4%) женщин. При распределении результатов маммографического обследования 3830 женщин г. Астаны по категориям выявлено, что 0 категории составили 284 (7,4%) женщины, 1 категорию — 1608 (41,9%) женщин, 2 категорию — 1608 (41,9%) женщин, 3 категорию — 278 (7,3%) женщин, 4 категорию — 46 (1,2%) женщин, 5 категорию — 6 (0,2%) женщин и категорию 6 - 3 (0,1%) обследованных женщин. Наиболее часто у женщин встречались диффузные изменения молочных желез (категория 2).

В молодом возрасте чаще, чем в среднем, требовалось дополнительное обследование молочных желез в связи с плотным фоном железистой ткани (категория 0) - в $9,3 \pm 0,17\%$ против $3,6 \pm 0,37\%$.

Узловые образования, которые имеют, вероятно, доброкачественную природу (категория 3) выявлялись чаще у женщин среднего возраста ($9,1 \pm 0,17\%$ против $6,4 \pm 0,42\%$). Категория 3 встречалась преимущественно у женщин среднего возраста (45-49 лет). В молодом возрасте (35-44 лет) чаще, чем в среднем (45-49 лет), требовалось дополнительное обследование молочных желез в связи с плотным фоном железистой ткани (категория 0) - в $9,3 \pm 0,17\%$ против $3,6 \pm 0,37\%$.

При выявлении непальпируемого рака молочной железы на маммографии была проведена толстоигольная трепан-биопсия. У 21 наблюдавшихся женщин с непальпируемым раком молочной железы в 71,7% случаев было выявлено узловое образование размером от 0,3 см, причем более половины узлов имели размер от 0,5 до 2,0 см. Контуры узлов наиболее часто были тяжистыми или частично тяжистыми. Микрокальцинаты обнаруживались в узлах в 19,7%. При отсутствии узловых образований (28,3% от всех наблюдений) только микрокальцинаты выявлены в 18,7%, очаги перестройки — в 3,8%.

Нами была проведена тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочных желез под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) у 98 женщин. При пункции под УЗИ-контролем 14 пациенток получено густое сметанообразное содержимое, которое при цитологическом исследовании у 11 больных расценено как содержимое кист, у троих - как галактоцеле. У 75,9% женщин фертильного возраста наиболее частой патологией были непальпируемые ненапряженные кисты молочной железы. Как правило, при цитологическом исследовании аспирата выявляли содержимое кисты без элементов выстилки (62,2%), что обусловлено отсутствием активности пролиферативных процессов в ткани железы и преобладании фиброзных изменений. У остальных женщин были обнаружены элементы выстилки кисты, у 7 из них с атипией отдельных клеток. При последующем наблюдении при-

знаков опухолевого роста не выявлено ни у одной больной. Рецидивирование непальпируемых кист после пункционного опорожнения отмечено в 14,6% случаях, им предложено оперативное лечение.

Таким образом, сегодня невозможно выявить характер узлового образования молочных желез без современных лучевых методов исследования и биопсии непальпируемых образований молочной железы под контролем методов визуализации.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ***Абдулаханова Р.Р., Кожакметов Б.Ш.,**Тлеугабилова Г.А., Есентаева С.Е.**Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей*

Актуальность. Рак шейки (РШМ) матки входит в число наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований и составляет около 12% злокачественных опухолей у женщин. Средний возраст колеблется от 48 до 50.

В Казахстане рак шейки матки составляет около 7,2% злокачественных опухолей гениталий и занимает 4-е место в структуре заболеваемости среди женщин (Арзыкулов Ж.Л. и др., 2009).

Как правило, возникновению РШМ предшествуют предраковые изменения эпителиального покрова. К ним относят эпителиальные дисплазии 3-х степеней выраженности, которые определяют предраковые состояния шейки матки- CIN (цервикальная интраэпителиальная неоплазия). I степень CIN I - соответствует эпителиальной дисплазии легкой степени; II степень CIN II - эпителиальной дисплазии средней степени; III степень CIN III - тяжелая эпителиальная дисплазия - преинвазивный рак шейки матки.

Несмотря на возможности ранней диагностики, в последнее время на фоне снижения общей заболеваемости РШМ возросла его частота у молодых женщин. Это, вероятно, объясняется неадекватным лечением фоновых и предраковых процессов шейки матки.

Цель работы. Улучшить качество диагностики и усовершенствования методов лечения патологии шейки матки.

Материалы и методы. Нами проанализирована группа пациенток (102 чел.), которым было проведено хирургическое лечение шейки матки.

Все пациентки (102) были обследованы на носительство цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса простого герпеса (ВПГ). ИФА методом обнаружено ЦМВ — в 4,5 % случаев (5), ВПГ — 92% (97), хламидии в 24,5% (25). Полученные результаты еще раз подтвердили доминирующую роль ВПГ в патогенезе предрака и рака шейки матки.

Всем исследуемым пациенткам было произведено хирургическое лечение в объеме: диатермокоагуляция шейки матки (ДЭК)- 30,4% (31); плоскостная диатермоэксцизия шейки матки (пл. ДЭЭ)- 48% (49); диатермоконизация шейки матки (Д/к)- 21,6% (22)

Результаты и обсуждение. По данным гистологических исследований, число CIN I, II, III встречалось в 86% случаев (58) из группы больных, получивших хирургическое лечение шейки матки. При этом в подавляющем большинстве случаев встречается дисплазия I степени, что можно объяснить своевременной ранней диагностикой больных: CIN I 33,40%

CIN II - 16,7%, CIN III - 2,8%, C-ч in situ 0,98%

В общей группе нерожавших (34 человека) с патологией шейки матки при предварительном кольпоскопическом исследовании лейкоплакия выявлена в 22 случаях (64,7%), а в результате гистологического исследования - лейкоплакия выявлена в 33 (97%) случаях, что объясняется большим ри-

ском злокачественной трансформации незрелого плоского эпителия у нерожавших женщин и несвоевременного проведения лечения фоновых процессов шейки матки.

Злокачественная трансформация многослойного плоского эпителия (Новикова М.Ю. и др., 1999) наблюдаются у 31,6% больных с лейкоплакией шейки матки и своевременная диагностика и лечение является необходимым этапом профилактики и снижения частоты заболеваемости шейки матки.

Таким образом, с учетом данных проведенного исследования мы сделали вывод, что необходим адекватный подход к диагностическим критериям при патологии шейки матки, в том числе у нерожавших женщин с целью профилактики и ранней диагностики предраковых и раковых заболеваний шейки матки.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ РОТОГЛОТКИ

Шатковская О.В.

Городской онкологический диспансер город Алматы.

Удельный вес злокачественных процессов ротовой части глотки среди всех локализаций опухолей головы и шеи, согласно данным ГОД, за 2009 год составляет 18,1%. В Казахстане, наблюдается рост заболеваемости раком ротоглотки и смертности от данной патологии.

Несмотря на визуальную доступность опухолей ротоглотки и возможности ранней диагностики, 80% больных начинают лечение в запущенных (III -IV) стадиях. Между тем 5 летняя выживаемость больных с данной патологией с I и II стадиями, после проведенного специализированного лечения, составляет до 75%, а с III стадией – до 15%.

Наиболее частые диагностические ошибки совершаются на этапе реализации вторичной профилактики.

Среди онкопатологий ротоглотки трудности вызывает диагностика опухолей миндалин. По данным Смирновой (2007 год) ошибки допускаются у 62,4% таких больных. Опухоли миндалин относительно редко встречаются и отсутствуют патогномические клинические симптомы, также не полностью используются диагностические методы, прежде всего цитологическое обследование.

Анализ диагностических ошибок, допущенных при обследовании 119 больных с опухолями миндалин, в период с 2008 года по июнь 2009 года показал, что наибольшие затруднения возникают при распознавании этого заболевания в ранних стадиях (90,6% ошибок). По отношению к более поздним стадиям этот процент составил 77,4%.

Время от появл. первых симптомов до обращения к врачу, мес	Всего больных	Число б-х, у которых период от обращения к врачу до установл. д-за составил, мес			
		До 1	1-3	3-6	6-9
До 1	53	5	18	29	1
1-3	54	13	32	9	-
3-9	12	9	2	1	-
Всего	119	27	52	39	1

По данным таблицы видна закономерность: чем менее продолжительным был период от появления первых признаков заболевания до обращения к врачу, тем больше времени потребовалось для установления диагноза.

Наличие хронических воспалительных процессов миндалин, резистентных к проводимой комплексной терапии, должно настораживать любого врача и вызывать необходимость обследования таких пациентов у онкологов. В условиях стационара также ошибки в диагностике приводят к выполнению неоправданных операций, способствующих ускорению роста опухоли и ее метастазированию, а инфильтрацию злокачественной опухолью миндалин окружающих тканей, ошибочно расценивают как «паратонзиллярный абсцесс».

Злокачественные опухоли миндалин, ретикулосаркомы и низко или недифференцированные раки, часто и рано метастазируют, поэтому увеличение лимфатического узла на шее может являться первым признаком заболевания.

Уменьшение количества ошибок во время диагностики онкологических заболеваний ротоглотки приведет к улучшению выявляемости заболеваний на ранних стадиях и позволит большему количеству больных излечиться от рака.

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

Рак шейки матки является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью женских гениталий (в мире ежегодно выявляется более 400 000 новых случаев). В мировой статистике заболеваемости злокачественными опухолями женского населения рак шейки матки находится на втором месте, уступая только раку молочной железы.

В Алматы рак шейки матки занимает 2 место в структуре заболеваемости женского населения, и 7 место в структуре заболеваемости всего населения. В 2007 году заболеваемость составила 10,2, в 2008 году – 10,6, 2009 г. – 10,7 на 100 тыс. населения. В 2008 отмечен рост заболеваемости рака шейки матки.

Отмечается достаточно высокий удельный вес больных РШМ репродуктивного возраста – 48% от всех заболевших. Увеличение числа заболевших фертильных женщин является весьма тревожным фактом, так как данный контингент пациенток представляет собой не только репродуктивно значимую часть женского населения, но и активную в социальном отношении группу. 40% первично выявленных больных в возрасте от 50 до 69 лет. Эта группа женщин часто оказывается вне рамок диспансеризации по фоновым заболеваниям и соответственно, у них наиболее часто встречается распространенная форма рака.

С 2007 в рамках реализации государственной программы обследования женщин с целью выявления рака шейки матки на ранних формах проводится цитологический. В 2007 году, несмотря на проводимые мероприятия, процент выявляемости также крайне низкий, и составил всего 0,03% (0,02%-2006г.). При профилактических осмотрах и взятии 105278 цитологических мазков выявлено только 37 больных раком шейки матки. Это свидетельствует о преследовании цели количественной реализации на участках, проводящих проф. осмотр, в ущерб качеству осмотров, что сказалось прежде всего, на низком проценте профилактической выявляемости и росте запущенных форм рака шейки матки.

Для своевременного выявления рака шейки матки необходимо улучшить работу по проведению профилактических осмотров женщин с обязательным цитологическим исследованием, а также проводить работу по диспансеризации и лечению больных с фоновыми заболеваниями шейки матки.

ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОМ.

Акишолов Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей г. Алматы.

Атерома образуется в результате задержки секрета сальных желез. Располагается на лице, волосистой части головы, туловища и т.д. Атеромы могут достигать значительных размеров. Они бывают единичными и множественными. Опухоль округлой формы, мягко-эластической консистенции. Цвет кожи обычно не изменен, но при нагноении атеромы появляются гиперемия кожи и отечность окружающих тканей.

Под нашим наблюдением находились 6 больных обратившихся к хирургу поликлинику центральной городской клинической больницы г. Алматы. Больные жаловались на наличие опухолевидного образования в различных участках тела: Двое больных с наличием образования в около сосковой области справа, волосистой части головы 2 и в области основания 4 пальца правой кисти. Зачастую, больные обращались при возникновении осложнения атеромы. Чаще всего нагноительный процесс. На коже определяется опухолевидное образование с покраснением кожи над опухолью, появляется болезненность при пальпации, что вынуждает обратиться больному за медицинской помощью.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование поверхностным датчиком с частотой от 7 до 12 МГц в поперечных и продольных проекциях. При этом атерома выявляется в виде гипзоэхогенного образования, размерами от 0,5 до 3,0 см. Глубина залегания на нашем материале не превышает 1-1,5 см. Ультразвуковое исследование позволило выявить экзогенность образования. Не осложненная атерома чаще выглядит средней экзогенности образованием, довольно правильной формы, с четкими ровными контурами. По мере возникновения воспалительных и нагноительных процессов меняется размеры атером в сторону увеличения, экзогенность снижается, контуры становятся неровными. Вокруг атеромы возникает признаки воспалительной инфильтрации. При возникновении гнойного процесса в центре или по одному из контуров возникает анэхогенный участок с неровными и нечеткими контурами. Могут формироваться гнойные карманы, которые при ультразвуковом исследовании определяется в виде затеков в толще мягких тканей или в виде свища направленное к поверхности кожи.

Таким образом, сонографическая диагностика атером является информативным и объективным методом неинвазивной диагностики атером, как при наличии осложнения и без него.

Параганглиома представляет собой редкую нейроэндокринную неоплазму, которая может развиваться в разных частях тела (включая голову, шею, грудную и брюшную полости). Примерно 97% доброкачественные. Параганглиомы происходят из хромафин-негативных гломусных клеток, происходящих из эмбрионального нервного гребешка, функционирующих в качестве части симпатической нервной системы. Эти клетки обычно действуют в виде хеморецепторов, расположенных вдоль кровеносных сосудов, в частности в каротидных телах (на бифуркации общей каротидной артерии на шее) и в аортальных телах (вблизи аортальной дуги). Большинство параганглиом либо бессимптомны, либо представляют собой безболезненную массу. Хотя все они содержат нейросекреторные гранулы, только в 1-3% случаев секреция гормонов, таких как катехоламины, бывает достаточно высокой, чтобы вызвать клинические симптомы, и в таком случае клинические проявления зачастую напоминают феохромоцитомы.

Под нашим наблюдением находились двое больных опухоль у которых по данным ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии нами установлен диагноз хемодектомы. У обеих больных параганглиома располагалась в области бифуркации общей каротидной артерий на шее. При УЗИ и МРТ хемодектома определялась в виде тканевого образования средней и повышенной плотности, расположенной в области бифуркации.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшолоаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей

Гигромы - Кистозная лимфангиома (гигрома) — гамартома, развивающаяся из лимфатических сосудов, не сообщающихся с лимфатической системой, что приводит к скоплению лимфы в многочисленных расширенных сосудах. Гигрома

имеет вид безболезненного куполообразного образования тестоватой консистенции. Кожа над кистой не изменена. Дермоидная киста растёт медленно, но может превышать 5 см в диаметре. Дермоидную кисту отличают от эпидермоидной отсуствие придатков кожи, в частности волосяных фолликулов, сальных и потовых желёз, в фиброзной стенке. Полость кисты выполнена роговым веществом и кожным салом, которые и обуславливают её тестоватую консистенцию и невозможность аспирации при пункции. Гигрома может формироваться в области суставов в результате скопления жидкости в влагалище сухожилия и отсутствии связи с полостью влагалища сухожилия за счет спаечного процессов. Лечение заключается в удалении кисты. Многие патологические образования мягких тканей имеют идентичную клиническую картину и затрудняет диагностику опухолевидных образований мягких тканей.

На данном этапе диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей применяются следующие методы: ультразвуковая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Нами поставлена задача изучить диагностические возможности лучевых методов исследования. При этом акцентировали внимание на неинвазивном ультразвуковом исследовании.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 34 больных, мужчин было 6, женщин 28, возрасте до 20 лет 5 человек, 20-29 лет 9 человек, 30-39 лет 5 больных, 40-49 лет 6 человек, 50-59 лет 5 больных и 60 и более лет 4 больных. Гигрома располагалась в предплечье у 2 больных, в области луче-запястного сустава 7, кисти 13, коленный сустав 3, голень 1, голеностопный сустав 3, стопа 4, паховой области 1. Длительность заболевания составила от одного месяца до десяти лет.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование с использованием датчиков частотой 7,5 до 12 МГц.

По данным ультразвукового исследования преимущественной локализацией т.е. глубина залегания в подкожной жировой клетчатке у 34 100%. Форма гигромы была округлой у 2 больных, овальной формы у 26 и неправильной формы у 6 больных. При установлении формы учитывались данные, полученные при полипозиционном исследовании, в одной проекции гиroma может иметь округлую форму, а в другой овальную то форма образования овальная, если форма в двух взаимно перпендикулярных проекциях округлая, то и образование имеет округлую форму. Размеры гигром колебались в пределах от 0,5-4,0 см. сонография позволила измерить не только линейные, но и объем опухоли.

При ультразвуковом исследовании гигрома в основном выявляется в виде анэхогенного образования с дорзальным эхоусилением. Дорзальное эхоусиление за гигромой нередко решает дифференциальную диагностическую задачу. При ультразвуковой инструментальной пальпации датчиком аппарата опухоль имеет плотно-эластичную консистенцию. По данным сонографии опухоль чаще имеет однородную структуру (у 26 больных), однородность структуры образования указывает на то, что содержимое жидкостное. В то же время органическое содержимое гигромы со временем имеет способность становится более густым и приобретает желеобразную консистенцию, т.е. становится более экзогенной, вплоть до смешанной экзогенности. Возможно появление линейных гиперэхогенных структур за счет плотных участков. Для гигром характерно наличие капсулы, окружающих опухоль и при сонографии капсула выявляется почти в 100%.

Таким образом, сонография является методом выбора при диагностике доброкачественной опухоли типа гигром, она позволяет уточнить размеры опухоли, глубину залегания, структуру образования, его экзогенность, длительность существования и т.д. После хирургического лечения позволяет оценить эффективность лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшопаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей
г. Алматы

Гемангиома — наиболее распространённая опухоль головы и шеи у детей. Поражение обычно единичное. Гемангиомы делятся на капиллярные и кавернозные.

Артериовенозные гемангиомы возникают исключительно у взрослых. Инвазивные гемангиомы расположены в глубоких подкожных тканях, фасциальных прослойках и мышцах. Выглядят как инфильтраты. Имеют тенденцию к рецидивированию после удаления, но не метастазируют. Внутримышечные гемангиомы обычно обнаруживают в юношеском возрасте. При пальпации они подвижные и плотные. Как правило, над ними нет шума и пульсации. Часто возникает болевой синдром вследствие сдавления близлежащих структур. Часто спаяны с кожей.

При кажущейся простоте диагностики гемангиом мягких тканей по данным клинического обследования многие характеристики образования требуют своего уточнения с применением инструментальных методов исследования. Методами радикального лечения являются хирургическое удаление опухоли, обнадёживающие результаты даёт лазерная терапия и криодеструкция. Появились сообщения о суперселективной эмболизация питающих гемангиому сосудов и последующая терапия сверхвысокочастотными токами, результаты оценены как обнадёживающими. Для предотвращения рецидивов данной опухоли при любом виде лечения необходимо полное ее удаление, а это возможно, только когда до вмешательства хирург имеет исчерпывающие данные о характере роста этой опухоли.

Для диагностики опухолей мягких тканей на современном этапе широко используются ультрасонография и магнитно-резонансная томография.

Под нашим наблюдением находились семь больных, из них мужчин было 3 и женщин 4 человек. У всех больных гемангиома была одиночная. Гемангиома локализовалась в коже и подкожной жировой клетчатке у 5 больных и у 2 больных межмышечно-межфасциально. По анатомическим областям опухоль локализовалась в области бедра, голени, голеностопного сустава, лучезапястном суставе и в области спины.

Для визуализации гемангиом нами в начальных этапах исследования использовалась ультрасонография с доплерографией образования. При необходимости прибегали к магнитно-резонансной томографии. Ультрасонография проводилась датчиками с частотой от 7,5 до 12 МГц, по стандартной методике в продольной и поперечной проекциях. В силу наличия различия по отражающей способности опухоли и окружающих мягких тканей возникает дифференцированная визуализация изучаемых объектов. Результате сонографии получены следующие характеристики сосудистой опухоли. Форма опухоли была округлая у 2 больных, овальная у 2 больных и у 3 больных установлена неправильная форма. Сонография позволяет установить размеры сосудистой опухоли, у исследуемых больных размеры опухоли составляли от одного до 5-6 см. Структура опухоли по данным сонографии однородная у 1 больного и у остальных неоднородная. Неоднородность структуры обусловлено наличием анэхогенных, гипозоногенных образований. Стенки сосудов, соединительная ткань визуализировались виде гиперэхогенных линейных структур в толще опухоли. Контуры опухоли были четкими и ровными у 3 больных и неровными у 4 больных. Эхогенность была пониженной у 3 больных и остальных была смешанной. Наличие капсулы установлена у 3 больных, у 4 больных четко установить наличие капсулы не удалось. У больных с сосудистыми опухолями обязательным компонентом ис-

следования является проведение доплерографии сосудов. Допплерография позволила выявить наличие сосудистой сети в опухоли, установить наличие кровотока, его скорость и направление, что позволило провести дифференциальную диагностику. Важным моментом диагностики сосудистых опухолей является диагностика рецидива. Под нашим наблюдением находились две больных с рецидивом опухоли, соно-доплерография позволили установить рецидив опухоли. Таким образом, при диагностике сосудистых опухолей мягких тканей методы сонографии играют решающую роль как в диагностике, дифференциальной диагностике и выборе объема хирургического.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА.

Еркатов Б.К., Тайлаков Б.Б.,
Мустафина Б.К., Сарбасов К.К.

РК «Городской онкологический диспансер», г. Астана

Введение. Улучшение качества дооперационного планирования больных с опухолями костей скелета, особенно оценка местной распространенности опухоли, имеет большое клиническое значение, так как определяет дальнейшую тактику лечения и прогноз заболевания.

Целью исследования явилось изучение магнитно-резонансной семиотики местной распространенности опухолей костей скелета для повышения качества дооперационной диагностики.

Материалы и методы. Нами были проанализированы магнитно-резонансные томографические (МРТ) данные 43 больных (29 мужчин, 14 женщин) в возрасте от 18 до 67 лет с гистологически подтвержденным диагнозом у оперированных 23 больных. МРТ-исследования были проведены на МР-томографе MAGNETOM «C» (Siemens) с индукцией поля 0,35 Тесла. Использовались T1 (SE и TSE), T2 взвешенные изображения (ВИ) (TSE), а также T2 ВИ с подавлением сигнала от жира (STIR).

Результаты. При проведении магнитно-резонансной томографии отмечались некоторые особенности преимущественно при подавлении жира, опухоль давала сигнал высокой интенсивности у 37 больных, который четко дифференцировался от низкоинтенсивного сигнала получаемого от неповрежденных костных структур. Опухолевая ткань чаще всего обладает высокими гипергидратационными свойствами, чем и обусловлено удлинение времени релаксации на T1 и T2-ВИ, при котором определяется снижение интенсивности МР-сигнала при коротких показателях TR/TE и усиление интенсивности при длинных TR/TE. Также при выполнении МРТ с внутривенным контрастным усилением опухоли костей скелета неравномерно активно накапливали контрастный препарат.

Заключение. Таким образом использование МРТ является высокоспецифичной методикой диагностического алгоритма опухолевых поражений костей скелета, так как позволяет дифференцировать патологически измененные ткани по интенсивности сигнала.

ПОВЫШЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Курсанова Н.Р., Малькова М.А., Балтаев Н.А., Хожеев А.А., Баймухаметов К.К., Бутырская И.Г., Иванов Н.Д.,
Шерланова Ш.А., Адиев М. М.

Городской Онкологический диспансер, г. Алматы

Актуальность: В структуре заболеваемости и смертности колоректальный рак занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, прогноз результатов терапии зависят от точности и

полноты диагностической информации о распространенности опухолевого процесса. Необходимо определение протяженности процесса, глубины поражения стенки кишки, выявление опухолевой инвазии в клетчаточные пространства, диагностика метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. Также КТ открывает возможности в изучении оценки регрессии опухоли после проведенного лечения, выявление рецидивов заболевания. На точных сведениях о степени распространения опухоли, полученных до начала лечения, строятся схемы комплексного и комбинированного лечения.

Цель исследования: изучение диагностической эффективности КТ-исследования при колоректальном раке путем оптимизации исследования.

Материал и методы: Нами обследовано 80 больных с колоректальным раком. После тщательной подготовки (очищения кишки от фекальных масс) с целью повышения диагностической эффективности КТ ректально вводилось разведенное контрастное средство 500-1500 мл для оценки патологии кишечной стенки: КТ-ирригография, и растяжения толстой кишки путем ректального раздувания воздухом, как негативным контрастным средством с помощью аппарата Боброва: КТ-колонография. После проведения КТ-колонографии производился просмотр внутри просвета кишки в формате виртуальной колоноскопии в антеградном и ретроградном направлениях для выявления образований. Осложнений после проведения исследований не отмечалось.

Сканирование охватывало область от диафрагмы до седалищных бугров. Нельзя ограничиваться сканированием области таза по поводу опухолей прямой кишки, так как можно пропустить отдаленные метастазы и первично-множественные раки. После проведения оперативного вмешательства изучался протокол операции, операционный материал и гистологическое заключение. На основании сопоставления данных КТ и гистологического заключения оценивались возможности метода. Сравнение шло по КТ-данным, в которых морфологические изменения оценивались по рентгенологическим симптомам, с одной стороны, и патологоанатомической оценкой, базирующейся на гистологическом исследовании опухоли, - с другой. Точность выявления опухоли в зависимости от правильности подготовки больного и размера опухоли практически составляла 100%. Но на КТ сложно выявить микроскопическая инвазию в клетчатку, серозу, сложно отличить увеличение пораженного метастазом лимфатического узла от его реактивной гиперплазии, а также выявить метастазы в неувеличенных лимфоузлах, сложно выявить перитонеальные метастазы и мелкие метастазы в печени.

Выводы: КТ-ирригография и КТ-колонография по полноте получаемой информации имеет значительные преимущества перед обычной КТ, перед ирригоскопией. Возможности детальной визуализации опухоли, органов и структур приводит к наиболее эффективному пути установления точного диагноза. Высокая точность в определении локализации опухоли, выявления выхода опухоли внеоргано и оценке степени местного распространения, особенностей роста опухоли и ее осложнений. КТ позволяет расширить возможности оценки регрессии опухоли и в ранней диагностике рецидивов.

МАММОГРАФИЧЕСКОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Жакенова Ж.К., Ж.Ж. Жолдыбай, А.Х. Хамзин
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы,
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова.*

Актуальность. Из 10 млн. новых случаев злокачественных опухолей различных органов, выявляемых сегодня на земле, 10-12% приходится на молочную железу. Результаты лечения,

прежде всего, зависят от своевременного выявления и дифференциальной диагностики образований молочных желез.

Цель. Определение возможностей маммографии и УЗИ в дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных образований молочной железы.

Материал исследования. Маммография и УЗИ проведены 160 пациенткам с заболеваниями молочной железы в возрасте от 27 до 75 лет.

По данным гистологического исследования диагноз РМЖ установлен у 132 (82,5%) женщин, из них узловатая форма РМЖ определена у 122 пациенток. Доброкачественные заболевания молочных желез выявлены у 28 (17,5%) пациенток.

Средний возраст больных РМЖ составил $51,3 \pm 7,7$ лет. Средний возраст женщин с доброкачественными образованиями молочной железы был $43,1 \pm 7,8$ лет.

Результаты. К типичным маммографическим симптомам РМЖ можно отнести округлую, овальную (44,3%) или неправильную (42,6%) форму опухолевого узла с нечеткими, неровными (49,2%) или спикурообразными (34,4%) контурами, с локальной гиперваскуляризацией (50,0%) и утолщением кожи (48,4%). Из микрокальцинатов, которые выявлялись в опухолевом узле в 38,5% случаев, преобладали сгруппированные (89,4%), множественные (61,7%), бесформенные, плеоморфные и ветвящиеся (89,4%). Достоверными отличительными рентгенологическими признаками РМЖ от доброкачественных образований молочной железы были нечеткие, неровные ($49,2 \pm 4,5\%$) и спикурообразные ($34,4 \pm 4,3\%$) контуры, утолщение кожи ($48,4 \pm 4,5\%$), затемнение железистого треугольника ($31,2 \pm 4,2\%$), наличие микрокальцинатов в проекции тени ($38,5 \pm 4,4\%$) ($p < 0,001$).

Информативность маммографии в выявлении РМЖ составила: чувствительность 96,2%, специфичность 78,6%, диагностическая точность – 93,1%.

Ультразвуковая картина РМЖ представляет собой солитарный узел неправильной формы (47,6%), неоднородной структуры (45,9%), с неровными контурами (57,4%), со сплошной (31,2%) дорсальной акустической тенью. Отличительными ультразвуковыми признаками РМЖ от доброкачественных заболеваний молочной железы в нашем исследовании были: неправильная форма образования ($47,6 \pm 4,5\%$), характерная для РМЖ ($p < 0,001$), и сферическая ($42,9 \pm 9,4\%$) – для доброкачественных узлов ($p < 0,001$); нечеткие, неровные ($57,4 \pm 4,5\%$) и спикурообразные контуры при РМЖ ($p < 0,001$) и четко очерченные края при доброкачественных образованиях молочной железы ($p < 0,001$); сплошная дорсальная акустическая тень при злокачественных новообразованиях ($p < 0,001$) и усиление дорсального сигнала при доброкачественных образованиях ($p < 0,001$). Наличие микрокальцинатов в образовании по данным УЗИ ($15,6 \pm 3,3\%$) являлось в нашем исследовании достоверным признаком РМЖ ($p < 0,001$).

Информативность УЗИ молочных желез в выявлении РМЖ составила: чувствительность 90,9%, специфичность 82,1%, диагностическая точность 89,4%.

Выводы. Маммография и УЗИ являются методами выбора в дифференциальной диагностике заболеваний молочных желез, точность которых, по нашим данным составила 90,9% и 89,4% соответственно.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Цель работы: ультразвуковая диагностика состояния паращитовидных желез при кардиологической патологии, очаговом остеопорозе, хронической почечной недостаточности (ХПН).

Материалы и методы: Ультразвуковое исследование было проведено 59 больным. Использовался ультразвуковой диагностический аппарат Viking-2400 (Дания) с мультимодальным высокочастотным поверхностным датчиком на частоте 12МГц, «Logic 7EX» (General Electric, США) с датчиком на частоте 13 МГц и мультимодальный матричный датчик с сверхвысокочастотной фазированной решеткой. При необходимости применялся метод энергетической доплерографии и цветового доплеровского картирования. Магнитно-резонансное исследование было проведено 39 больным.

Верхние паращитовидные железы, визуализируются позади верхней и средней трети долей щитовидной железы. Нижние располагаются за нижней третью долей щитовидной железы. Но, иногда, и впереди от нижней трети, а также, ниже щитовидной железы. Описаны случаи дистопии паращитовидных желез, когда 4 паращитовидные железы находятся в анатомически правильной локализации, а 4 расположены атипично - за грудиной.

При УЗИ - гиперплазия паращитовидных желез может наблюдаться при первичном и вторичном гиперпаратиреозе. Происходит симметричное или ассиметричное увеличение паращитовидных желез. Железы имеют округлую или овальную форму. Контур чаще ровный. Имеется тонкая гиперэхогенная капсула. Эхогенность пораженных паращитовидных желез снижена. Аденома определяется как анэхогенное образование с четкими ровными границами, иногда дающее акустическую тень. Проводилась ультразвуковая амплитудная гистография. При наличии аденомы паращитовидной железы SD= 9-12ЕД. Киста – как анэхогенное образование с четкими, ровными границами округлой или овальной формы, дающее акустическое усиление. SD= 0.5-1ЕД. Рак определяется как анэхогенное или гипозоногенное образование с нечеткими, неровными границами, дающее акустическую тень. SD= 6.7-11ЕД. При энергетической доплерографии – усиленная васкуляризация. В норме паращитовидные железы встречаются в количестве четырех. Но иногда встречаются варианты развития, когда паращитовидные железы располагаются эктопически. Могут быть расположены за трахеей или пищеводом, на различных уровнях в щитовидно-вилочковой связке, в вилочковой железе, на уровне бифуркации и по ходу общей сонной артерии. Крайне редко они могут локализоваться в щитовидной железе. Эхоструктура в норме не отличается от эхоструктуры щитовидной железы. В продольном размере – 4,8мм. В поперечном – 3-4мм, в переднезаднем – 1,5-3мм.

Результаты исследования: у 57 больных был поставлен точный диагноз, у 42 из них – аденома паращитовидной железы, у 7 – киста, у 6 - злокачественная опухоль. В 2 случаях аденома паращитовидной железы не была диагностирована по видимому из-за очень маленьких размеров (1,2мм).

Вывод: Таким образом, проведенное исследование позволило с высокой точностью диагностировать патологию паращитовидных желез, определить степень васкуляризации зоны интереса и выяснить истинную причину кардиологической патологии, обнаруженного остеопороза, хронической почечной недостаточности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Методика цветового доплеровского картирования (ЦДК), энергетического доплеровского картирования (ЭДК) и низкочастотной доплерографии позволяет получить цветные изображения различных сосудов с определением скорости и направления кровотока. Методика «вторичной тканевой гармоникой» позволяет получить изображения тканей в том

числе и сосудов, с отсечением артефактов, то есть с получением более качественного изображения. Место и значение ЦДК в клинической практике в настоящее время возрастает из-за высокой информативности, качества, возможности применения при многих локализациях. Указывается степень васкуляризации, качественные и количественные характеристики кровотока в опухолях, степень регрессии опухолей и изменения патологически измененных сосудов в процессе лечения.

Цель работы: Выявление при злокачественных образованиях, нарушений строения и расположения мелких ветвей сосудов и хаотический рисунок опухолевой сосудистой сети, сосуды с низкой резистентностью и, соответственно, выраженным диастолическим кровотоком. Оценка выявленных изменений в динамике, в процессе лечения.

Материалы и методы: Исследовалось: 30 пациентов с раком шейки матки, 15 с раком тела матки, 25 с раком молочной железы. Исследование проводилось на аппарате «Shimadzu-1200», аппарате «Viking 2400», «GE Logic7» с использованием датчиков с различной частотой в зависимости от локализации образований с использованием опций цветового доплеровского картирования, энергетического доплеровского картирования.

Результаты: Важным дифференциально-диагностическим признаком является - деформация сосудистого рисунка, чаще вен и изменения их изображения за счет локального уменьшения диаметра, вызванного сдавливанием узлами опухоли. При крупноочаговом диффузном поражении, изменения сосудистого рисунка представляются не только деформацией, но и ампутиацией сосудов и общим обеднением сосудистого рисунка, включая крупные ветви вен. Цветовым доплеровским исследованием, особенно энергетической доплерографией, можно более отчетливо, нежели в В-режиме, выявлять нарушения строения и расположения как мелких, так средних и крупных ветвей сосудов и хаотический рисунок опухолевой сосудистой сети. При проведении УЗИ в процессе лечения, при проведении химиотерапии либо лучевой терапии оценивается динамика изменений сосудов опухоли, при этом отмечалось уменьшение размеров первичного очага и метастатических очагов. При этом при проведении ЦДК и ЭДК у всех пациентов отмечалось снижение приоритета артериального кровотока, уменьшение количества патологических сосудов в опухоли, появление участков склероза, что свидетельствовало о регрессии опухолевого процесса.

Вывод: Таким образом, УЗИ с применением ЦДК и ЭДК является эффективным, не дающим лучевой нагрузки, доступным методом в диагностике и контроле регрессии образований в процессе лечения при различных локализациях образований.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

Тулеутеева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Определение диагностических критериев и изучение клинического течения болезни печени до настоящего времени остаются актуальными проблемами современной гепатологии.

Целью исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой диагностики в качестве точного неинвазивного метода исследования у больных с патологией печени.

Материалы и методы: был проведен анализ данных, основанный на обследовании 465 больных первичным (57) и метастатическим раком печени (290), кистой (48), гемангиомой (53) и эхинококкозом (17).

Среди 465 пациентов (44,9%) женщин и (55,0%) мужчин за период с 2007 по 2009 годы. Возраст больных составлял от 27 до 73 лет, средний возраст 50±1 год.

Первичный рак печени при ультразвуковом исследовании определяется как образование неправильной округлой или овальной формы с неровными контурами. В большинстве случаев рак печени имеет неоднородную структуру, появляются дополнительные очаги, обусловленные кистозными некротическими участками, обызествлением и кровоизлияниями. При динамическом контрольном исследовании имеет тенденцию к росту.

Ультразвуковое исследование выполнено на аппарате Sonoline-50 фирмы Siemens Германия с использованием конвексных датчиков.

Метастатическое поражение печени характеризовалось ярко выраженным разнообразием эхоструктуры. Чаще всего были диагностированы гиперэхогенные метастазы с наличием гипоехогенного ободка по периферии. В ряде случаев были диагностированы многоузловые метастатические очаги с наличием кальцинатов.

Увеличение лимфатических узлов диагностировано - у 6 (2,0%). Признаки билиарной гипертензии были выявлены у 59 (17,0%) обследованных, асцит - у 120 (34,5%) случаев.

Оперативные вмешательства в объемах правосторонней, левосторонней или расширенной гемигепатэктомии выполнены за 2009-2010 годы у 6 пациентов.

Сопоставление результатов ультразвукового исследования и интравеннозных данных в оценке характера опухолей показало совпадение в 100% случаев.

Таким образом, методику ультразвуковой диагностики патологии печени следует рассматривать в качестве одной из современных методик диагностики.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Рак мочевого пузыря занимает второе место среди онкологических заболеваний мочеполовой системы, достигая 6,2% от общего количества онкологических заболеваний. Ежегодно в мире выявляется около 275 тысяч человек, страдающих этим заболеванием, из них около 108 тысяч человек умирают. Заболевание чаще встречается у мужчин, в соотношении 3:1 по сравнению с женщинами. Средний возраст впервые выявленного рака мочевого пузыря составляет 68 лет, частота выявления заболевания увеличивается с возрастом. На поверхностный рак мочевого пузыря приходится до 75% всех случаев заболевания.

Цель работы: Оценка инвазии опухоли в слизистый, подслизистый слой и поверхностные отделы мышечной оболочки стенки мочевого пузыря. С помощью трансуретрального УЗИ (ТУУЗИ) возможно более отчетливо визуализировать мельчайшие изменения стенки мочевого пузыря, что позволяет определить местное распространение злокачественного процесса даже при очень небольших размерах опухоли. Однако этот метод не исключает риска повреждения слизистой оболочки уретры и требует применения местной анестезии. При решении вопроса о целесообразности выполнения трансуретральной резекции мочевого пузыря, а также для определения объема хирургического вмешательства цистэндонография является методом выбора.

Материалы и методы: С целью более точного установления глубины инвазии опухоли в пределах стенок мочевого пузыря проведено 56 исследований. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «Viking 2400», фирмы «B-K medical» (Holland) с трансуретральным датчиком 12МГц. В 24 случаях были рецидивные опухоли мочевого пузыря, в остальных – первичные. Из общего количества исследованных у 4 пациентов выявлено 3 образования, у

11 – 2 образования и у 17 пациентов выявлено 1 образование в мочевом пузыре. Визуализировались экзогенные образования, с четкими, неровными контурами, структура неоднородная. Размеры образований варьировали от 0,5 до 4,0 см в диаметре. При необходимости применялась функция энергетической доплерографии и цветового доплеровского картирования. Данные цистоскопического осмотра совпадали с данными ТУУЗИ. Все пациенты получили хирургическое лечение, проведена трансуретральная резекция образований (ТУР). Полученные результаты ТУУЗИ сравнивались с данными послеоперационного морфологического исследования. При этом лишь у 3 пациентов диагноз мышечной инвазии, не определявшийся при ультразвуковом исследовании, был подтвержден после оперативного вмешательства. У остальных пациентов данные ультразвукового и морфологического исследования совпали.

Вывод: Таким образом, применение ТУУЗИ способствует хорошей визуализации всех слоев стенки мочевого пузыря, позволяющий отчетливо определить глубину опухолевой инвазии, а также толщину стенки мочевого пузыря, что необходимо знать при проведении ТУР. Комбинирование ТУУЗИ и трансуретральной резекции позволяет увеличить эффективность оперативного вмешательства и избежать возможных осложнений. Дает возможность определить полноценные показания к ТУР, или возможной радикальной резекции опухоли мочевого пузыря. Определялась глубина инвазии и степень васкуляризации опухоли, наличие метастазов в лимфатические узлы паравезикальной клетчатки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

Тулеутеева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Определение диагностических критериев и изучение клинического течения болезни печени до настоящего времени остаются актуальными проблемами современной гепатологии.

Целью исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой диагностики в качестве точного неинвазивного метода исследования у больных с патологией печени.

Материалы и методы: был проведен анализ данных, основанный на обследовании 465 больных первичным (57) и метастатическим раком печени (290), кистой (48), гемангиомой (53) и эхинококкозом (17).

Среди 465 пациентов (44,9%) женщин и (55,0%) мужчин за период с 2007 по 2009 годы. Возраст больных составлял от 27 до 73 лет, средний возраст 50 ± 1 год.

Первичный рак печени при ультразвуковом исследовании определяется как образование неправильной округлой или овальной формы с неровными контурами. В большинстве случаев рак печени имеет неоднородную структуру, появляются дополнительные очаги, обусловленные кистозными некротическими участками, обызествлением и кровоизлияниями. При динамическом контрольном исследовании имеет тенденцию к росту.

Ультразвуковое исследование выполнено на аппарате Sonoline-50 фирмы Siemens Германия с использованием конвексных датчиков.

Метастатическое поражение печени характеризовалось ярко выраженным разнообразием эхоструктуры. Чаще всего были диагностированы гиперэхогенные метастазы с наличием гипоехогенного ободка по периферии. В ряде случаев были диагностированы многоузловые метастатические очаги с наличием кальцинатов.

Увеличение лимфатических узлов диагностировано - у 6 (2,0%). Признаки билиарной гипертензии были выявлены у 59 (17,0%) обследованных, асцит - у 120 (34,5%) случаев.

Оперативные вмешательства в объемах правосторонней,

левосторонней или расширенной гемигепатэктомии выполнены за 2009-2010 годы у 6 пациентов.

Сопоставление результатов ультразвукового исследования и интродермальных данных в оценке характера опухолей показало совпадение в 100% случаев.

Таким образом, методика ультразвуковой диагностики патологии печени следует рассматривать в качестве одной из современных методик диагностики.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Тулуттаева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Внутренний эндометриоз, несмотря на частоту распространения, является одним из трудно диагностируемых патологий.

Целью исследования явилось изучение возможностей трансвагинальной и трехмерной эхографии в диагностике эндометриоза.

Материалы и методы: был проведен анализ ультразвуковых исследований 52 женщинам с применением трансвагинальной и трехмерной эхографии в диагностике эндометриоза.

Нами сделана попытка эхографического описания характерных признаков распространения и ультразвуковых критериев диагностики внутреннего эндометриоза. Ввиду значительно более высокой информативности трансвагинальной эхографии, предпочтение было отдано именно этому методу и частично опровергнуто трехмерное исследование.

Всего обследовано 52 женщин с подозрением на внутренний эндометриоз. Возраст больных от 19 до 54 лет.

Наиболее характерным нарушением менструальной функции у больных с внутренним эндометриозом были

- болезненные менструации-83,3%;
- обильные – 81,4%;
- перименструальные скудные кровянистые выделения-52,0%;
- первичное бесплодие – 7,6%;
- вторичное бесплодие – 8,2%;
- привычное невынашивание - 3%;

При этом установлено, что внутренней эндометриоз I степени распространения имелся у 14 больных (27%);

II – 15 больных (29%);

III – 10 больных (19%);

узловая форма – 13 (25%)

Эхографическое исследование мы осуществляли при помощи ультразвуковых аппаратов «Sonoline - G50» производства Италия – США – Германия с использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков частотой 3,5 и 5 мГц, а также трехмерное на аппарате «SanoAce 9900» (Южная Корея).

Проведенные исследования показали, что наиболее характерными ультразвуковыми признаками внутреннего эндометриоза являются следующие:

1. Неравномерной контур М-эхо;
2. Увеличение передне-заднего размера матки, ассиметричное утолщение одной из стенок матки;
3. Появление в миометрии отдельных участков повышенной эхогенности;
4. Наличие в зоне повышенной эхогенности анэхогенных включений и мелких жидкостных полостей.

В целях более точной диагностики исследование проводили в предменструальные дни.

Использование этих критериев позволили значительно повысить точность диагностики внутреннего эндометриоза и особенно начальных его форм с обязательным учетом клинической картина заболеваний (болезненные и обильные

менструации, перименструальные кровянистые выделения, увеличение матки и т.д.)

Таким образом, эхография является ценным методом, особенно использование трансвагинального датчика наиболее информативно в диагностике внутреннего эндометриоза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Ультразвуковая диагностика является эффективным методом диагностики опухолей шейки матки. Ультразвуковое исследование (УЗИ) среди других методов визуализации является приоритетным, т.к. обладает высокой информативностью, быстротой, простотой, безвреден, безболезнен, возможно многократное проведение с объективным документированием, отсутствует лучевая нагрузка. Современные технологии создали новые поколения УЗ-аппаратов, позволяющих получить качественные изображения с высокой диагностической точностью. Метод позволяет выявлять непальпируемые образования, указать более детальную информацию о структуре образования, распространенности и топографии процесса, взаимоотношения с окружающими органами и тканями, а также проследить динамику регрессии опухоли и инфильтратов в параметральной клетчатке в ходе лечения.

Цель работы: оценка эффективности лучевой терапии рака шейки матки.

Материалы и методы: Осмотрено 52 больных с местно-распространенной формой рака шейки матки. Все пациенты осмотрены: до начала лечения, проведена предлучевая подготовка, на этапах лечения и после окончания лучевой терапии. Проводилось трансабдоминальное исследование на аппарате «Shimadzu-1200», «Viking 2400», аппарате экспертного класса «GE Logic7». Использован комплекс УЗ-методик (В-режим, вторая тканевая гармоника, pre- и postprocessing, амплитудная гистография, 3D-режим, цветное доплеровское картирование и энергетическое доплеровское картирование, доплерография).

Результаты: Изменение эхоструктуры опухоли на фоне СЛТ характеризовалось повышением эхогенности, снижением звукопроводимости за счёт склероза в опухоли. Кровоток в опухоли до СЛТ в основной группе определялся приоритетом артериального типа (87,5%) с гиповаскуляризацией (57,5%), в контроле - артериальный тип (71,4%), гиповаскуляризация (60,0%). После СЛТ в основной группе приоритет артериального кровотока (57,5%), гиповаскуляризация (82,5%), в контроле - венозный тип (40,6%), гиповаскуляризация (59,4%). В остальных случаях патологический кровоток не визуализировался, что свидетельствовало о полном лизисе злокачественной опухоли.

Вывод: Таким образом, УЗИ является высокоинформативным методом в диагностике и контроле в процессе лучевой терапии рака шейки матки.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА. ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Хуснутдинова Г.И., Кирсанова Н.Р., Бутырская И.Г.

Городской онкологический диспансер, Алматы

Остеохондроз позвоночника – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся дегенеративно – дистрофическим поражением межпозвонкового диска, тел смежных позвонков, истинных суставов и связочного аппарата.

Цель: дать краткие сведения по лучевой диагностике

остеохондроза позвоночника,

провести анализ диспансерного материала у больных, направленных на консультацию в ГОД г. Алматы за 2007-2009 гг.

Материалы и методы: Наш материал за 2007-2009 гг. составляет 110 больных с остеохондрозом позвоночника, направленных из различных медицинских учреждений: диагностических центров, лечебных учреждений (клиник и поликлиник) г. Алматы.

Результаты: Большей частью больные страдают поясничным остеохондрозом (71), реже грудным (21), и шейным (18). Остеохондрозом позвоночника страдают как мужской пол (45), так и женский (65), в любом возрасте от 30 до 70 и более лет.

Из 18 больных с шейным остеохондрозом, направленных на консультацию, спондилография выполнена у 6 больных (в возрасте 30-60 лет), МРТ-У 10 больных (30-60 лет), КТ - у 1 (30 лет). При этом выявлена болезнь Бехтерева у одного больного в возрасте 52 лет, компрессионный перелом - у одного больного в возрасте 17 лет, у 15 больных остеохондроз шейного отдела, однако ни у одного из них не было выявлено онкопатологии. Всем больным достаточно было сделать цифровую рентгенографию позвоночника в двух стандартных проекциях. Более детального исследования (КТ, МРТ) не требовалось.

Из 21 больного с грудным остеохондрозом выявлен остеохондропатический остеохондроз в возрасте 26-27 лет у двух пациентов; посттравматический остеохондроз на почве компрессионного перелома Th 12 в возрасте 69 лет у одного пациента; инволютивный остеохондроз у одного пациента 74 лет; синдром Титце у одной пациентки 48 лет; остеохондроз обменно-дистрофического характера на почве диабетической спондилопатии у одной пациентки 67 лет; остеохондроз грудного отдела позвоночника обменно-дистрофического характера у одной пациентки 51 года с раком молочной железы; у одного пациента 64 лет с диагнозом рак предстательной железы выявлены возрастные изменения. Рентгенография грудного отдела позвоночника выполнена 19 больным за период с 2007 по 2009 гг.; МРТ – за период с 2009 по 2010 гг. Двое больных были направлены с диагнозом мтс из РДЦ только на основании МРТ. У всех 21 больного с грудным остеохондрозом различной природы онкопатология исключена на данном консультативном материале.

Выводы: В диагностике остеохондроза позвоночника в современных условиях имеют значение следующие лучевые методы исследования:

1. В первую очередь цифровая рентгенография, выполненная в 2 взаимно-перпендикулярных в проекциях для оценки изменений в межпозвонковых дисках, телах и суставных отростках позвонков, а так же связочного аппарата позвоночника.

2. Для уточнения и оценки степени нестабильности в шейном и в поясничном отделах позвоночника – функциональная рентгенография в положении стоя или максимальном сгибании и разгибании позвоночника при анте- и –ретролистезе, при наклонах вбок (вправо и влево) при сколиозе.

3. Для уточнения изменений в телах пораженных позвонков, в истинных суставах позвонков - прицельная КТ.

4. Для уточнения состояния диска, спинномозгового канала предпочтительно МРТ.

Ни один из перечисленных методов не заменяет другой метод а лишь является взаимодополняющим.

ЧРЕСКОЖНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

В диагностике злокачественных новообразований придаточных пазух носа основными методами диагностики

является ЛОР-осмотр, рентгенологическое исследование, КТ, МРТ.

Изучена возможность ультразвукового исследования опухоли гайморовой пазухи. Традиционно сложилось мнение о невозможности ультразвукового исследования через костный каркас, поскольку костный каркас верхней челюсти является непреодолимым препятствием для исследования. Однако различные патологические процессы в полости гайморовой пазухи (опухоли, воспалительные процессы и т.д.) приводят к снижению воздушности пазухи, изменяют условия прохождения ультразвуковых лучей. В связи с этим возникает акустическое окно, позволяющее получить определенную информацию о патологических процессах.

Цель работы: разработка метода чрескожного ультразвукового исследования опухоли верхнечелюстной пазухи.

Материалы и методы исследования: Ультразвуковое исследование опухоли верхнечелюстной пазухи проведено 32 больным с морфологически верифицированными злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи. Среди больных преобладали мужчины — 22 больных, женщин - 10. УЗИ применено у больных раком верхнечелюстной пазухи с III и IV стадией заболевания, при этом с III стадией заболевания, составили 19 больных и с IV стадией - 14 больных. Возраст больных варьировал от 21 года до 70 лет. Всем больным выполнялась компьютерная томография ППН. В дополнение к стандартному методу исследования использовали ультразвуковой метод на аппарате Viking 2400 (Дания), осмотр проводился многочастотным датчиком электронного сканирования с частотой 2,5 МГц. Пациентам проводилась внутриартериальная регионарная полихимиотерапия, лучевая терапия. УЗИ проводилось как до лечения, так и после каждого вида лечения.

Результаты исследования: У всех 32 больных до лечения при УЗИ выявлено образование в гайморовой пазухе, гипозоногенное, либо анэзоногенное. Контуры нечеткие, неровные, структура неоднородная, в V от 9,5см3 до 195,0см3. Но УЗИ не дает оценку изменений в костях.

Корреляция с результатами КТ и МРТ подтвердила высокую чувствительность и специфичность ультразвукового метода исследования.

Выводы Разработанная методика чрескожного ультразвукового исследования опухоли верхней челюсти является информативным, безвредным и экономически дешевым методом диагностики. Предложенная методика позволяет проводить динамическое наблюдение за состоянием опухоли в гайморовой пазухе в процессе лечения.

Таким образом, ультразвуковое исследование опухоли гайморовой пазухи обладает большой диагностической ценностью в постановке диагноза и определении тактики лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстательной железы применяются различные варианты ультразвуковой томографии – трансбдоминальная, трансректальная, трансвагинальная и трансуретральная. Наиболее распространенным при диагностике опухолей мочевого пузыря является трансбдоминальное исследование. Ультразвуковая томография при раке предстательной железы должна применяться в комплексе с пальцевым ректальным исследованием и иммунологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой диагностики при опухолях мочевого пузыря и пред-

стательной железы.

Материалы и методы: Исследование проводилось 53 пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала лечения на аппарате Viking 2400 (Дания), с использованием трансабдоминального датчика 3.5.мГц, трансректального датчика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным методом при раке предстательной железы является трансректальное исследование с одновременной секстантной биопсией. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ является общепринятым методом верификации. Трансуретральное УЗИ более информативно для определения глубины инвазии опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом диагностического процесса при раке предстательной железы является трансабдоминальное и трансректальное исследование. Трансабдоминальное исследование не всегда дает полноценное изображение структуры предстательной железы, однако оно необходимо для оценки состояния печени, забрюшинных лимфатических узлов, верхних мочевых путей, позволяет судить об объеме остаточной мочи. УЗИ является не только основным скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультразвуковой томографии необходимы при поздних стадиях процесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для предлучевой подготовки и установления противопоказаний к лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальным

датчиком позволяет получить информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве и локализации, с помощью амплитудной гистогграфии определить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию из измененного участка железы. Ультразвуковая томография получила значительное распространение ввиду доступности аппаратуры и возможности применения при планировании лучевой терапии. Можно получить целесообразное распределение энергии излучения в облучаемом объеме только при помощи объемного планирования. Это дает возможность не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем институте проводится научно-исследовательская работа с целью повышения эффективности лучевого лечения при раке мочевого пузыря и предстательной железы путем интенсификации лучевой терапии в режиме динамического фракционирования дозы облучения.

Результаты: У 53 больным с раком предстательной железы выполнена трансректальная ультразвуковая томография в начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагностировали полную резорбцию опухоли, у 6 дали частичную регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мочевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса.

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позволяет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости его скорректировать.

Хирургическое лечение

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА

Арзыкулов Ж.А., Ижанов Е.Б., Есентаева С.Е., Турешева А.О., Ким В.Б., Абдрахманов Р.З.
КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы

Актуальность. Рак пищевода (РП) – наиболее неблагоприятная по течению злокачественная опухоль, на долю которого приходится около 6% от всех желудочно-кишечных новообразований.

В Республике Казахстан (РК) в общей структуре заболеваемости злокачественных новообразований РП занимает пятое ранговое место, составив в 2008 году 6,3%. Ежегодно по РК выявляются до 1700 больных РП, погибает от данного недуга до 1500 человек в год.

В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск более эффективных методов лечения рака данной локализации.

В настоящее время в современной литературе возникло новое понятие – мультимодальная терапия, подразумевающая проведение различных вариантов неоадьювантной химио-, а также лучевой терапии ЛТ с последующим оперативным лечением, результаты которой еще не до конца изучены и представляют повышенный интерес для абдоминальной онкологии.

Применение двух методов лечения – лучевой и химиотерапии в дооперационном периоде преследует две цели: уменьшение размеров первоначальной опухоли и уничтожение распространившихся опухолевых клеток по организму, так называемых микрометастазов. Применение этих методов позволяет значительно улучшить результаты лечения.

Цель исследования: повышение эффективности лечения местно-распространенных форм рака пищевода

Материалы и методы: в предоперационном периоде пациентам исследуемой группы (28 больных) проводился курс неоадьювантной химиотерапии по схеме: гемцитабин 1000 мг/м² в/в 1,8 дни + цисплатин 75 мг/м² в/в 1-ый день, через 21 день повторяли курс химиотерапии в аналогичном режиме в сочетании с конформной лучевой терапией РОД-2,0 Гр; СОД-50Гр; 5 фракций в неделю.

Результаты: на фоне лечения в 40% (11/28) случаях получен субъективный эффект, который выражался в значительном улучшении общего состояния, оцениваемого 1-2 степенью активности по шкале Карновского, полном купировании дисфагии и болей в грудной клетке.

Объективный эффект достигнут в 67,9% (15/28) случаев, из них у 4 (14,3%) пациентов отмечена полная регрессия опухоли, у 15 (53,6%) больных – частичная резорбция. Стабилизация процесса прослежена у 9 (32,1%) больных.

Лейкопения I-II степени наблюдалась у 11 (39,3%) пациентов.

Летальных случаев в послеоперационном периоде отмечено не было.

Таким образом, предварительные результаты исследования показали клиническую эффективность предлагаемого режима химиолучевой терапии у больных раком пищевода, не сопровождающуюся увеличением лимитирующей токсичности и характеризующуюся улучшением качества жизни данной категории больных, неотягощая течение послеоперационного периода.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОЛОГИИ

Дарменов О.К., Оразбеков Н.И.,
Курбанов Ш.А., Избасаров Р.Ж.
Кафедра хирургии с курсом кардиохирургии,
анестезиологии-реанимации и УЗ-диагностики, КазНМУ
имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы

Опухоли кожи по частоте среди всех опухолевидных заболеваний кожи занимают IV место. По данным разных авторов, опухоли кожи встречается у 25% населения. Наиболее высокий рост среди заболеваемости кожи локализуется на открытых участках тела. Онкологическая настороженность, знание признаков, симптомов проявлений опухолевидных изменений, наличие современных средств и методов диагностики, в том числе морфологическая верификация позволяют избежать диагностических ошибок.

Несмотря на современные возможности пластической хирургии закрыть любой дефект, любой локализации, хирургическое лечение больших и гигантских образований кожи на сегодняшний день остается актуальной проблемой и требует комплексного подхода.

В большинстве случаев такие пациенты нуждаются в хирургическом лечении, которое должно учитывать не только функциональный, но так же и эстетический эффект.

Больной Ф, 27 лет. Диагноз – врожденная гемангиома височной области головы справа. Локализация – от границы роста волос височно-лобной части головы медиально до внутреннего края правой брови, включая верхнее и нижнее веко, основание спинки носа, вниз до дуги скуловой кости и латерально спереди ушной раковины до уровня козелка.

Вся правая половина лица деформирована, правый глаз не открывается, правый угол ротовой полости не закрывается. Выраженный лимфостаз нижней части лица, кожная складка свисает от уровня нижней челюсти на 3-4 см.

Мобилизованы края раны вверх и вниз кожно-жировые лоскуты с помощью дополнительных разрезов подняты над всей гемангиомой. Гемангиома удалена в пределах здоровых тканей, излишки кожи после выкройки по форме раны иссечены, раневая поверхность закрыта полностью.

Течение послеоперационного периода без особенностей. Больной в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное долечивание.

Повторный осмотр через 8 месяцев показал хороший результат. На отдельных участках умеренная гиперемия рубцов сохраняется, рубцы мягкие подвижные без признаков келоида. Пересаженные расщепленные аутоотрансплантаты на верхнем и нижнем веке прижились. Функциональный и эстетический результат хороший. Слабые признаки микростомии при оскале зубов в правом углу ротовой полости. Результатом выполненной операции больной вполне удовлетворен.

Преимущество применения современных методов пластической хирургии как дермобразия, использование сложных кожно-фасциальных и других лоскутов питающих на ножке, а также сложных лоскутов на микроанастомозах позволяет добиться хорошего функционального и эстетического результата, что отвечает требованиям современной пластической хирургии. Хирургическое лечение большой гемангиомы включало мобилизацию краев раны, перемещение лоскутов на ножке и пластику отдельных дефектов расщепленным трансплантатом.

Таким образом, благодаря методике удалось избежать

вторичного изменения пересаженного аутоотрансплантата и деформацию донорского участка. Мы рекомендуем данную методику как альтернативный вариант лечения при опухолевидных заболеваниях кожи.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Кулмаганбетова А. А.

Кызылординский областной онкологический центр.

За последнее время отмечается рост обращаемых больных с узловыми образованиями щитовидной железы. В 2005 г количество больных составляло 56 человек, в 2009 г 167 больных. Всем больным проводится комплекс диагностических мероприятий (УЗИ щитовидной железы, определение уровня гормонов щитовидной железы, тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ). Показаниями к оперативному лечению являются – злокачественный процесс, подозрение к злокачественному процессу, рост в динамике, компрессионный синдром, косметический дефект. Минимальный объем оперативного лечения является – гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка.

В течение 2006-2010 г.г. в областном онкологическом центре оперативное вмешательство проведено 132 больным с узловыми образованиями щитовидной железы. Гемитиреоидэктомия с удалением перешейка проведено в 107 случаях, из них в 5 случаях установлен рак щитовидной железы. Всем больным проведена повторная операция с удалением противоположной доли. Субтотальная резекция щитовидной железы проведена 12 больным. Операция в объеме тиреоидэктомия проведена 13 больным. Рак щитовидной железы установлен в 7 случаях.

Послеоперационное осложнение как повреждение возвратного нерва наблюдалось в 5 случаях (3,8%).

ӨКПЕ ІСІГІ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН РЕКОНСТРУКТИВТІ-ПЛАСТИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ.

Қарасаев М.И.

Қазақтың Онкология және Радиология Ғылыми Зерттеу Институты

Өкпе ісігінің трахеобронхиальді хирургиясы жылдам дамуда. Оперативті әдістің өзгеруі - кеңірдек пен бронхқа резекция жасау мүмкіншілігін кеңейтті. Бірмезгілде кеңейтілген лимфодиссекция жасау позициясын қарастыру - өкпе ісігінің хирургиялық емінің қазіргі нұсқасы болып отыр.

Кілттік сөздер: өкпе ісігі, трахеобронхиальді хирургия, лимфодиссекция.

Бронх және трахея, әсіресе оның бифуркациялық сегментінің резекциясы жоғарғы қауіп-қатер дәрежесіне, техникалық, анестезиологиялық қамтамасыздандыру қиындықтарына байланысты трахеобронхиальді хирургияда «күрделі» категорияға жатады (Б. В. Петровский, М. И. Перельман және соавт., 1978; В. П. Харченко және соавт., 1982 және басқалар). Операция техникалық орындалуы И. С. Колесников және соавторлары сипатталған әдіс бойынша лимфаденэктомиямен жаслады. Соңғы жылдары лимфогенді метастаздану ерекшелігін ескере отырып лимфаденэктомия терминінің орнына лимфодиссекция қолданылып жүр және оперативті араласудың жаңа нұсқалары қарастырылуда (М. И. Давыдов және соавт., 1994; Л.Н. Бисенков және соавт., 1998 және басқалар). Осыған байланысты реконструктивті-пластикалық операцияның радикалдығын қамтамасыз ететін хирургиялық әдістің принципіалді маңызды сұрақтарына қатысы бар жағдайлар өкпе ісігінде қажетті компонент болып табылатын кеңейтілген операция (лимфодиссекция) арнайы бағаны қажет етеді.

Зерттеу мақсаты: Лимфодиссекциясыз және лимфодиссекциямен жасалған реконструктивті-пластикалық операция-

ларын нәтижелі.

Реконструктивті-пластикалық операцияның материалы, нұсқалары және нәтижелері.

171 науқасқа хирургиялық ем жасалған (ерлер - 141, әйел - 30; T2 - 112, T3 - 59; жалпақ жасушалы рак - 136, аденокарцинома - 35).

Реконструктивті-пластикалық операцияның көлемі: бөліктік резекция - 103, кеңірдектің кеуделік бөлімінің резекциясы - 7, пневмонэктомиямен жасалған кеңірдек бифуркациясының резекциясы - 61. Реконструктивті-пластикалық операцияның қолданылған нұсқалары: шеткілік (27), клиновидналық (52) және бронх пен кеңірдектің циркулярлы резекциясы (92).

Операция 1982 жылдан бері қолданыла бастаған. 1982-1987 жылдар аралығында 32 науқасқа лимфаденэктомиясыз реконструктивті-пластикалық операциясы жасалған.

1988-1998 жылдар аралығында 79 науқасқа лимфаденэктомиямен реконструктивті-пластикалық операция жасалған. 1998-2005 жылдар аралығында 59 науқасқа лимфодиссекциямен реконструктивті-пластикалық операциясы жасалған.

Реконструктивті-пластикалық операция жасау барысында өзіндік оперативті әдіс қолданылды: бронх пен кеңірдек диаметрінің сәйкессіздігінде анастомозға максимальді тартылу жүктемесін алдын алу мақсатында бронх пен кеңірдекке жалғанатын шеміршектің дистальді және проксимальді соңын тілмей және провизорлы тігіс салмай мембранозды қабырғасына клиновидті тігіс салынды.

Лимфаденэктомия И.С. Колесников бойынша жасалынды. Әдеби мәліметтерді ескере отырып, кеңірдек пен ірі бронхтың кең медиастенальді лимфаденэктомиясы мен «скелетизациясын» жасау оның жазылуына қолайсыз жағдай жасайды және тігістің тұрақсыздығының дамуына әкеледі (И. С. Колесников, С. Н. Соколов, 1960; Н.А. Жаворонков, 1987 және басқалар), негізінен трахеобронхиальді лимфа түйіндері алынды.

Лимфодиссекция жалпы қолданылған нұсқалар бойынша этаппен жүргізілді: трахеобронхиальді жоғарғы, төменгі (бифуркациялық), трахеальді, жоғарғы және төменгі кеудеаралық, сонымен қатар алдыңғы және артқы кеуде аралық лимфа түйіндері мен теріасты шелмай қабаты алынды.

Соңғы жылдары біздің клиникада лимфодиссекция кеудеішілік лимфа түйіндерінің процеске қатысы болған не болмаған жағдайда барлық топтарын алумен аяқталған.

Реконструктивті-пластикалық операциялардың нәтижелерінің анализі: әдісті қалыптастырудың алғашқы кезеңінде және операцияны клиникаға енгізу барысында плевра ішілік қан кету (5 науқас) және анастомоздың тұрақсыздығы (7 науқас) сияқты асқынулар болды. 1988-1998 жыл аралығында жасалған реконструктивті-пластикалық операцияларды жасау кезінде көрсетілген асқынулар айтарлықтай азайды. Соңғы жылдары плевра ішілік қан кету және анастомоздың тұрақсыздығы сияқты қатерлі асқынулар 1,9 %-ға азайды. Алдын алу шараларының жасалуына қарамастан, бұрынғыдай өкпе артериясының тромбозынан науқастардың өлімі жалғаса берді. Тромбоэмболиялық асқынуларға, аяқтың варикозды кеңеюіне көңіл бөлінді және гиперкоагуляцияның болу - болмауына қарамастан антикоагулянтты терапия жүргізілді: тренталмен реополиглюкин, рефортан, гепарин немесе фраксипарин.

Бір жағдайда операцияның келесі күні хилоторакстың клиникасы диагностикаланды. Хилоторакстың даму себебі - кеуде ішілік лимфа түйіндеріне араласумен шақырылған тарамдалған кеуделік лимфатикалық жолдың зақымдалуы.

Консервативті шаралармен (өзіндік әдіс бойынша плевра қуысына резектелі дренаж арқылы 1% метилен көгінің сулы ерітіндісін енгізу) операциядан кейін 14 тәулікте хилоторакс жойылды.

Институтта лимфодиссекциямен жасалатын реконструктивті-пластикалық операцияны енгізу (1988-2005) аралығында операциядан кейінгі асқынулар 16,4 %,

летальдік - 10,5% болды.

Осылайша, зерттеу нәтижелері реконструктивті-пластикалық операцияларды орындауға мүмкіншілік беруді сипаттайды. Қазіргі кезде, өкпе ісігінде қолданылатын «кеңейтілген операциялар» түсінігіне лимфодиссекциямен қосарланған реконструктивті-пластикалық операция енгізілуі қажет.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА

Боромбаев У.Т.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: за последние 30 лет заболеваемость раком желудка в развитых странах снижается, вместе с тем общее число ежегодно заболевших остается значительным. По данным ВОЗ и американских исследователей в мире ежегодно регистрируется 755 тыс. новых случаев рака желудка (чаще регистрируется только рак легкого).

Цель работы: проанализировать эффективность видов лечения рака желудка за 3 года в Павлодарском областном онкологическом диспансере.

Материалы и методы: истории болезни, амбулаторные карты пациентов за 2007 – 2009 г.г., пролеченных с диагнозом: рак желудка.

Из общего числа выявленных больных I - II стадия болезни диагностирована у 108 пациентов (19,6%). Только у этой категории больных может идти речь об излечивании после хирургического вмешательства (проведение радикальной операции), III стадия выставлена 184 (33,8%) больным. 259 человек (47,1%) – это больные с IV стадией заболевания. При рассмотрении вопросов заболеваемости раком желудка отметим ряд важных моментов. За 3 года нам удалось снизить показатель запущенности с 56,2% в 2003г. до 47,1% в 2009, несмотря на неуклонный рост онкологической заболеваемости. Примерно в 50% случаев наших наблюдений рак желудка встречался в антральном отделе, в 30% - в теле желудка, в 8% - в кардиальном отделе и в 12% наблюдалось поражение двух и более отделов желудка. Преобладающей формой роста явился инфильтративный, который не имеет специфической клинической картины. В наших наблюдениях распространение опухоли на пищевод наблюдалось в 34 случаях, прорастание в поджелудочную железу - в 27, прорастание в кишечник - в 15 наблюдениях. Наиболее часто отдаленные метастазы обнаруживались в печени - 40%, в забрюшинных лимфоузлах - 12%, в легких - 8%, метастазы Вирхова, Крукенберга, Щитцлера - в 3%, а также в костях, в головном мозге.

Основным методом лечения является оперативный. Радикальное хирургическое лечение возможно только у небольшого количества пациентов. Оптимальным объемом оперативного пособия на первичном очаге считают операции: тотальная и субтотальная гастрэктомия, резекция кардиального отдела желудка. За 3 года нами было выполнено 150 операций при раке желудка, из них радикальных - 68, что составило 45% от общего количества оперированных (гастрэктомии - 31, субтотальные резекции - 37), паллиативных операций проведено 44 (29%), которые выполнялись при осложненном раке желудка (кровотечения, стеноз), в отдельных случаях - даже при метастазах в печень. В 23% случаев операции носили экзplorативный характер (диагностический). 4 пациента оперированы в экстренном порядке ввиду наличия осложнений основного заболевания. Показатель операбельности составил - 46,8%, резектабельности - 29,2%. Умерло после операции 3 больных. Процент послеоперационной летальности составил 1,9%. Причинами смерти у больных явилась несостоятельность анастомоза после гастрэктомии - 1 случай, перитонит - 1 случай, сердечно-легочная недостаточность после резекции желудка,

осложненная двухсторонней нижнедолевой гнойной пневмонией - 1 случай. Процент послеоперационных осложнений составил - 2,9%. Противопоказаний к оперативному лечению было 11, что составило 3,7%, отказов больных от операции - 31 (10,9%). 57% больных получили только хирургическое лечение, комбинированное и комплексное - 31%, только лекарственное - 2%. По нашим данным, из числа пролеченных до 1 года жили 56,7%, от 1 до 2-х лет - 20,3%, более 2-х лет - 23%. Из числа проживших более 2-х лет основной процент приходится на больных, получивших комбинированное и комплексное лечение.

Выводы и заключение: проблема своевременной диагностики и эффективного лечения рака желудка остается до конца нерешенной. Низкие показатели раннего выявления больных требуют комплексного и комбинированного подходов к лечению. Паллиативная хирургическая помощь в сочетании с химиотерапией позволяет улучшить результаты лечения, в конечном итоге влияя на продолжительность и качество жизни онкобольных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Ежегодно выявляют около 120-130 больных с данной патологией. Однако хирургическому лечению подвергаются около 10% (10-12) больных. Основными причинами отказа в хирургическом лечении является распространенность опухолевого процесса в связи с поздним обращением больного, наличие сопутствующей декомпенсированной патологии.

Хирургическое лечение проведено 42 больным. Из них мужчин 17, женщин 24. Возраст больных от 34 лет до 68 лет. У 11 больных опухоль располагалась в н/3 пищевода. У 32 больных в с/3 пищевода.

Радикальные операции выполнены 27 больным, из них 3 больным экстирпация пищевода с колопластикой. Паллиативно-шунтирующие операции проведены 3 больным. В 14 случаях произведены экзplorативные операции. Осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 8-х больных: Частичная несостоятельность анастомоза по типу дивертикула - 1. Несостоятельность швов культи желудка - 2. Несостоятельность дистальной культи пищевода - 1. Дыхательная недостаточность - 4. Частичная несостоятельность анастомоза по типу дивертикула выявлено в послеоперационном периоде при контрольной рентгеноскопии, консервативным методом лечения удалось добиться заживления дефекта. Несостоятельность швов культи желудка возникло у 2-х больных с последующим развитием эмпиемы плевральной полости. На фоне консервативного лечения заживление дефекта желудка достигнуто через 56 и 63 сутки. В раннем послеоперационном периоде умерло 4 больных от острой дыхательной недостаточности.

Таким образом, ведущим методом лечения рака пищевода является оперативное вмешательство, позволяющее улучшить качество жизни и продлить выживаемость больных.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Рак желудка в Кызылординской области занимает одно из ведущих мест в рейтинге заболеваемости злокачественными опухолями. Около 25-30 процентах случаях выявляется в распространенной форме.

В промежуток 2004-2010г.г. 76 больным первичным раком желудка проведено оперативное лечение. Комбинированные операции проведены 14 случаях (18,5%).

- расширенная гастроплеаноэктомия с резекцией поперечно-ободочной кишки - 2

- расширенная гастроспленозэктомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы - 4
 - расширенная гастроспленозэктомия, корпорокаудальная резекция поджелудочной железы, резекция левой доли печени - 1.
 - расширенная гастроспленозэктомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы, резекцией поперечно-ободочной кишки - 2.
 - расширенная гастроспленозэктомия с резекцией диафрагмы - 1.
 - расширенная субтотальная резекция желудка с резекцией поперечно - ободочной кишки - 4.
- Осложнения наблюдались в 4 случаях.
 Дыхательная недостаточность - 2.
 Сердечно-сосудистая недостаточность - 2.

Несмотря на некоторые успехи комбинированных методов лечения, именно хирургический метод является «золотым» стандартом при радикальном лечении распространенного рака желудка, позволяющим надеяться на полное выздоровление.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Хирургическое лечение рака легкого является единственным эффективным методом. По данным разных авторов, операбельным является только 10-30% больных. Несмотря на постоянное совершенствование оперативной техники пятилетняя выживаемость колеблется в пределах 25-0%.

В течение 2006-2010гг. в областном онкологическом центре произведено 76 оперативных вмешательств при раке легкого. Возраст больных составил от 23 до 76 лет. I-II ст – 12 больных, III ст – 29 больных, IIIB ст – 35 больных. Мужчин 35, женщин 41. Радикальные операции произведены 52 больным. Прецизионная резекция легкого – 7, расширенная лобэктомия – 27, расширенная билобэктомия – 7, расширенная пневмонэктомия - 11. Комбинированные операции проведены в 16 случаях (30,8%). Диагностическая торакотомия – 24 (31,6%).

В 13 (17,1%) случаях в послеоперационном периоде наблюдались осложнения, представлены следующим образом: ДВС – 1, внутриплевральное кровотечение – 5, послеоперационная пневмония - 2, частичная несостоятельность культи бронха – 2, вывих сердца - 1, транзиторное нарушение мозгового кровообращения - 2, острая сердечно-сосудистая недостаточность – 1. Послеоперационная летальность составила 5,2% (4).

USE OF BRACHYTHERAPY IN CERVIX CANCER

Saidova K. O., Mansurova G. B., Sabirdjanova Z. R.

National oncological centre of the Public Health Ministry of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Nowadays cervix cancer is one of most often tumours of female genitals. The basic method of treatment of local spread cervix cancer is combined radial therapy and chemotherapy. However local spread cervix cancer becomes frequently complicated with acute bleeding and pain. In consequence of these complications fast developing anemia sharply burdens patient's condition and carrying out of chemo- and radial therapy becomes impossible. One of the effective methods to control bleeding in cervix cancer patients is endovascular embolization of internal iliac and uterine arteries. But at contra-indications to this method and patient's refusal, intracavitary brachytherapy is becoming an alternative method to control bleeding.

Aim of the inquiry: to assess the direct results of intracavitary brachytherapy in cervix cancer, complicated with hemorrhage.

Materials and methods: 37 women with local spread cervix cancer complicated with chronic bleeding were examined. The

mean age was 40±4,2 years (range, 32 – 45 yr). In 15 patients (40,5%) was anemia of I stage, in 20 (54,1%) – II and in 2 (5,4%) patients was determined anemia of III stage. Patients were categorized depending on cervix cancer stages. In 8 (21,6%) patients was defined II stage of cervix cancer (T2bNoMo), in 27 patients (72,9%) – III stage (T3aNxMo) and in 2 (5,4%) – IV stage (T4NxMo). All patients received conservative haemostatic therapy with the purpose of stopping of bleeding from tumour, increasing of haematological indicators, prevention of infectious complications, knocking over of a painful syndrome, strengthening of protective forces of patients. Brachytherapy on the apparatus Gammamed-plus with the source of radiation iridium-192 was applied in inefficiency of haemostatic therapy. Radiation dose reached the target with use of cylinder applicators Varian.

Results: direct results of intracavitary brachytherapy in cervix cancer patients, complicated with bleeding were showed in the first days and expressed in hemostasis. After stop of bleeding and correction of homeostatic disorders combined radial therapy was carried out. The irradiation was carried out on the device "Teratron - 780E" with a source of radiation cobalt 60. Thus, carrying out of intracavitary brachytherapy has allowed to stop in the shortest time bleeding from tumour, improve the general condition and haematological indicators in cervix cancer patients.

ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ У БОЛЬНЫХ, РАДИКАЛЬНО ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА

Альгожин Т.Б.

Павлодарский областной онкологический диспансер

Актуальность - гастрэктомия в большинстве наблюдений выполняется по поводу распространенного опухолевого процесса желудка и по данным различных авторов в 0,5–50% случаев приводит к рубцовым сужениям пищеводно-кишечного анастомоза, проблема профилактики и лечения которых остается актуальной.

Цель исследования – изучить влияние комплексного лечения рубцовых стенозов пищеводно-кишечных анастомозов, сформировавшихся после радикальных операций по поводу рака желудка в послеоперационном периоде на непосредственные и отдаленные результаты лечения на региональном уровне без применения высокотехнологических методов лечения.

Материал и методы. В ПООД за период 2000 – 2009 гг. прослежено 24 пациента с рубцовыми стенозами пищеводно-кишечных анастомозов, сформировавшимися после радикальных операций по поводу рака желудка в послеоперационном периоде. Курс комплексного лечения включал эндоскопическое рассечение рубцовой стриктуры, сеансы бужирования с помощью бужей и эндоскопов различных диаметров и применение интенсивной консервативной рассасывающей терапии.

Результат после курса лечения считался «отличным» при расширении анастомоза более 13 мм, при этом дисфагии не отмечалось, пациенты питались любой пищей, практически ни в чем себе не отказывая. Таких пациентов оказалось 9 (37,5 %). Результат оценивали как «хороший» при диаметре анастомоза от 10 до 13 мм, при этом отмечалась эпизодически возникающая дисфагия, связанная с нарушением диеты. Данный эффект был достигнут у 7 пациентов (29,2 %). «Удовлетворительным» был признан результат при диаметре соустья до 10 мм, когда анастомоз по сравнению с первоначальным был расширен, однако больные отмечали эпизодическую дисфагию, связанную с приемом грубой пищи. Подобный результат был получен у 5 (20,8 %). Результат считали «неудовлетворительным» при любом диаметре анастомоза, когда не было какого-либо эффекта после эндоскопического

лечения. Неудовлетворительный результат был у 3 (12,5 %), у которых дисфагия была связана с продолженным ростом опухоли, выявленным при эндоскопическом исследовании, подтвержденном через 6 месяцев после операции биопсийным материалом. Противовоспалительный эффект комплексной терапии подтвержден морфологическими исследованиями гастриобоптатов. У больных после курса лечения в 70 % случаев отмечалась нормализация процессов регенерации и пролиферации в слизистой оболочке зоны анастомоза в течение 10 дней.

Результаты и выводы. Комплексное лечение с применением малоинвазивной хирургии позволяет предотвратить повторное стенозирование зоны пищевода анастомоза в 87,5 % случаев, избежать повторного оперативного вмешательства и повысить уровень качества жизни пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Абдрахманова М.М.

Акмолинский областной онкологический диспансер

Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на органах грудной клетки является одной из наиболее сложных анестезиологических проблем и имеет ряд своих особенностей. При выборе способа интубации дыхательных путей следует исходить из необходимости поддержания адекватной вентиляции при нарушении герметичности дыхательных путей оперируемого легкого, проведения независимой вентиляции каждого из легких, изоляции пораженного легкого от здорового для предотвращения попадания в последнее патологического содержимого. С этой целью используется метод раздельной интубации главных бронхов и одноклонной интубации. Максимальная глубина анестезии необходима в процессе расширения межреберного промежутка. При негерметичной грудной клетке в отсутствие присасывающего отрицательного внутригрудного давления уменьшается венозный возврат. При операциях на легких инфузия жидкости строго ограничивается, восполняются только базальные потребности организма в жидкости и кровопотеря. С целью профилактики развития послеоперационной пневмонии уже интраоперационно, перед вводным наркозом начинается антибиотикотерапия. В конце операции культя бронха или оставшаяся легочная ткань проверяется на герметичность под водой и проводится обязательное расправление всей оставшейся легочной ткани. Нарушения газообмена и гемодинамики в следствии пневмоторакса, искусственной вентиляции легких, удаления части легочной ткани могут привести к грозным осложнениям. Правильная подготовка к операции, грамотное ведение анестезии с учетом всех особенностей и рациональный послеоперационный период позволяют снизить частоту осложнений, что и является целью данного исследования. За период 2008- первую половину 2010 гг. в Акмолинском областном онкологическом диспансере прооперированы 62 пациента торакального профиля. Мужчин- 46, женщин- 16. Возраст больных от 13 до 69 лет. У 56% из них имелись клинически значимые сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца у 15, постинфарктный кардиосклероз-1, артериальная гипертензия – 7, хронический бронхит 8, сахарный диабет- 1, варикозное расширение вен нижних конечностей-3, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки-2. Достаточная компенсация функций внешнего дыхания с нормальными и незначительными отклонениями была отмечена у 39 больных (63%), у 21 (34%) – нарушения легочной вентиляции были умеренными. У 2 пациентов (3%) отмечалось весьма значительное снижение жизненной емкости легких (60% и ниже). В 16 случаях операции закончились пульмонэктомией, 18- лобэктомией, 15- резекцией сегмента легкого, 7- удалением опухоли средостения, 6- пробной

торакотомией с биопсией. Продолжительность операции составила от 35 минут до 4 часов 40 минут, в среднем 2 часа 15 минут. Кровопотеря от 100 до 1300 мл, в среднем 450 мл. У 9 (14,5%) пациентов послеоперационный период осложнился развитием пневмонии, у 1 (1,6%) – инфаркта миокарда, еще 1 (1,6%) – нарушением ритма по типу фибрилляции предсердий. Наиболее грозным осложнением является внутриплевральное кровотечение. Оно наблюдалось в 2(3,2%) случаях. Из 62 прооперированных больных умерло 5 (8%), 4 после пульмонэктомии, 1-удаления опухоли средостения. Причина смерти в 2случаях-острая сердечно-сосудистая недостаточность, 2-пневмония единственного легкого, дыхательная недостаточность, интоксикация, 1-кровотечение. Дальнейшее улучшение результатов хирургического лечения больных с торакальной патологией возможно при более тщательной подготовке сердечно-сосудистой и дыхательной систем до операции, рациональном ведении больного в послеоперационном периоде, совершенствовании техники операции, анестезиологического и реанимационного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЛЬЮИСА.

Абдрахманова М.М.

Акмолинский областной онкологический диспансер

По Акмолинской области в структуре онкопатологии рак пищевода занимает 9 место. За период 2006- 2010гг. заболевание выявлено у 277пациентов. С 2006 года на базе нашего диспансера начато оперативное лечение больных с раком нижней и средней трети грудного отдела пищевода. Внедрена операция Льюиса. За это время прооперировано 16 пациентов, что составило 5,7% - 11 мужчин и 5женщин в возрасте от 41 года до 74 лет. Сопутствующая патология выявлена у 13 больных. Ишемической болезнью сердца страдали 11 человек, артериальной гипертензией – 2, хроническим пиелонефритом - 2. Пять пациентов являлись злостными курильщиками. Локализация была среднегрудной у 3, нижегрудной у 10 пациентов. В 3 случаях в опухолевый процесс был вовлечен кардиальный жом желудка. Два прооперированных больных со второй стадией заболевания, остальные с третьей стадией.

Одной из важных задач, стоящих перед анестезиологической и хирургической бригадами, является решение вопроса, связанного с функциональной операбельностью. Тщательное исследование функциональных резервов организма в сопоставлении с предполагаемой травматичностью операции позволяет уменьшить количество послеоперационных осложнений и летальность. Операция Льюиса относится к одной из самых травматичных хирургических вмешательств. Продолжительность операции составила в среднем 3 час 30 мин +- 35 мин. В среднем на 6-7 сутки после операции больным проводился рентгенологический контроль для оценки функционального состояния перемещенного желудка, легочной ткани. Примерно в эти же сроки начинали зондовое питание. Послеоперационные осложнения были зарегистрированы у 12 больных (75%). Пневмония- 4(25%), инфаркт миокарда-1(6,2%), острая сердечно-сосудистая недостаточность-3(18,7%), внутриплевральное кровотечение-1(6,2%), несостоятельность анастомоза-4(25%). Послеоперационная летальность составила 25 %. Наиболее грозным осложнением после операции Льюиса является не состоятельность швов внутригрудного пищевода-желудочного анастомоза. В 4 наблюдениях этого осложнения умерло 2 больных. Причиной смерти еще 2 пациентов стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Другая серьезная проблема послеоперационного периода - легочно-плевральные осложнения. Как правило, они являются следствием неблагоприятного фонового состояния трахеоброн-

химального дерева, а также односторонней вентиляции или в отсутствие раздельной интубации бронхов - гиповентиляции и вынужденного «сдавливания» правого легкого при выполнении торакального этапа операции. И здесь важный момент – оценка состояния легкого перед ушиванием торакотомной раны. К этому моменту не должно оставаться ателектазов, повреждений легочной ткани. К профилактике развития легочных осложнений также относятся ранняя активизация больных, стимуляция самостоятельного откашливания мокроты с выполнением ингаляций, вибромассаж грудной клетки, коррекция гиперкоагуляции. В наших наблюдениях пневмония констатирована у 4 больных. Исход благоприятный. Прогностическим для развития легочных осложнений является и фактор кровопотери, как интраоперационной, так и послеоперационной. С целью определения адекватности хирургического гемостаза и профилактики послеоперационных кровотечений ревизию средостения и плевральной полости необходимо проводить в условиях умеренной гипертензии, так как осуществление ее в условиях гипотензии не гарантирует правильную оценку гемостаза. Мы наблюдали 1 послеоперационное внутриплевральное кровотечение. Больной был взят на реторакотомию, кровотечение остановлено.

Безусловно, операция Льюиса сложна и не прощает ошибок. Но именно хирургическое вмешательство остается максимально эффективным и составляет основу комбинированного и комплексного лечения. Далеко не все резервы данного вмешательства исчерпаны, что определяет целесообразность совершенствования технических, анестезиологических, реанимационных аспектов.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА 3-Й СТАДИИ

Абдурахимов О.Н., Юсупов Б.Ю.

Республиканский научный центр онкологии МЗ РУз.

Цель: Оценить достоверность клинико-инструментальных исследований и пункционной биопсии при определении метастазов в регионарные лимфатические узлы.

Материалы и методы. В своей работе мы проанализировали достоверность до операционных методов исследований с результатами послеоперационных гистологических исследований шейных регионарных лимфатических узлов.

32 пациентам до операции проведена химиолучевая терапия с препаратами фторурацил, цисплатин и дистанционная гамматерапия СОД-40 Грей (РОД по 3 Гр) на первичный очаг с захватом зоны регионарных лимфатических узлов шеи. Через три недели всем пациентам произведено хирургическое лечение с удалением опухоли и регионарных лимфатических узлов.

По данным гистологических исследований удаленных шейных лимфатических узлов установлено, что из 32 пациентов метастазы обнаружены у 29 (90,6%). У 12 больных установлено поражение 1го уровня лимфатических узлов. У 9 (41,3%) отмечалось поражение 2-3 уровня лимфатических узлов. У 8 (27,5%) отмечалось поражение 1,2,3,4,5 уровней лимфатических узлов. Функциональная лимфодиссекция с двух сторон выполнялась у 6 (20,6%) пациентов. У 4-х пациентов объем операции оценивался как радикальная лимфодиссекция. Из 29 пациентов у 7 (24,1%) метастатические узлы были неподвижные, с прорастанием узлов на внутреннюю яремную вену и на мышцы шеи. Осложнение в виде вторичного заживления раны на шеи отмечена в 3-х случаях.

Таким образом, при раке слизистой оболочки дна полости рта 3 стадии, по нашим данным отмечалось поражение шейных лимфатических узлов у 90% случаев, следовательно, выполнение одномоментной лимфодиссекции

улучшает результаты комплексного лечения.

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Адылханов Т.А., Коровников А.Г., Чайжунусова Н.Ж.

Государственный медицинский университет г. Семей

Региональный онкологический диспансер г. Семей

*Научно-исследовательский институт радиационной
медицины и экологии г. Семей*

Актуальность: Важной проблемой современной онкологии является повышение качества жизни (КЖ) больных раком молочной железы (РМЖ) после радикальных операций. Для проведения эффективного восстановительного лечения необходимо определить реабилитационный потенциал (РП) пациентки на основе комплексной оценки КЖ. Ранее РП в онкологической практике не использовался, встречались единичные упоминания в научной литературе.

Цель работы: Оценка РП больных РМЖ после радикальных операций как основа для проведения лечебно-восстановительных мероприятий.

Материалы и методы: Проведены лечебно-восстановительные мероприятия с учётом РП у 60 больных РМЖ, перенесших радикальное оперативное лечение. Пациентки были разделены на три группы по 20 человек в зависимости от уровня РП: 1) с высоким РП; 2) со средним РП; 3) с низким РП.

Эффективность терапии оценивалась клинически и при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии и опросника депрессии Бека.

В первой группе тревожно-депрессивные нарушения отсутствовали либо были выражены умеренно и легко поддавались краткосрочной психофармакотерапии (ПФТ) малыми дозами транквилизаторов (до 2-х недель) или антидепрессантов (от 4-х недель). Проводились психопрофилактические беседы или экспресс-психотерапия (1-5 сеансов).

Во второй группе отмечались выраженные тревожно-депрессивные реакции, для коррекции которых требовался более длительный приём антидепрессантов (флувоксамин) в средних дозах в сочетании с мультимодальной психотерапией (6-10 сеансов).

В третьей группе отмечались стойкие тревожно-депрессивные расстройства, требующие длительного приёма антидепрессантов в средних и высоких дозах в сочетании с прерывистыми курсами транквилизаторов и длительной поддерживающей мультимодальной психотерапией.

Результаты: Через 3 мес. выраженный эффект ПФТ отмечался у 95 % больных первой группы, 80 % пациенток второй группы и 60 % больных третьей группы.

Выводы: Таким образом, нами показано, что определение РП способствует индивидуализации и эффективности лечебно-восстановительных мероприятий, направленных на повышение КЖ у больных РМЖ после радикальных операций.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БҮЙРЕК РАГЫН ЕМДЕУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ.

Балтабеков Н.Т., Аманбеков Н.А.

*С.Ж.Аспендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қалалық
онкодиспансері.*

Алматы қалалық онкологиялық диспансерінде 2010 жылы бүйрек рагына шалдыққан 542 науқас тіркелген. Олардың ішінде 83 науқасқа диагноз алғаш рет қойылған.

2010 жылы анықталған науқастардың арасында 60,2±5,3%

ісіктік процесстің І-II даму сатысында, $30,1 \pm 5,2\%$ ІІІ даму сатысында, $9,6 \pm 5,1\%$ ІV даму сатысында тіркелді.

Алғашқы рет анықталған 83 науқастың 4-не өмірлік маңызды ағзалар тарапынан ауыр дәрежедегі ауруы болғандықтан ем жүргізілмеді, науқастардың 7-і ұсынылған емнен бас тартты. 83 науқастың 47-не жеке хирургиялық ем жасалынды, ол $56,2 \pm 5,1\%$ құрады, сәулелік ем қолданылмады және 25 науқасқа хирургиялық еммен қабаттасқан иммунды терапия (α -интерферон) жүргізілді ($30,1 \pm 5,1\%$).

2010 жылы 7 ай ішінде анықталған 83 науқастың 12-сі алғашқы 6-ай ішінде қайтыс болды. Олардың 8-де $66,7 \pm 5,1\%$ ісіктік процесстің ІV даму сатысында, 3 науқас (25%) ІІІ даму сатысында және ісіктік процесстің І даму сатысындағы 1 науқас хирургиялық емнің асқынуынан қайтыс болды.

Қорытынды: сонымен Алматы қаласында бүйрек рагының ерте даму сатысындағы шалдыққан науқастар $60,2 \pm 5,3\%$ жағдайда анықталады. Асқынған даму сатысындағылар $9,6 \pm 5,1\%$ құрайды.

Бүйрек рагына шалдыққан науқастарды еммен қамту $86,1 \pm 5,1\%$ құраса, ал 1 жылдық өлім көрсеткіші $14,5 \pm 3,5\%$ құрады.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Онгарбаев Б. Т.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Рак мочевого пузыря является достаточно частой патологией: среди злокачественных заболеваний органов мочеполовой системы после опухолей почек находится на втором месте. Его встречаемость составляет 3,8 на 100 тыс населения нашей страны. На сегодняшний день, стандартом лечения инвазивного рака мочевого пузыря, признанного во всем мире, является радикальная цистэктомия.

Целью нашего исследования явилось определение тактики оперативного лечения при выявлении инвазивной формы рака мочевого пузыря.

Материалы и методы. С 2006 по 2009 годы и первое полугодие 2010 г в отделении онкоурологии КазНИИОиР находилось на лечении 560 больных раком мочевого пузыря, из них 155 больных прооперированы по поводу инвазивного рака мочевого пузыря: 30 больным проведена резекция мочевого пузыря, 135 больным – радикальная цистэктомия.

В зависимости от местного распространения опухоли больные распределены следующим образом. У пациентов с резекцией мочевого пузыря – у 24 пациентов заболевание было ограничено стенкой мочевого пузыря (Т2а-б), у 4 имела микроинвазия в перивезикальную клетчатку, у 1 больного опухоль распространялась на перивезикальную клетчатку. Для пациентов с радикальной цистэктомией у 61 больных отмечено прорастание мышечной оболочки, у 26 – прорастание в перивезикальную клетчатку и у 10 – опухоль распространялась на предстательную железу.

Во всех случаях гистологически был верифицирован переходно-клеточная рак.

Обращает на себя внимание уменьшение количества больных, которым проведена резекция мочевого пузыря (14 больных в 2006 году и 4 больных в 2009-2010 гг), и наоборот возрастание числа больных, которым произведена радикальная цистэктомия (в 2005 – 3, в 2006 году – 11, в 2009-2010- 71).

Больным после радикальной цистэктомии, у которых опухоль ограничена мышечной стенкой (Т2) и высокодифференцированными опухолями -G1 в после операционном периоде лечение не назначалось, всем остальным пациентам (Т≥2, G2-4, N+) назначались курсы ПХТ.

Результаты. Больные, которым мы провели резекцию

мочевого пузыря, это люди пожилые, с массой сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, анемией тяжелой степени, которым проведение оперативного лечения в объеме радикальной цистэктомии было сопряжено с высоким риском. У всех этих пациентов опухоль располагалась на подвижных стенках, не превышала 5см в диаметре и была ограничена мышечной стенкой мочевого пузыря. Также этим пациентам проводилась регионарная лимфодиссекция с одноименной стороны с диагностической целью. В 8 случаях опухоль закрывала устье мочеточника с нарушением эвакуаторной функции почки и была произведена резекция с уретероцистостомией. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под наблюдением. На фоне проведенного лечения у 5 больных выявлен рецидив заболевания и 2 больных умерли от прогрессирования процесса.

В послеоперационном периоде у пациентов после радикальной цистэктомии по различным причинам умерло 12 человек, из них в раннем послеоперационном периоде 3 больных. Анализ летальности в двух случаях выявил разлитой перитонит вследствие несостоятельности тонко-тонкокишечного анастомоза, в одном – развитие тромбоза боили легочной артерии.

Выводы. Таким образом, при инвазивном раке мочевого пузыря на сегодняшний день стандартом лечения является проведение радикальной цистэктомии при условии достаточной дооперационной подготовки больных и послеоперационного ведения больных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА.

Баймаханов Б.Б., Тулеутайұлы К., Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Ежегодно по Кызылординской области выявляется от 100 до 110 больных с первичным раком желудка. К сожалению, в связи с отсутствием скрининга рака желудка у 70-88% первично выявленных больных заболевание диагностируется в III-IV стадии, что предопределяет неудовлетворительные результаты лечения. Частота обнаружения ранних форм рака желудка не превышает 10-15%.

Целью исследования явилось изучение возможности оперативного лечения рака желудка в течении 6 лет (2004-2010гг) в Кызылординском областном онкологическом центре.

Материалы и методы: был проведен анализ оперативного лечения 64 больным первичным раком желудка.

При анализе оперативного лечения 64 больных первичным раком желудка расширенная гастропленозектомия проведена 12 пациентам, расширенная гастрозектомия с лимфодиссекцией ворот селезенки - 4, расширенная субтотальная резекция желудка – 12, комбинированная гастропленозектомия – 5:

- расширенная гастропленозектомия с резекцией поперечно-ободочной кишки
- расширенная гастропленозектомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы -3
- расширенная гастропленозектомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы, резекцией поперечно-ободочной кишки

Комбинированная субтотальная резекция желудка – 5:

- расширенная субтотальная резекция желудка с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы.
- расширенная субтотальная резекция желудка с резекцией поперечно-ободочной кишки – 4.

Экстирпация культи желудка с расширенной лимфодиссекцией – 2.

Обходной гастрозентероанастомоз – 13.

Эксплоративная лапаротомия – 11.

Осложнения наблюдались в 11 случаях:

Дыхательная недостаточность – 6 (9,3%).

Сердечно-сосудистая недостаточность – 3 (4,6%).

Несостоятельность швов анастомоза – 2 (3,1%).

Летальность наблюдалась в двух случаях (3,1%) при несостоятельности швов анастомоза.

Несмотря на некоторые успехи комбинированных методов лечения, именно хирургический метод является «золотым» стандартом при радикальном лечении рака желудка, позволяющим надеяться на полное выздоровление.

СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА (ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

*Баспаева М.Б., Дюсембеков С.Т., Жолмухамедова Д.А.
Медицинский Центр ЗКГМУ им. М. Оспанова, Актюбе*

Большинство операций при раке желудка выполняются в третьей стадии онкологического процесса и должны рассматриваться как условно радикальные. Показатель 5 летней выживаемости по данным подавляющего большинства исследователей не превышает 25-35%. Больные погибают от рецидивов и метастазов опухоли в течении 2-3 лет после операции. Необходим поиск дополнительных и одновременно совершенствование имеющихся методов лечения, в частности, химиотерапии.

Приводим пример пациентки Ф. 1950г.р. раком желудка 111 стадии T3N2Mo, состоящей на учете с 02.2007г (3 года 6 месяцев). После выполнения 6.02.2007г операции, гастрэктомии с лимфодиссекцией Д1 (гистология № 2837-51 от 15.02 – низкодифференцированная аденокарцинома с прорастанием мышечного слоя, стенки желудка и мтс в лимфоузлы малой кривизны; № 2837-54 – в лимфоузле а. sinuistica – мтс аденокарциномы, прорастает капсулу узла), учитывая циторедуктивность, гистологию и стадию заболевания было проведено 3 курса химиотерапии, которую закончила в июне 2007г. В марте 2009г выявлено прогрессирование – мтс в лимфоузлы шеи (цитология № 1736-7 от 30.03 – железистый рак) и парааортальные лимфоузлы (КТ). Проведено 3 курса химиотерапии (онкоплатин, 5фторурацил) с регрессией до 90%. В 10.09г вновь увеличение шейных лимфоузлов (цитология № 6298-9 от 20.10 – железистый рак). Проведено 4 курса химиотерапии (1 – онкоплатин, КАМПТО, кселода; 2 и 3 курсы – онкоплатин, кселода), 4 – оксалиплатин, кселода). Отмечена положительная динамика в виде регрессии лимфоузлов шеи до 80-90%. Находится на диспансерном наблюдении, состояние больной удовлетворительное.

Планируемая тактика – проведение химиотерапии при последующих рецидивах заболевания с использованием препаратов последующих поколений, их комбинаций; достижений при этом более длительных регрессий, что соотносится с современными тенденциями о переводе онкологических заболеваний в разряд хронических болезней.

ЦИРКУЛЯРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕГКОГО И ТРАХЕИ

Бейсебаев А. А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

С применением технически наиболее сложного вида органосохраняющей операции – циркулярной резекции и пластики бронхов и бифуркации трахеи, а также грудного отдела трахеи прооперированы 68 больных раком легкого в возрасте 21-73 лет (мужчин 59, женщин 9). Из них у 41 больного операция была в объеме долевых резекций с циркулярной резекцией главного и промежуточного или долевого бронхов, у 12 – правосторонняя пневмонэктомия с циркулярной резекцией нижней трети трахеи, левого главного бронха, у 15 – резекция грудного отдела трахеи.

Осложнения после операции диагностированы у 29,2% (2 случая хилоторакс, несостоятельность анастомоза у 13, внутриплевральное кровотечение – 3, острая дыхательно-

сердечная недостаточность – 5). Летальность 11,8%. Huang Jian, Wang Mao-sheng (2004) осложнения после подобных операций наблюдали в 37,5% случаев, Nawa Haroshi et al. (1999) – 26,8% случаев.

Важным условием внедрения этих операций в клинику – необходимы адекватное обеспечение анестезиологического пособия и высокая техника оперирования.

РАСШИРЕННЫЕ И РАСШИРЕННО-КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА.

*Бекмухамбетов Е.Ж., Дюсембеков С.Т.,
Бегунов В.В., Жолмухамедова Д.А.*

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР – болезней, г.Актюбе.

Актуальность. Заболеваемость колоректальным раком во всех возрастных группах неуклонно увеличивается, особенно в экономически развитых государствах. В Актюбинской области заболеваемость колоректальным раком не возрастает, но при этом количество запущенных случаев и смертность остается высокой. В связи, с чем возникает необходимость выполнения расширенных и расширенно-комбинированных операций, при этом приходится резецировать несколько сегментов как тонкой, так и ободочной кишки, соседних органов и структур, после которых увеличивается число послеоперационных осложнений, которое по литературным данным составляет 11,3-65,6 %, операции часто заканчиваются наложением колостомы, что приводит к ухудшению качества жизни больных.

Материалы исследования. В медицинском центре ЗКГМУ им.Марата Оспанова с 2001 по 2007 гг. 29 пациентам выполнены расширенные и расширенно-комбинированные операции при колоректальном раке с первичным восстановлением кишечной трубки. Показаниями к выполнению подобных операций явились: инвазия опухоли и ее метастазов в смежные органы и системы; первично-множественный рак ободочной кишки, с локализацией в других органах ЖКТ и органов брюшной полости; метастазы колоректального рака в печень.

Результаты. После проведенных операции отмечались следующие виды осложнения: нагноение послеоперационной раны – 3 (10,3 %), послеоперационный тотальный панкреонекроз – 1 (3,4 %), нижнедолевая пневмония слева – 1 (3,4 %), длительное желчеотделение – 1 (3,4 %). В послеоперационном периоде умер 1 больной (3,4 %), причиной которого явился панкреонекроз.

Выводы. Таким образом, тщательная предоперационная подготовка, правильный, дифференцированный подход к проведению подобного рода объемам операции позволяет снизить число стомированных больных и улучшить качество их жизни.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА.

*Букенов А.М., Рахманова Б. А., Мадыкенов Р. О.
Кафедра онкологии, лучевой терапии с курсами общей хирургии, травматологии и ортопедии ФНПР КГМУ.
Карагандинский областной онкодиспансер.*

Причины возникновения несостоятельности швов пищевода различны. Одни [Бондарь Г.В., Байдалин Ю.Д., 1971] хирурги считают основной причиной чрезмерную мобилизацию пищевода, другие [Ганул Л.В., Шевчук А.С., 1979] – снижение репаративной способности ткани пищевода, в связи с гнилостными процессами, развивающимися в пищеводе выше места обтурации. Не менее важным

считают уровень резекции пищевода [Кулаевская В.Г., 1980, Странадо Е.Ф., 1980], резекция пищевода на расстоянии близком к опухоли может привести к несостоятельности швов пищеводного соустья.

По мнению Русанова А. А. [1973] главной причиной возникновения несостоятельности пищеводного анастомоза являются технические погрешности, допущенные при формировании анастомоза, т.е. недостаточная квалификация хирурга. Поэтому изучение частоты несостоятельности швов пищеводного соустья в зависимости от способа наложения анастомоза является одной из актуальных задач клинической онкологии.

Цель исследования – уменьшить частоту несостоятельности швов пищеводного соустья при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы.

Анализируются истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990-2004гг. Послеоперационная летальность на 287 операций составила $17,1 \pm 2,2\%$ (умерло 49).

Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищеводного соустья $44,8 \pm 5,6\%$ (35 из 287 операций) среди всех осложнений. Летальность при чресплевральном и чрезбрюшинном доступе составила соответственно $23,5 \pm 3,6\%$ (32 из 136 операций) и $11,3 \pm 2,6\%$ (17 на 151 операцию), статистически разница существенна ($p < 0,05$).

Обсуждение результатов.

Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищеводного соустья значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова - Юдина – $13,3 \pm 6,0\%$ (умерло 6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича - Грэхема – $27,3 \pm 7,7\%$ (умерло 9), разница статистически существенна ($p < 0,05$). Значительного снижения летальности не было отмечено при использовании инвагинационного анастомоза с расширяющим швом Блохина, которая составила $24,4 \pm 6,4\%$, разница статистически не достоверна ($p > 0,05$) по сравнению с выше названными способами (из-за небольшого количества наблюдений). Нами разработан способ формирования погружного пищеводного соустья (авт. свидетельство № 45123, авторы Нам Э. Н., Букенов А. М.). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищеводного соустья сведена до минимума за счет внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г. В. Бондарю отмечено в $5,6 \pm 2,4\%$ (5 осложнений на 90 операций) случаев несостоятельности пищеводного соустья, а среди всех осложнений она составила $33,3 \pm 12,6\%$ (5 случаев на 15 осложнений). Из пяти больных с несостоятельностью пищеводного соустья при муфтообразном анастомозе погибли $3,3 \pm 1,9\%$ (умерло 3) пациента.

Сравнительный анализ частоты несостоятельности пищевода и ее летальности убеждает нас в правомерности выбора погружного анастомоза при хирургическом лечении рака желудка.

ВЫБОР ОБЪЕМА ЛИМФОДИСЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Джураев М.Д., Эшонов А.К.

Онкологический научный центр Узбекистана

Цель исследования: Улучшить результаты хирургического лечения рака желудка путем оптимизации объема лимфодиссекции.

Материалы и методы: Исследования проводились у 82 больных раком желудка в стадии Т3-4N3M0. В зависимости от объема лимфодиссекции больные распределены на 2

группы:

1. Стандартная радикальная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме Д2, $n=50$ больных.
2. Расширенно-радикальная гастрэктомия в объеме Д3, $n=32$ больных.

Поражение № 3 группы лимфоузлов во всех случаях подтверждено гистологически. В данную группу исследования включены больные только с гистологически верифицированным поражением № 3 группы лимфоузлов. В1 группе больных после СРГ с лимфодиссекцией в объеме Д2, с учетом, что имеется поражение № 3 группы лимфоузлов, проводилось 2 курса эндоартериальной химиотерапии препаратом Фторурацил ОД 5 гр, Цисплатин 100 мг в течение 120 часов непрерывно на фоне системного введения 150 мг Лейковорина. Во 2 группе после РРГ предусматривающей лимфодиссекцию в объеме Д3 при той же схеме химиотерапии, проводилось 2 курса системно. Так как на наш взгляд именно установление эндоваскулярного катетера в просвет аорты на уровне диафрагмы и капельное введение препарата равномерно обеспечивает распределение химиопрепаратов по висцеральным ветвям брюшной аорты.

Результаты: Послеоперационные осложнения в 1 группе составили 18%, умерли 2 больных от тромбоэмболии легочной артерии и другой от острого инфаркта миокарда. Послеоперационная летальность составила 4%. Во 2 группе общие осложнения составили 25%. Среди них превалировал послеоперационный панкреатит. Умер 1 больной от несостоятельности эзофагоэнтоанастомоза. Послеоперационная летальность составила 3,1% ($P1-2 > 0,05$). Осложнения, связанные с введением химиопрепаратов и от методов лечения в обеих группах не наблюдались. Одногодичная выживаемость составила 88% в 1 группе и 84,9% во 2 группе. Трехлетняя выживаемость соответственно 64% и 62,5%. Пятилетняя 28% и 27,2% соответственно. Медиана выживаемости в обеих группах оказалась практически одинаковой $36,2 \pm 0,4$ и $35,4 \pm 0,3$ ($P > 0,05$).

Вывод: При поражении № 3 группы лимфоузлов применение радикально расширенной гастрэктомии с лимфодиссекцией в объеме Д2 с последующим проведением 2 курса эндоартериальной химиотерапии является альтернативным методом, так как отдаленные результаты метода достоверно не отличаются от результатов РРГ.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Джураев М.Д., Худояров С.С., Эгамбердиев Д.М.

Онкологический научный центр Узбекистана, г.Ташкент

Цель исследования: Предотвратить возможные функциональные осложнения, путем создания желудка заменяющего резервуара.

Материалы и методы: В отделении абдоминальной хирургии в период 2004-2007 г.г. 25 пациентам раком желудка в стадии Т3N1-2M0 произведена расширенная гастрэктомия в объеме Д2 с созданием желудка заменяющего резервуара. Для сравнительного исследования в контрольной группе 30 пациентам произведена расширенная гастрэктомия без формирования резервуара. Больные были в возрасте от 13 до 60 лет. Гистологически у 44 (80,0%) пациентов выявлена аденокарцинома и 11 (20,0%) пациентов другие разновидности. Резервуар формировался из петель тонкого кишечника отступая 10 см от Трейцевой связки и включал в себя последовательное выполнение 4 анастомозов: эзофагорезервуар анастомоз, дуоденоэнто анастомоз конец в конец, энтеро-энтеро анастомоз бок в бок длиной до 18 см и энтеро-энтеро анастомоз конец в бок. Сравнительные исследования проводили в течение 6 месяцев по следующим критериям: 1)

Рефлюкс эзофагит; 2) Демпинг синдром; 3) Дискомфортное состояние после еды.

Результаты: В основной группе из 25 пациентов слабо выраженный рефлюкс эзофагит наблюдался у 2 (8,0%) пациентов спустя 1,5 месяца после операции, который быстро ликвидировали после консервативной терапии. В контрольной группе этот вид осложнения развился у 18 (60,0%) пациентов, из них слабо выраженный у 4 (13,3%) пациентов, умеренный у 5 (16,6%) и у 9 (30,0%) пациентов сильно выраженный рефлюкс эзофагит. Частота встречаемости демпинг синдрома в основной группе составила 0%, а в контрольной группе у 30,0% пациентов. Дискомфортное состояние после еды в основной группе не наблюдалось ни у кого, в то время в контрольной группе пациентов составила 49,9% пациентов.

Вывод: Формирование резервуара после расширенной гастрэктомии является оригинальным хирургическим способом, предотвращающим возможные функциональные осложнения.

РОЛЬ *HELICOBACTERI PYLORI* В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Джураев Ф.М.

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент

Актуальность проблемы: *Helicobacteri pylori* в 1994 г. официально признан канцерогенным агентом номер один. Частота инфицирования в развитых странах не превышает 15%, в то время в менее развитых странах до 100%. В тех популяциях, где снизилась зараженность *Helicobacteri pylori*, так же снизился показатель заболеваемости раком желудка.

Цель: Изучение роли *Helicobacteri pylori* в возникновении рака желудка у коренных жителей республики.

Материалы и методы: С этой целью проведено эндоскопическое исследование желудка у 540 больных при неонкологической патологии и у 360 больных раком желудка, у лиц узбекской популяции, с биопсией из 6 точек пилорического канала. В основной группе диагноз рак желудка установлен на основании комплексных данных. По локализации опухоль тела и антрального отдела желудка у 101 (28,1%) и опухоль антрального отдела у 259 (71,9%) больных. Высокодифференцированная аденокарцинома – 136 (37,7%), умереннодифференцированная аденокарцинома – 98 (27,2%), низкодифференцированная аденокарцинома – 126 (35,0%). Исследование *Helicobacteri pylori* проводилось морфологическим и бактериологическим методом.

Результаты: При эндоскопическом исследовании 540 больных выявлено наличие *Helicobacteri pylori* у 379 больных, инфицированность составила 70,2%. Из пациентов у которых выявлено присутствие бактерий обнаружен выраженный атрофический гастрит у 115 (30,3%), гиператрофический гастрит у 102 (26,9%), язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки у 22 (5,8%), выраженный гастродуоденит у 112 (29,5%) и без изменений у 19 (5,1%). Исследование показало, что из 360 больных, которым производили оперативное вмешательство у 270 больных выявлено наличие *Helicobacteri pylori*, у 90 (25,0%) больных *Helicobacteri pylori* не выявлено. Инфицирование составило 75,0%. Хотя во многих исследованиях *Helicobacteri pylori* является канцерогенным агентом номер один, но в наших наблюдениях несмотря на то, что у лиц узбекской популяции составляет 75,0%, встречаемость рака антрального отдела от общего числа составляет не более 12,1%.

Вывод: Исходя из вышеизложенного, вопрос является ли *Helicobacteri pylori* канцерогеном номер один для лиц узбекской популяции вызывает большое сомнение. Мы думаем, что данный вопрос с учетом обычаев, быта и менталитета требует более углубленного изучения.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сейсембаев М.А., Баймаханов Б.Б., Рамазанов М.Е., Наржанов Б.А., Сахипов М.М., Токсанбаев Д.С., Ибекенов О.Т., Исбамбетов А.С.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова

Актуальность: Опухоли проксимальных желчных протоков (ПЖП) остается актуальной проблемой клинической онкологии и составляет 10,5-26,5% от всех злокачественных поражений желчных протоков. Эффективность дооперационной диагностики опухолей печени колеблется от 3 до 97%. Без хирургического лечения большинство больных умирают в течение 4-6 месяцев после установления диагноза.

Цель: Улучшить диагностику и результаты хирургического лечения больных с опухолями ПЖП.

Материал и методы: Анализ подвергнуты результаты хирургического лечения 39 больных с опухолями ПЖП в возрасте от 21 до 76 лет. Преобладали пациенты старше 45 лет (74,3%), чаще мужчины (69,2%). Диагноз опухолевого поражения ПЖП устанавливали на основании комплексного клинического, лабораторного и инструментального исследований.

Клиническим проявлением заболевания явилась желтуха (100%), кожный зуд (84,6%), холангит (43,5%), боли в подреберье (30,7%), потеря в весе (61,5%). По классификации Bismuth-Corlette; тип I наблюдался у 6(15,4%), тип II - у 7(17,9%), тип IIIa – у 5(12,8%), тип IIIb у 11(28,2%) и тип IV - у 10(25,7%) больных. С диагностической целью и последующей декомпрессией билиарного тракта перед возможной радикальной операцией в 19(59,4%) случаях произвели ЧЧХГ и ЧЧХС.

Результаты: Радикальные оперативные вмешательства с лимфаденэктомией выполнены 17(43,6%). В 13 случаях была произведена резекция гепатикохоледоха, в 4 случаях резекция гепатикохоледоха сочеталась с резекцией печени: 3 правостороннюю, 1 левостороннюю гемигепатэктомию с резекцией воротной вены и I сегмента печени. В 6 наблюдениях в анастомоз были включены от 3 до 5 сегментарных протоков.

Паллиативные операции выполнены 22(56,4%); реканализация и наружное дренирование-4, резекция опухоли с билиодигестивным анастомозом-12, при неоперабельных опухолях выполнена холангиостомия-6 больным. При этом летальность отмечено в 3-х случаях.

Выводы: Современные методы исследования как, УЗИ, МРХПГ и КТ, а также прямое контрастирование желчных протоков: ЧЧХГ и ЭРХПГ, и высокое качество обследования больных позволяют выработать рациональную лечебную тактику. Выполнение двухэтапных операции с предварительной декомпрессией желчных протоков, снизит риск операции и количество возможных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПАДАЮЩЕГОСЯ И ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мадалиходжаев Р.С., Сыздыков К.З., Сарсенбаев А.У
ООД, МКТУ, г.Шымкент

Актуальность. Особенности развития и течения отечно-инфильтративного и распадающегося рака молочной железы (РМЖ) нередко делают хирургическое лечение весьма проблематичным. Цель работы. Повысить качество хирургического лечения распадающегося и отечно-инфильтративного РМЖ с использованием местных тканей. Материал и методы. При распадающемся РМЖ с одной стороны происходит нарастание раковой (эндогенной интоксикации), а с другой-

кровотечение из опухоли. И поэтому обычно производится гигиеническая мастэктомия без санации лимфатического коллектора регионарных областей. Инфильтративная форма РМЖ подразделяется на: первичную и вторичную. 1- характеризуется инфильтрацией молочной железы (раковые эмболы), но без наличия первичной, четко определяемой опухоли. При этом, кожа железы отечна, уплотнена и имеет вид «лимонной корки». В ряде случаев клиническая картина может напоминать мастит или рожистое воспаление. Во втором случае, отек железы чаще связан с нарушением транскапиллярной диффузии жидкости из-за фактора повышенной чувствительности тканей окружающих первичную опухоль непосредственно к самой опухоли и продуктам ее жизнедеятельности. А при имбиции капиллярной сети и лимфатических узлов раковыми клетками наступает блокировка лимфатической сети, что в свою очередь также усугубляет отечно-инфильтративный процесс и не дает возможности четко определить границу здоровой и пораженной зоны, а следовательно линия разреза заведомо окажется нерадикальной. Лечение в таких случаях -исключительно консервативное. Однако, в настоящее время, возможности комбинированной терапии с использованием высокоэффективных химиопрепаратов могут оказаться столь значимыми, что зона явного злокачественного процесса четко отграничивается, и как следствие, разрез можно производить радикально т.е. в пределах здоровой ткани. Исходя из этого, нами была разработана модификация радикальных операций, которые отличаются тем, что мы проводим расширенную радикальную мастэктомию с сохранением и большой и малой грудных мышц. Окаймляющий молочную железу разрез обязательно проводится электроножом отступая не менее 3 – 5 см от реально видимой или предполагаемой демаркационной линии. Производится сепаровка кожных лоскутов с удалением подключично-подмышечной и подлопаточной клетчатки. После операции образуется очень большой дефект кожи, который закрыть полностью остается проблематичным при каждой подобной операции. В нашем случае, для закрытия дефекта мы продолжаем увеличивать сепаровку кожных лоскутов и прошиваем их наводящими «толстыми» шелковыми лигатурами и определяем величину оставшегося кожного дефекта. Для покрытия оставшегося тканевого дефекта мы формируем трапецевидно образный кожно-подкожный лоскут из латеральной части грудной клетки, который формируется путем проведения продольных разрезов из углов раны в латеральном или латерально-верхнем направлении. После этого, подтягиваем образовавшийся трапецевидный лоскут к верхнему краю раны и накладываем обычные лигатуры с одновременным удалением наводящих лигатур. Результаты. По нашей методике пролечено 28 больных раком молочной железы. Из них: 9 с отечно-инфильтративной формой и 19 с распадающимся раком молочной железы. Заживление послеоперационной раны было в среднем за 15, 8 дней. Из осложнений- поверхностный ограниченный некроз медиального конца кожного лоскута был отмечен в 14,3%. Других осложнений не наблюдалось. Выводы. Предлагаемый нами модифицированный метод радикальной по объему операции может быть методом выбора при лечении инфильтративных и распадающихся формах рака молочной железы.

МЯГКОТКАННЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНО- ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Сыздыков К.З., Мадалиходжаев Р.С., Джумагалиев Д.Ж.
Областной онкологический диспансер, МКТУ, г. Шымкент*

Актуальность. В мире и в Республике Казахстан заболеваемость Раком Молочной Железы (РМЖ) продолжает увеличиваться и составила 19,5. В структуре заболеваемости женского населения Казахстана РМЖ занимает доминирующее место. При этом, в Южно-Казахстанской Области (ЮКО)

в 2004 году РМЖ занимал второе, а за первое полугодие 2005 года, в 2009 году и в первом квартале 2010 года продолжает занимать первое место.

Наряду с этим, часть больных поступает в клинику с самой тяжелой формой РМЖ, это инфильтративной формой болезни когда хирургическое лечение всегда сопряжено с большими трудностями, а зачастую просто не показано.

Цель работы. Усовершенствовать оперативные подходы для улучшения качества жизни больных при инфильтративном РМЖ путем выкраивания кожного лоскута и ротация его на питающей ножке.

Материалы и методы. При инфильтративной форме, как правило, первичная опухоль не имеет четкого определения. При этом, кожа молочной железы резко отечна, уплотнена и чаще представлена в виде «лимонной корки». В других случаях имеет место мастит подобная или рожисто подобная форма. Наличие выраженного отека молочной железы не дает возможности четко определить границу здоровой и пораженной зоны, а это означает, что линия разреза заведомо окажется нерадикальной. Лечение в таких случаях -исключительно консервативное. Однако, в настоящее время, с появлением высокоэффективных лекарственных препаратов комбинированное лечение оказывается столь существенным, что при лечении отечно-инфильтративного РМЖ нередко на границе злокачественного процесса и здоровой ткани четко обозначается демаркационная линия. А это позволяет правильно выбрать линию радикального разреза. Разработанная нами модифицированная операция выполнена 26 больным с T4N0M0 стадией после 4-6 курсов неоадьювантной полихимиотерапии на фоне антиэстрогенного гормонотерапии и отличается от традиционных операций тем, что окаймляющий молочную железу разрез в обязательном порядке проводится электроножом отступая на 3 – 5 см от реально видимой *ad oculum* или предполагаемой демаркационной линии. После этого, производится сепаровка кожных лоскутов с удалением подключично-подмышечной и подлопаточной клетчатки. В итоге, образуется очень большой кожный дефект для покрытия которого из кожи дорзальной части грудной клетки выкраивается лоскут на питательной ножке. После вентральной ротации лоскута производится ушивание операционной раны.

Результаты. Исследования в течение 2 лет показали, что сразу же после операции и на протяжении всего времени наблюдения психо-эмоциональный статус всегда находился на достаточно высоком уровне. При этом, умерло 11,5% больных или 3 человека. Рецидивы возникли у 13 больных или в 50,0%. Время заживления раны составил 15 – 18 дней, при этом поверхностный ограниченный некроз краев кожи отмечен в 38,5% или у 10 больных. Других осложнений не было.

Выводы. Предлагаемый нами метод расширенной операции с использованием вентральной ротации кожно-мышечного лоскута может быть методом выбора при лечении отечно-инфильтративных форм РМЖ, что несомненно улучшит качество жизни.

БРОНХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

*Енин Е.А., Адильгиреева Л.Х., Пюрова Л.П.,
Елеубаева Ж.Б., Решетина Н.В.*

*Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А.Н.Сызганова.*

Научно-практические публикации по вопросам онкологии в торакальной хирургии свидетельствуют о неуклонном росте показателей заболеваемости раком легкого во всех странах мира.

Целью: исследования было установление клинко-анатомической формы процесса, морфологическая вери-

фикация диагноза с установлением структуры опухоли и степени анаплазии.

Материалом: для исследования послужили 2799 (28%) больных, у которых эндоскопически был установлен или подтвержден диагноз новообразования легких и у 62 (0,6%) больных, оперированных по поводу опухолевого процесса, не верифицированного эндоскопически. Взятый материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). В проводке кусочки заливались в парафин. Готовые парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрон. Готовые стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция. Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином (С. Humphrey, F. Pittman, 1974). Препараты просматривались на световом микроскопе «Leica» DMLS 4000B с цифровой камерой Leica DFC 320 (Германия).

Результаты: центральная локализация опухоли была у 1715 (61,2%) больных, периферическая у 853 (30,5%), диффузный милиарный канцероматоз у 231 (8,3%). Соотношение центрального и периферического рака легкого у мужчин и женщин было 7:1. По данным гистологического и цитологического исследования прямой биопсии бронхов выявлены: аденокарцинома (3%), плоскоклеточный рак (22%), мелкоклеточный рак (11%), низкодифференцированный рак (4%), недифференцированный рак (5%), раковый лимфангоит (18%), различные элементы воспалительных деструктивных изменений (27%), безрезультативный материал (некротическая ткань, обрывки ткани, материал растворился) составил 10%. Наиболее трудной задачей в диагностическом плане представляли периферические округлые новообразования в легком. Бронхофиброскопия проведена 182 больным с подобной рентгенологической картиной. При этом предварительный диагноз рака легкого был установлен у 36 больных, из них у 2 больных обнаружена центральная локализация процесса (видимая в бронхах). У 24 больных с помощью гистологического исследования биоптата из периферической опухоли диагноз рака подтвержден, у 2 больных на операции обнаружено нагноительное заболевание, у 4 выявлен рак плевры, у 4 опухоль средостения.

Трансбронхиальная биопсия легкого у этой категории больных установила рак легкого в 123 случаях: плоскоклеточный рак – 11, недифференцированный рак – 13, раковый лимфангоит – 99. На операции рак легкого подтвержден только в 75 случаях, у других оказались заболевания хронического неспецифического нагноительного процесса.

У 62 больных, поступивших с предварительным диагнозом различных нагноительных заболеваний и кист легких, на операции центральный рак обнаружен в 3 случаях, периферический рак в 59 случаях (эндоскопически не установленный).

При исследовании операционного материала у 134 больных с периферической локализацией онкологического процесса, аденокарцинома получена в 13 случаях, плоскоклеточный рак в 26 случаях, мелкоклеточный рак в 14, низкодифференцированный рак в 16, недифференцированный рак в 24 случаях, смешанный рак в 41 случае.

Выводы: полученные данные морфологической верификации неопластических процессов в легких в дооперационном периоде на начальных этапах развития заболевания диктуют необходимость разработки и усовершенствования способов эндоскопической диагностики в условиях современного процесса техники и медицины.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии, г.Алматы

Актуальность. В республике Казахстан ежегодно регистрируется около 50 первичных случаев заболевания опухолей головного мозга (ОГМ) у детей, что составляет 18-25% среди всех солидных новообразований. Злокачественные глиомы (ЗГ) – составляют от 7 до 11% среди всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей. Отмечается рост заболеваемости с опухолями ЦНС у детей. Так в 2000 году заболеваемость с ОГМ составила 18,2%, в 2006 году – 24,8% и в 2009 году – 20,2%. Общепринятым лечением ЗГ является максимальное удаление опухоли, проведение постоперационной лучевой терапии (ЛТ) и применение различных схем химиотерапии.

Цель: изучение эффективности Темодала в лечении ЗГ головного мозга у детей.

Объект и методы исследования: в исследование были включены 31 детей с ЗГМ в возрасте от 3 до 17 лет, мальчики – 18 (58,1%), девочки – 13 (41,9%). Объем хирургических вмешательств: 8 больным «тотальное», 19 пациентам субтотальное удаление опухоли и 4 – биопсия опухоли. Гистологическая структура опухоли: анапластическая астроцитомы – 20, глиобластома – 11 больных. До начала терапии качества жизни больных по шкале Карновского от 30 до 60%. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии, а так же после завершения лечения в сроки 6, 12 и 18, 24, 30 мес. проводилась МРТ головного мозга с контрастным усилением (КУ). При оценке ответа на терапию использовали стандартные критерии: CR – полное отсутствие опухоли, PR – уменьшение размера опухоли более 50%, SD – уменьшение размера опухоли менее 50%, PD – увеличение размеров опухоли более 25% или появление новых очагов. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии выполнялись клинический, неврологический и офтальмологический осмотры.

Лечение: Операция → ЛТ + ХТ (темозоломид + ломустин = 1 цикл) → 6 циклов ПХТ (темозоломид + ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе, на 14-21 дни после операции, до СД= 50- 55 Гр., РД= 1,8 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился цикл ХТ: темозоломид – 150 мг/м² – 1-5 дни; Ломустин – 120 мг/м² – 1 день + гормональная терапия. В дальнейшем 6 циклов ХТ по выше указанной схеме с интервалами в 6 нед. + сопроводительная терапия.

Результаты: У 2 (6,5%) пациентов с МГБ в процессе ХЛЛ отмечены ухудшение состояния и были исключены из исследования. В процессе и после завершения ХЛЛ этапа терапии у 29 (93,5%) больных значительно купированы патологические неврологические симптомы, отмечены улучшения качества жизни: по шкале Карновского: 50-100%. Общие токсические проявления отмечены в основном II-III ст., и на фоне сопроводительной терапии были легко купируемые. Гематологическая токсичность: лейкопения II-III ст. наблюдалась у 12 (38,7%) больных, тромбоцитопения II степени – у 8 (25,8%) пациентов, в основном после первого этапа терапии. Признаков органной и кумулятивной токсичности не наблюдалось. 26 больным проведены и завершены все этапы терапии. По данным контрольного МРТ головного мозга с КУ, после ХЛЛ у 3 (10,3%) больных отмечены увеличение размеров опухоли, а у 26 детей (89,6%) достигнуто объективный ответ: CR- 7 (24,1%), PR- 14 (48,3%) SD- 5 (17,3%). В процессе цикловой ХТ 3 больных из-за прогрессирования заболевания переведены

на симптоматическую терапию. После завершения протокола лечения по данным контрольного МРТ головного мозга с КУ у 7 (26,9%) пациентов достигнута – CR, PR- у 9 (34,6%) SD - у 6 (23,1%) и у 4 (15,4%) больных - CR. Одногодичная выживаемость составила 83,9±6,6%, безрецидивная – 71±8,3%. 3-летняя выживаемость составила 57,7±9,9%, безрецидивная – 46,2±9,9%. 5-летняя выживаемость – 42,3±9,9%, безрецидивная – 34,6±9,5%.

Выводы: Применение темодала и ломустина на фоне и после ЛТ в лечении ЗГГМ у детей показало удовлетворительную эффективность без выраженных токсических симптомов и достигнуто улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения.

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ.

Ижанов М.Т. Жетибаева Г.К.

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) одна из наиболее распространенных форм злокачественных опухолей у женщин во всем мире. За последние 30 лет заболеваемость РМЖ возросла в 2,8 раза и имеет постоянную тенденцию к увеличению, но не смотря на это благодаря определенному улучшению ранней диагностики заболевания и клинических исследований проведение органосохраняющих операций при раке молочной железы на сегодняшний день становится все более популярным. Размер первичной опухоли один из сильных факторов прогноза течения рака молочной железы. Увеличение размера первичной опухоли прямо коррелирует с поражением регионарных лимфатических узлов, и тем самым влияет на снижение общей и безрецидивной выживаемости. Минимальный рак (опухоль менее 1 см в диаметре) характеризуется благоприятным течением после органосохраняющих операций. При размере опухоли до 1 см 20-летняя выживаемость достигает 90%, а риск развития рецидива не превышает 10%. При опухолях от 1 см до 2 см имеется уже 25% риск развития рецидива, а при T2N0M0 подобный риск достигает 30-35%. Наличие метастазов в лимфатических узлах, степень злокачественности, мультицентричность и мультифокальность опухоли «позитивные» хирургические края все это говорит об актуальности исследований, касающихся органосохраняющего лечения РМЖ и его прогноза.

Цель исследования: изучить факторы риска возникновения рецидивов при раке молочной железы после проведения органосохраняющих операций.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 95 женщин с T1-2N0-1M0 стадией РМЖ. Из них с 1 стадией заболевания было 32 (33,6%), со 2 стадией 63 (66,3%) пациенток. Возраст больных колебался в пределах 35-70 лет. Из них в возрасте 35-39 лет 11 (11,5 %) больных, 40-49 лет 32 (33,6%) пациенток, 50-59 лет - 38 (40%) больных, более 60 лет - 9 (9,4%) больных. Средний возраст больных - 49,5 года. Заболевание левой молочной железы наблюдалось у 52 (54,7%) больных, правой молочной железы - у 43 (45,2%) пациенток. Следует отметить, что у 73 (76,8%) больных опухоль локализовалась в верхне-наружных квадрантах молочной железы, у 22 (23,1%) больных в других квадрантах.

Результаты. Размер опухоли, - это один из наиболее весомых факторов при выполнении органосохраняющих операций. При размере опухоли от 0,5 до 2,0 см частота развития рецидивов не превышала 12%, тогда как при размере опухоли более 2,0 см этот показатель достигал 19,8%. Следует отметить, что при длительном наблюдении (5-10 лет) за больными, подвергшимися органосохраняющему

лечению, отмечается снижение показателей выживаемости по мере увеличения размера опухоли. В группах больных с pN0 и pN1 абсолютное отличие в 5-летней выживаемости равнялось 22% (89% против 67%).

Различия в выживаемости прослеживались и в общей 5-летней выживаемости. Для G1, G2, G3, 5-летняя общая выживаемость равнялась 91%, 83%, 78%.

Выводы. Таким образом размер опухоли больше 2 см, высокая степень гистологической злокачественности, пораженные метастазами лимфатические узлы, мультицентричность, «позитивные» края опухоли увеличивают риск развития местно-регионарных рецидивов на 10-15% после органосохраняющих операций рака молочной железы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ РАННИХ, МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ижанов М.Т., Сарсембаев А.А.,

Игликов М.К., Бимаганбетова Н.Б.

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер г. Шымкент

Актуальность. Рак молочной железы наиболее частая форма рака у женщин, и в ближайшие 10 лет ожидается, что этим заболеванием будут страдать около 5 млн. женщин в мире. (В.И. Тарутинов 2003г.) В Республике Казахстан это форма опухоли находится на первом месте в структуре заболеваемости у женщин (19,1%), а частота ее неизменно растет.

Цель работы: на основе изучения отдаленных результатов лечения рака молочной железы в зависимости от стадии предложить в практику наиболее эффективные методы лечебных воздействий.

Материалы и методы исследования: нами ретроспективно прослежена пятилетняя выживаемость 1047 больных раком молочной железы, леченных чисто операцией (425) больных, комбинированное лечение (38) больных, комплексное лечение (584) больных.

Хирургическое лечение было в различных вариантах: радикальная резекция по Блохину, радикальная мастэктомия по Маддену, до радикальной мастэктомии по Холстеду.

Результаты: На эффективность методов проведенного лечения при раке

молочной железы оказывали следующие факторы:

Размеры опухоли и ее взаимоотношение с окружающими тканями молочной железы.

Морфология и степень злокачественности опухоли.

Возраст и состояние иммунитета организма больных.

Чувствительность опухоли к лучевой терапии, а также к химио- и гормонотерапии.

Выводы: При раннем раке (T1N0M0) на сегодняшний день эффективным способом лечения является хирургический метод лечения. (Широкая секторальная резекция с лимфодиссекцией подмышечных лимфоузлов на стороне поражения) При этом пятилетняя выживаемость составила (90%). При (T1a-T1b) лечебный эффект достигнуто от комплексной терапии (РМЭ + химиотерапия + лучевая терапия). Более 5-ти лет живут (75-80% при T1a ст. и 70-75% при T1b ст.). При T1c-T1V ст. провели (НАПХТ 4-6 курсов в комбинации с лучевой и гормонотерапией + РМЭ по Холстеду) Пятилетняя выживаемость составила (58-65%).

Усовершенствование схем применения новых химиопрепаратов с учетом биоритма и гормонального статуса организма, а также включение в эту схему лечения радикальных операций в сравнительном аспекте дает хорошие отдаленные результаты.

ОРГАНОСОХРАННЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ВЕК.

Исламов З.С., Султанова Ш.Ш.
РОНЦ МЗ РУ, г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы: разработка новых методов реконструктивно-пластических операций при раке кожи века.

Материалы и методы: в онкоофтальмологическом отделении проведено 32 реконструктивно— пластических операций у больных с раком кожи век 3-4ст. Возраст больных варьировал от 52 до 78 лет. Мужчин было 18 (56%), женщин 14 (44%). У 13 больных (40,6%) был плоскоклеточный рак, у 19 (59,4%) — базальноклеточный рак. У 8 больных (25%) опухоль была коже верхнего века, 10 больных (31%) — нижнего века, 14 больных (44%) нижнего века с распространением на интермаргинальный край. После удаления опухоли век, для закрытия дефекта нами разработаны реконструктивно-пластические операции на сосудистой ножке, с выкраиванием лоскута с верхнего или нижнего века, височной области, внутреннего угла глаза. При распространении опухолевого процесса на интермаргинальный край используются операции с иссечением опухоли и пластикой местными тканями с области щеки.

Результаты: у всех больных пересаженный лоскут прижился первичным натяжением, грубых рубцов не отмечалось, косметических дефектов век не наблюдалось. Срок наблюдения от 1 до 2 лет.

Рецидивы не отмечались. Из осложнений — у 2 больных отмечался вторичный конъюнктивит. Им была назначена противовоспалительная терапия.

Выводы: внедрение в практику офтальмологии новых реконструктивно-пластических операций позволяет избежать грубых рубцов, косметических дефектов лица, а также улучшить качество жизни больных с этой патологией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ РЕКТО-АБДОМИНАЛЬНОГО ЛОСКУТА ПРИ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Ванесян А.С.
Кафедра онкологии и хирургии Казанской
государственной медицинской академии, Казань

Актуальность: При локализации рака в центральных или медиальных квадрантах молочной железы, помимо аксиллярного пути метастазирования, также возрастает роль парастерального коллектора. Поэтому, кроме радикальной операции по показаниям, необходимо также выполнить видеоторакоскопическую парастеральную лимфодиссекцию.

Цель: В данной работе рассматриваются недостатки сочетания радикальных операций на молочной железе с локализацией опухоли в центральной и медиальной зонах, с видеоторакоскопической парастеральной лимфодиссекцией и с различными способами одномоментных реконструктивно-пластических операций и пути их преодоления.

Материалы и методы: С 1996 - 2010гг. в отделении маммологии КОД МЗ РТ выполнено 515 реконструктивно-пластических операций по поводу РМЖ, из которых 459 были одномоментные реконструкции. Были выделены две группы пациентов, в первую из которых были включены больные, которым были выполнены одномоментные реконструкции в сочетании с парастеральной лимфодиссекцией (173), во вторую группу были включены больные с одномоментной реконструкцией без парастеральной лимфодиссекции (286).

Результаты и обсуждение: При анализе ранних послеоперационных осложнений достоверная разница ($p < 0.005$) была обнаружена только при сравнении групп с пластикой

лоскутом- TRAM и парастеральной лимфодиссекцией и без парастеральной лимфодиссекции. В первой группе больше количество послеоперационных осложнений (33,1% по сравнению с 28,2% в группе без парастеральной лимфодиссекции), в основном за счет наличия краевых некрозов (17,9% по сравнению с 10,4% в группе без парастеральной лимфодиссекции), что связано с невозможностью забора лоскута на обеих прямых мышцах живота при больших объемах переносимых тканей. Выходом из создавшегося ситуации является дополнительная васкуляризация лоскута-TRAM.

Выводы: Невозможность использования ипсилатеральной прямой мышцы живота при сочетании видеоторакоскопической парастеральной лимфодиссекции с одномоментной реконструкцией лоскутом TRAM решается за счет дополнительной васкуляризации контралатеральной мышцы путем наложения микрососудистого анастомоза между нижними надчревными и внутренними грудными сосудами (с видеоторакоскопической мобилизацией последних).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Ванесян А.С.
Кафедра онкологии и хирургии Казанской
государственной медицинской академии, Казань

Актуальность: Реконструкция молочной железы играет важную роль в физическом, эмоциональном и психологическом восстановлении женщин с раком молочной железы после перенесенной радикальной операции.

Цель: Целью данного исследования являлось изучение влияния одномоментных реконструктивных операций на качество жизни пациентов с раком молочной железы при помощи опросника MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey).

Материалы и методы: На вопросы опросника SF-36 самостоятельно ответили 36 пациента, 20 из которых была выполнена немедленная реконструкция молочной железы в сочетании с мастэктомией (средний возраст 42; границы 30-63), а 16 пациентам была выполнена только мастэктомия без реконструкции (средний возраст 55; границы 39-70).

Результаты: По результатам опроса выявлено, что по параметрам физическое функционирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), интенсивность боли (BP), общее состояние здоровья (GH), жизненная активность (VT) и психическое здоровье (MH) у больных с реконструкцией показатели намного выше, чем у больных без реконструкции ($p < 0,05$). Наиболее значимая разница наблюдалась по параметрам ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), среднее значение в группе с пластикой превосходит среднее значение в группе без пластики на 38,9%, а также по показателям физическое функционирование и интенсивность боли (37,7% и 34,6% соответственно). По показателям социальное функционирование и ролевое функционирование, обусловленное физическим здоровьем статистически значимой разницы между группами не выявлено ($p > 0,05$).

Заключение: Одномоментная реконструкция молочной железы у больных раком молочной железы улучшает физическое и ролевое-эмоциональное функционирование пациентов, общее состояние здоровья и психическое здоровье. Благодаря реконструктивным операциям увеличивается жизнеспособность пациентов и они чувствуют боль менее интенсивно, чем пациенты, которым была выполнена мастэктомия.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНО ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Овчинникова И.В., Ванесян А.С.

Республиканский клинический онкологический диспансер, г. Казань

Введение: В подавляющем большинстве случаев неотъемлемым компонентом лечения рака молочной железы остается радикальная мастэктомия, следовательно, вместе с ростом выживаемости, растет и число глубоко инвалидизированных в ходе радикального лечения женщин. Утрата молочной железы для большинства из этих больных является огромной психологической травмой и часто заставляет серьезно менять привычный образ жизни, одновременно поддерживая воспоминания о перенесенном лечении по поводу рака. Признано, что восстановление молочной железы является главным средством психо-социальной адаптации женщины к перенесенной мастэктомии.

Цель: Целью данного исследования являлось изучение отдаленных результатов хирургического лечения рака молочной железы, при сочетании радикальных операций с одномоментными реконструктивно-пластическими операциями.

Материалы и методы: Нами ретроспективно проведен сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического лечения 811 больных раком молочной железы, прооперированных в отделении маммологии КОД МЗ РТ с 1983 по 2009гг. Выделены две группы пациентов. В первую группу были включены больные, которым были выполнены одномоментные реконструктивно-пластические операции (406), из которых 160 больным была выполнена реконструкция лоскутом TRAM, 88 больным - реконструкция перманентным экспандер-имплантатом Беккера, и 158 больным была выполнена реконструкция лоскутом ТДЛ. Вторую группу составили пациенты, которым была выполнена только радикальная операция без реконструкции (405).

Результаты: В первой группе 5-летний срок преодолели 95,3±2,1 пациента I стадии. При IIA стадии показатель пятилетней выживаемости составил 86,4±2,1, при IIB – 84,7±2,1, при IIIA и IIIB соответственно 71,4±2,2 и 66,6±2,3. Во второй группе показатели распределились следующим образом: I - 96,9±2,6, IIA - 90,0±2,8, IIB - 87,9±2,7, при IIIA и IIIB соответственно 78,0±3,1 и 63,2±3,6.

Выводы: При сравнении этих данных, очевидно, что статистически значимой разницы не наблюдается между двумя группами, т.е. восстановление молочной железы не ухудшает онкологических результатов, так как не изменяет объем хирургического вмешательства и не влияет на общий план лечения.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Кайдаров Б.К., Хожаев А.А., Балтаев Н.А., Ким А.В., Шатковская О.В., Тумабаева Х.Т., Кайдарова А.Б., Шапаева У.К., Тасбулатов З.О., Кленин В.В. (ст)

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак желудка (РЖ) занимает одно из лидирующих мест в структуре онкозаболеваемости населения нашей республики. При этом удельный вес IV стадии заболевания составил в 2008 году 29,7% (среднереспубликанский показатель), занимая первое место среди всех локализаций. В связи с этим повышение эффективности паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) больных РЖ является одной из насущных проблем клинической онкологии.

Цель работы: повышение эффективности паллиативного

лечения и определение основных показателей КЖ у больных РЖ IV стадии.

Материал и методы. В исследование включено 62 пациента РЖ IV стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 г.г. В соответствии с задачами исследования пациенты составили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, получившие паллиативное комбинированное лечение: циторедуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ согласно стандартам лечения (23 больных); II (контрольная) группа – больные, которым проведено паллиативное терапевтическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (39 пациентов). Оценка КЖ проводилась посредством модульного опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: физического, социального (включая семейное), эмоционального функционирования, благополучия в повседневной жизни и специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опросника FACT-Ga в исследуемых группах не имели достоверных отличий ($p>0,05$).

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе по отношению к контрольной показала, что статистически значимые различия ($p<0,05$) по среднему баллу шкал опросника FACT-Ga были выявлены по всем 4 базовым шкалам и дополнительному модулю во всех точках исследования после начала лечения. При этом медиана выживаемости составила в основной группе 13,6 мес, а в контрольной – 6,2 мес ($p<0,05$).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при IV стадии РЖ позволяет улучшить отдаленные результаты лечения и КЖ больных.

РАННЕЕ ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ В ОНКОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ОПЕРИРОВАННЫХ НА ОРГАНАХ ЖКТ.

Кайрашева С.Е.

Региональный онкологический диспансер, г. Семей.

Интерес к энтеральному зондовому питанию (ЭЗП) больных после операции связано с представлениями о кишечнике как метаболическом, эндокринном, иммунном органе, барьере перед микробной инвазией, органе, обеспечивающем постоянство внутренней среды организма.

Цель исследования: Оптимизация терапии ЭЗП больных оперированных на органах ЖКТ на фоне изучения центральной гемодинамики.

Материалы и методы. В хирургическом отделении онкологического диспансера г. Семей ЭЗП в раннем послеоперационном периоде проводилось у 28 больных в возрасте от 38 до 72 лет (16 женщин, 12 мужчин) в том числе раком желудка – 23, рак пищевода-5.

В качестве зонда для питания использовали зонд собственной конструкции с мягкой оливой на конце плотно прилегающей к просвету внешнего зонда. Для оценки исходного трофического статуса пациентов и эффективности проводимой нутритивной поддержки определяли массу тела (МТ) и ее отношение к "идеальной" массе тела (ИМТ), рассчитанной по формуле Брока. С 1 суток после операции исследовали содержание альбумина плазмы, суточную экскрецию креатинина и мочевины с мочой.

Результаты исследования: Из 28 больных до операции у 24 больных (85,9%) имели нормальные показатели питательного статуса или умеренную недостаточность, остальные 4 (14,1%) больных-выраженную или предельную недостаточность питания. При выписке из стационара у 25 больных (90,2%) были нормальные показатели питания, а выраженная недостаточность отмечалась у 3 больных (9,8%). Исходные величины антропометрических показателей свидетельствовали об истощении больных, а уровень альбумина ($35,1\pm0,78$) – о значительной потере плазменных белков. На 3 сутки после

операции показатели МТ, МТ/ИМТ, ТМТ, КРИ, и альбумина незначительно уменьшались. Азотный баланс составлял $2,97 \pm 1,13$. Но уже на 5 сутки послеоперационного периода наблюдалась четкая тенденция к увеличению антропометрических показателей, уровня альбумина плазмы.

Выводы: Таким образом, нутритивная поддержка смесью «Унипит» в раннем послеоперационном периоде обеспечивает быстрое и эффективное уменьшение катаболизма и формирование анаболических процессов, ограничит полное парентеральное питание в период инфузионной терапии.

ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ ПРИ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ОНКОХИРУРГИИ

Кайрашева С.Е.

Региональный онкологический диспансер, г. Семей

Поражение печени лекарственными препаратами составляют около 10% всех побочных реакций организма больного, связанных с применением фармакологических препаратов.

Цель исследования: Прогнозирование и профилактика гепатопатии на фоне изучения печеночных показателей при расширенных операциях в онкологии.

Материалы и методы. Профилактика и лечение печеночной дисфункции было проведено 34 оперированным больным, со злокачественными новообразованиями в возрасте от 31 до 69 лет. Мужчин было 19, женщин-15. Объемные расширенные операции проводились при раке желудка-25 больным, раке пищевода-9. Всем им лабораторными тестами определяли функциональное состояние и степень дисфункции печени. В зависимости от этого проводилась защита и гепатопротекция препаратом гептрал. Препарат в дозе 0,4гр. включали в аутоэритроциты больного путем гипоосмотического гемолиза и вводили внутривенно в до-, интра- и послеоперационном периодах.

Результаты исследования: Высокая клиничко-лабораторная эффективность метода определена результатами исследования, которые показали, что после 3-х введений гепатопротектора гептрала в/в улучшились биохимические лабораторные показатели крови (таблица).

Таблица. Динамика функциональных показателей печени.

Показатели	Сроки наблюдения			
	Контр. группа	До операции (1 введение)	Во время операции (2 введение)	После операции (3 введение)
Общий билирубин	$21,3 \pm 0,7$	$23,4 \pm 0,9^*$	$21,7 \pm 0,8$	$21,0 \pm 0,5$
Холестерин	$5,6 \pm 0,35$	$4,5 \pm 0,29^*$	$4,8 \pm 0,30$	$5,1 \pm 0,32$
АлАТ	$0,75 \pm 0,049$	$1,2 \pm 0,087^*$	$0,97 \pm 0,066$	$0,70 \pm 0,052$
АсАТ	$0,53 \pm 0,023$	$0,56 \pm 0,028^*$	$0,50 \pm 0,022$	$0,46 \pm 0,020^*$
Гамма-глобулин	$16 \pm 0,48$	$15 \pm 0,43$	$15 \pm 0,43$	$17 \pm 0,49$
Тимоловая проба	$3,0 \pm 0,20$	$5,3 \pm 0,33^*$	$4,5 \pm 0,29$	$4,0 \pm 0,25$

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с контрольной группой $p < 0,05$.

Лабораторные анализы показали положительную динамику биохимических показателей, характеризующих синдром холестаза и цитолиза (АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубина) Улучшились и клинические данные у больных основной группы: уменьшились боли, дискомфорт и чувство тяжести в правом подреберье, исчезла тошнота, улучшилось общее самочувствие.

Выводы: гептрал может применяться как система «доставки» его в печень для непосредственной реализации своего терапевтического действия, а также многофункциональность гептрала делает его препаратом выбора для защиты и лечения дисфункции печени у онкологических больных.

РОЛЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ НЕФРЭКТОМИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ

Койшыбаев А. К.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.

Цель исследования: Улучшение отдаленных результатов комбинированного лечения и качества жизни пациентов раком почки с отдаленными метастазами.

Материал и методы исследования: Причиной смерти больных раком почки с отдаленными метастазами часто являются осложнения со стороны основной опухоли в виде кровотечения, сдавления жизненно важных органов, сосудов, разрыва опухоли и т.д.

На период с 2005 года по 2009 год 18 пациентам раком почки, имеющим отдаленные метастазы, произведены циторедуктивные нефруртерэктомии.

Пациентам в предоперационном периоде проводилось комплексное обследование с включением УЗИ, КТ-графии, МРТ, выделительной урографии, исследование азотистого обмена, с целью выяснения резектабельности опухоли и функциональных способностей контрлатеральной почки. У всех больных выявлены отдаленные метастазы: у 8-и больных – в лёгком, из них у 3-х имело место двухстороннее поражение, поражение костей скелета – 5 больных, из них у 2-х имело место множественное поражение скелета с патологическими переломами, метастазы в печени – у 4-х, в мягкие ткани брюшной стенки – у 1-го. У всех больных имело место осложнения опухолевого процесса в виде микро-макрогематурии. У 1-го пациента имело место патологические переломы CV и DIX позвонков.

Определяющими факторами, при наличии отдаленных метастазов, были нормальная функция противоположной почки и функциональная операбельность пациентов.

6-и больным производили, наряду с нефруртерэктомией, резекцию соседних органов (печень – 2 случая, дистальная резекция поджелудочной железы и спленэктомия - 1, спленэктомия в связи синвазией опухоли – 1, резекция ободочной кишки – 2).

Доступ при этих операциях - широкая срединная лапаротомия. Во время нефруртерэктомии выполняли парааортальную лимфодиссекцию по обе стороны аорты.

Результаты: В послеоперационном периоде у 2-х больных развились осложнения: у 1-го кровотечение, что потребовало выполнение релапаротомии, остановки кровотечения, у 1-го пациента развился панкреатический свищ, который закрылся самостоятельно. Послеоперационной летальности не было. Всем больным в последующем проводились курсы химиотерапии. В течение года живы все пациенты. Медиана выживаемости составила 24 месяца. У пациентов улучшилось самочувствие, показатели крови, уменьшился болевой синдром, исчезли симптомы интоксикации. У некоторых пациентов отмечена стабилизация и регрессия легочных метастазов. У больных, имевших скелетные метастазы, исчезли боли.

Выводы: 1. Паллиативная циторедуктивная нефруртерэктомия при раке почки с отдаленными метастазами, позволяет улучшить качество жизни пациентов и создает благоприятные условия для проведения дополнительной специальной терапии, предупреждает осложнения со стороны первичной опухоли и позволяет надеяться на улучшение отдаленных результатов комбинированного лечения.

2. Её следует выполнять всегда, если пациент функционально операбелен.

ПОКАЗАНИЯ К СИМУЛЬТАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ.*Койшыбаев А.К., Дюсембеков С.Т.,**Бегунов В.В., Зайцева Л.С., Уразаев О.Н.**Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.*

Актуальность. Современные возможности хирургии и анестезиологии позволяют расширить диапазон сочетанных операции, что позволяет избавить пациентов от повторных операции и эмоциональных стрессов, а также предупреждает возможности обострений и осложнений от сопутствующих заболеваний.

Симультанными операциями считаются те, которые выполняются одновременно при двух или более хирургических заболеваниях на разных органах. При сочетанных операциях различают основной и симультанные зоны, когда основным направлением является удаление наиболее опасного патологического процесса.

При выборе показаний выделяют абсолютные – когда оба заболевания взаимосвязаны друг с другом и отягощают состояние, превентивные показания по поводу заболевания, которые в будущем могут обусловить осложнения, рецидивы.

Цель исследования. Определение показаний к проведению симультанных операции при колоректальном раке, объёме предоперационной подготовки, обоснование хирургического доступа, анестезиологического пособия, улучшения качества жизни больных.

Материал и методы исследования. В медицинском центре ЗКГМУ им.Марата Оспанова в период с 2005 по 2009 г. оперированы 16 больных с опухолями ободочной, прямой кишки и сопутствующей хирургической патологией, которым были показаны симультанные операции. Из них у 6 больных основной сопутствующей патологией был калькулезный холецистит (произведены холецистэктомия), у 4 больных имелась опухолевая патология желудка – произведены моноблочная симультанная гастропленэктомия с лимфодиссекцией в объёме D2 и право-или левосторонняя гемиколэктомии. В остальных 6 случаях имелись патология органов гениталия и мочевыделительной систем.

Результаты исследования. Количество послеоперационных составило 2 случая (12,5 %) в виде нагноения послеоперационной раны и длительного желчеотделения в 1 случае. Летальности не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, приведенные данные говорят о необходимости проведения симультанных операции у больных колоректальным раком при наличии сопутствующей хирургической патологией и соблюдении онкологических принципов при выявлении первично-множественных опухолей, т.е. моноблочности и абластичности.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА*Кротов Н.Ф., Расулов А.Э., Имамов О.А., Алмардонов Р.Б.,**Мадияров Б.Т., Воротников В.В., Бердикулов Д.И.**Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент. Узбекистан.*

Цель исследования. Анализ результатов реконструктивно-восстановительных операций (РВО) при раке грудного отдела пищевода (РГОП).

Материалы и методы. С 2000 по 2009гг. в торакальном отделении РОНЦ МЗ РУз выполнено 306 РВО при РГОП. Мужчин было – 147 (48,1%), женщин – 159 (51,9%). Возраст больных колебался от 24 до 77 лет (средний возраст 51,3 лет). Распределение больных по стадиям заболевания: II – 23 (7,5%), III – 283 (92,5%). Локализация опухоли в верхнегрудном отделе (ВГОП) пищевода у 35 (11,4%) больных,

среднегрудном (СГОП) у 159 (51,9%) и у 112 (36,6%) в нижнегрудном (НГОП).

При локализации опухолевого процесса в ВГОП (35 (11,4%) больных) выполнялась трехдоступная эзофагэктомия - операция McKeown с наложением цервикального ЭГА. При локализации опухоли в СГОП и НГОП выполнялись следующие виды операций: операция Ивор-Льюиса выполнена 71 (23,2%) больному с более высокими функциональными показателями, трансхиатальная эзофагэктомия (ТХЭ) 200 (65,3%) пациентам, с более низкими функциональными показателями. Из 200 пациентов у 120 мобилизация СГОП и ВГОП, медиастинальная лимфодиссекция выполнена видеоассистированием. 124 больным цервикальный ЭГА наложен по предложенной нами методике.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде осложненное течение отмечено после операции McKeown у 19 (54,3%) больных, после операции Ивор-Льюиса у 42 (59,1%) и после ТХЭ у 43 (21,5%). Общая послеоперационная летальность составила 6,8% (21 больной), при этом: после операции McKeown – 2 (5,7%), после операции Ивор-Льюиса – 7 (9,8%) и после ТХЭ – 12 (6%). Наиболее частым поздним осложнением явилось рубцовое сужение ЭГА, что отмечено у 25 больных: после операции McKeown – 3 (8,5%), операции Льюиса – 9 (12,6%) и ТХЭ – 19 (9,5%). Наложение антирефлюксного цервикального ЭГА по нашей методике позволило снизить рубцовое сужение с 33 до 5%, а случаи аспирационной пневмонии с 9,8 до 1,5%.

Выводы. Правильный выбор оперативного доступа с учетом локализации опухолевого процесса на пищеводе, применение видеоассистирования при ТХЭ позволят уменьшить число интра- и послеоперационных осложнений. Формирование цервикального ЭГА по разработанной нами методике позволит практически избежать грозных осложнений РВО на пищеводе, свести до минимума частоту стенозов, избежать в отдаленном периоде выраженного желудочно-пищеводного рефлюкса.

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ*Кротов Н.Ф., Расулов А.Э., Имамов О.А., Чернышева Т.В.**Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент. Узбекистан.*

Цель исследования. Анализ результатов видеоторакоскопических операций (ВТО), выполненных при периферических образованиях легких (ПОЛ).

Материалы и методы. С 2000 по 2008 гг. в торакальном отделении РОНЦ МЗ РУз выполнено - 40 ВТО при ПОЛ. Возраст больных колебался от 15 до 63 лет, среди них мужчин - 26(65%), женщин 14(35%). Предоперационные комплексные обследования не позволили диагностировать гистологическую структуру образований. Использование ВТО позволило определить характер и распространенность патологического процесса, объём оперативного вмешательства. ВТО в основном выполнялись при периферической, субплевральной локализации образований.

Результаты. У 20 (50%) пациентов - наличие субплеврального округлого образования, без вовлечения в процесс окружающей легочной паренхимы. Произведено прецизионное удаление. Гистология: гамартохондрома – 15, хондрома в – 5 случаях. У 13 (32,5%) выявлена картина перифокального воспаления, выполнена атипичная резекция легочной ткани с опухолью. Гистология: туберкулема - 9; фиброма – 4. У 2 (5%) при ревизии диагностирован симптом стягивания висцеральной плевры и перифокальной легочной ткани в опухоль, наличие увеличенных лимфоузлов. Произведена анатомическая резекция пораженной доли. Гистология: низкодифференцированная аденокарцинома. У 5 (12,5%) - пери-

ферическая опухоль с диссеминацией по плевре. Операция окончена биопсией. Гистология: аденокарцинома. Каких-либо осложнений, связанных с проведением ВТО не отмечено.

Выводы. ВТО являются завершающим этапом диагностики ПОЛ, позволяют установить точный диагноз, выполнить необходимый объем операции, при необходимости перейти на стандартную торакотомию.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С КОЛОСТОМАМИ

Кусаинов Е. Т.

*Восточно-Казахстанский областной онкологический
диспансер*

Восстановление непрерывности толстой кишки приобретает решающее значение для социально-трудовой и моральной реабилитации этого контингента больных. Успех восстановительных операции зависят от выбора оптимального срока для их выполнения, общего состояния больных, отсутствия рецидивов, метастазов, наличие периколостомических осложнений. В период 2000 - 2010гг выполнено 49 операции по ликвидации различных видов колостом. Наибольшее количество восстановительных операции выполнялись после операции Гартмана -80 %, остальные с цекастомой, трансверзостомой, илеостомой.

Одноствольные колостомы после операции Гартмана закрывались через 10-12 месяцев. У наших пациентов в зависимости от вида колостом, состояния больных сроки восстановительных операции колебались от 3 месяцев до 3-х лет. Основными методами восстановительных операции были наложения сигмаректоанастомоза конец в бок, конец в конец, внебрюшинные устрания колостом у 5 больных, илеотрансверзоанастомоз с ликвидацией илеостомы, а также производились операции с левостомией, гемиколэктомией в 3-х случаях, передняя резекция прямой кишки с ликвидацией рецидива в области колостомы и в области культи дистального отрезка прямой кишки.

Выводы:

1. У больных с 2-х ствольной колостомой при восстановлении толстокишечной проходимости предпочтение следует отдавать внутрибрюшному методу, так как он более радикален и дает меньшее число послеоперационных осложнений.
2. Внебрюшинный метод закрытия лучше проводить при неосложненных пристеночных или петлевых колостомах с податливой шпорой и при отсутствии воспалительно-рубцовых изменений в области колостом.
3. При закрытии колостом оптимальным сроком восстановительных операции следует считать от 9- 12 месяцев.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Кыдырбаева Г.Ж.

*Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии г.Алматы*

Проблема лечения пациентов с данной патологией остается актуальной. Проводимые радикальные оперативные вмешательства ухудшают качество жизни пациента в связи с косметическими и функциональными нарушениями. Для решения этой проблемы решаются вопросы реконструктивной и эстетической реабилитации, разработка новых способов операций и технологий.

Цель работы: Оценить возможности пластической хирургии для восстановления жизненно-важных функций.

Проведен анализ 350 больных местно-распространенным раком полости рта и глотки 111-1У стадии. В 80% случаях реконструктивно-пластические операции выполнялись при

первичной комбинированной пластике и в 20% случаях при отсроченной.

Хорошие косметические и функциональные результаты получены при использовании торако-дорсального лоскута. Так полное приживление лоскута отмечено у 65% больных, краевой или частичный некроз в следствии нарушения кровоснабжения в питающей ножке наблюдался у 35% пациентов.

При использовании кожно-мышечного лоскута с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, торако-дорсального и дельтопекторального лоскутов в 90%, в 75% и 60% соответственно с отмечалось полное приживление лоскута. Применение кожно-мышечного лоскута с включением трапецевидной мышцы для создания внутренней выстилки оправдан в 86,6%.

С развитием микрохирургической аутоотрансплантацией нами был внедрен лучевой лоскут с помощью микрососудистых анастомозов. При использовании данного вида микрохирургической пластики в 72% случаев мы отмечали полное приживление тканей.

При применении отсроченной комбинированной пластики использовались кожно-мышечные лоскуты в сочетании с кожно-мышечными, кожно-жировыми и свободной кожной пластикой для формирования внутренней выстилки и наружной кожной выстилки.

Реконструктивные операции сопровождались ранними и поздними послеоперационными осложнениями. У 15% больных образовывались оро-фарингостомы, в следствии чего проводилась отсроченная пластика. Послеоперационные кровотечения наблюдались у 5% больных. У 1 больного развилась тромбоэмболия легочной артерии и у 1 пациента развилась пневмония.

Качество жизни больных мы оценивали по степени сохранения функции – самостоятельного питания, глотания и речи (85%). Применение первичных и отсроченных реконструктивно-пластических операций проведенных больным со злокачественными новообразованиями не увеличивают рецидивы и не ухудшают прогноз заболевания.

Выводы. Оптимизация и разработка методов реконструктивно-пластической хирургии способствует улучшению качества жизни пациента и сократить сроки реабилитации пациента.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

*Нурғалиев Н.С., Онғарбаев Б.Т.,
Кенжебаев Б.Ж., Ишкинин Е.И.*

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Опухоли надпочечников относятся к относительно редким заболеваниям, составляя не более 0,6% от всех злокачественных новообразований. В большинстве случаев эти новообразования являются опухолями, исходящими либо из коркового, либо из мозгового слоя. Иногда эти образования являются метастазами опухолей другой локализации. Известно, что большинство опухолей надпочечников сопровождается артериальной гипертонией, нередко злокачественного характера, исчезающей после удаления опухоли. В этой связи проблема опухоли надпочечников, помимо ее онкологической направленности, приобретает совершенно новое значение, так как гипертония, являясь одним из ранних проявлений опухолевого страдания, должна учитываться для ранней диагностики новообразования.

Основным методом лечения опухолей надпочечников в настоящее время является хирургический. Успех хирургического лечения во многом зависит от предоперационной подготовки, адекватности обезболивания, правильности ведения послеоперационного периода. Предоперационную подготовку следует проводить с учетом степени гормональной активности опухоли, проявлений заболевания, его осложне-

ний и сопутствующей патологии. Обязательным является исследование уровня гормонов надпочечников – минералоглюкокортикоидов, кортикостероидов. В предоперационном периоде с целью коррекции состояния, ведение больного во время операции и послеоперационном периоде, необходимо координировать действия эндокринологов-терапевтов, урологов (хирургов) и анестезиологов.

Радикальным методом лечения является удаление опухоли (надпочечника), при необходимости с последующей заместительной терапией глюко-минералокортикоидов. Во время операции при гормонально-активных опухолях можно столкнуться с различными трудностями. Как правило, на начальном этапе ревизии и выделения надпочечника происходит массивный выброс гормонов, сопровождающийся тахикардией и гипертензией (частота сердечных сокращений повышается до 100-150 ударов в минуту, систолическое АД – до 200-280 мм.рт.ст.), в связи с чем для уменьшения нежелательных последствий необходимо использовать «управляемую гипотонию» – инфузию растворов нитроглицерина, пентамин и т.д. Необходимо стремиться быстрее перевязать основную вену надпочечника. Наоборот, после удаления железы наблюдается резкое снижение гемодинамики, что требует дополнительного введения гормональных средств (дексаметазон, адреналин, мезатон, полиглюкина).

В нашей клинике с 2006 года прооперировано 17 больных с опухолями надпочечников, в 5 случаях из которых гистологически выявлены аденома надпочечника, в остальных рак (в 1 случае метастаз рака легкого в надпочечник). На результатах нашего небольшого опыта можно высказать следующее заключение: 1. обязательно осмотр эндокринолога для решения вопроса о необходимости операции на данном этапе и коррекция гормонального статуса предоперационного и послеоперационного периода; 2. осмотр анестезиолога, для необходимости подготовки больного к операции, иметь возможность подготовиться самому анестезиологу к возможным скачкам АД во время операции; 3. стремиться максимально раньше перевязать основную надпочечниковую вену. На наш взгляд, при наличии достаточно квалифицированной службы анестезиологии-реаниматологии, подобные операции могут с успехом выполняться.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Балтабеков Н.Т., Абисатов Х.А.

*Алматинский городской онкологический диспансер.
Казахстанско – Российский медицинский университет*

Актуальность. Несмотря на то, меланома кожи относится к визуально доступным локализациям опухоли, среди впервые выявленных больных удельный вес поздних стадий (III – IV) колеблется в пределах 30 – 47% (Арзыкулов Ж.А. с соавт., 2007, Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008.). Поэтому совершенствование существующих и разработка новых методов диагностики ее является актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить состояние диагностики меланомы кожи в поликлиниках г.Алматы по отчетам 2004 года. Внедрить в практику современных методов уточняющей диагностики, таких как дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы «Менард» (Япония), газоразрядный визуализации (электронно – полевой топоческой томографии, определение иммунного статуса больных).

Методы исследования. Материалом для исследования послужили данные о 633 больных, которым наряду с рутинными методами применялись вышеуказанные методы диагностики. Так, дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» применялись у 308 пациентов, газоразрядная визуализация – у 85, иммунологические исследования – у 122 пациентов, кроме того среди врачей поликлиник г.Алматы в 2005г прочитаны 37 лекций по современным методам диагностики, через 3 месяца совместно с сотрудниками кафедры онкологии проведена аттестация

врачей поликлиник на знание «симптомов тревоги» при подозрении на наличие меланомы кожи.

Результаты исследования.

- Состояние ранней диагностики меланомы кожи в 2004г было неудовлетворительным, так как у 39,2+6,8% пациентов диагноз установлена в III и IV стадии опухолевого процесса. Повышение онкологической настороженности врачей общей лечебной сети путем чтения регулярных лекций и обязательной последующей аттестацией на знание ранних симптомов меланомы кожи позволяет снизить уровень поздней диагностики в 2006 году с 39,2+6,8% до 20,5+6,7% ($P<0,05$).

- Применение дерматоскопии аппаратом «Скиноскоп» позволяет увеличить эффективность выявления внутрикожных метастазов (сателлитов) с 28,0+3,4% при визуальном осмотре до 75,0+4,1% ($P<0,001$) и правильно выбрать объем оперативного вмешательства.

- Использование газоразрядной визуализации (ГРВ) перед началом лечения меланомы кожи помогает определить субклинические метастазы во внутренние органы. Частота совпадений диагнозов ГРВ в последующих гистологических исследованиях составила 88,9%, а с рентгеновским исследованием – 71,4%.

- Уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором. При рецидиве кожи в 98,2 2,3% случаев доклинически определяемого рецидива отмечается снижение основных показателей Т-клеточного иммунитета, включая СД3, СД4, СД8 и СД4/СД8 более чем на 30% от исходного.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ.

Мирманова Г.Ж., Савхатов Д.Х.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Актуальность темы. Рак кожи остается заболеванием, проблема которого продолжает быть актуальной в связи с тенденцией роста его во всем мире. Ведущий метод лечения – хирургический. Следует отметить, что основным критерием операций является частота тромботических осложнений и некроза пересаженных тканей.

Цель: Оценить возможности ультразвуковой доплерографии до операции и пересаженных лоскутов в послеоперационном периоде. Изучить непосредственные результаты лечения больных раком кожи.

Материалы и методы: На базе КазНИИОиР на клиническом материале были проанализированы результаты лечения 50 больных раком кожи, находившихся на стационарном лечении с 2007 по 2010гг. Эхоскопическое исследование проводилось на базе отделения ультразвуковой диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Обследование осуществлялось с использованием основных стандартных режимов сканирования: режимы цветового и энергетического доплеровского картирования, спектральное доплеровское исследование. Предварительная подготовка пациентов к исследованию не проводилась. В ходе диагностического процесса последовательно изучались границы опухоли, её линейные размеры и объем, глубина инвазии, условная плотность ткани опухоли, взаимоотношение артерии и вены в составе сосудистой ножки, приоритет кровотока, а также показатели кровотока по обнаруженным сосудам. Не менее важной задачей был контроль над кровоснабжением и жизнеспособностью лоскута в послеоперационном периоде. В нашем исследовании ультразвуковая диагностика трансплантированного лоскута во всех вышеописанных режимах проводилась через 24, 48 и 72 часа после операции.

Результаты исследования. При ультразвуковом исследовании предполагаемой донорской зоны, у 37 пациентов

преобладал артериальный кровоток. Вероятность микротромбозов сосудов не определялась. Степень дисперсности при ультразвуковой амплитудной гистографии не превышала 4,9 ЕД. У 13 больных наблюдалась низкая – до 1/3 – степень васкуляризации предполагаемого трансплантата, степень дисперсности была снижена до 3,8 – 3,9 ЕД. По всей видимости, эти показатели были снижены в связи с нарушением сосудистого кровотока в лоскуте, что, косвенным образом, свидетельствовало о возможных проблемах с его приживлением и соответствующим кровоснабжением в будущем.

При энергетической доплерографии на первые сутки после операции положительная реваскуляризация отмечалась у 44 пациентов. Кровоток сосудов регистрировался четко. Степень дисперсности – в пределах 4,6 – 4,8. У 6 больных использование данной тактики позволило выявить в лоскуте нарушения кровоснабжения. После принятых соответствующих мер, при мониторинге отмечалось восстановление кровотока. Осложнения на 2-3-е сутки наблюдались у 11 больных. Из них: в 2-х случаях – тромбоз сосудистой ножки (в одном случае удалось возобновить кровоток); в 7 – некроз лоскута, у одного больного с раком нижней губы наблюдалось кровотечение и еще у одного – лимфостаз. Во всех остальных наблюдениях ультразвуковая доплер-флоуметрия не выявила каких-либо закономерностей в изменении скоростных параметров. Дальнейшее заживление раны протекало без осложнений. Удовлетворительные непосредственные результаты составили 78%.

Вывод: Применение комплексной программы ультразвуковой диагностики до и после пересадки кожного лоскута для замещения послеоперационного дефекта позволяет оценить состояние трансплантата, прогнозировать возможность приживления и скорректировать, в случае необходимости, программу лечения, тем самым, добиваясь высоких непосредственных результатов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОРТАНИ

Набиев А.К., Орманов Н.К., Мухидинова И.Н.

Областной онкологический диспансер, г. Шымкент, Казахстан

Рак гортани (РГ) является наиболее часто встречающейся онкопатологией ЛОР-органов. Заболеваемость РГ составляет 0,8-5% среди всех злокачественных опухолей, по ЮКО выявляются 25-30 новых случаев РГ. Широко применяемая радикальная операция при РГ, то есть ларингэктомия (ЛЭ), может обеспечить хороший прогноз в плане излечения. Но многие больные отказываются от такого лечения, потому что ЛЭ является калечащей операцией, которая приводит к пожизненной трахеостомии и лишению гортани как органа, т.е. такой человек не только становится инвалидом на всю оставшуюся жизнь, но и не может быть реабилитирован социально. Все вышеизложенное показывает, что проблема лечения больных РГ остается актуальной и в настоящее время.

Целью нашей работы явилось изучить результаты комбинированного лечения больных РГ по данным Южно-Казахстанского областного онкологического диспансера.

Материал и методы. В ООД ЮКО за период 2006-2009гг. пролечено 98 больных РГ. Нами в сравнительном аспекте проанализированы результаты лечения 45 больных РГ III стадии в двух группах, где в I группе 20 больным (20,4%) проведена дистанционная гамма терапия (ДГТ) по радикальной программе (РОД 2 Гр до СОД 60 Гр в режиме с двух встречных полей), а во II группе 25 больным (25,5%) производилась радикальная операция - ЛЭ. Большинство наблюдений обеих групп составили в возрасте 51-70 лет. В исследуемых группах преобладали больные со смешанной формой роста опухоли (соответственно 49,0% и 52,2%). По степени распространения метастазов у большинства больных обеих групп метастазы

отсутствовали (Т3N0M0).

Результаты и их обсуждение. После проведенной лучевой терапии было примерно одинаковое количество больных в обеих группах (соответственно 40% и 36%). Больных с частичной регрессией опухоли в I группе было немного больше (50%), чем во II группе (44%). Без эффекта оставались 10% больных I группы и 16% больных II группы. У всех больных II группы с полной регрессией опухоли через 1,5-2 года развивался рецидив, в связи с чем им, а также больным с частичной и без регрессии опухоли выполнялась ЛЭ. После ЛЭ питание больного восстанавливали через рот, а дыхание через трахеостому. Основным недостатком данной операции является утрата голосовой функции, восстановление которой с использованием логопедических методик неодинаково успешна.

Анализ полученных данных по срокам появления рецидивов и метастазов показал, что после ДГТ рецидивы и метастазы чаще развивались в сроки 1-3 года (соответственно 25% и 15%), причем они проявлялись уже в 1 год после начала лечения в 5% и 10% случаев, достигая максимума к 3 году и уменьшаясь к 5 годам до 5%. В группе больных, получивших комбинированное лечение с выполнением операции - ЛЭ, наибольшая численность больных с рецидивами и метастазами отмечена в течение первого года после начала лечения (соответственно 4% и 12%); в сроки 1-3 лет и 3-5 лет в равных количествах развивались только метастазы (по 4%), рецидивов не было.

5-летняя выживаемость в группе больных с ДГТ была также ниже (40,8%), чем в группе больных с ДГТ+ЛЭ (67,3%). При сравнении выживаемости больных этих групп данные статистически достоверны ($P<0,05$). В этот период в I группе умерших не было, а во II группе умерло 2 (4,3%) больных.

Выводы. Таким образом, комбинированное лечение с включением ЛЭ позволило сократить в 2,7 раз развитие рецидивов метастазов на протяжении 5 лет после начала лечения, увеличить 3-х и 5-летнюю выживаемость больных по сравнению с чисто ДГТ, сократить общую смертность с 59,1% до 32,6%. Полученные данные показывают явное преимущество комбинированного метода лечения ДГТ+ЛЭ над чисто ДГТ. Однако, реабилитация больных РГ III стадии, потерявших орган после калечащей операции - ЛЭ, представляется очень трудной и до конца нерешенной проблемой. Поэтому больные часто категорически отказываются от данной операции.

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ

Пироженко О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Одной из важнейших задач современной онкологии является адекватное лечение рака молочной железы, направленное на достижение максимального эффекта при минимальных токсических воздействиях. До сих пор выбор адекватного лечения основывался на учете степени местно-регионарного распространения опухоли (система TNM), уровня экспрессии рецепторов к стероидным гормонам и репродуктивном статусе (или, чаще, возрасте) больных. Современная диагностика опухолей включает не только верификацию гистологического варианта и степени дифференцировки, но и оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли (морфофункциональной характеристики новообразования). Основными иммуногистохимическими маркерами, отражающими функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы, являются пролиферативная активность, экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона и экспрес-

сия онкопротеина HER2/neu (c-erbB-2). По данным O'Maller F.P. et al (2001) гиперэкспрессия HER2/neu обнаружена в 20–30% инвазивного протокового рака молочной железы, а в случаях неинвазивного рака эта величина достигает 90%. Гиперэкспрессия HER2 указывает на усиленное деление опухолевых клеток, повышение кровоснабжения опухоли, высокий риск развития метастазирования и резистентность к проводимой химиотерапии. Знание состояния гена HER2/neu и уровня экспрессии белка HER2/neu имеет важное значение для определения прогноза у больных инвазивным раком молочной железы и для отбора пациентов с наличием гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu для дальнейшего лечения. Все большее значение приобретают точные, прямые и стандартные методы определения наличия гиперэкспрессии и/или амплификации HER2/neu. По данным Завалишина Л.Э. и др. (2006) в настоящее время существует несколько методов выявления гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu: иммуногистохимический (ИГХ), гибридизация *in situ* (флюоресцентная и хромогенная), полимеразная цепная реакция. Однако на практике доминирующее положение занимает ИГХ-метод определения HER2-статуса рака молочной железы. При неопределенном иммуногистохимическом HER2-статусе (2+) требуется исследование, выявляющее наличие или отсутствие амплификации. Такими методами являются флюоресцентная *in situ* гибридизация (FISH) и хромогенная *in situ* гибридизация гена (CISH). Метод FISH является более чувствительным, так как позволяет напрямую оценивать наличие (или отсутствие) амплификации, но и гораздо более дорогостоящим, чем ИГХ. Метод CISH позволяет выявлять амплификацию гена HER2 под световым микроскопом и учитывать морфологическую картину ткани. Недостатками методики является ее новизна и наличие «мертвой зоны» при оценке результатов исследований, так же как и при ИГХ-исследовании. Оба метода выполняются на срезах с того же образца (блока), на котором проводилось ИГХ-исследование. Конкордантность методов FISH с использованием двухцветных зондов (на участки центромеры 17-й хромосомы и гена HER2) и CISH с использованием монокромного зонда, комплиментарного только участку HER2, составляет 85%.

Следовательно, для окончательной диагностики наличия амплификации гена HER2 целесообразно использовать метод FISH, так как получаемые с его помощью результаты более точно отражают истинный HER2-статус пациентки, что крайне важно для назначения таргетной терапии. Метод CISH позволяет с высокой вероятностью выделять группу опухолей с высокой амплификацией и может использоваться в отделениях патологической анатомии, не имеющих оборудования для флюоресцентного исследования. Образцы опухолей с низкой амплификацией гена должны в обязательном порядке повторно исследоваться с помощью метода FISH.

РАК ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ТРОМБОЗОМ КРУПНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ.

Онгарбаев Б.Т., Малгельдиев Н.Н.
КазНИИОиР, отделение онкоурологии.

В мире ежегодно регистрируется 189,1 тыс. новых случаев рака почки (РП), что составляет 2,2% злокачественных новообразований у мужчин и 1,5% у женщин. Каждый год от этого заболевания погибает 91,1 тыс. пациентов [1]. В Республике Казахстан по данным 2008 года общая заболеваемость раком почки среди населения составляет 833 случая на 100 тысяч человек. На протяжении последних 5-ти лет показатель заболеваемости колеблется в пределах 5,0-5,8 на 100 тыс населения.

Материалы и методы. В отделении онкоурологии Казахского НИИ онкологии и радиологии в периоды с 2007 по 2009 год получили лечение 157 больных раком почки различных стадий.

Из общего количества пациентов у 16 больных имело место наличие опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены, что составляет 10,2% случаев. Первичный опухолевый очаг локализовался в правой почке у больных с тромбозом значительно чаще (у 12 больных – 75%), левой почки – 4 больных (25%). Средний возраст оперированных больных 54,1 года, максимальный возраст 84 года, минимальный возраст 35 лет.

В таблице-1 представлены данные о пролеченных больных раком почки в отделении онкоурологии с 2007 года

Таблица-1. Больные раком почки находившиеся на лечении в отделении онкоурологии КазНИИОиР в период 2007-2009 года

	всего	I ст	II ст	III ст	IV ст	опухолевый тромбоз	% с III - IV ст
2009	55	6	14	30	5	8 (14,5%)	63,6%
2007-2008	102	19	21	43	19	8 (7,8%)	60,8 %
ВСЕГО	157	25	35	73	24	16 (10,2%)	61,8 %

Во всех 16 случаях было выполнено радикальное хирургическое вмешательство - нефрэктомия с тромбэктомией. В 6 случаях тромб располагался на уровне почечных вен, в 1 случае – в вене надпочечника, в 6 случаях произведена тромбэктомия из НПВ при субпеченочном расположении тромба, в 3 случаях - при ретропеченочном расположении тромба. В 1 случае у больного имелся опухолевый тромб распространяющийся с левой почки в ретропеченочный отдел НПВ, а ниже уровня отхождения почечных вен имелся сформированный кровяной тромб. Во время операции после проведения тромбэктомии опухолевого тромба из НПВ, удаление кровяного сформировавшегося тромба не производилось, в связи с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Учитывая наличие сформированного коллатерального кровотока больному произведена перевязка нижней полой вены ниже уровня отхождения почечных сосудов.

Выводы. Хотя венозная инвазия ухудшает выживаемость больных раком почки, радикально выполненная операция может дать шанс больному на продление жизни и выздоровление независимо от протяженности опухолевого тромба. С появлением эффективных методов лекарственного воздействия выделение групп различного прогноза может оказаться полезным для решения вопроса о назначении адъювантного лечения.

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

Нургалиев Н.С.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Введение. Одной из наиболее сложных проблем, после проведенных радикальных цистэктомий является выбор метода деривации мочи. Такие операции обеспечивают относительно удовлетворительное качество жизни пациентам, однако, сопровождаются довольно значительным количеством ранних и поздних осложнений. Летальность, связанную с осложнениями в раннем послеоперационном периоде зачастую удается снизить выработкой оптимальной тактики лечения, согласно распространенности процесса, общего состояния больного и приобретенным опытом хирургов. Это в свою очередь согласуется с данными разных авторов, занимающихся данной проблемой.

Комплексная профилактика и лечение поздних послеоперационных осложнений после любых методов деривации мочи остается актуальной проблемой для онкоурологов и хирургов. Проблема лечения больных с кишечной пластикой мочевого пузыря объясняется тяжелым течением инфекци-

онных процессов, расстройствами водно-электролитного баланса, риском развития гиперхлоремического метаболического ацидоза, диареи, снижением иммунореактивности организма, остеопороза, камнеобразования.

Материал и методы. В нашем отделении в период 2005-2009 гг (включительно) произведено 110 радикальных цистэктомий. По выбору методов дренирования мочи после проведенных 110 радикальных цистэктомий в 3 случаях применена методика «сухой» уростомы, в 10 случаях – двусторонняя уретерокутанеостомия, 27 операций с созданием илеумкондуита по Бриккеру, в 18 наблюдениях нами применена методика ортотопического резервуара по Штудеру и 52 операции по методике Хаутмана.

Около 30% больных (32 пациента) находятся под наблюдением в нашем институте, периодически согласно срокам динамического наблюдения проходят весь перечень обследования. Нами выявлены следующие основные поздние осложнения.

Результаты. После уретерокутанеостомии практически у 100% пациентов развивается восходящий пиелонефрит, бактериурия. При этом более характерна вялотекущая форма пиелонефрита, без яркой клинической симптоматики, но стойкая, трудно поддающаяся противовоспалительной терапии и в динамике в сроки от 6 мес до 1,5-2 лет прогрессирует в ХПН с развитием всей характерной для него картины.

У пациентов с илеумкондуитом по Бриккера также наблюдается восходящий пиелонефрит, периодически с обострениями, но достаточно хорошо поддается противовоспалительной терапии. Кишечные расстройства не столь ярко выражены при соблюдении диеты. Наибольшее количество осложнений здесь обусловлено с погрешностями ухода за стомами, развитие различных местных воспалительных реакций в области стом.

Пациенты с ортотопическим мочевым пузырем составили наибольшую группу наблюдения (18 пациентов). Частота воспалительных осложнений с развитием восходящего пиелонефрита наблюдалось у 95%, примерно у 25% периодически ярко выраженные атаки пиелонефрита, что требовало назначения мощных антибактериальных препаратов. Кишечные расстройства в виде диареи, нарушение водно-электролитного баланса, картины метаболического ацидоза наблюдались примерно в 30%. Около 90% пациентов отмечают дискомфорт в виде недержания мочи по ночам, что требует использования прокладок (1-2 прокладки за ночь). Тем не менее, большинство пациентов удовлетворены наличием у них самостоятельного акта мочеиспускания.

Выводы. Выбор метода деривации мочи зависит от стадии рака мочевого пузыря (РМП), анатомо-физиологических особенностей и функционального состояния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), верхних мочевых путей и почек. При любом из вышеперечисленных методов деривации мочи имеют место различные поздние осложнения. Наиболее предпочтительными являются операции с созданием ортотопического мочевого пузыря и илеумкондуита по Бриккера. Правильно выполненная операция и последующие профилактические мероприятия улучшают качество жизни данных пациентов.

МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ

Полатова Д.Ш.

*Республиканский Онкологический Научный Центр,
Узбекистан, Ташкент*

Задача исследования. определение экспрессии p53 и bcl-2 в опухолевых клетках а также изучение спектра аберраций хромосом в мононуклеарах периферической крови больных с остеогенной саркомой.

Материал и методы. Было проведено обследование цитогенетическим методом 22 пациентов в возрасте от 14 до 20 лет (13 юношей, 9 девушек). Экспрессию белков p53 и bcl-2 изучали с использованием моноклональных антител к p53 (клон ДО-7) «Дако» и к bcl-2 (NCL-bcl-2 -486) «Novocastra». До проведения исследования лечение пациенты не получали.

Результаты. Наличие аберраций хромосом от 9,0 до 19,1% отмечено у всех больных. Цитогенетический анализ типов аберраций хромосом показал наличие видимых делеций хромосомы 22 (22 p-) в 9 случаях (у 6 юношей и 3 девушек), у 2 больных были обнаружены множественные микрофрагменты, у остальных больных (6 юношей и 5 девушек) в кариотипе лимфоцитов стимулированных ФГА, обнаружены делеции 4, 13, 18 и X-хромосом, а также фрагменты различной величины и малые двойные хромосомы. Результаты иммуногистохимического анализа, особенностей экспрессии белков p53 и bcl-2 в опухолевых клетках, свидетельствуют о том, что положительная реакция определялась не во всех клетках, не у всех больных. Белковый продукт мутантного гена апоптоза p53 выявлен в ядрах опухолевых клеток у 15 больных (9 юношей и 6 девушек), в относительных случаях результаты иммуногистохимической реакции были отрицательными. Количество p-53 – положительных опухолевых клеток колебалось от 25 до 50% у 4/6 больных юношей и у всех девушек, а от 50 до 98% у остальных 4/7 юношей. Экспрессия, которая кодирует белок-экспрессор апоптоза, выявлен у 6 больных юношей и 6 девушек. Количество bcl-2-положительных клеток было высоким (до 90%) только у одной больной девушке, а в остальных случаях положительная реакция наблюдалась только в 50% клеток и ниже, при этом реакция на мутантный p53 (mtp53) ген имела отрицательный характер.

Выводы. Потеря хромосомного материала приводит к снижению экспрессии гена или даже к полной потере белкового продукта. Определение спектра молекулярно-генетических повреждений, характерных для остеогенной саркомы позволяет использовать их в качестве маркеров для диагностики и прогноза этого заболевания, а также выработки тактики лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Нургалиев Н.С., Онгарбаев Б.Т., Кенжебаев Б.Ж.
Казахский НИИ ОиР, отделение онкоурологии.*

Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста. За период с конца 1970-х до начала 1990-х годов частота раковых заболеваний предстательной железы почти удвоилась [4]. Согласно последним данным, в 2000 г. в США зарегистрировано 180 400 новых случаев заболевания раком простаты и 31 900 больных скончались от этого заболевания, в Европе — 200 000 и 40 000 соответственно. В структуре онкологических заболеваний в ряде стран РПЖ выходит на 2—3-е место после рака легкого и желудка, а в США и Швеции — на 1-е место. Вместе с тем среди причин смерти мужчин от злокачественных новообразований РПЖ в настоящее время занимает 2-е место после рака легкого. Летальность на первом году жизни после установления диагноза составляет около 30%, что свидетельствует о крайне низкой выявляемости заболевания в начальных его стадиях. По данным канцеррегистра за 2008 год по Республике Казахстан заболеваемость раком предстательной железы составила 3,7 на 100 тыс. человек, смертность 2,1 на 100 тыс. человек. В 2008 году с впервые в жизни установленным диагнозом взято на учет 581 больных раком простаты. Контингент больных на 2008 год составлял 2198 человек. Удельный вес запущенных форм в 2008 году составил 17,7% (больные с IV стадией).

Материалы и методы: В онкоурологическом отделении Каз

НИИ ОиР с 2008 по 2010 год было проведено 22 радикальных простатэктомии. Диагноз локализованного рака простаты был установлен на основании комплексного обследования включающего определение уровня ПСА, ПРИ, УЗИ и трансректальное УЗИ простаты с мультифокальной биопсией, скинтиграфию скелета и МРТ органов малого таза. Уровень колебания ПСА составлял от 8 до 22 нг/мл. Сумма баллов по шкале Глиссон составляла от 3 до 7 баллов. Оперативное вмешательство проводилось из стандартного доступа в объеме радикальной позадилобной простатэктомии.

Результаты лечения: длительность операции составляла от 150 до 240 мин. Кровопотеря составила от 500 до 1500 мл (средний объем около 700 мл). После операции по данным планового гистологического исследования у 3 больных выявлена экстракапсулярная инвазия опухоли предстательной железы – Т3а No Mo, у 1 пациента было выявлено врастание опухоли в семенные пузырьки – Т3NoMo, и 17 пациентов стадия Т2 No Mo. Положительный хирургический край выявлен в одном случае.

Все больные активизировались на 1-2 сутки после операции. У всех больных использовались наркотические анальгетики в течении 2 дней. Уретральный катетер удалялся на 12 сутки после операции. У двух пациентов в раннем послеоперационном периоде отмечалась несостоятельность уретрального анастомоза, в одном случае несостоятельность устранена консервативно после длительного до 20 дней удержания уретрального катетера. В одном случае потребовалось повторное хирургическое вмешательство. У остальных пациентов осложнений не наблюдалось. Сроки наблюдения за больными составляют от 3 до 12 месяцев.

Выводы: В данном наблюдении представлен первый опыт проведения радикальных простатэктомий в нашей клинике. Для увеличения количества радикальных операций необходимо проведение тщательного отбора пациентов, улучшение ранней диагностики рака предстательной железы в общей лечебной сети и внедрение программы скрининга рака предстательной железы в целом по Республике Казахстан.

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ

Сандыбаев М.Н., Зейнелова Л.Т., Жұмықбаева Н.К., Елемесов Н.Н.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері

Академик Н.Н.Петровтың (1947) пікірі бойынша обырдың себептері туралы біз көп білеміз, обырға қарсы күрес мәселесін алдын алу релсіне қою мүмкіндік қана емес, қажеттілік. Бірақ, тұрғындар арасында жүргізілетін обырға қарсы ағартушылық жұмыстар қазақстандағы алдын алу (профилактикалық) жұмыстарды жүзеге асыратын бірден – бір бағыт болып табылады.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады.

Зерттеу мақсаты. Семей өңірінде 2008 -2009 жыл аралығы кезеңдегі обырға қарсы күрестің тиімділігіне зерттеу жүргізу.

Материалдары мен әдістері. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансеріндегі 2008-2009 жыл аралығы кезеңіндегі деректер бойынша қатерлі ісіктерді ерте анықтау және асқынудың статистикалық көрсеткіштеріне салыстырмалы түрде талдау жүргізілді. 2005-2009 жылдар аралығында онкология диспансерінің қызметкерлерімен 79 мақала, 98 теледидардан және радиодан қатерлі ісіктерді алдын-алу мақсаты жөнінде 30 баяндама жасалды.

Қорытынды. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен

бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады. Сонымен, статистикалық талдау деректері негізінде мынадай қорытынды жасауға болады, онкологиялық диспансер мамандары жүргізіп жатқан мазмұны мен түрі жағынан әртүрлі ағартушылық жұмыстар Семей аймағындағы қатерлі ісіктердің ерте анықтауды жақсартуға, онкологиялық аурулардың асқыну жағдайларын төмендетуге және қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың өміршеңдігін ұзартуға қол жеткізуге мүмкіндік туғызды.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САРКОМ КОСТЕЙ ТАЗА

Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А., Косаев А.К., Савхатов Д.Х.
КазНИИОиР, г. Алматы

Первичные злокачественные опухоли костей – группа ЗН, развивающихся из тканей скелета. Первичные ЗН костей наблюдаются редко. В отличие от большинства других распространенных ЗН, злокачественные опухоли костей чаще возникают у лиц молодого возраста (в среднем 28-32 года). Чаще поражаются длинные трубчатые кости и кости таза.

Цель работы: выработка оптимального объема хирургического вмешательства при опухолях тазовой кости.

В отделении опухолей костей и мягких тканей в период с 2000 по 2010 гг. хирургическое лечение проведено 48 пациентам. У всех больных была 111-1У стадия заболевания. У 38 (79,2%) выявлена хондросаркома, у 2 (4,2%) – злокачественная фиброзная гистиоцитома, у 8 (16,6%) – гигантоклеточная опухоль.

Объем хирургического вмешательства был различен и зависел от распространенности опухолевого процесса:

- резекция подвздошной кости проведена 8 (16,6%) пациентам;
- резекция седалищной и лонной кости - 6 (12,5%);
- резекция лонной кости - 2 (4,1%);
- резекция тазовой кости с сохранением н/конечности в 5 (10,4%) случаях;
- межподвздошно-брюшная ампутация у 27 (56,2%) больных.

Послеоперационной летальности не было. У 3 (6,2%) пациентов наблюдался частичный некроз заднего лоскута. После некрэктомии заживление происходило вторичным натяжением. Различные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались у 4 (8,3%) – у лиц старше 60 лет.

После резекции подвздошной и лонной костей, через 2-3 месяца больные самостоятельно ходили без посторонней помощи.

Внутренняя резекция таза, т.е. полное удаление подвздошной, седалищной и лонных костей вместе с головкой бедренной кости, была показана при опухолях образующих безымянную линию, но без распространения на прилегающие мягкие ткани. Через 2-3 месяца больные передвигались с помощью костылей с частичной опорой на конечность. Через 9-12 месяцев больной полностью опирался на конечность и передвигался с помощью трости или ходунков. Отмечено укорочение конечности, в среднем на 5см, при этом движения в коленном и голеностопном суставах полностью сохранены.

Выводы:

1. Объем оперативного вмешательства при опухолях тазовой кости зависит от локализации опухоли, степени распространенности процесса.

2. Внутренняя резекция тазовой кости является операцией выбора, и может выполняться при нераспространенном опухолевом процессе.

3. При правильно спланированной тактике (объема резекции, предоперационной подготовки, подготовленности хирурга) можно значительно уменьшить послеоперационные осложнения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А., Косаев А.К., Савхатов Д.Х.,
Примкулова Р.З.
КазНИИОуР, г. Алматы

Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием. От всех онкологических заболеваний составляет 2%, и 1% в структуре смертности. Наиболее встречаются фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом больных саркомами мягких тканей являются пожилой возраст (старше 60 лет), распространенность опухоли (более 5см), степень ее злокачественности.

Саркомы мягких тканей – злокачественные, агрессивно текущие опухоли, склонные к развитию отдаленных метастазов и локальных рецидивов. Возникновение рецидивов зависит от объема хирургического вмешательства. После иссечения опухоли рецидивы возникают у 80-90% больных, а после широкого иссечения – только у 10-20%. Поэтому, не-радикальное удаление опухоли является одним из факторов неблагоприятного прогноза заболевания и требует скорейшего широкого иссечения опухоли.

Цель работы: выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

За период с 2005 по 2009 годы через отделение опухолей костей и мягких тканей прошло 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Гистотип опухоли был различен, таблица 1.

Назология	Кол- %	Стадия / %	
		III	IV
Фибросаркома	26 / 19,7	24 / 92,3	2 / 7,7
Дерматофибросаркома	20 / 15,1	20 / 100,0	-
Синовиальная саркома	26 / 19,7	25 / 96,1	1 / 4,9
Злокачественная фиброзная гистиоцитома	25 / 18,9	22 / 88,0	3 / 12,0
Липосаркома	19 / 14,4	19 / 100,0	-
Рабдомиосаркома	16 / 12,1	15 / 93,7	1 / 6,3
Всего	132	125 / 94,7	7 / 5,3

Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение:

- Удаление опухоли с резекцией мышц, ребер, перикарда, диафрагмы с пластикой дефекта грудной стенки 12 (9,1);
- Широкое удаление опухоли (фулярное удаление), с пластикой дефекта и без 95 (71,9);
- Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом 2(1,5);
- Межподвздошно-брюшная ампутация 4 (3,0);
- Межлопаточно-грудная ампутация 6 (4,5);
- Экзартикуляция суставов (тазобедренный, плечевой) 5 (3,8);
- Ампутация(н/ в/конечности) 8 (6,1)

Низкий процент осложнений достигнут путем тщательной предоперационной подготовкой, коррекцией сопутствующей патологии, выбора оптимального объема хирургического вмешательства.

Объем хирургического вмешательства зависел от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

СЦИНТИГРАФИЯ СКЕЛЕТА И РАДИОИММУННЫЕ АНАЛИЗЫ ПРИ МЕТАСТАЗАХ БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА

Тажединов И.Т., Хан О.Г., Алпеисова Ш.Т.,
Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Цель исследования – улучшение диагностики патологических изменений в костях у онкологических больных.

Материал и методы: Сцинтиграфия скелета на гамма-камере Philips Forte (Германия) с ^{99m}Tc-технофор проводилась 27 пациентам с метастазами без выявленного первичного очага. Для метки технофора («Радиопрепарат», Узбекистан) использован «Натрий пертехнетат ^{99m}Tc, раствор для инъекции» из переносного гель-генератора, разработанного ИЯФ НЯЦ РК.

Результаты исследования. У 5 мужчин выявлены метастазы в костях таза, позвоночника, ребер в виде гиперфиксации остеотропного РФП. У этих больных уровень ПСА, определенный методом РИА, был высоким (10,0 нг/мл и выше) и составил 71,5±10,1 нг/мл. У трех женщин выявлены очаги в костях с интенсивным накоплением ^{99m}Tc-технофора и опухолевый маркер СА 15-3 был высоким (40,0 МЕ/мл и выше) 101,7±14,3 МЕ/мл.

У одного пациента с выявлением изменений в костях по результатам гистологии биоптата установлен диагноз лимфогранулематоз.

Таким образом, радионуклидные исследования скелета больных с метастазами, без выявленного первичного очага с технофором, меченным «Натрий пертехнетат ^{99m}Tc - раствор для инъекции» из переносного гель-генератора, разработанного ИЯФ НЯЦ РК, позволяют диагностировать наличие патологических изменений в костях, характерных для некоторых опухолей с метастазами в скелет. При этом рекомендуется определить в сыворотке крови специфический антиген предстательной железы ПСА у мужчин, у женщин – СА 15-3, для диагностики опухолей молочной железы.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА.

Букенов А.М., Рахманова Б. А., Мадыкенов Р. О.
Кафедра онкологии, лучевой терапии с курсами общей
хирургии, травматологии и ортопедии ФНПР КГМУ.
Карагандинский областной онкодиспансер.

Причины возникновения несостоятельности швов пищевода различны. Одни [Бондарь Г.В., Байдалин Ю.Д., 1971] хирурги считают основной причиной чрезмерную мобилизацию пищевода, другие [Ганул Л.В., Шевчук А.С., 1979] – снижение репаративной способности ткани пищевода, в связи с гнилостными процессами, развивающимися в пищеводе выше места обтурации. Не менее важным считают уровень резекции пищевода [Кулаевская В.Г., 1980, Странадко Е.Ф., 1980], резекция пищевода на расстоянии близком к опухоли может привести к несостоятельности швов пищевода.

По мнению Русанова А. А. [1973] главной причиной возникновения несостоятельности пищевода являются технические погрешности, допущенные при формировании анастомоза, т.е. недостаточная квалификация хирурга. Поэтому изучение частоты несостоятельности швов пищевода в зависимости от способа наложения анастомоза является одной из актуальных задач клинической онкологии.

Цель исследования – уменьшить частоту несостоятель-

ности швов пищеводного соустья при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы.

Анализируются истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990-2004г.г. Послеоперационная летальность на 287 операций составила $17,1 \pm 2,2\%$ (умерло 49).

Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищеводного соустья $44,8 \pm 5,6\%$ (35 из 287 операций) среди всех осложнений. Летальность при чресплевральном и чрезбрюшинном доступе составила соответственно $23,5 \pm 3,6\%$ (32 из 136 операций) и $11,3 \pm 2,6\%$ (17 на 151 операцию), статистически разница существенна ($p < 0,05$).

Обсуждение результатов.

Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищеводного соустья значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова - Юдина – $13,3 \pm 6,0\%$ (умерло 6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича - Грэхема – $27,3 \pm 7,7\%$ (умерло 9), разница статистически существенна ($p < 0,05$). Значительного снижения летальности не было отмечено при использовании инвагинационного анастомоза с расширяющим швом Блохина, которая составила $24,4 \pm 6,4\%$, разница статистически не достоверна ($p > 0,05$) по сравнению с выше названными способами (из-за небольшого количества наблюдений). Нами разработан способ формирования погружного пищеводного соустья (авт. свидетельство № 45123, авторы Нам Э. Н., Буkenov А. М.). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищеводного соустья сведена до минимума за счет внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г. В. Бондарю отмечено в $5,6 \pm 2,4\%$ (5 осложнений на 90 операций) случаев несостоятельности пищеводного соустья, а среди всех осложнений она составила $33,3 \pm 12,6\%$ (5 случаев на 15 осложнений). Из пяти больных с несостоятельностью пищеводного соустья при муфтообразном анастомозе погибли $3,3 \pm 1,9\%$ (умерло 3) пациента.

Сравнительный анализ частоты несостоятельности пищеводного соустья и ее летальности убеждает нас в правомерности выбора погружного анастомоза при хирургическом лечении рака желудка.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Султаналиев Т.А., Джумабеков А.Т., Жанталинова Н.А., Жораев Т.С.

АГИУВ, кафедра хирургии, Алматы, НЦНМ, Астана РК

Цель. Улучшение результатов расширенной гастрэктомии при распространенном раке желудка (РРЖ).

Введение. Исход хирургического лечения распространенного рака желудка зависит от многих факторов: стадии и гистологического типа опухоли, регионарного и отдаленного метастазирования, уровня поражения лимфоузлов. Основным методом лечения РРЖ является гастрэктомия [Давыдов М.И. и др., 1998; 2002; Черноусов А.Ф. и др. 2000]. Этот вид вмешательства в последние годы возросла до 70% [Жерлов Г.К. и др., 1998; Клименков А.А. и др., 1998]. Неудачные исходы после гастрэктомии чаще всего обусловлены несостоятельностью швов анастомоза. Но в последние годы отмечается снижение летальности до 5-7% [Давыдов М.И. и др., 2002; Земляной А.Г. и др., 1994; Черноусов А.Ф. и др., 2000].

Материал и методы. Представлены результаты хирургического лечения 91 больного в период 1990-2010 г.г. с РРЖ, которым была выполнена гастрэктомия. Из общего числа

больных мужчины составили 79,1%, женщин – 20,9% в возрасте от 35 до 72 лет.

Преобладали больные с проксимальной локализацией опухоли (35,2%) и тела желудка (34,1%), в антральном отделе – 24,2%, поражение двух отделов желудка отмечено у 6 (6,6%) пациентов. По стадиям характеризовались: Т3 – у 68 (74,7%), Т4 – у 23 (25,3%).

По степени дифференцировки опухоли высокодифференцированная аденокарцинома (G1) выявлена в 38 (41,7%) случаях, умеренно-дифференцированная (G2) – в 21 (23,1%), низкодифференцированная (G3) – в 32 (35,2%).

Среди сопутствующих заболеваний преобладала патология сердечно-сосудистой (46,7%) и дыхательной (23,4%) системы.

Результаты. Расширенная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме D2 выполнена у 50,5%, D3 – у 49,5% больных. Во всех случаях проксимального рака желудка и локализации опухоли в теле, а также при поражении нескольких отделов выполнена спленэктомия. Из общего числа оперированных пациентов (91) в 19 (20,9%) случаях ввиду прорастания опухоли в близлежащие органы и структуры выполнены комбинированные операции: резекция печени, поперечнободочной кишки, хвоста и тела поджелудочной железы. Гастрэктомия завершена в 7 (7,7%) случаях наложением пищеводно-дуоденального анастомоза (ПДА) и в остальных 84 (92,3%) наблюдениях выполнен пищеводно-кишечный анастомоз (ПКА) по М.И. Давыдову. У 11 (12,1%) больных рак желудка осложнилось кровотечением и при этом 1 пациента оперировали на высоте кровотечения. Симультантные операции выполнены у 11 (12,1%) больных, при этом у 10 – холецистэктомия и у 1 больного – резекция аневризмы брюшного отдела аорты. В этой группе осложнений не наблюдалось.

В раннем послеоперационном периоде у 5 (5,5%) больных развилась несостоятельность швов анастомоза при этом у 1 пациента с наложенным ПДА, что привело к развитию перитонита и летальному исходу. У остальных 4 пациентов несостоятельность швов носила ограниченный характер и улавливалось оставленным контрольным дренажом, что не потребовало повторного вмешательства. Исход в этих случаях был благоприятный. Внеабдоминальные осложнения наблюдались в 19 случаях, что составило 20,9%, в основном послеоперационные пневмонии (10), экссудативный плеврит (7) и в 2 случаях – инфаркт миокарда с летальным исходом. Общая послеоперационная летальность составила 3,3%.

Выводы. Преимущества методики наложения ПКА по М.И. Давыдову при распространенном раке желудка заключается в надежности, в плане развития несостоятельности швов анастомоза. Таким образом, применение способа ПКА по М.И. Давыдову после гастрэктомии способствует улучшению непосредственных результатов лечения рака желудка.

ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.

Олжаев С.Т., Тельгозин Е.Т.,

Байдилбеков С.А., Зайнидинов Р.Р.

АО «Медицинский университет Астана», г. Астана.

«Алматинский региональный онкологический диспансер»

Актуальность. В повседневной деятельности врачей-хирургов часто возникает необходимость диагностики злокачественных новообразований, распространенность которых с каждым годом увеличивается среди различных контингентов и возрастных групп населения.

Цель. Выявить исходную готовность врачей-хирургов к диагностике злокачественных новообразований, имеет большое практическое значение.

Материал и методы. Проведено социологическое исследование среди врачей-хирургов некоторых регионов Казахстана. Умение правильно поставить диагноз и провести

необходимое лечение злокачественных новообразований.

Результаты. По раку желудка знания в полном объеме продемонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей, соответственно, 23,1%, 13,8%, 15,4%. Неуверенные умения показали 32,3% врачей: города Алматы (10,8%), Алматинской области (6,2%), Южно-Казахстанской и Атырауской (7,7%). Отсутствие этих знаний выявлено у 3,1% респондентов города Алматы. Затруднились ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской области (3,1%).

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут осуществить 64,6% респондентов. Среди них врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской области – 16,9%, Алматинской – 18,3%, Южно-Казахстанской – 21,5%. Недостаточный уровень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город Алматы – 10,8%, Павлодарской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Атырауской, соответственно, 4,6%, 3,1%, 1,5% и 7,7%). 3,1% опрошенных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% опрошенных (по 1,5% врачей города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей).

Что касается рака молочной железы, то при этом заболевании достаточно компетентными были 58,5% опрошенных. В их числе врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (18,5%), Алматинской – 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респондентов, в том числе из города Алматы (9,2%), Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (по 4,6%), Алматинской и Атырауской (по 7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% врачи Алматы и Алматинской области – по 1,5%).

Выводы. Проведенные исследования показывают разный уровень исходной готовности врачей-хирургов к диагностике и лечению злокачественных новообразований. Эти результаты диктуют необходимость проведения среди врачей-хирургов систематических и целенаправленных учебных мероприятий, а также самоподготовки на рабочем месте по вопросам ранней, дифференциальной диагностики и лечения злокачественных новообразований, которые обеспечат лучшее качество плановой хирургической помощи населению.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВОГО АНГИОГЕНЕЗА И ВАСКУЛЯРНОЙ ИНВАЗИИ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ

*Абдулаханова Р.Р., Кожаметов Б.Ш.,
Тлеугабилова Г.А., Есентаева С.Е.
Алматинский государственный институт
совершенствования врачей*

Актуальность. В литературе имеются сообщения о том, что плотность сосудов как мера опухолевого ангиогенеза, имеет важное прогностическое значение для больных раком тела матки (Каки Т. et al, 2000). Авторы обнаружили, что количественная плотность сосудов важна в прогнозе метастазов и выживаемости больных. Плотность микрососудов коррелирует с гистологическим типом опухоли, инвазией в сосуды, в лимфатическую стенку. Больные с большим количеством сосудов (более 60) имели худший прогноз и выживаемость.

Цель работы. Определить влияние опухолевого ангиогенеза на эффективность лечения больных местнораспространенным раком тела матки.

Материалы и методы. В основу работы положены материалы 67 больных раком эндометрия I стадии, прооперированных в Казахском НИИ онкологии и радиологии. Диагноз верифицирован гистологически в 100% случаев. Возраст больных колебался от 30 до 60 лет и старше. Степень васку-

ляризации оценивали по трехбалльной системе:

1. выраженная -- более 10 сосудов в поле зрения;
2. умеренная - от 5 до 10 сосудов в поле зрения;
3. слабая - менее 5 сосудов в поле зрения.

Коэффициент относительного риска (ОР) рассчитывали по формуле, предложенной В.В.Двойриным и В.А.Кашеевым (1980):

$OP = a.c/b.d$, где а и с - числа больных в двух группах, подверженных действию изучаемого фактора, b и d - количество умерших в данных группах. Балльная оценка отдельных признаков производилась на основе расчетов показателей относительного риска по четырехбалльной таблице Стюкениса М.К.(1984).

Результаты и выводы. Результаты исследования позволили сделать заключение, что чаще встречалась умеренная степень инвазии, в 41,8±6,0% случаев, и гораздо реже слабая - в 25,4±5,3% случаев.

При минимальной величине рака выраженная васкуляризация опухоли была обнаружена в (27,3±0,5)% случаев, при распространении опухоли была до 2/3 полости матки - в (45,5±15,0)%, а при поражении всей полости матки - в (18,8±9,8)%. Это позволило заключить, что степень распространения рака в полости матки не связана с выраженностью васкуляризации его стромы.

При сопоставлении выраженности васкуляризации опухоли и степени ее инвазии установлено, что хорошо васкуляризированные опухоли независимо от степени ее инвазии встречались у каждой 3-й больной. Вместе с тем, слабо васкуляризированные опухоли обнаруживались у (45,5±15,0)% при отсутствии инвазии в миометрий. При глубокой инвазии их процент в 2 раза меньше - (25,0±12,5)%, но разница статистически незначима. Иными словами, степень васкуляризации опухоли не влияет на степень ее инвазии в миометрий.

При анализе состояния васкуляризации различных типов рака эндометрия выявлено, что высокая степень васкуляризации характерна для половины низкодифференцированных аденокарцином, примерно такое же количество железисто-плоскоклеточного рака и 100% - серозно-папиллярных раков.

Относительный риск умереть зависит от степени васкуляризации опухоли, подсчитанный на основе теста logrank, при выраженной васкуляризации составляет 1,6, что в 2,5 выше по сравнению со слабой и умеренной васкуляризацией (0,63).

Таким образом, при прогностически неблагоприятных морфологических формах рака (низкодифференцированная аденокарцинома, серозно-папиллярный и железисто-плоскоклеточный раки) эндометрия выраженная васкуляризация стромы наблюдалась довольно часто (50-100%), хотя отмечается низкая корреляция между степенью опухолевого ангиогенеза и эффективностью лечения.

ЭЗОФАГЕАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА

*Жураев Ш.Ш., Шайхиев Е.У., Байтилеуов Т.А.,
Садыков Н.К., Шокебаев А.А., Маметова Т.А.
Национальный Научный Центр Хирургии им. А.Н.
Сызганова, г. Алматы*

По данным Европейской организации противораковых институтов (ОЕЦИ), рак пищевода занимает восьмое место среди всех онкологических заболеваний в Мире. Радикальная хирургическая резекция опухоли, на момент обращения пациентов в стационар, возможна менее чем в половине случаев, вследствие местной распространенности опухолевого процесса либо обширного метастазирования. По этой причине, в лечении пациентов с опухолевой обструкцией пищевода на первый план выходят паллиативные методы.

На сегодняшний день, во многих развитых странах Мира

«золотым» стандартом паллиативного лечения больных с неоперабельными формами рака пищевода признан метод эзофагеального стентирования. Данная технология имеет ряд преимуществ: саморасширяющиеся проволочные стенты можно устанавливать даже при весьма выраженных стриктурах; в силу своих механических свойств, они оказывают постоянное дилатирующее действие на суженный участок пищевода; из-за незначительной толщины и эластичности стенок стентов, возможность их закупорки пищей ничтожна; стенты, покрытые биологически инертными пленками, способны идеально герметизировать просвет пищевода. Все эти качества делают саморасширяющиеся стенты незаменимыми для устранения дисфагии при обтурации просвета пищевода опухолью.

Целью нашей работы явилось внедрить метод эзофагеального стентирования в клиническую практику ННЦХ им. А.Н. Сызганова для устранения синдрома дисфагии онкологического генеза.

В Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова метод эзофагеального стентирования внедрен в практику с 2009 года. За это время, произведена установка 20 эзофагеальных стентов Boubella-E, производства компании «Ella-CS» (Чехия). Специальная конструкция данных стентов практически исключает их миграцию, а, наличие антирефлюксного клапана позволяет предупредить пищеводный рефлюкс. Установка стентов проводилась под рентгенологическим и эндоскопическим контролем, после предварительного бужирования пищевода. При этом, непосредственный технический успех был достигнут в 100% случаев. Серьезных осложнений при проведении стентирования в наших наблюдениях не было. К незначительным можно причислить кровотечение из опухоли малой интенсивности (6 случаев). У всех 20 пациентов была восстановлена возможность к естественному употреблению пищи, что значительно улучшило качество жизни данных больных.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кулишов В.А.

Областной онкологический диспансер, г. Караганда

Актуальность: В Республике Казахстан рак молочной железы возглавляет рейтинг злокачественных опухолей у женщин (17,7%), то есть ежегодно в Казахстане более 2,5 тыс. женщин заболевают этим видом рака. Высокая заболеваемость и выраженная гетерогенность рака молочной железы определяют актуальность реабилитации при этой опухоли.

Реконструкция молочной железы при раке весьма серьезная проблема, позволяющая успешно решать психосоциальную и трудовую реабилитацию больных.

Цель работы: совершенствование реконструктивно-пластических операций у больных раком молочной железы в комплексе с лучевой и химиогормонотерапией, обеспечивающих высокие показатели безрецидивной пятилетней выживаемости, а также ранней реабилитации.

Материалы и методы: Работа основана на анализе результатов лечения 1078 больных, находящихся в отделении общей онкологии «Карагандинского Областного Онкологического диспансера» с 1986 по 2009 гг. с диагнозом: Рак молочной железы. Возраст пациенток был различным. Самой юной было 19 лет и пожилой 78 лет, до 30 лет – 14 (1,4), от 31-40 лет – 115 (11,3), от 41-50 лет – 473 (46,3), от 51-60 лет – 345 (33,8), от 61-70 лет – 50 (4,9), > 70 лет – 24 (2,3). Как видно более высокая заболеваемость была у пациенток до 50 лет (59,8%) – 599, старше 50 лет – 419 (41,2%), средний возраст составил $49,1 \pm 1,3$ случая.

По степени распространенности опухолевого процесса распределение оказалось следующим: I ст. (T1 N0 M0) – 242 (23,7%), T2 – 436 (42,8%), T3 – 338 (33,1%), T4 – 2 (0,2%).

Размеры опухоли колебались от 0,5 до 15 см, но в большинстве случаев (83,8%) составляла от 0,5 – 5 см. Среди гистологических форм наиболее часто встречался дольковый рак в 28,3%. Хирургическое лечение получили – 257 (25,2±1,4%), комбинированное – 471 (46,3±1,5%), комплексное – 293 (28,8±1,4%). Функционально-щадящие операции (Пейти-Диссона, Маддена) – 653 (64,1±8,0%). Органосохраняющие операции (Радикальная резекция молочной железы) – 194 (19,1±1,2%). Реконструктивно-восстановительные маммопластики (первичные и отсроченные) – 171 (16,7±1,2%), из них первичная маммопластика кожно-мышечным лоскутом широчайшей мышцы спины (КМЛ-ШМС) и эндопротезированием с кожносохраняющей мастэктомией выполнена у 27 (15,8%), первичная маммопластика КМЛШМС и эндопротезированием с Радикальной мастэктомией (Пейти, Маддену) – 62 (36,3%). Первичная маммопластика ТРАМ-лоскутом и кожносохраняющей мастэктомией – 6 (3,5%). Первичная маммопластика ТРАМ-лоскутом и радикальная мастэктомия – 54 (31,6%). Отсроченная маммопластика КМЛШМС с эндопротезированием – 22 (12,8%). Отсроченная маммопластика ТРАМ-лоскутом – 3 (1,7%).

В группе функционально-щадящих ранние и поздние осложнения преобладали после операции Пейти, составляя соответственно – 110 (10,8±0,9%) и 104 (10,2±0,9%).

Одногодичная и трехлетняя выживаемость составляет 98,2±0,5% и 78,5±0,6%. Пятилетняя выживаемость пациентов равнялась 65,9±1,8%.

В группе больных, которым выполнены органосохраняющие операции осложнения, составили – 21 (2,1±0,4%). Одногодичная выживаемость составила 100%, трехлетняя 98%, пятилетняя 70%, безрецидивная трехлетняя выживаемость составила 95%, пятилетняя 65%.

В группе больных с реконструктивно-восстановительными маммопластическими ранние осложнения отмечены в 13 (7,6±2,0%) случаях и поздние осложнения у 16 больных, т.е. 9,4±2,2%. Трехлетняя выживаемость составила 72,5±4%, пяти- и десятилетняя выживаемости составили соответственно 64,3±4,5% и 44,4±3,8%.

Таким образом, отдаленные результаты лечения рака молочной железы зависят в основном от степени распространенности опухолевого процесса, а на качество жизни пациенток влияет объем и характер выполненных операций (щадящая мастэктомия, органосохраняющая операция или реконструктивная маммопластика).

ОТДАЛЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ФЕНОТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Малышев Н.В.¹, Тургунов М.Б.¹, Омарова И.М.²,

Кулишов В.А.², Перминов В.С.², Уйсин А.Х.²

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан¹, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан²

Актуальность – использование молекулярной классификации рака молочной железы позволяет индивидуализировать назначение системного лечения и улучшить результаты общей и безрецидивной выживаемости.

Цель исследования – выявление зависимости времени жизни больных раком молочной железы от морфологического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. В данное исследование были включены 313 пациенток раком молочной железы, получавших специальное лечение в Карагандинском областном онкологическом диспансере в 2006 году. Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью иммуногистохимиче-

ского анализа в соответствии с национальными и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль классифицировалась, как ER и/или PR положительная при окрашивании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/neu проводилась по шкале Hercep-Test: 0-1+ - отрицательная экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия.

Все больные разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногистохимических параметров ER, PR, Her-2/neu.

Базальноподобный тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu-) имели 37 больных (1 группа), позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu+) – 41 пациентка (2 группа), люминальный A тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu-) имели 173 больных (3 группа) и люминальный B тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu+) – 62 пациентки (4 группа). Распределение больных по стадиям рака во всех группах было в процентном отношении гомогенным. Используя компьютерную программу «Statistica 5.5» больным всех групп определены средние значения времени жизни и безрецидивного периода, проведено сравнение по Т-критерию Стьюдента и χ^2 . Определена 3-летняя безрецидивная и общая выживаемость больных по таблицам дожития.

Полученные результаты и обсуждение

ИГХ фенотип	Фенотип по Perou	Ср. время без рецидива, мес.*	Ср. время жизни, мес.*	3-летняя безрецидивная выживаемость, %	3-летняя общая выживаемость, %
ER-PR-Her-2/neu-	Базальный	28.5±1.2	31.3±0.9	67.6±4.6	74.3±4.3
ER-PR-Her-2/neu+	Her2/neu+ фенотип	24.5±1.6	28.8±1.3	51.5±6.1	63.2±5.8
ER+PR+Her-2/neu-	Luminal A	31.7±0.9	34.3±0.6	79.0±4.0	90.5±2.9
ER+PR+Her-2/neu+	Luminal B	29.4±1.8	33.4±1.0	68.6±7.8	82.6±6.4

* - время диспансерного наблюдения - 3 года

Безрецидивная выживаемость статистически значимо отличалась у групп 1 и 2 ($p<0.05$), 1 и 3 ($p=0.006$), 2 и 3 ($p=0.00004$), 2 и 4 ($p=0.02$).

Различия по общей выживаемости были достоверны между группами 1 и 2 ($p=0.046$), 1 и 3 ($p=0.04$), 2 и 3 ($p=0.00009$), 2 и 4 ($p=0.05$).

Заключение. Таким образом, полученные результаты показывают, что наличие базального фенотипа и сверхэкспрессия Her2/neu оказывают статистически значимое отрицательное воздействие на общую и безрецидивную выживаемость. Наличие люминального A фенотипа коррелировало с наилучшей выживаемостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

У.С. Мамедов¹, М.А. Гафур-Ахунов².

Республика Узбекистан. Бухарский областной онкологический диспансер¹. Республиканский Онкологический Научный Центр².

Цель: Изучить результаты шейной лимфадиссекции регионарных метастазов шеи с символами N2-3 в комплексном лечении при злокачественных опухолях головы и шеи.

Материалы и методы: В отделении опухолей головы и шеи Бухарского областного онкологического диспансера в период с 2007-2009 года 41 больным с местно-распространенными регионарными метастазами на шее было выполнено различные объемы шейной лимфадиссекции с удалением первичной опухоли. По распространенности первичной опухоли и поражение регионарных метастазов установлено, что T1-4N2M0- 30 больных и T2-4N3M0- 11 больных. Всем больным было проведено предоперационная лучевая терапия на зону регионарного метастазирования и первичной опухоли СОД 40 Гр. и полихимиотерапия по схеме Цисплатин 100 мг. м2+ Фторурацил 1000 мг. 1-4 дни. После проведенного лечения из

них 16 больным произведена операция Крайля и 25 больным фасциально-фуллярное иссечение клетчатки шеи.

Результаты: В сроке наблюдения от 3 до 12 месяцев у 14 больных после проведенного оперативного вмешательства обнаружены рецидивы метастазов. У 8 больных в сроке наблюдения выявлены регионарные метастазы в шейные лимфатические узлы на противоположной стороне поражения. Состояние метастазов оценивалось как N1-2. Этим больным были произведены стандартные лимфаденэктомии.

Выводы: Таким образом, частота рецидивов регионарных метастазов шеи после хирургического лечения за период от 1 года и 3 лет составило 34,1%. Предоперационная химиолучевая терапия не может улучшить показатели выживаемости больных. Для улучшения показателей хирургического метода лечения регионарных метастазов опухолей головы и шеи с символами N2-3 требует новых подходов и модификаций хирургического метода лечения.

УШИВАНИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ СОБСТВЕННЫМИ ТКАНЯМИ С РАЗДЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ ДРЕНИРОВАНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ ПО MADDEN

Танжарыков Е.С.

Городской онкологический диспансер, Алматы

Важной проблемой хирургической онкоматологии является возникновение ранних и поздних осложнений после радикальных мастэктомий (РМЭ). Так,

лимфорея (ЛР) развивается у всех пациентов, которым была проведена РМЭ, впоследствии приводя к развитию воспалительных изменений в области послеоперационной раны, грубых рубцовых изменений в области лимфаденэктомии, постмастэктомического синдрома (ПМЭС).

Цель работы: разработка новой хирургической методики эффективной профилактики ЛР и ПМЭС после РМЭ.

Материал и методы: Основой работы явился анализ 149 больных раком молочной железы (РМЖ) отделения маммологии городского онкологического диспансера, средний возраст которых составил 58 лет. Контрольную группу составили 85 пациенток, которым выполнена РМЭ по Madden, основную – 64 больных, которым была использована новая хирургическая методика – ушивание подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием подмышечной впадины и области передней грудной клетки. Всем больным проводилось измерение длительности и количества выделяемой по дренажам и эвакуируемой пункционно лимфы, оценка развития воспалительных изменений в области послеоперационной раны, болевого синдрома и ПМЭС.

Результаты: В контрольной группе после РМЭ по Madden средний объем (срV) ЛР составил 1653 мл при среднем количестве дней – эвакуаций лимфы (КДЭЛ) – 21 день. После РМЭ по Madden с ушиванием подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием послеоперационной раны срV = 980 мл при КДЭЛ = 13. В контрольной группе ранние раневые осложнения (воспалительные изменения в области послеоперационной раны) после РМЭ по Madden были выявлены у 7 (8%) больных, постмастэктомический отек I-II степени развился у 10 (12%), болевой синдром – у 19 (22%). В основной группе ранние раневые осложнения после РМЭ по Madden отмечены у 3 больных (4,7%), постмастэктомический отек I-II степени – у 5 (7,8%), болевой синдром – у 16 (25%) пациенток.

Выводы: Новая разработанная методика ушивания подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием подмышечной впадины и области

передней грудной клетки показала свою эффективность в профилактике длительной и обильной послеоперационной ЛР и развития ПМЭС у больных РМЖ. Использование новой методики при РМЭ позволило сократить объем и длительность ЛР на 40,7% и 8 дней соответственно, уменьшить раневые осложнения на 3,3%, частоту развития постмастэктомического отека I-II степени на 4,2%. Отмечено увеличение (на 3%) болевого синдрома в основной группе по сравнению с контрольной группой, однако болевой синдром в основной группе был кратковременным и на качество жизни больных в дальнейшем не влиял. Положительные результаты применения новой хирургической методики позволяют рекомендовать ее к широкому применению в хирургических стационарах онкологического профиля.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ.

Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Сахипов М.М., Токсанбаев Д.С., Чорманов А.Т., Миржакыпов А.Т., Баймаханов Ж.Б.

ННЦХ им. А.Н. Сызганова, отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы

Резекция печени остается операцией выбора среди многочисленных хирургических подходов в ведении категории пациентов с различными опухолями печени. Центральным вопросом, определяющим исход оперативного лечения, при резекциях печени, в особенности обширных и предельно обширных, является проблема снижения интраоперационной кровопотери, послеоперационных геморрагических осложнений.

Цель: изучение некоторых принципов кровосбережения при выполнении резекционных вмешательств на печени у больных с опухолевыми и другими очаговыми заболеваниями печени.

Материал и методы: За период с 2004 по 2010гг выполнено 110 резекционных вмешательств на печени по поводу различных ОПП. Размеры очагов варьировали от 4 до 30см в диаметре. Пациенты в возрасте от 2 до 74 лет находились на лечении в отделении хирургии печени, желчных путей, поджелудочной железы ННЦХ им. А.Н. Сызганова.

Использование современного специфического для резекций печени оснащения использовалось у всех больных. В частности, процесс «бескровного» разделения паренхимы печени производили с помощью ультразвукового скальпеля (UltraCision Harmonic Scalpel). В обработке сосудистых структур применяли клипп-аппликаторы с наложением танталовых клипс. Желаемый коагуляционный эффект по резекционной поверхности печени достигался применением потока аргоновой коагуляции и адгезией фибрин-коллагеновой субстанции «ТахоКомб». С целью профилактики больших кровопотерь операции сопровождалась применением приема Прингла (пережатие гепатодуоденальной связки). Восполнение кровопотери при значительных кровотечениях (2 случая) производилось с помощью кровосберегающего оборудования «Секвестр -1000».

Результаты: С применением современных специфических технологий благодаря отработанной технике выделения элементов глиссоновых и кавальных структур в группе больных с анатомическими обширными резекциями без применения приема Прингла удалось достоверно снизить общую операционную кровопотерю с 711 до 375мл.

Вывод: По мере накопления опыта технического исполнения резекционных вмешательств, при условии наличия оснащения операционной специфическим оборудованием и средствами гемостаза выполнение анатомических обширных резекций печени без афферентной сосудистой изоляции представляется тактикой выбора.

ЭВИСЦЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Шукруллаев Ш.А., Абдикаримов М.Г., Вахобов О.У., Гринберг В.В., Болтаев М.И.
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, Ташкент.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 56 больных раком шейки матки в стадии Т4И0-1М0, с прорастанием в мочевого пузыря и с метастазами в регионарные лимфоузлы. Гистологически у всех больных верифицирован плоскоклеточный неороговевающий рак. Основную группу составили 36 больных (64,3%), из них у 12 больных имело наличие пузырно-влагалищного свища (33,3%) и им всем была выполнена передняя эвисцерация органов малого таза с различными методами деривации мочи с 2006 по 2010 годы в урологическом отделении РОНЦ. В 14 случаях выполнена передняя эвисцерация с созданием искусственного мочевого пузыря из восходящей толстой кишки, с аппендикостомией (38,9%). Троем больным за счет уретерогидронефроза (нефункционирующая почка по данным экскреторной урографии) выполнена передняя эвисцерация с односторонней нефрэктомией (8,3%) и уретерокутанеостомией. Десяти больным выполнена эвисцерация с двусторонней уретерокутанеостомией (27,8%). Девяти больным выполнена эвисцерация с созданием мочевого резервуара по Брикеру (25%). Контрольную группу составили 20 (35,7%) больных, ранее получавшие химио и/или лучевую терапию и выписанные на симптоматическую терапию. Из них у 12 имело место явление двустороннего гидронефроза (60%), у 6 наличие одностороннего (30%) гидронефроза и этим больным проводили одно или двухстороннюю перкутанную нефростомию для улучшения качества жизни.

Результаты: В основной группе в раннем послеоперационном периоде одна больная умерла на 12-ые сутки от тромбоза легочной артерии (2,8%). У двух больных основной группы имело место послеоперационная эвентерация передней стенки брюшины, что потребовало хирургической коррекции (5,6%). У одной больной через пять месяцев после операции констатирована спаечная кишечная непроходимость, что также потребовало хирургического вмешательства (2,8%). Трехлетняя выживаемость в контрольной группе составило 10% (2 больных), а в основной группе 86,1% (31 больных).

Выводы: Эвисцерация органов малого таза при осложненном раке шейки матки с созданием мочевого резервуара характеризуется удовлетворительными ближайшими и отдаленными результатами. В результате проведенных нами комплексных лечений у данной категории больных значительно продлилась жизнь (трехлетняя выживаемость 86,1%).

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БОЛЬНЫМ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.

Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Эргашев О.Н., Султонов Б.Б.

Республиканский онкологический научный центр, Ташкент.

Задачи исследования: оценить роль симптоматических операций больным с опухолями органов малого таза, прорастающие в соседние органы.

Материалы исследования. Проанализированы 25 историй болезней больных с опухолями органов малого таза, в стадии Т4И0М0, ранее получавших химио и/или лучевую терапию. Возраст больных колебался от 26 до 70 лет. Из них: 13 больных страдали раком шейки матки (52%), 4 больных раком прямой кишки (16%), 8 больных раком мочевого пузыря (32%), с прорастанием в соседние органы. Возраст больных

колебался от 24 до 72 лет (средний возраст 48 лет). Всем больным была предложена экзистенциальная операция малого таза с различными вариантами деривации мочи, от которой они отказались. В этот период у 22 больных (88%) имело место повышенный уровень мочевины и креатинина в крови (> 8.5 ммоль/л и > 0.115 ммоль/л), у 14 больных (56%) боль в поясничных областях и у 20 анорексия (80%). У 16 больных имела суправезикальная обструкция, (64%), а у 7 инфравезикальная обструкция (28%).

Результаты: После проведения чрезкожной нефростомии и чрезкожной цистостомии выше указанным больным - у 24 мочевины снизилась до уровня нормальных показателей (96%).

Таким образом: у больных с местно-распространенными формами опухолей малого таза, несмотря на имеющиеся осложнения со стороны мочевыделительной системы с нарушением уродинамики, после паллиативных операций выполненных с целью ликвидации явлений уретерогидронефроза и хронической задержки мочеиспускания, улучшилось качество жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Тожибоев А.А., Гафур-Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г.
РОНЦ МЗ РУз, г. Ташкент

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения гигантоклеточной опухоли трубчатых костей с использованием медицинского костного цемента.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 89 больных, с диагнозом гигантоклеточной опухоли трубчатых костей, которым при хирургическом лечении использовали медицинский костный цемент. Мужчин – 35(39,3%), женщин – 54(59,7%). Возраст больных колебался от 14 до 60 лет. В 28(31,5%) случаях опухоль локализовалась в бедренной, в 34(38,2%) – большеберцовой, в 6(6,7%) – плечевой, в 1(1,1%) – локтевой, в 7(7,9%) – лучевой, в 13(14,6%) – фаланги пальцев. Во всех случаях диагноз верифицирован гистологическим исследованием. У 14(15,7%) выявлен злокачественный и у 75(84,3%) – доброкачественный вариант гигантоклеточной опухоли. Рентгенологически у 51 больного (57,4%) выявлена ячеисто-трабекулярная, у 19(21,3%) – остеолитическая и у 19(21,3%) – смешанная форма опухоли. Размер поражения кости составил от 2 до 12 см. У 75 больных поражение было от 1/3 до 1/2 полуокружности кости. Все больные распределены на 3 группы. 1-группа - экскохлеация и цементопластика - 48 больных, 2-я группа - экскохлеация, криовоздействия и цементопластика – 27 больных, 3-я группа - экскохлеация, аутопластика и цементопластика - 14 больных.

Результаты. Больные прослежены от 6 месяцев до 5 лет. Как показали результаты анализа в первой группе больных из 48 больных у 5(10,4%), во 2-группе из 27 больных у 1(3,7%) и в 3-ей группе из 14 больных у 2(14,3%) выявлен рецидив опухоли. Сроки появления рецидивов составили от 6 до 21 месяцев. В связи с рецидивом опухоли у 3(3,4%) больных произведены калечащие операции. У 2 (2,2%) больных отмечен патологический перелом на уровне цементопластики. Из 89 больных у 79(88,7%) получены хорошие функциональные результаты.

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что использование медицинского костного цемента при гигантоклеточных опухолях трубчатых костей, является эффективным методом хирургического лечения больных опухолями костей. Этот вид хирургического лечения менее сложен в исполнении, позволяет замещать большие дефекты костной ткани и экономически доступен большинству онкологических больных.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ НИЗКОЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПОСЛЕ СФИНКТЕРОСБЕРЕГАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Хожаев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Адиев М.М., Баймухаметов К.К., Шапаева У.К., Тасбулатов З.О.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Проблема улучшения качества жизни (КЖ) больных раком прямой кишки (РПК) продолжает оставаться в центре внимания онкологов, что связано с высокой степенью инвалидизации этих пациентов. Это обусловлено анатомо-функциональными нарушениями, неизбежно следующими вследствие оперативных вмешательств.

Цель работы: определение основных показателей КЖ у больных РПК после низких сфинктеросберегающих операций.

Материал и методы. В исследование включено 58 больных раком среднеампулярного отдела прямой кишки II-III стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 гг. Из них 37 больных, которым выполнена низкая передняя резекция прямой кишки (НПРПК) с тотальной мезоректумэктомией, составили основную группу, 21 пациент, которому произведена брюшно-анальная резекция прямой кишки (БАРПК), – контрольную. Инструментом оценки КЖ больных РПК после проведения его языковой и культурной адаптации был модульный опросник Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3) с модулем EORTC QLQ-CR29, содержащий 59 вопросов и состоящий из 5 функциональных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего КЖ, 6 одиночных пунктов, а также 29 вопросов, составляющих специфический модуль EORTC QLQ-CR29.

Результаты. Анализ результатов исследования в основной группе по отношению к контрольной группе показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30, модуль EORTC QLQ-CR29 были выявлены по функциональным шкалам PF (физическое функционирование), RF (ролевое функционирование), EF (эмоциональное функционирование), SF (социальное функционирование) и модульной шкале, отражающей специфические проблемы. Показатели частоты локо-регионарных рецидивов и безрецидивной выживаемости в сравниваемых группах не имела достоверных отличий ($p > 0,05$).

Выводы. Комплексная оценка КЖ больных низколокализованным РПК показала, что в аспекте КЖ больных в послеоперационном периоде НПРПК с тотальной мезоректумэктомией является более предпочтительной операцией по сравнению с БАРПК.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Хожаев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Адиев М.М., Баймухаметов К.К.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Несмотря на разработку сшивающих аппаратов и совершенствование хирургической техники, значительному числу больных колоректальным раком (КРР) на сегодняшний день формируется искусственный абдоминальный задний проход, что обусловлено как распространенностью, так и осложнениями самого опухолевого процесса. Восстановление целостности кишечного тракта является основным и определяющим этапом в комплексе реабилитационных мероприятий у этих пациентов.

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-

ванных больных КРР.

Материал и методы. В исследование включено 48 больных КРР II-III стадий заболевания, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 г.г. и которым ранее в плановом или экстренном порядке были выполнены об-структивные резекции толстой кишки с формированием концевой абдоминальной колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом канале – 9, б) в малом тазу – 23, в) под тазовой брюшиной («короткая культи» прямой кишки) – 16 больных. Из них 13 больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции с использованием механических аппаратных швов, а 35 больным – ручных двух- и однорядных швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза составила 2,1%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью опросника Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функциональных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего КЖ и 6 одиночных пунктов.

Результаты. Сравнительная оценка показателей КЖ больных КРР до восстановительной операции и во всех точках обследования после ликвидации колостомы показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RF), эмоциональное функционирование (EF), социальное функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые затруднения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» составил $85,4 \pm 5,5\%$.

Выводы. Выполнение реконструктивно-восстановительных операций, как хирургического этапа медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу пациентов вернуться к труду.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАКЕ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Эгамбердиев Д.М., Струцкий Л.П., Джуроев Ф.М.

Онкологический научный центр Узбекистана,
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент

Актуальность: Рак желудка в республике Узбекистан, как и во многих государствах, прочно занимает 1 место в структуре онкопатологии. Ежегодно первично регистрируют около 1800 больных с диагнозом рак желудка. Помимо общей мировой тенденции снижения рака антрального отдела желудка, в республике существуют и национальные особенности, где более 60 больным устанавливается рак проксимального отдела желудка с переходом на н/3 пищевода или рак кардиоэзофагеального отдела.

Цель: Улучшить результаты лечения и качество жизни больных нерезектабельным раком кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии.

Материалы и методы: С целью восстановления проходимости пищи по пищеводу в клинике РОНЦ совместно с СЦХ МЗ РУз разработана методика поэтапной эндоскопической электрокоагуляции опухоли пищевода с реканализацией и эндопротезированием. С этой целью после обычной премедикации больным проводится эзофагоскопия и с помощью электрода проведенного через биопсийное отверстие проводится коагуляция опухоли. Чтобы открыть проходимость понадобится 3-4 сеанса с интервалом 2-3 дня. После восстановления проходимости и реканализации по конфигурации кардиоэзофагеальной зоны изготавливается соответствующий эндопротез из искусственного материала с учетом протяженности по 2 см выше и ниже процесса, и устанавливаются с помощью эндоскопического аппарата. Через час после установки эндопротеза больным разрешается принимать пищу. Исследование проводилось у 36 больных

раком кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии. Мужчин – 32, женщин – 24.

Результаты: Из 56 больных, у 1 больного отмечались сильные боли после установки эндопротеза, что вынудило нас убрать его на 3 сутки. Других осложнений, связанных с эндопротезированием не наблюдалось. Изучение непосредственных результатов через 3 недели и в более отдаленные сроки показали, что у 3 больных в просвете эндопротеза застревал комок твердой пищи, который устранялся после эндоскопической санации. У 55 (98,2%) больных из 56, результаты эндопротезирования по объективным и субъективным данным оценивались на хорошо и отлично, у 1 больного неудовлетворительно.

Вывод: Поэтапная термоэлектрокоагуляция при нерезектабельном раке кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии, является методом выбора, которая быстро устраняет явления дисфагии и улучшает качество жизни больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И., Абдурахимов О.Н.

Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз

Местно-распространенное поражение с прорастанием верхних дыхательных и пищеварительных путей при злокачественных опухолях щитовидной железы является сложной проблемой онкохирургии.

Цель: улучшение результатов лечения местнораспространенного рака щитовидной железы.

Материалы и методы. С 2003 по 2009 год под наблюдением находилось 28 больных в возрасте от 18 до 72 лет. Из 28 больных у 12 (42%) отмечалось явление стеноза верхних дыхательных путей 1-2 ст. и у 6 (21,4%) пациентов дисфагия различной степени. После комплексного обследования до операции установлено прорастание опухоли щитовидной железы в глотку у 3-х (10,7%) пациентов. Прорастание опухоли в трахею у 5(17,8%) пациентов.

16(57%) пациентам проведена химиолучевая терапия с предоперационной целью и через три недели произведены расширенные комбинированные операции. У 12(42,8%) пациентов по жизненным показаниям первым этапом выполнена операция.

Лимфодиссекция, тиреоидэктомия с резекцией стенки гортаноглотки выполнена 5(17,8%) больным, с резекцией стенки трахеи у 16(57%) пациентам, 7(25%) пациентам резекция трахеи и гортани. Из 23 пациентов, которым выполнена резекция верхних дыхательных путей у 19(82,6%) сформирован трахеостом или ларинготрахеостом. Одномоментная пластика стенки глотки выполнена у всех 5 пациентов. Одномоментная пластика верхних дыхательных путей выполнена 4-м пациентам.

Вывод: выполнение радикальных расширенно-комбинированных операций с резекцией пораженных соседних органов улучшает качество жизни и выживаемость пациентов.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Юсупов Б.Ю. Хатамов Ш.Н.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз

Несмотря на достигнутые успехи современной онкохирургии проблема хирургического лечения новообразований основания черепа остается мало изученным.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 7 больных с опухолями основания

черепе оперированных в отделении опухолей головы и шеи РОНЦ г.Ташкент. Из 7 больных, было 3 мужчин, 4 женщин, в возрасте от 19 до 45 лет. Гистологически были верифицированы у 3 больных ангиофиброма, у 2-плоскоклеточный рак и у 2-саркома. Во всех случаях хирургический доступ произведен через верхнечелюстную пазуху. В 5 случаях опухоль удалена радикально, в 2 – произведена циторедуктивная операция. Интраоперационная кровопотеря в 2 случаях достигал до 900мл, гемостаз произведен использованием медицинского цемента. Послеоперационный период у 4 больных протекал гладко, у 2-в послеоперационном периоде наблюдалось массивная ликворея. Ликворею в 1 случае не удалось купировать.

Заключение. Таким образом удаление опухолей основания черепа трансмаксиллярным доступом утяжеляет радикальное удаление опухоли и требует использования различных модификаций комбинированных доступов.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.

Юсупов Б.Ю., Абдурахимов О.Н., Полвонов А.Ч.
РОНЦ МЗ РУз. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценить результаты паротидэктомии и паротидэктомии с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышцы шеи (m.Sternocleidomastoideus и m.Platyzma) при плеоморфной аденоме околоушной слюнной железы.

Материалы и методы. В исследование включены 40 больных (1 группа) которым произведена паротидэктомия и 23 больных (2 группа) которым произведена паротидэктомия с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышц шеи (m.Sternocleidomastoideus и m.Platyzma). У всех больных морфологически верифицирована плеоморфная аденома околоушной слюнной железы. Возраст больных составлял от 5 до 62 лет.

Результаты: В 1 группе послеоперационный период у 11 (27,5%) больных осложнился синдромом Льюси-Фрея (гипергидроз в околоушной области, покраснения, гиперэстезия кожи, боль во время еды), а также парез лицевого нерва наблюдался в периоде от 2 до 6 мес. У больных 2 группы вышеуказанный синдром не наблюдался. Парез лицевого нерва наблюдался в течении 2-4 мес.

Выводы. Оптимальным объемом операции при плеоморфной аденоме околоушной слюнной железы является паротидэктомия с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышцы шеи.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Якубова М.Б., Байназарова А.А., Югай К.В.
Казахский Национальный медицинский университет им. Асфендиярова, г. Алматы, Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Шымкент

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наиболее распространенных опухолей у женщин.

В настоящее время рентгеноэндоваскулярные вмешательства являются важной составляющей в терапии больных с местнораспространенным раком шейки матки и локорегионарными рецидивами заболевания в случаях кровотечения и болевого синдрома. Регионарная химиотерапия является компонентом комбинированного лечения больных с локализованными стадиями заболевания в качестве адъювантной или неоадъювантной терапии.

Целью настоящей работы явилось изучить непосредственные результаты лечения больных с РШМ с применением

методики химиоэмболизации.

Материал и методы. Начиная с июля 2008г. нами на базе областного онкологического диспансера внедрена методика одномоментной болюсной химиоинфузии селективно во внутренние подвздошные артерии (ВПА) с последующей эмболизацией маточных артерий у больных раком шейки матки. Лечение подверглись 22 пациенток в возрасте от 33 до 48 лет. У всех больных была IIa-IIb стадия процесса (T2N0M0 – T2bN0M0). В устья ВПА вводили болюсно химиопрепараты со скоростью 2мл/с. В основном применяли схему FAP (Фторурацил 1гр/м2, Адриобластин 60мг/м2, Цисплатин 80мг/м2). Далее селективно катетеризировали маточную артерию на стороне исследования (слева) и производили эмболизацию гемостатической губкой. После выполнения процедуры эмболизации перемещали в аорту и выполняли катетеризацию второй (правой) ВПА и после инфузии химиопрепаратов эмболизировали маточную артерию. Если необходима одномоментная катетеризация обеих ВПА, производили пункцию и установку катетеров с обеих сторон контра- или ипсилатеральным методом. Из 22 больных повторную процедуру провели 13 больным.

Результаты и их обсуждение. Анализ непосредственных результатов лечения показал эффективность методики у всех 22 больных (100%). У 8 больных было отмечено остановка кровотечения из опухоли шейки матки на следующие сутки после процедуры. У 9 больных отмечено купирование болевого синдрома внизу живота. При контрольном осмотре через 1 месяц у всех больных была отмечена частичная регрессия опухоли с уменьшением опухолевого узла по данным контрольного УЗИ на 40-60%. 10 больных успешно прооперированы (радикальная расширенная гистерэктомия), остальным пациенткам проведен курс лучевой терапии по радикальной программе. Анализ осложнений показал, что в основном осложнения были связаны с проведенной химиотерапией. У 15 больных отмечена тошнота и рвота, у 3 лейкопения 2-3 степени, у 2 анемия 2 степени, которые купировались консервативной терапией. Осложнений связанных с эмболизацией нами не отмечено.

Выводы.

В настоящее время большинством исследователей доказана целесообразность широкого практического применения регионарной химиоинфузии с эмболизацией маточных артерий в лечении больных раком шейки матки. В связи с этим вопрос о ее применении следует рассматривать как один из эффективных методов комбинированного и комплексного лечения больных раком шейки матки. Артериальная эмболизация является малотравматичным и эффективным способом остановки кровотечения из опухоли шейки матки, а также создает дополнительную ишемизацию опухоли, что повышает эффективность непосредственных результатов лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

Мамедов У.С.¹, Гафур-Ахунов М.А.².
Республика Узбекистан. Бухарский областной онкологический диспансер¹. Республиканский Онкологический Научный Центр².

Цель: Изучить результаты шейной лимфадиссекции регионарных метастазов шеи с символами N2-3 в комплексном лечении при злокачественных опухолях головы и шеи.

Материалы и методы: В отделении опухолей головы и шеи Бухарского областного онкологического диспансера в период с 2007-2009 года 41 больным с местно-распространенными регионарными метастазами на шее было выполнено различные объемы шейной лимфадиссекции с удалением первичной опухоли. По распространенности первичной опухоли и поражение регионарных метастазов установлено, что T1-

4N2M0- 30 больных и T2-4N3M0- 11 больных. Всем больным было проведено предоперационная лучевая терапия на зону регионарного метастазирования и первичной опухоли СОД 40 Гр. и полихимиотерапия по схеме Цисплатин 100 мг. м2+ Фторурацил 1000 мг. 1-4 дни. После проведенного лечения из них 16 больным произведена операция Крайля и 25 больным фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи.

Результаты: В сроке наблюдения от 3 до 12 месяцев у 14 больных после проведенного оперативного вмешательства обнаружены рецидивы метастазов. У 8 больных в сроке наблюдения выявлены регионарные метастазы в шейные лим-

фатические узлы на противоположной стороне поражения. Состояние метастазов оценивалось как N1-2. Этим больным были произведены стандартные лимфаденэктомии.

Выводы: Таким образом, частота рецидивов регионарных метастазов шеи после хирургического лечения за период от 1 года и 3 лет составило 34,1%. Предоперационная химиолучевая терапия не может улучшить показатели выживаемости больных. Для улучшения показателей хирургического метода лечения регионарных метастазов опухолей головы и шеи с символами N2-3 требует новых подходов и модификаций хирургического метода лечения.

Химиотерапия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Арзыкулов Ж.А., Кузикеев М.А.,
Избагамбетов Н.А., Смагулова К.К., Лашкул С.В.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Актуальность. В Республике Казахстан ежегодно выявляется более 2000 больных раком ободочной и прямой кишки и, по данным Арзыкулова Ж.А. с соавт. (2009), в структуре онкологической заболеваемости занимает с 6 по 10 ранговое место. По показателям смертности от рака ободочной и прямой кишки занимает соответственно 6 и 7 место.

Цель работы. Целью нашего исследования явилась разработка более эффективного способа предоперационной химиолучевой терапии рака прямой кишки.

Материалы и методы. Больным с местнораспространенными формами рака прямой кишки проводят 3 курса предоперационной химиотерапии по схеме FOLFIRI: иринотекан из расчета 180 мг/м², внутривенно капельно, в 1-й день, в тот же день внутривенно вводится лейковорин из расчета 200мг/м² в течение 2 часов в 1 и 2 день + 5 фторурацил 400 мг/м² болюсно 1,2 день, 5 фторурацил 600мг/м² 24-часовая инфузия. Межкурсовой интервал составляет 14 дней. Параллельно 3 курсу химиотерапии проводится лучевая терапия методом дистанционного облучения РОД-2Гр, 5 фракций в неделю до СОД-50Гр. Проведение сеансов конформной лучевой терапии осуществлялось на линейном ускорителе «Clinac 600C/D». Через 3 недели после окончания химиолучевой терапии (на 65-й день) выполнялось оперативное лечение.

Предлагаемым способом пролечено 10 пациентов. Во всех случаях гистологическая форма опухоли представлена аденокарциномой прямой кишки.

Перед проведением хирургического лечения результат предоперационной химиолучевой терапии оценивался по данным рентгенологического, эндоскопического и морфологического методов исследования, кроме того, изучались побочные эффекты проводимой химиолучевой терапии.

При контрольном рентген-эндоскопическом исследовании прямой кишки установлено, что общий объективный эффект достигнут в 70% случаях (7 б-ых), из них у 1 пациентки достигнута полная регрессия опухоли, частичная резорбция отмечена у 6 больных. Стабилизация процесса прослежена в 3-х случаях (таблица №1).

Таблица №1 Показатели эффективности предоперационной химиолучевой терапии у больных раком прямой кишки

Метод лечения	Степень регрессии опухоли			
	Полная	Частичн.	Стабилизация	Прогрессир.
FOLFIRI + лучевая терапия, n=10	1 (10,0%)	6 (60,0%)	3 (30,0%)	-

В ходе лечения проявление токсичности III-IV степени отмечено не было. Лейкопения I и II степени наблюдалась в 1 и 4 случаях соответственно. Диарея отмечена в 4(40,0%) случаях. В одном случае отмечено появление афтозного стоматита.

Выводы. Таким образом, предлагаемый способ эффективен, позволяет достичь регрессии опухоли в большем проценте случаев, снижая спектр токсических проявлений, улучшить непосредственные и ближайших результаты.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОИНФУЗИЯ В ЧРЕВНЫЙ СТВОЛ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА

Арыбжанов Д.Т., Ганцев Ш.Х.*,
Кулакеев О.К.***, Орманов Н.К., Сабуров А.Р.
*Кафедра онкологии с курсом ИПО Башкирского ГМУ,
г. Уфа, Башкортостан; **Международный Казахско-
Турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан;
Южно-Казахстанский областной онкологический
диспансер, г. Шымкент, Казахстан

В Республике Казахстан заболеваемость раком желудка составляет 19-20 на 100000 населения, в структуре онкопатологии рак желудка занимает четвертое место и составляет 10,3%. Лечение больных раком желудка всегда остается актуальной задачей для онкологов. По данным литературы при применении неоадьювантной химиотерапии частичная регрессия опухоли наступает у 38% больных, частота послеоперационных осложнений снижается в 3 раза. В настоящее время применению регионарной химиотерапии у больных раком желудка открываются более широкие возможности.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных раком желудка путем применения внутриартериальной регионарной химиоинфузии в чревный ствол.

Материал и методы. Нами проанализированы непосредственные результаты комплексного лечения 50 больных раком желудка прошедших лечение в Южно-Казахстанском областном онкологическом диспансере за период 2005-2009гг. Все 50 больных в клинику поступили с первичной опухолью.

Средний возраст составил 58,1 ± 0,8 года. Стадия опухолевого процесса по TNM была следующей: T3N0M0 - 17 (34%) больных, T3N1M0 - 19 (38%) больных и T3N2M0 - 14 (28%) больных. Гистологически у 45 (90,0%) больных выявлена аденокарцинома, у 5 (10,0%) – скirroзный рак. Всем больным первым этапом проведена неоадьювантная внутриартериальная химиоинфузия в чревный ствол по схеме TPF (Таксотер 75мг/м² + Цисплатин 75мг/м² + Фторурацил 1000мг/м² в 1й день) 2 курса с интервалом 28 дней, затем операция. В последующем в зависимости от результатов неоадьювантной химиотерапии больным проводился следующий этап лечения.

Результаты и их обсуждение. Непосредственные результаты показали эффективность лечения после 2 курсов неоадьювантной внутриартериальной регионарной химиоинфузии у 26 (52%) больных: частичная регрессия отмечена у 18 (36%) больных и значительная регрессия процесса отмечена у 8 (16%) больных. Этим больным вторым этапом комплексного лечения проведена радикальная операция – расширенная гастрэктомия с лимфодиссекцией Д2. В 15 (30%) случаях отмечена стабилизация процесса, во время операции у этих больных хирургическое вмешательство завершилось паллиативным удалением опухоли из-за прорастания в соседние органы. В 9 (18%) случаях на фоне проводимого лечения отмечено прогрессирование и диссеминация процесса по брюшине с асцитом, что привело к ухудшению общего состояния больных, и они были выписаны на симптоматическое лечение. Изучение удаленного гистологического материала желудка после операции показало наличие лекарственного патоморфоза 1-2 степени у 12 (24%) больных, патоморфоза 3 степени у 14 (28%). Учитывая результаты гистологического исследования и наличие лечебного патоморфоза всем 26 (52%) больным в течение 1-го месяца после радикальной операции начаты курсы адьювантной химиотерапии по той

же схеме. Всем больным проведены по 4 курса адъювантной химиотерапии.

Заключение. Таким образом, неoadъювантная внутриартериальная регионарная химиоинфузия в чревный ствол при раке желудка по схеме ТРФ (Таксотер 75мг/м² + Цисплатин 75мг/м² + Фторурацил 1000мг/м² в 1й день) оказалась эффективной у 52% больных. При этом всем им удалось провести радикальное хирургическое вмешательство. У всех 52% больных отмечен лечебный патоморфоз 3-4 степени. Данная методика лечения больных раком желудка является методом выбора для повышения операбельности процесса и улучшает непосредственные результаты лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Дуненова Г.А.

ГККП «Городской онкологический диспансер», г.Алматы.

Лечение рецидивного рака шейки матки является сложной задачей практической онкогинекологии. Актуальность обусловлена тем, что в течение 2 лет после успешного лечения первичной опухоли шейки матки вероятность рецидива и метастазирования РШМ в зависимости от стадии по данным разных авторов составляет от 10 до 51%.

Основным способом лечения рецидивов и метастазов рака шейки матки до настоящего времени считалась лучевая терапия. В последнее время многими авторами подтверждена терапевтическая эффективность химиотерапии в лечении РШМ.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния системной химиотерапии при рецидивном и метастатическом раке шейки матки.

Материал и методы. За период с 2007 – 2009 гг в Городском онкологическом диспансере г.Алматы было пролечено 27 пациенток с рецидивами и метастазами рака шейки матки в возрасте от 25 до 67 лет путем применения системной химиотерапии.

Рецидивы и метастазы были диагностированы среди больных раком шейки матки I стадии у 15%, при II стадии – у 37%, III стадии – у 41%, IV стадии – 7%. 33% пациенток ранее получали неoadъювантную химиотерапию.

Рецидивы в культе влагалища отмечены у 19% женщин, поражение параметральной ткани развилось у 22% больных, распространение на тело матки – у 4% пациенток. Прорастание в мочевой пузырь отмечено у 7% больных, в стенку прямой кишки – у 11% пациенток. Метастазы в печень диагностированы в 11% случаях, причем у всех больных отмечалось поражение значительной части печеночной ткани. Метастазы в легкие выявлены у 4% пациенток, в кости таза – у 7% больных. Метастатическое поражение отдаленных лимфатических коллекторов отмечено в 15% случаев.

Всем женщинам было проведено от 2 до 4 курсов химиотерапии по схеме СР, включавшей цисплатин 100 мг/м² 1-й день, и 5-фторурацил 750 мг/м² со 2-го по 5-й дни (внутривенно). После всех курсов ПХТ проводилось УЗ-исследование, КТ или МРТ органов малого таза с целью оценки эффекта лечения.

Результаты лечения. Оценка лечебного эффекта осуществлялась по данным клинического осмотра, УЗИ, показаниям КТ/МРТ, цистоскопии и ректороманоскопии (в зависимости от формы рецидива). Полной регрессии опухоли ни в одном случае рецидивного и метастатического рака шейки матки не отмечено, частичная регрессия наступила у 60% больных, стабилизация – у 28% больных, прогрессирование на фоне полихимиотерапии отмечено у 12% пациенток. 20% больных после окончания курсов ПХТ была проведена противорецидивная лучевая терапия. У больных с частичной регрессией рецидивной опухоли в 62,5% случаев имелась низкодиффе-

ренцированная форма рака шейки матки.

Выводы. Использование химиотерапии в лечении рецидивов и метастазов рака шейки матки с включением платиносодержащих препаратов продемонстрировало положительный терапевтический эффект. Отмечена лекарственная чувствительность при низкодифференцированных формах РШМ, что характерно и для первичного низкодифференцированного рака.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧРЕСКАТЕТЕРНЫХ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ

Арыбжанов Д.Т., Кулакеев О.К., Орманов Н.К.

**МКТУ им. Х.А. Ясави, областной онкологический
диспансер г. Шымкент, Казахстан*

Попытки найти малоинвазивные и эффективные способы терапии опухолевых поражений печени стимулировали разработку и применение методов химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА) и химиоэмболизации печеночной артерии (ХЭПА).

Цель: изучить результаты ХИПА и ХЭПА выполненных 2004-2009гг. в ООД ЮКО.

Материал и методы. Пролечены 70 больных, мужчин 47 (67,1%), женщин 23 (32,9%). Первичный рак печени (РП) 42 (60%), метастатические поражения печени (МПП) 28 (40%). ХИПА выполнена у 50 больных, у 20 больных проведена ХЭПА. У больных РП применили схемы FACE (Фторурацил 1000мг/м², Адриобластин 40 мг/м², Цисплатин 60 мг/м², Этопозид 100 мг/м²) – 16 (38%) больных, схема GF (Гемзар 1000 мг/м², Фторурацил 750мг/м² 1 и 8 день) – 16 больных. При МПП применили схемы ТР (Таксотер 75 мг/м², Цисплатин 75 мг/м²) и FOLFOX (Фторурацил 500мг/м², Оксалиплатин 100мг/м²).

Результаты. У больных РП значительная регрессия отмечена у 2 (4,76%) больных, частичная регрессия у 6 (14,3%), стабилизация процесса у 16 (38%) и прогрессирование процесса отмечено у 8 (19%). Из 42 больных первичным раком печени в сроки от 4 до 8 месяцев после лечения умерло 13 (30,9%) больных. После ХЭПА у 8 из 10 больных отмечена частичная регрессия процесса, которая наблюдается в течении 3-5 месяцев, в настоящее время этим больным в плановом порядке проводится 2-й и 3-й сеанс ХЭПА.

Выводы. Полученные нами данные показали эффективность ХИПА при РП у 19 (45,2%) больных с хорошим качеством жизни. Результаты ХЭПА также обнадеживают, так как после 1 процедуры дает стабилизацию процесса и улучшает качество жизни пациентов.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ РАКА ПОЧКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ

*Арыбжанов Д.Т., Орманов Н.К., Беседин Б.В., Жуматаев Ж.Ж., Умарова К.Р., Суттибаева Р.С., Юсупов А.М.,
Абдурахманов Б.А., Сабирова Ф.А.*

*Южно-Казахстанский областной онкологический
диспансер, г. Шымкент, Казахстан*

Рак почки является одним из наиболее распространенных онкоурологических заболеваний. По данным Южно-Казахстанского областного онкологического диспансера (ООД) ежегодно по ЮКО выявляется 50-55 новых случаев рака почки, к сожалению, из них 12-15% больных обращаются к специалистам уже с наличием метастатических поражений других органов и диссеминацией процесса. Для лечения больных с распространенным раком почек операция не приносит желаемого отдаленного результата, при этом травма операции ухудшает в некотором роде качество жизни пациентов и откладывает сроки начала системной химиоиммуноте-

рапии. В этой связи нами предпринята попытка применения химиоэмболизации опухоли почек с последующей операцией и химиоиммунотерапией у пациентов с распространенным, метастатическим раком почек в условиях ООД ЮКО.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных распространенным раком почки.

Материал и методы: с 2008г. мы имеем опыт лечения 9 больных с распространенным раком почек, которым в плане комбинированного лечения применена чрескатетерная химиоэмболизация опухоли почек. Все больные были в возрасте 55-73 лет. Мужчин – 6, женщин – 3. У всех 9 больных был диагностирован распространенный рак почки T3NxM1, рак правой почки отмечен у 5 больных, рак левой почки у 4 больных. У 4 больных имелись метастазы в костях позвоночника (поясничном и крестцовом отделах) и ребрах, у 4 имелись метастазы в легких, у 1 больной в контралатеральной почке. Общий статус по Карновскому на момент начала лечения у всех 9 больных был оценен выше 80%. Всем больным проведено комбинированное лечение, 4 больным первым этапом произведена масляная химиоэмболизация опухоли почки липиодол 5мл + Адриобластин 50мг с доэмболизацией гемостатической губкой до полной редукции кровотока сосудов, а также паллиативная лучевая терапия с целью купирования болевого синдрома на метастазы позвоночника, суммарная очаговая доза (СОД) 25 Грей. 3 больным удалось произвести селективную эмболизацию сосудов нижнего полюса почечной артерии с частичным сохранением функции пораженной почки. Вторым этапом этим больным проведено 4-6 курсов иммунохимиотерапии Винкристин 2мг 1й и 8й день внутривенно + Роферон 4,5 млн. МЕ подкожно 1-12 дни + терапия Бонефосом 1500мг внутривенно 1й день, затем 1600мг внутрь с 2-го дня постоянно, в течение 1 года. 1 больному этой группы после 6 курсов иммунохимиотерапии применили лечение таблетками Нексавар (Сорафениб) по 400мг внутрь, ежедневно в течение 6 месяцев. 2 больным первым этапом произведена эмболизация почечной артерии с последующей нефрэктомией, с последующим назначением таб. Нексавара 800мг/сут.

Результаты и их обсуждение: При контрольных ангиографиях у 5 пациентов прогрессирования основного процесса в почках не было отмечено. При динамическом наблюдении за вышеуказанными больными у 2 больных в течение 4-5 месяцев в процессе лечения отмечено дальнейшее прогрессирование процесса, и они были направлены на симптоматическое лечение. У 3 больных после комплексного лечения отмечена стабилизация процесса и полное купирование болевого синдрома в позвоночнике, которое продолжалось в течение 12-13 мес. После указанного срока у больных отмечено дальнейшее прогрессирование процесса. 2 больных в настоящее время продолжают лечение.

Выводы. Таким образом, применение чрескатетерной химиоэмболизации в комбинированном лечении больных с распространенным раком почек является альтернативным методом выбора в лечении этой сложной категории пациентов. Предварительные результаты анализа показали, что 50-60% больным этой группы, возможно, получить стабилизацию процесса в течение 1 года с хорошим качеством жизни.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЛИМОНИДИН В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

Наряду с поиском новых противоопухолевых препаратов активно разрабатываются подходы к модификации фармакологических эффектов уже известных лекарственных веществ. Препараты из растительного сырья, обладая широким спектром свойств, могут оказывать действие на различные

звенья онкопатогенеза, а также являться модификаторами химио- и лучевой терапии.

Отечественный фитопрепарат Лимонидин представляет биологически активный комплекс из корней кермека Гмелина, содержит полифлаваны, флавоноиды, полисахариды, витамины, аминокислоты, фенольные кислоты, микроэлементы, получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Разработаны две жидкие лекарственные формы – «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп, выпущенные промышленным способом АО «Химфарм», г. Шымкент. Ранее нами были изучены противоопухолевые свойства субстанции лимоницина и комбинации ее с цитостатиками.

Цель исследования: изучить химиомодифицирующие свойства лекарственных форм фитопрепарата Лимонидин при сочетании с известными цитостатиками.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных крысах (массой 120-160 г) и мышах белых беспородных и линии СВА (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосфамид вводили внутривенно, лимонидин – per os, использовали различные дозы и режимы введения препаратов. Противоопухолевая активность изучена по общепринятой методике на трансплантируемых опухолевых штаммах (опухоль Эрлиха, лимфосаркома Плисса, саркома 45). Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили изменение поведенческой реакции животных, гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

Результаты. Было показано, что лекарственные формы лимоницина не проявляют значимого противоопухолевого действия (торможение роста опухоли от 14,4% до 33,2%), но они не вызывают стимуляцию роста экспериментальных опухолей, что является необходимым условием для модификаторов. При изучении комбинации лимоницина с известными цитостатиками на различных моделях переживаемых опухолей выявлено, что исследуемые лекарственные формы лимоницина увеличивают противоопухолевый эффект 5-фторурацила на 12,4-28,2%, доксорубина – на 8,5-14,4%, циклофосфамида – на 3-23,6%. В токсикологических исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимоницина и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимоницина, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимоницина до и после введения цитостатика. Наблюдается уменьшение гибели животных на 10-30%, при этом отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, нормализация показателя селезеночного коэффициента, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови.

Выводы. Лекарственные формы фитопрепарата из кермека Гмелина - «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп обладают потенцирующим действием при сочетании с цитостатиками (5-фторурацилом, доксорубином, циклофосфамидом) на животных с экспериментальными опухолями, увеличивая противоопухолевый эффект. Применение настойки лимоницина снижает токсическое действие 5-фторурацила и доксорубина.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИМОНИДИНА КАК ПРОТЕКТОРА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О., Чичуа Н.А.,

*Смагулова К.К., Аялбергенова Г.О., Г.Е. Жусупова
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,*

В настоящее время широко проводятся исследования по оптимизации действия противоопухолевых препаратов,

коррекции их токсических проявлений. В этом плане широким спектром свойств обладают растительные препараты. Лимонидин - комплексный препарат получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби из корней кермека Гмелина - *Limonium Gmelinii* (Willd.) сем. *Plumbaginaceae*. Обладает противовоспалительным, противовирусным, гепатопротекторным действием. Две жидкие лекарственные формы - сироп и настойка лимонида производства АО «Химфарм» разрешены Фармкомитетом РК для клинического применения в качестве противовоспалительного средства в гастроэнтерологической практике.

Цель исследования: изучение возможности использования лимонида в качестве протектора, снижающего токсичность химиотерапии.

Материалы и методы. Токсикологические исследования проведены на белых беспородных мышах (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосфамид вводили внутривенно, лимонидин – *per os*. Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

В клиническое исследование вошли 26 больных раком молочной железы, которым проводилось лечение в отделении химиотерапии КазНИИОиР. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа – больные, которым проводилась полихимиотерапия на фоне приема настойки лимонида – основная (14 больных), 2 группа – больные, получавшие стандартные курсы полихимиотерапии - контрольная (12 больных). В схемы лечения входили следующие цитостатики: цисплатин, 5-фторурацил, доксорубин, циклофосфамид.

Результаты. В экспериментальных исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимонида и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика (уменьшение гибели животных на 10-30%, отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови).

Было проанализировано влияние лимонида на частоту токсических проявлений полихимиотерапии со стороны желудочно-кишечного тракта (наличие эметического синдрома) и гематотоксичности. При проведении полихимиотерапии у больных на фоне приема настойки лимонида эметический синдром встречался в 35,7% случаев, в то время как среди пациентов 2-й группы, получивших химиотерапию без лимонида, этот вид осложнения наблюдался гораздо чаще – в 66,7%, то есть применение лимонида у больных во время химиотерапии способствовало снижению гастроинтестинальной токсичности в 1,8 раз по сравнению с контрольной группой. Показатель гематологической токсичности в 1-й группе больных составил 42,9%. Во 2-й группе больных лейкопения наблюдалась у 5 (41,6%) пациентов. Степень токсичности в обеих группах была примерно одинаковой.

Выводы. В условиях эксперимента происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика. Применение лимонида у больных во время химиотерапии способствует снижению гастроинтестинальной токсичности.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Камышов С.В., Юлдашева Н.Ш., Салимова Л.Р.

Республиканский онкологический научный центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Рак шейки матки (РШМ) в настоящее время остается одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Распространенные формы заболевания ухудшают прогноз и требуют использования комбинированных и комплексных методов лечения. У онкологических больных после проведения комплексного противоопухолевого лечения наблюдается иммунодепрессия смешанного генеза, которая обусловлена как исходным дефектом функции иммунного надзора и иммуносупрессивном влиянием клеток опухоли за счет выработки различных субстанций, так и непосредственно химио-лучевым и хирургическим воздействием, которое оказывается мощным фактором, индуцирующим генерализованную иммуносупрессию. В связи с этим, разработка, изучение и внедрение в клиническую практику различных методов иммунотерапии является актуальной проблемой лечения РШМ.

Целью исследования явилось установить эффективность методов экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) у больных РШМ в процессе комбинированной терапии.

Объектом исследования служили больные РШМ стадий T2-3N0-1M0 (II-III клинические стадии), проходившие обследование и лечение в отделении онкогинекологии РОНЦ МЗ РУз с 2001 по 2009 гг. Больные были разделены на следующие группы: 1) получающие ЭИФТ с предварительным плазмаферезом (27 больных); 2) получающие ЭИФТ без плазмафереза (30 больных); 3) контрольная группа без иммунокорректирующей терапии (76 больных). Все больные получали консервативное лечение в рамках стандартов диагностики и лечения РШМ. Показанием к проведению ЭИФТ служили изменения показателей крови (лейкопения 1-3 балла по CTC-NCIC), лимфопения.

У больных РШМ до проведения комбинированного лечения наблюдалась выраженная иммуносупрессия, которая выражалась в снижении количества цитотоксических клеток и увеличении количества супрессорных клеток, следствием чего было снижение показателя иммунорегуляторного индекса.

При проведении курсов химио-лучевой (ХЛТ) терапии у больных контрольной группы отмечалось достоверное снижение количества эритроцитов, лейкоцитов, субпопуляций лимфоцитов с усугублением иммунологического дисбаланса с выраженной иммуносупрессией, ускорение СОЭ, снижение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов, и фагоцитарной активности иммунных клеток. При этом отмечалось снижение уровня IgA и увеличение IgG.

На фоне применения ЭИФТ у больных отмечалась нормализация показателей субпопуляций лимфоцитов, с увеличением иммунорегуляторного индекса и увеличением индекса фагоцитоза. При этом отмечается увеличение числа эритроцитов, лейкоцитов и уменьшение СОЭ. Отмечалась тенденция к нормализации уровня IgA и IgG. В то же время наблюдалось увеличение функционального показателя – индекса фагоцитоза. При этом ЭИФТ с плазмаферезом оказывала более благоприятное действие на гематологические и иммунологические показатели больных.

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном иммуномодулирующем действии метода ЭИФТ, который может с успехом применяться в качестве терапии сопровождения при лечении больных РШМ.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ В КАЧЕСТВЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

*Камышов С.В., Юлдашева Н.Ш., Салимова Л.Р.
Республиканский онкологический научный центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан*

Рак яичников (РЯ) продолжает оставаться четвертой ведущей причиной онкологической смертности среди женщин. Высокая чувствительность большинства эпителиальных неоплазий к широкому спектру противоопухолевых лекарств создает предпосылки для длительного лечения РЯ с помощью химиотерапии (ХТ). Вместе с тем, даже лечение новыми комбинациями препаратов, не всегда оказывается эффективным при патологии, преклонный возраст, иммунодепрессию, усугубляющуюся цитотоксическим РЯ. Онкологические больные, как правило, имеют выраженную сопутствующую воздействием ХТ. Выполнение у них травматичных и объемных хирургических вмешательств может способствовать также развитию гнойно-септических осложнений. Сведения о более благоприятном течении заболевания при сохраненном иммунитете, побуждают многих исследователей к разработке более эффективных схем лечения больных РЯ с включением методов иммунотерапии.

Целью исследования явилось установить эффективность методов экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) у больных РЯ в процессе комбинированной терапии.

Объектом исследования являются больные РЯ стадий Т2-3N0-1M0 (II-III клинические стадии), проходившие обследование и лечение в отделении онкогинекологии РОНЦ МЗ РУз с 2001 по 2009 гг. Больные были разделены на следующие группы: 1) получающие ЭИФТ с предварительным плазмаферезом (43 больных); 2) получающие ЭИФТ без плазмафереза (50 больных); 3) контрольная группа без иммунокорректирующей терапии (104 больных). Все больные получали консервативное лечение в рамках стандартов диагностики и лечения РШМ. Показанием к проведению ЭИФТ служили изменения показателей крови (лейкопения 1-3 балла по CTC-NCIC), лимфопения.

У больных РЯ еще до проведения химиотерапии (ХТ) наблюдались существенные изменения гематологических и иммунологических показателей: выраженная анемия, ускорение СОЭ, снижение количества лейкоцитов, лимфоцитов и их субпопуляций. Цитотоксическое воздействие ХТ приводило к усилению данных нарушений, которое выражалось в достоверном снижении количества Т-лимфоцитов в целом, в большей степени Т-хелперов и Т-киллеров. В то же время, уровень Т-супрессоров был повышенным изначально, и при проведении курсов ХТ, изменялся незначительно.

Проведение ЭИФТ после курсов ХТ сопровождалось значительным увеличением абсолютного числа эозинофилов и моноцитов, общего числа лимфоцитов, наблюдалась активация реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), отражающей функциональную активность Т-клеточного звена иммунной системы. Иммуностимулирующее действие ЭИФТ выразилось в активации преимущественно Т-лимфоцитов-хелперов и реализующего фагоцитарного звена. Наблюдалась тенденция к нормализации показателей, отражающих гуморальный иммунитет (В-лимфоциты, IgA, IgM, IgG). Воздействие на свертывающую систему крови приводило к слабовыраженной активации фибринолитической активно-

сти, не выходящей за пределы диапазона нормы. При этом ЭИФТ с плазмаферезом оказывала более благоприятное действие на гематологические и иммунологические показатели больных.

Таким образом, методика ЭИФТ может быть рекомендована для применения в онкологической практике в качестве сопровождения ХТ у больных РЯ за счет иммуномодулирующего и противовоспалительного действия.

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ТЕРАПИИ ГЕМЦИТАБИНОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.

*Латипова Д.Х., Стуков А.Н., Семиглазова Т.Ю., Филатова Л.В., Гершанович М.Л., Вершинина С.Ф.
ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий,
Санкт-Петербург. ФГУ Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий
Росмедтехнологий, Санкт-Петербург.*

Актуальность. Экссудаты в серозные полости наиболее часто встречаются при метастатическом раке молочной железы, раке легкого, яичников и значительно снижают качество жизни онкологических больных.

Цель исследования. В эксперименте установить эффективность гемцитабина при злокачественных выпотах.

Материал и методы. Исследование проведено на 28 мышах SHR самках с перевитой внутрибрюшинно асцитной опухолью Эрлиха. Мышам подопытной группы через 48 часов после перевивки был введен однократно внутрибрюшинно гемцитабин в дозе 25 мг/кг. Мышам контрольной группы был введен внутрибрюшинно 0,9% раствор натрия хлорида в объеме 0,2 мл на 20 г массы тела мыши.

Результаты. Однократное внутрибрюшинное введение гемцитабина в дозе 25 мг/кг обусловило значительный противоопухолевый эффект без заметного токсического действия. Медиана времени появления асцита у мышей, получивших гемцитабин, оказалась почти в 3 раза больше, чем в контроле (соответственно 16 и 5 дней; $p < 0,01$). К 10 дню после перевивки асцит имелся у 100% мышей в контроле и ни у одной из мышей подопытной группы ($p < 0,025$). Медиана общей выживаемости в контроле составила 24 дня, а при лечении гемцитабином - 31 день ($p < 0,01$).

Выводы. Интраперитонеальное введение гемцитабина оказывает выраженный противоопухолевый эффект у мышей с асцитной опухолью Эрлиха. Полученные предварительные данные позволяют предполагать, что внутриполостные инфузии гемцитабина могут быть эффективными в лечении злокачественных выпотов у онкологических больных.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ОПУХОЛИ ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

*Юлдашева Н.Ш., Наврузова В.С., Ахмедов О.М.,
Умарова Н.А., Камышов С.В.
Республиканский онкологический научный центр,
Узбекистан.*

В последние годы заболевание выявляется все чаще молодом репродуктивном возрасте (60% больных). В настоящее время использование химиотерапии находит все более широкое применение при местнораспространенном РШМ, что улучшает непосредственные и отдаленные результаты лечения. Задачей нашего исследования стала оценка лекарственного патоморфоза при применении неоадьювантной химиотерапии при местнораспространенном РШМ (IIb-IIIa ст.), которая помогла бы на этапе обследования больных РШМ предсказать эффективность дооперационного химиотерапевтического воздействия на опухоль.

Материалы и методы: В настоящей работе проведено патоморфологическое исследование дооперационного биопсического материала и операционных препаратов 84-х пациентов с местнораспространенным РШМ (Ib–IIa ст.). На 1 этапе комплексного лечения проводился курс неoadъювантной эндартериальной регионарной длительной полихимиотерапии (НЭАДПХТ) в режиме: метатрексат–50мг, 5ФУ–1000 мг/м², цисплатин–100 мг/м², на 2 этапе – хирургическое лечение в объеме расширенная гистерэктомия 3 типа (модификация Вертгейма – Мейгса). Гистологически плоскоклеточный ороговевающий и неороговевающий рак диагностирован у 72 пациенток (84,6%), железисто–плоскоклеточный–у 4 (3,9%), аденокарцинома– у 8 (11,5%) больных. Степень лечебного патоморфоза оценивалась по критериям Лавниковой.

Результаты исследований: Лечебный патоморфоз в опухоли разной степени выраженности отмечен у 86,9% больных, метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены у 36% оперированных пациенток. Также изучался степень лечебного патоморфоза в лимфоузлах.

При плоскоклеточным варианте, лечебный патоморфоз 3-4 ст. в опухоли выявлен у 34,2%, в лимфоузлах 50%, при аденокарциноме патоморфоз 2-3 ст. отмечен у 33,3% и полностью отсутствовал в метастатических лимфоузлах. При железисто-плоскоклеточном варианте у 2% пациенток отмечен лечебный патоморфоз 2-3ст в опухоли и метастатических лимфоузлах, при этом в плоскоклеточном компоненте– 3 ст., железистом– 2ст. отмечена прямая зависимость лечебного патоморфоза в лимфатических узлах от лечебного патоморфоза в опухоли ($R>0.6$) ($p<0.05$)

Таким образом, применение НЭАПХТ у больных с местнораспространенным РШМ позволяет добиться лечебного патоморфоза в опухоли 3-4 ст. в 37,8% наблюдениях, в лимфоузлах в 46,2%, что свидетельствует о положительном влиянии химиотерапии на первичные очаги и регионарные метастазы.

ХИМИОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ДИФфуЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ НХЛ

Олимова З.А., Пулатов Д.А., Ибрагимов Ж.М.

РОНЦ МЗ РУз г. Ташкент, директор проф. С.Н.Наврозов

Цель: Провести оценку терапевтической эффективности и токсичности химиотерапии по схеме СНОЕР в сочетании с ИГ у группы пациентов с рецидивом ДКНХЛ. Установлено, что под ИГ противоопухолевой эффект химиотерапевтических агентов значительно повышается.

Методы: В данное исследование были включены 163 пациентов с рецидивом ДКНХЛ, леченных на базе нашего института с 2002 по 2007гг. Лечение проводилось по схеме СНОЕР на фоне ИГ, при которой уровень сахара в крови поддерживался на уровне 22-33 ммоль/л. Гипергликемия создавалась путем внутривенной инфузии 20% глюкозы из расчета 6,0 ммоль/кг/час. Определенный уровень сахара в крови поддерживался в течение 3 часов посредством введения в каждые получасовые интервалы сеанса 20% раствора глюкозы в дозе, равной в среднем 0,66 г/кг. Цитостатические агенты вводились на высоте гипергликемии. Курсы лечения повторялись каждые три недели. В раствор глюкозы инсулин не вводился.

Результаты: Клиническая эффективность лечения при сочетании схемы СНОЕР на фоне ИГ по общей эффективности составила 63,3% из них полная ремиссия (ПР) - у 40 больных и частичная ремиссия(ЧР) - у 64. Время медианы достижения ПР было после четырех курсов. Длительность медианы ПР была 21 месяца. Длительность медианы ЧР была 9 месяцев. Среди пациентов с ПР у 26 развилось раннее прогрессирование болезни (в течение 9 месяцев), у 6 больных в течение 1 месяца было прекращено лечение по

схеме СНОЕР на фоне ИГ, 13 больных продолжали получать лечение по этой схеме и у 7 приостановили лечение после четырех курсов. У 23больных из этих 26 пациентов болезнь стабилизировалась. Три умерли от прогрессирования лимфомы в течение 6 месяцев. Только 19 пациентов не достигли ЧР. Длительность безрецидивного выживания составила 20мес, общая выживаемость 34 мес.

Выводы: Применением режима СНОЕР на фоне ИГ мы достигли высоких показателей ответа в группе пациентов с рецидивом ДКНХЛ. ИГ не усиливает токсичности лечения, частоту побочных эффектов и улучшает качество жизни.

ХИМИОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ДИФфуЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ НХЛ

Олимова З.А., Пулатов Д.А., Ибрагимов Ж.М.

РОНЦ МЗ РУз г. Ташкент, директор проф. С.Н.Наврозов

Цель: Провести оценку терапевтической эффективности и токсичности химиотерапии по схеме СНОЕР в сочетании с ИГ у группы пациентов с рецидивом ДКНХЛ. Установлено, что под ИГ противоопухолевой эффект химиотерапевтических агентов значительно повышается.

Методы: В данное исследование были включены 163 пациентов с рецидивом ДКНХЛ, леченных на базе нашего института с 2002 по 2007гг. Лечение проводилось по схеме СНОЕР на фоне ИГ, при которой уровень сахара в крови поддерживался на уровне 22-33 ммоль/л. Гипергликемия создавалась путем внутривенной инфузии 20% глюкозы из расчета 6,0 ммоль/кг/час. Определенный уровень сахара в крови поддерживался в течение 3 часов посредством введения в каждые получасовые интервалы сеанса 20% раствора глюкозы в дозе, равной в среднем 0,66 г/кг. Цитостатические агенты вводились на высоте гипергликемии. Курсы лечения повторялись каждые три недели. В раствор глюкозы инсулин не вводился.

Результаты: Клиническая эффективность лечения при сочетании схемы СНОЕР на фоне ИГ по общей эффективности составила 63,3% из них полная ремиссия (ПР) - у 40 больных и частичная ремиссия(ЧР) - у 64. Время медианы достижения ПР было после четырех курсов. Длительность медианы ПР была 21 месяца. Длительность медианы ЧР была 9 месяцев. Среди пациентов с ПР у 26 развилось раннее прогрессирование болезни (в течение 9 месяцев), у 6 больных в течение 1 месяца было прекращено лечение по схеме СНОЕР на фоне ИГ, 13 больных продолжали получать лечение по этой схеме и у 7 приостановили лечение после четырех курсов. У 23больных из этих 26 пациентов болезнь стабилизировалась. Три умерли от прогрессирования лимфомы в течение 6 месяцев. Только 19 пациентов не достигли ЧР. Длительность безрецидивного выживания составила 20мес, общая выживаемость 34 мес.

Выводы: Применением режима СНОЕР на фоне ИГ мы достигли высоких показателей ответа в группе пациентов с рецидивом ДКНХЛ. ИГ не усиливает токсичности лечения, частоту побочных эффектов и улучшает качество жизни.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАКЕ КОЖИ ВЕК НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЭКОЦИН

Рахматуллаева Д.Т., Усманов Р.Х.

РОНЦ МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан

В последнее время, наряду со стремительным повсеместным ростом частоты опухолей век, отмечается тенденция к увеличению числа случаев с запущенными формами или неадекватно лечеными злокачественными опухолями (Лихванцева В.Г.2007).

Известно, что эта патология ассоциируется не столько кос-

метическими дефектами или с утратой зрительных функций, сколько с ухудшением витального прогноза. Вышеуказанные причины определяют медицинскую и социальную значимость своевременно проводимых лечебных мероприятий, особенно органосохранного характера (Бровкина А.Ф.2002).

Цель: изучение влияния нового противоопухолевого препарата Дэкоцин при раке кожи век II-III стадии.

Материал и методы: С раком кожи век со стадией T2N0M0 местно применяли новый препарат - 3% мазь Дэкоцина в виде монотерапии у 22 (46,8%) больных. В течение 1 месяца больным ежедневно на 16 часов мазали 3% мазь Дэкоцина на область опухоли. Эффект оценивали через 1 месяц лечения, 25 больным (53,2%) со стадией T3N0M0 аппликации 3%ной мази проводили вместе с лучевой терапией. Эффект оценивали непосредственно после лечения и через 1 месяц.

Гистологическая верификация у всех больных – базально-клеточный рак. Возраст больных колебался от 27 до 84 лет. Из них 19 мужчин (40,5%) и 28 женщин (59,5%).

Результаты. У больных, получавших местно препарат Дэкоцин в виде монотерапии, были следующие результаты: у 15 больных наблюдалась полная регрессия (68,2,5%), а у 7 больного наблюдалась частичная регрессия опухоли на 70%, что соответствует 31,8%, что способствовало в дальнейшем для радикального хирургического лечения. У 5 больных (20%), которым проведено-декоцин 3%+ТГТ РОД 2Гр СОД 30 Гр опухоль в 2 случае уменьшилась на 30%, в 3 случае на 50% непосредственно после лечения. Через 1 мес. на 50% и 75% соответственно; 19 больным (76%), которым проведено - декоцин 3%+ТГТ РОД 2,5Гр СОД 30 Гр. Во всех случаях опухоль уменьшилась на 50% непосредственно после лечения. Через 1 месяц у двух больных на 75% и 95%, одному больному проведено лечение с Дэкоцином 4%+ТГТ РОД 2,5 Гр СОД 40 Гр, непосредственно опухоль уменьшилась на 25%, через 1 месяц на 50%, что привело к возможности дальнейшего хирургического лечения больного.

Выводы: при местном применении нового препарата Дэкоцин в лечении рака кожи век выявлен выраженный противоопухолевой эффект, в сочетании с лучевой терапией оптимальной схемой терапии является декоцин 3%+ТГТ РОД 2,5 Гр СОД 30 Гр с последующим хирургическим лечением.

ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРАФУРА В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Саидова К.А., Мансурова Г.Б., Туйджанова Х.Х., Каххаров Ж.Н., Разаков А.Р.
РОНЦ МЗ РУз, г. Ташкент

Основную роль в лечении больных раком шейки матки (РШМ) играют хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Хирургическое лечение является основным методом на ранних стадиях заболевания (IA–IB), в то время как лучевая терапия, сама по себе или в сочетании с оперативным вмешательством, широко используются при лечении местнораспространенного РШМ (IB2–IVA). 5-летняя выживаемость при использовании лучевой терапии достигает 65% и варьирует от 15% до 80% в зависимости от степени распространения опухолевого процесса. Прогрессирование процесса в области малого таза является наиболее частой причиной смерти больных распространенным РШМ.

Для улучшения результатов лучевой терапии с целью радиомодификации мы применяли химиопрепарат Фторафур.

Материалом исследования: составили 65 больных местнораспространенным РШМ. Из них 25 больным проводили лучевую терапию без радиомодификаторов - 1 группа, а 45 – проводили лучевую терапию на фоне Фторафура - 11 группа.

Больным назначался Фторафур по 1 капсуле 2 раза в день и лучевая терапия. Облучение осуществлялся на гамма-

терапевтической установке "Teratron – 780E" фирмы "MDS – nordion" источник Co 60. Лечение проводилась в статическом режиме («бокс-техника»), мультифракционированием, с 4-х полей на весь малый таз: включая опухоль, тело матки и лимфатический коллектор малого таза. РД составляла 1,25Гр 2 раза в день с интервалом 4 часа, до СОД- 50Гр.

Результаты исследования: у больных в первой группе наблюдались выраженная интоксикация, снижение показателей крови и медленная регрессия опухоли.

У больных во второй группе наблюдалась быстрая регрессия опухоли, менее выраженная интоксикация, а также хорошая переносимость препарата.

В дальнейшем рецидивы в этой группе не наблюдались.

Работа по исследованию данного материала продолжается и представляет собой перспективное направление в поиске прогностических факторов эффективного лечения рака шейки матки.

РЕЗУЛЬТАТЫ «LOW STAGING» ТЕРАПИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ И МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫХ ФОРМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Садыкова Н.Ф.

Мангистауский областной онкологический диспансер

Актуальность: Проблема лечения генерализованных или метастатических и местнораспространённых форм мелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ), рака молочных желёз (РМЖ), рака желудка (РЖ) весьма актуальна и, в связи с этим, в последние годы, в клинической онкологии появился новый термин «low staging» терапия (LST).

Цель работы: Определение клинического эффекта LST далеко зашедших форм РЛ, РМЖ, РЖ с использованием современных противоопухолевых химиопрепаратов, таргетной терапии, достижения продления жизни и возможности выполнения циторедуктивных операций.

Материалы, методы и результаты: В течение 2005-2010г. LST проводилась 7 больным с НМРЛ, 7 – с РМЖ и 5 – с РЖ. Среди больных с НМРЛ – у 6 процесс носил местнораспространённый характер и, 1 с метастазами в лёгкие, кости, печень. В двух случаях проводилась таргетная терапия. Из них - 1 больная получала таргетную терапию тарцевой (эрлотиниб). Длительность наблюдения – 12 месяцев. За время лечения удалось добиться значительного сокращения метастатических очагов в печени, лёгких. Выраженный терапевтический эффект прослеживался в течение 6-7 месяцев. В настоящее время, в связи с отсутствием положительной динамики, переведена на терапию ирессой (гефитиниб). У одного больного, на фоне терапии тарцевой, после короткого периода стабилизации, произошло прогрессирование заболевания. Остальные пациенты получали полихимиотерапию (ПХТ) по схеме GP (гемзар + цисплатин). У одного из них удалось добиться полной регрессии процесса. В двух случаях достигнута частичная регрессия процесса. Один из пациентов отказался от операции. Другому выполнена циторедуктивная операция. В остальных случаях РЛ прогрессировал, несмотря на проводимую ХТ.

Всем больным с местнораспространённым РЖ проводилась ПХТ по схеме таксотер + цисплатин + 5- фторурацил + кальция фолиат. Только у двоих больных наблюдалась значительная регрессия процесса: у 1 больной на 80% (длительность наблюдения 12 месяцев, погибла от метастатического поражения головного мозга), у 1 – на 50% (выполнена циторедуктивная операция в объёме R0). Остальные больные умерли от прогрессирования РЖ.

Всем женщинам с метастатической формой РМЖ проводилась ПХТ по схеме ТХ: таксотер + кселода. У двух больных с метастазами в печень удалось добиться значительного регресса процесса в печени и увеличения срока жизни до

14 и 25 месяцев соответственно. У 3, с метастазами в позвоночник, достигнута регрессия заболевания с улучшением качества жизни. У остальных заболевание прогрессировало на фоне ХТ.

Выводы: Результаты проведенной LST достаточно скромны. Тем не менее, в отдельных случаях запущенных форм РЛ, РМЖ, РЖ, можно добиться выполнения циторедуктивных операций и значительного удлинения срока жизни путём использования современных противоопухолевых препаратов, таргетной терапии. LST должна стать стандартным лечением в практике клинической онкологии.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЦЕТАКСЕЛА В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННОГО И ДИСSEМИНИРОВАННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКОГО

Булатова А. Б.

Северо-Казахстанский областной онкологический диспансер, г.Петропавловск.

Актуальность. Одной из наиболее частых причин смерти от злокачественных опухолей является рак лёгкого. Основной проблемой остаётся поздняя выявляемость – около 80% больных на момент установления диагноза имеют III-IV стадию.

Рак лёгкого	2008 г	2009 г	7 мес 2010 г
Впервые выявленные	259	252	134
III-IV стадия	203 (78,3%)	197 (78,1%)	102 (76,1%)

Темп снижения за 2008-2009г составил всего 2,2. Кроме того, даже после радикально выполненных операций более чем у половины пациентов возникает либо местный рецидив, либо отдалённые метастазы. Практически все больные на разных этапах нуждаются в лекарственной терапии. За последние десятилетия появился ряд современных химиопрепаратов (таксол, таксотер, навельбин, гемцитабин, ирино-текан), применение которых наряду с производными платины при неоперабельном НМРЛ позволило отнести эту форму рака к опухолям чувствительным к химиотерапии.

Цель. Изучение эффективности комбинации таксотер с цисплатиной у больных с местнораспространенным и диссеминованным немелкоклеточным раком легкого.

Материалы и методы: В исследование включены 19 пациентов в возрасте от 47 до 67 лет (16 мужчин и 3 женщины), с морфологически верифицированным диагнозом (12 с плоскоклеточным, 7 с аденокарциномой различной степени дифференцировки), стадией процесса IIIB – IU. Терапевтический режим введения препаратов: таксотер 75мг/м² + цисплатин 75мг/м² внутривенно 1 день, интервал между курсами 21 день. Всего проведено 78 курсов, от 2 до 6 циклов, среднее число проведенных курсов – 4,1. Перед введением таксотера проводилась пре- и постмедикация дексаметазоном в дозе 8мг, профилактика тошноты и рвоты осетроном 8мг.

Результаты. Полная регрессия опухоли- 5,2% (1), частичная регрессия- 31,5%(6), стабилизация-31,5%(6), прогрессирование-31,5%(6). Объективный лечебный эффект составил 36,7%(7). Однолетняя выживаемость – 36,8% (7).

В процессе лечения отмечены негематологические осложнения (астения, тошнота, рвота) 1-2ст у 42,1%(8), 3ст- 10,5%(2). Тошнота и рвота хорошо корректировались антагонистами 5НТЗ. Гематологические осложнения: лейкопения 1-2ст- 57,8%(11), лейкопения 3ст- 10,5%(2); анемия 1-2ст- 63,1%(12). Коррекция гематологических осложнений проводилась колониестимулирующими факторами(граноцит, нейпоген), эритропоэтинами и препаратами железа.

Выводы. 1. Полученные результаты сопоставимы с

обобщенными литературными данными по эффективности системной химиотерапии у больных с нерезектабельным немелкоклеточным раком лёгкого.

2. Данный режим продемонстрировал приемлемый профиль безопасности, гематологических и негематологических осложнений 3-4ст, требующих отказа от продолжения лечения не наблюдалось.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЩАДЯЩАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ

Адилбаев Г.Б., Кыдырбаева Г.Ж., Турешова А.О., Садыков С.С., Савхатова А.Д., Ким Г.Г., Кайбаров М.Е., Бестембеков С.Т., Ахметов Д.Н., Шипилова В.В.

Использование химиотерапии и лучевой терапии, применяемых одновременно или последовательно, а также сокращение длительности плановых перерывов может быть одним из перспективных направлений в улучшении эффективности лечения больных злокачественными опухолями головы и шеи

Цель исследования: повышение эффективности комплексной терапии местнораспространенного рака головы и шеи путем оптимизации методов химиолучевой терапии.

Материал и методы: лечению подвергнуты 54 больных (Т3,Т4) плоскоклеточным раком верхней челюсти, 19 больных - полости рта и 22 - гортани. Больные раком верхней челюсти были разделены на 2 группы: в 1-й группе первым этапом проводился 2 курса неoadьювантной внутриартериальной регионарной полихимиотерапии по схеме: таксотер – 80мг/м², цисплатин – 100мг/м² с трехнедельным перерывом. Вторым этапом - радиотерапия разнофракционным методом до СОД-60Гр. После трех-четырёх недельного перерыва больные подвергались оперативному лечению в показанном объеме. Во 2-й группе - ВАРПХТ и радиотерапия в уплотненном режиме и хирургическое лечение после трехнедельного перерыва. Всем пациентам с злокачественными опухолями полости рта и гортани проводился 2 курса системной ПХТ препаратами оксалиплатин-130мг/м² внутривенно, перорально кселода 2000мг/м² с 1-14день с 3х недельным интервалом и радиотерапия с разнофракционным методом, СОД 60Грей. После трех-четырёх недельного перерыва больные с остаточными опухолями подвергались оперативному лечению в показанном объеме.

Результаты лечения: После консервативной терапии наиболее лучшие результаты больных раком верхней челюсти получены во второй группе - полная регрессия опухоли достигнута у 29,4% пациентов, частичная -58,8%, без эффекта – 11,7%. В первой группе эти показатели составили соответственно – 16,2%; 67,5% и стабилизация – 17,6%. Несмотря на интенсификации курсов химиолучевой терапии нами не установлены увеличение токсических проявлений противоопухолевой терапии. Негематологическая токсичность химиотерапии проявлялась в виде алопеции у 87,1% больных, умеренно выраженными периферическими нейропатиями в 12,9%.. Гематологическая токсичность 1-11 степени проявилось только у 20,3% пациентов. В данное время оперативному лечению органосохраняющего характера подвергнуты 62,9% пациентов, при этом у четырех больных в послеоперационном материале опухолевых клеток не обнаружено.

Параллельное применение химио-лучевой терапии позволила повысить общий положительный клинический эффект от проведенного лечения до 90,9% больных раком гортани, 84,2% - злокачественными опухолями слизистой оболочки полости рта. При этом 100% регрессия опухоли достигнута у 72,7% больных раком гортани и 63,1% - полости рта., в результате чего больным с остаточными опухолями были выполнены органосохраняющие операции значительно улучшившие качество жизни данных пациентов. При проведении химиолучевого лечения гематологических, нейротоксических

осложнений не наблюдались, в основном зарегистрировались местные радиозопителиты различной степени у 73,7% и токсические проявления в виде тошноты, рвоты, общей слабости зарегистрированы у 12 больных (65,0%) данные осложнения купировались путем проведения дезинтоксикационной, антиэмитической терапии.

Таким образом, одновременное и последовательное применение химио-лучевой терапии, позволяют значительным количествам больных местнораспространенным раком провести органосохраняющее лечение. Исследование продолжается.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АРГЛАБИН В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА

К. Ж. Мусулманбеков¹, В. Б. Сирота¹, А. Х. Досаханов², Н. В. Бочкова³, Е. В. Кострова³, Н. Л. Целикова³

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан¹. Национальный научный медицинский центр МЗ РК, Астана, Казахстан². КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда³

Одним из путей повышения эффективности лучевой терапии является поиск оптимальных режимов распределения дозы во времени и радиомодуляция с помощью применения цитостатиков.

Цель исследования: изучение эффективности применения арглабина при лучевой терапии (ЛТ) больных раком пищевода (РП).

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 79 больных РП. Средний возраст - 63,9 лет, с III стадией рака - (71,4±6,5)%. Из них 30 получали ЛТ классическим фракционированием дозы: по 2 Гр один раз в день, 5 раз в неделю до СОД 60-62 Гр (группа контроля). 49 больных получали ЛТ динамическим фракционированием дозы (ДФ): первые 3 дня РОД - 4,0 Гр, далее методом мультифракционирования: РОД - 1,2 Гр 2 раза в день с интервалом в 4,5 часа до СОД, изоэффективной 64-68 Грей классического фракционирования. Пациенты основной группы методом слепой рандомизации разделены на две подгруппы. Из них 14 больных получали только ЛТ ДФ (I подгруппа). На фоне ЛТ 35 больным основной группы (II подгруппа) перед сеансом вводили внутривенно арглабин из расчета 370 мг/м² 20 дней. Суммарная доза варьировала от 8000 до 14000 мг. Определяли непосредственные и отдаленные результаты: функцию выживания в программе Statistica 5.5 и общую наблюдаемую выживаемость по Е. Kaplan - Р. Meier.

Полученные результаты. Полный клинический ответ в основной группе отмечен у 19 больных (38,7±1,1%), в группе контроля у 3 больных (10,0±5,5%) (p<0,05), положительный клинический ответ соответственно у (69,3±6,6)% и (66,6±8,6)%. Объем опухоли до лечения у больных основной группы (8,32±2,2 см³) в два раза больше, чем у пациентов в контрольной группе (4,18±0,5 см³). В основной группе больных объем опухоли по окончании ЛТ уменьшился в 3,6 раза, через месяц в 5,2 раза, в контрольной группе - в 2,2 и 2,3 раза, соответственно. У пациентов подгруппы I объем опухоли после лечения уменьшился в 3,4 раза (p>0,5), через месяц в 4 раза (p<0,5). У пациентов подгруппы II объем опухоли уменьшился после лечения в 3,7 раза, через месяц после ЛТ в 6 раз (p<0,5). Применение арглабина у больных раком пищевода повышает эффективность ЛТ ДФ на 18,1% и требует дальнейшего изучения.

Одногодичная общая наблюдаемая выживаемость больных раком пищевода основной группы по Е. Kaplan - Р. Meier составила 82%, двухлетняя - 70%, трехлетняя - 50%. В группе контроля одногодичная выживаемость составила 85%, двухлетняя - 56%, трехлетняя - 36%. Функция выживания в основной группе 1-й год равна (99,0±0,01)%, 2 год снижается до (69,8±0,12)%, 3 год - до (41,2±0,17)%. В контрольной группе

- 1-й год опускалась до (84,9±0,09)%, 2-й год - (55,9±0,15)%, 3-й год - (35,6±0,15)% (p<0,001). В I подгруппе больных функция выживания 1-й год варьировала от (96,4±0,05)% до (75,8±0,14)%, 2-й год - (45,2±0,17)%, 3-й год - (26,4±0,14)%. В II подгруппе больных функция выживания на первый год имеет показатель от (97,7±0,03)% до (86,9±0,09)%, 2-й год - (65,2±0,17)%, 3-й год - (35,7±0,21)%. Во II подгруппе больных, получавших ЛТ ДФ дозы с арглабином, функция выживания на первый и второй годы жизни выше на 20%, на третий год - на 9,3% по сравнению с таковой у больных I подгруппы, получавших ЛТ ДФ дозы без арглабина.

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРГЛАБИНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ

Сирота В.Б.¹, Муравлева Л.Е.¹, Бочкова Н.В.², Исакова С.Х.², Крук В.А.²

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан¹, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан²

Интерес исследователей к сесквитерпеновым лактонам вызван их высокой фармакологической активностью: противовоспалительной, антибактериальной, противоязвенной, анти-мутагенной, противоопухолевой, иммуномодулирующей ...

Цель исследования: изучение влияния арглабина на некоторые биохимические показатели крови больных раком пищевода (РП) на фоне лучевой терапии (ЛТ).

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 79 больных РП. Средний возраст - 63,9 лет, с III стадией рака - (71,4±6,5)%. Из них 30 получали ЛТ классическим фракционированием дозы: по 2 Гр один раз в день, 5 раз в неделю до СОД 60-62 Гр (группа контроля). 49 больных получали ЛТ динамическим фракционированием дозы (ДФ): первые 3 дня РОД - 4,0 Гр, далее методом мультифракционирования: РОД - 1,2 Гр 2 раза в день с интервалом в 4,5 часа до СОД, изоэффективной 64-68 Грей классического фракционирования. Пациенты основной группы методом слепой рандомизации разделены на две подгруппы. Из них 14 больных получали только ЛТ ДФ (I подгруппа). На фоне ЛТ 35 больным основной группы (II подгруппа) перед сеансом вводили внутривенно арглабин из расчета 370 мг/м² 20 дней. Суммарная доза варьировала от 8000 до 14000 мг.

Специальные методы исследования включали в себя определение сорбционной емкости эритроцитов (СЕЭ), уровень малонового диальдегида (МДА), одного из стабильных метаболитов оксида азота - нитрит-иона и показатели альбумина.

Полученные результаты. При исследовании биохимических показателей в крови больных РП до лечения выявлено превышение уровня нитрит - иона, снижение содержания альбумина в плазме крови больных РП - на 29% по сравнению с таковыми контроля. В эритроцитах крови больных РП уровень МДА был достоверно выше контроля в 2,6 раза. СЕЭ достоверно превышала контроль на 17%.

В середине лучевого лечения происходит резкое снижение нитрит - ионов в плазме крови больных в 2,2 раза по сравнению с таковым до лечения. После окончания лучевого лечения уровень нитрит - иона был, сопоставим с показателями контроля. В тоже время содержание альбумина в плазме крови больных этой группы на середине и после лечения был ниже контроля.

В середине и после лучевого лечения с арглабином уровень нитрит - иона был ниже такового до лечения и контроля. Содержание альбумина в крови больных этой группы был достоверно ниже контроля на 37% и 52% соответственно. В нашем исследовании у пациентов, получавших ЛТ с арглабином, наблюдали достоверное снижение оксида азота по отношению к контролю и показателям до лечения. Аналогичные данные получены при исследовании МДА.

Следовательно, результаты проведенного исследования

свидетельствуют о том, что включение арглабина в комбинированную терапию больных РП способствует уменьшению содержания нитрит – ионов в плазме крови больных, снижению СЕЭ и уровня МДА. Нормализация данных показателей свидетельствует о снижении эндогенной интоксикации у больных раком пищевода.

Выводы. Применение арглабина на фоне проводимой лучевой терапия динамическим фракционированием дозы способствует достоверному снижению сорбционной емкости эритроцитов с $54,4 \pm 6,2$ до $31,7 \pm 4,5$, уменьшению содержания нитрит – ионов с $6,2 \pm 2,5$ до $3,9 \pm 0,4$ и уровня МДА плазмы крови больных раком пищевода с $15,4 \pm 1,6$ до $7,8 \pm 0,7$.

ОКСАЛИПЛАТИН В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО, МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА(МКРР)

Умерзакова Б.Г.

КГКП» Северо-Казахстанский областной онкодиспансер»
г.Петропавловск

Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак прочно занимает второе- третье место в большинстве экономически развитых стран мира как у мужчин, так и у женщин. В Республике Казахстан рак ободочной кишки занимает девятое, а рак прямой кишки- восьмое ранговые места в структуре онкопатологии. В Северо-Казахстанской области колоректальный рак занимает 5-6 место в структуре онкозаболеваемости, III-IVст регистрируется в 55-61%случаев.

Цель исследования: оценить эффективность и токсичность режима FOLFOX(оксалиплатин, фторурацил, лейковарин) по сравнению с режимом FL(фторурацил, лейковарин) в лечении местнораспространенного, метастатического КРР.

Материал и методы. 20 пациентам с МКРР(III-IVст) проведено 96 курсов химиотерапии по схеме FOLFOX.

При IVст заболевания отдаленные метастазы обнаруживались в основном в печени.

Использовался следующий режим введения: оксалиплатин 85мг/м^2 2-ч инф в 1 д, лейковарин 200мг/м^2 2ч инф 1,2д, фторурацил 400мг/м^2 болюсно, затем 600мг/м^2 22ч инф 1,2д. Интервал между курсами составлял 2 недели.

15 пациентам с МКРР проведено 72 курса ПХТ по схеме FL- Фторурацил 500мг/м^2 1-5д, лейковарин $20-30\text{мг/м}^2$ 1-5д, курсы повторялись с интервалом 3 недели.

Результаты: Объективный эффект в виде частичной регрессии отдаленных метастазов, первичного очага при режиме FOLFOX наблюдался в 55% случаев(у 11пациентов), при режиме FL в 26%(у 4 пациентов)

При проведении химиотерапии по схеме FOLFOX основными побочными эффектами являлись периферическая нейропатия (71%), диарея 2-3ст (5%). Гематологической токсичности не регистрировалось. Редукции дозы препаратов не потребовалось.

При режиме FL основным проявлением токсичности была диарея 2ст в 10%.

Выводы: Полученные результаты указывают на высокую эффективность и безопасность режима FOLFOX при местнораспространенном, метастатическом колоректальном раке, что позволяет реально повысить качество и продолжительность жизни.

ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ ИММУНОТЕРАПИИ

Жумагазин Ж.Д., Абенова М.Т., Ахметова Н.С., Карагулиев М.М., Абишев Б.К.

ГККП «Онкологический диспансер» г. Астана, Казахстан

При рецидивах поверхностного рака мочевого пузыря после терапии БЦЖ альтернативой лечения таким больным

остается радикальная операция. Вместе с тем, из-за некоторых объективных факторов, как тяжелые сопутствующие заболевания, преклонный возраст и т.д., части пациентам проведение цистэктомии крайне рискованно.

Поэтому, поиски профилактики рецидивов поверхностного рака мочевого пузыря после удаления опухоли остаются актуальной проблемой.

Материал для исследований составили 122 больных поверхностным уротелиальным раком мочевого пузыря, которым после ТУР проводилась одноразовое введение химиопрепарата, а спустя две-три недели БЦЖ терапия. Мужчин было 381, тогда как женщин – 41. Средний возраст группы наблюдения составил 67 лет. Время наблюдения 2006-2009гг. Дозы и сроки введения БЦЖ были стандартными: после удаления опухоли через 10-14 дней 100 мг препарата вводился внутривезикулярно 1 раз в неделю, каждые шесть недель. В последующем аналогичные дозы введения БЦЖ продолжались 1 раз в месяц - 9 месяцев, затем 1 раз в два месяца в течение 2 лет.

В случае выявления рецидивов опухоли мочевого пузыря более 2-х раз или прогрессировании роста опухоли лечение БЦЖ прекращались.

Среди наблюдаемой группы рецидивы опухоли мочевого пузыря возникали: через 3 месяца от начала лечения БЦЖ – у 3, через 6 – у 4, через 9 – у 3, через 12 – у 22, через 16 – у 18, через 22 – у 4, через 36 – у 12 больных соответственно.

Таким образом, рецидивы опухоли мочевого пузыря после БЦЖ терапии в течение 3-х лет были отмечены у 66 из 122 пациентов.

В группе больных из 10 человек с рецидивными опухолями мочевого пузыря после БЦЖ терапии лечение было продолжено Митомицином С.

В исследуемой группе женщин было 3, тогда как мужчин – 7. Средний возраст пациентов составил 70,5 лет.

Химиопрепарат препарат Митомицин С применялся через неделю после удаления рецидивной опухоли мочевого пузыря. Цитостатик вводился в виде внутривезикулярных инстилляций по 40 мг один раз в месяц в течение года.

При контрольном обследовании в группе больных после применения Митомицина С рецидивы опухоли мочевого пузыря были выявлены у 2 пациентов через 3 месяца с момента начала химиотерапии, у 1 через 6 месяца, тогда как у 7 из 10 пациентов была отмечена ремиссия заболевания в течение 12 месяцев.

После введения Митомицина С 6 из 10 пациентов отмечали болезненное с резами мочеиспускание, осложнения, которые были купированы уроантисептиками.

Таким образом, эффективность БЦЖ терапии поверхностных опухолей мочевого пузыря при возникновении их рецидивов возможно увеличить применением Митомицина С. Объективность проведенного исследования необходимо подтвердить увеличением количества пациентов и более длительным временем наблюдения за ними.

ВКЛАД ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА КАЗАХСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

Арзыкулов Ж.А., Чингисова Ж.К., Чичуа Н.А.,

Ажмагамбетова А.Е., Утельбаева А.Е.,

Ибрагимова Д.Д., Кожобекова З.А.

Казахский Научно-Исследовательский Институт
Онкологии и Радиологии

Актуальность: в Казахстане ежегодно регистрируется около 30000 новых случаев злокачественных заболеваний. При этом на учете состоит более 130000 больных, из них химиотерапию получает 60%.

Задача исследования: провести анализ работы отделения

дневной стационар за 2010г

Материалы и методы: в исследование были включены медицинские карты пациентов, получивших лечение в условиях дневного стационара КазНИИОиР с 01.02 по 31.08.2010г

Результаты: с момента открытия отделения лечение получило 262 пациента, при этом среднее пребывание больного на койке составило 6,7 дней, что практически в 2 раза меньше среднего пребывания больного в стационарном химиотерапевтическом отделении.

Основной контингент отделения это пациенты с раком молочной железы - 130 (50%) и колоректальным раком 47 (17,9%) госпитализаций за указанные периоды. В отделении также получили лечение пациенты практически со всеми солидными злокачественными заболеваниями. Всем пациентам была проведена химиотерапия согласно современным протоколам лечения, в том числе с включением таргетных препаратов трастузумаб, бевацизумаб, иматиниб. В основном пациенты получили химиотерапию в самостоятельном и адъювантном режимах, более 70% и 20%, соответственно.

У 4 больных достигнута полная регрессия процесса, у 10 - частичная регрессия процесса, в основном отмечалась стабилизация процесса, только у 2 пациентов отмечалось прогрессирование процесса на фоне проводимого лечения. Летальных случаев и IV степени токсичности за указанный период не было.

В связи с большим оборотом койки дневного стационара 90% пациентов получили химиотерапию соблюдением требуемых сроков. Более 10% пациентов продолжали работать.

Заключение: результаты анализа показывают - в настоящее время возможно проведение современных схем химиотерапии в условиях дневного стационара. В связи с ростом числа больных, нуждающихся в проведении химиотерапии, необходимо дальнейшее развитие стационарозамещающей помощи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕНИЕМ ОПУХОЛЕВЫХ ЭМБОЛОВ И СТЕПЕНЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Арзыкулов Ж.А., Чичуа Н.А., Ижанов Е.Б., Утельбаева А.Е., Хамидуллина Г.А., Тохеев З.В., Нурсулейменова М.А., Соколенко Е.Г.

Казахский Научно-Исследовательский Институт Онкологии и Радиологии

Актуальность: в Казахстане ежегодно регистрируется около 3000 новых случаев РЖ. При этом ежегодно умирает более 2200 больных от данной патологии. Радикальным методом лечения РЖ остается хирургический метод, при этом одним из основных прогностических факторов является поражение регионарных лимфатических узлов.

Задача исследования: определить степень взаимосвязи между наличием опухолевых эмболов и поражением лимфатических узлов при раке желудка.

Материалы и методы: в исследование включены результаты патоморфологических заключений по операционному материалу пациентов с РЖ, получивших лечение в КазНИИОиР с 2006 по 2010г.

Результаты: Проанализированы результаты патоморфологического исследования операционного материала 68 пациентов с РЖ. У 10 пациентов (14,7%) отсутствовали метастазы в лимфатические узлы (л/у), при этом в 100% выявлена умереннодифференцированная аденокарцинома, у 30 (44,1%) отмечалось поражение N1 л/у, у 28 (41,2%) - поражение N2 л/у.

У 14 (20,6%) из 68 выявлены опухолевые эмболы, при этом поражение лимфатических узлов наблюдалось в 100%, N1 порядка - в 21,4%, N2 - 78,6%. При выявлении опухолевых эмболов, у 7 (50%) определялась низкодиф. аденокарцинома, у 2 (14,3%) - перстневидноклеточным компонентом, у 4

(28,6%) - умереннодиф. аденокарцинома и в 1 случае (7,1%) - недифференцированная аденокарцинома.

Заключение: результаты показывают высокую вероятность поражения лимфатических узлов при наличии опухолевых эмболов при раке желудка. Таким образом, выявление опухолевых эмболов при раке желудка может служить признаком поражения лимфатических узлов и соответственно определяться как неблагоприятный прогностический фактор.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ РАКА ЖЕЛУДКА С ВКЛЮЧЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ХИМИОПРЕПАРАТОВ

Арзыкулов Ж.А., Чичуа Н.А., Ижанов Е.Б., Утельбаева А.Е. Казахский Научно-Исследовательский Институт Онкологии и Радиологии

Актуальность: в Казахстане ежегодно регистрируется около 3000 новых случаев РЖ. При этом ежегодно умирает более 2200 больных от данной патологии. При раке желудка отмечается высокая частота послеоперационного рецидивирования и метастазирования. В связи с чем идут поиски методов лечения, улучшающих результаты хирургических вмешательств.

Задача исследования: определить эффективность неоадъювантной химиотерапии с включением современных химиопрепаратов

Материалы и методы: В исследование включены пациенты с местно распространенным раком желудка (стадия I-IV, M0). До операции проводилось 3 курса О/С/И (Оксалиплатин 75мг/м² д1, Капецитабин 1000мг/м² д1-14, Иринотекан 160мг/м² д1, каждые 21дн. Объективный ответ оценивался эндоскопическими и рентгенологическими методами исследования. Через 2-3 недели проводилась операция гастрэктомия с ЛД2.

Результаты: были включены 18 пациентов с 01/07 по 12/09 (исследование продолжается). Средний возраст составил 53 года (42-67); мужчины/женщины, 28%/72%; ECOG PS 0/1/2 22%/67%/11%; диффер/недифференцированная аденокарцинома и перстневидноклеточный рак (9/6/3); IIIa (22%), IIIb (50%), IVa (28%). Все пациенты закончили предоперационную химиотерапию и 15 из них были оперированы (3 пациента от оперативного лечения отказались). Токсичность 3 степени: нейтропения 22%, анемия 11%, тошнота 33%, и диарея 33%. Токсичности 4 степени и летальных случаев не было. 2 пациентов достигнуты полные регрессии (11%), у 9 - частичные регрессии (50%), у 7 пациентов - стабилизация процесса (39%).

У 4 (22,2%) пациентов обнаружены опухолевые эмболы, при этом отсутствовало метастатическое поражение лимфатических узлов. В то же время анализ патоморфологических заключений операционного материала 68 пациентов с РЖ без предшествующей химиотерапии показал, что у 14 (20,6%) из 68 присутствовали опухолевые эмболы, при этом поражение лимфатических узлов наблюдалось в 100%, N1 порядка - в 21,4%, N2 - 78,6%.

Заключение: Предварительные результаты по исследованию показали клиническую эффективность без лимитирующей токсичности, и требуют дальнейшего проведения исследования в данном направлении.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ КАПЕЦИТАБИНА ДИСSEМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) С УЧЕТОМ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Чичуа Н.А., Есентаева С.Е., Смагулова К.К., Туманова А.К. Казахский НИИ онкологии и радиологии

Диссемированный РМЖ остается неизлечимым заболеванием, медиана выживаемости пациентов после выявления

метастазов составляет примерно 2 года. Поэтому проводимая терапия должна быть направлена на уменьшении симптомов заболевания, поддержание качества жизни и увеличение выживаемости пациенток.

Идентификация иммуногистохимических маркеров, отражающие функциональное состояние опухолевых клеток, имеют важное значение в оценке особенностей течения и исхода онкологических заболеваний.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 2005 по 2008г.г. В представленной работе было включено 49 пациенток РМЖ с генерализацией процесса после ранее проведенного лечения (ФАК, СМФ). Во всех случаях были проведены иммуногистохимические исследования с определением уровня рецепторов стероидных гормонов, с-erbB-2. Возраст больных колебался от 25 до 67 лет, средний возраст составил 46 лет

Все больные были разделены на 2 группы: в 1 группе проводилось лечение по схеме винорельбин – 30 мг/м² 1,8 дни, кселода 2000 мг/м² 1-14 дни – 27 больных, 2 группе - доцетаксел 75 мг/м² 1 день, кселода 2000 мг/м² 1-14 дни – 22 больных. Результаты лечения оценивались после проведения 4-5 курсов химиотерапии.

В 17 случаях (10 больным 1 группы и 7 больным -2 группы) с гиперэкспрессией с-erbB-2 (3+) в лечение был включен герцептин в режиме: 4 мг/кг веса при первом введении, затем по 2 мг/м² еженедельно.

У 26 пациенток отмечались положительные эстроген- и прогестероновые рецепторы. Этой группе больных после химиотерапии проводилась гормонотерапия тамоксифеном или летрозолом.

При проведении второй линии химиотерапии объективный эффект в 1 группе составил- 37%, во II- 40%.

При изучении побочных эффектов установлено, что у больных 1 группы лейкопения отмечалась у 22 (81,5%) больных, причем в 22,7% случаев - IY степени, у больных II группы лейкопения встречалась у 17 (77,3%) пациенток, но оценивалась в основном II степенью токсичности. У 7(22,2%) больных 1 группы наблюдался «ладонно-подошвенный» синдром.

Время до прогрессирования процесса в 1 группе составило- 8 месяцев, во второй – 9,2 месяца. Годичная выживаемость в 1 группе составила 59,2%, а во второй – 63,6%. Из 17 больных с гиперэкспрессией (+3), получивших лечение герцептином, в настоящее время живы 14 (82,3%) пациенток со сроком наблюдения 22 месяцев.

Таким образом, применение химиотерапии навельбин+кселода и таксотер+ кселода позволяет получить объективный эффект у 37-40% больных соответственно. Применение герцептина у больных с высокой экспрессией с-erbB-2 способствует увеличению сроков времени до прогрессирования процесса.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОСТАТИКОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Шуканова Н.А., Путырский Л.А.,

Мартынова М.А., Козловская Н.А.

ГНУ "Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси", Минск, Беларусь, ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова", МЗ РБ, Минск, Беларусь

Актуальность проблемы: Проведение химиотерапии при заболеваниях раком молочной железы (РМЖ) в 25-50% случаях не имеет эффекта. Необходимо выработать критерии индивидуальной чувствительности опухоли к цитостатикам до начала лечения.

Материал и методы: исследовано влияние цитостатиков

схем СМФ и АС на активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в первичной культуре опухолевых клеток, полученных из операционного материала 40 больных раком молочной железы, инкубированной в течение 48 ч в питательной среде RPMI 1640, в присутствии цитостатиков и без них. Сравнивались два биохимических параметра, позволяющих оценить влияние химиопрепаратов на клетки РМЖ: активности АХЭ и активности дегидрогеназ (МТТ-тест). При воздействии обеих групп препаратов наблюдалось однонаправленное изменение активности исследованных ферментов,

В основной и контрольной группах оценивали активность АХЭ и дегидрогеназ. При активности указанных показателей в основной группе (с химиопрепаратами) ниже, чем в контрольной, считалось, что опухолевые клетки чувствительны к данным цитостатикам, при равной активности – резистентны.

Результаты: В 34 (80%) случаях наблюдалась полная корреляция показателей пролиферативной активности опухолевых клеток (снижение активности ферментов АХЭ и дегидрогеназ при культивировании с цитостатиками) с хорошими клиническими показателями выживаемости.

У 6 больных (20%) культивирование клеток в присутствии химиопрепаратов приводило к увеличению числа активно пролиферирующих опухолевых клеток что свидетельствовало о резистентности клеток к исследуемым цитостатикам. У этих пациенток наблюдался возврат заболевания в течение года.

Выводы: 1.Активность митохондриальных дегидрогеназ и активность АХЭ могут служить критериями оценки способности злокачественно трансформированных клеток к бесконтрольному делению и чувствительности опухолевых клеток к действию химиопрепаратов.

2.Выявленная корреляция между количеством активно пролиферирующих опухолевых клеток в первичной культуре и активностью АХЭ может быть положена в основу разработки относительно простого, быстрого и недорогого биохимического метода определения индивидуальной чувствительности данных клеток к цитостатикам в условиях in vitro.

ОКСАЛИПЛАТИН В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО, МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА (МКРР)

Умерзакова Б.Г.

Северо-Казахстанский областной онкодиспансер

Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак прочно занимает второе- третье место в большинстве экономически развитых стран мира как у мужчин, так и у женщин. В Республике Казахстан рак ободочной кишки занимает девятое, а рак прямой кишки- восьмое ранговые места в структуре онкопатологии. В Северо-Казахстанской области колоректальный рак занимает 5-6 место в структуре онкозаболеваемости, III-IVст регистрируется в55-61%случаев.

Цель исследования:

оценить эффективность и токсичность режима FOLFOX(оксалиплатин, фторурацил, лейковарин) по сравнению с режимом FL(фторурацил, лейковарин) в лечении местнораспространенного, метастатического КРР.

Материал и методы. 20 пациентам с МКРР (III-IVст) проведено 96 курсов химиотерапии по схеме FOLFOX.

При IVст заболевания отдаленные метастазы обнаруживались в основном в печени.

Использовался следующий режим введения: оксалиплатин 85мг/м² 2-ч инф в 1 д, лейковарин 200мг/м² 2ч инф 1,2д, фторурацил 400мг/м² болюсно, затем 600мг/м² 22ч инф 1,2д. Интервал между курсами составлял 2 недели.

15 пациентам с МКРР прведено 72 курса ПХТ по схеме FL- Фторурацил 500мг/м² 1-5д, лейковарин 20-30мг/м² 1-5д, курсы повторялись с интервалом 3 недели.

Результаты: Объективный эффект в виде частичной регрессии отдаленных метастазов, первичного очага при режиме FOLFOX наблюдался в 55% случаев (у 11 пациентов), при режиме FL в 26% (у 4 пациентов)

При проведении химиотерапии по схеме FOLFOX основными побочными эффектами являлись периферическая нейропатия (71%), диарея 2-3 ст (5%). Гематологической токсичности не регистрировалось. Редукции дозы препаратов не потребовалось.

При режиме FL основным проявлением токсичности была диарея 2 ст в 10%.

Выводы: Полученные результаты указывают на высокую эффективность и безопасность режима FOLFOX при при местнораспространенном, метастатическом колоректальном раке, что позволяет реально повысить качество и продолжительность жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ХОРИОНКАРЦИНОМЫ МАТКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

*Юлдашева Н.Ш., Умарова Н.А.,
Наврзуова В.С., Ахмедов О.М.*

*Республиканский онкологический научный центр,
Узбекистан.*

В последние десятилетия в лечении различных заболеваний опухолевой и неопухолевой природы, осложненных кровотечением, для остановки последней, а также коррекции нарушений функции органов широкое распространение получили рентгеноэндоваскулярные вмешательства (РЭВ) окклюзия или эмболизация артериального русла. Окклюзирование артериального сосуда, питающего пораженный злокачественной опухолью орган, приводит к некрозу опухоли и замедлению ее роста (Гранов А.М и др. 1998г, Oldhafer K et al 2000, Vogl T. et al 2003)

Цель работы - изучение роли эмболизации и химиоэмболизации у больных хорионкарциномой матки, осложненной кровотечением.

Материал и методы: за период с 2005-2008г в РОНЦ пролечено 32 больных с трофобластической болезнью. Возраст больных от 18 до 48 лет. Проведено комплексное обследование больных с последующей химиотерапией. У 8-х больных хорионкарцинома матки, осложненная кровотечением, не поддавалась консервативной гемостатической терапии. Пяти больным из этой группы выполнена 2-х сторонняя эмболизация маточных артерий, а 3 больным с учетом клинико-инструментальных данных выполнена 2-х сторонняя химиоэмболизация маточных артерий. В качестве химиопрепарата применялся сухой доксорубин из расчета 40мг/м².

Результаты исследований: При хорионкарциноме матки, осложненной кровотечением использование эмболизации и химиоэмболизации в комбинированном лечении имеет большие преимущества. С помощью указанных методов удалось купировать кровотечение практически у всех больных. Контрольное обследование показало уменьшения размеров опухоли на 25-50% по сравнению с исходными данными. Эффективность разработанной методики подтверждена высокими показателями отдаленных результатов лечения больных хорионкарциномой матки, осложненной кровотечением.

Таким образом, при хорионкарциноме матки, осложненной кровотечением применение эмболизации и/или химиоэмболизации не только приводит к остановке кровотечения, но и к уменьшению объема опухоли и повышению эффективности проводимой терапии.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ORIGINAL PREPARATION ARGLABIN IN TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED CANCER OF UTERINE CERVIX

Abdyldaev T.A., Naizabekova S.Sh.

*The National Center of Oncology of the Kirghiz Republic,
Bishkek*

Urgency: Cancer of uterine cervix takes the sixth place in structure of oncological female diseases (after cancer of breast, lung, large intestine, body of uterus and ovaries). Over 300 000 women die annually from this disease all over the world. 12 285 cases of disease of cancer of uterine cervix were registered in Russia in 2008. Women of middle age (35-55 years) have this disease. In 20 % of cases the cancer of uterine cervix is found out in the age of 65 years. The young age has seldom this disease. It should be noted that disease of cancer of uterine cervix considerably exceeds disease of other tumors of female genital system. In the beginning of XXI century the increase of patients with the cancer of uterine cervix is determined at late stages: a share of cancer of IV stage makes 37,1%-47,3%.

Purpose of research: to study the efficiency of a new antitumor preparation arglabin in a combination to others cytostatic agents for the locally advanced cancer of uterine cervix.

Materials and methods: 32 patients with cancer of uterine cervix of IIb-IIIb stage of disease have been included in research. They obtained treatment in department of chemotherapy of the National center of oncology from October 2009 up to February, 2010. Patients have not been carried out previous treatment (chemotherapy, ray therapy) before.

Arglabin was administered in an optimum dose 5 mg/kg of weight of patient before introduction of chemotherapy. The chemotherapy was carried out in mode: 5 fluorouracil 500mg/m² intravenously from 1 up to 4 day; cisplatin in dose 75 mg/m² intravenously by drop for 5 day with hydration. 2 - 3 courses of polychemotherapy were carried out. 10 patients have obtained 1 course of chemotherapy with arglabin. 14 patients have obtained 2 courses. 8 patients have obtained 3 courses with arglabin. Efficiency of treatment was estimated by standard criteria of WHO.

Results: Study of direct results of clinical effect in investigated group has shown: 1 of 32 patients (3,2 %) had full regress of tumor, 16 (50 %) patients had partial regress of tumor and 15 (46,8 %) patients had stabilization of process. The general efficiency (full, partial regress) has made 53,2 %. Toxicity of the carried out mode of chemotherapy with arglabin was moderated. None of patients was noted the febrile neutropenia. 6 patients were observed (18,7 %) the haematological toxicity of I - II degrees.

Conclusions: The studied mode of chemotherapy with arglabin was effective. The frequency of the total effect was 53,2%.

PHARMACOKINETICS AND BIOTRANSFORMATION OF ARGLABIN IN EXPERIMENT

Sariev A.K¹, Adekenov S.M.²

¹ Scientific Center of Neurology of RAMS, Moscow, the Russian Federation, ² JSC "International research and production holding "Phytochemistry", Karaganda, 100009, Republic of Kazakhstan

The urgency study of pharmacokinetics of new medical preparations in experiment is indisputable. The received data on processes of absorption, distribution, biotransformation and excretion at animals allow to predict and to extrapolate these data on the person. In connection with the aforesaid, the purpose of the present research was a study of processes of absorption, distribution, biotransformation and excretion of an original antitumor preparation arglabin in experiment on animals. 90 white

male-rats (body weight - 220 ± 30 g), received from the nursery "Stolbovaya" of the Russian Academies of Medical Science, were researched. The animals were injected single, perorally suspension of arglabin native into 1 % starched flour paste in doses of 200 and 400 mg/kg. Probes of blood and organs were selected in discrete intervals of time: 0,0; 15; 30; 45; 60; 75 and 90 min after injection of preparation. The study of excretion of preparation was carried out in animals' daily urine and stool. The quantitative content of arglabin native in biomaterials was carried out by the high-performance liquid chromatograph "System Gold" (Beckman Coulter; the USA). The study of biotransformation of arglabin native in rats' daily urine was carried out by HPLC-mass spectrometry "Agilent 1100 Series", the USA. The preparation is determined in rats' plasma of blood and organs during 75 min with half-period of 7 min elimination after peroral injection of arglabin native in doses of 200 and 400 mg/kg. Thus, the clear linearity of pharmacokinetics of arglabin in a range of doses from 200,0 up to 400,0 mg/kg was determined. The tissue availability of arglabin native was showed in the good vascularized organs (liver, spleen, lungs, kidneys) approximately in 10 - 60 times more than in moderately and weakly vascularized organs (skeletal muscles and mesentery). 0,020 % and 0,32 % of invariable compound was excreted with daily urine and stool after single peroral injection of arglabin native in doses of 400 mg/kg. The invariable compound was identified in animals' daily urine after peroral injection of arglabin native into rats. As well as 3 products of the invariable compound was determined: methoxylating metabolite, tetra- hydroxylating metabolite and conjugate of arglabin native. Thus, the complete situation of pharmacokinetic laws and biotransformation of original preparation arglabin after injection into animals are presented. As a result the availability of development the peroral medicinal form is predicted.

PLANTS – POTENTIAL SOURCES OF NEW COMPOUNDS, POSSESSING ANTITUMOR ACTIVITY

Adekenov S.M.

JSC "International research and production holding
"Phytochemistry", Karaganda

Search and development of antitumor preparations among compounds of plant origin as application of synthetic cytostatic agents is interfaced to their side effect on normal tissues is actual. In territory of our republic over 6000 species of plants grow, including: 1025 species of sources of essential oils, over 200 terpenoid species, 120 alkaloid species, possessing the potential cytotoxic activity.

The successful development of new medical drugs is difficult task. Realization is possible as a result of the carrying out of the multiple-aspect and complex study, including the chemical study of plant raw material, isolation and determination of structure of molecules of biologically active compounds, bioscreening, pre-clinical and clinical tests.

At present it is determined the biological effect of chemical compounds is caused by their structure. As a rule, process of search and designing of medical drugs includes three basic stages: search and designing of compound-leaders (substance with the expressed biological activity); optimization of compound of the leader (derivatives with more expressed activity or lower toxicity or possessing the best pharmacokinetic parameters) and development of medical preparation. Tests for biological activity are an obligatory component of first two stages. The longest and labour-intensive is a first stage, where the biological screening is widely applied with use of methods of combinatory chemistry.

Researches in vivo determine the biological activity, thus, the modelling of pathology on animals allows to estimate influence of a new chemical compound on complete organism.

Though, the results of screening of natural compounds do not give full confidence that the selected perspective compounds

will show the expressed pharmacological properties both in pre-clinical, and clinical tests. For this purpose the carrying out of the profound complex of pre-clinical researches according to requirements GLP is necessary.

One of perspective classes of plant compounds by way of creation on their basis of new antitumor preparations is sesquiterpene lactones. That is connected, first, with their structural features, and secondly, with relative availability of these natural compounds. Consideration of chemical structures of cytotoxic sesquiterpenoids leads to the conclusion. All of them contain the potential alkylating functional groups. Enzymes contain the nucleophilic groups (sulfhydryl, amino groups) in their compositions. The sesquiterpene lactones inhibit their action, connecting these groups. Ability to inhibit synthesis of DNA is the general attribute of sesquiterpene lactones, possessing cytotoxic and antitumor activity.

The flora of Kazakhstan riches plants of Asteraceae L. family. They are the basic sources of sesquiterpene lactones. As a result of purposeful search of sources of these compounds at holding "Phytochemistry" it was investigated over 450 species of the Kazakhstan plants. Over 100 lactones were isolated. The structure of 26 new compounds of this class was determined. Over 600 derivatives were obtained on the basis of isolated lactones. Search of the plant raw material, possessing sesquiterpenoids, promotes creation of base for the subsequent synthetic researches directed on the obtaining of biologically active derivatives of these substances and determination of interrelation of structure of compound with the shown antitumor activity.

The carried out researches have determined that an endemic plant of the Central Kazakhstan - *Artemisia glabella* Kar. et Kir. is a source of undescribed sesquiterpene lactone arglabin before. Screening of arglabin and number of its derivatives has shown the hydrochloride dimethylaminoarglabin possesses the high antitumor activity concerning the investigated strains. The inhibition degree of tumors' growth of hydrochloride dimethylaminoarglabin makes from 36 up to 88 %. The lyophilized medicinal form for parenteral injection - preparation "Arglabin" was developed on basis of hydrochloride dimethylaminoarglabin.

The perspective direction of researches, developed by holding "Phytochemistry", is synthesis of new derivatives on the basis of arglabin and research of their biological activity. Last years the new amine-derivatives of arglabin and their quaternary ammonium salts, tetrachlorocyclopropane derivatives as well as other substances were obtained. They are showed interest in research of their antitumor and other types of physiological activities.

CYTOTOXIC ACTIVITY OF SESQUITERPENE LACTONES, ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES

Seidakhmetova R.B., Akhmetova S.B., Adekenov S.M.

JSC "International research and production holding
"Phytochemistry"

Urgency: It is necessary to note sesquiterpene lactones and alkaloids among perspective classes of biologically active compounds. The majority of compounds of these classes possess the expressed cytotoxic and antitumor activities as in conditions in vitro and in vivo.

Purpose of research: Search of new compounds with cytotoxic and antitumor activity.

Materials and methods: The samples of sesquiterpene lactones and their derivatives (ludartin, dimethylamino-, diethylamino-, methylidid dimethylamino-, methylidid diethylaminoturneforine, the sum of sesquiterpene lactones of *Saussurea salsa* (Pall.) Spreng., 3β -chlor-4 α -hydroxy-5,7 α ,6 β (H)-guai-1(10),11(13)-dien-12,6-olid, 3β -brom-4 α -hydroxy-5,7 α ,6 β (H)-guai-1(10),11(13)-dien-12,6-olid and 3 α -hydroxy-4 β -brom-5,7 α ,6 β (H)-guai-1(10),11(13)-dien-12,6-olid, dichlorcarben-derivative arglabin, tetrachlorcarben-derivative estafiatin, dimethylamino- derivative astefin, isoepoxyestafiatin, methylidide

dimethylaminochanfillin, ethyl iodide diethylaminogrossheimin, bromcarben-derivative arglabin, bromine-derivative arglabin, oxim grossmisin, methyl iodide dimethylamino-derivative argolid, methyl iodide diethylaminogrossheimin, ethyl iodide dimethylaminogrossheimin) were investigated. The samples of alkaloids and their derivatives (phenacylharminobromide, 9-methoxy-2-phenyl-11H-indolysino[8,7-b]indole, (N-(2)-(4-methoxyphenyl)harminobromide, (9-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-11H-indolysino[8,7-b]indole, (2-(3,4-dichlorophenyl)-9-methoxy-indolysino[8,7-b]indole, (N-(2)-2-(2-etoxy-2-exoethyl)harminobromide), N (2) -hydroharminetosilat, N (2) -hydroxyharminenitrate, N (2)-oxyharminephthalate, N (2)-hydroxyharminchloride, oxim papaverine, lappakonitin, harmine, hydrochloride harmine, methyl iodide harmine, N-oxide harmine, bromide harmine, peganin, methyl iodide peganin, vasicinon, zongoramin and delkisin on cytotoxic activity concerning to *Artemia salina* (Leach) in conditions in vitro.

In experiment the larvae of 2 day age of *Artemia salina* (Leach) were used. The half toxic dose LD50, the top toxic limit, bottom toxic limit, probit-coefficient for each sample, shown cytotoxic activity, was calculated.

Conclusion: From all investigated sesquiterpene lactones and their derivatives dimethylamino-, diethylamino-, methyl iodide dimethylamino-, methyl iodide diethylaminoturneforine, 3 β -brom-4 α -hydroxy-5,7 α ,6 β (H)-guai-1(10),11(13)-dien-12,6-olid, 3 α -hydroxy-4 β -brom-5,7 α ,6 β (H)-guai-1(10),11(13)-dien-12,6-olid, dichlorcarben-derivative arglabin, tetrachlorcarben-derivative estafiatin, isoeoxyestafiatin, ethyl iodide diethylaminogrossheimin, bromcarben-derivative arglabin, oxim grossmisin, methyl iodide dimethylamino-derivative argolid have the high cytotoxic activity. From alkaloids and their derivatives phenacylharminobromide, 9-methoxy-2-phenyl-11H-indolysino[8,7-b]indole, (2-(3,4-dichlorophenyl)-9-methoxy-indolysino[8,7-b]indole, (N-(2)-2-(2-etoxy-2-exoethyl)harminobromide), N (2)-hydroxyharminchloride, oxim papaverine, hydrochloride harmine, N-oxide harmine, bromide harmine, peganin, methyl iodide peganin and vasicinon.

ESTIMATION OF CYTOTOXIC ACTION OF HYDROCHLORIDE HARMINE WITH APPLICATION OF METHOD MTT

Nurmaganbetov Zh.S., Turmukhambetov A.Zh., Shulgau Z.T., Ogorodnikova M.V., Baryshnikov A.Yu., Adekenov S.M.

¹ JSC "International research and production holding "Phytochemistry", Karaganda, ² SU ROSC N.N. Blokhin RAMS, Moscow, the Russian Federation

Urgency: Despite of existence of over 60 antitumor substances in clinical practice, the majority of their efficiency is insufficient. The spectrum of the oncological diseases, which sensitive to chemotherapy, is limited. Therefore, there is actual a question on development of new more active substances. The active substance of preparations of plant origin with antitumor activity is basically alkaloids, possessing cytotoxic action. Alkaloid plants are considered as one of perspective for use in a medical practice, owing to their structural variety, high physiological activity and wide spectrum of action. In flora of Kazakhstan it is totaled over 900 species of alkaloid plants, having a wide area of distribution in territory of republic, i.e. there is a reliable renewed raw-material base for isolation of alkaloids. New approaches of chemical transformation of alkaloids are developed. Many of them for a long time are used in a medical practice. The new effective medical drugs are developed on their basis. The study of the water-soluble form of alkaloid harmine - hydrochloride harmine has a big interest.

Purpose of research: to estimate cytotoxic activity of hydrochloride harmine on cell lines of Jurkat, Raji and U937 with use of the MTT-test.

Materials and methods: In work the following cell lines were used: Jurkat, Raji and U937. The MTT-test is based on ability of

dehydrogenase of alive cells to transform the pale yellow water-soluble 3-(4,5-dimethylthiazol-2)-2,5-diphenyltetrasole bromide (MTT) into blue crystals of formazan, which are not soluble in water. Nonviable dead cells do not possess such ability. The quantity of formed formazan characterizes an intensity of the oxidation-reduction processes, proceeding in culture cells. It is the indirect characteristic of an active biomass.

Results: During the research of cytotoxic activity of hydrochloride harmine concerning to Jurkat cell line, the following results have been obtained: the survival rate of cells has made 73,8 % under action of hydrochloride harmine in the minimal concentration of $1 \cdot 10^{-5}$ M; the survival rate of tumor cells has made 32 % at increase in concentration of hydrochloride harmine up to $0,5 \cdot 10^{-4}$ M and the survival rate of tumor cells has made 12,2 % at the further increase in concentration of hydrochloride harmine up to $1 \cdot 10^{-4}$ M. During the research of cytotoxic activity of hydrochloride harmine in the minimal, average and maximal concentration concerning to Raji cell line, the following results have been obtained: 97,6 %, 58,3 % and 18,6 %, accordingly.

During the research of cytotoxic activity of hydrochloride harmine in the minimal, average and maximal concentration concerning to U937 cell line, the following results have been obtained: 76,4 %, 46 % and 15,6 %, accordingly.

Concentration of hydrochloride harmine (mole/l)	Cell line / number of alive cells		
	Jurkat, % of alive cells	Raji, % of alive cells	U937, % of alive cells
1×10^{-5}	73,8%	97,6%	76,4%
$0,5 \times 10^{-4}$	32%	58,3%	46%
1×10^{-4}	12,2%	18,6%	15,6%

Conclusions: Thus, hydrochloride harmine is a cytotoxic effective compound concerning to tumor cells of lines of Jurkat, Raji and U937. The survival rate of tumor cells depends on concentration of hydrochloride harmine. The percent of alive cells is decreasing at increase in concentration.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ АРГЛАБИНА НА СОСТОЯНИЕ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Цой И.Г., Рахимов К.Д.

НИИ фармакологии и токсикологии НАН РК, ТОО «ОО Казахская Академия питания»

Характер прямого действия потенциальных иммуномодуляторов в определенной степени может быть использован для индивидуализации показаний к его использованию. Одним из интегральных параметров функционального состояния лимфоцитов является уровень экспрессии их дифференцировочных антигенов. При этом следует помнить о том, что направленность действия иммунокорректора на степень экспрессии антигенных маркеров отдельных субпопуляций лимфоцитов будет существенно различаться, что можно интерпретировать для объяснения механизма и обоснования для применения.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись мононуклеарные клетки периферической крови условно здоровых взрослых людей с проявлениями астенического синдрома, хронической усталости или вторичного иммунодефицита. Экспрессию дифференцировочных антигенов определяли методом непрямой иммунофлуоресценции с использованием моноклональных антител CD3, CD4, CD8, CD25, CD26, CD95, CD16 и CD72. Применяли методику нагрузочных тестов, когда опытная проба в течение 60 минут инкубировалась с арглабином в конечных концентрациях 10 и 50 мкг/мл. Затем клеточные взвеси отмывались от препарата и проводилось обычное фенотипирование. Контрольная

проба этап преинкубации проходила только в питательной среде. По разности относительных показателей опытной и контрольной проб судили о характере прямого действия арглабина на ту или иную субпопуляцию лимфоцитов.

Результаты и их обсуждение. При исходно низких показателях относительного содержания CD3+ и CD4+-лимфоцитов в присутствии арглабина отмечалось достоверное усиление экспрессии этих маркерных антигенов общего пула Т-клеток и их хелперной субпопуляции. При нормальном уровне этих клеток эффект либо отсутствовал, либо отмечалось даже некоторое снижение экспрессии этих маркерных антигенов. В отношении субпопуляции CD8+-лимфоцитов чаще регистрировалось усиление экспрессии, независимо от исходного их количества. Что касается маркеров активации и способности к стимуляции (CD25+ и CD26+), то здесь практически во всех случаях отмечался эффект усиления до верхнего предельного уровня. Практически во всех случаях после кратковременной экспозиции мононуклеарных клеток с арглабином отмечалось угнетение экспрессии CD95+-маркерного антигена апоптоза. Наибольший активизирующий эффект препарата имел место в отношении экспрессии дифференцировочного антигена натуральных киллерных клеток (CD16+), особенно при первоначально низких значениях. Экспрессия маркера В-клеток чаще снижалась в присутствии арглабина, включая и исходно низкий их уровень.

Строго выраженного дозозависимого эффекта арглабина на изученные параметры на не удалось.

Выводы: Полученные предварительные данные указывают не неоднозначный эффект непосредственного действия арглабина на функциональное состояние отдельных субпопуляций лимфоцитов периферической крови условно здоровых людей. Однако в целом можно говорить об общей активизации Т-системы иммунитета и цитотоксических субпопуляций иммунокомпетентных клеток (CD8+ и CD16+).

ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА АРГЛАБИНА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФАГОЦИТОВ

Рахимов К.Д., Цой И.Г.

НИИ фармакологии и токсикологии НАН РК, ТОО «ОО Казахская Академия питания»

При оценке иммунотропных эффектов одним из необходимых моментов является комплексная оценка структурно-функциональных показателей иммунокомпетентных клеток, так как изменения отдельных параметров конкретного вида клеток не всегда носят синхронный характер, а без установления этих особенностей сложно говорить, как о непосредственных механизмах иммунокоррирующего эффекта, так и обосновывать рекомендации по дифференцированной иммунотерапии. В этом плане особый интерес представляет фагоцитарная система, являющаяся первым звеном защиты организма.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на белых беспородных крысах – самцах весом 180,0-200,0 г, которым однократно перорально с помощью зонда вводился раствор арглабина в дозировке 10 мг/кг в течение 5 суток. Эффект оценивался по состоянию структурно-функциональных параметров на 3 сутки от последнего введения препарата. Объектов исследования являлись макрофаги брюшной полости, полученные стандартным методом внутрибрюшинного введения крахмала. Оценивали экспрессию иммуноглобулиновых и комплементарных рецепторов, их функционально-метаболическую активность в НСТ-тесте, а также способность отвечать усилением кислородзависимого метаболизма в ответ на различную рецепцию. Экспрессию рецепторов изучали в стандартном розеточном тесте на эритроцитах человека I(0) группы, Rh-, нагруженных субагглютинирующими дозами кроличьих антисывороток (FcRy), а также компонентом (C3bR).

В качестве стимуляторов в НСТ-тесте были взяты пирогенал, агрегированный нагреванием IgG сыворотки человека, и пул донорских сывороток, образованных зимозаном.

Полученные результаты и их обсуждение. На фоне перорального приема арглабина отмечалось достоверное повышение экспрессии иммуноглобулиновых рецепторов на перитонеальных макрофагах (на 25-30% от контрольного уровня) с одновременным снижением доли клеток с комплементарными рецепторами. При этом регистрировалось более значительное нарастание относительного количества макрофагов с высокой активностью кислородзависимого метаболизма (73,9±4,6% против 46,1±3,8% - в контрольной группе животных).

Что касается ответа фагоцитирующих клеток на дополнительную стимуляцию использованных активаторов, то в целом ответ у животных опытной группы был выше такового в контрольной. Наибольший ответ макрофагов регистрировался на бактериальный липополисахарид (пирогенал), особенно у животных, предварительно получавших арглабин. Наименьшее усиление функционально-метаболической активности макрофагов имело место в присутствии агрегированного IgG. Так, фагоцитарные клетки контрольной группы животных по средним величинам практически не отвечали на этот стимулятор, а в опытной группе степень усиления составила 10-12%.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о неоднородности перорального краткосрочного приема арглабина на основные структурно-функциональные параметры перитонеальных макрофагов белых крыс. Однако в целом, он существенно усиливал активность фагоцитов, как по характеру изменений экспрессии основных рецепторов клеток, так и их способностью отвечать усилением кислородзависимого метаболизма в ответ на различные виды.

ИЗУЧЕНИЕ ФИТОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО ПРЕПАРАТА – ГЛИАМИН

Темиргалиева Э.М.

Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний, ЦБИ МОН РК, Алматы

В последние годы возрос интерес к тритерпеновым гликозидам, изучение которых ведется в широком аспекте. Эти соединения используются для синтеза лекарственных препаратов, по силе действия приближенных к стероидным (гормональным) препаратам, но лишенные их нежелательных побочных эффектов. В настоящий момент наблюдается повышенный интерес к тритерпеноидным соединениям, содержащим фрагменты аминокислот, благодаря способности последних к селективному связыванию с рецепторами. В связи с этим получены производные глицирретовой кислоты, содержащие различные аминокислотные фрагменты (Арыстанова Т.А., Ирисметов М.П., 2006).

Цель работы: изучение острой токсичности и специфической активности субстанции Глиамин.

Материалы и методы: - изучение острой токсичности Глиамина проведено на белых беспородных Крысах самцах весом 150 – 180 г и белых беспородных мышях весом 18-20 г. Животным опытных групп (2 группы по 6 голов) вводили зондом в желудок 5 мл раствора Глиамина в дозе 1400 мг/кг.

Результаты и обсуждения: Животным контрольной группы вводили крахмальную слизь в тех же объемах. Токсический эффект Глиамина оценивался по результатам наблюдения за общим состоянием животных, с момента введения в течение 6 ч. Дальнейшее наблюдение проводилось в течение 7 суток. За весь период эксперимента животные, как в контрольной, так и в опытной группе оставались активными, общее состояние их было удовлетворительным, внешние признаки (шерстяной покров, окраска кожи и слизистых оболочек) не претерпевали изменений, на сенсорные раздражения отвечали достаточно

энергично. Нарушений в локомоторной координации не отмечено, масса тела была в норме. Явлений интоксикации и летальных исходов не было.

Изучение хронической токсичности изучалась в течение 6 месяцев. Подопытным животным ежедневно вводили 4 % раствор Глиамина в дозе 200 мг/кг. Анализы, производившиеся раз в месяц, показали, что существенного влияния на картину крови введение препарата не оказало, в состав мочи животных не обнаружено каких – либо значительных патологических отклонений от нормы. При гистологическом исследовании органов и тканей животных, забитых через 6 месяцев после ежедневного приема препарата, были обнаружены сосудистые расстройства и гиперплазия лимфоидного аппарата. Обнаруженные изменения наблюдались в равной степени, как у подопытных, так и у контрольных животных.

Выводы: в результате проведенных исследований выявлено, что Глиамин является малотоксичным веществом и не представляет опасности для организма.

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ САНТОНИНА КАК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИИ

¹Арыстанова Т.А., ²Рахимов К.Д.,

¹Серикбаева А.Д., ²Темиргалиева Э.М.

¹Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент ²Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний, ЦБИ МОН РК, Алматы

Одним из основных методов лечения злокачественных новообразований до настоящего времени остается цитостатическая терапия. Специфика лечения соматически истощенных онкологических больных в период цитостатической терапии требует минимальной нагрузки их лекарственными препаратами, особенно, ксенобиотиками.

Цель работы: повышение эффективности цитостатического лечения целесообразным считается применение модификаторов биологического действия, в число которых входят средства природного происхождения, воздействующие как на опухолевые клетки, так и на регуляторные системы организма.

Материалы и методы: Сесквитерпеновый лактон сантонин, содержащийся в надземной части эндемического растения Казахстана полыни цитварной (*Artemisia cina* Berg. ex Polyak) является действующим началом новых модифицированных соединений и представляет большой научный интерес в плане цитостатической терапии. С целью направленного изменения биологической активности и поиска новых производных сантонина нами проведена химическая модификация его молекулы по кето-группе и получены сантонина семи- и тиосемикарбазон (Арыстанова Т.А., Ирисметов М.П., Серикбаева А.Д., 2006). Исследования показали выраженную противоопухолевую активность полученных соединений (Рахимов К.Д., 2007).

Результаты и обсуждения: Изучены физические и химические свойства и проведена стандартизация сантонина семи- тиосемикарбазона как лекарственных субстанций. Определены спецификации качества, включенные в проекты ВАНД на сантонина семи- и тиосемикарбазоны: описание, растворимость, подлинность, температура плавления, потеря в массе при высушивании, прозрачность, pH, остаточное количество органических растворителей, примеси хлоридов, сульфатов, железа, тяжелых металлов, микробиологическая чистота, посторонние примеси, количественное определение. На основании изучения стабильности в процессе хранения в естественных условиях, установлены сроки хранения исследуемых соединений – 2 года.

Разработаны специфичные и воспроизводимые методики количественного определения сантонина семи- и

тиосемикарбазона с помощью УФ-спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Валидирование разработанных методик показало, что относительная ошибка среднего результата при УФ-спектрофотометрии составляет $\pm 1,34$ % для сантонина семикарбазона и $\pm 1,04$ % - для сантонина тиосемикарбазона; при ВЭЖХ - $\pm 0,27$ % для сантонина семикарбазона и $\pm 0,31$ % - для сантонина тиосемикарбазона.

Выводы: в результате проведения целенаправленного исследования, изучены физические и химические свойства, определены спецификации качества и проведена стандартизация сантонина семикарбазона и сантонина тиосемикарбазона, по результатам которых разработаны проекты ВАНД.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СЕСКВИТЕРПЕНОИДА ПОЛЫНИ ЦИТВАРНОЙ

Рахимов К.Д., Темиргалиева Э.М.

Центральная лаборатория биоконтроля, сертификации и предклинических испытаний, ЦБИ МОН РК, Алматы

Сесквитерпеновые лактоны являются активными иммуномодуляторами и влияют именно на те звенья иммунологической цепочки, которые ответственны за формирование необходимого пула эффекторных Т-клеток, способных предотвратить развитие метастазов и рецидивов (Kawai S. et al., 2000). В плане поиска новых производных сесквитерпеновых лактонов, к числу которых относится сантонин, проведены исследования химической модификации его молекулы по кето-группе с получением семи- и тиосемикарбазонов (Арыстанова Т.А., Ирисметов М.П., Серикбаева А.Д., 2006).

Цель: Изучение противоопухолевой активности новых модифицированных производных сантонина – сантонина семикарбазона и сантонина тиосемикарбазона (Рахимов К.Д., Темиргалиева Э.М., 2008).

Материалы и методы: В работе использованы мыши массой 18-25 г линий SHR, C57Bl, DBA2, гибриды первого поколения BDF1 и белые беспородные крысы массой 180-250 г, линии Вистар. Исследованы следующие опухолевые штаммы: солидная карцинома Эрлиха, аденокарцинома молочной железы Ca755, меланома B16, карцинома легких Льюис, лейкемия P388, карциносаркома Уокер, лимфосаркома Плисса, саркома 45. Карцинома Эрлиха перевита подкожным введением 106 клеток мышам линии SHR; лейкемия P388 - внутрибрюшинным введением 106 клеток мышам DBA2; меланома B16 - подкожным введением 0,2 мл 25% взвеси опухолевых клеток мышам C57Bl; Ca755 и опухоль Льюис - подкожным введением такой же взвеси мышам гибридам; карциносаркому Уокер, лимфосаркому Плисса и саркому 45 - подкожным введением 0,4 мл 25% взвеси крысам.

Результаты: Противоопухолевый эффект оценен по задержке роста опухолей в результате внутримышечного введения и по увеличению продолжительности жизни животных.

В опытах с влиянием сантонина семи- и тиосемикарбазона на продолжительность жизни животных показано достоверное увеличение этого показателя на 54 % и 52 % у мышей с солидной карциномой Эрлиха и на 63 % и 59 % - с саркомой 45, соответственно. На 42 % и 45 % увеличивается продолжительность жизни мышей с меланомой B16. Со спонтанными опухолями всего было 94 мышей. Исходный объем опухоли у животных был различен, равно как и их состояние. Лечение проведено в дозах от 100 мг/кг - 150 мг/кг по три инъекции в неделю до исчезновения опухоли или гибели животного. Оптимальной дозой в эксперименте является 100 мг/кг. Оптимальная схема применения препаратов - 3-5 введений с интервалами 2-3 дня. Картина влияния сантонина семи- и тиосемикарбазона на спонтанные опухоли мышей сводится к тому, что после нескольких введений зачастую опухоль

увеличивается в размерах, затем некротизируется и далее частично исчезает. При некрозе опухолей с кровотечением семи- и тиосемикарбазоны могут быть использованы для орошения, что приводит к прекращению кровотечения и способствует эпителизации в месте некроза и заживлению.

Выводы: Изучена специфическая активность сантонина семи- и тиосемикарбазона в специальных исследованиях на разных опухолевых штаммах и при разных режимах введения, показавшая выраженную противоопухолевую активность полученных соединений.

СИНТЕЗ НОВОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРОИЗВОДНОГО САНТОНИНА С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Арыстанова Т.А., Серикбаева А.Д.
Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия, Шымкент

Сесквитерпеноид полыни цитварной – сантонин, обладает широким спектром фармакологического действия: антигельминтным, противовоспалительным, антипиретическим, гемолитическим, кардиотоническим, иммуномодулирующим, в том числе собственным противоопухолевым (Рахимов К.Д., 1999; Fargoq A., 2000). В этой связи сесквитерпеноид полыни цитварной является перспективным природным синтоном для получения противоопухолевых лекарственных средств.

Целью исследования является разработка способа получения нового модифицированного производного сантонина с противоопухолевой активностью.

Материалы и методы. ИК-спектр субстанции снят на спектрофотометре ИКС-29 ЛОМО (Россия), образцы готовили в виде суспензии в вазелиновом масле. Спектр ЯМР-Н1 снят на приборе Tesla BS-567 с рабочей частотой 100 МГц в Py-d_5 . В качестве внутреннего стандарта использован тетраметилсилан (ТМС), сигнал которого принят за 0 (δ шкала). Хроматографирование проводилось на пластинках для ТСХ «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» (Россия) размером 15х15. Использована стеклянная хроматографическая камера размером 150х20х80мм, УФ-хроматоскоп. Все реактивы и растворители категории «ч.д.а».

Результаты и обсуждения. Синтез нового соединения проведен путем нуклеофильного присоединения сантонина с тиосемикарбазидом с учетом следующих условий: природы растворителя, pH среды, температуры, время нагревания и объем растворов исходных веществ. Установлено, что оптимальными условиями для получения высокого выхода конечного продукта являются: объем растворителя не более 10 мл, среда - нейтральная, нагревание при температуре 1000 С в течение 1 часа. Контроль за ходом реакции проводили с помощью тонкослойной хроматографии. На полученной хроматограмме зона абсорбции полученной субстанции находится ниже, чем зона абсорбции его составляющих, что подтверждает получение соединения с большей молекулярной массой. На последней стадии выход конечного продукта составляет 84-85%.

Полученные данные по ИК-спектрам подтвердили предполагаемую структуру соединения, в спектре присутствуют характерные полосы поглощения, присущие сантону и фрагментам тиосемикарбазида, которые соответствуют метиновым (C-H), метиленовым (CH_2) и метильным (CH_3) группам, первичной аминогруппе NH_2 , карбонильной группе (C=O) γ-лактонного цикла, тионной группе (C=S) тиосемикарбазонового фрагмента.

ЯМР спектральный анализ сантонина тиосемикарбазона также подтвердил наличие указанных фрагментов, при этом наблюдаются сигналы протонов третичной метильной, вторичной метильной групп при γ-лактонном цикле.

Фармакологические исследования подтвердили противоопухолевую активность полученного соединения - сантонина

тиосемикарбазона, перспективного для дальнейших исследований его как лекарственной субстанции (Арыстанова Т.А., 2006).

Вывод. Разработан способ получения нового производного сесквитерпеноида полыни цитварной - сантонина тиосемикарбазона. Исследованы спектральные характеристики, подтверждающие структуру полученного соединения.

ИММУНОФАРМАКОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Рахимов К.Д.
НИИ фармакологии и токсикологии НАН РК

Несмотря на наличие широкого спектра современных противоопухолевых фармакологических средств в клинике, все они имеют весьма серьезные ограничения, связанные как с недостаточной эффективностью, так и с наличием у большинства из них побочного токсического действия на нормальные клетки и на иммунный статус организма.

В связи с этим большое внимание уделяется выявлению и экспериментальному изучению новых иммуномодулирующих природных препаратов не обладающих нежелательными побочными токсическими эффектами; изучению возможностей использования в качестве иммунокорректоров в комплексном лечении злокачественных опухолей.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на белых беспородных крысах-самцах весом 190,0 – 210,0 г. Изучили иммунологические показатели в сыворотке крови у интактных крыс и с перевиваемыми лимфосаркомой Плисса, саркомой 45. Исследование влияния растительных препаратов (арглабин, алхидин, альнусидин и натриевой соли Δ1,2 – 3-кето – 18-дегидроглицерретоной кислоты (препарат ГК) проводили в сравнении с действием известных цитостатиков сарколизином, 5-фторурацилом, платидиамом и их комбинациями: на 5,10,15 дни в терапевтических дозах ежедневно 10 раз после внутрибрюшинного введения. При этом нами были выбраны тесты (как клеточные, так и гуморальные), характеризующие все звенья иммунологической реактивности.

Результаты и обсуждения. Применение арглабина, алхидина, альнусидина и препарата ГК по сравнению с сарколизином, платидиамом и 5-фторурацилом, не вызывало иммунодепрессивного воздействия у интактных животных. Более того совместное введение арглабина, проявляющего иммуностимулирующий эффект у интактных крыс, с сарколизином значительно снижало иммунодепрессию последнего. Алхидин, альнусидин и препарат ГК оказывали разнонаправленное действие на различные иммунологические показатели: они стимулировали РГЗТ, но снижали показатели Е-РОК, НСТ-тест и РГА, хотя и в меньшей степени, чем сарколизин.

Данные о влиянии природных противоопухолевых соединений на показатели иммунологической реактивности у крыс с исходной лимфосаркомой Плисса была чувствительна к арглабину, алхидину, альнусидину и препарату ГК. Такая же закономерность проявлялась и при лечении другой опухоли - исходного штамма саркомы 45 и слабо чувствительной к альнусидину. Иммунологические показатели при комбинации альнусидина и препарата ГК с сарколизином имели тенденцию к увеличению уровня Е-РОК по сравнению контрольной группой, только на 15 день после начала лечения чувствительность опухоли к ним была высокой. Природные препараты позволяют смягчить токсический иммунодепрессивный эффект химиопрепаратов. Особенно наглядно видно, что комбинация арглабина с высокотоксичными иммунодепрессантами платидиамом и 5-фторурацилом позволили значительно повысить иммунологические показатели леченных животных.

Выводы: Иммунофармакологические изучения природных соединений проявляют иммуностимулирующее действие. Их

комбинации с цитостатиками значительно повышают реологический статус организма животных. Противоопухолевый эффект растительных соединений кроме прямого цитотоксического действия, возможно, обусловлен и опосредованным иммунологическим механизмом.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ АЛХИДИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Рахимова А.К.

*Международный научно-производственный холдинг
«Фитохимия» Караганда*

Алхидин является оригинальным лекарственным препаратом нестероидной природы, обладающим противовоспалительным, гепатопротекторным действиями. Активным началом препарата является полимерный проантоцианидин.

Цель исследования явилось изучение процессов всасывания, распределения и экскреции действующего компонента проантоцианидина в эксперименте на животных.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на 310 белых крысах-самцах (масса тела 220 ± 30 г), полученных из питомника «Столбовая» РАМН. Проантоцианидин вводили крысам однократно внутрь в дозах 25,0; 50,0 и 100 мг/кг и внутривенно в дозе 25 мг/кг. Содержание проантоцианидина определяли в плазме крови, печени, сердце, селезенке, головном мозге, скелетной мышце, легких, почках, брыжейке через 0,0; 0,05; 0,1; 0,17; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 и 12,0 часов. Изучение экскреции препарата проводилось в суточной моче и кале животных. Хроматографирование проантоцианидина проводили в изократическом режиме на хроматографе «Beckman System Gold» (США), состоящем из изократической помпы – «PM-127», УФ-детектора – «PM-166» и компьютера с пакетом программ для обсчета хроматограмм «Амперсенд» (Россия).

Результаты и обсуждения. В результате исследования впервые была разработана методика количественного определения проантоцианидина в биологическом материале на основе ВЭЖХ. Установлено, что проантоцианидин в организме крыс определяется на протяжении 12 часов, независимо от введенной дозы и способа его введения. Полупериод элиминации для перорального введения составляет от 1,80 до 2,18 часа и для внутривенного введения – 7,32 часа. Выявлена линейная зависимость фармакокинетики проантоцианидина в диапазоне доз 25,0 - 100,0 мг/кг. Показано, что тканевая доступность проантоцианидина почти в 2-3 раза выше в печени, селезенке, легких, почках, чем в сердце, брыжейке, скелетной мускулатуре, мозге крыс. Абсолютная биодоступность проантоцианидина составляет ~14,1 %. Установлено, что 0,74% и 0,77% проантоцианидина от введенной дозы экскретируется с суточной мочой и калом соответственно.

Вывод. Представлена полная фармакокинетическая картина оригинального препарата алхидина после его перорального и внутривенного введения животным, что позволяет экстраполировать эти данные на человека при проведении клинических его испытаний.

НОВЫЙ ФИТОПРЕПАРАТ ИЗ *EUROTIA CERATOIDES* (L.) И ЕГО АКТИВНОСТЬ

*Бутабаева К.Ж., Бурашева Г.Ш., Хажиакбер Айса
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби*

Синьзянский технический институт физики и химии КАН. Актуальность исследования обусловлена потребностью здравоохранения и фармацевтической промышленности Республики Казахстан в новых эффективных лекарственных средствах растительного происхождения. В последние десятилетия зарубежные исследователи проявляют внимание к химическому исследованию надземной части растения рода *Eurotia* (Терескен), произрастающего в Китае, который вызы-

вает интерес как объект для полного химического изучения и выделения биологически активных веществ. Исследование химического состава казахстанского вида растения *Eurotia ceratoides* (L.) проводится на кафедре органической химии и химии природных соединений КазНУ им. аль-Фараби впервые. Целью исследования является установление химического состава *Eurotia ceratoides* (L.), семейства *Chenopodeaceae*, произрастающего в Республике Казахстан и изучение его биологической активности. Материал и методы исследования. Методами двумерной и одномерной хроматографии на бумаге, а также ТСХ в различных системах растворителей впервые установлено, что в исследуемом растении содержатся следующие основные группы биологически активных веществ: лигнаны, неолигнаны, флавоноиды, фенолокислоты, аминокислоты, сапонины, кумарины, органические кислоты, а также углеводы [1]. Результаты и обсуждения. По общепринятым методикам Государственной фармакопеи СССР и РК количественно определены вышеперечисленные биологически активные вещества. Установлено процентное содержание действующих веществ в пересчете на абсолютно сухое сырье: лигнаны – 1.9%, неолигнаны – 1.5%, флавоноиды – 1.0%, феноло- и органические кислоты – 1.9%, кумарины – 1.1%, сапонины – 4.0%, углеводы – 1.7% [2,3]. Данные вещества более полно экстрагируются 70% водно-этиловым спиртом, который был нами взят как условный фитопрепарат, для дальнейшего исследования его биологической активности.

Далее проведен биологический скрининг данного фитопрепарата в лаборатории Синьзянского технического института физики и химии, КАН, Урумчи (Китай).

Фитопрепарат из 70%-ной спиртовой вытяжки, полученный из надземной части растения рода *Eurotia ceratoides* (Терескен роговидный) показал высокую антидиабетическую активность. При концентрации испытуемого условного экстракта (компонента) 100 мг/мл, он показал 91.2% антидиабетическую активность по отношению к контролю NaVO_3 .

Изучена противоопухолевая активность фитопрепарата 70%-ной спиртовой вытяжки *Eurotia ceratoides* (Терескен роговидный). Установлено, что данный (ЕА-7) при концентрации компонента 100 мг/мл подавляет клетки карциномы толстой кишки *Saco-2-cell* на 100%.

Вывод. Изучение компонентного состава надземной части Терескена роговидного и выявление антидиабетической и противоопухолевой активности, позволяют в перспективе расширить арсенал новых доступных отечественных фармацевтических средств. Данный факт подтверждается литературными данными, что действующим началом в проявлении антидиабетической и противоопухолевой активности являются лигнаны.

ПЕРСПЕКТИВЫ СУБСТАНЦИИ «ТОНБИОЛ», ОБЛАДАЮЩЕЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ

Тогандыков Т.Ж.

ФАО г.Алматы ЖГМК «Клиническая дорожная больница»

Результатом многолетней работы коллектива кафедры физической химии и электрохимии КазНУ им. аль-Фараби под руководством профессора Оспанова Х.К. явился ряд комплексов переходных и непереходных металлов с унитиолом.

Цель исследования является, результаты предварительных доклинических исследований в качестве перспективного нового фармакологического соединения было выбрано унитиолатное соединение ртути под условным названием тонбиол.

Материал и методы исследования. Тонбиол - $\text{Na}_2[\text{Hg}(\text{SRS})(\text{OH})\text{H}_2\text{O}]$.

Аква-гидроксо-динатрий-1-сульфонато-2,3-димеркаптопропан-S,S' ртуть (II) гидрат. Молекулярная масса – 462,7. Температура плавления – 145 °С. pH раствора в воде – (0,15 г в 100 мл) – 5,0.

Экспериментальные животные: белые беспородные мыши обоего пола массой 17-19 г в количестве 53 голов, белые беспородные крысы обоего пола с массой тела 160-200 г. Перевиваемые опухоли: саркома-180 и лимфосаркома Плисса.

Результаты и обсуждения. В первую очередь оценивался уровень безопасности и эффективности фармакологического соединения тонбиол. (Рахимов К.Д. 1998 г.).

Острая токсичность определена при однократном внутривенном введении на крысах и мышах. Получено следующее значение уровня летальных доз: для мышей - $DL_{16} = 140$ мг/кг; $DL_{50} = 205$ мг/кг; $DL_{90} = 289$ мг/кг; для крыс - $DL_{16} = 150$ мг/кг; $DL_{50} = 220$ мг/кг; $DL_{90} = 310$ мг/кг.

В качестве максимально переносимых доз соединения тонбиол для мышей зафиксировано 10,0 ($7,9 \div 12,1$) мг/кг при введении в брюшную полость и 40,5 ($33,7 \div 47,3$) мг/кг - при введении внутрь, для крыс - 12,2 ($10,4 \div 14,0$) мг/кг при внутрибрюшинном введении и 60,4 ($48,0 \div 72,8$) - при введении вещества внутрь.

Определен выраженный значительный противоопухолевый потенциал у фармакологического соединения тонбиол. Установлено, что химиотерапевтический эффект исследуемого соединения проявляется при различных путях введения - внутрибрюшинном, подкожном, введении внутрь. Если стандартное средство миелосан в дозе 2 мг/кг (МПД) обеспечивает выживание 30% (при 100%-ной гибели в контроле), то новый препарат в дозе, близкой МПД, защищал от гибели 40% животных с саркомой-180. При этом показатель торможения роста опухоли был также на 10% выше. Суммарная продолжительность жизни при применении исследуемого соединения составила 349 суток, а при применении миелосана - 251 (в контрольной группе - 226). Наиболее показательным в условиях нашего эксперимента был рост УПЖ - исследуемое соединение обеспечивало УПЖ от 83 до 170% с увеличением дозы от 10 мг/кг до 30 мг/кг. Повышение дозы до 50 мг/кг, видимо в связи с токсическими проявлениями препарата, не способствовало дальнейшему росту показателя УПЖ. При этом стандартный противоопухолевый препарат миелосан давал УПЖ в 50%.

Исследуемый препарат демонстрировал в отношении животных-опухоленосителей лимфосаркомы Плисса бесспорный эффект увеличения продолжительности жизни. Так, УПЖ при дозе 10 мг/кг составил 94%, при дозе 30 мг/кг - 140%, миелосан при этом обеспечивал УПЖ в 44%.

Вывод. Исследуемое фармакологическое соединение тонбиол может считаться перспективным для проведения клинических испытаний на противоопухолевую активность.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕНОСИМОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИТИОЛАТНОГО СОЕДИНЕНИЯ РТУТИ

Тогандыков Т.Ж.

ФАО г.Алматы ЖГМК «Клиническая дорожная больница»

К настоящему времени на кафедре физической химии и электрохимии КазГНУ им. аль-Фараби синтезирован целый ряд унитиолатных комплексов металлов. Результаты систематических экспериментальных исследований химических и физических свойств этих соединений, проводимого на протяжении последних 10 лет, позволяют прогнозировать с высоким уровнем вероятности наличие биологической активности.

Проведенные на вышеуказанном теоретическом основании первичные экспериментальные исследования, показали, что при комплексообразовании унитиола с ионами металлов его биологическая активность усиливается.

Цель исследования является, поиск новых фармакологических соединений с высоким потенциалом биологической активности, в частности, с противоопухолевыми свойствами в ряду координационных соединений металлов с унитиолом, обоснован и оправдан.

Материал и методы исследования.

На первом этапе клинических испытаний нового противоопухолевого препарата унитиол в исследование приняло участие 9 здоровых добровольцев и 24 больных с онкологической патологией, находящихся в стационаре «хоспис».

Результаты и обсуждения. Исследование переносимости нового противоопухолевого препарата унитиол проведено при однократном внутривенном назначении. Использован следующий диапазон доз: 7,5 мг/кг, 5 мг/кг, 2, 5 мг/кг, 1 мг/кг, 0,5 мг/кг.

Определено, что максимальной переносимой дозой можно считать 5 мг/кг. Основные побочные эффекты развиваются постепенно после однократного введения: через сутки появляется повторная рвота, через 2 суток - диарея. Указанные побочные эффекты проходят без коррекции через сутки.

При повторном многократном введении внутривенно в дозе 2,5 мг/кг в первые сутки после введения тошноты, рвоты и диареи не развивается, однако, через 8-13 дней после начала терапии выявляется лейкопения до минимального уровня $4,2 \times 10^6$ /мл. Лейкопения исчезала на 3-4 сутки после прекращения введения препарата без корректирующей терапии.

У 14 пациентов в дозе 0,5 мг/кг при многократном повторном ежедневном введении (10-27 суток) ни в одном случае не было зарегистрировано диареи или лейкопении.

Ориентировочное определение терапевтического эффекта проведено на 24 больных с IV фазой опухолевого процесса (рак простаты, рак легких, рак молочной железы, рак желудка, меланома).

Субъективное улучшение отметили 20 больных в течение первых 5 дней от начала терапии. В 7 случаях были объективные признаки регресса опухолевого процесса.

Вывод. Детальный анализ терапевтической эффективности на данной фазе клинических испытаний не предусмотрен, однако положительный клинический эффект может прогнозироваться с большой долей уверенности.

Лучевая терапия

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛАЗА И ОРБИТЫ

Ажигалиев Н.А.¹, Кайназарова М.А.¹,
Ажигалиева М.Н.², Ким В.Б.¹

КазНИИ онкологии и радиологии, КазНИИ глазных
болезней г. Алматы Республика Казахстан

Распространенным методом лечения опухолей орбиты и глаза является хирургическое вмешательство, однако оно во многих случаях не спасает больных от генерализации опухолевого процесса. Поэтому многие авторы рекомендуют комбинированное лечение, при котором результаты получаются лучше, чем при чисто хирургическом лечении. Другим распространенным методом лечения является лучевая терапия.

В последние годы в связи с появлением новых источников излучения открылись новые перспективы в лечении опухолей глаза и орбиты. При опухолях орбиты применяются радиовые аппликаторы, рентгеновское и гамма облучение, сочетанная лучевая терапия. Благодаря лучевой терапии во многих случаях удавалось перевести процесс из неоперабельного состояния в операбельное или уничтожить остаточные опухолевые элементы после проведенной операции.

Электронная терапия имеет преимущества перед рентгеновским и гамма-излучением. Оно заключается в резком спаде дозы за очагом поражения, равномерном распределении ее до определенной глубины, причем глубина проникновения электронов зависит от энергии генерирования. Это побудило нас детально изучить особенности применения быстрых электронов при лечении опухолей глаз и орбиты. Прежде всего, необходимо было выяснить дозные распределения энергии излучения при электронной терапии патологических очагов, расположенных в глазном яблоке и орбите, и разработать методику их лечения. Техника облучения опухоли глаз осложняется тем, что необходимо сохранить зрение. Кроме того, нужно полностью избежать облучения головного мозга. В связи с этим выбор условий облучения должен быть индивидуальным.

Результаты комбинированного метода лечения опухолей глаза и орбиты приведены в таблице 1. Из 35 больных, получивших комбинированное лечение, умерли от генерализации опухолевого процесса 7, нет сведений о 4 больных. С меланобластомой сосудистой оболочки глаза живы в течении трех лет наблюдения 16 из 25 больных, что составляет 64 %. при комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения.

Таблица 1- Результаты комбинированного лечения больных с опухолями глаза и орбиты

Гистологический тип опухоли	Кол-во больных	Живы 3 года	Умерли от метаст.	Нет сведений
Меланобластома	25	16	6	3
Ретинобластома	5	4	1	--
Саркома	2	1	--	1
Плоскоклет. рак	2	2	--	--
Аденокарцинома	1	1	--	--
Всего	35 (100,0%)	24 (68,6±7,3%)	7 (20,0±6,6%)	4 (11,4±5,0%)

Удовлетворительные результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза. Кроме хирургического лечения необходимо допол-

нительно использовать быстрые электроны, но применять электронную терапию лучше после оперативного лечения.

45-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В КАЗНИИОИР

Ажигалиев Н.А., Ким В.Б., Садыков С.С., Сырымбеткызы Ж., Савхатова А.Д., Антропова Т.Ю., Ким С.И., Ибраимова М.А., Алмабекова А.Т., Кайназаров Ч.

КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК, г. Алматы

Научно-технический прогресс и достижения в области медицинских наук позволили значительно расширить спектр применения лучевой терапии (ЛТ) в лечении онкологических больных, из которых не менее 60-70% нуждаются в лучевом лечении. При этом отчетливо выявились возможные направления дальнейшего совершенствования ЛТ. К числу последних можно отнести применение медицинских ускорителей, преимущество которых является возможность проводить облучение в фотонном и электронном режимах, позволяющих создать оптимальное пространственное распределение дозы в облучаемом объеме. Все это позволило внедрить в клиническую практику методики конформного, интенсивно-модулированного и управляемого по изображению лучевого лечения, а, также радиохирургическое (стереотаксическое) облучение.

Ускорители заряженных частиц в практике отечественной клинической радиологии стали применяться с начала 60-х годов, когда были созданы медицинские ускорители (бетатрон, линейные ускорители). В КазНИИОИР впервые в СССР с 1965 года в широких масштабах начали проводить лечение злокачественных новообразований различных локализаций электронами высоких энергий на бетатроне Б15МэВ (опухоли кожи и мягких тканей, меланомы, опухоли глаза и орбиты, гортани, полового члена, вульвы и молочной железы, злокачественных лимфом и др.). С вводом в эксплуатацию в 1978 году бетатрона Б25МэВ были усовершенствованы и оптимизированы методики ЛТ электронным пучком. Стали широко использоваться методики облучения рака пищевода, молочной и щитовидной желез, опухолей мягких тканей и костей на пучках быстрых электронов и тормозного излучения.

С запуском линейных ускорителей ЛУЭВ15М1 (1989 г.), «Clinac-2100» (1995 г.), «Clinac 600 C/D» (2004 г.), были апробированы и внедрены в клиническую практику новые методики ЛТ рака пищевода и молочной железы, мочевого пузыря, предстательной железы, прямой кишки, опухолей головного мозга, злокачественных лимфом.

Стали широко применяться различные иммобилизирующие устройства. Так при ЛТ опухолей головы и шеи, опухолей головного мозга широко используются специальные фиксирующие термопластические маски. При облучении пациенток с опухолями молочной железы используется специальная доска-подставка, а для лучшей фиксации детей используются вакуумные мешки. Кроме того, при проведении ЛТ на пучках электронного и тормозного излучения, широко применяются радиомодифицирующие агенты, такие как радиосенсибилизаторы гипоксических клеток: метронидазол, АК-2123, и радиопротекторы: химические (цистамин, мексамин) и физические (ГГС-8, 10), средства комбинированной онкологии.

С помощью рентгеновского симулятора с КТ приставкой «Acuity CBCT» были отработаны технологические циклы в индивидуальной 2-3-D предлучевой подготовке онкологических больных с различными локализациями злокачественных опухолей. А использование компьютерной системы «Eclipse» позволило значительно улучшить и упростить клинито-

дозиметрическое планирование лучевого лечения. При этом контроль качества ЛТ осуществлялся с помощью системы портальной визуализации «Portal Vision».

За последние годы широко внедрена конформная 3-D лучевая терапия при опухолях головного мозга, пищевода, легкого, прямой кишки, мочевого пузыря, предстательной железы, метастатическом поражении костей. Начато активное освоение и внедрение методик интенсивно-модулированной ЛТ.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, что использование медицинских ускорителей, генерирующих электронное и тормозное излучение, значительно расширило возможности лучевой терапии злокачественных опухолей различных локализаций.

ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛАЗА И ОРБИТЫ

Ажигалиев Н.А.¹, Кайназарова М.А.¹,

Ажигалиева М.Н.², Ким В.Б.¹

КазНИИ онкологии и радиологии, КазНИИ глазных болезней, г. Алматы Республика Казахстан

Лечение опухолей глаза до сих пор остается трудным и далеко нерешенной задачей клинической онкологии. Это объясняется сложными анатомическими особенностями органа, разнообразием гистологической структуры опухолей и различной степенью их злокачественности. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическое вмешательство, однако оно во многих случаях не спасает больных от генерализации опухолевого процесса. Химиотерапия в основном используется в плане комплексного лечения. В начальных клинических стадиях заболевания показано оперативное вмешательство. По данным литературы, при запущенных стадиях послеоперационная летальность достигает 90% и более. поэтому многие авторы рекомендуют комбинированное лечение при котором результаты получаются лучше, чем при хирургическом методе.

Объем хирургического вмешательства зависит от характера и распространенности процесса - энуклеации или экзентерации глаза. При двухстороннем поражении удаляется тот глаз, в котором процесс развит сильнее, а второй глаз подвергается облучению.

Другим распространенным методом лечения является лучевая терапия. Литературные данные об этом противоречивы. До настоящего времени нерешенным остается вопрос о целесообразности применения лучевой терапии после хирургического вмешательства. При опухолях орбиты применяются радиевые аппликаторы, рентгеновское и гамма облучение, сочетанная лучевая терапия.

Успех лучевой терапии опухоли орбиты помимо характера и распространенности процесса в значительной мере определяется правильным выбором метода и условий облучения, позволяющих подвести к опухоли необходимую дозу за курс лечения при минимальном облучении окружающих тканей.

Анализ распределения доз при облучении быстрыми электронами опухоли орбиты показывает важное преимущество их перед рентгеновскими и гамма-излучением.

Мы применяли электроны 66 больным с опухолями глаза и орбиты. Большинство больных, получивших электронную терапию находились в клинике КазНИИ глазных болезней. Облучение проводилось после совместного осмотра и консультации окулиста.

Электронная терапия при лечении больных с опухолью глазницы применялась как самостоятельный метод у 17 больных (см таблицу1).

Таблица 1- Результаты электронной терапии больных опухолями глаза и орбиты

Гистологический тип опухоли	Кол-во больных	Живы 3 года	Умерли от метаст.	Нет сведений
-----------------------------	----------------	-------------	-------------------	--------------

Плоскоклеточный рак	8	6	1	1
Ретинобластома	5	3	2	--
Аденокарцинома	2	1	1	--
Эозинофильная гранулема	2	2	--	--
Всего	17 (100,0%)	12 (70,6%)	4 (23,5%)	1 (5,9%)

Наше наблюдения свидетельствуют о том, что лечение опухоли глаз электронным пучком больные переносят хорошо. Общие реакции в виде эритемы и эпителиита возникали при дозе 35-45 Гр. Восстановление кожи завершалось за 12-15 дней. картина периферической крови у всех больных оставалась в пределах нормы.

Результаты электронной терапии оказались вполне удовлетворительными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ

Сиченко В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями рак шейки матки составляет 9,3%(2009 год, павлодарская область), а среди поражений органов женской половой сферы стабильно занимает 1 место. Летальность больных раком шейки матки составила в 2009 году 5,3% , показатель запущенности остается достаточно высоким, у 40% заболевание выявляют в 3-4 стадии. Одним из главных методов лечебного воздействия при данной патологии является лучевая терапия.

Цель работы: повышение эффективности лучевой терапии за счет применения нетрадиционных режимов фракционирования.

Материалы и методы: истории болезни и амбулаторные карты больных, состоящих на диспансерном учете в ПООД.

Были проанализированы результаты лечения 227 больных, получавших радикальный курс сочетанной лучевой терапии. У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически. В соответствии с целями и задачами, больные были распределены на 3 группы: I группу составили 50 пациенток, которым дистанционное облучение проведено в режиме гиперфракционирования, II группу были включены 40 пациенток, получавших дистанционное облучение в режиме динамического фракционирования. В III группу вошли 137 пациенток, получающих лучевую терапию в режиме классического фракционирования. 52% составили пациентки с 3 стадией рака шейки матки.

Дистанционное облучение проводили в подвижном и статическом режимах на гамма-терапевтических установках «РОКУС-АМ», «АГАТ-С». Режим гиперфракционирования, применяемый нами: РОД-1,25 Гр- 2 раза в день с интервалами между сеансами 4-5 часов; режим динамического фракционирования: дистанционное облучение первые три дня проводилось укрупненными фракциями РОД-4 Гр, последующее облучение проводили в режиме гиперфракционирования.

Анализ результатов лечения в зависимости от режима фракционирования показал, что при применении режима гиперфракционирования уменьшается количество ранних и поздних лучевых осложнений в 2,5 раза по сравнению с III группой.

Результаты и выводы: при сочетанной лучевой терапии рака шейки матки режим гиперфракционирования обеспечил достоверное снижение острых лучевых реакций (15% против 32%) и поздних лучевых повреждений (7,6% против 25%). Использование режима динамического фракционирования

применялось, в основном, у пациенток с 3 стадией процесса и позволило получить полную резорбцию опухоли у 60% больных в сравнении с III группой(38%). У больных с местнораспространенным раком шейки матки режим динамического фракционирования обеспечил достоверное усиление противоопухолевого эффекта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОГО И ХИМИЛУЧЕВОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ III – IV СТАДИЙ

Сиченко. В.Н., Актаева Н.М.,
Тусуп А.Ж., Жансагимова З.С.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар.

Актуальность работы: Лучевая терапия является не только основным методом консервативного лечения многих злокачественных опухолей, но и важным компонентом комбинированного или комплексного лечения.

В качестве самостоятельного метода лучевая терапия применяется при ряде злокачественных заболеваний. Ежегодно около 68% больных, подлежащих лечению, получают лучевую терапию.

Цель работы: показать эффективность химиолучевой терапии в лечении рака прямой кишки III-IV ст. в сравнении с лучевой терапией как самостоятельного метода.

Материалы и методы: истории болезни и амбулаторные карты больных, состоящих на диспансерном учете в ООД.

Нами были проанализированы результаты лечения шестидесяти больных с раком прямой кишки 3-4-й стадий, получавших лучевую и химиолучевую терапию в 2008 – 2010г. Из них 41 мужчины, 19 женщин. Возраст от 36 до 77 лет.

У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически. Больные сформированы в две группы.

Первая группа (38 человек) получала лучевую терапию в самостоятельном варианте.

Вторая группа (22человека) получала параллельно химиотерапевтическое лечение по следующей схеме:

5 - фторурацил 500мг в/в капельно, перед облучением. Суммарная доза 3000мг. Оноксплатин 50 мг в/в капельно 1раз в неделю, суммарная доза 150-200 мг.

Облучение больных в обеих группах проводилось на гамма - терапевтическом аппарате «Рокс-АМ», РОД 2 Гр, 5 фракций в неделю, до суммарной очаговой дозы 60 Гр.

Анализ результатов лечения в зависимости от метода лечения показал, что у больных второй группы регресс размеров образования отмечается значительно раньше. У 10 больных процесс из неоперабельного состояния переведен в операбельный и проведено оперативное лечение.

Результаты и выводы: в лечении больных раком прямой кишки III-IV ст более эффективным является вариант химиолучевой терапии в сравнении с облучением в качестве монотерапии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Чакенова Б.К.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: результат лечения рака молочной железы зависит от своевременности диагностики. Основным скрининговым и диагностическим методом выявления объемных образований молочных желез является лучевой метод диагностики: маммографический.

Цель исследования: изучение вопросов организации и эффективности проводимого маммографического скрининга для ранней диагностики рака и другой патологии молочной

железы.

Материалы и методы: статистический анализ учётных и отчётных форм, мониторинг маммографического исследования в области.

Активное внедрение в практическое здравоохранение маммографии – один из возможных путей улучшения выявления рака молочной железы. Внедрение в практику современных медицинских технологий, главным образом, рентгеновской и ультразвуковой маммографии, позволяют увеличить выявляемость раком молочной железы в I-II стадии до 70%, увеличить число больных с 5-летней выживаемостью до 90%, снизить смертность от этого заболевания на 30%. Такие результаты могут быть достигнуты при проведении профилактических рентгеномаммографических обследований женского населения с последующим диспансерным наблюдением пациенток с заболеваниями молочных желез.

За маммографическими кабинетами закреплено всё женское население области старше 40 лет. В управлении здравоохранения утверждён количественный план проведения исследований на каждый год. Неоднократно проводимые совещания, обучающие семинары для врачей ПМСП и рентгенологов, в том числе и с участием ведущих специалистов КазНИИОиР, позволили добиться определённых результатов в вопросах ранней диагностики рака молочной железы.

Мной проанализирована работа маммографических кабинетов за 2007-2009 годы.

Количество проведённых обследований и удельный вес выявленной патологии

Показатели	2007 год		2008 год		2009 год	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Проведено исследований	27612	105%	19543	100%	15301	100%
Здоровые женщины	16037	58,1%	11451	58,6%	9718	63,5%
Выявлено патологии	11575	41,9%	8092	41,4%	5583	36,5%
В том числе:						
Рак	45	0,2%	45	0,2%	20	0,1%
Другая патология	11530	41,8	8047	41,2%	5563	36,4%

Как видно из представленной таблицы, с каждым годом увеличивается процент здорового контингента в связи с более тщательным клиническим отбором женщин для проведения маммографии.

Результаты и выводы: в связи с высоким уровнем заболеваемости раком молочной железы, метод маммографического скрининга приобретает главенствующую роль в ранней диагностике, тем самым, позволяя повысить показатель 5-летней выживаемости и снизить смертность от этого заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАММОГРАФИИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сулейменова Ж.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: прогресс в лечении рака молочной железы зависит от своевременности диагностики. Основными скрининговыми и диагностическими методами выявления объемных образований молочных желез являются лучевые методы диагностики: рентгеномаммография и ультразвуковая маммография.

Цель исследования: сравнение преимуществ и недостатков рентгеновской и ультразвуковой маммографии, обобщение

ние собственного опыта работы.

Материалы и методы: амбулаторные карты больных, данные кабинета УЗИ онкологического диспансера и маммографических кабинетов области.

Нами проведен анализ результатов проведенных исследований за 2009 год. С профилактической и диагностической целью обследовано 16165 женщин, в том числе: рентгеновская маммография - 15301, ультразвуковая маммография - 864. Выявлено 6447 случаев патологии, что составляет 39,9% от количества обследованных женщин. Среди выявленной патологии 1 место занимает мастопатия – 5343 случая (82,9% от выявленной патологии), на 2 месте – фиброаденома – 597 (9,3%), на 3 месте – рак молочной железы – 243 (3,8%), липомы и кисты занимают соответственно 4 и 5 места (3,1% и 1% соответственно). В процессе анализа были оценены возможности различных видов лучевой диагностики патологии молочных желез. Преимущества рентгеномаммографии: возможность массового обследования больших контингентов женского населения, диагностика непальпируемых объемных образований, особенно на фоне диффузных и узловых доброкачественных новообразований и гиперплазий, возможность проведения дифференциальной диагностики, оценка распространенности процесса, его локализация. Недостатки рентгеномаммографического метода: лучевая нагрузка на пациентов и персонал, которая может быть уменьшена с применением цифровых маммографов, малая информативность у пациенток молодого возраста, в связи с преобладанием железистого типа строения молочных желез, суммарное наложение теневой картины на рентгенограммы, отсутствие мобильности маммографических установок, что не позволяет в полной мере приблизить диагностическую маммологическую помощь к населению, наличие труднодоступных зон для обследования, в частности, в верхненаружных квадрантах молочных желез, в которых наиболее часто встречаются опухоли молочной железы, субъективные факторы - дискомфорт, который испытывают пациентки во время обязательной компрессии молочных желез. Преимущества ультразвуковой маммографии: метод практически не имеет противопоказаний к проведению, отсутствие лучевой нагрузки, возможность обследования беременных, кормящих женщин, детей и подростков обоего пола, метод позволяет сканировать все участки железы, включая малодоступную для рентгеновской маммографии аксиллярную область, возможность прицельной пункционной биопсии объемных образований, возможность обследования в период острого воспаления, в ранний посттравматический период, исследование рентгенплотных молочных желез с преимущественно железистым типом строения, пациенткам в возрасте до 30 лет, возможность первичной оценки состояния регионарных лимфоузлов, их изменения в результате проведения лечения, 100 % достоверность при дифференциальной диагностике кистозных и солидных образований, ультразвуковой мониторинг результатов лечения, возможность контроля состояния силиконовых протезов, мобильность аппаратов УЗИ, малая затратность расходных материалов.

Выводы и заключение: применяя в совокупности этих два метода для исследования молочной железы, реально улучшить раннюю диагностику опухолей молочных желез и своевременно начать адекватное лечение.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВОВ РАКА ЖЕЛУДКА

Альгожин Т.Б.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: одним из основных направлений онкологической службы является совершенствование как первичной

диагностики рака желудка, так и своевременное выявление рецидивов с целью повышения эффективности лечения и улучшения качества жизни онкологических больных. Это связано с тем, что за последние годы рак желудка прочно занял лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости.

Цель работы: целью исследования явилось изучение возможности лучевых методов обследования и их комплексного применения в диагностике рецидивов рака желудка.

Материалы и методы: В нашей клинике за последние 10 лет было обследовано 17 больных с рецидивами рака желудка, которым проведено рентгенологическое, ультразвуковое и компьютерно-томографическое исследование (по показаниям) с учетом эндоскопической картины, в сопоставлении с операционными находками. Рецидивы рака желудка развились в течение первого года после операции в 5 случаях, в срок от 1 до 2 лет – в 4, от 2 до 3 лет – в 3, через 3 года – в 5 случаях. По данным морфологического исследования преобладали диффузно-инфильтративный (10 случаев) и язвенно-инфильтративный (7 случаев) характер роста рецидивной опухоли. Аденокарцинома выявлена у 14 больных (у 8 – низкодифференцированная, у 4 – умеренно-дифференцированная и у 2 – высокодифференцированная), недифференцированный рак – у 2, перстневидноклеточный рак – у 1 больного.

Результаты и выводы: Неблагоприятными прогностическими факторами (на этапе операции) являются метастазы в лимфатических узлах, а также наличие опухолевых клеток по линии резекции. При рентгенологическом исследовании органов ЖКТ с контрастированием у послеоперационных больных в большинстве случаев выявлялся стеноз отводящей петли, обусловленный сдавлением кишки извне увеличенным конгломератом лимфатических узлов. Реже выявлялся рецидив в культе диффузно-инфильтративного характера роста, подтвержденный выполнением эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта. Ультразвуковое (УЗИ) и компьютерно-томографическое исследование (по показаниям) позволяло выявить рецидивную опухоль и судить о степени прогрессирования процесса. При УЗИ стенка культы желудка, из которой исходит опухолевый узел, как правило, неравномерно утолщена в зависимости от выраженности инфильтрации, пораженный участок лишен эластичности. Контур четкий, поверхность может быть ровной при чисто инфильтративном росте и бугристой – при смешанном. При рецидивах чаще всего имел место экзогастральный компонент опухоли, который характеризовался объемным образованием, расположенным в брюшной полости и связанным со стенкой культы желудка на ограниченном участке. Особенностью данного варианта роста опухоли является невыраженная опухолевая инфильтрация стенки желудка и сохранение в ряде наблюдений рельефа слизистой над участком поражения, что значительно затрудняло выявление этих опухолей рентгенологически и эндоскопически. Выполненное КТ исследование в большинстве случаев подтверждало наличие рецидивной опухоли, как в культе желудка, так и в зоне анастомоза. Визуализировалась неравномерно утолщенная стенка культы или мягкотканой плотности объемное образование, исходящее из наружного слоя стенки культы желудка. Определялись увеличенные лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства, размерами от 1,5 до 3,0 см. Анализ возможностей лучевых методов исследования показал, что данные рентгенологического метода исследования оказались информативными в выявлении рецидива в культе желудка и в зоне анастомоза. УЗИ и КТ успешно выявляла не только экзогастральный компонент опухоли, инфильтрацию стенок культы желудка, но и поражение лимфатических узлов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОЛУЧЕВОГО И ЛУЧЕВОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ II – III СТАДИИ

Жансагимова З. С.

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: Рак шейки матки (РШМ) занимает 1 место в структуре злокачественных образований женской половой сферы. Несмотря на значительное улучшение диагностики ранних стадий РШМ основной контингент больных поступает в онкодиспансеры с 2-3 стадиями, когда клинические и субклинические метастазы опухоли определяются в различных группах лимфоузлов, при этом в лечении возрастает роль лучевой терапии, особенно при распространенных опухолях, когда оперативное лечение невозможно. Традиционным методом лечения при местно-распространенном РШМ является сочетанная лучевая терапия.

Цель работы: показать эффективность химиолучевой терапии в лечении РШМ с 2-3 стадиями, в сравнении с сочетанной лучевой терапией, как самостоятельного метода лечения.

Материалы и методы лечения: амбулаторные карты диспансерных больных, истории болезней в период 2007-2009 годы.

Проанализировано 117 историй болезни пациентов с РШМ 2-3 стадий.

1 группа - 78 человек, получавших сочетанную лучевую терапию, как самостоятельный метод лечения.

2 группа - 29 человека, получавших сочетанную лучевую терапию в комбинации с монокимиотерапией (онкоплатин) по следующей схеме: 1 раз в неделю внутривенное капельное введение онкоплатина в дозе 50 мг, в режиме облучения 5-7 недель. Суммарная доза онкоплатина 250-300 мг за весь период облучения.

Анализ результатов: в 1 группе по окончании курса сочетанной лучевой терапии из 78 человек у 47 отмечалась полная резорбция опухоли.

Во 2 группе из 29 больных, при дозе в т А 50 Грей в т В 35 Грей (ТГТ до СОД 30 Грей + ВГТ 20 Грей) + онкоплатин 200 мг - была отмечена полная резорбция опухоли, в связи с чем произведено 5 радикальных операции, из них у 3 больных гистологически отмечался лечебный патоморфоз 4 степени.

У 21 пациента после проведенной радикальной химиолучевой терапии отмечалась полная резорбция опухоли.

В течение года продолженный рост опухоли отмечался у 3 пациентов, которые в дальнейшем прошли лечение в отделении химиотерапии.

Результаты и выводы: при лечении больных с РШМ с 2-3 стадиями продемонстрировано достоверное улучшение непосредственных результатов (72% против 52%) после химиолучевого лечения в сравнении с сочетанной лучевой терапией как самостоятельного метода лечения.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Антропова Т.Ю.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

За последние годы в соответствии с программой модернизации парка оборудования лучевой терапии практически во всех онкологических учреждениях республики были установлены новые современные гамма-терапевтические и рентгенотерапевтические аппараты, симуляторы, компьютерные планирующие системы, в нескольких областных диспансерах

начата установка линейных ускорителей. В связи с этим остро встает вопрос качественного использования оборудования лучевой терапии, для чего необходимо создание и внедрение в практику программы контроля качества.

Контроль качества оборудования является одним из важнейших составляющих программы обеспечения качества лучевой терапии, цель которой – обеспечить подведение к злокачественной опухоли дозы, необходимой для лечения, при минимизации воздействия излучения на нормальные ткани и органы. Применение сложного современного оборудования повышает эффективность лучевой терапии, но требует тщательного контроля физико-технических характеристик, влияющих на точность подведения дозы. Для такого контроля необходимо иметь соответствующие приборы, квалифицированный персонал и методики проведения проверок. Нужны протоколы контроля качества для каждого вида оборудования лучевой терапии, предлучевой подготовки и планирования. Они должны включать все этапы контроля оборудования, начиная от приемки аппарата от поставщика, введения в клиническую эксплуатацию и регулярное проведение дальнейших проверок. В мировой литературе имеется достаточно много рекомендаций по контролю качества оборудования лучевой терапии, разработанных Международным агентством по атомной энергии, Европейским обществом терапевтической радиологии и онкологии, Американской ассоциацией медицинских физиков и другими организациями. В Белоруссии разработаны и официально утверждены протоколы контроля качества для всех видов оборудования лучевой терапии. В Казахстане до сих пор таких документов не было. Контроль физико-технических характеристик оборудования осуществляется в основном специалистами организаций, с которыми заключаются договоры на перезарядку и техническое обслуживание аппаратов лучевой терапии, и выполняется такой контроль зачастую бессистемно и некачественно. Это не может не сказаться на качестве лучевого лечения. Совершенно необходимо разработать и внедрить в обязательную практику документы программы контроля качества оборудования лучевой терапии и организовать подготовку кадров физиков и инженеров онкоучреждений, которые и должны осуществлять систематический контроль характеристик оборудования.

В КазНИИОиР программа контроля качества для дистанционных гамма-терапевтических аппаратов была разработана и утверждена впервые в 2004 году. За прошедшие годы эта программа дорабатывалась на практике, с учетом вновь появлявшейся литературы, и в 2010 году был принят новый, переработанный вариант. Идет работа по созданию программы контроля качества для линейных ускорителей. Планируется создание аналогичных документов для рентгенотерапевтических аппаратов, аппаратов брахитерапии, симуляторов и планирующих систем. Эти протоколы могли бы стать основой для Республиканской программы контроля качества в лучевой терапии, пройдя утверждение Министерства здравоохранения РК.

Лучевая терапия – сложный комплексный процесс, в котором участвуют врачи, физики, инженеры, техники, медицинские сестры. Качественный результат, то есть эффективное лечение, может быть достигнут только при правильной организации и высокой точности каждого этапа этого процесса.

ПЕРЕХОД ОТ 2-Х МЕРНОЙ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ К 3-Х МЕРНОМУ КОНФОРМНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Антропова Т.Ю., Ким В.Б.,

*КазНИИ онкологии и радиологии г. Алматы, Республика
Казахстан*

С 2005 года в КазНИИ онкологии и радиологии внедрена

методика конформного облучения в 3-D режиме при злокачественных глиомах головного мозга (С71 по МКБ-10). Ранее все больные получали стандартную конвенциональную лучевую терапию в

2-D режиме. При этом, как правило, использовались 2-х полное статическое облучение при классическом режиме фракционирования дозы.

Однако при проведении такого лечения мы не могли подвести суммарные очаговые дозы более 55-60 Гр, что не позволяло добиться полной регрессии остаточной опухоли, в виду её радиорезистентности. Причиной, лимитирующей подведение высоких доз ионизирующей радиации, были местные лучевые реакции, а именно лучевой эпидермит в зоне вхождения радиационных полей, отек головного мозга ввиду большого охвата здоровых тканей головного мозга. Развитие данного вида реакций и осложнений было связано с невозможностью точно обозначить патологический очаг в 2-х мерном режиме и необходимостью увеличивать поля облучения.

Внедрение конформной лучевой терапии в 3-D режиме позволило нам увеличить суммарную очаговую дозу до 65-70 Гр.

Для планирования конформной лучевой терапии предварительно делалось КТ-сканирование с иммобилизацией пациентов с помощью термопластических масок в положении облучения (на спине). Серия КТ-сканов (толщина слоев сканирования 3 мм) передавалась на планирующую систему Eclipse (VARIAN Medical Systems). Очерчивание объемов мишени делалось с использованием предоперационных МРТ-сканов. Контурирование выполнялось в соответствии с рекомендациями ICRU, Report 62. Видимый объем опухоли (GTV) включал в себя остаточную опухоль и операционное ложе. Клинический объем мишени (CTV) охватывал область микроскопического распространения, включая отек тканей, и представлял собой GTV + 2 см. Планируемый объем мишени (PTV) создавался из CTV добавлением 5 мм для учета движения пациента и геометрических неточностей укладки при лечении. Здоровые ткани мозга, глаза, оптические нервы, хиазма, ствол головного мозга контурировались как органы риска (OAR).

План облучения включал, как правило, 4-6 пучков, с использованием многолепесткового коллиматора. При необходимости для достижения гомогенности облучения очага использовались взвешивающие коэффициенты и клиновидные фильтры. В ряде случаев, чтобы избежать облучения глаза и оптического нерва, использовались некопланарные поля. Оценка планов делалась визуальным сравнением и с помощью гистограмм доза-объем (DVH). Для лечения утверждался план, обеспечивающий облучение очага в пределах 95-105%.

Уменьшение объема облучения здоровых тканей за счет использования многолепесткового коллиматора, а также увеличение числа полей облучения позволило повысить гомогенность облучения очага и значительно снизить лучевую нагрузку на здоровые ткани.

Лучевое лечение проводилось на ускорителе Clinac-600C/D с многолепестковым коллиматором Millenium-80, фотонным пучком энергией 6 МэВ, РОД 2,5 Гр, 5 фр/неделю.

Таким образом внедрение методики конформного облучения позволило в среднем увеличить суммарную очаговую дозу на 20% до 70Гр, и тем самым значительно повысить непосредственную эффективность лучевой терапии, при минимальном количестве лучевых реакций.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА ЛУЧЕВЫХ АППАРАТОВ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Арзыкулов Ж.А., Филиппенко В.И., Ким В.Б.
КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

В Республике Казахстан (РК) ежегодно выявляется около 29 000 новых онкологических больных, и примерно 140 000 состоят на учете. По самым скромным оценкам лучевая терапия (ЛТ) показана не менее чем половине первично выявленных пациентов, а часть из них получает повторное облучение. Таким образом, радиологические отделения в РК должны обеспечивать пропускную способность порядка 25 000 больных в год.

В экономически развитых странах ЛТ подвергаются более чем, 70% онкологических больных. А сам успех применения лучевой лечения не менее чем на половину зависит от возможностей специального диагностического и радиотерапевтического оборудования, поэтому гарантией повышения её эффективности является создание условий для максимального использования современного радиотерапевтического оборудования.

В настоящее время для повышения эффективности ЛТ необходим качественно новый подход в стратегии развития радиологической службы РК. А именно внедрение высокотехнологичных инновационных технологий в ЛТ и визуальной диагностике, т.е. оснащение онкологических учреждений современными линейными ускорителями электронов (ЛУЭ), позволяющими проводить высокотехнологичное лечение и современным диагностическим оборудованием для визуализации опухоли (ПЭТ-КТ, мультиспиральные КТ, МРТ и УЗИ).

Цель: создание высокотехнологических онкорadiологических центров на базе онкологических лечебных учреждений Республики Казахстан.

В настоящее время в РК заканчивается 1-й этап пакетно-модульного переоснащения базовыми лучевыми аппаратами для дистанционной и близкофокусной ЛТ, брахитерапии, а также для предлучевой подготовки – рентгеновскими симуляторами.

Министерство здравоохранения РК и КазНИИ онкологии и радиологии разработали программу модернизации парка лучевых аппаратов на ближайшие 2-3 года, которая включает в себя дальнейшее переоснащение парка лучевых установок современными ЛУЭ, позволяющими проводить конформное, интенсивно-модулированное и управляемое по изображениям облучение. А также установка ПЭТ-КТ, МР и КТ томографов нового поколения.

Прежде всего, необходимо оснастить областные онкологические диспансеры новейшими ЛУЭ, позволяющими проводить облучение в фотонном и электронном режимах, применять конформное, интенсивно-модулированное, и управляемое по изображениям лучевое лечение, а, также радиохирургическое лечение (стереотаксическое). К преимуществам эксплуатации ЛУЭ относится отсутствие необходимости учитывать распад радионуклидного источника и заменять его через несколько лет. А также высокая энергия излучения ускорителей (от 4 до 25 МэВ), обеспечивающая большую проникающую способность излучения и эффект сжатия поверхностных здоровых тканей.

Кроме того, необходимо современное диагностическое оборудование для визуализации опухоли (ПЭТ-КТ, мультиспиральные КТ, МРТ и УЗИ), позволяющие наиболее точно определить топографическую локализацию опухоли, степень её распространения, и тем самым провести прецизионное

облучение с минимальным повреждением окружающих нормальных тканей.

На базе КазНИИОиР планируется создание центра протонной терапии единственного в Казахстане и Средней Азии, который позволит сделать качественно новый шаг в реализации концепции радикальной лучевой терапии, а также установка радиохирургического комплекса «кибер-нож». Кроме того, наиболее остро стоит вопрос об открытии центра радионуклидной терапии, а именно лечение открытыми и закрытыми радиоизотопами. В настоящее время в Казахстане нет отделения радионуклидной терапии (ядерной медицины) и пациенты вынуждены ехать на лечение в Россию или дальше зарубежье.

Реализация данного плана позволит сделать качественно новый прорыв в радиологической службе РК.

КОМПЛЕКСНОЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ И ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

*Байжанов Ш.К., Каххаров Ж.Н., Бабаева Н.Г.,
Рахматуллаева Д.Э., Убайдуллаев У.Э.*

*Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,
Узбекистан.*

Наше исследование основано на 62 больных с глиобластомой головного мозга.

Задача исследования: оценить возможности различных вариантов химио-лучевой терапии в составе комплексного лечения глиобластом головного мозга. Средний возраст больных составил 42 года.

Общее состояние всех больных 60 и более баллов по шкале Карновскому. Все больные первым этапом были подвергнуты хирургическому удалению. Из них у 27 больных опухоль удалена тотально, а у 35 больных субтотально. В последующем всем больным проведена послеоперационная одновременная химиолучевая терапия.

Первая группа - 30 пациента получила Цисплатин 80 мг/м² в/в., Винкристин 1,4 мг/м² в/в., Ломустин 100 мг/м² Per os (однократно первый день)

Вторая группа - 32 больных получила Цисплатин 80 мг/м² в/в., Винкристин 1,4 мг/м².

Лучевая терапия проведена непрерывным курсом на весь головной мозг РОД 1,8 гр 6 фр в неделю, СОД - 30 гр. и локально РОД - 1,8 гр 6 фр в неделю СОД - 58 гр.

Гематологическая токсичность 3-4 степени развилась у 3 - х больных из первой группы и у второй группы 2 - х больных.

Длительность ремиссии, до прогрессирования опухолевого процесса у первой группой составила 14 мес, у второй 8 мес.

Рецидив на месте образования наблюдалась в 1 - группе у 22 больных и во второй группе 25 больных.

На соседних участках рецидивы наблюдались в первой группе у 8 больных и во второй группе у 7 больных.

Оценивалась длительность ремиссии до прогрессирования, по сколько медиана выживаемости пока не была достигнута.

Заключение: одновременная химиолучевая терапия как с использованием препаратов нитрозомочевины, так и с применением только цисплатина и винкристина обладает приемлемым профилем токсичности. Выявлено увеличение медианы времени до прогрессирования в группе больных получавших комбинированную химиолучевую терапию с использованием ломустина.

Необходимо отметить, что полученные нами результаты лечения больных с данной формой опухолевого поражения головного мозга наиболее эффективны при использовании комплексных методов лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА.

Бутырская И.Г.

*Городской онкологический диспансер, Алматы,
Республика Казахстан*

Актуальность. Рак желудка в настоящее время продолжает занимать ведущее место в структуре онкологической заболеваемости и смертности. У значительной части пациентов заболевание выявляется в стадии распространенности опухолевого процесса, когда только расширенная операция с резекцией соседних органов и расширенной лимфодиссекцией дает возможность достижения ремиссии, а нередко радикальность оперативного лечения становится под сомнение и заканчивается пробной лапаротомией или паллиативной операцией. Для правильного решения вопроса о тактике лечения, объеме оперативного вмешательства и его месте среди других методов необходима точная диагностика распространенности опухолевого процесса.

Цель исследования - изучение информативности предоперационной комплексной лучевой диагностики карцином желудка, включающей стандартизированную методику рентгенологического исследования желудка, расширенное ультразвуковое исследование, КТ брюшной полости.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи обследовано 19 первичных больных, поступивших на оперативное лечение в хирургическое отделение с верифицированным диагнозом рака желудка. В группе обследованных было 9 (47,4%) мужчин и 10 (52,6%) женщин. В предоперационном периоде всем больным было проведено стандартизированное рентгенологическое исследование желудка с применением методики двойного контрастирования, расширенное УЗ-исследование, включающее трансабдоминальную эхографию датчиками 3,5 - 5 МГц и трансвагинальную эхографию датчиками 5 - 8 МГц, компьютерная томография органов брюшной полости с пероральным и внутривенным контрастированием.

Результаты. При комплексном исследовании в 5 (26,3%) случаях процесс оказался значительно более распространенным в сравнении с данными эндоскопии. В 2 случаях (10,5%) эндоскопические изменения характеризовались наличием язвенного дефекта на стенке желудка, а на рентгенограммах и КТ-сканах дополнительно выявлено утолщение стенок на значительном протяжении, указывающее на инфильтративно-язвенный характер роста опухоли. В 3 (15,8%) случаях данные эндоскопии характеризовали преимущественное поражение антрального и выходного отделов желудка, а при проведении рентгеноскопии и КТ выявлено субтотальное поражение, с вовлечением в процесс тела желудка. Местнораспространенный процесс в виде наличия метастатического поражения лимфоузлов абдоминальной группы, инфильтрации парапанкреатической клетчатки был выявлен в 4 (21%) случаях, при этом в 4 (21%) случаях по данным комплексного исследования не было выявлено прорастания опухоли в капсулу печени, диафрагму, перикард. Отдаленные метастазы были выявлены в 6 (31,5%) случаях. Из них в 3 случаях выявлены метастазы в паренхиму печени, в 2 случаях выявлены метастазы в яичники с развитием асцита, в 2 случаях выявлены метастазы Вирхова. В 1 (5,25%) случае заподозрен системный характер заболевания на основании увеличенных абдоминальных и забрюшинных лимфоузлов, спленомегалии и метастатического поражения почек (случай подтвержден гистологически).

Выводы. Комплексная лучевая диагностика различных форм рака желудка позволяет повысить точность дооперационной диагностики, уточнить глубину инвазии опухоли, протяженность опухолевого процесса по органу, правильно определить стадию опухолевого процесса, что дает возможность планировать объем оперативного вмешательства и его целесообразность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОИНФУЗИИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА.

Джураев М.Д., Нематов О.Н., Эгамбердиев Д.М.
Онкологический научный центр Узбекистана, г. Ташкент

Цель: Изучить эффективность масляной химиоэмболизации и внутриартериальной химиоинфузии при нерезектабельном гепатоцеллюлярном раке печени на фоне цирроза.

Материал и методы: Проведен анализ лечения 102 больных с гепатоцеллюлярным раком печени. Мужчин 79, женщин 23. Возраст больных колебался от 14 до 78 лет, в среднем составил 53,4. Морфологическая верификация достигнута у 97 больных (95,1%) путем применения пункционной биопсии, лапароскопической биопсии и биопсии из опухоли во время пробной лапаротомии с взятием материала из опухоли и наиболее цирротически измененного участка печени. Все больные разделены на три группы:

1 группа - 23 (22,5%) больных, которым проведена системная химиотерапия.

2 группа - 33 (32,4%) больных, проведена длительная регионарная эндоартериальная химиотерапия.

3 группа - 46 (45,1%) больных, проведена масляная химиоэмболизация печеночной артерии пораженной опухолью доли печени.

Результаты: Результаты и эффективность оценивались согласно рекомендациям ВОЗ. Полная регрессия опухоли не отмечалась ни у одного больного. В первой группе частичная регрессия опухоли составила у 2 (8,7%) больных, стабилизация 16 (69,6%), прогрессирование у 5 (21,7%), средняя продолжительность жизни при этом составила 6,4 + 1,2 месяцев. Во второй группе соответственно 10 (30,3%); 19 (57,6%); 4 (12,1%), средняя продолжительность жизни составила 13,2 + 1,4 месяцев. У третьей группы – частичная регрессия отмечена у 30 (65,2%), стабилизация у 16 (34,8%), прогрессирование не отмечено ни у одного больного, средняя продолжительность жизни составила 18,5 + 1,6 месяцев.

Заключение: Химиоинфузия печеночной артерии по эффективности уступает масляной химиоэмболизации, но результаты несколько лучше, чем при применении системной химиотерапии.

ЗНАЧЕНИЕ МЕМБРАННОГО ГЛИКОПРОТЕИНА В РАЗВИТИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Джураев М.Д., Нематов О.Н., Эгамбердиев Д.М.
Онкологический научный центр Узбекистана, г. Ташкент

Актуальность: Несмотря на достижения современной фармакологии, эффективность химиотерапии опухолей остается недостаточной. Это связано с важнейшей особенностью живых систем (в т.ч. опухолевых клеток) – способностью адаптироваться к изменениям внешней среды. Одно из проявлений такой пластичности – развитие в опухолевых клетках устойчивости к лекарственным препаратам. Основной механизм лекарственной устойчивости – пониженное накопление препаратов в клетке, обусловленное активным выведением веществ в межклеточную среду. Такой транспорт осуществляется белком плазматической мембраны Р гликопротеином (Pgp), кодируемым геном MDR1 (multidrug resistance 1).

Цель исследования: Изучить роль мембранного гликопротеина в развитии лекарственной устойчивости на химиотерапию при нерезектабельном раке желудка.

Материалы и методы: В абдоминальном отделении РОНЦ МЗ РУз 10 больным с нерезектабельным раком желудка проведена системная химиотерапия в комбинации препаратов фторурацил, доксорубин и цисплатин. Мужчин 7, женщин

3. Возраст больных колебался от 33 до 74 лет, в среднем составил 58,7. Всем больным перед проведением системной химиотерапии определен уровень мембранного гликопротеина, среднее значение которого колебалось от 0,718 до 0,943 мкмоль/мин/Нв.

Результаты: После завершения двух курсов полихимиотерапии изучена эффективность химиотерапии согласно рекомендациям ВОЗ. Полный ответ не отмечался ни у одного больного. Частичная регрессия опухоли составила у 1 (10%), стабилизация у 5 (50%), прогрессирование у 4 (40%) больных. У больных, у которых отмечалась прогрессия процесса, уровень мембранного гликопротеина в крови имел высокие цифры, частичная регрессия и стабилизация опухоли отмечалась у больных с низким показателем мембранного гликопротеина в крови.

Выводы: Таким образом, высокий уровень в крови больных мембранного гликопротеина может своевременно предсказать о развитии лекарственной устойчивости. Это один из многих факторов в развитии множественной лекарственной устойчивости.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Дигаи Л.К.¹, Жусупова Ж.Т.¹,
Мустафина Б.К.², Крискус Л.К.², Дигаи А.К.²
¹Республиканский диагностический центр, г. Астана,
²Городской онкологический диспансер, г. Астана

Несмотря на большое число методов исследования, применяемых в гинекологии, продолжают поиски новых путей изучения внутренних половых органов, причем существенное внимание уделяется таким критериям, как неинвазивность, безопасность и высокая информативность.

Цель исследования – оценить эффективность методов диагностики рака шейки матки в процессе лечения и в возникновении рецидивов.

Материалом для исследования послужили данные о 193 больных раком шейки матки, проходивших лечение за период с 2004 до 2009 годы в городском онкологическом диспансере г. Астаны. Основными критериями включения в исследование явились: морфологически подтвержденный диагноз рака шейки матки и проведение магнитно-резонансной томографии на различных этапах диагностики и лечения.

Методы исследования – всем больным были проведены общеклинические, морфологические исследования.

В качестве лучевых методов диагностики проводились УЗИ и МРТ. Магнитно – резонансная томография проводилась на аппарате Magnetom Avanto (Siemens – Германия) с напряженностью 1,5 Тесла с использованием поверхностной катушки. Протокол исследования включал Т2-взвешенные изображения (ВИ) в сагитальной, коронарной и аксиальной плоскостях, Т1-ВИ в аксиальной плоскости, Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира, Т1-ВИ в сагитальной и аксиальной плоскостях с внутривенным контрастным усилением.

Ультразвуковые исследования проводились на аппарате Logiq 5 EXP с конвексным датчиком для абдоминальных исследований 3,5-5 МГц и внутриполостным конвексным датчиком 8-10 МГц.

Результаты и выводы: При первичной диагностике рака шейки матки по данным МРТ у 23 больных выявлено вовлечение в опухолевый процесс эндометрия матки, у 17 влагалища, у 4 – сочетанное поражение эндометрия матки и влагалища, в 4 случаях прорастание в прямую кишку, в 2 – в мочевой пузырь, у 55 больных выявлены увеличенные лимфатические узлы. Таким образом, для магнитно-резонансной томографии при первичной диагностике рака шейки матки коэффициент эффективности (Keff) равняется 142,9, что в 13,1 раза превышает показатель Keff для УЗИ.

Разница коэффициентов эффективности при Tis пре-

вышает 22,3 раза, при T1 Keff для УЗИ равен 0, так как при небольших размерах опухоли не выявил ни в одном случае увеличенные лимфатические узлы, которые были выявлены при МРТ. Разница Keff для УЗИ и МРТ при T2 составила 6,1 раза, при T3 эта разница составила 15,5 раз, при T4 эта разница составляет 22,3 раза. Таким образом, экономически наиболее эффективно проведение МРТ при небольших размерах опухоли (T1 или T2).

По результатам проведенного исследования установлено, что магнитно-резонансная томография обладает большей чувствительностью и эффективностью по сравнению с результатами УЗИ. В то же время клинко-экономический анализ показал, что к проведению МРТ нужно подходить селективно, наиболее экономически целесообразно назначение МРТ при размерах первичной опухоли T2.

ТРЕХМЕРНЫЕ 3-D ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ К КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Ким В.Б., Антропова Т.Ю., Кайназаров Ч., Ибраимова М.А., Сырымбеткызы Ж., Алмабекова А.Т., Галушкин М.А., Садыков С.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Основной задачей лучевой терапии (ЛТ) является уничтожение опухолевых элементов с максимальной защитой нормальных тканей и органов от повреждающего действия ионизирующей радиации для сохранения их регенераторной способности. При этом использование линейных ускорителей – позволяет подвести к опухолевому очагу достаточно высокие суммарные дозы, обеспечивающие хороший терапевтический эффект. Однако это сопряжено с опасностью лучевого повреждения здоровых тканей, попадающих в зону облучения. Поэтому прецизионное облучение стало современным стандартом лучевого лечения. Оно достигается путем использования объемного 3-D планирования и конформной лучевой терапии (КФЛТ) на линейных ускорителях с многолепестковым коллиматором (MLC).

Предлучевая топометрическая подготовка к объемному облучению базируется на специально проводимых рентгенологических, ультразвуковых, радиоизотопных, антропометрических и других методах исследования. Она определяет объем облучаемых тканей, его глубину расположения в теле больного и соотношение с окружающими органами и тканями. На основании полученных результатов определяются поля облучения. Наконец, топометрические исследования обеспечивают одинаковые условия облучения при всех сеансах ЛТ.

Следует учесть, что в связи с появлением КТ, МРТ и ПЭТ-КТ, создаются принципиально новые возможности предельно точной наводки пучков излучения на «мишень». От анализа расположения «мишени» на плоскости совершается переход к объемному восприятию опухоли, от анатомической информации к геометрическим представлениям, к построению сложных дозиметрических распределений, обеспечиваемых компьютерными программами. Их использование позволяет осуществить в полной мере все концепции трехмерного конформного облучения. А сама ЛТ по данной методике – это новая технология, которая позволяет улучшить распределение и сконцентрировать подводимую дозу к опухоли, не увеличивая частоту постлучевых осложнений.

Это достигается с помощью пространственного изображения в 3-х плоскостях. Проводится КТ-сканирование с шагом в 3-5 мм, что позволяет получить более четкое изображение опухоли, ближайших тканей и точно произвести разметку и расчеты для подведения высокой дозы к опухоли.

Нами впервые в Республике Казахстан был отработан технологический цикл предлучевой подготовки к проведению конформной ЛТ с применением рентгеновского симулятора «Acuity CBCT» с компьютерно-томографической приставкой.

Этапы предлучевой подготовки включали в себя: 1) иммобилизацию пациента, т.е. области, подлежащей облучению, с использованием индивидуальных термопластических фиксирующих устройств; 2) симуляции на «Acuity CBCT» с вынесением опорной точки; 3) получение КТ и МРТ срезов области подлежащей облучению при идентичных условиях с переносом их в систему дозиметрического планирования; 4) контурирование мишени и критических органов, реконструкция объемного 3-D виртуального изображения анатомических структур, попадающих в зону облучения, а также самой опухоли с сопоставлением их образов с данными КТ и МРТ томограмм; 6) виртуальное дозиметрическое планирование с формированием защитных блоков с помощью встроенных защитных лепестков симулятора; 7) верификация плана на симуляторе и линейном ускорителе с применением MLC; 8) контроль качества с помощью портальной визуализации на системе «Portal vision»; 9) проведение сеансов КФЛТ.

Таким образом, оптимизация технологического цикла предлучевой подготовки для проведения КФЛТ с применением рентгеновского симулятора «Acuity CBCT», позволило значительно сократить сроки его проведения до 2-3-х дней, а также повысить точность и качество, что позволило улучшить непосредственные результаты ЛТ.

ВОЗМОЖНОСТИ КАЛУМИДА В ПОВЫШЕНИИ ГОРМОНОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ким В.Б., Филиппенко В.И., Ажигалиев Н.А., Сырымбеткызы Ж., Ибраимова М.А., Алмабекова А.Т., Нурғалиев Н.С.
КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

В последнее время рак предстательной железы (РПЖ) становится наиболее распространенным злокачественным новообразованием у мужчин, занимая лидирующее положение во многих странах мира. В лечении РПЖ применяют весь арсенал специфического противоопухолевого воздействия: хирургический, лучевой, химио- и гормональный.

Среди всех гормонально зависимых опухолей РПЖ считается наиболее чувствительными к гормональной терапии (ГТ), которая является наиболее эффективным методом лечения данного заболевания, позволяющим добиться положительного результата в большинстве случаев, как в самостоятельном режиме, так и в комбинации с лучевой терапией (ЛТ) или операций.

Установлено, что нормальные и малигнизированные клетки простаты чувствительны к андрогенам, которые вырабатываются в яичках и надпочечниках. Поэтому механизм действия антиандрогенов основан на блокаде андрогеновых рецепторов, и в зависимости от химической структуры подразделяются на 2 группы: стероидные и нестероидные. Отличием нестероидных антиандрогенов является отсутствие блокады синтеза тестостерона, поэтому у пациента сохраняется половое влечение и сексуальная активность.

Лучевая терапия (ЛТ) РПЖ является методом выбора, в определенной степени конкурирующим с простатэктомией. Следует отметить, что ЛТ не вызывает столь серьезных осложнений, как хирургическое вмешательство и качество жизни больных, практически не страдает. При этом следует отметить, что с внедрением методик конформной, интенсивно-модулированной и управляемой по изображениям ЛТ, отдаленные результаты обеих (операции и облучение) методов лечения стали приблизительно одинаковы. Однако сама ЛТ в отличие от радикальной простатэктомии не сопровождается теми грозными осложнениями, которые возникают после проведенной операции.

Цель исследования – повышение эффективности лечения местнораспространенного рака предстательной железы.

Материал и методы – В контролируемое исследование январь 2005 – январь 2010 включено 90 больных местнораспространенным РПЖ (T3-4N0-1M0) в возрасте 56-72 года, разделенных на 2 группы. Средний уровень ПСА до начала лечения составил 98,9 нг/мл (от 25 до 285 нг/мл). Гистологически с G1, G2, G3-4 было 21 (23,3%), 36 (40,0%), 33 (36,7%) больных соответственно. В 1-й группе у 47 (52,2%) больных в неoadьювантном режиме в течение 3-х месяцев проводилась гормонотерапия (ГТ) по схеме МАБ: золадекс 3,6 один раз в 28 дней + калумид 50 мг ежедневно, с дальнейшей конформной лучевой терапией (КФЛТ) в СОД 70-74 Гр и последующей адьювантной ГТ по той же схеме. Во 2-й группе у 43 (47,8%) больных лечение начинали с КФЛТ и одновременным назначением калумида в дозе 150 мг ежедневно и дальнейшей самостоятельной ГТ в монорежиме калумидом. У всех больных проводился ТРУЗИ, МРТ, КТ контроль для диагностики заболевания и планирования КФЛТ.

Результаты и обсуждение. Объективный эффект в 1- и 2-й группах был достигнут у 42 (89,4%) и 39 (90,7%) больных, при полных регрессиях у 38 (80,9%) и 35 (81,4%) больных соответственно. Отмечалось снижение ПСА до 1,8 и 3,4 нг/мл в 1-й и 2-й группах соответственно. Общая 5-летняя выживаемость составила в 1-й группе 71,9%, что достоверно превышало аналогичные показатели 2-й группы на 8,1%, где она составила 63,8% соответственно. Медиана общей выживаемости в 1-й и 2-й группах составила 57,5 и 53,1 месяцев соответственно, при статически значимой разнице в 4,4 месяца. Следует отметить, что у большинства больных, принимавших калумид, сохранялась эректильная функция, половое влечение. Нами не отмечено практически никаких побочных токсических эффектов от приема калумида.

Таким образом, полученные непосредственные и отдаленные результаты свидетельствуют о высокой эффективности, проведенной гормонолучевой терапии у больных РПЖ. При этом наилучшие результаты получены при использовании ГТ по МАБ схеме.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОМУСТИНА И ТЕМОДАЛА В ХИМИО- И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МУЛЬТИФОРМНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ

¹Ким В.Б., ¹Ажигалиев Н.А., ³Акшулаков С.К., ¹Сырымбеткызы Ж., ²Дюсембеков Е.К., ¹Ахметова Г.С., ¹Ибраимова М.А., ¹Кайназаров Ч., ¹Галушкин М.А., ²Есентаева С.Е.
¹КазНИИОнР г. Алматы, ²АГИУВ г. Алматы, ³РНЦНХ г. Астана, Республика Казахстан

Проблемы лечения мультиформной глиобластомы (МГБ) является одной из сложных задач современной нейроонкологии. МГБ - наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль головного мозга - до сих пор имеет весьма неблагоприятный прогноз, даже при комплексном лечении. Поэтому за последние 30 лет не прекращаются поиски более эффективных программ терапии.

Цель исследования – повышение эффективности комплексного лечения больных мультиформной глиобластомой

Материал и методы. В контролируемое исследование январь 2005 – январь 2010 включено 61 больных МГБ, проходивших в послеоперационном периоде химио- и лучевое лечение и разделенных на две группы в зависимости от методики химиотерапии (ХТ). У всех пациентов вначале проведено оперативное вмешательство в объеме тотального или субтотального удаления опухоли. Далее больным проведена конформная лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 70 Гр за 28 фракций при разовой очаговой дозе 2,5 Гр в сочетании с приемом темодала (TZM) 100 мг № 40-45 ежедневно на протяжении всего курса. Допускалось проведение конвенционального облучения. Первичная симуляция проводилась на рентгеновском симуляторе «Acuity CBCT» с КТ-

приставкой с изготовлением индивидуальных фиксирующих масок. План дозиметрического расчета осуществлялся в 3-D режиме на системе компьютерно-дозиметрического планирования «Eclipse-6» с выведением зон интереса и критических органов. Верификация плана облучения реализовывалась вначале на симуляторе с использованием встроенных защитных лепестков, и, далее на линейном ускорителе «Clinac 600 C/D» с MLC. Контроль качества конформной лучевой терапии проводился с помощью портальной визуализации на системе «Portal vision».

В зависимости от схемы ХТ больных разделили на две группы. В 1-й группе у 31 (50,8%) больных применялся карбоплатин 600 мг 1-й день + TZM 250 мг 1-5 дни; во 2-й группе у 30 (49,2%) использовался ломустин (CCNU) 120 мг 1-й день + TZM 350 мг 2-6 дни. Лечение продолжали до начала прогрессирования опухоли, развития непереносимой токсичности или завершения 6 циклов ХТ.

Оценка результатов лечения проводилась с помощью МРТ исследования.

Результаты и обсуждение. Общий ответ после проведенного химио- и лучевого лечения был получен у 19 (61,2%) и 25 (86,2%) 1-й и 2-й групп соответственно при статически достоверной разнице в 25,0% (p<0,05). Количество полных ответов после окончания курса химио- и лучевой терапии составило соответственно в 1-й группе 3 (9,7%) во 2-й группе 4 (13,7%), частичных ответов 9 (29,0%) и 15 (51,7%) соответственно при статически значимой разнице в 22,7% (p<0,05).

Общая 2-х летняя выживаемость составила во 2-й группе 34,9%, и достоверно превышала на 13,6%, аналогичный показатель 1-й группы, где она составила 21,3%. Медиана общей выживаемости в 1-й и 2-й группах была 15,6 и 22,5 месяцев при статически значимой разнице в 6,9 месяцев.

Следует отметить, что гематологическая и негематологическая токсичность от проведенной адьювантной химиотерапии была примерно одинаковой.

Таким образом, полученные клинические данные показали, что включение ломустина в схему послеоперационной химиотерапии позволило добиться более высоких непосредственных и отдаленных результатов лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ

Мухитдинова И.Н.

Южно-Казахстанский онкологический диспансер

Злокачественные опухоли кожи занимают последнее место в структуре смертности от злокачественных новообразований. Подобная ситуация создает иллюзию относительной доброкачественности злокачественных опухолей кожи.

В структуре онкопатологий по Южно-Казахстанской области новообразования кожи продолжают занимать IV место. За последний год частота новообразований кожи составила 8,3/000 (в 2003г. - 9,9/000).

Цель: Изучить распространенность рака кожи и оценить результаты лучевого лечения.

Материалы и методы: Из первично зарегистрированных 989 больных к лучевому лечению подверглись 509 больных, что составляет - 50,4%. Из них: мужчины 254 - 49,9%, женщины 255 - 50,1% больных. По возрасту: до 50 лет - 44 (8,3%), до 60 лет - 79 (15%), до 70 лет - 152 (28,7%) и свыше 70 лет - 254 (48%) больных. По степени заболевания: I-II стадия - 459 (86,8%), III стадия - 60 (11,3%), IV стадия - 10 (1,9%) больных. Среди больных раком кожи преобладали пожилые люди - 74,9%, особенно велико их число среди больных женщин.

Наиболее часто поражаются область головы (щеки, нос, ушные раковины) и шеи. Плоскоклеточный рак - 298 (58,5%), базально-клеточный рак - 211 (41,4%).

Короткодистанционная R-терапия проводилась на аппарате «Рентген-ТА», в последние годы «Голмэй», с набором тубусов различного диаметра при напряжении генерирования 60

кВ, силе тока 5 мА, с фильтром 1,2 мА, РИП – 40 мм, по пять фракций в неделю. Величина поля облучения превышала видимую границу опухоли не менее чем на 1 см. При экзофитном росте опухоли и больших размерах лечение начинали с дистанционной гамма-терапии на аппарате «ТЕРАГАМ», дозу облучения доводили до 30-35 Грей, в последующем лечение продолжали на аппарате «Рентген - ТА».

Из числа больных подвергшихся лучевому лечению новообразования на коже лица и волосистой части головы были расположены у 437 (85,8%) больных и у 72 (14,1%) больных опухоли расположились на коже туловища и конечностях.

Результаты. Полная регрессия опухоли кожи от исходного размера опухоли составила у 404 (79,4%) больных. Значительная регрессия опухоли у 101 (19,8%) больных. Отсутствие регрессии наблюдалось у 4 больных (0,8%). Отсутствие регрессии связано с тем, что они не явились для продолжения лечения. Ближайшие результаты лучевого лечения: с I—II— стадией заболевания 3 года без рецидива живут - 99,3% больных, 0,7% больных лечились повторно с рецидивами, с III - стадией заболевания 68% больных живут без рецидива и метастазов, 11% больных лечились повторно от рецидива, 11,3% исчезли из наблюдения, 9,7% умерли от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, на современном этапе выбор метода лечения рака кожи должен быть ориентирован на стадию опухолевого процесса и анатомические особенности локализации рака кожи. В заключении можно отметить, несмотря на визуальности локализации удельный вес с III-IV-стадией заболевания остается высокой, при которой эффективность лучевого лечения резко падает по сравнению с малыми размерами опухоли кожи.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Молдашева А.М.

*Казахстанско – Российский медицинский университет.
Алматинский городской онкологический диспансер*

Актуальность. Основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический. Несмотря на совершенствование техники операции, соблюдение принципов онкологического радикализма. 5-летняя выживаемость колеблется в пределах 46 – 58%, причем около 20 – 40% больных погибают в течение первых трех лет в результате возникшего рецидива рака (Ожиганов Е.Л., 1993, Масляк В.М. с соавт., 1996, Ю.М.Тимофеев, 1997, Ю.А.Барсуков с соавт., 1998, В.И.Чиссов с соавт., 2006.).

В целях повышения эффективности хирургического лечения применяется предоперационная лучевая терапия, которая все еще не нашла всеобщего признания в силу разнозначности показателей выживаемости больных и отсутствия единой методики ее применения.

Цель – оценить эффективность хирургического и комбинированного лечения рака прямой кишки по непосредственным и отдаленным результатам.

Материал и методика. Нами проведена сравнительная оценка непосредственных результатов и трехлетней выживаемости 112 больных раком прямой кишки, подвергавшихся хирургическому (57 больных) и предоперационному облучению (55 больных). Облучение проводилось интенсивно – концентрированным методом (ежедневно РД 5Гр до СОД 20Гр). Операция осуществлялась через 1 – 3 дня после последнего сеанса облучения. Распределение больных по локализациям, стадиям, видом операции и гистологической форме опухоли в обеих группах были приблизительно одинаковые. Резектабельность среди 57 больных подвергавшихся только хирургическому лечению составила 87,8%, комбинированному – 89,0%. Среди 112 оперированных больных у 30 (26,8%) имело место различного характера осложнения

в послеоперационном периоде. При хирургическом лечении у 29,1%, комбинированном – 24,5%, летальность – соответственно 4,2% и 5,2%. Лучевой патоморфоз у подавляющего большинства больных (85%) был II степени.

Трехлетняя выживаемость по основным прогностическим факторам изучалась у 94 больных (по 47 больных в каждой группе). Трехлетняя выживаемость после хирургического лечения равнялась 42,5±7,0%, комбинированного – 48,2±7,2%.

У больных с III стадией (Т3N1M0) трехлетняя выживаемость соответственно составила 26,0±8,6% и 12,0±6,6%, а при дифференцированной аденокарциноме – соответственно 42,8±11,0% и 50,0±13,9%, недифференцированный – 40,0±10,0% и 53,5±9,6%.

Выводы.

1. Предоперационная лучевая терапия, проведенная интенсивно – концентрированным методом не ухудшает создает дополнительных технических трудностей во время выполнения операции на прямой кишке.

2. Послеоперационные осложнения и летальность практически не отличается от такового у аналогичных больных, оперированных без облучения.

3. По основным прогностическим факторам трехлетняя выживаемость больных при комбинированном лечении несколько лучше, чем при одном хирургическом лечении ($p>0,05$).

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Филиппенко В.И., Савхатова А.Д., Сарсенбаева Г.Е.

*Казахский научно исследовательский институт
онкологии и радиологии*

Под опухолями мягких тканей, согласно определению научного комитета ВОЗ, понимают все неэпителиальные опухоли, за исключением новообразований ретикулоэндотелиальной системы и опорной ткани органов. Источники развития опухолей МТ могут быть производные всех зародышевых листков: эктодерма, мезодерма, энтодерма. Знание эмбриогенеза тканей позволяет определить гистопринадлежность опухоли.

Лечение сарком мягких тканей должно быть многокомпонентным и направлено одновременно на борьбу с рецидивами опухоли и метастазами. Наиболее распространенным на практике является метод предоперационной лучевой терапии, который снижает биологическую активность опухоли, уменьшает риск возникновения рецидивов, а также имплантационных и отдаленных метастазов, создает более благоприятные условия для хирургического вмешательства: уменьшения перифокального воспаления в объеме опухоли, уменьшения общего объема опухоли, формирование «ложной капсулы» вокруг опухоли, более четкое её отграничение от окружающих здоровых тканей.

По результатом наших исследований интервал между предоперационной лучевой терапией и операцией составил 2,5 – 3 недели. При меньшем сроке оперативное вмешательство затруднено из-за отека, реактивных изменений окружающих тканей, на 3-4 неделе возобновляется рост опухолевых клеток, которые сохранили жизнеспособность, и тем самым теряется эффект облучения. Послеоперационную лучевую терапию проводили после условно радикальных операций для уничтожения остаточных опухолевых комплексов. Лучевое воздействие разрушает диссеминированные в ране опухолевые клетки и предупреждает развитие рецидивов и метастазов, подавляет рост оставленных элементов опухоли. Необходимо иметь в виду, что при облучении с больших полей в плане пред- или послеоперационной лучевой терапии СОД не должны превышать 50-52 Гр, а в случае их сочетания 70Гр (дозы приведены с учетом ВДФ при условии классического

фракционирования) Радикальное послеоперационное облучение начинали через 4-6 недель после полного удаления опухоли для контроля субклинических очагов в ложе опухоли. Интраоперационная лучевая терапия реализовали как при радикальной операции, так и при паллиативных вмешательствах. При проведении брахитерапии СОД 45 Гр. После удаления опухоли хирург укладывает в послеоперационную рану эндостаты в интервале 1 см в заданном объеме мишени. При высокодифференцированных саркомах мягких тканей, использование брахитерапии позволяет увеличить 5- летнюю выживаемость при только хирургическом лечении с 67 до 82%. Сочетание хирургического и лучевого лечения является локальным воздействием на опухоль. Лечение саркомы МТ должно быть многокомпонентным, включающим комбинированный и комплексный методы.

Тактика лечения вырабатывается на основании степени злокачественности и размера опухоли. Выполнение радикального объема хирургического лечения является адекватным при I стадии процесса, при степени дифференцировки соответствующей G1-2. При II стадии со степенью дифференцировки G1-2 целесообразно применять неоадьювантную лучевую терапию или химиотерапию. При III стадии при любой степени дифференцировки – лечение должно быть комплексным: лучевая терапия + операция + химиотерапия или нео- или адьювантная химиолучевая терапия + операция. При IV стадии - паллиативная химиолучевая терапия или только химиотерапия

Таким образом, улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов возможно только при разумном сочетании всевозможных методов воздействия: лучевая терапия, химиотерапия, радикальная хирургия, пластическое восстановление дефектов мягких тканей.

ЯДРОЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ КЛАСТЕР ҚҰРУ

*Сандыбаев М.Н., Зейнелова Л.Т., Базарбаев Н.А.
Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері*

Өзектілігі. Медициналық радиология өзінің 100 жылдық тарихында сан мың жылдар бойы өмір сүріп келе жатқан хирургиялық және дәрілік медицинаны қуып жетті. Диагностика мен басқарылатын терапиядағы таңдаулы ем әсеріндегі нақты сандық бақылаудың ерекшелігі арқасында медициналық радиология әдістері медициналық көмек тиімділігін анағұрлым арттыра отырып, өлім-жітімді азайтып және тұрғындардың өмір сүру сапасын қамтамасыз ете отырып, мүшені сақтап қалу емдерін жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады.

Мақсаты: Медициналық радиологиялық кластер құру жолымен Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының денсаулық жағдайын жақсарту

Зерттеудің материалдары мен әдістері: Радиацияға байланысты онкологиялық ауруларды анықтау мен емдеу жөніндегі Қазақстанның медициналық орталықтарын (басын қосатын) біріктіретін радиологиялық медицина кластерін дәл Семей қаласында құру туралы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 2009 жылдың 18 маусымында Семейдің ядролық полигонындағы сынақтардың тоқтатылуына 20 жыл толуына арналған митингіде сөйлеген сөзінде айтқан болатын.

Нәтижелер мен тұжырымдар: Ұсынылып отырған Концепцияны жүзеге асыру радиациядан болған онкологиялық ауруларды анықтау мен емдеу жөніндегі Қазақстанның медициналық орталықтарының басын қосатын медициналық радиологиялық кластерді ШҚО Семей қаласында құруға мүмкіндік туғызады. Кластер негізі қазіргі кезде салынып жатқан, сәулелі томографияға арналған (рентгендік, бір фотонды эмиссиялы, позитронды-эмиссиялы) және сәулемен емдеудің ПЭТ анықтау үшін қысқа жасайтын изотоптар алуға шағын циклотронмен дозиметрлеуді жоспарлау

жүйесімен (дистанционды, қуыстық және тіндік) жаңа үлгідегі құрылғылармен, сонымен қатар радионуклидті емге арналған арнаулы оқшауланған палаталармен («ыстық төсектер») жабдықталатын Семей қаласы Өңірлік онкологиялық диспансерінің Радиологиялық орталығы негіз болып табылады.

Төмендегіге қол жеткізуге болады:

- Онкологиялық және онкологиялық емес науқастарды ерте анықтап ядролық технологияға негізделген тиімді ем жүргізу.

- Отандық радиофармпрепараттарды қолдана отырып, ядролық медицинада жаңашыл технологияны енгізу.

- Пациенттердің, персоналдардың радиациялық қауіпсіздігі мен клиникалық дозиметрияның жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

- Диагностика мен емдеу сапасының жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітімді төмендетіп, пациенттердің өмір сүру жағдайын жақсартуға әкеледі.

- Қымбат тұратын құрылғыларды пайдалану тиімділігі және оны алуға жұмсалғанның орны 8-10 (МАГАТЭ) есе артады, өңірдегі онкологиялық және кардиологиялық, эндокринологиялық ревматологиялық, неврологиялық және басқа да науқастарды емдеуге мүмкіндік туғызады. Осының барлығы ядролық технологияға негізделген медициналық кластер құру прецеденті болуы мүмкін.

СИСТЕМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАДИОЭПИТЕЛИТА

Умерзаков М.С.

КГКП «ООДСКО» г. Петропавловск.

Лучевая терапия сопровождается развитием местных и общих реакции. В клинической практике радиоэпидермит протекает в виде гиперемии, отека кожи, болевых ощущений. При появлении мокнутия - экссудативный радиодерматит – возможно присоединение вторичной инфекции. У онкобольных из-за снижения иммунитета процесс заживления принимает затяжной характер. Применение местно лекарственных средств без знания патогенетических механизмов может привести к усилению воспалительной реакции.

Кожа состоит из эпидермиса и собственно дермы. Интерес представляет базальный слой эпидермиса, где находятся стволовые клетки. При воздействии ионизирующего излучения последние прекращают делиться, вышерасположенные слои не обновляются, происходит их физиологическая потеря. Эпидермис отслаивается, что приводит к оголению дермы.

Общепринятые правила щажения облучаемых поверхностей: тщательное планирование, применение болусов, клиновидных фильтров, предупреждают или отодвигают проявления радиоэпителимита. При его развитии необходимо назначить местно лекарственную терапию.

1 стадия воспаления. Высокоэффективны мази и кремы с глюкокортикоидами: оксикорт, преднизолоновая мазь, метазон фуюат.

2 в стадии регенерации с целью ускорения обменных процессов назначают мази с метилурацилом, актовегином

3 Эпителизацию стимулируют сок коланхоэ, лечебные масла (шиповника, персиковое, кызыл-май), аппликации прополиса.

Личный опыт последовательного применения вышеперечисленных средств - 2 года. Лечение назначалось 92 пациентам с зонами облучения локализаций: «голова-шея»; переходная складка молочной железы, подмышечная и паховая области. Суммарная доза от 40 до 60 Грей. После назначения гормональных мазей за 3-5 дней уменьшались гиперемия и отек, в дальнейшем ликвидировались болевые ощущения. По завершению лучевой терапии при контрольных осмотрах - умеренная сухость кожи, алопеция пушкового волоса.

Выводы:

1. Применение местно лекарственных средств с учетом патогенеза радиоэпидермита уменьшает воспалительные реакции в короткие сроки

2. Позволяет провести курс облучения по плану – без вынужденного перерыва.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ.

Кашаков Б.С.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда.

Цель: оценка эффективности сочетанной лучевой терапии при раке шейки матки.

Материалы и методы: Внутриполостная лучевая терапия в Кызылординском областном онкологическом центре стала проводиться с 2008 года с момента приобретения гамма-терапевтического аппарата «Multisource». За период 2008-первые четыре месяца 2010 г.г. в онкологическом центре сочетанную лучевую терапию получили 42 женщины с раком шейки матки. Все больные верифицированы (плоскоклеточный рак), с IIB-IIIВ стадиями заболевания. На первом этапе проводилась дистанционная лучевая терапия до СОД 40 Гр (с центральными блоками после СОД 20 Гр) на область малого таза с захватом тазовых и подвздошных лимфатических узлов. Облучение проводилось на кобальтовом аппарате «Teragam» с РОД 2 Гр 5 раз в неделю. После получения СОД 20 Гр переходили на внутриполостную терапию с РОД 5 Гр на т.А два раза в неделю до СОД 50 Гр. Лучевая терапия проводилась на аппарате «Multisource» с источником Со 60. Суммарная очаговая доза от двух видов облучения составила на т.А 76 Гр, на т.В 57,5 Гр.

Результаты: Эффективность лечения оценивалась на основании динамического наблюдения. У 20 больных (48%) наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения опухоли более чем на 70%, у 16 больных (38%) отмечалась стабилизация процесса и у 6 больных (14%) было прогрессирование процесса (больные с IIIВ стадией).

Выводы: Сочетанная лучевая терапия рака шейки матки является оптимальным методом лечения у больных с IIB-IIIВ стадиями заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК ПРИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Хамзабаев Ж.Х.

АО Медицинский университет Астаны

Рентгенорадиология на современном этапе является важнейшей отраслью клинической медицины. Без ее применения трудно представить постановку и уточнение диагноза, определение распространенности патологического процесса и дать оценку эффективности проведенного лечения.

Не смотря на появление в последние годы нерадиационных методов диагностики, таких как ультразвуковые, термографические и магнитно-резонансной томографии и других, рентгенодиагностика остается главным средством получения диагностической информации в клинической практике. При этом, рентгенография и профилактическая флюорография органов дыхания в нашей стране традиционно считается одной из самых распространенных процедур и достаточно эффективной в плане раннего выявления доклинических форм туберкулеза и рака легкого, заболеваний костно-суставной системы и других органов.

В тоже время, многие специалисты бьют тревогу по поводу опасности таких исследований, открыто заявляя о том, что полученная пациентом доза облучения может негативно сказаться на здоровье. Связано это, главным образом, с плохим состоянием рентгеновского оборудования и флюорографической техники, а отсюда высокая лучевая нагрузка на

пациента, низкое качество изображений пленочных снимков и флюорограмм и трудоемкость архивирования полученных изображений. По данным Международного комитета по радиационной защите, при массовой флюорографии они до-бавляют к средней ежегодной заболеваемости не менее 200 злокачественных опухолей на каждый миллион населения. Иначе говоря, рентгенологические обследования нередко провоцируют возникновение онкологических заболеваний. Ведь по нормам радиационной безопасности доза облучения, получаемая человеком, не должна превышать 1000 мкЗв в год (от всех видов облучения, не относящихся к медицинским диагностическим). Старый пленочный флюорограф обеспечит ее за один снимок!

В докладах ежегодной научно-практической конференции РАМН сообщается об итогах комплексной оценки условий труда медицинского персонала в отделениях лучевой диагностики. Данные ИДК показали, что наибольшие дозовые нагрузки приходятся на хирургов-травматологов (до 16 мЗв/год, а так же на рентгенохирургов, выполняющих сердечно-сосудистые интервенционные исследования с использованием рентгеновской техники (до 10-13 мЗв/год). Вместе с тем, в санитарных правилах для персонала группы «А» (лица, находящиеся в зоне действия техногенных источников ионизирующего излучения) установлен предел дозы облучения за год в размере 20 мЗв при нормальных условиях эксплуатации.

Учитывая вредные воздействия радиации на организм человека, сегодня во всем цивилизованном мире ведутся активные научные разработки, направленные на минимизацию ее последствий. Среди них важнейшим является постепенный переход на цифровые технологии в радиологии. Так, при использовании метода малодозной цифровой рентгенографии эффективная доза облучения при рентгенографии грудной клетки не превышает 15 мкЗв (микрорентгенов). Сейчас также ведутся активные работы по разработке новых рентгенизлучателей и рентгеновских трубок, новых детекторов с новой оптикой, снижающей дозу в 5-10 раз, а также с увеличенным в 1,5-2 раза количеством каналов.

Необходимо особо подчеркнуть, что широкое внедрение альтернативных нерадиационных методов диагностики (УЗИ, МРТ, соноэластографии, метода Hi-Fu диагностики и терапии) позволит поднять качество радиологической диагностики на более высокий уровень без негативных лучевых нагрузок.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что обеспечение радиационной безопасности при радиографии, без снижения ее качества, является важнейшей задачей рентгенорадиологической службы.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ И КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сырымбеткызы Ж., Талаева Ш.Ж.,

Ким В.Б., Жандосова Э.У.

КазНИИОур, г. Алматы, Республика Казахстан

В большинстве развитых стран мира в том числе и в Республике Казахстан рак молочной железы (РМЖ) прочно занимает первое место по заболеваемости в общей структуре онкологических заболеваний у женщин. Рак молочной железы как ни одно другое онкологическое заболевание, затрагивает профессиональную, социальную и интимную сторону жизни женщины. Именно поэтому возможность восстановления груди после мастэктомии с психологической и эстетической точки зрения является крайне важной. В настоящее время онкологи и пластические хирурги сходятся во мнении, что одномоментная реконструкция молочной железы, выполненная по показаниям, является гарантированным и безопасным

методом хирургической реабилитации пациенток, оперированных по поводу рака молочной железы, поэтому число одномоментных реконструкций груди во всем мире неуклонно растет. В то же время необходимость локального контроля с помощью лучевой терапии после данных операции по прежнему остается дискуссионной, что связано с возникновением большего количества местных лучевых реакций. Использование 3D технологий в предлучевой подготовке и лучевом лечении, т.е. конформная лучевая терапия (КФЛТ), позволяет минимизировать данные риски.

Цель исследования – повышение эффективности комплексного лечения рака молочной железы, путем использования одномоментной реконструкции молочной железы с применением имплантов и конформной лучевой терапии (КФЛТ).

Материалы и методы. В исследование январь 2009 – январь 2010 включено 21 больных РМЖ в стадии IIA-IIB, которым после 4 курсов неoadъювантной химиотерапии проведена одномоментная реконструкция молочной железы. Метод пластики молочной железы зависел от распространенности процесса, стадии и локализации опухоли. Методики одномоментной реконструкции молочной железы в сочетании с имплантом были таковы: торако-дорсальный лоскут (ТДЛ) в сочетании с имплантом и кожесберегающая мастэктомия (skin-sparing mastectomy) с одномоментной реконструкцией в комбинации с имплантом. В адъювантном режиме пациенткам проведена конформная лучевая терапия РОД=2Гр, 5 фракции в неделю СОД= 50 Гр за 25 фракций. Первичная симуляция проводилась на рентгеновском симуляторе «Acuity CBCT» с компьютерно-томографической приставкой на специальной подставке с фиксирующими устройствами. План дозиметрического расчета осуществлялся в 3-х мерном (3-D) режиме на системе компьютерно-дозиметрического планирования «Eclips-6» с выведением зон интереса и критических органов (легкие, сердце). Верификация плана облучения реализовывалась вначале на симуляторе с использованием встроенных защитных лепестков, и, далее на линейном ускорителе «Clinac 600 C/D» с MLC.

Контроль качества конформной лучевой терапии проводился с помощью портальной визуализации на системе «Portal vision».

Результаты и обсуждение. В результате проведения КФЛТ нами не выявлено ни одного случая лучевых осложнений. У 17 (85,0%) больных отмечена эритема кожи, у 3 (15,0%) сухой эпидермит. Нами не выявлено ни одного случая лучевого пульмонита или перикардита по данным проведенных рентгенологических, КТ, ЭКГ исследований. В течение всего периода наблюдения от 2 до 12 месяцев ни у одной пациентки не отмечено случая рецидива болезни. Таким образом, проведение КФЛТ в послеоперационном периоде после одномоментной реконструкции с применением имплантов у больных РМЖ, позволяет добиться стойкого непосредственного результата.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сырымбеткызы Ж., Талаева Ш.Ж.

Жандосова Э.У. Ким В.Б.

КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Необходимость первичного радикального удаления, пораженной опухолью, молочной железы одновременно с регионарными лимфатическими узлами, в настоящее время не

все-гда оправдано, а увлечение хирургов сверхрадикальной мастэктомией с лимфодиссекцией парастернальных и других более глубоких лимфатических узлов не улучшило отдаленных результатов лечения. При этом следует учитывать, что РМЖ, как ни одно другое онкологическое заболевание, затрагивает профессиональную, социальную и интимную сторону жизни женщины. Именно поэтому возможность восстановления груди после мастэктомии с психо-логической и эстетической точки зрения является крайне важной.

В настоящее время онкологи и пластические хирурги сходятся во мнении, что одномоментная реконструкция молочной железы (МЖ), выполненная по показаниям, является гарантированным и безопасным методом хирургической реабилитации пациенток, оперированных по поводу рака, поэтому число одномоментных реконструкций МЖ во всем мире неуклонно растет. В то же время необходимость локального контроля с помощью облучения после данных операций по-прежнему остается спорной, из-за большего количества местных лучевых реакций. Использование 3-D технологий в предлучевой подготовке и лучевом лечении, т.н. конформная лучевая терапия (КФЛТ), позволяет минимизировать данные риски.

Цель исследования – повышение эффективности комплексного лечения рака молочной железы, путем использования одномоментной реконструкции молочной железы с применением имплантов и конформной лучевой терапии.

Материалы и методы. В исследование январь 2009 – июнь 2010 включено 24 больных РМЖ в стадии IIA-IIB, которым после 4 курсов неoadъювантной химиотерапии проведена одномоментная реконструкция МЖ с использованием имплантов. Метод пластики МЖ зависел от распространенности процесса, локализации опухоли и достаточного количества имплантируемых аутоклеток, с учетом косметического эффекта. Методики одномоментной реконструкции МЖ в сочетании с имплантом проводились двумя способами: торако-дорсальный лоскут (ТДЛ) в сочетании с имплантом после радикальной мастэктомии и ко-жесберегающая мастэктомия (skin-sparing mastectomy) с одномоментной реконструкцией в комбинации с имплантом. В адъювантном режиме пациенткам проводилась КФЛТ РОД 2Гр, 5 фракций в неделю СОД 50 Гр/ 25 фракций. Первичная симуляция проводилась на рентгеновском симуляторе «Acuity CBCT» с КТ-приставкой на специальной подставке с фиксирующими устройствами. План дозиметрического расчета осуществлялся в 3-D режиме на системе компьютерно-дозиметрического планирования «Eclips-6» с выведением зон интереса и критических органов (легкие, сердце). Верификация плана облучения реализовывалась вначале на симуляторе с использованием встроенных защитных лепестков, и, далее на линейном ускорителе «Clinac 600 C/D» с MLC. Контроль качества конформной лучевой терапии проводился с помощью портальной визуализации на системе «Portal vision».

Результаты и обсуждение. В результате проведения КФЛТ нами не выявлено ни одного случая лучевых осложнений. У 21 (87,5 %) больных отмечена эритема кожи, у 3 (12,5%) сухой эпидермит. Нами не выявлено ни одного случая лучевого пульмонита или перикардита по данным проведенных рентгенологических, КТ, ЭКГ исследований. В течение всего периода наблюдения от 2 до 18 месяцев ни у одной пациентки не отмечено случая рецидива болезни.

Таким образом, проведение КФЛТ в послеоперационном периоде после одномоментной реконструкции с применением имплантов у больных РМЖ, позволяет добиться стойкого непосредственного результата без выраженных местных лучевых реакций и полном отсутствии лучевых осложнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГЛАБИНА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА

Олжатаева Г.О.², Сирота В.Б.¹, Исакова С.Х.², Нукубаева Г.Б.², Мамедова Л.Г.², Садуакасова М.Б.²

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан¹, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан²

Лучевой метод лечения является одним из самых распространенных в терапии злокачественных новообразований слизистой полости рта. Он применяется у 90% больных с опухолями органов полости рта, причем у 72% в качестве самостоятельного метода. С целью повышения эффективности лучевой терапии предлагается радиомодификация арглабином. Арглабин создан в РК (разработчик – Институт фитохимии МОН РК) на основе одноименного сесквитерпенового лактона, выделенного из эндемичного растения для Центрального Казахстана – полыни гладкой. Арглабин является ингибитором фермента фарнезилпротеинтрансферазы, участвующего в процессинге Ras-онкобелков, отвечающего за митотическую активность опухолевой клетки.

Задачи исследования: повышение эффективности лучевой терапии (ЛТ) рака слизистой полости рта путем комбинации ЛТ с арглабином в качестве радиомодификации.

Материалы и методы исследования. За период 2006-2008гг. в КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганды пролечено 38 больных раком слизистой полости рта и глотки. Всем пациентам проведена ЛТ классическим фракционированием дозы: по 2 Гр один раз в день, 5 раз в неделю до СОД 60-62 Гр. Первая группа из 16 больных получала только ЛТ. Второй группе больных из 22 человек на фоне ЛТ перед сеансом вводили внутривенно 2% раствор арглабина из расчета 370 мг/м² в количестве 20. Суммарная доза - от 8000 до 14000 мг. Средний возраст больных составил 56,8 года. В первой группе запущенный опухолевый процесс имели 14 больных (87,5%), во второй - 17 больных (77,3%). Плоскоклеточный рак без ороговения наблюдали у (42,1±8,0)%, плоскоклеточный рак с ороговением - в (36,8±7,8)% случаев.

Эффективность комбинированного лечения оценивали по стандартным критериям ВОЗ (1978) с использованием клинического, ультразвукового и эндоскопического методов исследования. Оценка гематологической токсичности проводилась согласно рекомендациям ВОЗ.

Полученные результаты и обсуждение. Полный регресс опухоли наблюдали в группе больных, получавших на фоне ЛТ арглабин, у (31,8±9,9)% пациентов; в группе больных, получавших ЛТ без арглабина, - у (12,5±8,3)% ($p>0,05$). Частичный ответ опухоли: в группе больных с арглабином - у (50,0±10,7)% пациентов, в группе без арглабина - у (18,8±9,8)% ($p\leq 0,05$). У (68,8±11,6)% больных, получавших ЛТ без арглабина, стабилизация опухолевого процесса. В группе больных, получавших лучевую терапию в комбинации с арглабином, частичный ответ получен в 2,6 раза чаще, чем в группе пациентов, получавших лучевую терапию без арглабина.

При использовании арглабина при ЛТ не наблюдали анемии и агранулоцитоза. В то время как при лучевой терапии без арглабина гематологические изменения проявились более рельефно: анемия в (12,6±8,3)%, лейкопения – в (31,2±11,6)%, агранулоцитоз – в (12,5±4,6)% случаев. Тромбоцитопения не отмечена ни в одной из групп.

Выводы. Наблюдается общая положительная динамика лучевого лечения у больных раком слизистой полости рта и глотки, получавших ЛТ с арглабином. Необходимо отметить положительную субъективную оценку состояния больных при введении арглабина, что способствует улучшению качества жизни данных пациентов.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО.

Садыков С.С., Тажибаева С.Д., Джакипбаева А.К., Амангалиев Ж.А.
Каз.НМУ им. С.Д. Асфендиярова, Каз.НИИ онкологии и радиологии.

Рак легкого представляет собой актуальную проблему, так как занимает первое место по заболеваемости и смертности среди всех злокачественных новообразований в Казахстане на протяжении последних 20 лет (Арзыкулов Ж.А. и соавт., 2004).

Цель исследования – выбор оптимального режима лучевой терапии и радиосенсибилизации для повышения непосредственной эффективности лечения немелкоклеточного рака легкого.

Материал и методы. В нашей работе проанализированы результаты лечения 166 больных местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого, преимущественно с центральной формой. У всех больных имелось морфологическое (цитологическое или гистологическое) подтверждение диагноза. В зависимости от методики лучевого лечения все больные были разделены на 4 группы. Радиосенсибилизация проводилась препаратом тинидозол, который больные принимали os или его вводили per rectum.

I группа (57 больных) – Метод мелкого дробления дозы разовыми очаговыми дозами (РОД) 2,0 Гр интервалом между сеансами облучения 24 часа, 5 фракции в неделю. При суммарной очаговой дозе (СОД) 30,0 Гр назначался перерыв на 2 недели, после чего проводился II этап лучевой терапии. В среднем СОД за курс лечения составила 58 Гр за 30 фракций (ВДФ 97ед., КРЭ – 1720 ерз).

II группа – Режим среднего фракционирования дозы по методу расщепленного курса РОД 3,5-4,0 Гр, 3 фракции в неделю СОД 57,0 Гр. Лучевая терапия проводилась за 2 примерно равных периода с интервалом между ними 2 недели (ВДФ 97,0 ед., КРЭ – 1750 26 ерз).

III группа (47 больных) – Ускоренный метод мультифракционирования дозы, непрерывный курс с двухсуточными фракциями по 1,8 Гр с интервалом не менее 6-18 часов 10 раз в неделю до СОД – 45-50 Гр (ВДФ – 93 ед., КРЭ-1750 ерз).

IV группа (30 больных) – Ускоренный метод мультифракционирования дозы. Непрерывный курс с двухсуточными фракциями по 1,8 Гр с интервалом 6-18 часов в неделю до СОД – 45-50 Гр. (ВДФ – 93 ед., КРЭ-1750 ерз) в сочетании с тинидозолом за 2 часа до облучения по 500 мг, всего на курс 8,0 г.

Результаты и обсуждение. При оценке непосредственных результатов установлено, что общая регрессия опухоли отмечена у 43 (75,4%) больных

I группы, у 24 (75%) больных II группы, 34 (72,3%) больных III группы и 23 (26,7%) больных IV группы

Отдаленные результаты показали лучшую эффективность лечения в I и IV группах: более 3 лет прожили 10% больных, в то время как во II и III группах 6,4% и 5,2% соответственно.

Оценка переносимости различных режимов фракционирования доз, а именно лучевых реакции кожи, пищевода, а также общей интоксикации организма показали более низкий процент лучевых реакции IV группе: примерно в 3% случаев в сравнение от 8,7% до 9% других групп.

Выводы. Полученные результаты могут служить основой для использования мультифракционного расщепленного метода, а так же для дальнейшего более эффективного способов временного распределения дозы при неоперабельных формах рака легкого.

Цитология

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Беламанова Л.Ж., Шибанова А.И., Мухаметгалиев Н.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, отдел патологии
опухолей, г. Алматы

Недостаточная эффективность обычной цитологической диагностики рака легкого связана с трудностью получения информативного материала для исследования и с проведением дифференциальной диагностики. Компьютерная морфо-денситометрия находит все большее применение в патоморфологии и в частности в цитологической диагностике новообразований как метод объективизации морфологических данных.

Цель: разработка и объективизация цитологических критериев диагностики рака легкого на основе компьютерной морфо-денситометрии.

Материал и методы исследования: Проведено исследование 10 цитогрaмм рака легкого у 10 больных в возрасте от 47 до 65 лет, верифицированной гистологически. Изучен материал 7 мужчин и 3 женщин. Материал для цитологического исследования получен во время оперативного вмешательства на легких.

Контрольную группу составили 6 больных (3 женщин и 3 мужчин), у которых при цитологическом исследовании обнаружены лишь реактивные изменения клеток бронхиального эпителия. Материал для цитологического исследования у данной группы больных получен с помощью браш-биопсии во время фибробронхоскопии (ФБС).

Исследовались цитологические препараты, окрашенные по Паппенгейму. Исследование ядер клеток проводили на микроскопе Leica DMLS под увеличением $\times 400$. Обработка и количественный морфометрический анализ полученных оцифрованных изображений проводили на системе анализа изображений «ВидеоТест – Морфология 5,0». С помощью данной системы оценивались следующие параметры: площадь, периметр, диаметр и коэффициент округлости ядра. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в статистическом пакете «SPSS 11.5» и программе «Биостат».

Результаты: Цитологическая картина эпителия бронхов в норме была представлена клетками цилиндрической формы с кутикулярной каемкой и ресничками, с ровными контурами ядерной оболочки. Хроматин равномерно-мелкозернистый, интенсивно «темная» окраска ядер, базофильная цитоплазма – все это было характерно для гиперплазированных клеток бронхиального эпителия.

Из 10 больных с диагнозом рак легкого у 7 больных гистологически был верифицирован плоскоклеточный рак и в 3 случаях – аденокарцинома. Цитологический диагноз плоскоклеточный рак был основан на обнаружении признаков эпидермоидной дифференцировки: полигональные или округло-овальные клетки с центрально расположенным ядром, с неравномерно-крупноглыбчатой структурой хроматина. В отдельных клетках определялись неправильной формы увеличенные ядрышки. Фон мазка был представлен бесструктурными аморфными массами, остатками ядер и цитоплазмы.

Цитологическая картина аденокарциномы была представлена клетками железистой дифференцировки. При этом в мазке преобладали цилиндрические и кубические раковые клетки с эксцентрически расположенными ядрами, встречались железистоподобные комплексы из округлых раковых клеток.

При морфометрическом исследовании изучено 1500 ядер клеток бронхиального эпителия в норме и 3500 ядер опухолевых клеток рака легкого. При этом значения площадей ядер, периметров и диаметров ядер больше при плоскоклеточном раке и аденокарциноме легких, чем соответствующие показатели в норме.

Так, площадь ядра при плоскоклеточном раке легкого составила от 91,34 до 210,91 $\mu\text{м}^2$, при $M = 133,56 \pm 15,2$. Периметр ядер колебался от 30,34 до 105,75 $\mu\text{м}$, составляя в среднем $M = 55,85 \pm 0,54 \mu\text{м}$. Средний диаметр ядра при этом был равен $15,57 \pm 0,09$, амплитуда колебаний составила от 12,61 до 20,44 $\mu\text{м}$. Коэффициент округлости ядер был равен $1,82 \pm 0,01$, при этом размах колебаний составил от 0,52 до 3,98 отн. ед.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОЖИ

Беламанова Л.Ж., Мирманова Г.Ж.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

В настоящее время частота возникновения злокачественных новообразований кожи значительно увеличилась и продолжает неуклонно возрастать. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50%.

Вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в определении абластичности оперативного вмешательства не вызывает сомнений.

Цель: оценить возможности срочной цитологической диагностики при новообразованиях кожи с краев послеоперационной раны.

Материал и методы исследования: Были проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Результаты: Из 40 больных на дооперационном этапе установлены цитологически следующие варианты: плоскоклеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом у 12 больных были выявлены опухолевые клетки, в том числе в 8 случаях (66,7%) цитологическая картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная. Данная цитогрaмма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных (из 12) с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки.

У одного пациента с меланомой кожи (8,3%) в опухолевых клетках обнаруживался пигмент. Ядра - полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная.

Встречались резко полиморфные двухядерные клетки.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток. В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Выводы: Таким образом, значение цитологического метода исследования велико не только при постановке, но также и определение гистогенеза опухоли, что играет большую роль в выборе метода лечения. В дальнейшем проведение цитологического исследования на абластичность из краев резекции указывает на их значимость и необходимость, так как позволяют клиническим врачам вовремя провести коррекцию плана лечения у этой категории больных.

АСПИРАЦИОННАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ОНКОЛОГИИ

*Аманов Т.Т., Айтуганова К.К., Якупова Л.М.,
Ахметкалиева Г.Р.*

*ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер», Казахстан, г. Уральск*

В настоящее время пункция является обязательным методом в диагностическом алгоритме при некоторых заболеваниях. Широкое применение получила методика аспирационной пункционной биопсии. Пункция может быть тонкоигольной - использование игл с внутренним диаметром до 1мм и толстоигольной - использование игл диаметром более 1 мм. В настоящее время широкое применение получила методика ТАПБ. Ряд авторов расценивают методику как основной скрининговый метод в диагностике заболеваний ЩЖ и молочной железы и единственным дооперационным методом прямой оценки структурных изменений и установления цитологических особенностей образований. Морфологический анализ ткани позволяет выявить и дифференцировать болезни, например ЩЖ, молочной железы на ранних стадиях их развития, когда клинические проявления заболевания чаще отсутствуют. Проведение пункционной биопсии или трепанбиопсии направлено на получение материала из опухоли для цитологического или гистологического исследования. В результате появляется возможность морфологически подтвердить диагноз, установить гистологический тип опухоли и степень ее злокачественности, а также получить информацию о рецепторном статусе клеток рака. Противопоказаниями к проведению пункции, по мнению некоторых авторов, являются: декомпенсированные нарушения свертывающей системы крови, заболевания с нарушением проницаемости сосудистой стенки, в тех случаях, когда риск процедуры выше ее информативности, категорический отказ больного от проведения процедуры, психические заболевания пациента в стадии обострения, тяжелое состояние больного. Побочные эффекты и осложнения можно разделить на местные (болевого синдром, признаки местного воспаления, парез или паралич нервов и др.) и общие (дискомфорт, нарушения общего самочувствия, повышение температуры, нарушения гормонального статуса, кровотечения, воспаления, абсцессы и др.). На результативность ТАПБ значительно влияют квалификация врачей, производящих пункцию, соблюдение правильной техники приготовления мазков, количество полученного материала, квалификация врача-цитолога. Метод аспирационной пункционной биопсии под контролем ультразвука стал внедряться в Западно-Казахстанском онкологическом диспансере с недавнего времени, после обучения врача УЗД в РОНЦ им. Блохина. До этого проводилась пункция врачом хирургом, чаще пальпируемых образований, что также имело немаловажную роль для постановки диагноза. За июнь-июль 2010

г. проведено совместно врачами УЗД, хирурга, цитолога 20 пункционных биопсий. Пропункцированы: печень - 8, из них 2 гепатоцеллюлярного рака,

1-метастаз плоскоклеточного рака, 1-метастаз аденокарциномы, 1-недифференцированного рака, 1- возможно паразитарная киста. 2-неинформативный материал. Поджелудочная железа -3, из них выявлены 2 – аденокарциномы, 1-неинформативный. Почка-1, получен недифференцированный рак. Надпочечники-1, недифференцированный рак. Щитовидная железа-2, в одном случае получен фолликулярный рак, в другом материал неинформативен. Проведена также пункция молочных желез - 3, из них в одном случае – высокодифференцированная аденокарцинома, в 2 случаях доброкачественные образования. Лимфатические узлы 2, в них выявлены метастатические клетки. Таким образом, аспирационная пункционная биопсия играет важную роль в диагностическом алгоритме при заболеваниях. Современная комплексная диагностика вовсе не предполагает обязательного использования всего арсенала диагностических методов. В каждом конкретном случае нужно определять объем диагностических мероприятий, которые позволят получить максимальную информацию

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОИГОЛЬНЫХ ПУНКТАТОВ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аманов Т.Т., Якупова Л.М.

*ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер»*

Актуальность. Общеизвестно, что рак молочной железы уверенно лидирует среди заболеваемости и причин смертности женского населения. Маммографическое исследование с последующей цитологической диагностикой, является одним из ведущих методов диагностики опухолей молочной железы. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы (РМЖ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий РМЖ.

Материалы и методы. Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» ГК КП «Западно-Казахстанский ООД» проводит маммографическое обследование женщин Западно-Казахстанской области (ЗКО). В 2009 году было проведено 16 201 маммографических исследований женщин, за 7 месяцев 2010 года - 11 083.

Результаты. В 2009 г. выявлены рак молочной железы женщин скринингового возраста 17 (0,1%). Всего по области выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы 122 пациентки, заболеваемость РМЖ составила 19,7% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 90 (73,8%), III ст. - 28 (23,0%), IV ст. - 4 (3,2%).

За 7 месяцев 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак молочной железы 87 пациенток, из них 20 женщин скринингового возраста. Заболеваемость составила 13,9% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 77 (88,5%), III ст. - 9 (10,3%), IV ст. - 1 (1,15%). Выявляемость РМЖ I-II ст. возросла на 11,7%.

Информативность маммографических исследований, техники тонкоигольной пункции и интерпретации полученного материала в значительной степени зависит от степени подготовки специалиста, качества материала, размера молочных желез. Результаты анализа диагностики поражений молочной железы у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований - за 2007 год было взято 132 женщины РМЖ, стадии заболевания были распре-

делены следующим образом: I-II ст. – 82 (62,1%), III ст. – 39 (29,5%), IV ст. – 10 (7,6%), в 2008 г. – 135 женщин: I-II ст. – 95 (70,3%), III ст. – 35 (25,9%), IV ст. – 4 (2,9%).

Вывод. Таким образом, наиболее информативным методом обследования молочных желез является маммография, позволяющая выявлять РМЖ на ранней стадии, дифференцировать опухоли молочной железы, а также скрыто протекающий рак. Улучшились статистические показатели по ранней выявляемости.

Однако для уточняющей диагностики невидимых и непальпируемых образований приобретает аппарат «Мамма-тест», цифровая рентгенологическая установка для пункционной биопсии и постановки диагноза опухолей размером менее 0,5 см.

Также одной из наукоемких диагностических технологий на сегодня является лазерная проточная цитофлюориметрия (ПЦМ), которая затрагивает наиболее важные направления развития цитологической лабораторной диагностики. Направление технологии ПЦМ – возможность количественного определения ДНК и расчета стадий клеточного цикла. Особенности плоидности ДНК и фаз клеточного цикла позволяют существенно дополнить информацию о цитоструктуре и степени дифференцировки малигнизированных клеток, получить сведения о кинетике опухолей, что, в свою очередь, определяет тактику и выбор адекватных схем лечения.

МОРФОЛОГИЯ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Артыкбаева Н.Т., Мамбетова Г.К.
КАЗНМУ ИМ.с.д.Асфендиярова, г.Алматы*

Цель исследования: систематизация морфологических признаков различных вариантов папиллярного рака щитовидной железы (ЩЖ).

Материал исследования. Истории болезней и операционный материал, полученный при хирургических вмешательствах на щитовидной железе в Городской клинической больнице №7 г.Алматы с 1992 по 2009 гг. и в медицинском центре «ХАК» с 2003 по 2009гг. Было отобрано 52 случая папиллярного рака (ПР ЩЖ). Средний возраст больных – 43 года.

Результаты. Фоновыми процессами для развития ПР ЩЖ явились коллоидный зоб – 27 случаев, коллоидный зоб с базедовификацией – 3 случая, базедов зоб – 3 случая, коллоидный зоб с очаговым аутоиммунным тиреоидитом – 2 случая, аутоиммунный тиреоидит – 3 случая. В 14 случаях вся ЩЖ была представлена опухолью.

При гистологическом исследовании учитывали форму ядер (округлая, овальная, округло-овальная), контуры ядер (ровные, неровные), наличие оптически чистых ядер (локально, диффузно, отсутствуют), бороздки в ядрах, внутриядерные цитоплазматические включения (в 10 полях зрения), ядерно-цитоплазматическое соотношение определялось визуально (Я+Ц, Я>Ц, Я<Ц).

Весь изученный материал был разделен на три группы по гистологическим типам: классический папиллярный вариант, фолликулярный вариант, Б-клеточный вариант. Описанный в литературе длинноклеточный вариант нами обнаружен не был.

Классический папиллярный вариант ПР ЩЖ был диагностирован в 33 случаях (64,7%), представлен опухолями с чисто сосочковым или преимущественно сосочковым типом роста. Сосочки имели фиброваскулярный стержень, были покрыты кубическим эпителием. Клетки опухолевого эпителия характеризовались наличием кругло-овальной формы, оптически пустых, накладывающихся друг на друга ядер с гематоксилиновыми «бороздками» вдоль продольной оси и зазубренными контурами ядерной мембраны. Степень клеточной атипии в 81,8% случаев определялась умеренная,

в 9,1% – выраженная, в 5,1% – слабая. Инвазия опухоли в сосуды определялась в 6,1% случаев, в 33,3% – в капсулу, в 69,7% – за пределы капсулы. Метастазы в регионарные лимфоузлы обнаружены в 18,2% случаев. Кистозная дегенерация опухоли обнаружена в 3% случаев.

Фолликулярный вариант ПР ЩЖ был верифицирован в 15 случаях (29,4%), характеризовался фолликулярным или преимущественно фолликулярным типом роста. Клетки с патогномоничными для ПР ЩЖ ядрами обнаруживались локально и диффузно. Клеточная атипия в 6,7% случаев определялась умеренная, выраженная – в 20%, слабая – в 13,3% случаев. Инвазия в капсулу определялась в 53,3% случаев, выраженная инвазия за пределы капсулы в окружающую ткань – в 46,7% случаев. Метастазы в регионарные лимфоузлы обнаружены в 6,7% случаев.

Б-клеточный или онкоцитарный вариант ПР ЩЖ был обнаружен в 3 случаях (5,9%), характеризовался наличием нежных сосочков, покрытых крупными кубическими или полигональными клетками с широкой зернистой эозинофильной цитоплазмой. Особенность этих опухолей – незначительное количество клеток с ядрами, характерными для ПР ЩЖ и сочетание их с аутоиммунным тиреоидитом.

Таким образом, морфологическая диагностика классического папиллярного варианта папиллярного рака щитовидной железы не представляет сложности. Диагностика же фолликулярного и онкоцитарного вариантов требует тщательного и внимательного изучения всех полей зрения для выявления клеток, патогномоничных для папиллярного рака.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 2006-2009 ГГ. ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ ВКО

*Байпеусов Д.М., Бань Т.П., Шалаганова К.Б.,
Кыдырбаева Ж.Н., Бойко Н.И.*

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Актуальность: В мире накоплен большой опыт по проведению цитологического скрининга рака шейки матки (РШМ), проведение которого способствовало снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%.

Цель исследования: провести анализ эффективности диагностики заболеваний шейки матки у женщин при цитологическом скрининге за период с 2006г- 2009 гг.

Материалы и методы исследования: В Казахстане цитологический скрининг рака шейки матки проводится с 2005 года. В 2005 г.: 20- 34 года; в 2006 и 2007 гг.: 18-49 лет; в 2008 г.: 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет. Приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007 г.

В регионе города Семей обследовано в 2006г.-145249 женщин, 2007г.-138684 женщин, 2008г.-22630 женщин, 2009г.-18311 женщин. Материал для исследования получали из шейки матки при помощи Cervix-Brush. Метод окраски препаратов – по Романовскому в 2006-2007гг. В 2008 году- 60% всех исследований окрашены по методу Папаниколау, 40% - по Романовскому. РОД г. Семей один из первых начал обследование по этому методу. С 2009 г. все скрининговые исследования 100% окрашиваются по методу Папаниколау (Пап-тест).

Результаты исследования: установлено, что решающим фактором влияющим на эффективность скрининга является широта охвата женского населения. В 2006 г. процент охвата подлежащих обследованию женщин составлял 110%.(в число обследованных вошли повторные исследования при цитоконтроле-при воспалении, дисплазии, неадекватном материале). В 2007 г. выполнено 94,1% от планируемого количества женщин, 2008 г. 98,4% и в 2009 г.-97,9%.Для решения проблемы охвата скринингом женского населения проводили разъяснительную работу, привлечение средств массовой информации, издания популярных печатных материалов. Вторым, не менее важным фактором эффективности

проведения скрининга является адекватность мазка. Точность цитологического исследования определяется качеством полученного материала (клеточным составом мазка). Материал расценивался как адекватный для исследования, если в мазке имелись клетки плоского, метаплазированного и эндоцервикального эпителия, т. е. материал должен быть получен из зоны трансформации (зона стыка плоского и цилиндрического эпителия, где наиболее часто возникает опухоль). Самую «опасную» категорию женщин представляет именно «недостаточно адекватный материал». Проведение обучающих семинаров, тренингов для гинекологов и акушеров позволило снизить количество неинформативных мазков (с 20,3% в 2007г. до 3,1% в 2009г.). Все ранние раки были выявлены по методу Папаниколау, что подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Женщины с выявленной патологией (согласно терминологии Бетесда) ASCUS (атипия неясного значения), LSIL (легкая степень дисплазии) наблюдались у участкового гинеколога по месту жительства с последующим цитоконтролем. Женщины с более серьезной выявленной патологией – умеренная, тяжелая степень дисплазии (HSIL), подозрение на злокачественный процесс направлялись в онкодиспансер для углубленного обследования (кольпоскопия, биопсия) и лечения.

Выводы: Таким образом, для эффективного проведения скрининга необходимо соблюдение трех основных факторов: широта охвата женского населения, подлежащего исследованию, полноценность полученного цитологического материала, обследование и лечение выявленных больных. Метод окраски цитологических препаратов по Папаниколау показал себя, как метод более эффективный при диагностике патологии шейки матки, имеет больше преимуществ при проведении скрининга, то есть способствует снижению заболеваемости и смертности от РШМ на 70-80%. С 2009 г. наблюдается рост выявления рака шейки матки по скринингу в 15 раз (0,01% 2007 г., 0,07% 2008 г., 0,15% 2009г.). Из 20 (подтвержденных гистологически) выявленных раков в 2009 г. – 4 *in situ*, 14 микроинвазивных и 11 инвазивных раков.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЬНИЦ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Черняков С.С.

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: современные подходы к лечению рака молочной железы предполагают проведение иммуногистохимического исследования ткани опухоли.

Цель работы: иммуногистохимическое исследование уровня экспрессии HER-2/neu и рецепторов эстрогена и прогестерона у больных раком молочной железы в популяции жительниц Павлодарской области.

Материалы и методы: иммуногистохимическое исследование проводилось 103 больным РМЖ по стандартному протоколу с использованием реактивов фирмы «Dako» и HercepTest (Дания) и применением позитивного контроля. Интерпретация результатов проводилась с помощью оценочной системы приложенной к HercepTest, а для подсчета экспрессии рецепторов гормонов использовался полуколичественный метод.

Результаты и выводы: Для больных раком молочной железы популяции Павлодарской области характерен низкий уровень экспрессии HER-2/neu – так гиперэкспрессия (3+) наблюдалась у 10 больных из 103 (9,7%), слабопозитивная реакция (2+) зарегистрирована у 13 пациенток (12,6%), тогда как согласно литературным данным гиперэкспрессия встречается у 20-30 % больных РМЖ. Возраст пациенток составлял от 40 до 61 года. Гиперэкспрессия чаще всего наблюдалась в возрастной группе 50-60 лет. Гиперэкспрессия HER-2/neu

характеризуется – увеличением скорости роста опухоли, повышением частоты метастазирования, ухудшением прогноза для ранних и поздних стадий, снижением в 2 раза безрецидивной и общей выживаемости. Также гиперэкспрессия HER-2/neu свидетельствует о резистентности опухоли к химиотерапии.

Отрицательная экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона наблюдалась в 54 случаях (52,4%). У 7 больных из 10 с гиперэкспрессией белка HER-2/neu зарегистрирована отрицательная экспрессия рецепторов гормонов эстрогена и прогестерона («плохая» карцинома молочной железы). Такие больные «нечувствительны» к гормонотерапии и нуждаются в терапии Герцептином. Применение гормонотерапии у лиц с «чувствительными» опухолями с большой степенью вероятности приводит к увеличению общей и безрецидивной выживаемости.

Если определение рецепторов эстрогена и прогестерона, HER-2/neu можно отнести к обязательным этапам иммуногистохимического исследования без которых невозможно назначение адекватной терапии, то выявление индекса пролиферации Ki-67 пока является рекомендуемым, желательными маркером.

Задачей патоморфологов и клиницистов является определение набора наиболее значимых, дополняющих друг друга показателей (маркёров), который бы позволил при минимально возможной стоимости обследования обеспечить максимальную эффективность лечения каждого пациента.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПАПАНИКОЛАУ ПРИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ

Мусина Г.С

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: метод Папаниколау является общепризнанным методом цитологического исследования в международных масштабах.

Цель работы: оценка эффективности метода Папаниколау при цитологическом скрининге.

Материалы и методы: результаты практической работы за 2009 – 2010гг.

Учитывая рост заболеваемости раком шейки матки в Республике Казахстан, роль цитологического метода возрастает в ранней диагностике. В Павлодарской области цитологическая служба организовано 28 августа 1951 года. Цитологическая диагностика является морфологическим методом исследования, который основан на микроскопическом изучении характера изменений клеточных элементов при различных патологических состояниях. Нами применяется несколько методов окраски цитологического материала. Наиболее приемлемой методикой при проведении массовых профилактических осмотров является окраска мазков по методу Папаниколау, который считается классическим и в настоящее время широко применяется во многих странах мира. Цитологическое исследование мазков, взятых с поверхности шейки матки и цервикального канала – это надёжный скрининговый тест, достоверность которого достигает 98%. Цель скрининга – выявить предраковые изменения шейки матки, которые при отсутствии своевременного лечения могут привести к развитию заболевания. Скрининг будет эффективным, если хорошо организовано наблюдение и лечение за обследованными женщинами. Женщины с выявленной патологией при скрининговом обследовании нуждаются в уточняющей диагностике в нашем онкологическом диспансере, возможно и лечении с целью предотвращения рака шейки матки в дальнейшем. Следует помнить, что попытка максимального охвата женщин будут бесполезны, в случае отсутствия последующего контроля за женщинами с

выявленной патологией. С этой целью было приобретено в цитологическую лабораторию «ПООД» новое оборудование MICROM HMS – 70, производство Германия. Приобретенная машина-автомат для окраски стеклопрепаратов представляет собой автоматический программируемый прибор для цитологических и гистологических методик. Работа на нем безопасна, при соблюдении правил техники безопасности. Увеличилось количество окрашиваемых стеклопрепаратов, улучшилось качество окраски, что повлияло на процент выявляемости патологии. Метод Папаниколау позволяет хорошо улавливать способность цитоплазмы клеток окрашиваться различными красителями и различать детали ядра. Преимущество методики по Папаниколау заключается в том, что полихромная окраска препарата позволяет оценить степень созревания цитоплазмы (от синего-зеленого цвета в незрелых клетках до розового в клетках со зрелой цитоплазмой и оранжевого в клетках с орогованием).

Одним из необходимых условий данной методики является влажная фиксация биоматериала, способствующая сохранению ядер, клеточной мембраны и структуры хроматина. Данный метод позволил эффективно выявлению предраковых состояний и рака ш/м в цитологическом скрининге женщин отдельно взятых категорий (30 - 60 лет) и женщин других возрастов, не вошедших в программу. Процент выполнения Республиканской программы в предыдущие годы составил 100 %.

Результаты и выводы: широкое использование Пап-теста в рамках скрининговой программы отдельной категории женщин области привело к значительному улучшению качества выявляемости предопухолевых процессов женской половой сферы. Считать целесообразным использования Пап-теста в рамках скрининговых программ при наличии четкой государственной концепции организации противораковой борьбы и её регулярном финансировании.

DETECTION OF ACTIVITY IN NUCLEOLUS ORGANIZERS (NO) IN COMBINED TREATMENT OF THE BLADDER CANCER

*Abenova M.T., Mustaphina B.K.
Oncology center, Astana, Republic Kazakhstan*

Improvement in treatment as well as detection of determining disease prognosis attributes demand objective morphological assessment. Routine cytomorphological methods have certain limits, out of them an objective evaluation can hard be done. Therefore there is a necessity in a complex of methods that allows to investigate tumor cell morphology as well as their functional condition in order to assess changes carrying under treatment. In cytological diagnostics evaluation of changes in tumor cells is based on morphological features of nucleus and nucleolus. Nucleoluses are usually detected by alkaline coloring that is not contrast enough on background of chromatin, besides nucleolus contours are not always well defined. Cytochemical method of NO' silvering helps to avoid the mentioned above defect. NO are chromosome's areas where nucleoluses are formed. This method gives opportunity to assess NO' activity where ribosome RNA transcription is going on that influences on further cell growth, mature and volume.

To evaluate efficiency of endolymphatic radiosensibilization by AK-2123 cytograms of 25 patients with morphologically confirmed bladder cancer (stage T3) have been studied. Patients were divided into two groups: I – 10 patients underwent split course of irradiation by dynamic fractionation with total dose 60.0 Gy (control) and II – 15 patients received radiation therapy plus sensibilization by AK-2123 that was applied by 1 hour endolymphatic infusion 20 minutes before irradiation. Cytological control was done in the middle and after treatment. Cytological patterns were received from wash liquid or smear during cytосcopy. Study of consequence and expression of morphological and functional

changes in tumor cells under irradiation has showed follows: before treatment nucleoluses of tumor cells contained average 1-3 hypertrophied nucleoluses with corresponding number of Ag-granules (15-25). In the middle of treatment the nucleolus volume was increasing but number of Ag-granules dropped to 4-8. To the end of treatment coloring of Ag-granules was not intensive or absent. More expressive disturbance in nucleolus apparatus was observed in the studying group, 13 from 15 patients did not have any coloring of Ag-granules. In the control despite on tumor regression single cells with nucleus and nucleolus without any destruction were detected (number of Ag-granules was numerous). As a consequence of difference in cell differentiation some tumor cells are likely to be resistant to irradiation that may cause a tumor recurrence in future.

Thus, depression of ribosome RNA synthesis (as a result of decreasing of Ag-granules) has been observed on studying of NO activity of bladder cancer cells. On combination of radiation therapy and radiosensibilization by AK-2123 this process was more intensive that led to better treatment results. Therefore such morphological and functional study should be considered as highly informative in assessment of treatment efficiency.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА И ПРОГЕСТЕРОНА И HER2(NEU) ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Болсынбекова С.О., Рахимжанова Г.С.,
Муканова Ж.М., Манамбаева З.А.*

*Региональный онкологический диспансер г.Семей,
Государственный Медицинский Университет г.Семей*

Цель: изучение гормональной чувствительности и уровня экспрессии HER2(neu) при раке молочной железы.

Материалы и методы: В процессе выполнения настоящего исследования с 2007-2009гг было проведено ИГХ у 424 больных с РМЖ с определением рецепторов эстрогена, прогестерона и HER2(neu).

Результаты исследования: Диагностика опухолей на современном этапе включает верификацию варианта, степень дифференцировки, оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли.

К основным иммуногистохимическим маркерам, отражающим функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы (РМЖ), относятся:

- экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона,
- экспрессия онкопротеина HER2(neu)

Одним из важных прогностических факторов РМЖ является статус рецептора эпидермального фактора роста человека типа 2 (HER2).

При исследовании экспрессии HER2(neu) у больных РМЖ за 3 года выявлено, что в 227 (53%) из 424 случаев опухоль является HER2(neu) негативной (степень гиперэкспрессии 0, 1+), в 87 (21%) случаях - «слабо позитивной» (2+) и в 110 (26%) - «сильно позитивной». Таким образом, гиперэкспрессия HER2(neu) обнаружена в 26% случаев, которая соответствует данным литературы и что крайне важно для прогнозирования течения заболевания и лечения Герцептином.

Благодаря открытию в клетках опухолей рецепторов стероидных гормонов, осуществляющих избирательное, специфическое связывание гормонального лекарственного средства в органах-мишенях, разработаны методы оценки возможной чувствительности этих новообразований к данному виду лечения. Поэтому определение рецепторов эстрогена(РЭ) и прогестерона(РП) в РМЖ в настоящее время рассматривается как обязательное для успешного гормонального лечения. Из 424 изученных РМЖ 224 (53%) опухолей составили 1-ю группу, в которой отмечалась экспрессия

обоих рецепторов (РЭ+РП+). 24 (6%) случаев опухолей составили 2-ю группу эстрогенпозитивных раков (РЭ+РП-) и 34 (8%) опухолей 3-ю группу, прогестеронпозитивных (РЭ-РП+). Остальные 132 (33%) наблюдений составили 4-ю группу рецепторонегативных раков (РЭ-РП-).

Вывод: ИГХ дает возможность оценить функциональное состояние опухолевых клеток и с помощью полученных данных прогнозировать особенности течения и исхода злокачественного новообразования молочной железы.

ЭКСПРЕССИЯ HER2(NEU) РЕЦЕПТОРОВ И СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН Г.АКТОБЕ

Жумашева А.В.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, Областное патологоанатомическое бюро, г.Актобе

Актуальность. В Казахстане рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место из числа всех злокачественных опухолей у женщин, составляя 17,7 %. Ежегодно в Казахстане выявляется около 3000 новых случаев, при этом отмечается омоложение состава женщин, болеющих раком молочной железы. В связи с этим в последнее время стало успешно развиваться новое направление в онкоморфологии - иммуногистохимическое исследование.

Цель исследования - изучение особенностей экспрессии HER 2 (neu) рецепторов и стероидных гормонов эстроген и прогестерон при инфильтративных раках молочной железы

Материалы и методы исследования. В лаборатории иммуногистохимии научного центра университета в течение года проведено иммуногистохимическое исследование 68 женщин с клиническим диагнозом: инфильтративный рак молочной железы.

Таблица 1. Распределение HER-2neu и стероидных гормонов по возрастам

Возраст,г	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
HER-2/neu-	1	4	6	13	3	1
HER-2/neu++		2	12	6	1	
HER-2/neu+++		2	8	5	1	
ESTR(+)PROG(+)		5	13	17	4	1
ESTR(-)PROG(-)	1	2	5	2	1	
ESTR(-)PROG(+)		1	4	1		
ESTR(+)PROG(-)			4	4		

Как видно из таблицы HER/2 neu гиперэкспрессия чаще встречалась у женщин молодого возраста от 40-49 лет в 8 случаях, а у женщин от 50 до 59 лет - в 5 случаях, у женщин пожилого возраста - в 1 случае. В нашем случае отмечается в 2 случаях у женщин молодого возраста от 30 до 39 лет.

По результатам нашего исследования видно, что рак молочной железы имеет тенденцию омоложения: 9 случаев из 68 женщин. Таким образом, гиперэкспрессия HER-2 /neu в опухоли сопровождается более агрессивным течением и ранним метастазированием. По рецептору стероидных гормонов результаты таковы: ESTR(+)PROG(+) у женщин от 50 до 59 лет обнаруживались в 17 случаях, а у женщин от 40 до 49 лет - в 13 случаях. Заключение. С помощью иммуногистохимического исследования можно установить не только гистогенетический диагноз опухоли, но и дать её морфофункциональную характеристику с точки зрения агрессивности и прогноза онкологического заболевания и её чувствительности к химиотерапевтическим и лучевым методам лечения.

ВИМЕНТИН-ПОЗИТИВНЫЕ МАКРОФАГИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОЛИТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Жарков Н.В.^{1,2}, Жаркова И.М.²,

Хамидуллина Г.А.³, Нуртазин С.Т.²

¹ТОО «Консультант Биотех», ²НИИ ПЭ при КазНУ им. аль-Фараби, ³КазНИИ ОиР

До недавнего времени считалось, что все макрофаги (МФ) имеют моноцитарное происхождение [van Furth R., 1988]. Однако, некоторые авторы указывают на наличие МФ, которые, как уже указывалось выше, являются особой самообновляющейся клеточной популяцией [Daems W.T., 1980]. Эти МФ проявляют признаки, указывающие на их мезенхимальное (а не моноцитарное) происхождение - в цитоплазме этих клеток иммуногистохимически выявляется виментин [Муслимов, Мусина, 2007]. Авторы считают эти МФ «матриксформирующими», участвующими в репаративных процессах.

Цель исследования - провести иммуногистохимическое (ИГХ) и электронномикроскопическое (ЭМ) исследование МФ при хроническом колите, экспериментальной толстокишечной обтурационной непроходимости и раке толстой кишки.

ИГХ и ЭМ исследование МФ проведено в 3 группах: группа 1 - 12 пациентов с хроническим колитом; группа 2 - 17 экспериментальных животных (собак) с моделированной толстокишечной обтурационной непроходимости (ТКОН); группа 3 - 79 пациентов с раком толстой кишки.

При ИГХ исследовании среди клеток макрофагального ряда выявлялись клетки с выраженной позитивной цитоплазматической реакцией на виментин. Количество виментин-позитивных МФ в исследуемых группах различалось. В группе пациентов с хроническими колитами количество виментин-позитивных МФ было 8,0±0,3 на 1 п.з (x400). В экспериментальной группе у собак количество данных клеток было снижено и составило в среднем 1,8±0,1 на 1 п.з.

В пограничной слизистой при раке толстой кишки количество виментин-позитивных МФ было практически таким же, как и при хроническом колите (8,2±0,2 на 1 п.з.). Непосредственно в ткани опухоли количество «матриксформирующих» макрофагов было минимальным и составило 3,0±0,3 на 1 п.з. Максимальное количество клеток с морфологией макрофагов и позитивной реакцией в цитоплазме на виментин отмечено в окружающей опухоль строме (9,0±0,3).

Ультраструктурно данные МФ представляли собой крупные клетки (более 20 мкм) эллипсоидной или слегка вытянутой формы с множеством толстых и тонких цитоплазматических отростков - псевдоподий и микроворсинок. В клетках отмечались признаки выраженной функциональной активности и повышенного внутриклеточного транспорта метаболитов в виде многочисленных вакуолей, окаймленных одиночной мембраной, с хлопьевидным, мелкозернистым или плотным содержимым и множества пиноцитозных пузырьков в цитоплазме. Клеточная поверхность макрофагов образовывала множество длинных тонких выростов, некоторые МФ контактировали с активными формами фибробластов.

Таким образом, при хроническом и остром воспалении, а также в пограничной с опухолью слизистой и окружающей опухоль строме отмечается выраженная репаративная активность «матриксформирующих» МФ. Непосредственно в ткани опухоли количество этой субпопуляции МФ резко снижено.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЭКСПРЕССИИ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И ЛИЗОЦИМА В МАКРОФАГАХ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Жарков Н.В.^{1,3}, Хамидуллина Г.А.²,

Нуртазин С.Т.³, Жаркова И.М.³

¹ТОО «Консультант Биотех», ²КазНИИ ОиР, ³НИИ ПЭ при КазНУ им. аль-Фараби

Макрофаги (МФ) являются исключительно полифункциональными клетками. Помимо того, что в МФ хорошо развит механизм фагоцитоза, они являются секреторными и регуляторными клетками. Основными лизосомальными ферментами, синтезируемыми макрофагами являются миелопероксидаза (МПО), экспрессирующийся преимущественно в моноцитах и незрелых формах, и лизоцим (ЛЦ), экспрессирующийся в активированных фагоцитарных МФ.

Цель исследования – изучить динамику экспрессии МПО и ЛЦ в МФ при воспалительных состояниях и раке толстой кишки.

Исследована экспрессия МПО и ЛЦ в МФ, инфильтрирующих стенку толстой кишки (ТК) при хроническом колите (n=12), экспериментальной толстокишечной обтурационной непроходимости (ЭТКОН у собак) (n=17) и раке ТК (n=79).

При хроническом колите количество МФ в слизистой ТК определялось значительное число МФ экспрессирующих МПО+ $31,7 \pm 2,2$. Количество ЛЦ+ МФ было значительно меньше и составляло $11,7 \pm 1,0$ на 1 п.з.(x400).

При ЭТКОН общее количество МФ было незначительным, при этом большая часть клеток ($8,2 \pm 0,8$) экспрессировала в своей цитоплазме МПО, ЛЦ+ клеток было $2,3 \pm 0,2$ на 1 п.з.

В ткани опухоли МПО+ и ЛЦ+ МФ распределялись неравномерно. Пограничная слизистая по уровню экспрессии МПО и ЛЦ соответствовала хроническому колиту (МПО+ $35,8 \pm 2,9$, ЛЦ+ $10,1 \pm 1,1$). Непосредственно в ткани опухоли преобладали МФ, экспрессирующие ЛЦ ($17,7 \pm 2,0$). МПО-позитивных макрофагов было $17,7 \pm 2,0$. В окружающей опухоль строме соотношение МПО+ и ЛЦ+ было примерно равным - $59,4 \pm 5,7$ и $46,3 \pm 4,8$ соответственно.

Таким образом, в слизистой ТК при воспалительных состояниях преобладают молодые и незрелые формы МФ. Пограничная с опухолью слизистая по иммуногистохимическим характеристикам популяции МФ схожа со слизистой при хроническом воспалении. Непосредственно в опухоли преобладают активированные МФ с фагоцитарным фенотипом. В окружающей строме присутствует значительное количество как молодых форм МФ, активно мигрирующих из кровеносного русла, так и активированных фагоцитирующих МФ.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Фолликулярной аденомы и фолликулярного рака щитовидной железы у детей и подростков.

Иванова Н.В., Поляков В.Г., Шишков Р.В., Павловская А.И.
НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН, Москва, Россия

Цель: Установить клинические и морфологические особенности фолликулярной аденомы (ФА) и фолликулярного рака (ФРЦЖ) щитовидной железы (ЩЖ) у детей и объем оперативного вмешательства.

Методы: За период с 1975 по 2008 г, было пролечено 90 детей и подростков (фолликулярный рак n=30 и фолликулярная аденома щитовидной железы n=60). В исследование были включены дети возрастной группы от 2 до 18 лет. Средний возраст девочек $12,6 \pm 2,6$ и мальчиков $11,4 \pm 3,4$ лет. Соотношение полов 3:1. При проведении предоперационного клинического обследования не удалось выявить достоверных различий между группой пациентов с ФРЦЖ и группой детей с ФА. В большинстве случаев, опухоль была представлена одиночным узлом. Предоперационный диагноз фолликулярная опухоль ЩЖ был установлен у 70 пациентов (66,6%). Срочное гистологическое исследование выполнено у 33 (36,6%) пациентов. Проведен анализ предоперационной и интраоперационной дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей.

Результаты: У 16 (48,4%) из 33 гистологический диагноз был - фолликулярная опухоль, в 4 (12,1%) случаях фоллику-

лярный рак и у 13 (39,3%) – аденома. Из 16 больных с диагнозом фолликулярная опухоль при плановом гистологическом исследовании у 9 (56,2%) установлен фолликулярный рак. У 13 больных с предоперационным диагнозом аденома при плановом гистологическом исследовании подтвержден диагноз. У оставшихся 7 (43,7%) из 16 больных установлен диагноз аденомы после планового гистологического исследования.

При гистологическом исследовании выявлены основные отличия фолликулярного рака от фолликулярной аденомы: толщина капсулы окружающей опухолевый узел, инвазия опухоли в капсулу и её сосуды. Так у 77,5% больных с ФА выявлена тонкая капсула, в отличие от ФРЦЖ при котором по всех случаях выявлена толстая капсула. При фолликулярном раке во всех случаях выявлена инвазия в капсулу опухоли и её сосуды, что является главным диагностическим признаком ФРЦЖ. Из всех случаев ФРЦЖ широко инвазивный вариант выявлен в 4 (13,3%), минимально-инвазивная форма в 26 (86,6%) случаях. У трёх пациентов был выявлен фолликулярный рак с инсулярным компонентом.

Операция в объеме гемитиреоидэктомии с резекцией перешейки была выполнена у 84 (93,3%) пациентов из них у 27 (32,1%) с диагнозом фолликулярный рак и у 57 (67,8%) с диагнозом аденома. Субтотальная резекция ЩЖ у 5 (5,5%) из них у 3 (60%) с диагнозом фолликулярного рака и у 2 (40%) с аденомой. Тиреоидэктомия выполнена у 1 (1,1%) пациента с фолликулярным раком. При сроках динамического наблюдения от 1,0 до 16,5 лет, ни у одного больного не выявлено рецидива или метастатического процесса.

Выводы: Полученные данные говорят о сложности дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей на предоперационном и интраоперационном этапах. Методом позволяющим четко дифференцировать аденому и фолликулярный рак остаётся только плановое гистологическое исследование, которое позволяет выявить ряд признаков характерных для фолликулярного рака. Менее агрессивный характер течения фолликулярного рака у детей и подростков, в отличие от папиллярного рака позволяет нам рекомендовать проведение органосохраняющих операций при этом заболевании детского возраста.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА

Айсарова А.М., Жарихина Т.А., Кусакина Г.К.,
Тажединов А.И., Махметова Н.И.

Региональный диагностический центр, г.Алматы

При эндоскопическом исследовании желудка значительные затруднения вызывают очаговые изменения слизистой оболочки, которые выглядят как небольшие гиперплазии и инфильтраты. Они имеют признаки карциномы: серого или синюшного цвета, иногда с изъязвлениями неправильной формы, различного размера. В то же время активная перистальтика, расправление органа при инфляции воздуха, подвижность складок, отсутствие ригидности в области поражения не позволяют с уверенностью дать заключение о раке. Поэтому эндоскопическое заключение формулировалось так: инфильтрация неясной этиологии (ИНЭ).

Цель исследования: определить частоту выявления ИНЭ и изучить морфологические находки при этих состояниях.

Материал и методы. Проведено эндоскопическое исследование 32892 пациентов с морфологической (цитологической и гистологической) верификацией патологических процессов.

Полученные результаты. ИНЭ выявлена у 26 пациентов (0,98%). В результате цитологического исследования у 15 из них (57,7%) обнаружен рак, который подтвержден гистологически. Гистологические формы были: определены как аденокарциномы умеренной дифференцировки (5 боль-

ных, 33,3%), низкой дифференцировки (8 больных, 53,3%), перстневидноклеточный рак (1 больной, 6,7%), у 1 больного (6,7%) – фокусы аденокарциномы. В остальных 11 случаях (42,3%) обнаружены различные формы гастритов.

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что в 57,7% случаев ИНЭ была раковой природы, при этом чаще выявлялись аденокарциномы низкой и умеренной дифференцировки и ранние формы рака. Это еще раз доказывает необходимость широкого применения морфологических методов исследования при эндоскопическом исследовании, особенно при ИНЭ, причем количество биопсийных кусочков должно быть не менее 7-8.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Ирменев К.М., Аманов Т.Т., Якупова Л.М., Айтуганова К.Г.
ГК КП «Западно-Казахстанский областной
онкологический диспансер»*

Актуальность. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» централизованная цитологическая лаборатория (ЦЦЛ) ГККП «Западно-Казахстанский ООД» проводит обследование женского населения в возрасте 35-60 лет с использованием окраски препаратов по методике Папаниколау (Пап-тест). Основанием для выбора такой возрастной категории послужили рекомендации ВОЗ.

Материалы и методы. В 2009 году было проведено цитологическое обследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, за 7 месяцев 2010 года 13 585 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего по области в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки, заболеваемость составила 8,4% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 43 (82,7%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 3 (5,8%).

За 7 месяцев 2010 года выявлено 225 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 164 (1,2%), CIN II – 28 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,08%). Число неинформативного материала составило 1345 случаев (8,9%). Всего выявлено и взято на учёт 31 случай РШМ. Заболеваемость составила 4,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 26 (83,9%), III ст. - 4 (13%), IV ст. - 1 (3,2%). В 2007 РШМ I-II ст. составляла 62,1%, в 2008 г. - 70,3%, в 2009 – 82,7%. Диагностика РШМ I-II ст. возросла на 20,6%.

Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки. Поэтому эффективному цитологическому скринингу способствует взаимодействие цитологов, гистологов, гинекологов, использование специальных инструментов для взятия материала (комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щётки типа Cytobrush, Cervex-brush). Целесообразен переход к

ежегодным скрининговым цитологическим исследованиям и снижению возраста обследуемых женщин до 25 лет.

Вывод. Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.), показатель за 7 месяцев 2010 г. составил 83,9%. Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Метод цитологической диагностики с использованием Пап – теста как метода скрининга является одним из наиболее успешных в плане уменьшения частоты диагноза рака шейки матки, особенно эффективен при ранней диагностике РШМ, т. к. позволяет обнаружить злокачественное поражение на клеточном уровне, признаки ВПЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБОВ С КОЖИ В УСЛОВИЯХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

*Айсарова А.М., Жарихина Т.А.,
Махметова Н.И., Сейкетов А.Ж., Муратханова М.М.
Региональный диагностический центр*

Нет более доступного для цитологического исследования органа, чем кожа. Однако дерматологи в своей ежедневной практике используют цитологическое исследование (ЦИ) соскобов довольно редко. В Региональном диагностическом центре г.Алматы при наличии опухолевидных и пигментированных образований, а также изъязвлений на коже больные направляются дерматологом центра в отделение цитоморфологических исследований для проведения ЦИ с целью дифференциальной диагностики различных патологических процессов.

Материал и методика. Проведено ЦИ соскобов с кожи 78 пациентов. Соскоб брали в процедурном кабинете с соблюдением всех правил асептики и требований, предъявляемых к получению материала для ЦИ. Мазки окрашивались по общепринятой методике Паппенгейма (Май-Грюнвальд, Романовский).

Полученные результаты. Наиболее часто выставлялся диагноз базалиомы – у 38 (48,7%) больных цитологическая картина была типичной, в 4 (5,1%) случаях в мазках обнаруживались отдельные клетки мелких и средних размеров, вызывающие подозрение на базалиому. Как правило, процесс обнаруживался на открытых участках кожи (лицо, уши, заушная область, волосистая часть головы), только в 4 случаях опухоль располагалась на спине, плечах.

Цитограмма одной больной (1,28%) была характерной для плоскоклеточного рака. В одном случае (1,28%), в мазках картина соответствовала метатипическому раку. В мазках одной больной (1,28%) с направительным диагнозом неспокойный невус были обнаружены резко атипичные клетки с включениями пигмента, что дало основание дать заключение о наличии меланомы.

Доброкачественные процессы диагностированы у 5 больных (6,4%). С учетом особенностей цитограмм у 1 больного предположительно высказано заключение о фиброме, у 1 – о гистиоцитоме, у 1 диагностирован невус, у 1 – опухоль сосудистого генеза.

У 3 (3,8%) пациентов цитограммы характеризовались обилием ороговевших безъядерных чешуек (гиперкератоз), у 6 (7,7%) в соскобах на безъядерных чешуйках находились адгезированные округлые мелкие бластоспоры мицетов (дерматомикоз).

Воспалительные процессы выявлены у 9 (11,5%) больных, цитограммы отличались большим количеством нейтрофильных лейкоцитов, иногда с примесью гистиоцитов, клетки плоского эпителия обычно с признаками деструкции. У одного

из них с учетом клинической картины высказано заключение о наличии эпидермальной кисты с нагноением.

В 10 (12,8%) случаях цитологические картины не имели признаков, позволяющих дать конкретное заключение, поэтому дано описание цитограмм с указанием на отсутствие злокачественного новообразования. Вероятно, имели место образования, связанные с возрастными изменениями кожи (это были пациенты пожилого возраста).

Таким образом, применение цитологического исследования соскобов кожи в условиях Диагностического центра помогает дифференциальной диагностики опухолей, опухолевидных образований и других патологических процессов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ДНК-ЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Мухаметгалиев Н.А., Кабиева А.О.,
Кусаинова Б.Т., Шибанова А.И.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы.

Повышение эффективности диагностики злокачественных новообразований остается важной задачей онкологии. Цитоморфологический метод исследования нуждается в повышении объективизации, в дополнении морфологической картины данными о молекулярно-биологических особенностях клеток опухоли, по сути лежащих в основе изменений цитологической и гистологической картины злокачественного процесса. Одним из методов, позволяющих выявить дополнительные цитологические критерии дифференциальной диагностики, является анализ цитологических препаратов с использованием компьютерной морфо-денситометрии, который дает возможность разрабатывать диагностические алгоритмы для разделения процессов на доброкачественные, предраковые диспластические и злокачественные. Метод проточной цитометрии позволяет быстро и объективно определять особенности пролиферации, достоверно выявлять аномальное содержание ДНК в ядрах опухолевых клеток и провести изучение корреляционных связей с классическими параметрами, характеризующими течение опухолевого процесса.

Цель: Разработка цитологических критериев диагностики рака легкого на основе цито-гистологических сопоставлений и ДНК-цитометрии.

Материал и методы исследования: Сопоставлена цитология и гистология у 46 больных раком легкого. Цитологические препараты окрашивались стандартной методикой по Паппенгейму. Для сопоставления использовался архивный гистологический материал. Морфометрия проводилась с использованием программы ВидеоТест Морфология 5.

Определение ДНК пloidности опухолевых клеток проводилось методом лазерной проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur, был использован операционный материал, полученный от 34 больных раком легкого. В качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови доноров, выделенные в градиенте плотности. Опытные и контрольные пробы окрашивали раствором пропидия йодида.

Результаты. В цитологических препаратах особое внимание уделялось строению и размерам комплексов клеток. Оценивались в сопоставлении с гистологией три признака комплексов: форма, гомогенность, размеры периметра комплексов. Форма комплексов клеток при плоскоклеточном раке имеет следующие характерные признаки: угловатость, Г-образные, три-, и многоугольные комплексы с поперечными перетяжками, ветвистые структуры которые наблюдались во всех наблюдениях. Нарушение гомогенности комплексов при плоскоклеточном раке проявлялось в характерной «дырчатости» структур в виде просветлений разных размеров и неравномерного их распределения, что встречалось в 23 наблюдениях (50%). При сопоставлении цитологии и гистологии плоскоклеточных карцином обнаружено соответствие

строения комплексов клеток со строением ткани опухоли по этим двум признакам. Размеры комплексов в цитологических препаратах при плоскоклеточном раке широко варьируют от небольших угловатых до крупных угловатых ветвистых структур нередко занимающих всё поле зрения ($1646,0 \pm 12,2$ мкм).

При ДНК-цитометрическом исследовании клеточных популяций индекс ДНК (DI) диплоидных клеток на гистограммах соответствовал 1,0. DI анеуплоидных клеток был больше или меньше 1,0. Диплоидный тип опухоли был выявлен у 8 больных (23,5%). Анеуплоидный тип новообразования был обнаружен у 26 пациентов (76,5%).

Выводы: Наряду с классическими признаками клеточной атипии изучение комплексов клеток позволяет судить о тканевой атипии и тканевой принадлежности по цитологическим препаратам, что способствует повышению объективизации цитологической диагностики рака легкого. Данные ДНК-цитометрии являются дополнением в оценке биологических особенностей опухоли.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Беламанова Л.Ж., Шибанова А.И.,
Мухаметгалиев Н.А., Турмуханов Т.Ж.*

Казахский НИИ онкологии и радиологии, отдел патологии опухолей, г. Алматы

Недостаточная эффективность обычной цитологической диагностики рака легкого связана с трудностью получения информативного материала для исследования и с проведением дифференциальной диагностики. Компьютерная морфо-денситометрия находит все большее применение в патоморфологии и в частности в цитологической диагностике новообразований как метод объективизации морфологических данных.

Цель: разработка и объективизация цитологических критериев диагностики рака легкого на основе компьютерной морфо-денситометрии.

Материал и методы исследования: Проведено исследование 10 цитограмм рака легкого у 10 больных в возрасте от 47 до 65 лет, верифицированной гистологически. Изучен материал 7 мужчин и 3 женщин. Материал для цитологического исследования получен во время оперативного вмешательства на легких.

Контрольную группу составили 6 больных (3 женщин и 3 мужчин), у которых при цитологическом исследовании обнаружены лишь реактивные изменения клеток бронхиального эпителия. Материал для цитологического исследования у данной группы больных получен с помощью браш-биопсии во время фибробронхоскопии (ФБС).

Исследовались цитологические препараты, окрашенные по Паппенгейму. Исследование ядер клеток проводили на микроскопе Leica DMLS под увеличением $\times 400$. Обработка и количественный морфометрический анализ полученных оцифрованных изображений проводили на системе анализа изображений «ВидеоТест – Морфология 5,0». С помощью данной системы оценивались следующие параметры: площадь, периметр, диаметр и коэффициент округлости ядра. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в статистическом пакете «SPSS 11.5» и программе «Биостат».

Результаты: Цитологическая картина эпителия бронхов в норме была представлена клетками цилиндрической формы с кутикулярной каемкой и ресничками, с ровными контурами ядерной оболочки. Хроматин равномерно-мелкозернистый, интенсивно «темная» окраска ядер, базофильная цитоплазма – все это было характерно для гиперплазированных клеток бронхиального эпителия.

Из 10 больных с диагнозом рак легкого у 7 больных гистологически был верифицирован плоскоклеточный рак и в 3 случаях – аденокарцинома. Цитологический диагноз плоскоклеточный рак был основан на обнаружении признаков эпидермоидной дифференцировки: полигональные или округло-овальные клетки с центрально расположенным ядром, с неравномерно-крупноглыбчатой структурой хроматина. В отдельных клетках определялись неправильной формы увеличенные ядрышки. Фон мазка был представлен бесструктурными аморфными массами, остатками ядер и цитоплазмы.

Цитологическая картина аденокарциномы была представлена клетками железистой дифференцировки. При этом в мазке преобладали цилиндрические и кубические раковые клетки с эксцентрически расположенными ядрами, встречались железистоподобные комплексы из округлых раковых клеток.

При морфометрическом исследовании изучено 1500 ядер клеток бронхиального эпителия в норме и 3500 ядер опухолевых клеток рака легкого. При этом значения площадей ядер, периметров и диаметров ядер больше при плоскоклеточном раке и аденокарциноме легких, чем соответствующие показатели в норме.

Так, площадь ядра при плоскоклеточном раке легкого составила от 91,34 до 210,91 мкм², при $M = 133,56 \pm 15,2$. Периметр ядер колебался от 30,34 до 105,75 мкм, составляя в среднем $M = 55,85 \pm 0,54$ мкм. Средний диаметр ядра при этом был равен $15,57 \pm 0,09$, амплитуда колебаний составила от 12,61 до 20,44 мкм. Коэффициент округлости ядер был равен $1,82 \pm 0,01$, при этом размах колебаний составил от 0,52 до 3,98 отн. ед.

ТРУДНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛИЗИСТЫХ РАКОВ ЖЕЛУДКА

*Айсарова А.М., Кусакина Г.К., Жарихина Т.А.,
Абылкасымова К.А., Погребицкая Т.В.*

Региональный диагностический центр, г.Алматы

Раки, клетки которых продуцируют большое количество слизи, отличаются более злокачественным течением и плохим прогнозом. Они встречаются, по литературным данным, от 3,2 до 11% случаев рака желудка (РЖ). В Лионской классификации опухолей желудка (2000 г.) перстневидноклеточный рак желудка (ПКРЖ) выделен в отдельную форму рака желудка, как и слизистая аденокарцинома. Он характеризуется диффузным инвазивным ростом, при этом могут формироваться кружевные и трабекулярные структуры; микроскопически могут обнаруживаться очаговые разрастания, имеющие солидное строение.

Гистологически слизистая аденокарцинома характеризуется тем, что муцин продуцируется клетками опухоли, формирующими железы. Иногда эти железы кистозно расширены, в них также встречаются перстневидные клетки (ПК). Слизь содержит кислые мукополисахариды.

Перстневидноклеточный рак желудка (ПКРЖ) отличается тем, что ПК составляют основную массу опухолевых клеток, располагаются в строме, разрозненно, не строят никаких железистых структур.

По содержанию муцина и морфологии опухолевых клеток выделяют 4 варианта ПК:

- 1) классической перстневидной формы: цитоплазма содержит полости, заполненные кислым муцином, оттесняющие ядро к периферии, в результате чего оно приобретает полулунную форму;
- 2) клетки с центрально расположенными ядрами;
- 3) клетки с цитоплазматическими эозинофильными гранулами в цитоплазме, содержащие нейтральный муцин;
- 4) клетки с растянутой секреторными гранулами кислых мукополисахаридов цитоплазмой, напоминающие бокаловид-

ные клетки.

Указанные клетки могут встречаться как по отдельности, так и в одной опухоли..

В гистологической диагностике существенную помощь оказывает окрашивание на слизь (альциановым синим, ШИК-реакция, муцикармин).

При цитологическом исследовании мазков возникают определенные трудности. Полиморфизм и признаки злокачественности в клетках ПКРЖ выражены нечетко, в основном они средних размеров, только единичные клетки более крупные. Цитоплазма чаще всего прозрачная, располагается эксцентрично, отодвигая ядро в одну сторону. Тем самым, ПК сходны с элементами доброкачественных процессов. Их нужно отличать от макрофагов (которые содержат липиды), кантомных клеток (с мелковакуолизированной цитоплазмой), от бокаловидных клеток при кишечной метаплазии, от кубических клеток при кистозно расширенных железах слизистой желудка. При исследовании мазков необходимо искать классические или наиболее полиморфные клетки крупных размеров. При описании цитогрaмм следует указывать на наличие даже единичных ПК. Иногда это бывает достаточным для постановки диагноза ПКРЖ, что подтверждается гистологическим исследованием, при котором ПК, которые находятся в глубине стромы, попадают в биоптат в большем количестве.

Кроме того, ПКРЖ приходится дифференцировать от аденокарциномы с ослизнением. В этом случае нужно ориентироваться на количество ПК. При аденокарциноме с ослизнением кроме ПК много полиморфных опухолевых клеток. При ПКРЖ ПК составляют основу массива опухолевых клеток. Кроме того, фон препаратов при аденокарциноме более «грязный», в отличие от цитогрaммы ПКРЖ.

Нами проанализировано 234 случая рака желудка на материале биопсий диагностического центра. Аденокарцинома с ослизнением диагностирована у 4 больных (1,7%) и ПКРЖ – у 7 (2,99%) от числа всех РЖ.

Трудности при морфологической диагностике ПКРЖ возникали при наличии:

- начальных раков желудка,
- малых по объему гастробиоптатов, или взятых поверхностно,
- при наличии 2-3 кусочков, взятых из краев язвы с выраженным фиброзом,
- значительной воспалительной инфильтрации, затрудняющей поиск мелких опухолевых клеток со светлой цитоплазмой.

В трудных случаях мы использовали дополнительные окраски на слизь (альциановым синим, ШИК-реакция, муцикармин).

Дифференциальную диагностику проводили со слизистой аденокарциномой, недифференцированным раком, лимфомой. В клетках недифференцированного рака могут содержаться ШИК-положительная или муцикарминофильная слизь. В собственной пластине слизистой оболочки при лимфомах могут встречаться клетки, подобные клеткам ПКРЖ, так называемые муцифаги.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Нишанов Д. А., Уморов М. Х., Махкамов У. У.

*Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз
г.Ташкент*

Задачи исследований: Иммуногистохимическим методом определить онкобелки Ki-67, P53.

Материалы и методы исследования: В этих целях исследовали 23 биопсийных материала с мастопатий молочной железы. Для определений использовали онкомаркеры Ki-67,

mt p53. Характер иммуногистохимических реакций оценивали визуально по 3-х балльной системе.

Результаты исследования: исследования показали, что при мастопатии Ki-67 позитивные (3+) что составляет 36% случаев, в 48% случаях наблюдалось (2+) и p53, в остальных 16% случаях.

Заключение: Результаты исследования показали, что при мастопатии - индекс пролиферации выше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ HER-2 NEU ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЭНДОМЕТРИЯ.

Нишонов Д.А., Махкамов У.У., Уморов М. Х.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент.

Задачи исследований: Изучение частоты выявления рецептора Her-2 neu в опухолях больных раком эндометрия.

Материалы и методы исследования: Исследован биопсийный материал, полученный у 21 больных. Распределили больных по гистологической структуре по 3 группам. 1-ая группа высокодифференцированная аденокарцинома – 12, 2-ая группа умеренно дифференцированная аденокарцинома – 7, 3-ая группа низкодифференцированная аденокарцинома у 2-х больных. Возраст больных от 45 до 70 лет. Проводили иммуногистохимический тест на Her-2 neu (фирма Dako citomation, 2010г.).

Результаты исследования: При высокодифференцированной аденокарциноме положительной реакции не наблюдалось. При умеренно и низко дифференцированной аденокарциноме, положительных реакций («2+», «3+») наблюдалось в двух случаях. В общей сложности her-2 neu составило в среднем 19 %.

Заключения: Таким образом, у больных с раком эндометрия чаще встречается прогноз неблагоприятный с повышенной реакцией her-2 neu рецепторов. Которые нуждаются в проведении системной и таргетной терапии.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Актуальность. Рак печени составляет 1-1,5% всех злокачественных опухолей. Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составляла 9,6 на 100 тыс. населения (59 случаев), в 2008 г. – 11,3 (70 случаев) и в 2009 г. 10,3 (64 случая), за 7 месяцев 2010 г. 35 случаев.

Полноценного скринингового метода для диагностики рака печени на данный момент нет. У людей, находящихся в группе риска по раку печени, можно провести проф. осмотры и измерить альфа-фетопротеин (норма 15 нг/мл), но этот анализ не обладает большой достоверностью и нередко даёт как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. Для визуализации опухоли применяется ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).

Несмотря на вышеперечисленные методы диагностики, диагноз рак печени может быть поставлен только на основании морфологического исследования биоптата (образца ткани), который может быть взят во время чрескожной пункции печени, во время диагностической операции или другими способами.

Для своевременного обнаружения рака печени необходимо обратиться к участковому терапевту, который направит на дополнительные исследования и в случае необходимости назначит консультацию онколога или перенаправит в онкологический диспансер.

Пункционная биопсия печени - это современный, наиболее точный и информативный метод диагностики образований печени. При помощи исследования пунктатов из образований печени можно оценить структуру печеночной ткани, печеночных клеток, злокачественные изменения, определить метастатические поражения на микроскопическом уровне. Процедура пункции печени проводится в течение нескольких секунд, является безопасной для пациентов (риск осложнений не превышает 1%).

Основы пункционной биопсии для уточняющей диагностики поражений внутренних органов были разработаны Rudin (1955), Menghini (1957).

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г. в ЗКООД было проведено цитологическое исследование тонкоигольных пунктатов 130 больных с различной локализацией первичной опухоли. Пункция производилась через переднюю брюшную стенку. После извлечения иглы её содержимое выдувалось на предметное стекло. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 96 случаях (73,9%).

Результаты. В 42 случаях был выставлен гепатоцеллюлярный рак, в 22 случаях изменения характерные для цирроза, в 32 случаях метастазы рака, в 34 случаях в препаратах обнаружены элементы крови.

Вывод. Пункция объёмных образований печени позволяет не только получить подтверждение диагноза того или иного заболевания (что само по себе имеет немаловажное значение), но во многих случаях дает возможность прижизненно составить представление о морфологическом варианте болезни и ее этиологии, что может иметь решающее значение при назначении адекватной терапии и определении прогноза заболевания.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирменев К.М., Аманов Т.Т., Якупова Л.М., Айтуганова К.Г.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Одной из главных задач практического здравоохранения является профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагностика начальных стадий рака, предопухолевых и фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды жизни женщины.

Согласно приказу № 607 от 15.10.07 МЗ РК «О проведении профилактических медицинских осмотров отдельных категорий населения» централизованная цитологическая лаборатория (ЦЦЛ) ГККП «Западно-Казахстанский ООД» проводит обследование женского населения в возрасте 35-60 лет с использованием окраски препаратов по методике Папаниколау (Пап-тест). Основанием для выбора такой возрастной категории послужили рекомендации ВОЗ.

Материалы и методы. В 2009 году было проведено цитологическое обследование шейки матки 18 614 женщин ЗКО, за 7 месяцев 2010 года 13 585 женщин независимо от анамнестических данных.

Результаты. В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число неинформативного материала составило 615 случаев (3,3%).

Всего по области в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак шейки матки 52 пациентки, заболеваемость составила 8,4% на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 43 (82,7%), III ст. - 6 (11,5%), IV ст. - 3 (5,8%).

За 7 месяцев 2010 года выявлено 225 случаев с пораже-

ниями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что составляет 1,6%. CIN I – 164 (1,2%), CIN II – 28 (0,2%), CIN III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,08%). Число неинформативного материала составило 1345 случаев (8,9%). Всего выявлено и взято на учёт 31 случай РШМ. Заболеваемость составила 4,9 на 100 тыс. населения. По стадиям заболевания: I-II ст. – 26 (83,9%), III ст. – 4 (13%), IV ст. – 1 (3,2%). В 2007 РШМ I-II ст. составляла 62,1%, в 2008 г. – 70,3%, в 2009 – 82,7%. Диагностика РШМ I-II ст. возросла на 20,6%.

Информативность цитологических исследований в значительной степени зависит от адекватности материала. В адекватном материале высока вероятность выявления предопухолевых состояний эпителия шейки матки. Поэтому эффективному цитологическому скринингу способствует взаимодействие цитологов, гистологов, гинекологов, использование специальных инструментов для взятия материала (комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щётки типа Cytobrush, Cervex-brush). Целесообразен переход к ежегодным скрининговым цитологическим исследованиям и снижению возраста обследуемых женщин до 25 лет.

Вывод. Результаты анализа диагностики поражений шейки матки у женщин во время скрининга показывают высокую эффективность проводимых исследований. За счёт цитологических исследований возросла ранняя и своевременная диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.), показатель за 7 месяцев 2010 г. составил 83,9%. Выявление различных неопухолевых заболеваний важно для активного лечения.

Метод цитологической диагностики с использованием Пап – теста как метода скрининга является одним из наиболее успешных в плане уменьшения частоты диагноза рака шейки матки, особенно эффективен при ранней диагностике РШМ, т. к. позволяет обнаружить злокачественное поражение на клеточном уровне, признаки ВПЧ.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TP53 КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭПИТЕЛИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПОПУЛЯЦИИ КАЗАХСТАНА

Перфильева А.В.¹, Джансуурова Л.Б.¹, Аюпов Ф.Т.³, Беламанова Л.Ж.³, Шибанова А.И.³, Берсимбай Р.И.²

¹Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ²Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак шейки матки (РШМ) занимает третье место в мире по заболеваемости и смертности женщин от онкологических заболеваний. В Казахстане уровень заболеваемости РШМ в 3-4 раза выше, чем в странах Европейского сообщества. Также велика частота перехода фоновых заболеваний шейки матки (дисплазии, кондиломы, эрозии и др.) в РШМ.

В качестве молекулярно-генетического маркера предрасположенности к развитию РШМ рассматривается Arg72Pro полиморфизм гена TP53 - гена регуляции клеточного цикла, индуктора апоптоза, контроля геномной стабильности и ингибирования ангиогенеза. В литературных источниках предполагается, что онкобелок Е6, кодируемый вирусами HPV-18 и HPV-16, признанных факторов риска развития РШМ, может взаимодействовать с белком p53, вызывая его деградацию. При этом белок Е6 разрушает продукт аллеля 72Arg со значительно большей скоростью, чем аллеля 72Pro. Тем не менее, в различных исследованиях одни и те же аллели имели как защитный, так и проонкогенный эффект в зависимости от этнической принадлежности населения.

Целью данного исследования было изучение ассоциации полиморфизма 72-го кодона гена TP53 с риском развития

фоновых патологии шейки матки и РШМ у женщин г.Алматы, представляющих популяцию Казахстана.

Образцы ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом из периферической крови и соскобов патологически измененной (фоновые патологии – 92 чел., РШМ – 164 чел.) и нормальной эпителиальной ткани шейки матки (объем выборки – 76 чел.). Изучение однонуклеотидного полиморфизма TP53 Arg72Pro проводили методом полимеразной цепной реакции с последующей рестрикцией амплифицированных фрагментов.

Распределение аллельных вариантов генов в когортах соответствовало распределению Харди-Вайнберга. Частота встречаемости минорного аллеля TP53 72 Pro в контрольной популяции составила - 0,421, что соответствовало результатам других исследований, занесенных в базу данных NCBI для азиатских популяций (0,386-0,511 для TP53 72 Pro).

Для оценки значения полиморфизма TP53 Arg72Pro в предрасположенности к развитию патологий эпителия шейки матки методом соотношений шансов был вычислен относительный риск (OR). Анализ показал, что с развитием фоновых заболеваний шейки матки ассоциированы генотипы TP53 72 Pro/Pro и TP53 72Pro/Arg (OR=1,123, CI 95%=0,495-2,547, P=0,78156 и OR=2,550, CI 95%=1,330 – 4,870, P=0,78156 соответственно), с развитием РШМ - генотип TP53 72Arg/Arg (OR=1,387, CI 95%=0,779-2,468, P=0,17561).

Таким образом, выявлена ассоциация полиморфизма Arg72Pro гена TP53 с риском развития как фоновых патологических процессов в эпителии шейки матки, так и РШМ, однако по сравнению с данными, полученными для других популяций, она менее значима.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-РЕГУЛЯТОРОВ КЛЕТЧНОГО ЦИКЛА CCND1 И TP53 КАК ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Курманов Б.К.¹, Джансуурова Л.Б.¹, Берсимбай Р.И.², Шибанова А.И.³, Абетов Д.А.¹

¹Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ²Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак пищевода занимает 4-е место в общей структуре смертности от онкологических заболеваний в мире. Особо остро эта проблема стоит для Казахстана, где встречаемость рака пищевода достигает 23,7 – 28,3 случая на 100 тыс. населения.

Молекулярной основой развития любого вида рака является накопление мутаций в ключевых генах, участвующих в таких важных процессах как контроль клеточного цикла, апоптоз, детоксикация ксенобиотиков, репарация ДНК и др. Некоторые из таких мутаций могут длительно существовать в популяциях, выражаясь в генетическом полиморфизме.

В данной работе изучалась взаимосвязь полиморфизмов ключевых генов-регуляторов клеточного цикла CCND1 и TP53 с предрасположенностью к развитию рака пищевода на примере казахстанских популяций.

Циклин D1, кодируемый геном CCND1, действует как сенсор ростовых факторов и способствует переходу клеток из фазы G1 в фазу S. Замена гуанина на аденин по локусу 870 гена CCND1 приводит к синтезу более устойчивого к деградации белкового продукта, что приводит к более длительному связыванию циклина D1 с циклин-зависимыми киназами и, соответственно, к пролиферации клеток, даже с неисправным геномом.

TP53 – ключевой ген-онкосупрессор человека, коди-

рующий транскрипционный фактор p53, участвующий в ряде важных клеточных механизмов, таких как блокирование клеточного цикла, репарация ДНК и индукция апоптоза. Замена аргинина на пролин в 72 положении SH3 домена белка p53 способна ослаблять его проапоптотическую функцию, что может способствовать выживанию клеток с дефектами в геноме.

Материалом для исследования служили образцы EDTA-обработанной периферической крови и букальные мазки 184 жителей г. Алматы, из которых 86 человек были здоровы и представляли собой контрольную группу и 98 человек имели диагноз рака пищевода. Материал собирали на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК с согласия пациентов.

ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом с модификациями в составе лизирующего буфера для образцов периферической крови (0,2 М ацетата натрия и 1% додецилсульфата натрия, pH 8,0) и букальных мазков (0,02 М EDTA; 0,02 М трис HCl, pH 8,0; 0,16 М NaCl; 0,5 % SDS).

Генотипирование TP53 Arg72Pro и CCND1 A870G аллелей осуществлялось при помощи метода прямого секвенирования ДНК и метода дискриминации аллельных вариантов TaqMan.

Было показано, что с развитием рака пищевода в изученных казахстанских популяциях проявляют достоверную ассоциацию генотипы гетерозигот Arg72Pro (OR=1,417) и гомозигот Pro72Pro (OR=2,860) гена TP53. Носители полиморфного аллеля A870 гена CCND1 также имеют повышенный риск развития рака пищевода (OR=2,654) с высокой степенью достоверности.

ГЛУТАТИОН И ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗА В ПРОГНОЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (НХЛ).

Пулатов Д.А., Абдиганиева С.Р.,
Туйджанова Х.Х., Абдурахмонов Д.А.
МЗ РУз РОНЦ, Ташент.

НХЛ часто характеризуется непредсказуемостью клинического течения, т.е. у пациентов с одинаковой стадией заболевания, морфологии и способов лечения течение данного заболевания может кардинально различаться. Как следствие, одни могут оставаться латентными многие годы, а другие, наоборот, быстро прогрессируют в некурабельные с распространением заболевания. Одной из возможных причин столь неожиданного течения заболевания может явиться множественная лекарственная устойчивость опухолевых клеток к химиопрепаратам.

Резистентность злокачественных клеток устойчивость к химиотерапевтическим препаратам является основной причиной рецидивов заболевания и смерти большинства больных. Один из основных причин возникновения клеточной лекарственной резистентности это- гиперэкспрессия транспортного гена семейства множественной лекарственной устойчивости, а также экспрессия специфических белков, отвечающих за «нейтрализацию» химиопрепарата в опухолевой клетке. К таким белкам относятся Pgp170, multidrug resistance-associated protein - MRP, LRP, глутатион-трансфераза.

Задача исследования. Оценка клинических перспектив определения содержания глутатиона и активности глутатион-S-трансферазы при лекарственном лечении больных НХЛ.

Материалы и методы. Изучены содержание глутатиона (GSH) и активность глутатион-S-трансферазы (GT) в злокачественных опухолях и эритроцитах 37 больных НХЛ, получивших химиотерапию по стандартной схеме.

Результаты. Показано, что уровень GSH ($0,65 \pm 0,03$

мкмоль/г) и активность GT ($1,85 \pm 0,05$ мкмоль/мин/г) НХЛ выше. В то же время оказалось, что исходно в опухолях при эффективном лечении уровень GSH и активность GT ниже, чем при прогрессировании заболевания. Установлена обратная корреляционная связь между биохимическими показателями и эффективностью лечения ($r = -0,81$; $p = 0,003$ и $r = -0,88$; $p = 0,005$).

У больных НХЛ исходный уровень GSH колебался в значительных пределах (от 0,4 до 2,03 мкмоль/мл эритроцитов). Ретроспективный анализ показал, что при эффективном лечении исходный уровень GSH не превышал 0,8 мкмоль/мл (при норме $1,19 \pm 0,17$). В противоположность этому у больных с высоким содержанием GSH (от 0,95 до 2,03, т.е. выше 0,8 мкмоль/мл) наблюдалось прогрессирование заболевания. Обратная корреляция была обнаружена также при сопоставлении активности GT и эффективности лечения ($r = -0,76$, $p = 0,002$). Эффективное лечение сопровождалось постепенным повышением содержания GSH и понижением активности GT, что может быть одной из причин развития лекарственной устойчивости к препарату в процессе лечения.

Выводы. Выявлена обратная корреляционная зависимость между уровнем GSH, активностью GT и эффективностью лечения. Установленная односторонненность изменений в опухолях и эритроцитах дает основание рекомендовать определение этих показателей больных НХЛ для прогностической оценки чувствительности опухоли к лекарственному лечению.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ARG399GLN ГЕНА XRCC1 И THR241MET ГЕНА XRCC3 В РАЗВИТИИ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Курманов Б.К.¹, Джансугурова Л.Б.¹, Берсимбай Р.И.²,
Шибанова А.И.³, Абетов Д.А.¹

¹ Институт общей генетики и цитологии, Алматы, Казахстан, ² Евразийский национальный университет им. Гумилева Л.Н., Астана, Казахстан, ³ Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Казахстан

Рак пищевода представляет собой одну из наиболее агрессивных опухолей в мире. Он может быть вызван мутациями и полиморфизмами ключевых генов регуляции клеточного цикла, апоптоза, репарации ДНК и т.д. Исправление генетических изменений и повреждений структуры ДНК осуществляется разнообразными путями и с участием сложных комплексов ферментов и белковых факторов. Ключевую роль в процессах репарации ДНК играют гены группы XRCC, сокращенно от X-ray cross-complementing group (перекрестно-комплементарная группа репарации радиационных повреждений).

На данный момент описан ряд полиморфизмов генов группы XRCC, способных приводить к различным патологиям, в частности к развитию рака.

Нами изучена ассоциация наиболее значимых полиморфизмов отдельных представителей данной группы – Arg399Gln гена XRCC1 и Thr241Met гена XRCC3 – с риском развития рака пищевода у жителей г. Алматы.

XRCC1 является мультидоменным белком, участвующим в эксцизионной репарации оснований (ЭРО; BER – base excision repair) и репарации однонитевых разрывов ДНК. Он может играть важную роль в устойчивости организма к действию разнообразных мутагенных факторов (окисляющие и алкилирующие агенты, ионизирующая радиация). Одним из наиболее важных полиморфизмов гена XRCC1 является замена аргинина на глутамин в 399 кодоне (Arg399Gln). По литературным данным аллель Gln399 связана с увеличением уровня повреждений ДНК, что может происходить за счет

снижения эффективности репарации.

Белок XRCC3 участвует в репарации двуниевых разрывов и поперечных сшивок ДНК, а также взаимодействует с белками Rad51 (RecA у бактерий), ключевыми компонентами рекомбинационной репарации. Наиболее значимым полиморфизмом гена XRCC3 является замена треонина на метионин в 241 кодоне (Thr241Met). Предполагается, что она способна нарушать сайт фосфорилирования и таким образом снижать репарационную функцию.

Материалом для исследования служили образцы EDTA-обработанной периферической крови и буккальные мазки 184 жителей г. Алматы, из которых 86 человек были здоровы и представляли собой контрольную группу и 98 человек имели диагноз рака пищевода. Материал собирали на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК с согласия пациентов.

ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным методом с модификациями в составе лизирующего буфера для образцов периферической крови (0,2 М ацетата натрия и 1% додецилсульфата натрия, pH 8,0) и буккальных мазков (0,02M EDTA; 0,02 М трис HCl, pH 8,0; 0,16 М NaCl; 0,5 % додецилсульфата натрия).

Генотипирование XRCC1 Arg399Gln и XRCC3 Thr241Met проводили методом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).

В результате было показано, что с развитием рака пищевода проявляют достоверную ассоциацию генотипы гетерозигот Arg399Gln (OR=1,384) и гомозигот Gln399Gln (OR=2,362) гена XRCC1. Интересен тот факт, что ассоциацию с раком пищевода показали гомозиготы по обоим аллелям гена XRCC3: Thr241Thr (OR=1,410) и Met241Met (OR=6,538), в то время как у гетерозигот Thr241Met подобной взаимосвязи выявлено не было (OR=0,550).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОТИНГЕМСКОГО ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА (NPI) В РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РМЖ.

Середа Е.Н.¹, Хамидуллина Г.А.², Шалахметова Т.М.³

¹ ТОО «Консультант Биотех», г. Алматы, ² Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, ³ Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

Актуальность: Нотингемский прогностический индекс — клиничко-патоморфологическая система классификации базирующаяся на сочетании размера опухоли, гистологической степени злокачественности, и статусе лимфатических узлов, широко используемый в Европе и Великобритании для предсказания течения РМЖ. Наряду с этим в мировой практике активно внедряется распределение РМЖ по молекулярно-генетическим подтипам, основанное на иммуногистохимическом определении рецепторов эстрогена и прогестерона и онкопротеина HER2neu.

Целью нашего исследования явилось определить Нотингемский прогностический индекс в различных молекулярно-генетических подтипах РМЖ.

Материал и методы: В данное исследование вошли 243 больных РМЖ находившихся на лечении в КазНИИОиР с 2006 по 2009гг. Всем больным проведено стандартное морфологическое исследование, иммуногистохимическое исследование с определением рецепторов эстрогена (clone 1A5), рецепторы прогестерона (clone PgR 636) белков Her2/neu (polyclonal), Ki67(clone MIB-1), p53 (clone DO-7) производства DAKO (Дания).

Результаты исследования: Все больные разделены на 4 молекулярно-генетических подтипа: люминальный А подтип (РЭ+ПР+HER2neu-) — составил 90 больных, люминальный Б (РЭ+ПР+HER2neu+) — 52 больных, HER2neu+ подтип — 32 больных, базальный подтип (РЭ-ПР-HER2neu-) — 35 больных. Также отдельно была выделена группа больных с HER2neu-

сомнительным статусом в которую вошли 34 больных. При определении NPI получили, что в Люминальном А подтипе «хороший прогноз» (NPI<3,4) составляет у 26,7% больных, тогда как в остальных молекулярно-генетических подтипах он не превысил 6%, наименьшее количество больных с «хорошим прогнозом» получено в базальном подтипе РМЖ. Получены достоверные различия в «умеренном прогнозе» (NPI 3,4-5,4) в подтипах Люминальный А (45,6%) и Люминальный Б (40,4%) и в группе с HER2neu-сомнительным фенотипом (52,9%). Наибольшее количество больных с «плохим прогнозом» (NPI>5,4) получены в Люминальном Б (53,8%), HER2neu+ (53,1%) и базальном (54,3%) подтипах.

Выводы: Таким образом подучены достоверные различия при определении NPI между Люминальным А и Люминальным Б подтипами (p=0,001), Люминальным А и HER2neu+ подтипами (p=0,006), Люминальным А и базальным подтипами (p=0,003), а так же между Люминальным А и HER2neu-сомнительным подтипами (p=0,046).

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА

Якупова Л.М.

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Рак желудка (РЖ) остается одним из самых распространенных заболеваний в мире. Ежегодно регистрируется почти 800 тысяч новых случаев и 628 тысяч смертей от этого заболевания.

Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составила 21,0 на 100 тыс. населения (126 случаев - 3 место), в 2008 г. — 22,0 (135 случаев-3-4 место) и в 2009 г. 19,0 (119 случаев — 4 место).

Диагностический поиск направлен на морфологическую верификацию и обнаружение лимфогенных и гематогенных метастазов. Эзофагогастродуоденоскопия с цитологическим и гистологическим исследованием — является ведущим методом диагностики.

Международным Агентством по изучению рака Helicobacter pylori (HP) признан канцерогеном первого порядка, то есть связь с развитием РЖ считается доказанной.

Цель работы. Показать возможности цитологического метода при диагностике заболеваний желудка.

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г.(7 мес.) в централизованной цитологической лаборатории ЗКООД было проведено цитологическое исследование эндоскопического материала желудка 1064 пациентов. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 1051 случаях (98,8%).

Результаты. В 203 (19,3%) случаях была обнаружена аденокарцинома желудка (все случаи подтверждены гистологически), в 848 (80,7%) случаях - доброкачественные процессы (выраженные пролиферативные изменения, характерные для хронических гастритов, язвенной болезни желудка, полипов), из них в 269 (31,7%) случаях обнаружены Helicobacter pylori (HP), в 25 (2,9%) случаях кандидоз желудка, в 13 (1,2%) случаях были получены неинформативные препараты.

Из 848 случаев доброкачественных пролиферативных процессов: 200 (23,6%) случаев язвенной болезни желудка, где в 79 (39,5%) случаях обнаружены HP, в 9 (4,5%) случаях обнаружен рак желудка, в 6(3%) — кандидоз; 112 (13,2%) случаев полипов желудка, из них всего в 12 (10%) случаях обнаружены HP, в 5 (4,5%) случаях рак желудка; 242 (28,5%) случая гастритов, из них в 178 (73,5%) случаях обнаружены HP.

Вывод. Цитологическое исследование является высокоинформативным методом, позволяющим в короткие сроки диагностировать заболевания желудка, обеспечивает врача информацией о наличии доброкачественного или злокаче-

ственного поражения, подтверждая или отрицая предварительный клинический диагноз. Важное значение имеет диагностика заболеваний желудка, их своевременное лечение. Установление этиологического значения *Helicobacter pylori* (HP) в развитии заболеваний желудка делает цитологическое исследование особенно ценным.

В настоящее время улучшение результатов лечения рака желудка связывают, главным образом, не с совершенствованием оперативной техники, а с диагностикой и лечением ранних стадий рака желудка. Процесс опухолевой трансформации клеток до первых клинических проявлений рака желудка длительный, многоэтапный, что обуславливает возможность его диагностики на ранней стадии, которая может продолжаться с момента обнаружения заболевания в сроки от 6 месяцев до 10 лет и более. Отсюда становится очевидной реальная возможность диагностики опухоли на ранней стадии, когда рак желудка еще не проявляет такой высокой степени злокачественности, как при распространенных формах.

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАДИРОВАНИЯ НЕФРОБЛАСТОМЫ В ПРОТОКОЛАХ COG (CHILDREN'S ONCOLOGY GROUP) И SIOP (INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY). (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Нурсулейменова М.А.

Казахский НИИ онкологии радиологии.

В международной онкологической практике лечения нефробластом придерживаются протоколов, предложенных международными группами COG и SIOP.

Табл. Клиническая стадия нефробластомы: SIOP и COG.

Стадия	классификации	Отличия
I	COG:	Ограничена почкой и полностью резектабельна. Капсула интактна.
	SIOP:	Ограничена почкой или окружена фиброзной псевдокапсулой, если имеется выход за пределы границ почки.
	COG & SIOP:	Почечные синусы или окружающие мягкие ткани могут быть минимально инфильтрированы опухолью без вовлечения в опухолевый процесс сосудов. Тонкоигольная биопсия не меняет стадию заболевания.
II	COG & SIOP	Опухоль прорастает за пределы собственной капсулы почки (инфильтрирует сосуды, прорастает в окружающие органы, и полую вену), но полностью резектабельна. Включая местно распространенные опухоли.
III	COG & SIOP	Макро или микрорезидуальные опухоли ограниченные брюшной полостью. Включая случаи: а) опухоль имеется по краю резекции; б) метастазы во внутрибрюшные лимфатические узлы; с) диффузная перитонеальная контаминация первичной опухолью, опухолевые импланты во время проведения операции д) остаточная опухоль брюшной полости е) удаление опухоли частями (кускование) ф) биопсия опухоли перед проведением химиотерапии
IV	COG & SIOP	Гематогенные метастазы или метастазы в лимфоузлы за пределами брюшной полости.

V	COG & SIOP	Двустороннее поражение почек. Опухоли каждой почки в подобных случаях должны быть отдельно подстадированы.
---	------------	--

При прогнозировании терапевтического лечения учитывают наличие благоприятного или неблагоприятного гистологического варианта.

При наличии неблагоприятных признаков прогнозируют возможность отсутствия эффекта на лечение. К неблагоприятным признакам относят ядерную анаплазию: патологические митозы, отчетливый полиморфизм и гиперхроматоз ядер. В контексте гистологической оценки имеет значение локальная или диффузная анаплазия.

Табл. Гистологические варианты нефробластомы.

I. опухоли с низким риском злокачественности	Кистозная частично дифференцированная Полностью некротизированная
II. опухоли с промежуточным риском злокачественности	эпителиальный тип, стромальный тип, смешанный тип, регрессивный тип, с фокальной анаплазией
III. опухоли с высоким риском	бластемный тип, с диффузной анаплазией

Заключение: Главными особенностями предложенных протоколов является:

- назначение консервативной терапии в неоадьювантном режиме с последующим хирургическим лечением дает возможность оценить эффективность терапевтического лечения и провести коррекцию схемы лекарственного лечения в зависимости от гистологического варианта опухоли (протокол SIOP).

- выполнение радикальной операции с последующим назначением химиотерапевтической схемы в зависимости от гистологического варианта опухоли (протоколы COG).

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Якупова Л.М.

ГК КП «Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер», г. Уральск

Актуальность. Рак печени составляет 1-1,5% всех злокачественных опухолей. Заболеваемость по ЗКО в 2007 г. составляла 9,6 на 100 тыс. населения (59 случаев), в 2008 г. – 11,3 (70 случаев) и в 2009 г. 10,3 (64 случая), за 7 месяцев 2010 г. 35 случаев.

Полноценного скринингового метода для диагностики рака печени на данный момент нет. У людей, находящихся в группе риска по раку печени, можно провести проф. осмотры и измерить альфа-фетопротеин (норма 15 нг/мл), но этот анализ не обладает большой достоверностью и нередко даёт как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. Для визуализации опухоли применяется ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).

Несмотря на вышеперечисленные методы диагностики, диагноз рак печени может быть поставлен только на основании морфологического исследования биоптата (образца ткани), который может быть взят во время чрескожной пункции печени, во время диагностической операции или другими способами.

Для своевременного обнаружения рака печени необходимо обратиться к участковому терапевту, который направит на дополнительные исследования и в случае необходимости назначит консультацию онколога или перенаправит в онкологический диспансер.

Пункционная биопсия печени - это современный, наи-

более точный и информативный метод диагностики образований печени. При помощи исследования пунктатов из образований печени можно оценить структуру печеночной ткани, печеночных клеток, злокачественные изменения, определить метастатические поражения на микроскопическом уровне. Процедура пункции печени проводится в течение нескольких секунд, является безопасной для пациентов (риск осложнений не превышает 1%).

Основы пункционной биопсии для уточняющей диагностики поражений внутренних органов были разработаны Rudin (1955), Menghini (1957).

Материалы и методы. За период с 2007-2010 г. в ЗКООД было проведено цитологическое исследование тонкоигольных пунктатов 130 больных с различной локализацией первичной опухоли печени. Пункция производилась через переднюю брюшную стенку. После извлечения иглы её содержимое выдувалось на предметное стекло. Препараты окрашивались по методике Паппенгейма. При этом материал, пригодный для исследования был получен в 96 случаях (73,9%).

Результаты. В 42 случаях был выставлен гепатоцеллюлярный рак, в 22 случаях изменения характерные для цирроза, в 32 случаях метастазы рака, в 34 случаях в препаратах обнаружены элементы крови.

Вывод. Пункция объемных образований печени позволяет не только получить подтверждение диагноза того или иного заболевания (что само по себе имеет немаловажное значение), но во многих случаях дает возможность прижизненно составить представление о морфологическом варианте болезни и ее этиологии, что может иметь решающее значение при назначении адекватной терапии и определении прогноза заболевания.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОЖИ

*Беламанова Л.Ж., Мирманова Г.Ж., Гаврилова Е.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы*

В настоящее время частота возникновения злокачественных новообразований кожи значительно увеличилась и продолжает неуклонно возрастать. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50%.

Вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в определении абластичности оперативного вмешательства не вызывает сомнений.

Цель: оценить возможности срочной цитологической диагностики при новообразованиях кожи с краев послеопе-

рационной раны.

Материал и методы исследования: Были проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Результаты: Из 40 больных на дооперационном этапе установлены цитологически следующие варианты: плоско-клеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом у 12 больных были выявлены опухолевые клетки, в том числе в 8 случаях (66,7%) цитологическая картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная. Данная цитограмма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных (из 12) с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки.

У одного пациента с меланомой кожи (8,3%) в опухолевых клетках обнаруживался пигмент. Ядра - полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная. Встречались резко полиморфные двухядерные клетки.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток. В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Выводы: Таким образом, значение цитологического метода исследования велико не только при постановке, но также и определение гистогенеза опухоли, что играет большую роль в выборе метода лечения. В дальнейшем проведение цитологического исследования на абластичность из краев резекции указывает на их значимость и необходимость, так как позволяют клиническим врачам вовремя провести коррекцию плана лечения у этой категории больных.

Онкогематология

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУРПУРЫ ШЕНЛЯЙНА-ГЕНОХА

Габбасова Э.З., Шерияздан Ж.С., Сабырбаева Г.А.,

Кайдарова Р.К., Есеналиева Д.Б., Оспанова А.О.

Казахский Национальный Медицинский Университет им.
Асфендиярова С. Д.

Пурпура Шенляйн-Геноха (ПШГ) известна как приобретенная вазопатия. Между тем, каждый индивидуум обладает повышенной чувствительностью к различным патогенным агентам, что обусловлено генетическими маркерами системы HLA. В возникновении ПШГ не исключается роль наследственной предрасположенности (Сухов В.М., 1990; Прохоров Е.В., 1992; Amoli M., 2002). Между тем, известно, что на характер ассоциативных связей болезней с системой HLA оказывает влияние этническая принадлежность обследуемых лиц.

В связи с изложенным, антигены системы HLA в нашей работе исследованы у взрослых лиц казахской и русской национальностей, жителей города Алматы, больных ПШГ.

Материалы и методы: были обследованы больные с ПШГ в возрасте от 14 до 67 лет. Женщин среди обследованных было 55,4%, мужчин – 44,5%. Лиц казахской национальности было 60 человек, русской – 50 человек.

Нами получены данные об иммуногенетической гетерогенности пурпуры Шенляйн-Геноха в изучаемых этнических группах, ассоциируемых с клиническим полиморфизмом болезни. Так, у больных казахской национальности при кожно-суставной форме ПШГ антигенами предрасположенности определены антигены В12 и Сw6. Относительный риск RR кожно-суставной формы для антигена В12 был равен 7,0, для антигена Сw6 – 13,7, что свидетельствует о заметном риске при наличии их у больного. Отсутствовавший в данной группе антиген Сw3, признан как протективный. При абдоминальной форме заболевания предрасполагающими антигенами признаны – В8 и Сw6, отсутствовавший антиген А3 определен как антиген – протектор. Почечная форма ПШГ характеризовалась у больных частотой антигенов В18, В27, В35. Смешанная форма ПШГ отличалась высокой частотой у больных антигена В7 с относительным риском $RR=5,37$. Отсутствовавший среди больных данной группы антиген А11 – признан антигеном протектором.

В такой же последовательности и с теми же критериями изучены ассоциативные связи у больных пурпурой Шенляйн-Геноха русской популяции. В русской популяции при кожно-суставной форме ПШГ чаще других встречается антиген В16 с относительным риском равным 5,17, который был определен как антиген предрасположенности. Протективным антигеном признан А3. Антигеном предрасположенности при абдоминальной форме определен также антиген В16 при $RR=7,05$. Другим антигеном предрасположенности оказался Сw1 ($RR=3,62$). Протективным антигеном определен А10, который у данной группы больных отсутствовал. При почечной форме болезни антигены В8 и В35 отличались высокой частотой встречаемости при относительном риске – 4,43 и 3,93 (соответственно), в связи с чем, они отнесены к антигенам предрасположенности. К протективным антигенам причислены Сw3 и Сw4, отсутствовавшие у данных больных. У больных смешанной формой ПШГ В18 признан антигеном предрасположенности, в силу величины $RR(4,43)$. Антигенами резистентности определены: А1, встречавшийся в 4,5 раз реже, чем в контроле ($p<0,05\%$) с относительным риском равным 0,25, а также В15, который при данной форме болезни отсутствовал.

Таким образом, при ПШГ существуют достоверные иммуногенетические механизмы, предопределяющие возникновение болезни, ее течение и прогноз, а также детерминирующие резистентность. На характер ассоциативных связей ПШГ с системой HLA оказывает безусловное влияние этническая принадлежность, возраст больного, регион его проживания и клиническая форма болезни.

АУТОИММУНДЫ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯНЫҢ ЕМІНДЕ ТИМОДЕПРЕССИНДІ ҚОЛДАНУ

Шерияздан Ж.С., Габбасова Э.З., Сабырбаева Г.А.,

Искакова Д.Е., Алимгазиева К.Т.

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық
университеті

Біріншілік және екіншілік цитопениялардың патогенезі мен емі заманауи гематологияның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Иммунды цитопениялардың патогенезі меншікті жасушаларының антигендеріне аутоантиденелердің өндірілуіне негізделген. Сондықтан иммунносупрессия үшін негізінен жанама әсерлері көп стероидты гормондар, цитостатикалық иммунодепрессанттар қолданылады. Осы тарапта лимфопозддің ерте кезеңдеріне әсер ететін ерекше иммуносупрессивті қасиетке ие пептидті иммунодепрессанттар тобына жататын тимодепрессин оңтайлы болып табылады.

Бұл жұмыстың мақсаты кортикостероидтардан әсер болмаған аутоиммунды тромбоцитопениямен науқастардың емінде тимодепрессинді қолданудың әсерлілігін анықтау.

Клиникалық зерттеу 20-40 жас аралығындағы 11 кортикостероидтардан әсер болмаған аутоиммунды тромбоцитопениямен науқастарда өткізілді. Диагноз петехиалды-дақты қанталау типімен өтетін геморрагиялық синдромға, гемограмм, миелограмма мәліметтеріне сүйеніп қойылды. Ауру ұзақтығы 2 айдан 5 жыл аралығында.

Тромбоцитопениямен науқастарға тимодепрессинді біз келесі мөлшерде енгіздік: 1 мл бұлшық етке 7 күн бойы, 1 апта үзілістен соң, тимодепрессинмен екінші ем курсы жүргізілді. Тимодепрессин науқастарда монорежиммен қатар, кортикостероидтармен немесе плазмафарезбен комбинацияда қолданылды.

Препараттың әсері бірінші жетікүндік емнен соң-ақ байқалды, ол преднизалонның жалпы мөлшерін азайтып және оны тоқтатуды тездетумен көрінді. Монотерапияда тимодепрессин геморрагиялық синдромды тоқтатып, тромбоциттер мөлшерін критикалық деңгейден жоғарылатуға мүмкіншілік берді. Тимодепрессинді плазмафарезбен бірге тағайындау кортикостероидтармен комбинацияға және тимодепрессинмен монотерапия режиміне қарағанда әсерлі болды.

Емнің екінші курсынан соң тромбоциттер санының 50 мыңнан жоғарылауы байқалды.

Тимодепрессинмен емдеу кезеңінде жанама, токсикалық, аллергиялық байқалған жоқ.

Сонымен, тимодепрессин аутоиммунды тромбоцитопениялық пурпура кезінде монотерапия режимінде де, плазмафарезбен бірге қолданғанда да кеңінен белгілі жанама әсерлері көп иммунодепрессанттарға альтернативті ем бола алады.

СЛУЧАЙ ТРУДНОКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ ФОРМЫ В-КЛЕТОЧНОГО ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ахматуллина С.К.

ГКП «Городская больница №1», Астана

Исходная разнокачественность субстрата малигнизации (около 20 х 106 клонов В-лимфоцитов), «остановка дифференцировки» на разных уровнях, непредсказуемые изменения морфологии, а также секреции клеток к моменту распознавания опухоли создают определенные трудности при классификации парпротеинемических гемобластозов, чем объясняется различная интерпретация при анализе различных форм.

Больная К., 58 лет, поступила в гематологическое отделение ГКП «Городская больница №1» г. Астаны с жалобами на повышенную утомляемость, похудание.

В течение полугода было обращено внимание на ускорение СОЭ.

В объективном статусе: Умеренная бледность кожи и слизистых. Периферические лимфоузлы не увеличены. Печень+1см. Селезенка не увеличена. При дообследовании выявлены гиперпротеинемия, лимфоцитоз (часть лимфоцитов плазматизирована); в костном мозге – 50% лимфоцитов, из них 37% плазматизированные, плазматических клеток 14%. Костной деструкции рентгенологическим исследованием не выявлено.

Пациентка направлена на дообследование в ГНЦ РАМН (г. Москва).

В лаборатории гуморального иммунитета ГНЦ обнаружена моноклональная секреция G λ 31,6 г/л, следовая секреция B λ , гуморальный иммунодефицит.

ОАК: Нв – 96 г/л; эритроциты – 2,78х10¹²/л; L – 11,7 х 10⁹/л; MCV 111 фл; MCH 34 пг; тромбоциты - 211 х10⁹/л; нейтрофилы - палочкоядерные 1%, сегментоядерные 12%; лимфоциты - 84% (9,8 тыс/мкл), 20 лимфоцитов с плазматизацией цитоплазмы; моноциты -3%; СОЭ – 65 мм/час.

Цитологическое исследование костного мозга: Лимфоциты - 64%; плазматические клетки - 12,2%.

Гистологическое исследование костного мозга: Картина парпротеинемического гемобластоза.

Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи: Моноклональная секреция G λ 31,6 г/л. Следовая секреция белка Бенс-Джонса λ . Вторичный иммунодефицит. Повышение уровня СРБ и β 2 микроглобулина в сыворотке.

Иммунофенотипирование костного мозга на проточном цитофлуориметре: В исследованной пробе костного мозга полигон крупных клеток не выявляется. Лимфоцитарный полигон составляет 64% от всех просчитанных событий. В нем выявляются клетки с фенотипом CD45-/CD38+/CD138+/CD19-/CD56-/CD79 α -, клональные по λ легкой цепи иммуноглобулинов (цитоплазматическая экспрессия).

Цитогенетическое исследование костного мозга: проанализировано 20 метафаз. Кариотип 46, XX.

У пациентки подтверждено наличие клона клеток с цитоплазматической экспрессией λ -цепей, секретирующих парпротеин G λ и СЛЦ λ . Иммунофенотип моноклональных клеток соответствует плазматическим, но морфологически основная масса клеток представляет собой лимфоциты и лимфоплазмциты. Кроме того, в ОАК имеется абсолютный лимфоцитоз (до 9 тыс/мкл).

Таким образом, В-клеточное лимфопрولیферативное заболевание у пациентки занимает промежуточное положение между множественной миеломой и лимфоплазмочитарным лейкозом. Интоксикационный синдром (снижение массы тела, выраженная общая слабость, утомляемость), глубокий гуморальный иммунодефицит являются показанием к незамедлительному началу лечения.

По рекомендации ГНЦ РАМН (г.Москвы) начата терапия по программе VMP (велкейд, мелфалан, преднизолон).

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ ЦИТОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Астапкевич Л.А.

Городская больница №1, г. Астана

Панцитопенический синдром может вызываться несколькими причинами: 1) относительная недостаточность костного мозга \ возникает из-за дефицита фолата или витамина В-12, который влияет на все три ростка клеток в костном мозге, но костный мозг в этом случае всегда будет гиперклеточным, 2) чрезмерная деструкция клеток периферической крови. Костный мозг может быть гиперклеточным, как и при апластической анемии, мие-лодиспластическом синдроме, миелофиброзе. Примером периферической утилизации является гиперспленизм. На сегодня актуальна проблема цитопенического синдрома с пред-полагаемым этиологическим фактором: лекарственные или токсические, ассоциированные с вирусами \ гепатита, парвовирусами, вирусом иммунного дефицита, цитомегалови-русом, вирусом Эпштейна-Барр\.

В отделение гематологии Городской больницы №1 госпитализирован пациент с жалобами на общую слабость, утомляемость, головокружение, наличие высыпаний на коже, кровоточивость десен. Наблюдается у гематолога с ноября 2009г. по поводу цитопениче-ского синдрома. При первичном исследовании костного мозга, в связи с наличием мега-лобластности, выставлен диагноз В-12-дефицитная анемия, терапия витамином В-12-эффекта нет. Объективно: состояние больного средней степени тяжести. Кожа и видимые слизистые бледные, диффузно петехии. Кровоточивость десен. Периферические лимфо-узлы не увеличены. Печень и селезенка не пальпируются.

Общий анализ крови-Нв-56 г\л, Эр-1,58 х 10¹²/л, Л-3,2 х 10⁹/л, Тр-12,8 х10⁹/л, СОЭ-54мм\ час, п\1,с\15, л\78,м\6, ретикулоциты-15 промилей. Анализ крови на LE-клетки-отриц.

Реакция Райта-Хеддельсона-отрицат. Витамин В-12- 1007 pg\ml, фолиевая кислота-7,58 ng\ml \ в пределах нормы\ . Общий билирубин – 11,7 ммоль\л, АЛТ-60 u\л, ЛДГ- 615 u\л, сыв. железо-53,1ммоль\л, СРБ-отр, свободный Нв-154,3 мг%.

ИФА на гепатит В -отр. ИФА на гепатит С- а-НСV -полож. ПЦР-диагностика на вирус гепатита С-3270 МЕ в 1 мл. Генотип гепатита С- 3А положительно. Количественное определение РНК вируса гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального време-ни от 13.05.2010г.- 3,27 х 10³.

Миелограмма \ трижды\: костный клеточный или гиперклеточный. Гиперплазия эритро-идного ростка41,2-49% с элементами диспоэза, мегалобластности, встречаются 2- и 3-ядерные нормоциты \ базофильные, полихроматофильные\ . МКЦ 1-2 в препаратах. Суже-ние гранулоцитарного ростка с нарушением созревания-33,5%. Увеличение числа плазма-тических клеток до 7,0%. Лимфоцитоз до 29%.

Трепанобиопсия : часть костномозговых полостей представлены полностью жировыми клетками, среди которых в виде островков рассеяны кроветворные клетки. Другая часть \костных полостей более клеточная, но резко снижен красный росток, МКЦ нет. Изме-нения носят вторичный характер.

Иммунофенотипирование: данных за острый лейкоз нет.

Морфоцитохимическое исследование – уровень негемоглобинового железа в эритроид-ных клетках в пределах нормы. Обнаружено 52% сидеробластов\ норма\, патологических кольцевидных форм не выявлено.

Цитогенетическое исследование клеток костного мозга \ дважды\ - хромосомных пере-строек не выявлено.

В результате обследования у пациента исключены: Апластическая анемия, Миелоди-спластический синдром,

Дефицит витамина В-12 и фолатов, Острый лейкоз. Данное состояние расценено как гепатитассоциированная цитопения. Необходима разработка совместной тактики введения инфекционистов и гематологов в данных ситуациях.

ОСОБЕННОСТИ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ МЕЛКОКЛЕТОЧНЫХ САРКОМАХ У ДЕТЕЙ.

Горбунова Т.В., Поляков В.Г., Шведова Т.В.,

Серебрякова И.Н., Тимошенко В.В., Тупицын Н.Н.

Учреждение РАМН РОНЦ имени Н.Н. БЛОХИНА НИИ ДОГ.
Россия, Москва.

Клетки костного мозга способны подавлять развитие отдаленных метастазов у больных мелкокруглоклеточными саркомами. Это доказано в эксперименте и в клинике, однако, эффекторные клетки иммунной системы, ответственные за этот феномен, не известны. Обсуждается роль естественного иммунитета, Т-цитотоксических клеток и Т-регуляторных клеток. Учитывая важность подобных исследований для разработки иммунотерапевтических протоколов лечения, нами проведено изучение субпопуляций лимфоцитов костного мозга у 29 детей с саркомами негемопоэтической природы (мальчики — 16, девочки — 13; возраст 1-16 лет). Преобладали больные рабдомиосаркомой (11 пациентов) и саркомой Юинга (9 пациентов). Группу сравнения составили 12 детей, у которых диагноз злокачественной опухоли в ходе комплексного обследования не был подтвержден. Больным проводилось детальное морфологическое изучение костного мозга и иммунологическая оценка клеток врожденного и адаптивного иммунитета, включающая Т-клетки и их субпопуляции, В-лимфоциты, НК-клетки и активированные лимфоциты. Установлены некоторые достоверные различия в субпопуляциях лимфоцитов костного мозга больных в сравнении с нормой, а также в зависимости от нозологической формы заболевания. Содержание Т-цитотоксических клеток (CD3+, CD8+), было достоверно более высоким у больных с саркомой Юинга в сравнении с нормой и таковым у больных с рабдомиосаркомой ($65,3 \pm 4,8\%$; $51,5 \pm 2,8\%$ и $47,3 \pm 5,5\%$ соответственно; $p=0,028$ и $0,025$). Напротив количество CD4+ Т (CD3+)-лимфоцитов у больных саркомой Юинга было ниже, чем в норме ($23,8 \pm 4,5\%$ и $38,6 \pm 3,4\%$, $p=0,016$). НК-клетки естественного иммунитета (CD56+, CD3-) у больных саркомой Юинга были значительно выше, чем в норме — $23,5 \pm 6,6\%$ и $9,8 \pm 2,2\%$, $p=0,046$. Характерной особенностью рабдомиосаркомы было резкое повышение TCR γ/δ — Т-клеток в сравнении с нормой; $17,0 \pm 0,9\%$ и $9,9 \pm 1,7\%$, $p=0,04$. Полученные данные могут свидетельствовать о существовании особенностей субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга в зависимости от нозологической формы мелкоклеточных сарком.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМА ViCAP У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВНЫМИ И РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ

Абдурахманов Д.А., Пулатов Д.А.,

Туйджанова Х.Х., Абдиганиева С.Р.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУЗ

Заболеваемость неходжкинскими лимфомами (НХЛ) имеет неизменную тенденцию к росту в течение последних лет. В развитых странах она выше и за последние 20 лет увеличилась более чем на 50% превышая по темпу прироста лимфому Ходжкина. НХЛ относится к опухолям, чувствительным к химиотерапии. Однако не менее чем у трети пациентов стандартная терапия неэффективна или возникают рецидивы и представляют большие сложности в терапии их. Основным

в лечении рефрактерных и рецидивирующих форм болезни является использование новых комбинаций противоопухолевых агентов и интенсификация лекарственной терапии (Salvage-терапия, высокодозная полихимиотерапия с последующей трансплатацией аутологичного костного мозга или периферических стволовых клеток, и различные варианты аллогенных трансплантаций). Однако часть этих методов высоко токсична, некоторые не всегда доступны, например, из-за отсутствия родственных доноров костного мозга, при использовании отдельных методов терапии недостаточно изучены отдаленные результаты и не всегда определены факторы отбора для конкретного варианта терапии. Длительная выживаемость пациентов этой категории НХЛ не велика. В связи с этим разработка новых схем полихимиотерапии для лечения резистентных и рецидивирующих форм злокачественных лимфом является актуальной. Цель исследования состояла в улучшении результатов полихимиотерапии (ПХТ) рефрактерных и рецидивных форм неходжкинской лимфомы (НХЛ), путем применения режима ViCAP. В исследование включались пациенты: морфологическое подтверждение наличия неходжкинской лимфомы, клиническая стадия любая за исключением первой (Ann Arbor классификация, 1971г.), статус ECOG – ВОЗ не менее – 3, возраст больного 15- 70 лет, проведение системной химиотерапии по схеме ViCAP, отсутствие сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации.

Схема ViCAP: Винкристин 1,4мг/м² 1 и 8 день, Цисплатин 100мг/м² 1 день, Доксорубин 50мг/м² 1 день, Циклофосфан 600мг/м² 1 день.

В исследование включены 32 больных (14 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 16 до 65 лет с рецидивом и рефрактерной формой (не менее 2 курсов по одной из схем: COP, ACOP, CNOP, CNOEP с регрессией менее 30%) НХЛ II-IV стадии. 19 больным (I гр.) проводилось 2 курса ПХТ по схеме ViCAP, 13 больным, не получавшим ПХТ по схеме CNOEP (II гр.), 2 курса в указанном режиме.

У больных I гр. общий ответ отмечался у 14 (73,6%) больных, причем у 4 (21%) - полная ремиссия (у 1 пациента рассосались метастатические очаги в легких), у 11 (57,9%) пациентов - частичная ремиссия, у 3 (15,8) отмечалась стабилизация и в 1 (5,3%) случае прогрессирование процесса (метастазы в головной мозг и легкие). Во II гр. объективный эффект отмечался у 8 (61,5%) пациентов, из них у 1 (7,7%) полная и у 7 (53,8%) пациентов частичная ремиссия. Стабилизация отмечалась в 4 (30,8%) случаях и в 1 (7,7%) случаях прогрессирование процесса.

В I гр. токсичность 1 степени отмечалась у 13 (68,4%), 2 степени - у 5 (26,3%) и 3 степени - у 1 (5,3%) больных. Аналогичные показатели во II гр. составили соответственно 4 (30,8%), 5 (38,5%) и 1 (7,7%). Статус всех больных соответствовал 1-2 баллам.

Таким образом, применение схемы ViCAP у больных рецидивными и рефрактерными формами НХЛ повышало частоту объективного ответа, причем без повышения токсичности и снижения качества жизни.

СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ (CD 34+) КЛЕТОК КРОВИ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ.

Гривцова Л.Ю., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр им. Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Цель. Характеристика субпопуляционного состава стволовых клеток крови здоровых доноров на основании иммунологического фенотипа CD34+ клеток

Материалы и методы. Оценено 63 образца клеток лейкоконцентрата (обогащенная фракция мобилизованных стволовых клеток периферической крови), полученных при

наборе кроветворной ткани для аллогенной трансплантации у 59 здоровых доноров. Подсчет стволовых CD34+ клеток проводили на основании ISHAGE-протокола в реакции двойной иммунофлуоресценции с использованием прямых конъюгатов моноклональных антител к антигену стволовых клеток CD34 и общелейкоцитарному антигену CD45. Оценку субпопуляционного состава CD34+ (экспрессия на стволовых CD34+ клетках антигенов, ассоциированных с различными этапами дифференцировки стволовых кроветворных клеток) проводили с использованием тройной флуоресцентной метки. В пределах гейта CD34+ определяли пропорцию ранних предшественников, на основании экспрессии линейно-неограниченных антигенов (HLA-DR, CD38), маркеров ранних этапов дифференцировки (CD117, CD71) и молекул клеточной адгезии (CD50, CD56), оценивалась пропорция клеток, экспрессирующих общелейкоцитарный антиген CD45, а также количество линейно-коммитированных стволовых кроветворных клеток: миелоидных (антигены CD13, CD33), лимфоидных (CD7, CD19) мегакариоцитарных (CD61), в 7 образцах проанализировано количество эритроидных предшественников по экспрессии антигена клеток красного ряда гликофорина А (CD236).

Результаты. Средний процент CD34+ клеток среди лейкоцитов составил $0,35 \pm 0,03\%$ (от 0,02 до 1,23%). Субпопуляционный состав стволовых клеток доноров был достаточно разнородным. Более 90% CD34+ клеток экспрессировали антигены CD50, HLA-DR, CD13. В среднем 70,0% стволовых клеток были позитивны в отношении антигенов CD117, CD33 и CD45. В отношении антигена CD38 стволовые клетки были достаточно гетерогенны, количество CD34+CD38+ клеток в образцах донорской кроветворной ткани варьировало от 22,2 до 97,6%. Количество стволовых клеток с экспрессией лимфоцитарных антигенов как пан-В (CD19) так и пан-Т (CD7), антигена NK-клеток, а также предшественников мегакариоцитов (CD61+ клетки) в среднем не превышало 10,0%. Для ряда популяций нами установлены достоверные корреляционные связи – число CD34+HLA-DR+ клеток было пропорционально количеству миелоидных предшественников и стволовых клеток, экспрессирующих CD71 ($p < 0,004$), и обратно пропорционально количеству Т-линейных предшественников ($p = 0,026$). Число В-линейных предшественников было достоверно взаимосвязано с количеством Thy-1+ стволовых клеток ($p = 0,03$); мало вероятным оказалось наличие клетки-предшественницы, полипотентной в отношении миелоидного ростка (CD34+ CD13+CD33+) и Т-лимфоидного звена кроветворения (CD34+CD7+), $R = 0,687$, $p = 0,0001$. В большинстве образцов (61 из 63) в пределах фракции CD34+ клеток выявлена пропорция CD45neg клеток. В 20,6% случаев негативная по экспрессии CD45 антигена популяция стволовых клеток превысила 50,0%. Число CD34+CD45- клеток достоверно коррелировало с количеством CD45-DR+CD34+ клеток ($p = 0,013$). 6,4% стволовых клеток имели фенотип CD45neg CD34+ HLA-DR-. Субпопуляция CD34+HLA-DR-CD38- клеток составила $4,3 \pm 1,9\%$ от суммарного пула CD34+ клеток. Корреляций между количеством CD38-DR- стволовых клеток и числом CD45-CD34+ клеток нами не получено.

Заключение. Таким образом, мы подтвердили гетерогенность субпопуляционного состава мобилизованных клеток периферической крови здоровых доноров, их неоднородность в отношении экспрессии CD45 антигена и возможность существования дискретных субпопуляций CD45neg стволовых CD34+ клеток, отличающихся по экспрессии молекул CD45, HLA-DR и CD38.

В-ЛИНЕЙНЫЕ ОСТРЫЕ ЛИМФОБЛАСТНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ У ДЕТЕЙ. ИММУНОДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ОСТАТОЧНОЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ.

Гривцова Л.Ю., Серебрякова И.Н.

Божьева М.Г., Попа А.В., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр им. Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Цель работы. Изучение особенностей иммунофенотипа острых лимфобластных лейкозов из В-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ) у детей и отработка методов мониторинга минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (ПЦ) на этапе терапии индукции (15 день) в данной группе пациентов для риск-стратификации.

Материалы и методы. В анализ включено 57 детей с впервые установленным диагнозом острого лейкоза. Средний возраст детей составил 5,5 лет (6 мес. - 18 лет). Детей младше года в группе было двое (6 и 9 мес). Иммунофенотип бластных клеток оценивали до начала лечения (день 0) с использованием 3-цветной ПЦ. Диагностическая панель включала моноклональные антитела к пан-Т-клеточным антигенам (CD3, CD7, CD4, CD5, CD8), антигенам В-клеток (CD19, CD22, CD20), миело-моноцитарным антигенам (CD33, CD64, CD13), антигенам, характеризующим пул клеток-предшественниц (CD34, TdT, CD10) и линейно не ограниченным молекулам (HLA-DR, CD38, CD56), оценивалась пропорция клеток красного ряда (gly A) и мегакариоцитов (CD61). Популяция бластных клеток при ПЦ идентифицировалась на основании экспрессии общелейкоцитарного антигена CD45. При установлении варианта ВП-ОЛЛ дополнительно оценивалась цитоплазматическая экспрессия IgM. В ряде спорных случаев (присутствие миелоидных антигенов на бластах) оценивалась цитоплазматическая экспрессия миелопероксидазы. Детекция клеток МОБ выполнялась на 15 день химиотерапии индукции с использованием 3-цветной ПЦ (протокол D. Самрапа панель – CD19/CD10/CD34), основанной на факте элиминации В-линейных предшественников в ответ на кортикостероиды и 4-хцветной ПЦ в рамках протокола ALL-BFM-2000, панель - syto19/CD10/CD45/CD19 и CD20/CD10/CD34/CD19. Параллельно с иммунологическим исследованием пунктатов костного мозга во всех случаях выполнялось морфологическое (день 15) или морфоцитохимическое (день 0) исследование.

Результаты. В большинстве случаев (94,7%) установлен "common" пре-пре-В иммуноподвариант ОЛЛ (CD19+CD10+cylgM-), только у 3 детей иммунофенотип бластов соответствовал про-В-клеткам (CD19+ CD10-cylgM-). В 75,4% случаев бластные клетки экспрессировали антиген стволовых клеток CD34, при этом все про-В варианты были CD34+. Частота выявления экспрессии антигена CD20 была низкой – 7%, тогда как более чем в трети образцов (38,5%) бласты коэкспрессировали пан-миелоидные антигены (CD13, CD33). На 15 день химиотерапии индукции адекватного ответа не получено у 11 из 57 (19,3%) пациентов (морфологически выявлено более 5,0% бластных клеток в костном мозге), данные ПЦ подтвердили присутствие выраженной пропорции В-линейных предшественников (CD19+CD10+CD34+) в данной группе больных. Среди пациентов с хорошим ответом (46 человек) по данным ПЦ остаточных бластов не выявлено в 6 образцах – $< 0,01\%$ CD19+CD10+ и/или CD19+CD34+. Низкий уровень МОБ ($0,01-0,1\%$ CD19+ мононуклеарных клеток с экспрессией CD10 или CD34) выявлен в 41,3% случаев, у 16 уровни МОБ были средними ($0,1-1,0\%$), и только в 10,8% образцов определялось более 1,0% клеток МОБ (высокий уровень).

Заключение. Адекватная детекция МОБ на начальных этапах лечения больных может быть проведена у большинства больных с ВП-ОЛЛ на основании 3-цветного цитометрического протокола. Использование данного подхода на этапе химиотерапии индукции (15-19 дни от начала лечения)

позволяет оценить клиренс лейкоэмических клеток и достоверно выявить группу пациентов с высоким риском развития рецидива, требующих более интенсивного лечения, и, что не менее важно, пациентов, у которых интенсивность последующей химиотерапии может быть редуцирована.

GR130 КАК МИШЕНЬ ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОНКОЛОГИИ

Костюкова М.Н., Тупицын Н.Н.

Российский онкологический научный центр имени Н.Н.

Блохина РАМН, Москва

Изучение нарушений гемопоэза и разработка новых подходов к терапии гемобластозов, а также тяжелых цитопенических состояний костного мозга показали в последнее время ключевую роль в регуляции этих процессов гликопротеина gr130 – трансдучера цитокиновых сигналов. Этот рецептор экспрессирован на всех типах человеческих клеток и является общей составной частью олигомерных рецепторных систем. Тканеспецифичность его действия обусловлена локализацией цитокинов и их первичных рецепторов. Одним из наиболее привлекательных направлений исследований в этой области является индуцируемая интерлейкином-6 (IL-6) активация gr130, описанная при различных заболеваниях, в том числе при В-клеточных опухолях (болезни Кастлемана, некоторых типах лимфом, хроническом лимфолейкозе и множественной миеломе), а также для опухолей крови, ассоциированных с вирусными инфекциями (HNV8). С этим направлением сигнальной трансдукции связан один из успешных примеров антицитокиновой терапии – широкое клиническое использование анти-IL-6 антитела В-Е8. Вместе с тем, модуляция действия цитокинов может быть достигнута с помощью моноклональных антител (МКА) не только к определенным эпитопам лигандов, но и самого рецептора gr130.

В настоящей работе рассмотрены структурно-функциональные и методологические предпосылки создания различных подходов к клинически значимому воздействию на функциональный ответ gr130. Показано в экспериментах на человеческих миеломных клеточных линиях, что ряд анти-gr130 моноклональных антител специфически ингибирует передачу сигнала IL-6 или IL-11, а также блокирует ответ острой фазы. Обратный эффект, связанный с МКА – это феномен бесцитокиневой активации рецептора с помощью специфических пар антител, который дает возможность культивирования стволовых гемопоэтических клеток *in vitro* и усиления гемо- и тромбопоэза *in vivo*. Предложен цитофлуориметрический метод решения ряда диагностических задач и мониторинга эффективности проводимой терапии, основанный на описании уровня активации gr130 на мембране клеток.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАСТОВ ПРИ ОЛЛ ВЗРОСЛЫХ.

Лебедева Н.Б., Купрышина Н.А., Колбацкая О.П.,

Гривцова Л.Ю., Жарова З.Д., Френкель М.А.

РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина, г. Москва.

Лейкемическая популяция при ОЛЛ характеризуется значительной гетерогенностью по морфоцитохимическим параметрам, иммунофенотипической характеристике, цитогенетическим и молекулярно-биологическим особенностям. Нам представилось интересным сопоставить данные иммунофенотипирования с морфологическими и цитохимическими показателями бластов для выявления возможных взаимосвязей между ними.

Было обследовано 80 первичных больных ОЛЛ в возрасте от 15 до 60 лет (47 мужчин и 33 женщины). При исследовании костного мозга проводился подсчет миелограммы, морфологическое и цитохимическое (на пероксидазу, липиды,

неспецифическую эстеразу и PAS-позитивное вещество) исследования бластов. Иммунофенотипирование бластов выполнялось методом проточной цитометрии на приборе FACScan (Becton Dickinson). Панель моноклональных антител (МКА) включала В и Т-линейные маркеры, стволовый клеточный антиген CD34, миелоидные маркеры (ММ) и ряд других МКА. Вариант про-В ОЛЛ (CD19+CD22cyt+) составили 17 (21,3%) больных. Из них у 4 (23,5%) определялась коэкспрессия ММ. Пре-пре-В (CD19+CD10+) вариант был констатирован в 45 (56,2%) случаях, из них в 22 (48,9%) с коэкспрессией ММ, в одном наблюдении иммунофенотип бластов был CD19+, CD10+, CD13+, Гликофорин А+. У 18 (22,5%) больных определялись бласты из Т-линейных предшественников. Из них в 8 случаях бластные клетки были CD34+, в 6 – ММ+. В 6 случаях кортикотимокитарного Т-варианта (CD1a+) экспрессия CD34 и ММ отсутствовала. Сравнение морфологических параметров бластов (частота микроформ, соотношение округлых и складчатых ядер клеток), цитохимических показателей у больных с разными иммунологическими вариантами не выявило достоверных различий. В 3 случаях, позитивных на ММ (2 про-В и 1 пре-Т), были обнаружены липиды в лимфобластах. Реакция с МКА к пероксидазе в этих наблюдениях была негативна. Наши данные свидетельствуют об отсутствии взаимозависимости между морфологическими и иммунофенотипическим показателями бластов, а также о высокой частоте aberrантного иммунофенотипа лейкоэмических лимфобластов независимо от варианта заболевания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ БОРТЕЗОМИБА, ДОКСОРУБИЦИНА, ДЕКСАМЕТАЗОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ

Габбасова С.Т., Каракулов Р.К., Султангазиева С.Е.,

Ниембаева О.В., Сагиндыков Г.А.,

Насипов Б.А., Косенко Н.Ю.

КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г. Алматы

В течение последних 5-ти лет велкейд (бортезомиб) достаточно активно используется в лечении миеломной болезни. (ММ) Препарат проявил высокую активность в продвинутых стадиях ММ. Как показали результаты исследования, в течение 3-6 месяцев после окончания курса лечения у 30 % пациентов регистрируются рецидивы заболевания, связанные с возникновением рефрактерности к стандартным схемам ПХТ. Как известно, уже исходно часть опухолевых клеток может быть резистентна к целому ряду цитостатических средств, т.е. больные (ММ) могут быть первично резистентными. (по данным Р.М. Рамазановой, Р.К. Каракулова, С.Е. Султангазиевой, Н.Ж. Шалбаевой.).

С целью преодоления рефрактерности, нами впервые была применена (ММ) комбинация PAD (бортезомиб 1.3 мг/м² в/в, доксорубин 9 мг/м² в/в, дексаметазон 40 мг внутрь). ПХТ получили 5 пациентов. Все они ранее получили стандартные режимы химиотерапии: велкейд в сочетании с дексаметазоном, велкейд в сочетании с циклофосфаном и преднизолоном, велкейд в сочетании с мелфолоном и дексаметазоном, но положительный эффект не был достигнут, заболевание продолжало прогрессировать. У них установлены III А и IIIБ стадии, со всеми проявлениями, характерными для этих стадий заболевания. Пациенты получили от 2-х до 4-х 21 дневных циклов PAD. В результате лечения у 2-х частичная ремиссия, у 3-х стабилизация процесса. Прогрессирование заболевания не отмечено. Со стороны красной крови уровень гемоглобина вырос от 85 до 115 г/л. Тромбоцитопения стала менее выраженной, количество тромбоцитов в наблюдаемой группе выросло в среднем на 20-30тыс. Уровень общего белка у 3-х пациентов приблизился к норме, проявления ГВС(гипервискозного синдрома) значительно

уменьшились. Хроническая почечная недостаточность не нарастала, причем уровень креатинина у некоторых пациентов удалось снизить до 183 мкмоль/л. В среднем из 5-ти пациентов на фоне проводимого курса не отмечено тяжелых побочных эффектов (3-4 степени токсичности). Основными побочными реакциями были: слабость, утомляемость (1 и 2 степень по классификации ВОЗ, тошнота умеренной степени выраженности, у 2-х больных отмечено однократное повышение температуры тела от 37.5 С до 38.5 С, у одного пациента на выбранном курсе появилась сыпь на коже. В течение 10 дневного перерыва все проявления побочных реакции удавалось купировать, что позволяло продолжать курсы специфической терапии. Нужно отметить, что у одного из пациентов сопутствующим заболеванием является хронический гепатит «В» с признаками активности (АЛТ превышало норму в 2 раза, АСТ в 3 раза). Пациент получил 2 цикла комбинации PAD, на фоне лечения показатели трансаминаз не росли, а в динамике даже снизились, диспепсические явления купировались. Исходя из вышеизложенного нами сделан предварительный вывод, что комбинация PAD может быть успешно использована в терапии больных ММ с явлениями рецидива и рефрактерности, нарушением функции почек, печени, явлениями выраженной тромбоцитопении и анемии. При сравнении с другими режимами включающими велкейд отмечен более отчетливый синергичный антимиеломный эффект при сочетании бортезомиба с антрациклиновыми антибиотиками.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕСНА ШТАДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛИМФОМАМИ И САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КАЗНИИОИР

Габбасова С.Т., Султангазиева С.Е., Сагиндыков Г.А., Асанов А.А., Насипов Б.А., Жумадуллаев Б.М., Каракулов Р.К.

КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы

Месна – препарат, снижающий токсичность цитостатической терапии.

Данный препарат почти полностью выводится через почки, и незначительное количество выводится с желчью. Почечная элиминация препарата начинается сразу же после приема препарата и через 8 часов препарат полностью выводится из организма. В течение первых 4-х часов после приема препарата он выводится в виде SH-месны, а затем – в виде дисульфида (димесна). Снижение уротоксического эффекта происходит за счет накопления в мочевом пузыре SH-месны, составляющей 30% от введенной внутривенно дозы препарата.

Механизм действия уропротектора месна основан на стабилизации уротоксичных гидроксиметаболитов циклофосфамидов, с одной стороны, и образовании нетоксичных компонентов с акролеином, с другой стороны. За счет этого достигается местная детоксикация в почках и нижерасположенных отделах мочевыводящего тракта по данным Burkert H, Schnitker H, Fichtner E 1979.

Показаниями к применению являются: профилактика токсического воздействия циклофосфамида на мочевыводящий тракт при введении противоопухолевой терапии цитостатиками.

Нами была проведена апробация 15 пациентам с лимфомами (12), с острыми лейкозами (3) в отделении гемобластозов и 10 пациентам с саркомами мягких тканей в отделении детской онкологии. Месна вводилась внутривенно во время введения циклофосфамида, через 4 часа и через 8 часов из расчета препарата – 20% от дозы циклофосфамида. У детей препарат вводился более 6 раз, при более коротких интервалах, через 3 часа общая доза составляет 60% от дозы

циклофосфамида. Побочных эффектов не наблюдалось.

По данным наших наблюдений можно сделать следующие выводы:

- препарат хорошо переносится, может широко использоваться в схемах ПХТ с применением высоких доз циклофосфамида;
- выраженных побочных эффектов не отмечено ни у взрослых ни у детей;
- в результате применения препарата Месна удалось избежать серьезных осложнений со стороны мочевыделительной системы;
- у всех пациентов сохранились удовлетворительные показатели анализов мочи;
- ни у одного из пациентов не было явлений геморрагического цистита, макро- и микрогематурии;
- выделительная функция почек сохранена полностью.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

*Чернявская Т.З., Абдусаламов С.Н., Гривцова Л.Ю., Мелкова К.Н., Тупицын Н.Н., Чимишкян К.Л.
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва*

Выбор источника гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) для проведения конкретной трансплантации зависит от характера основного заболевания и его стадии, клинического протокола, наличия противопоказаний к получению того или иного источника, массы тела донора и реципиента. Настоящее исследование было начато с целью разработки тактики получения достаточного количества качественного гемопоэтического материала для проведения аллогенных трансплантаций (аллоТКМ) в группе пациентов с факторами развития реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и, соответственно, минимизации рисков ее развития.

За период с августа 2006 года по июль 2010 г в отделении трансплантации костного мозга (ТКМ) РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН было выполнено 14 эксфузий костного мозга (КМ) у здоровых доноров (8 жен, 6 муж) в возрасте от 15 до 69 лет (медиана 29), в том числе в 12 случаях проводилась эксфузия КМ, стимулированного Г-КСФ (в дозе 10 мкг/кг/сут.). Эксфузия выполнялась у КМ для проведения аллогенной родственной ТКМ пациентам с факторами высокого риска развития РТПХ.

Неудач эксфузии не было, собрано ядросодержащих клеток (ЯСК) 4,67 x108/кг м.т. (разброс от 1,93 до 16,85), CD34+клеток 2,09 x106/кг (0,27-4), CD3+ 3,03 x107/кг (0,59-4,6), КОЕ-ГМ 9,8x104/кг (3,9-57,3). Во всех 14 случаях были выполнены аллоТКМ пациентам (4 жен и 10 муж) в возрасте от 17 до 53 лет (медиана 25,5 лет). Большинство аллоТКМ (13 чел, 93%) выполнялись по поводу лейкозов после миелоаблативного кондиционирования (Бусульфан/Циклофосфан 8, режимы, содержащие тотальное терапевтическое облучение 6), 3 из которых – в прогрессировании, и 1 аллоТКМ с немиелоаблативной подготовкой проведена больной с множественной миеломой (ММ). Восстановление уровня нейтрофилов свыше 500 кл/мкл наблюдалось к Д+18 (Д+14–Д+35), а уровня тромбоцитов свыше 50 тыс/мкл к Д+18 (Д+16–Д+46). 100-дневная посттрансплантационная летальность составила 7,1%, причиной смерти пациентки с ММ явилась тяжелая острая РТПХ IV ст, рефрактерная к стероидам. У 10 пациентов с лейкозами вне прогрессирования ни в одном случае РТПХ не была фатальной. Острая РТПХ III-IV ст. развилась в 2 случаях (20%), экстенсивная хроническая РТПХ наблюдалась у 4 больных (40%). Восстановление уровня CD4+Т-лимфоцитов свыше 100 кл/мкл к Д+200 наблюдалось в 60% случаев и коррелировало с тяжестью РТПХ и частотой инфекционных эпизодов. Безрецидивная выживаемость на

2 года составила 64%.

Таким образом, при проведении аллоТКМ использование КМ, содержащего значительно меньшее количество Т-лимфоцитов по сравнению с СКПК, приводит к снижению рисков развития рефрактерной тяжелой РТПХ.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

*Чернявская Т.З., Абдусаламов С.Н., Гривцова Л.Ю.,
Мелкова К.Н., Тупицын Н.Н., Чимишкян К.Л.
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва*

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) позволяет относительно безопасно увеличивать интенсивность химиотерапии. Однако, ряд факторов ограничивает ее широкое применение, один из которых – невозможность получения достаточного количества качественного гемопоэтического материала для трансплантации. Исходные неудачи сборов стволовых клеток периферической крови (СКПК) могут составлять 5-30%. Кроме того, при некоторых нозологиях (например, ОМЛ), использование СКПК повышает риск рецидива основного заболевания. Настоящее исследование было начато с целью разработки тактики получения адекватного количества ГСК в различных группах больных и, соответственно, возможности выполнения трансплантации при ее необходимости, а также минимизировать риски функциональной недостаточности трансплантата и сократить фатальные, прежде всего инфекционно-геморрагические, осложнения трансплантации.

За период с августа 2006 года по июль 2010 г в отделении трансплантации костного мозга (ТКМ) РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН было выполнено 66 эксфузий аутологичного костного мозга (аутоКМ) у 66 человек (32 жен, 34 муж) в возрасте от 16 до 67 лет (медиана 28) (ЛХ 49, ОЛ 9, НХЛ 6, солидные опухоли 2). В том числе в 54 случаях проводилась эксфузия КМ, стимулированного Г-КСФ 10-24 мкг/кг/сут (стКМ). Достаточным для выполнения ТКМ считалось количество ЯСК в полученном материале 1 x108/кг и выше. Было получено ЯСК от 0,47 до 6,77 x108/кг (медиана 2,7), 2 эксфузата содержали менее 1 x108/кг ЯСК и были расценены как неудачные. Со-

держание в трансплантате CD34+клеток 1,9 x106/кг (0,4-6,5), КОЕ-ГМ 7,2x104/кг (4,8-13,2). Показанием для заготовки аутоКМ являлось: необходимость заготовки ГСК для проведения 2 курсов ВХТ при лимфомах (31 чел.), предшествующая неудача сбора СКПК (14 чел.), высокая вероятность неудачи сбора СКПК при рефрактерной ЛХ (11 чел.), необходимость консолидации 1-ой ремиссии ОЛ (10 чел.). Всего этой группе было выполнено 48 трансплантаций КМ. Для сравнения течения посттрансплантационного периода в группе ТКМ и трансплантаций СКПК был применен парный метод. В каждую группу было включено по 13 трансплантаций у пациентов с рефрактерной ЛХ. В группе СКПК было трансплантировано CD34+ от 2 до 3,71 x106/кг (медиана 3), восстановление уровня нейтрофилов свыше 500 кл/мкл произошло к Д+11 (разброс 9-15), а тромбоцитов свыше 50 тыс/мкл к Д+12 (дни 10-19). В группе КМ было трансплантировано ЯСК от 2,17 до 4,3 x108/кг (медиана 2,48), отмечено более позднее восстановление как нейтрофилов - к Д+20 (разброс 12-33), так и тромбоцитов - к Д+26 (дни 13-37). Соответственно, была выше потребность в заместительных гемотранфузиях тромбоцитов (медиана 4 дозы, разброс 1-14, против 2, разброс 0-4) и эритроцитов (медиана 5 доз, разброс 1-8, против 2, разброс 0-5). Не было выявлено корреляции между восстановлением уровня CD4+лимфоцитов в периферической крови и инфекционными осложнениями в посттрансплантационном периоде. Частота инфекционных и жизнеугрожающих осложнений существенно не отличалась. Посттрансплантационной летальности в обеих группах не наблюдалось. Для консолидации 1 ремиссии ОЛ нами было проведено 5 аутоТКМ с миелоаблативным режимом кондиционирования (1 жен и 4 муж в возрасте от 20 до 42 лет, медиана 24 года). Для аутоТКМ было использовано ЯСК от 1,38 до 2,68 x108/кг (медиана 2,37). Восстановление нейтрофилов - к Д+32 (Д+18-Д+46), тромбоцитов - к Д+100 (Д+24-Д+150). Посттрансплантационной летальности не наблюдалось. Безрецидивная выживаемость на 2 года - 48%.

Таким образом, можно отметить, что аутоКМ в качестве источника ГСК является приемлемой альтернативой СКПК для пациентов с неудачей сбора СКПК, при ОЛ и при проведении повторных аутоТКМ. Использование стКМ по сравнению с трансплантацией СКПК не сопровождается повышением смертности и серьезных посттрансплантационных осложнений.

Разное

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Абдрахманова Л.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: ежегодно в отделении общей онкологии получают специализированную помощь свыше 1000 пациентов. Выполняется более 850 операций. Объем медицинской помощи возрастает с каждым годом, поэтому необходимо улучшить условия пребывания больных в стационаре, уменьшить число осложнений, поднять престиж и профессионализм медицинских сестер. Этому

Цели работы: проанализировать влияние соблюдения принципов этики и деонтологии медицинской сестры хирургического отделения в процессе выздоровления больных.

Материалы и методы: отчет отделения за 2009 год, материалы семинаров по этике и деонтологии, проводимых в отделении.

Функции медицинских сестер значительно шире, чем простое выполнение указаний врача. Это: выполнение медицинскими сестрами своих обязанностей по оказанию помощи пациентам, составление плана действия по уходу, оценка своей работы. Для медицинской сестры онкологического учреждения прежде всего важна культура общения, личные, духовные и эстетические качества, образованность, высокий профессионализм, коммуникабельность, умение вовремя оказать психологическую поддержку, высокая степень нравственного долга перед больным человеком. Все мероприятия по улучшению качества жизни онкологических пациентов основаны на доверии между врачом, медицинской сестрой и пациентом. Они требуют длительного и кропотливого участия медицинской сестры не только в обеспечении необходимой лечебной помощи, но и в процессе организации социальной и психологической поддержки и его реабилитации. Основным методом лечения онкологических больных – хирургический. За 2009г. в отделении общей онкологии было выполнено 850 операций. Из них: 193 на органах пищеварительной системы, 275 на молочных железах, 185 на женских половых органах, на кишечнике 85. Радикальные операции травматичны сами по себе и часто приводят к инвалидности и психосоматическим нарушениям. Существуют также и паллиативные методы лечения. Из проводимых в отделении операций наиболее травматичной считается наложение колостомы больным с заболеваниями толстого отдела кишечника. Таких операций в год проводится в среднем около 30. Многим больным необходима психологическая поддержка до операции, поскольку психология стресса очень сильно влияет на соматическую сферу человека. Медсестре необходимо выявить типологию пациента и адекватно взаимодействовать с ним. За время нахождения в стационаре медсестра должна научить больного правильному уходу за колостомой, помочь в выборе диеты. Пациента могут напугать обильные, нерегулярные выделения с неприятным запахом, раздражение ткани вокруг колостомы. Задачами медицинского персонала являются восстановление жизненно-важных функций организма, обеспечение заживления послеоперационной раны, предупреждение осложнений. Чуткое отношение, внимание со стороны медицинской сестры помогает в процессе выздоровления пациента. Медицинская сестра, выполняя процедуру, может повлиять на пациента своим настроением, взглядом, интонацией. Медсестра может поддержать, утешить, успокоить больного. Иногда это намного важнее, чем сама процедура. Надежная бригада, состоящая из врача, медицинской сестры и самого пациента, должна

быть постоянной опорой в его борьбе с недугом.

Результаты и выводы: онкологические больные требуют от среднего медицинского персонала не только высоких профессиональных навыков, но и особого внимания, чуткости, душевного подхода к его проблемам. Медицинская сестра не должна противоречить информации, которую врач всячески помогать пациенту в адаптации и правильного восприятия заболевания. Знание основ психологии должно быть приоритетом современной медсестры.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Абугалиева Г.С.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность работы: Павлодарская область в течение 3-х последних лет занимает первое ранговое место в РК по уровню онкологической заболеваемости и смертности. Обеспеченность онкологическими койками составляет 2,3 на 10.000 населения (в РК – 2,2 на 10,000 населения). С учетом уровня заболеваемости данное количество коек недостаточно. Предельные объемы госпитализации в рамках Государственного заказа в течение 3-х последних лет составляют 4000 больных в год. В этих условиях особенно важным является оптимизация стационарозамещающей помощи, позволяющей рационально использовать финансовые ресурсы. Специализированную онкологическую помощь населению Павлодарского Прииртышья оказывает областной онкологический диспансер с мощностью стационара – 170 коек, поликлиники на 50 посещений в смену, 12 районных онкологических кабинетов и 33 смотровых кабинетов в городах и районах области.

Цель работы: Изучение состояния стационарозамещающей помощи в ПООД с 2007 по 2009 г.г.

Материалы и методы: Материалом для данной работы явились статистические карты прошедшего лечения в дневном стационаре и стационаре на дому – Ф 066-4/у, счета-реестры.

В Павлодарском областном онкологическом диспансере с 28.05.1999 года приказом ДЗО № 195-пр. организован дневной стационар на 30 коек, из которых 20 радиологических коек и 10 коек при диспансерном отделении, предназначенных, в основном, для проведения амбулаторных оперативных вмешательств, химиотерапии и медицинской реабилитации онкологических больных.

Количество пролеченных больных в дневном стационаре диспансерного отделения и в стационаре дневного пребывания больных при радиологическом отделении за 2007 – 2009 г.

Вид стационара и лечения	2007	2008	2009
Дневной стационар при диспансерном отделении	1223	1287	1468
Стационар дневного пребывания при радиологическом отделении	301	337	398

Динамика финансовых показателей по дневному стационару за 2007 – 2009 г.г.

Показатели	Годы		
	2007	2008	2009

Заработано средств по счетам-реестрам	20860200 т.	22644000 т.	28857400 т.
Тариф за пролеч. больного	11700 т.	12580 т.	14.00 т.

Результаты и выводы: Ежегодно увеличивается общее число больных, получивших стационарозамещающую помощь. Ежегодно увеличивается финансирование стационарозамещающей помощи, увеличиваются средства для проведения специального лечения за счёт применения современных, дорогостоящих, эффективных химиопрепаратов. Эффективно используются современные аппараты для проведения лучевой терапии.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Альгожин Т.Б.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: Всевозрастающий интерес к проблемам маммологии вызван ростом заболеваемости раком молочной железы, высокими показателями запоздалой диагностики, смертности и однодневной летальности в наиболее развитых странах.

Цель работы: разработать оптимальный алгоритм оказания маммологической помощи женщинам Павлодарской области.

Материалы и методы: опыт оказания маммологической помощи за 2007 – 2009 годы в области.

В Республике Казахстан ежегодно регистрируется около 3000 женщин с раком молочной железы, в Павлодарской области - более 250. Намечилась тенденция к лидирующему положению РМЖ в структуре онкологической заболеваемости. Этот факт диктует необходимость поиска новых методов ранней диагностики патологии молочной железы, совершенствованию уже существующих, улучшению методов управления лечебно-диагностическим процессом, повышению качества диспансеризации женщин с неонкологической патологией молочной железы, как наиболее вероятного контингента по риску возникновения РМЖ в течение предстоящей жизни.

Основными принципами улучшения качества маммологической помощи являются:

1. Доврачебная помощь: должно быть обеспечена доступность маммологической помощи, максимальная приближенность её к населению. Эта задача обеспечивается акушерками смотровых кабинетов ЛПО ПМСП, фельдшерами. Основными формами работы на этом этапе являются профилактические осмотры женщин, анкетирование женщин с формированием групп повышенного риска и передачи информации на следующий уровень. Обеспечение преемственности в работе должно контролироваться врачом-гинекологом ЦРБ и районкологом. На этом этапе важнейшим компонентом профилактической работы являются подворовые обходы с осмотром неорганизованного населения, особенно старших возрастных групп.

2. Первая врачебная помощь: осуществляется гинекологом, хирургом ЦРБ и городских ЛПО. Всем пациенткам в возрасте после 30 лет, впервые обратившимся в текущем году в лечебно-профилактические учреждения, а также госпитализированным в стационары, в обязательном порядке должны быть осмотрены молочные железы. Женщины с выявленными узловыми образованиями в молочных железах, должны быть направлены на консультацию к маммологу онкодиспансера.

3. Специализированная помощь: оказывается маммологами областного диспансера. Наличие в диспансере маммогра-

фической установки, УЗ аппаратов с большой разрешающей способностью, функционирующие патоморфологическая и цитологическая лаборатории, иммуногистохимическая лаборатория позволят произвести дифференциальный диагноз, назначить лечение фоновых заболеваний и при выявлении рака молочной железы своевременно взять больную на учёт.

4. Высококвалифицированная помощь: оказывается специалистами Казахского НИИ онкологии и радиологии с применением высокотехнологичных эффективных современных методов лечения в соответствии с международными стандартами на основе последних научных разработок.

5. Информационное обеспечение: обеспечивается санитарно-просветительской работой в СМИ. Из нашего опыта эффективным методом пропаганды является проведение декадников, дней открытых дверей, организация широкомасштабных акций.

Результаты и выводы: Улучшение состояния маммологической помощи женскому населению может быть достигнуто применением комплекса организационных, лечебно-профилактических мероприятий на всех этапах медицинской помощи.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Дробкова О.М.

КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар

Актуальность: залог успешной и слаженной работы всего отделения - это слаженно работающий коллектив, уважительное отношение коллег между друг другом, а также с пациентами, и огромная роль в этом отводится именно медицинским сестрам.

В настоящее время в торакальном отделении ПООД оказывают плановую специализированную медицинскую помощь при заболеваниях легких, пищевода, желудка, опухолях средостения и шеи, заболевания мягких тканей грудной клетки, специфичность нашего отделения еще и в том, что оказывается экстренная помощь при ранениях и травмах грудной клетки и средостения, легочных кровотечениях. Ежегодно в торакальном отделении получают специализированную помощь свыше 900 пациентов. Выполняется более 300 операций.

Цель исследования: проанализировать принципы работы медицинской сестры в условиях хирургического отделения.

Материалы и методы: алгоритмы работы среднего медицинского персонала, протоколы оказания экстренной помощи.

В отделении работают 90% медицинских сестер с первой и высшей категорией. Высокий уровень их квалификации является неотъемлемой частью качественной работы отделения. Выполнение назначений врачей, перевязок, контроль за температурой, артериальным давлением пациентов, контроль за положением дренажей в плевральной и брюшной полостях, а также отделяемых по ним жидкостям, контроль за основными физиологическими показателями и функций жизненно важных органов, проведение комплекса профилактических мероприятий для улучшения дыхательной функции и для предупреждения осложнений, обезболивание пациентов это лишь часть обязанностей которые выполняют медицинские сестры в торакальном отделении. Особенности в работе медицинской сестры в хирургическом отделении заключается в умении работать со сложным медицинским оборудованием, ассистировать врачу при постановке дренажей, санационной и диагностической фибробронхоскопии, проведении гемотрансфузий, умение правильно подготовить больного и собрать анализы. Данные манипуляции требуют высочайшего уровня подготовки среднего медицинского персонала работающего в торакальном отделении. Одним

из важнейших качеств медицинской сестры любого уровня является сострадание пациенту, ответственный и профессиональный подход к своей работе. Для улучшения качества лечения необходимо внимательное и чуткое отношение к проблемам больного, что особенно актуально в условиях единой системы здравоохранения. Необходимо постоянно повышать специальные знания медицинских сестер. Это достигается путем проведения регулярных семинаров для среднего персонала отделения по вопросам этики и деонтологии, техники процедур, специальным навыкам и знаниям по смежным специальностям. На базе Павлодарского медицинского колледжа проводится постдипломное обучение по терапевтическому и хирургическому профилю. Немало важную роль играют ежегодное проведение конкурсов на лучшую медицинскую сестру, проводимые в условиях диспансера и участие победителей в областных олимпиадах. В недалеком будущем квалификация медицинского работника, его профессионализм будут напрямую влиять на его уровень заработной платы. Приказ МЗ РК № 249 от 12.04.2010г. «Об утверждении правил оплаты труда медицинских работников» предусматривает возможность стимулирующей доплаты к заработной плате медицинских работников. Поскольку сестринское дело является центральной частью индустрии охраны здоровья, в настоящее время резко изменяется отношение общества к медицинским сестрам, престиж нашей профессии растет.

Результаты и выводы: Выполнение сложнейших операций дает пациенту 50% шансов на благополучный исход, остальные 50% зависят от послеоперационного ухода, большая часть которого ложится на плечи медицинской сестры.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ

Исламов З.С.

*Республиканский онкологический научный центр,
Узбекистан, Ташкент.*

Ретинобластома злокачественная внутриглазная опухоль, развивающаяся из сетчатки, встречается в основном у детей дошкольного возраста. Как отмечает Бровкина А.Ф. (2002), в последнее время она имеет тенденция к взрослению, то есть у детей более старшего возраста. Опухоль, на разных стадиях маскируется под многие заболевания глаза у детей.

Целью нашей работы явилось анализ больных с ретинобластомой поступивших на стационарное лечение в онкоофтальмологическое отделение.

Материал и методы. Нами анализированы истории болезни и амбулаторные карточки 355 детей госпитализированных в онкоофтальмологическое отделение РОНЦ МЗ РУз с 2001 по 2010 гг. на стационарное обследование и лечение с диагнозом ретинобластома. Все больные обследованы: методом бокового освещения, офтальмоскопии, биомикроскопии, УЗИ и Допплерографии, КТ.

Результаты. В результате обследования из 355 больных у 44 диагноз ретинобластома не подтвердился. Им установлены следующие диагнозы и направлены детским офтальмологам: Ретинит Коатса, Ретрогенальная фиброплазия, Фиброз стекловидного тела, Увеит, Эндофтальмит, Хориоретинальная дегенерация сетчатки, Отслойка сетчатки, Колобома сосудистой оболочки, Вторичная глаукома.

Из 311 больных с ретинобластомой 53,8% составляли мальчики и 46,2% девочки. Возраст больных колебался от 1 месяца до 11 лет. Больных до 1 года было 19,7%, от 1 до 3 лет — 60%. Основная масса больных - 94,1% обратившихся к нам с диагнозом ретинобластома были в возрасте до 6 лет. После 6 лет до 11 лет количество больных резко уменьшается (5,8%). Больных с односторонней ретинобластомой было 77,4%, двусторонней 22,5%. У 17,5% была обнаружена ретинобластома в стадии T1N0M0. В 51% была

диагностирована стадия T2N0M0. В 20,4% случаях обнаружена стадия T3 и в 9% случаях была стадия T4. Опухоль в стадии T1 в основном была выявлена в парных глазах у больных с двусторонней ретинобластомой (60 глаз), только у 2 больных стадия T1 была выявлена в одностороннем процессе первично.

Время прошедшее, когда родители заметили первые признаки ретинобластомы до начала обследования и адекватного лечения, варьировала от 1 недели до 5 лет. У 4 больных (1,4%) признаки ретинобластомы - свечение зрачка заметили сразу после рождения, но обратились к онкоофтальмологу через 2, 6, 9 и 10 месяцев, соответственно. Лишь только в трёх случаях (1%) больных привели к онкоофтальмологу через неделю после проявления первых симптомов болезни. У 138 больных (48%) от обнаружения симптомов до поступления в стационар прошло от 1 до 6 месяцев. У 108 больных (37%) до поступления в стационар ушло 6 месяцев и более. У 30 больных (10,4%) от начала заболевания до поступления в стационар прошел 1 год и более. У 3 больных (1%) до обращения к онкоофтальмологу прошло 3 года, у одного больного (0,3%) от появления первых симптомов до получения адекватного лечения прошло 5 лет. Большинство больных обратившихся с запущенными формами были развитых стадиях опухолевого процесса, и в возрасте 5 лет и старше. В этих стадиях клиническая картина ретинобластомы может быть разнообразной, похожей на другие заболевания глаза, с их симптоматикой. Всё это время эти больные получали неадекватное лечение от других болезней, или же просто не обращались к врачам, и лечились у знахарей.

Выводы. Возникновение ретинобластомы у детей более старшего возраста, с клинической картиной других заболеваний глаза и отсутствие онкологической настороженности могут привести к диагностическим ошибкам и запущенным случаям.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Каримова Г.А.

*КГКП «Областной онкологический диспансер», г.
Павлодар*

Актуальность работы: В лечении больных злокачественными опухолями нельзя ограничиваться только облучением опухоли. Необходимо мобилизовать все средства для лечения самого больного, используя при этом современный арсенал лечебных мероприятий. Важным критерием эффективности лучевой терапии является также предупреждение развития лучевых реакций и повреждений здоровых тканей. В ведении больных, получающих лучевую терапию, можно выделить 3 периода: предлучевой, лучевой и послелучевой. На всех этих этапах большую роль играет высококвалифицированная работа медицинской сестры радиологического отделения.

Цель работы:

1. Определить особенности введения больных со злокачественными новообразованиями получающих лучевую терапию.

2. Разработать алгоритмы работы среднего мед. персонала в отделении радиологии.

Материалы и методы: статистические отчёты, карты лучевой терапии.

В 2009 году в отделении радиологии пролечено 949 больных, в условиях дневного стационара - 398. В отделении функционируют 4 аппарата для проведения лучевой терапии. На аппарате дистанционной гамматерапии «Агат С» закончили лечение 429 пациентов, на аппарате дистанционной гамматерапии «РОКУС АМ» пролечено 373 человека, на аппарате для внутримолостной лучевой терапии «Multisource» пролечено 86 больных, на аппарате близкофокусной рентгенотерапии «Gualmei» - 250 больных.

Для улучшения работы среднего медицинского персонала в работе с пациентами определены алгоритмы.

Предлучевой период. В этот период обычно проводят дополнительные исследования с целью уточнения локализации опухоли, а также подготовка больного к лучевой терапии. Предлучевая подготовка продолжается 1-2 дня. За указанное время больной адаптируется к условиям клиники (организация режима, питания). Персонал отделения проводит индивидуальные беседы с каждым пациентом о сущности лучевой терапии и возможностях снижения и предупреждения лучевых реакции.

Лучевой период. Это время прохождения самого курса облучения. При близкофокусной рентгенотерапии он занимает 2 – 3 нед., при дистанционной гамма-терапии – 4 – 8 нед.

Предупреждение общей лучевой реакции включает назначение полноценного питания, витаминотерапии.

Для предупреждения местных лучевых реакций и повреждений кожу обычно обрабатывают растительными и животными маслами, начиная с 8-10 дня.

Больным, страдающим сердечно – сосудистым заболеванием, необходимо назначить сосудорасширяющие и кардиотропные средства.

При проведении лучевой терапии больным с опухолями полости рта ежедневно назначают полоскание рта с раствором натрия гидрокарбоната.

Для профилактики повреждений слизистой оболочки верхних дыхательных путей проводятся ингаляции с персиковым маслом. Для профилактики повреждений слизистой оболочки рта, пищевода, гортани рекомендуется 10-15 гр. сливочного масла 2-3 раза в день держать во рту. При проведении лучевой терапии по поводу рака прямой кишки или шейки матки для уменьшения механического раздражения слизистой оболочки прямой кишки необходимо с первых дней лечения систематически проводить предупреждение запоров.

Результаты и выводы: таким образом, использование разработанного алгоритма работы среднего медперсонала в отделении радиологии позволяет избежать осложнений лучевой терапии.

СЛУЧАЙ АЛЬВЕОКОККА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ, ИМИТИРУЮЩИЙ ОПУХОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ

*Кравчук В.А., Гимадиева Г.М., Боромбаев И.У.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», Центральная больница учреждения АП 162/2, г. Павлодар*

Актуальность: появление объемного процесса в области шеи обычно вызывает серьезные опасения у больного и лечащего врача. В этом случае больные или члены их семьи почти всегда думают о злокачественном процессе, но на самом деле он является только частью широкого спектра патологии, которую должен дифференцировать врач. Для того чтобы оценить все возможные варианты диагноза, обследование следует проводить последовательно и систематично. Нужно рассматривать как нормальные анатомические варианты, так и инфекционные заболевания, врожденные аномалии, доброкачественные и злокачественные опухоли. Дифференциальная диагностика объемных образований в области шеи очень важна, так как существенно влияет на выбор наиболее эффективного метода лечения. Диагностическая и лечебная тактика у больных с объемными образованиями в области шеи зависит от возраста больного, локализации образования и анамнеза заболевания. Альвеококкоз (синоним: альвеолярный эхинококкоз, многокамерный эхинококкоз) — гельминтоз с преимущественным поражением печени. Альвеококк имеет определенное географическое распространение. Встречается в Сибири, Якутии, Казахстане, Башкирии, Татарии, Киргизии.

Цель работы: Показать необычный случай имитирующий опухолевую патологию шеи.

Материалы и методы исследования: История болезни пациента Г.

Пациент Г., 27 лет поступил в ЦБ АП 162/2 с жалобами на слабость, субфебрильную температуру, наличие объемного малоподвижного образования на шее справа. Образование отмечает в течение 3 лет, постепенно увеличивалось, неоднократно обследовался по месту содержания направлен в хирургическое отделение для оперативного лечения с диагнозом ЛГМ с поражением шейных лимфоузлов справа. В условиях ЦБ АП 162/2 проведено обследование: рентгенография ОГК, УЗИ ОБП, консультация терапевта, клинические анализы – патологии не выявлено. Пункция образования не проводилась из-за расположения под сосудисто-нервным пучком шеи. Пациенту планировалась операция типа Крайля справа. При проведении операции 07.08.10. При мобилизации образования установлен переход его на верхнее средостение, при выделении выявлена фиброзная капсула, опухолевый характер поражения вызвал сомнения, образование в пределах здоровых тканей удалено, на разрезе заполнено множественными «кистами» (альвеококк). Остаточная полость обработана формалином 10%, установлен дренаж. Дренаж удален на третьи сутки. Гистологическое заключение № 43121 от 16.08.10. - Альвеококкоз мягких тканей. Послеоперационный период протекал гладко, швы сняты на 10-е сутки.

Результаты и выводы: при сомнительной клинической картине диагностическая операция с гистологическим исследованием имеет решающее значение для постановки диагноза. В данном случае имело место атипичное течение альвеококкоза (отсутствует поражение легких и печени, нет четкой связи со стенкой пищевода).

АНАЛИЗ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ IV СТАДИИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Кравчук В.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: рак легкого в течение многих лет занимает первое место структуре онкологической заболеваемости, уровень IV стадии при раке легкого обуславливает высокие показатели запущенности в большинстве регионов.

Цель работы: анализ и изучение причин установления IV стадии при раке легкого.

Материалы и методы исследования: амбулаторные карты пациентов с установленной IV стадией рака легкого.

Проведен анализ амбулаторных карт за последние 3 года пациентов, которым была установлена IV стадия рака легкого. За 3 года было 276 пациентов.

Работающие составили только 10%, остальные либо пенсионеры, либо не работающие. При анализе возрастных показателей: в возрасте до 60 лет – 29%, в возрасте 60-69 лет – 32%, старше 70 лет – 39%.

Все пациенты взятые на учет с IV стадией процесса умерли в первый год от момента установления диагноза. В 56% случаев запущенность была установлена в связи отдаленными метастазами, при чем в 35% случаев отмечались множественные метастазы. По локализации метастазы распределились следующим образом: в кости, по плевре, в билатеральное легкое – по 21%, головной мозг и отдаленные лимфоузлы – по 10-11%, в мягкие ткани, печень и др. – 16%. В 13 случаях было установлено развитие рака легкого на фоне другой онкологической патологии, что составило чуть менее 5%.

При анализе длительности обследования до установления диагноза выявлено: обследование до 3-х месяцев – 60%, от 3-х до 6 месяцев – 15%, более 6 месяцев – 25%.

Результаты и выводы: Среди запущенных пациентов преобладают пациенты старших возрастов, которые не проходят

систематического профилактического обследования. Более 50% пациентов при установлении диагноза имели отдаленные метастазы, большая часть которых в пределах грудной клетки, отмечается высокий процент поражения головного мозга. Четкой связи между длительностью обследования и стадий процесса не установлено, что по-видимому связано с высокой биологической активностью рака легкого.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА ЛЕГКОГО В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2009 ГОДАХ.

*Кравчук В.А., Сулейменов М.К., Буть Л.Г.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: в Республике Казахстан северо-восточные регионы лидируют по уровню онкологической заболеваемости. Заболеваемость в этом регионе превышает средние республиканские показатели за 20-30%. В структуре при этом в течение последних 40 лет преобладает рак легкого. Если в 70-80 годы отмечался повсеместно значительный прирост заболеваемости раком легкого, по данным различных авторов в 2-3 раза за 10-летие. То в 90-е и «нулевые» годы отмечается стабилизация эпидемиологических показателей рака легкого, а в ряде стран в основном странах Европы снижение.

Цель исследования: анализ и изучение статистических показателей рака легкого в Павлодарской области в 1990-2009 годах.

Материалы и методы исследования: статистические отчеты КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», конъюнктурный обзор деятельности.

При анализе заболеваемости раком легкого отмечается его стабилизация в относительных цифрах, а в абсолютных даже уменьшение, что связано демографическими изменениями населения области. Изменилось положение рака легкого и в структуре заболеваемости, он по-прежнему занимает первое место, но процентное соотношение его к остальным опухолям становится меньше. Так в 1990 году рак легкого составлял 18,1%, в 1999 году только 14,9%, в 2009 году 13,6%. Заболеваемость практически не изменялась и колебалась от 34 до 39 на 100 000 населения. Смертность от рака легкого сохраняется высокой, но отмечаются моменты стабилизации, а в последние годы и снижения, начиная с 2002 года (с 34,9 до 30,8). Если в 90-е годы отмечалось снижение удельного веса I-II стадии процесса и нарастание больных с IV стадией. То в 2000 годы в связи с внедрением единых стандартов диагностики и лечения, улучшения финансирования здравоохранения наметилась обратная динамика. (I-II стадии 1990 – 20%, 1997 – 6%, 2003 – 8%, 2009 – 24,5%, а IV стадия 1990 – 38%, 1999 – 48%, а с 2001 года неуклонно снижалась с 46,2 до 26,8%). Аналогичная ситуация с однолетней летальностью, так в 90-е годы отмечалось увеличение с 65 до 75%, то в 2009 году однолетняя летальность при раке легкого составила 61,7%. Соотношение мужчин и женщин практически не изменилось и составило 6,6:1. Стандартизованный показатель заболеваемости для мужчин составил 74,55, для женщин – 10,25. За отчетный период больные в возрасте до 60 лет составили только 30,8%, в возрасте 60-64 года – 25,2%, 65-69 лет – 15,5 %, старше 70 лет 28,5%, стандартизованный показатель заболеваемости составил соответственно в возрасте до 60 лет 14,6, 60-64 года – 203,5, 65-69 лет – 221,7, старше 70 лет – 257,6. При этом клинически значимую сопутствующую патологию имели 81% больных (колебания по годам от 74,2 до 84,9%), основную массу составили заболевания сердечно-сосудистой системы 39,8%, хронические заболевания легких 19,6%, заболевания ЖКТ 9,4%, патология почек 7,4%, сахарный диабет 2,2%, а сочетание с туберкулезом 2,3%.

Заключение и выводы: за последние 20 лет серьезных успехов в диагностике и лечении рака легкого добиться не

удалось как в нашем регионе, стране, СНГ. В связи с внедрением стандартов диагностики и лечения заболеваний, улучшением финансирования здравоохранения положительные подвижки всё-таки есть: несколько уменьшилась смертность, увеличился процент пациентов с малыми стадиями, процент пациентов получивших специальное лечение. По-прежнему актуальны вопросы возраста больных, сопутствующей патологии у них, высоких темпов роста опухолей легкого.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ПРИ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ИСХОД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Лозовой В.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: по сводной статистике Шалимова А.А. (1987, Киев) послеоперационная летальность при операциях на пищеводе и кардиальном отделе желудка менялась в течение последних 50 лет, так в 1940-49 гг. она составляла более 40%, 1950-59 гг. – 30%, 1960-69 – 25%, а в 70-80-е годы составляла 19%. Улучшение результатов лечения связаны с наработкой методик операций, созданию школ хирургов, более четким ведением операционного и послеоперационного периода в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Цель работы: провести анализ влияния различных методов послеоперационного обезболивания на интенсивность послеоперационного болевого синдрома (ПБС), послеоперационную летальность, частоту сердечно-сосудистых осложнений, а также длительность послеоперационного пареза кишечника.

Материалы и методы: истории болезни пациентов торакального отделения за 2005 – 2009гг., которым были проведены операции на пищеводе и кардиальном отделе желудка при раке. За 5 лет в торакальном отделении Павлодарского областного онкологического диспансера проведено 67 радикальных операций при раке пищевода и кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Средний возраст оперированных больных составил 59 лет, в то время как средний возраст больных взятых на учет 65 лет. Все больные были разделены на 2 группы, группы различались по применяемым методам интра – и послеоперационного обезболивания: в 1 группе во время операции проводили общую анестезию, для послеоперационного обезболивания в 1 группе использовали системное введение опиоидных анальгетиков по требованию, во 2 группе на интраоперационном этапе использовали высокую (уровень Th III-V) эпидуральную анестезию (ЭА) в качестве анальгетического компонента общей анестезии, для послеоперационного обезболивания – длительную ЭА с сочетанным введением местного анестетика (0,5% лидокаин) и опиоида. Был проведен анализ влияния различных методов послеоперационного обезболивания на интенсивность послеоперационного болевого синдрома (ПБС), послеоперационную летальность, частоту сердечно-сосудистых осложнений, а также длительность послеоперационного пареза кишечника.

Результаты и выводы: интенсивность ПБС во 2 группе была значительно ниже, чем в 1 группе. Также во 2 группе была ниже частота сердечно-сосудистых осложнений (ЭКГ признаки ишемии миокарда, нарушения сердечного ритма.) Процент осложнений в 1 группе составил 14,2%, летальность составила 3,5%. Во 2 группе процент осложнений 12,8%, летальность 1,6 %. Общий процент осложнений составил 13,5%, летальность составила 2,5%. Во 2 группе было отмечено значительное снижение продолжительности послеоперационного пареза кишечника.

Применение ЭА на интраоперационном этапе повышает эффективность анестезиологической защиты от операционной травмы и снижает вызванную операционной травмой

гипервозбудимость спинальных нейронов, что существенно уменьшает выраженность негативных рефлекторных воздействий на сердечно-сосудистую систему. Применение продленной ЭА оказывает выраженное влияние на моторику ЖКТ при торакоабдоминальных операциях, что способствует раннему началу энтерального питания пациентов. Вышеуказанные факторы, а также снижение выраженности операционного стресс-ответа при применении высокой ЭА способствует снижению послеоперационной летальности. Для выздоровления особое значение имеет также комплекс мер предоперационной подготовки и особенно послеоперационного ведения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОФЛЮРАНА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ В ОНКОХИРУРГИИ (ТВБА)

Лозовой В.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: адекватная анестезия недостижима без правильного режима доставки анестетика в кровоток. Если анестетик вводят дробными дозами в/в струйно через определенные промежутки времени, то кривая концентрации препарата в плазме выглядит как чередование пиков и провалов. Пики проявляются чрезмерной глубиной анестезии и побочными эффектами анестетика, провалы – слишком поверхностной анестезией, сопряженной с риском восстановления сознания. Если анестетик вводить слишком часто, то он может кумулировать, что замедляет пробуждение. При ТВБА необходимо вводить два препарата – гипнотик и анальгетик, поэтому существует много стратегий инфузии. Но интенсивность ноцицептивной (хирургической) стимуляции изменяется во времени, поэтому инфузия анальгетика в дозе, эффективно подавляющей наиболее интенсивное болевое раздражение, может привести к относительной передозировке опиоида и замедлить восстановление самостоятельного дыхания в конце операции. Недостатком методов, основанных на использовании наркотических средств для поддержания общей анестезии, является тот факт, что от анестезиолога требуется большое умение, чтобы обеспечить равномерный эффект анестезии в течении операции.

Цель работы: провести сравнительный анализ применения ингаляционного анестетика Изофлурана как дополнительного компонента при (ТВБА) тотальной внутривенной анестезии в онкохирургии.

Материалы и методы: опыт применения Изофлурана как дополнительного компонента при (ТВБА) тотальной внутривенной анестезии в онкохирургии, в работе анестезиолога – реанимационного отделения Павлодарского онкодиспансера за 5 лет.

Проведено - 278 ТВБА + Изофлуран анестезий на органах пищеварения, органах грудной клетки, органах мочеполовой системы у больных в возрасте от 36 до 79 лет, что составило 8,5% от общего числа проведенных анестезиологических пособий в этой группе больных. Применение Изофлурана как дополнительного компонента при (ТВБА) определялось в процессе проведения ТВБА, вводный наркоз TiNa 2.5% , основной наркоз (морфин (фентанил) + кетамин) с применением мышечных релаксантов, с интубацией трахеи, O₂, ИВЛ. У всех больных в анамнезе артериальная гипертензия 1-2 ст., а также терапия ингибиторами АПФ, бета – блокаторами. У них также отмечалась выраженная гипертензивная реакция на неадекватную аналгезию во время операции. Подача Изофлурана во время анестезии составляло от 1,5 об% - до 0,3 об%.

Результаты и выводы: у всех больных после применения Изофлурана отмечалась устойчивая гемодинамика, без

чередование пиков и провалов, что часто отмечается при обычной болюсной ТВБА. Основное количество больных которым применялся форан имеют возраст от 45 до 60 лет. По окончании операции практически у всех больных наблюдался мягкий выход из наркоза, быстрее восстанавливалось адекватное самостоятельное дыхание. Расход наркотических анальгетиков и гипнотиков за период анестезии особо не изменялся. При использовании изофлурана является мощным дыхательным депрессантом и снижает артериальное давление за счет общепериферического сопротивления. Возможность применения у больных со стойкой артериальной гипертензией, не увеличивая дозу наркотических анальгетиков и гипнотиков что приводит к более быстрому восстановлению самостоятельного дыхания в конце операции. Применение изофлурана дополнительного компонента при (ТВБА) Тотальной внутривенной анестезии, является методом выбора анестезиологического пособия у онкологических больных.

РОЛЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Сатабаев М.Т.

КГКП «Поликлиника №1 г. Павлодара», г. Павлодар

Актуальность: раннее выявление онкологических заболеваний является залогом успешного лечения, содействует улучшению основных онкологических показателей (снижение смертности, увеличение пятилетней выживаемости, снижение однодневной летальности).

Цель работы: демонстрация значимости деятельности врачей и среднего медицинского персонала городской поликлиники в раннем выявлении онкологических заболеваний.

Материалы и методы: методические разработки по диагностике рака, отчеты о выполнении скрининговых программ, проводимых в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 607 за 2008 – 2009 годы.

Городская поликлиника № 1 г. Павлодара обслуживает население численностью около 80000 человек. Основными задачами для улучшения онкологической ситуации на прикрепленной территории являются: организация ранней диагностики злокачественных новообразований; диспансеризация лиц групп повышенного риска; оказание медицинской помощи онкологическим больным по рекомендациям областного онкологического диспансера; восстановительное лечение и реабилитация. К приоритетным направлениям работы относятся организация ранней диагностики рака; санация предраковых заболеваний у лиц из групп повышенного риска; направление всех выявленных больных или больных с подозрением на онкопатологию в онкологический диспансер; оказание восстановительного лечения в амбулаторных условиях. Поликлиника оснащена медицинской аппаратурой, позволяющей проводить обследования: клинические, биохимические, рентгенологические; эндоскопические; функциональные. В смотровом кабинете и в женской консультации проводится забор материала для проведения цитологических исследований в централизованной цитологической лаборатории. Биопсийный материал, взятый врачами - хирургами и гинекологами, доставляется на морфологическое исследование в патогистологическую лабораторию на договорной основе. Все перечисленные обследования проводятся в рамках ГОМБП. Реализуемая в Республике Программа по ранней диагностике рака молочной железы и рака шейки матки позволила нам планомерно обследовать в 2008г. 5028 женщин декретированного возраста (3300 обследовано цитологически, 1728 – маммографически), в 2009г. – 5100 (3000 – цитологический скрининг, 2100 – маммографический скрининг). При проведении маммографического скрининга в 2008г. выявлен 1 случай рака молочной железы, 758 случаев

доброкачественной гиперплазии молочной железы и доброкачественных узловых образований. В 2009г. выявлено 3 случая рака молочной железы, другой патологии - 732. Проведение цитологического скрининга позволило выявить в 2008г. патологию у 677 женщин, в 2009г. – у 667 женщин. Процент выявленной патологии составил по годам соответственно 20,5% и 22,2%. Лечебные мероприятия сводятся к санации и лечению групп повышенного риска и проведению симптоматической терапии больных с IV ст. заболевания, лечению выраженного болевого синдрома. Критерием качества проводимых мероприятий является увеличение числа санированных больных с одно-временным уменьшением числа онкобольных с III-IV стадиями заболевания из числа диспансеризуемых групп риска.

Заключение и выводы: в последнее время государство уделяет много внимания раннему выявлению заболеваний, в том числе и онкологических, приводящих население к инвалидности. Для улучшения онкологической ситуации каждый житель прикрепленной к поликлинике территории, обязан ежегодно пройти минимальный набор медицинских обследований. Профилактический осмотр должен способствовать выявлению начальной формы онкологического заболевания, лечение которого, несомненно, более результативно при его начальных стадиях.

ПРОБЛЕМА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКИХ.

Сулейменов М.К.

*КГКП «Павлодарский областной онкологический
диспансер», г. Павлодар*

Актуальность: Рак легкого во многих индустриально развитых странах представляет одну из самых актуальных проблем клинической онкологии. Он является наиболее частой злокачественной опухолью и основной причиной смерти от онкологических заболеваний. В Павлодарской области отмечается прирост показателя заболеваемости на 9% и смертности на 5% за последние 15 лет.

Цель работы: проанализировать удельный вес сопутствующих заболеваний у больных раком лёгкого и их влияния на возможности лечения.

Материалы и методы: истории болезни, статистические показатели.

Для рака лёгкого характерны высокий процент запущенности и одногодичной летальности. Одногодичная летальность в Павлодарской области колеблется от 62 до 75% в различные годы, хотя в 2000-х годах постепенно снижается, но остается на высоких цифрах и составляет 62-63%, то есть в первый год при постановке диагноза умирают все больные с IV стадией и половина больных с III стадией процесса. По нашим данным, специальное лечение получают 40 - 44% больных взятых на учет, при этом хирургическое и комбинированное лечение не более 10 - 12%. Отказы от лечения составляли 6 - 8 %. Противопоказания для специального лечения составлялись 12 - 15%. Больные с IV стадией процесса составляют до 50%.

По данным ВОЗ неуклонно растет количество населения старших возрастов, и, как следствие, заболеваемость онкологической патологией. За последние 5 лет больные раком легкого в возрасте до 60 лет составили 30,8%, в возрасте 60 - 64 года – 25,2%, 65 - 69 лет – 15,5 %, старше 70 лет 28,5%. Стандартизованный показатель заболеваемости составил соответственно в возрасте до 60 лет 14,6; 60-64 года – 203,5; 65-69 лет – 221,7; старше 70 лет – 257,6.

Среди онкологических больных немалую долю составляют пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями, значительно снижающими функциональные резервы и в большой мере определяющими риск лечения.

За последние 5 лет клинически значимую сопутствующую патологию имели 81% больных раком легкого (колебания по

годам от 74,2 до 84,9%).

Основную массу составили заболевания сердечно - сосудистой системы (39,8%), что объясняется преклонным возрастом пациентов. При анализе пациентов с сопутствующей сердечно - сосудистой патологией примерно одинаковое количество составляли пациенты с ИБС и артериальной гипертензией, часто имели место сочетание этих патологий, очень редко (единичные случаи) отмечалась врожденная патология, поражение клапанного аппарата и др. Одним из предрасполагающих факторов в отношении развития рака легкого являются хронические заболевания легких, у наших пациентов они составили 19,6%. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта составляют 9,4%, среди них преобладают поражения гепатобилиарной системы (до 95%). Патология почек встречается в 7,4% случаев. Сахарный диабет зарегистрирован в 2,2%, а сочетание с туберкулезом - 2,3%. Среди прочей патологии преобладали поражения нервной системы, особенно центральной.

Результаты и выводы: таким образом, среди заболевших РЛ около 70% лиц старше 60 лет, как следствие имеют место наличие выраженной сопутствующей патологии (до 81% от числа заболевших), которая в купе с поздней диагностикой не позволяет проводить радикальное лечение основной массе больных. Выбор оптимальной лечебной тактики у онкологических пациентов - сложный и индивидуальный процесс. Для оценки функционального состояния онкологического больного необходимо использование многофакторной шкалы, охватывающей все сферы жизнедеятельности.

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ

Сандыбаев М.Н., Зейнелова Л.Т.,

Жұмықбаева Н.К., Бегатарова Қ.Н.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері

Академик Н.Н.Петровтың (1947) пікірі бойынша обырдың себептері туралы біз көп білеміз, обырға қарсы күрес мәселесін алдын алу релсіне қою мүмкіндік қана емес, қажеттілік. Бірақ, тұрғындар арасында жүргізілетін обырға қарсы ағартушылық жұмыстар қазақстандағы алдын алу (профилактикалық) жұмыстарды жүзеге асыратын бірден – бір бағыт болып табылады.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады.

Зерттеу мақсаты. Семей өңірінде 2008 -2009 жыл аралығы кезеңдегі обырға қарсы күрестің тиімділігіне зерттеу жүргізу.

Материалдары мен әдістері. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансеріндегі 2008-2009 жыл аралығы кезеңіндегі деректер бойынша қатерлі ісіктерді ерте анықтау және асқынудың статистикалық көрсеткіштеріне салыстырмалы түрде талдау жүргізілді. 2005-2009 жылдар аралығында онкология диспансерінің қызметкерлерімен 79 мақала, 98 теледидардан және радиодан қатерлі ісіктерді алдын-алу мақсаты жөнінде 30 баяндама жасалды.

Қорытынды. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады. Сонымен, статистикалық талдау деректері негізінде мынадай қорытынды жасауға болады, онкологиялық диспансер мамандары жүргізіп жатқан мазмұны мен түрі жағынан әртүрлі ағартушылық жұмыстар Семей аймағындағы қатерлі ісіктердің ерте анықтауды жақсартуға, онкологиялық аурулардың асқину жағдайларын төмендетуге және қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың өміршеңдігін ұзартуға қол жеткізуге мүмкіндік туғызды.

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

*Зейнелова Л.Т., Сандыбаев М.Н., Челдыбаева Т.И.
Региональный онкологический диспансер г. Семей,
Республика Казахстан*

Актуальность. Глава государства в своем Послании «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» отметил, что здоровье народа - это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в достижении своих стратегических целей. В условиях экономических преобразований роль, функции и организационные формы деятельности сестринского персонала меняются в соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением. В настоящее время в системе Министерства здравоохранения Республики Казахстан работают 119884 средних медицинских работников, что более чем в 2,4 раза больше врачей. Сегодня это соотношение врачебного и среднего медперсонала говорит о том, что в современной системе здравоохранения наряду с врачебной, эффективность оказания медицинской помощи зависит от применения модернизированной сестринской деятельности, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи, путем осуществления организационных сестринских технологий.

Управлять качеством сестринской помощи, по мнению Дороти Холл, можно лишь тогда, когда деятельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом.

Цель: Анализ качества работы среднего медицинского персонала на основе изучения анкет.

Материалы и методы: Всего за период с 2005-2009 гг. было изучено 2134 анкеты экспертных оценок сестринской помощи, 11971 анкета опроса пациентов о качестве оказываемой сестринской помощи.

На базе Регионального онкологического диспансера г. Семей работают 158 средних медицинских работников, из них 75% медсестер имеют квалификационную категорию, с высшим медицинским образованием 8 человек.

Для мониторингирования действий и результатов по принятой технологии сестринского процесса в лечебных отделениях стационара с 2005 года были внедрены «Карты сестринского наблюдения больных». Проведение анализа с использованием разработанных карт оценки сестринской деятельности улучшает качество медицинской специализированной помощи онкологическим больным, позволяет оценить качество работы структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений. Предложенные механизмы внедрения в практику новых медицинских технологий обеспечивают проведение всесторонней и качественной оценки, учитывающей клинические, профессиональные и этические аспекты.

С целью изучения мнения пациентов об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи проводится анкетирование пациентов по качеству ведения, культуре обслуживания, наличию информации по видам услуг, организации и качеству питания. Данные анализа результатов опроса оказывают несомненную роль в корректировке работы сестринской службы.

Результаты и выводы: Систематический анализ мнения больных показывает, что, начиная с 2005 года, удовлетворенность пациентов деятельностью среднего медицинского персонала в РОД г. Семей характеризуется ростом на 33,3%. При этом наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в отделениях, имевших низкие показатели.

Таким образом, применение технологических карт оценки деятельности медицинских сестер способствовало повышению качества работы среднего медицинского персонала.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО III СТАДИИ

*Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Нсанов Ж.К.
Казахстанско – Российский медицинский университет,
Алматинский городской, Атырауский областной
онкологический диспансер*

Актуальность. Ведущим методом лечения рака легкого является хирургический, однако отдаленные результаты его нельзя считать удовлетворительными, так как от 30 до 50% больных, перенесших радикальные операции, погибают в течение первых трех лет от рецидива и метастазов (Трахтенберг А.Х. с соавт., 1996г., Жарков В.В.с соавт., 2003г., Стилиди И.С. с соавт., 2004г., Фокеев С.Д. с соавт., 2006г.). В целях улучшения продолжительности жизни больным проводятся комбинированные и комплексные методы, однако по данным литературы показатели отдаленных результатов разноречивые, поэтому мы хотим поделиться опытом и результатом применения вышеуказанных методов лечения больных раком легкого.

Цель – улучшение результатов лечения больных раком легкого III стадии на основании сравнительной оценки современных методов лечения. Материал и методы исследования. Нами проанализированы истории болезни 666 больных раком легкого, выписанных из стационара, из них 285 больных подвергались радикальному хирургическому лечению, 236 больных – адьювантной полихимиотерапии, 45 больных – неоадьювантной лучевой терапии интенсивно – концентрированным методом (ежедневно) РОД-4Гр, до СОД 20Гр, через 1-3 дня операция. Адьювантная лучевая терапия в РОД-2Гр до СОД-45-50Гр, а также 50 больным с операбельным раком легкого III стадии, отказавшимся от операции или имевшим противопоказания к ней и получившим дистанционную гамма – терапию расщепленным курсом по радикальной программе. Адьювантная ПХТ проводилась больным раком легкого через 3 – 4 недели после операции, 6 – 8 курсов в течение двух лет с применением циклофосфана, гемзара, карбоплатина, метотрексата, винкристина. Прослеженность свыше 5 лет составила 100%.

Результаты исследования и заключение. Хирургическое лечение, как самостоятельный метод более или менее эффективен при I стадии, 5 – летняя выживаемость равнялась 65,2%, из них при дифференцированных морфологических формах – 76,8%, мало- и недифференцированных формах – 62,5%, при II стадии – аналогичные показатели – 43,6%, 50,0% и 40%, при III стадии – 9,7%, 13,0%, 6,8% соответственно. Следует отметить, что наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах резко ухудшает прогноз при всех гистологических формах.

- При проведении более 6 курсов адьювантной полихимиотерапии больным с III стадией трехлетняя выживаемость составила 45,8+ _6,4%, после одного хирургического лечения – 36,2+ _5,6%, при дифференцированных формах – соответственно 54,8+ _6,5% и 24,8+ _5,4%, низко- и недифференцированных – 38,7±5,8% и 17,1+ _6,4%.

- При применении послеоперационной лучевой терапии больным с III стадией трехлетняя выживаемость равнялась 44,1+ _3,5%, после хирургического лечения – 36,2+ _5,6%, при дифференцированной форме 48,0+ _6,5%, 24,3+ _5,4%, низко- и недифференцированной форме – 27,5+ _3,6% и 12,5+ _5,8%.

- После расщепленного радикального курса лучевой терапии трехлетняя выживаемость составила 14,0+ _4,9%, при дифференцированных формах – 16,4+ _4,8%, низко- и недифференцированных формах ни одной больной не прожил более двух лет.

Таким образом, исходя из полученных данных о выживаемости больных раком легкого следует заключить, что выбор оптимального метода лечения остается очень сложной проблемой, в которой все отчетливее выступает необходимость индивидуализации тактики лечения в зависимости от основных прогностических факторов. Хирургическое лечение как самостоятельный метод эффективен при ранних стадиях в условиях отсутствия метастазов в регионарных лимфатических узлах при всех морфологических формах, а при IIb, III стадии малоэффективен, так как расширение объема оперативного вмешательства путем резекции соседнего анатомического образования с регионарной лимфодиссекцией существенно не улучшает продолжительность жизни больных при всех морфологических формах.

Адьювантные курсы полихимиотерапии и лучевой терапии позволяют заметно улучшить результаты хирургического лечения при раке III стадии с метастазом в регионарных лимфатических узлах. Неoadьювантная лучевая терапия эффективна при отсутствии метастазов.

При III стадии рака легкого лучевая терапия, проведенная расщепленным курсом по радикальной программе, носит паллиативный характер, где трехлетняя выживаемость при дифференцированных формах составляла 16,4+4,8%, низкая и недифференцированных формах – 0%.

Следовательно, для улучшения отдаленных результатов лечения рака легкого во IIb и III стадиях необходимы совершенствования существующих и разработка новых схем адьювантных курсов полихимиотерапии с использованием современных противоопухолевых препаратов, таких, как карбоплатин, таксотер, гемзар, навельбин и др..

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫХ ОПУХОЛЯХ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Бекмухамбетов Е.Ж., Дюсембеков С.Т., Койшыбаев А.К., Симбатов Т.К., Ешимов С.А.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней

Актуальность. По данным литературы гормонально неактивные опухоли надпочечников «клинически немые» или же инсиденталомы описывались как случайные находки при аутопсии по различным причинам. В последние десятилетия после внедрения в клиническую практику таких методов уточняющей диагностики, как УЗИ, КТ и ЯМРТ появились публикации, указывающих, что у 0,5 до 5 % больных, не имеющих клинической симптоматики нарушения функции надпочечников, при проведении вышеперечисленных методов обследования выявляются различные опухоли надпочечников. Среди них чаще всего встречаются доброкачественные образования, так по данным M.S. Gross и B. Shapiro (1993) доброкачественные аденомы встречаются с частотой 1:4000, а злокачественные меньше чем 1:250 000. Кроме первичных опухолей выявляются и метастатические поражения рака легких, молочной железы и др. Из редких опухолей выявляются нейрофиброма, гамартома, тератома, кисты и др.

Цель исследования. Значение хирургического лечения при случайно выявленных аденомах коры надпочечника.

Материал и методы исследования. По нашим данным за период с 2000 по 2009 годы были диагностированы 3 случая больных с «немыми» формами опухолей надпочечников, при этом все случаи выявлены при профилактических осмотрах. Клинических проявлений характерных для опухолей надпочечников больные не предъявляли. По данным УЗИ и компьютерной томографии размеры опухолей варьировали от 3 см до 4,5 см, данных за диссеминацию процесса в дооперационном периоде не выявлено. Всем больным проведено хирургическое лечение в объеме адреналэктомии с

опухолью. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. При морфологическом исследовании у больных выявлены аденомы надпочечника. Все больные выписаны под динамическое наблюдение онколога и эндокринолога по месту жительства, за время наблюдения состояние больных без ухудшения.

Выводы. Таким образом, при «немых» опухолях надпочечников, ведущим методом лечения является хирургический.

БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК (БМСК) ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ИНОВАЦИЯЛАУ.

Жұмағалиев Д.Ж.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасында қатерлі ісік ауруларынан өлім, қан айналымы ауруы және жарақаттан соң, үшінші орынға ие. Жалпы республикамызда көлемінде қайтыс болғандардың жетіншісі қатерлі ісік аурунан қайтыс болған. Еліміздің қатерлі ісікке қарсы күресуші мекемелерінде 2009 жылы 138823 (9742) астам адам есепте тұрса, оларды 100 000 халыққа шаққанда республикамызда 868,6 (ОҚО-401,5) көрсеткен. Жыл сайын елімізде 29 000 астам қатерлі ісік ауруымен тіркелсе, (ОҚО-2328), ал өлгендер саны республикамызда 17 000 жуық (ОҚО-1350) адам. Осылардың 45 пайыздан астамы еңбекке жарамды жастағылар. Сондықтан, қатерлі ісік ауруларын әлуметтік мәні бар аурулар қатарына жатқызуының өзі, біз онкологтар қауымына үлкен жауапкершілік артыратыны, әсіресе БМСК деңгейіндегі онкологиялық қызметті иновациялау керектігі, бұл қазіргі кезеңнің талабы.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық қызметтің жағдайын БМСК деңгейінде зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2005-2009 жылдар аралығында қатерлі ісік ауруларының сапалы көрсеткіштері аясында және де БМСК деңгейіндегі онкологиялық қызметтің жұмыс барысын талдау негізінде алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2009 жылы 2328 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса (100 000 халыққа шаққанда 98,7), ал 2005 жылы 2345 науқас (100 000 халыққа шаққанда 106,0) болған. Аурушандық 2005-2008 жылдар аралығында 92,8 дейін төмендегенімен 2009 жылы 98,7 қайта өскен. Қатерлі ісіктің асқынған түрімен 2005 жылы 474 науқас (20,2 пайыз) тіркелсе, 2009 жылы 443 науқас (19,0 пайыз), тек бір пайызға азайған. Бірақ, 2009 жылы облыс көлемінде Мақтаарал ауданында 26,1 пайыз, Шардарада 25,0 пайыз, Сарыағашта 22,1 пайыз, Кентау қаласында 22,3 пайызға жоғары болған. Өлім 2009 жылы 1350 науқас 55,6 (100 000 халыққа шаққанда) болса, 2005 жылы 56,6 қалыпты деңгейде, осыған қармастан, облыс көлемінде Төлеби ауданында 70,6, Арыста 68,7, Кентауда 68,2, Ордабасыда 64,1, Түлкібаста 62,8 жоғары көрсеткіштер болған, бұл осы ауданмен қалаларда өлімнің көптігі. Науқастардың ауырғыштығы 2005 жылы 7949 науқас 356,2 100 000 халыққа шаққанда, ал 2009 жылы 9742 науқас 413,3 өскен. Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2005 жылы 33,6 пайыз болса, ал 2009 жылы 45,1 пайызға өскен, бірақ облыс көлемінде ең төмен көрсеткіштер Түлкібас ауданында 34,1 пайыз, Созақта 35,3 пайыз, Арыста 36,3 пайыз, Ордабасыда 38,0 пайыз болған. Міне, осы көрсеткіштерді ескере отырып онкологиялық қызметті жақсарту мақсатында БМСК деңгейінде 2010 жылдың 7 айында бірнеше рет тексеру жүргіздік, әсіресе Созақ, Түлкібас, Ордабасы, Арыс аудандарында. Анықталған негізгі кемшіліктер тоқталсақ, бұл онкологтардың тұрақты жұмыс істемеуі, тез-тез ауысуы, әлде қосалқы түрде міндетін атқаруы. Диспансерлік есептің дұрыс жүргізілмеуі, науқастардың арнайы ем барысының толық

қадағаланбауы, созылмалы немесе қатерлі ісік алды, қатерлі емес ісіктердің сауықтыру процессі нашарлығы, дәрігерлердің арасында өз-ара әріптестік қарым-қатнастың жоқтығы және де ҚР ДСМ № 607,685 бұрықтарының орындалуы барысы қағаз жүзіндегі ойландырады

Сондықтан, онкологиялық қызметті жақсарту үшін БМСК деңгейінде жаңа жүйелі іс-шаралар ойластырып, ҚР ДСМ №206 26.05.1994 жылғы бұйрығына өзгерістер жасап, инновациялық жаңалықтар енгізу, бұл өмір талабы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАД В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Астапкевич Л.А.

Городская больница №1, г. Астана

Поражение почек является наиболее частой висцеральной патологией (в 50-90% случаев) при множественной миеломе ММ и одной из основных причин сокращения продолжительности жизни больных. Наиболее важное значение в развитии поражения почек и формировании ХПН при ММ имеют: гиперпродукция патологических легких цепей иммуноглобулинов с их накоплением в дистальных канальцах, последовательное прогрессирование парапротеинемии и протеинурии, что приводит к микроциркуляторным нарушениям, дистрофии эпителия почечных канальцев, развитию склероза и рубцовой деформации анатомических структур почек, а также гиперкальциемия, гиперкальциурия, фосфатурия, повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, диффузный амилоидоз.

В условиях гематологического отделения 2 пациентам с подтвержденным диагнозом Множественная миелома IIIБ стадия \ данные морфологии, электрофореза белка, определение уровня креатинина в сыворотке, иммунологическое обследование \ проведены курсы полихимиотерапии по протоколу РАД \ Велкейд 1,3 мг/м² в/в - 1,4,8,11 дни, адриабластин 9 мг/м² в/в в течение 1-4 дней, Дексаметазон 40 мг в/в по 4 дня-3 блока \ с пер-спективной проведения в дальнейшем аутологичной трансплантации стволовых клеток.

Пациенты	1 пациент				2 пациент		
курсы	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	1 курс	2 курс	3 курс
Нв	50	84	91	95	62	87	82
Лейкоциты	5,0	7,1	6,3	5,2	2,6	2,5	3,7
Тромбоц.	219	290	261	236	27,4	103,3	55
СОЭ	68	50	36	31	75	60	52
Протеинур.	6,2	0,089	0,081	0,081	0,372	0,01	0,34
Белок Б-Д.	+	-	-	-	+	-	-
Общ\белок	83,4	72	68	75	112,6	94	95
М-град.	+	-	-	-	+	-	-
креатинин	563	172	156	144	644	370	424
мочевина	22,6	10,2	6,7	6,9	34,3	21	20
ЛДГ	638	1179	626	844	652	663	1314
СРБ	++++	отр	отр	отр	++++	отр	+++
КМ	Пл. кл - 23,8%				Пл. кл - 41,7%		
ОД	+				+ патолог. переломы		
печень	+9,0	+2,0	+3,0	N	+2,0	N	N
селезенка	133 x52	N	N	N	N	N	N

Белок Б-Д- белок Бенс-Джонса, КМ-костный мозг, ОД-остеодеструкция, пл.кл-плазматические клетки.

В результате проведенной терапии у пациентов достигнуто улучшение-восстановились показатели красной крови \отказ от трансфузии Эр-взвеси\, снизились показатели креатинина и мочевины, общего белка в крови и моче, купированы оссалгии. Отмечена хорошая переносимость протокола.

Протокол РАД можно рекомендовать как протокол первой линии у пациентов с множественной миеломой IIIБ стадии.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Гофур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Нишонов Д.А.,
Хаитов Ф.Э., Каримова Н.М.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,
г.Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: Определить показатели маркеров пролиферации и апоптоза у больных с остеогенной саркомой трубчатых костей.

Материалы и методы: Обследованы 46 больных остеогенной саркомой в возрасте от 8 до 16 лет. В 26 наблюдениях опухоль локализовалась в бедренной кости и в 20 – большеберцовой кости.

В зависимости от рентгенологического проявления опухоли все больные подразделены на 3 группы: остеопластический тип – 4 (30,4%), остеолитический тип – 16 (34,8%), смешанный тип – 16 (34,8%) .

Для проведения молекулярно-генетического исследования использованы парафиновые срезы образцов опухолевой ткани с определением экспрессии генов p-53 и Ki-67 (фирма "Novo Castro" , Великобритания).

Уровень пролиферации опухолевой ткани определяли по экспрессии гена Ki-67 маркера клеток, находящихся в митотическом цикле, а также определен уровень апоптоза по экспрессии мутационного гена p 53. Степень экспрессии оценивали поликоличественным способом: от 0 до 10% клеток с наличием окраски - отрицательная экспрессия, до 50% средняя экспрессия, свыше 50% сильная экспрессия.

Результаты: Нами изучены показатели ген - супрессора p-53 и ген пролиферации клеток Ki-67 в зависимости от пола и рентгенологического типа опухоли. Рентгенологически смешанном типе частота Ki-67 положительных опухолей составила - 64,2%, а отрицательных – 38,5% (16,9% - среди

мальчиков и 16,2% среди девочек). Митотический индекс оказался ниже в образцах смешанного типа опухоли (55% у мальчиков и 9,0% у девочек), но выше при остеолитическом и остеопластических типах. При смешанном варианте опухоли установлен самый низкий уровень экспрессии гена mtp-53 (12,1% мальчиков и 7,7% девочек).

Самый высокий апоптотический индекс обнаружен при самом низком митотическом индексе. При этом среди мальчиков положительные реакции обнаружены у 15%, среди девочек у 45,5%.

Заключение: Высокая экспрессия ген - супрессора p53 обнаружена при остеолитическом типе остеогенной саркомы, наименьшая при смешанном. Экспрессия гена Ki-67 и p53 не зависит от рентгенологического типа опухоли.

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АСБОЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дауренов Б.Б.

Южно-Казахстанский областной онкологический
диспансер, г. Шымкент

Борьба со злокачественными новообразованиями является одной из актуальных задач в области здравоохранения. В настоящее время в ее решении большое внимание уделяется первичной профилактике, а именно, выявлению и устранению факторов внешней среды, в том числе производственных, способствующих возникновению онкологических заболеваний. Распространенным профессиональным канцерогенным фактором риска является ас-

бест, который по классификации Международного Агентства по изучению рака относится к первой группе канцерогенов.

Нами проведена оценка реальной онкологической опасности у работающих Шымкентского производства асбоцементных конструкции и разработка научно обоснованных дифференцированных мероприятия предупредительного характера.

Данные о состоянии производственной среды за период с 1999 по 2006 год свидетельствуют о том, что на основных рабочих местах отмечается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) асбестосодержащей пыли.

Наибольшее загрязнение асбестосодержащей пылью наблюдается в формовочном цехе, где ее концентрация превышает гигиеническую норму до 2,7 раза, а в аппаратном цехе превышение ПДК составляет до 2,15 раза. За исследуемые годы загрязненность атмосферного воздуха формовочного цеха повысилась на 0,9%, а в аппаратном цехе снизилась на 0,5%. Результаты изучения онкологической смертности свидетельствуют о том, что у работающих данного производства повышен риск развития злокачественных новообразований.

Статистически значимыми являются различия между стандартизованными показателями смертности от злокачественных новообразований легких, которые в группе работающих завода асбоцементных конструкции превышает аналогичные показатели среди городского населения (у мужчин – в 1,9 раза, у женщин – в 1,8 раза), что свидетельствует о достоверном влиянии условия труда в асбоцементном производстве на заболеваемость и смертность работников злокачественными новообразованиями легких.

Подтверждением канцерогенной опасности производства асбоцементных конструкции, наряду с показателями стандартизованного относительного риска развития злокачественных новообразований у работающих, явились также данные о том, что у онкологических больных основных цехов стаж работы в контакте с профессиональным фактором достоверно меньше в 2,5 раза, чем у работающих во вспомогательных цехах.

Таким образом, условия труда в Шымкентском производстве асбоцементных конструкции характеризуется повышенной канцерогенностью, что обусловлено высокой респираторностью асбестосодержащей производственной пыли, которая по концентрации в воздухе формовочного и аппаратного цехов от 2,15 до 2,7 раза превышают гигиенические нормативы.

Достоверно высокие уровни онкологической смертности от рака легкого наблюдается среди стажированных рабочих в возрасте 40-49 лет с нарастающим увеличением в каждой последующей возрастной и стажевой группе контингента.

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

*Зейнелова Л.Т., Сандыбаев М.Н., Челдыбаева Т.И.
Региональный онкологический диспансер г. Семей*

Актуальность. Глава государства в своем Послании «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» отметил, что здоровье народа - это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в достижении своих стратегических целей. В условиях экономических преобразований роль, функции и организационные формы деятельности сестринского персонала меняются в соответствии с новыми задачами, стоящими перед здравоохранением. В настоящее время в системе Министерства здравоохранения Республики Казахстан работают 119884 средних медицинских работников, что более чем в 2,4 раза больше врачей. Сегодня это соотношение врачебного и среднего медперсонала говорит о том, что в современной системе здравоохранения наряду с врачебной, эффективность оказания медицинской помощи зависит от применения модернизированной сестринской деятельности, направленной на повышение качества

оказания медицинской помощи, путем осуществления организационных сестринских технологий.

Управлять качеством сестринской помощи, по мнению Дороти Холл, можно лишь тогда, когда деятельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом.

Цель: Анализ качества работы среднего медицинского персонала на основе изучения анкет.

Материалы и методы: Всего за период с 2005-2009 гг. было изучено 2134 анкеты экспертных оценок сестринской помощи, 11971 анкета опроса пациентов о качестве оказываемой сестринской помощи.

На базе Регионального онкологического диспансера г. Семей работают 158 средних медицинских работников, из них 75% медсестер имеют квалификационную категорию, с высшим медицинским образованием 8 человек.

Для мониторингирования действий и результатов по принятой технологии сестринского процесса в лечебных отделениях стационара с 2005 года были внедрены «Карты сестринского наблюдения больных». Проведение анализа с использованием разработанных карт оценки сестринской деятельности улучшает качество медицинской специализированной помощи онкологическим больным, позволяет оценить качество работы структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений. Предложенные механизмы внедрения в практику новых медицинских технологий обеспечивают проведение всесторонней и качественной оценки, учитывающей клинические, профессиональные и этические аспекты.

С целью изучения мнения пациентов об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи проводится анкетирование пациентов по качеству ведения, культуре обслуживания, наличию информации по видам услуг, организации и качеству питания. Данные анализа результатов опроса оказывают несомненную роль в корректировке работы сестринской службы.

Результаты и выводы: Систематический анализ мнения больных показывает, что, начиная с 2005 года, удовлетворенность пациентов деятельностью среднего медицинского персонала в РОД г. Семей характеризуется ростом на 33,3%. При этом наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в отделениях, имевших низкие показатели.

Таким образом, применение технологических карт оценки деятельности медицинских сестер способствовало повышению качества работы среднего медицинского персонала.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

*Коровников А.Г., Адылханов Т.А.,
Сандыбаев М.Н., Тулеутаев М.Е.*

*Региональный онкологический диспансер г. Семей,
Государственный медицинский университет г. Семей*

Актуальность: Прогресс в диагностике и терапии онкологических заболеваний поставил задачу сохранения качества жизни (КЖ) онкологических больных. Значительное снижение КЖ обусловлено как самим онкологическим заболеванием, так и специальным лечением, а также психогенными реакциями, встречающимися у всех больных.

Купирование пограничных психических расстройств у онкологических пациентов в настоящее время представляет значительные трудности, связанные с отсутствием в онкологических диспансерах системы психотерапевтической помощи.

В Региональном онкологическом диспансере (РОД) г. Семей с 2000 года введена штатная должность врача-психотерапевта. Работа врача-психотерапевта регламентируется Приказом № 147 МЗ РК от 31.03.1997 г. «О дальнейшем улучшении психотерапевтической помощи населению

Республики Казахстан».

Цель работы: Оценка эффективности работы врача-психотерапевта в учреждении онкологического профиля за период 2006 – 2009 гг.

Материалы и методы: В течение рассматриваемого периода врачом – психотерапевтом РОД было принято по рекомендации врачей-онкологов и самостоятельно 5912 больных, из них 1504 в диспансерном отделении, 4408 осмотрами в стационаре.

Психотерапевтическая помощь оказывалась на всех этапах лечения онкологических больных: на этапе диагностики, поступления в стационар, предоперационном, послеоперационном, этапе выписки из стационара, катамнестическом этапе и включала в себя индивидуальную, групповую и семейную мультимодальную психотерапию в сочетании с психотерапией. В зависимости от выраженности психологических нарушений, конкретных целей и запросов пациентов проводилось от 1-го (экспресс-психотерапия) до 15 сеансов.

Оценка эффективности психотерапевтических мероприятий проводилась клинически и по данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS.

Результаты: Субъективное и объективное улучшение психического состояния, снижение уровней тревоги и депрессии после проведенных психотерапевтических мероприятий отмечалось у 85 % получивших психотерапевтическую помощь онкологических больных.

Выводы: Таким образом, нами показано, что в большинстве случаев отмечен позитивный эффект проводимой врачом-психотерапевтом РОД коррекции пограничных психических расстройств у онкологических больных, что способствовало повышению КЖ пациентов. Полученные данные позволяют рекомендовать введение штатной должности врача-психотерапевта и организацию психотерапевтической службы в учреждениях онкологического профиля Республики Казахстан.

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ.

*Сандыбаев М.Н., Суров М.Ю., Алдынгуров Д.К.,
Иванченко Е.В., Жунусов Г.А.*

Региональный онкологический диспансер г. Семей.

Актуальность проблемы: со второй половины XX века «реабилитация» является комплексом мероприятий, направленных на эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов в общество.

Почти 94%, стомированных пациентов – люди, прооперированные по поводу онкологических заболеваний. По данным Всемирной Организации здравоохранения число стомированных пациентов в каждой стране составляет примерно 0,05% – 0,1% от численности населения данной страны. Около 80% из них это люди преклонного возраста.

Материалы работы: по данным амбулаторного отделения Регионального онкологического диспансера г. Семей на «Д» учете с колостомами на начало 2010 года состоят 78 пациентов, из которых 52 (68%) человека жители города, 26 (32%) человека сельские жители.

Цель работы: улучшение качества жизни стомированных больных. Стомированный пациент зачастую не умеет правильно провести уход за стомой, сбалансировать питание, обслужить себя. О том чтобы вернуться к активной социально-трудовой жизни и речи не может идти. По вопросам социальной реабилитации обращаться чаще всего ему не куда. На сегодняшний момент в Казахстане нет литературы для стомированных людей, не налажена централизованная поставка средств индивидуального ухода. Пациентам приходится пользоваться моделями калоприемников устаревших морально. Средства высокого качества для большинства не

доступны.

Необходима служба реабилитации для данной категории людей. В развитых странах мира ассоциации стомированных больных существуют с конца 60-х годов. При правильно спланированном подходе большую часть людей можно адаптировать к новым условиям, вернуть на рабочее место и т.д.

Первым шагом к этому будет создание стома-кабинетов. В них люди получают исчерпывающую информацию по всем вопросам, начиная от питания и заканчивая вопросами семейной жизни. При возникновении сложных социально-трудовых вопросов могут привлекаться психолог, психотерапевт, специалист МСЭ. В наличии будет иметься литература по всем основным вопросам реабилитации и необходимое количество высококачественной продукции позволяющей пациентом чувствовать себя комфортно.

Выводы: Таким образом, возможно, значительно повысить качество жизни и добиться адаптации стомированного человека к новым условиям жизни.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОФОЛА И ТРАМАДОЛА ОНКОХИРУРГИИ.

Раев Г.Б.

*Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК,
Алматы.*

Одним из важных критериев в оценке анестезиологической защиты организма от хирургической агрессии является динамические показатели сердечно-сосудистой системы, в котором отражаются изменения нейровегетативного характера, обусловленные не только операционным стрессом, но и степенью ее антиноцицептивного эффекта.

Комплексное исследование центральной гемодинамики преследовало цель раскрыть патогенетические механизмы реакции кровообращения, наблюдаемые при хирургических операциях в условиях тотальной внутривенной анестезии (ТВА) и на основании изменений охарактеризовать степень адекватности каждого компонента обезболивания.

Были исследованы показатели центральной гемодинамики во время торакальных операций под ТВА у 42 онкохирургических больных в возрасте от 18 до 42 лет. По характеру оперативных вмешательств больные распределялись следующим образом пневмонэктомия-14, трансстернальная трансперикардальная окклюзия культи главного бронха-2, лобэктомия-10, сегментарная резекция – 27 больных. Премедикация была стандартной и включала пероральный прием седативных препаратов на ночь и внутримышечное введение за один час до операции реланиума, атропина, трамадола и нестероидных противовоспалительных препаратов в стандартных дозировках.

Индукцию осуществляли рекофолом $2,91 \pm 0,16$ мг/кг с одновременным введением трамадола $0,14 \pm 0,03$ мг/кг. Поддержание анестезии продолжали инфузией рекофола $3,03 \pm 0,16$ мг/кг/час и болюсным введением трамадола $0,11 \pm 0,03$ мг/кг/час. По ходу операции и наркоза изучали ударный объем крови, минутный объем крови, сердечный индекс, линейная скорость движения крови, мощность левого желудочка, расход энергии на передвижении крови, общее периферическое сосудистое сопротивление, конечное диастолическое давление в левом желудочке. Параметры центральной гемодинамики определялись методом реографии при помощи аппаратно-компьютерного комплекса «Рео-Спектр». У онкобольных несмотря на анемию, интоксикацию и гипопротинемию, средние значения всех гемодинамических показателей до операции соответствовали формальной «норме». У 27% больных зарегистрирован нормокINETический тип, у 48% гипокINETический тип, 23% гиперкинетический тип и 2% коллаптоидный тип кровообращения. Поэтому до 63%

у онкологических больных в предоперационном периоде нуждаются в коррекции функции сердечно-сосудистой системы.

Премедикация существенно не повлияла на показатели центральной гемодинамики. Индукционная доза трамадола вызывало кратковременное статистически недостоверное снижение УОК. УИ. Незначительно повышалось ОПСС, а болюсное введение рекофола уменьшало ОПСС, что приводило к снижению артериального давления на 15%. Течение анестезии на протяжении всего контролируемого периода характеризовалось стабильностью показателей центральной гемодинамики и отсутствием существенных изменений.

Вывод. Таким образом, онкологические операции при ТВА с использованием рекофола и трамадола у онкологических больных сопровождались стабильными показателями центральной гемодинамики.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Рахимжанова Р.И., Майер К.М.

*Национальный научный центр материнства и детства,
г. Астана РК*

Широкий научный и общественный интерес к проблеме рак молочной железы (РМЖ) обусловлен высокой заболеваемостью и смертностью от этого заболевания. Поэтому выявление причин этого явления призвано способствовать предотвращению этого ущерба. Профилактика РМЖ может быть эффективной только при комплексном рассмотрении факторов и условий, способствующих возникновению заболевания. Причинами роста заболеваемости РМЖ являются факторы, имеющих непосредственное отношение к той роли, которую выполняют молочные железы в организме женщин.

Факторы риска повышают шанс заболеть раком. Однако наличие фактора риска или даже нескольких факторов риска не означает, что возникнет рак. Риск может со РМЖ временем измениться за счет, например, изменения возраста или образа жизни.

Факторы риска развития РМЖ (Факторы риска рака и профилактика молочной железы (комплексная оценка) Я.Г. Райхман):

Первый фактор риска - наследственность по материнской линии, то есть наличие РМЖ у родственниц первой степени родства (матери, сестры, тети). Учеными был обнаружен ген, который определяет предрасположенность к РМЖ. Носители этого гена, по различным данным, передают его своим потомкам с вероятностью до 40%. Наличие РМЖ у кровных родственников 1-ой степени родства по материнской линии, увеличивает риск развития онкологических изменений в молочных железах в 4,5 раза.

Второй фактор риска - возраст. Риск возникновения РМЖ увеличивается с возрастом. Около 18% случаев РМЖ выявляется у женщин в возрасте 40-50 лет, в то время как 77% случаев рака диагностируется после 50 лет (Севостьянова О.С., 2006). Возникновению РМЖ способствуют также различные гормональные нарушения. Такие заболевания, как миома, эндометриоз, полипы, нарушение менструальной функции - все это факторы риска.

Больше вероятности заболеть у не рожавших женщин. Отсутствие послеродовой лактации и отказ от грудного вскармливания также может привести в дальнейшем к заболеваниям молочной железы. У женщин, имевших поздние первые роды (в возрасте более 30 лет) или не имевших родов, риск заболеть РМЖ в 2-3 раза выше, чем у рожавших до 20 лет. Каждые последующие роды в возрасте до 30 лет сопровождаются дальнейшим снижением риска. Риск заболеть РМЖ в возрасте до 40 лет в 5,3 раза выше у женщин, рожавших в возрасте >30 лет, чем у рожавших до 20 лет.

Ранние роды не оказывают защитного действия у женщин, имеющих мутации BRCA1 или BRCA2. Рожавшие женщины-носительницы мутаций BRCA1 или BRCA2 существенно чаще (в 1,71 раза) заболевают РМЖ в возрасте до 40 лет, чем не рожавшие. Каждая беременность у них ассоциируется с возрастом риска заболеть РМЖ в возрасте до 40 лет (Портной С.М., 2006).

Целью исследования явилось изучить факторы риска возникновения мастопатии у женщин с гинекологическими заболеваниями. Всего обследованы 2500 женщин, из них в основной группе 1250 больных с диффузной фиброзно-кистозной мастопатией на фоне гинекологической патологии и в контрольной группе 1250 пациенток с гинекологическими заболеваниями без патологии молочных желез. Выявлена прямая корреляционная связь патологии молочной железы с гинекологическими заболеваниями ($r=0,6$) такими как миома матки, гиперплазия эндометрия. Факторами риска развития диффузной фиброзно-кистозной мастопатией у женщин с гинекологическими заболеваниями являются: раннее менархе, альгодисменорея, снижение частоты рождаемости, прерывание первой беременности, выполнение больше трех медицинских аборт, отсутствие послеродовой лактации, наличие экстрагенитальных заболеваний - болезней органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы.

Таким образом, гинекологам необходимо особое внимание уделять на состояние молочных желез и проведение соответствующей патогенетически-обоснованной терапии, как гинекологических заболеваний, так и патологии молочных желез.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА В ОНКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА

Тажединов И., Хан О.Г., Кайназаров Ч.

*Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы,
Республика Казахстан*

Качество и эффективность службы Ядерной медицины связаны с широтой и полноценностью ее внедрения в клиническую онкологию. Ядерная медицина состоит из разделов: Радионуклидная диагностика (in vivo), Радиоиммунные анализы (in vitro) и Радионуклидная терапия. В Республике применяются радионуклидные in vivo и in vitro методы исследования под общим названием Радионуклидная диагностика. Радионуклидная терапия в Республике используется эпизодически, в виде отдельных разработок.

В КазНИИОиР на двухдетекторной цифровой гамма-камере – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) PHILIPS FORTE (2007г) проводится сцинтиграфия различных органов (печень, почки, кости скелета, щитовидная железа, сердце). Разработанные Институтом ядерной физики НЯЦ, прошли экспериментальные и клинические испытания радионуклиды: ^{99m}Tc , ^{131}I , ^{67}Ga , ^{201}Tl , меченые ^{99m}Tc -ДТПА и ^{131}I -гипуран, а также «Гель-генератора ^{99m}Tc ». Освоение технологии производства радиофармпрепаратов, особенно генератора ^{99m}Tc – событие государственной важности, является надежной предпосылкой для дальнейшего развития Ядерной медицины в Республике.

Высокоточный метод РИА также требует особого внимания. В КазНИИОиР проводят исследования по определению специфичных опухолевых маркеров: СА 15-3 для опухолей молочных желез, СА 125 – рака гинекологической локализации, СА 19-9 – рака желудочно-кишечного тракта, ПСА – рака простаты и универсального раковоэмбрионального антигена РЭА.

Если развитие радионуклидной диагностики можно разделить на этапы – до и после появления генераторов короткоживущих радионуклидов (70-ые годы), то с новой эрой можно связывать появление ПЭТ-центров. Впервые в Казахстане Республиканском диагностическом центре г.

Астаны открылся ПЭТ-центр. Современный ПЭТ-центр сложный дорогостоящий комплекс, состоящий из медицинского циклотрона, радиохимической лаборатории и лаборатории радионуклидной диагностики с гамма- и ПЭТ-камерами, совмещенные с КТ. Из циклотронных радионуклидов исследования с ^{18}F , ^{11}C , ^{13}N и ^{15}O с $E_{\gamma}=511$ кэВ проводятся на ПЭТ-камерах, с ^{67}Ga , ^{201}Tl , ^{111}In , ^{123}I с E_{γ} от 93 до 173 кэВ – на гамма-камерах.

ПЭТ-центр административно должен находиться в составе отдела «Ядерной медицины» онкологической клиники, территориально в одном отсеке с единой вентилирующей системой и общим отстойником для жидких радиоактивных отходов, а также с общим хранилищем для твердых и мягких радиоактивных отходов. Штатные нормативы лаборатории радионуклидной диагностики с ПЭТ-центром должны включать кроме врача-радиолога по радионуклидной диагностике и терапии, радиохимика, инженера и дозиметриста.

На нынешних условиях не возможно привлечь новых сотрудников. Работа с повышенной радиоактивностью (жидкие открытые РФП) на сложных в эксплуатации современных гамма-камерах и ПЭТ-камерах. Необходимо увеличить надбавку на зарплату сотрудников за вредность и психоэмоциональную нагрузку, а также восстановить уход на льготную пенсию.

Радионуклидная терапия основана на применении метаболически активных радионуклидов и меченых соединений, избирательно накапливающихся и повреждающих в метаболической активной фазе клеточный механизм злокачественного роста. Для полноценного функционирования Ядерной медицины в Республике необходимо организовать центр радионуклидной терапии. Поскольку в ИЯФ производит выпуск ^{131}I , уже возможна радиойодотерапия больных раком щитовидной железы. В последующем можно организовать радионуклидную терапию больных с метастазами в костях.

НЕНАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК КАК КОМПОНЕНТ КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Танатаров С.З., Жакупов Р.К., Сандыбаев М.Н.,
Есболатов Д.А.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Многокомпонентная анестезия обеспечивает полное и длительное выключение болевой чувствительности лишь при использовании последних в относительно высоких концентрациях, что вызывает нарушение гомеостаза и срыв адаптационных возможностей организма у больных с высоким анестезиологическим риском. Одним из направлений антиноцицептивной защиты стала предупреждающая анальгезия с применением средств системной и регионарной анестезии.

Цель исследования: Изучить анальгетическую эффективность парацетамола на фоне ингаляционной и эпидуральной анестезии.

Материал и методы исследования: Исследовано 35 пациента в возрасте от 43 до 75 лет, оперированных на органах желудочно-кишечного тракта. Объем выполненных операций в обеих группах были однотипными. В операционной на столе перед вводным наркозом вводили шприцевым насосом SEP-10S жидкий парацетамол в дозе 3,3 мг/ч. МВЛ проводили в режиме нормовентиляции с использованием *minimal flow anesthesia* (до 0,4 л/мин). Продленный эпидуральный блок на уровне Th4-6, осуществляли 10% раствором лидокаина. Центральная анальгезия парацетамолом в общей дозе 1 гр. Всем пациентам проводили мониторинг кардиомонитором Nikon Konden - FiO_2 ; ЭКГ с подсчетом ЧСС, АД, пульсоксиметрия; а также исследовали кислотно-основное состояние, К и Na плазмы крови.

Результаты исследования и их обсуждение: К началу основного этапа операции достоверно понизилось АДср,

однако это снижение не превышало в среднем 10% от исходного, что наряду с неизменными значениями общего периферического сосудистого сопротивления свидетельствовало о стабильности гемодинамики. Причины подобной стабильности АД – достоверный рост ударного объема в среднем на 20-30%. Относительное уменьшение ЧСС, отсутствие тахикардии снижает потребность миокарда в кислороде, что обеспечило более благоприятные условия функционирования сердечно-сосудистой системы при комбинированной анестезии. В нашем случае при использовании разработанной комбинированной анестезии ни в одном случае не наблюдалось гипертензии, а также не было выраженных гомеостатических сдвигов при комбинированной анестезии. Прочие показатели, характеризующие основные функции гомеостаза, не имели ухудшения относительно группы сравнения.

Вывод: Анестезия высокотравматичных операций продленным эпидуральным блоком в комбинации с ингаляционной анестезией и использованием парацетамола, обеспечивает значительную глубину анестезии, стабильность гемодинамики и гомеостаза при расширенных операциях в онкологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Танатаров С.З.

Региональный онкологический диспансер г. Семей

Хирургические вмешательства в онкогинекологии являются главным этапом лечения большинства гинекологических больных. Однако расширение показаний к оперативному лечению и увеличение объема вмешательства были бы невозможными без углубленного изучения клинико-физиологических особенностей высокотравматичных и продолжительных операций с соответствующим развитием анестезиологии.

Цель исследования: Оптимизация анестезии внутривенным анестетиком пропофол в комбинации с ингаляционным анестетиком форан при онкогинекологических операциях.

Материалы и методы: Исследовано 37 наркозов, что соответствует и количеству пациентов (возраст от 25 до 65 лет) двух групп, оперированных в отделении мамогинекологии. Группы по полу, возрасту, росту, массе тела, классу ASA и продолжительности были сопоставимы.

После интубаций трахеи подключали ингаляцию форана в дозе 0,3-0,4 об.%. Центральная анальгезия поддерживалась введением субнаркозных доз фентанила. На основной наркоз рекофол вводили шприцевым насосом SEP - 10S в дозе 15-25 мл/ч с параллельной ингаляцией паров форана в дозе 0,3-0,5 об.% и кислорода, для поддержания хирургической стадий наркоза.

Интраоперационно изучали ЭКГ, ЧСС, АД, ЦВД, SpO_2 , FiO_2 , кислотно-основное состояние.

Результаты исследования: При комбинированной ингаляционно-внутривенной анестезии снижения АД мы не наблюдали. На этапах начала основного хода операции достоверно понизилось АДср в обеих группах, однако это снижение не превышало в среднем 5% от исходного, что наряду с неизменными значениями СИ и ОПСС свидетельствовало о стабильности гемодинамических показателей в обеих группах.

Преимущества комбинированной ингаляционно-внутривенной анестезии при онкогинекологических операциях отражены в следующем. При однотипном характере оперативных вмешательств, время восстановления сознания и экстубации трахеи составило в 1-й - 0,33 мин. $\pm 0,11$, а во 2-й группе 1 ч.30 мин. $\pm 1,19$.

Выводы: Ингаляционно-внутривенный наркоз обеспечивает значительную глубину анестезии и достаточную стабильность регуляторных систем и гомеостаза при выполнении высокотравматичных онкогинекологических операций, что по-

звolyет уменьшить расход наркoтикoв в 15,3 раза, а фoрaнa в 1,36 раза, а тaкжe сoкрaщaя пepиoд пpoбуждeния пaциeнтoв в 2,5 раза, а вpeмя пocлeопepaциoннoй ИВЛ - в 1,5 раза.

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Лашкул С.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, г.Алматы

Фактор питания необходимо учитывать при выборе мер профилактики заболеваний различной этиологии, включая онкозаболевания.

Значительная роль в послеоперационном периоде онкобольных отводится продуктам зондового, парентерального и перорального питания. Учитывая основные этиопатогенетические механизмы, лежащие в основе развития онкопатологий был разработан специализированный продукт для послеоперационных больных на соевой основе, богатый полноценным легкодоступным белком, полиненасыщенными жирными кислотами, моно- и дисахаридами, а также витаминами- антиоксидантами и микроэлементами.

Продукт создан на основе соевого молока, сброженного специальными штаммами молочнокислых бактерий с высокой биохимической активностью, с добавлением соевого творога, соевого масла, облепихового и/или шиповникового сиропа, сиропа черной смородины, яблочного пюре, витаминов А, Е, С, фолиевой кислоты, микроэлементов железа, селена, цинка. Назначение специализированного продукта «Унипит-КАП» с целью лечения послеоперационных онкологических больных в мировой практике неизвестно. Соевое молоко и соевый творог, как известно, богаты полноценным, легкодоступным белком, а также низкомолекулярными пептидами. Продукт содержит соевое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами А и Е.

Наличие специальных штаммов молочнокислых бактерий с высокой биохимической активностью препятствует развитию дисбактериоза, возникающего в результате длительного воздействия антибиотиков широкого спектра действия и химиотерапии в период лечения.

Продукт «УнипитКАП» обладает антиоксидантными, иммунокоррегирующими, детоксицирующими и микробиоценоз-нормализующими свойствами.

Основными принципами конструирования спецпродукта для онкобольных были:

- 1) высокая пищевая и биологическая ценность исходного сырья;
- 2) повышенный уровень легкодоступных протеинов, жиров и углеводов;
- 3) антиоксидантная направленность в подборе как сырья, так и пищевых добавок;
- 4) иммуномодулирующая направленность в выборе сырья;
- 5) присутствие микробиоценоз-нормализующих факторов;

Рецептура продукта и технология приготовления продукта проста, удобна с экономической точки зрения. Действие специализированного продукта направлено на повышение защитных сил организма, снижение процессов перекисного окисления липидов, активацию монооксигеназной системы, улучшению функциональной активности желудочно-кишечного тракта, уменьшению токсемии.

Основными принципами или условиями применения продукта «УнипитКАП» в комплексной терапии онкобольных были:

- профилактика дисбактериоза кишечника, нормализация функции желудочно-кишечного тракта в случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения;
- снижение всасывания токсических продуктов рас-

пада;

- снижение свободнорадикального окисления липидов;

- активация иммунологической реактивности и гемопозитической функции организма.

Учитывая вышеизложенное, надо полагать, что лечение онкологических больных с включением специализированного диетического продукта «УнипитКАП» с иммуностимулирующими, детоксицирующими и антиоксидантными свойствами следует отнести к способам патогенетического лечения онкологических заболеваний, поскольку процессы перекисного окисления липидов и нарушение иммунологической реактивности являются одними из ведущих патогенетических механизмов после химио-и лучевой терапии онкологических больных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГАДОВИСТ» И «МАГНЕВИСТ» В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОАДЕНОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Рахимжанова Р.И., Садуакасова А.Б., Байтурлин Ж.Г.

АО Медицинский университет Астаны

Широкое внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным усилением в отечественной медицине сдерживается недостаточной доступностью МРТ-аппаратов и слабой осведомленностью специалистов о высокой диагностической эффективности этого метода.

МРТ молочной железы осуществлялась на МРТ SIEMENS SYMPHONY с резистивным магнитом 3,0 Тл. Для сравнения эффективности МР контрастных веществ (МРКС) 12 женщинам, при их информированном согласии, был введен «Магневист» при первичной диагностике, повторная МР-маммография с введением нового МРКС «Гадовист» (Schering, Германия) проведена через 5 дней в первой фазе менструального цикла.

Диагностика фиброаденомы базируется только на семиотике доброкачественного процесса. Из характерных для МРТ-симптомов следует назвать присущую фиброаденоме и локальному фиброзу изоинтенсивность и однородность гипоинтенсивного сигнала от образования в протоколах T1 и T2ВИ. На T1ВИ фиброаденома имеет гипоинтенсивный сигнал, на T2ВИ сигнал от образования повышенный. Чем больше относительная доля фиброзной ткани, тем ниже сигнал от фиброаденомы. При МРТ до применения пост-процессорной обработки мы получали информацию, позволяющую оценить образование не менее чем по 9 критериям, свидетельствующие в пользу доброкачественной природы образования. Однако, указанные МР-признаки не применимы для всех образований доброкачественной природы, т.к. они не являются единственно возможными для злокачественных образований. Поэтому необходима дополнительная информация, которую мы получали при наблюдении за скоростью нарастания интенсивности МР-сигнала (накопление контрастного вещества) на T1 ВИ и скорости ее снижения (вымывания). Чувствительность МР-маммографии с контрастным усилением при введении Гадовиста больше, чем при использовании МРКС первого поколения («Магневист») за счёт большего релаксационного воздействия. Сравнение двух парамагнитных контрастных средств «Магневист» и «Гадовист» в диагностике фиброаденом установлено, что при времени достижения максимума у двух МРКС от 3 до 5 мин, фаза вымывания «Магневиста» выявлялась к 6-7 минуте, а на кривой изменения интенсивности сигнала от опухоли после введения «Гадовиста» формировалось «плато» с тенденцией к появлению незначительного уменьшения МР-сигнала только к 11-15 минуте.

Таким образом, при исследовании молочных желез показано применение «Гадовист» в виду его большей специфичности.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тулеутаев М.Е., Оразбеков Б.С., Муслим М.М., Жумагазин Ж.Д., Медеубаев Р.К.

Онкологический диспансер г. Астана

Введение: Хронический пиелонефрит (ХП) и вторичный цистит часто осложняют рак мочевого пузыря (РМП) и иногда являются причиной летальных исходов при этих заболеваниях. Поэтому предупреждение и рациональное лечение пиелонефрита и вторичного цистита у больных РМП является весьма актуальной проблемой до проведения специального лечения.

Цель работы: Изучить влияние инфекционно-воспалительных осложнений на течение РМП.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 36 больных РМП, которым было выполнено комплексное обследование и оперативное лечение в онкологическом диспансере города Астаны с 2003 по 2009 г. В основном больные поступали в плановом порядке, только 3 (5,3%) из них были госпитализированы по экстренным показаниям. Основными показаниями для экстренной госпитализации явились: макрогематурия, невозможность самостоятельного мочеиспускания в связи с тампонадой мочевого пузыря (МП) сгустками крови и обострение ХП. Мужчин было 29 (80,6%) и женщин - 7 (19,4%). Возрастной диапазон колебался от 35 до 73 лет и в среднем составил $57,5 \pm 1,3$ года. Симптомы инфравезикальной обструкции наблюдались у 9 мужчин: у двоих с дивертикулезом МП, у одного со стриктурой уретры и у остальных 6 она была вызвана доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Результаты: Подавляющее большинство больных 34 (94,4%) поступили в клинику с инвазивной формой РМП, поэтому многие из них были отягощены его осложнениями. Вторичный цистит был у 27 (75,0 %) больных. Одностороннее нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей имело место у 15 (41,6%) пациентов, двусторонний гидроуретеронефроз у 3 (8,3%). С обострением ХП в клинику поступил 14 (38,8%) пациентов. Хроническая почечная недостаточность 1-2 стадии выявлена у 9 (25,0%) больных РМП, анемия легкой и средней степени тяжести у 12 (33,4%) пациентов.

В дооперационном периоде у 19 (52,8%), больных, несмотря на проводимую антибактериальную терапию, регистрировали бактериурию. Данные о характере микрофлоры мочи, высеянной у них, приведены в таблице 1.

Вид микроорганизмов	Количество больных	
	абс.	%
<i>Escherichia coli</i>	7	36,8
<i>Enterobacter spp.</i>	5	26,4
<i>Enterococcus faecalis</i>	4	21,0
Прочие	3	15,8

Заключение: Инфекционно-воспалительные осложнения часто встречаются у больных РМП. Это обусловлено общим снижением иммунитета при онкологическом процессе, нарушением архитектоники стенки мочевого пузыря, и как следствие, нарушение микроциркуляции с распространением неопластического процесса на устья мочеточников с развитием ретенционных изменений в верхних мочевыводящих путях (ВМП), как правило, сопровождающихся обструктивным пиелонефритом. Поэтому, большое значение приобретает дооперационное дренирование ВМП при наличии гидроуретеронефроза и проведение этиопатогенетического лечения инфекционно-воспалительных осложнений, что, безусловно, улучшает показатели послеоперационной выживаемости у данной категории больных.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Исмаилова Г.Н., Зейтын М.К.,
Ермаханова Г.А., Абдрахманов А.Б.

КазНИИОР, Институт развития здравоохранения МЗ РК

Концептуальная переменная имеет определенные значения, которые в совокупности исчерпывают диапазон возможных изменений. Количество значений переменной практически бесконечно.

Нами проведен социологический опрос населения в 6 регионах Казахстана по изучению мнения изучаемой популяции о культуре безопасности пациентов в медицинских организациях. На основе данного анкетирования сформированы следующие концептуальные переменные: степень информированности пациента; степень ответственности самого пациента; степень удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации. В качестве шкалы измерения использовалась анкета (опросник).

Шкала измерения для концепции «Степень информированности пациента» состояла из вопросов об информировании врачом пациента о состоянии его здоровья, о возможных методах диагностики и лечения, прогнозирования возможных осложнений; о форме получения согласия пациента на проведение мероприятий; о соблюдении пациентом рекомендаций врача; об информировании врачом о правилах приема лекарственных средств и их совместимости; о проведении инструктажа при получении физиотерапевтических процедур; об информировании о мерах предосторожности после инъекций и др.

Шкала измерения для концепции «Степень ответственности самого пациента» включала вопросы о соблюдении пациентом рекомендаций лечащего врача, о приеме лекарств пациентом, не рекомендованных лечащим врачом, об изучении вкладыша (инструкции) лекарственного средства, об информировании пациентом врача о любых аллергических и побочных эффектах от лекарств.

Вопросы, касающиеся создания условий в медицинских организациях для соблюдения личной гигиены; отношении медицинского персонала к пациенту; случаях получения травм в пределах медицинского учреждения объединены в концепцию «Степень удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации».

На основе шкалы измеряемой концепции разработана операциональная определяющая в бальной системе. Например, на вопрос об информированности врачом о состоянии здоровья пациента, методах диагностики и лечения ответу «да, в полном объеме» соответствует 2 балла, это максимальный балл, ответам «да, но не в полном объеме» и «не всегда» - 1 балл, а категорично отрицательные ответы, такие как «нет», «никогда», «не получал» равны 0 баллов.

Оценка степени информированности проводилась следующим образом. Полная информированность пациента составляет 8 баллов и более, средняя информированность - 4-7 баллов, низкая информированность - 0-3 балла.

По такому же принципу распределены баллы по ответам на вопросы, сгруппированные в концепции «степень ответственности самого пациента» оценивалась по совокупности баллов - 10 баллов и более оценивается как высоко ответственный; от 5 до 9 баллов - недостаточно ответственный; безответственное отношение пациента к своему здоровью - 0-4 балла.

Аналогично распределение баллов и по степени удовлетворенности пациента условиями пребывания в медицинской организации. При сумме баллов 5 баллов и выше оценивается как удовлетворительная степень; неудовлетворительная - 0-4 балла.

Таким образом, формирование концептуальных переменных создает методическую основу для оценки уровня

культуры безопасности среди пациентов в медицинских организациях.

ИНДОЛ-3 КАРБИНОЛ В ЛЕЧЕНИИ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тлеугабилова Г.А., Кожамбетов Б.Ш., Абдулаханова Р.Р.,
Есентаева С.Е.

Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей

Актуальность. За последние годы увеличилось число пациенток, обращающихся в различные лечебные учреждения по поводу дисгормональных нарушений молочной железы и доброкачественных опухолей молочной железы. Самым распространенным среди них является мастопатия, встречающаяся у 20-40% женщин в возрасте от 20 до 50 лет.

Индол-3 карбинол – вещество, обладающее способностью к множественной фармакологической коррекции молекулярно-биологических процессов.

Цель работы. Улучшение методов лечения дисгормональных нарушений молочной железы

Материалы и методы. Комплексно обследовано более 270 женщин. Обследование включало клинический осмотр, маммографию (МГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), осмотр гинеколога, консультацию эндокринолога. Выделены группы больных (N=88) в возрасте от 22 до 56 лет со следующими нозологическими формами:

- выраженная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием кистозного компонента -26 (29,5 %);
- выраженная ФКМ с преобладанием фиброзного компонента – 28 (31,8 %)
- диффузная мастопатия (ДМ) с преобладанием железистого компонента (аденоз) – 6 (6,8 %)
- формирующаяся фибroadенома – 28 (31,8 %).

75 (85,2%) больных предъявляли жалобы на боли (масталгии) в молочных железах. Уплотнение в молочных железах пальпировалось у 24 (27,3%), сопутствующая патология была выявлена у 13 (14,8%). Сопутствующие заболевания включали миому матки – 6 (6,8%), тиреодит- 10 (11,4%), узловой зоб – 12 (13,6 %).

В 8% случаев при подозрении на рак проводилась пункционная биопсия с цитологическим исследованием. Больным с сопутствующими заболеваниями проводилось дообследование, включающее анализ крови на гормоны (ТТГ, Т3, Т4, ЛТГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон и пролактин), УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологическое обследование. У 7,4% пациенток было повышенное содержание эстрогена в крови, 2,7% - повышение уровня Т4 гормона щитовидной железы.

Результаты и выводы. Индол-3 карбинол назначался всем больным с мастопатией, фибroadенозом, формирующейся фибroadеномой в течении 3-6 месяцев с динамическим контролем.

Через 3 месяца пациентам был проведен контроль, включающий клинический осмотр, МГ (женщинам старше 35 лет), УЗИ (до 35 лет) и дообследование больным с сопутствующей патологией (анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологический осмотр).

После 3-х месячного курса лечения в ходе комплексного обследования получены следующие результаты. У всех больных ФКМ, ДМ, формирующейся фибroadеномой было отмечено субъективно – уменьшение боли (масталгия), нормализация менструального цикла. Объективно – уменьшение плотности ткани и отека на МГ, уменьшение или полное рассасывание формирующихся аденом по данным УЗИ. Побочные эффекты не наблюдались.

Таким образом, индол-3 карбинол является эффективным

и безопасным средством для нормализации гормонального баланса при различных формах мастопатий, формирующихся фибroadеном. Эффект лечения от применения препарата достигает от 3 до 6 месяцев, что зависит от формы мастопатии и от размера формирующихся фибroadеном, также связано с глубинными механизмами воздействия на регуляцию гормонально- метаболических процессов в организме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г.СЕМЕЙ.

Бекетова Б.Б., Кузнецова Т.В.,
Кротова А.Г., Хамитова Д.А.

Региональный онкологический диспансер г.Семей

Актуальность. Внедрение в практическое здравоохранение эффективной скрининговой диагностики рака молочной железы (РМЖ) – один из возможных путей улучшения результатов этой патологии. Экономическая эффективность скрининга определяется снижением смертности и уменьшением общих затрат на лечение.

Цель работы: Изучить эффективность маммографического скрининга по данным регионального онкологического диспансера

Материал и методы: С 2008 года в региональном онкологическом диспансере г.Семей начато проведение маммографического скринингового обследования женщин в возрастной группе от 50 до 60 лет с интервалом проведения маммографии 1 раз в 2 года. Данное обследование производится на основании приказа МЗ РК от 15.10.2007 № 607. Обследование осуществляется на маммографах: «Alpha ST» (Финляндия, 2006 год) и «Melody B» (Италия, 2004 год). Исследование у менструирующих женщин выполняется с 5-го по 12-й день менструального цикла.

В ходе скрининга маммографическому исследованию за 2008 -2009 годы были подвергнуты 8608 (80,3%) женщин из запланированных 10711. Патологии молочных желез не обнаружено у 4947 (57,5%) женщин. Им рекомендовано самообследование и регулярный осмотр молочных желез с профилактической целью в медицинских учреждениях и повторная маммография через 2 года. Патологические образования в ткани молочной железы выявлены у 3661 (42,5%) женщин. У 2531 (69,1%) пациенток эти образования имели диффузный невыраженный характер, им не требовалось дообследование и рекомендовано диспансерное наблюдение у маммолога. Для уточнения характера патологического процесса в дополнительном обследовании нуждались 1130 (30,9%) женщин. В онкодиспансер для дальнейшего обследования обратилось 854 (75,5%) женщин.

Результаты и выводы: При дополнительном исследовании диффузные изменения отмечены у 591 (69,2%). Чаще всего они были представлены диффузной фиброзно-кистозной мастопатией. Узловые образования диагностированы у 263 (30,8%) пациенток, из них фибroadеномы у 165, узловые мастопатии у 98. Секторальная резекция молочной железы выполнена 128 (48,7%) женщин, при которой данных подтверждающих злокачественный процесс не получено. Подозрение на рак молочной железы на основании маммографического исследования выставлен у 82(0,9%) женщин, из них у 29 (0,3%) женщин диагноз был подтвержден морфологически.

В Казахстане маммографический скрининг данной возрастной категории женщин идет 2 года и конечно делать выводы еще рано, однако уже сейчас видно, что выявляемость ранних стадий рака молочной железы стало больше.

Таким образом, проведение маммографического скрининга, несомненно, является неотъемлемым мероприятием в борьбе с раком молочной железы.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕКСАНА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бектурсынов С.М.

Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган

Цель работы: Является улучшение микроциркулярной крови, а также улучшение ближайших и отдаленных результатов лечения РМЖ путем предупреждения макро и микротромботических осложнений в процессе комбинированного лечения.

Материалы и методы: Обоснованного проведения в раннем послеоперационном периоде антитромботической терапии с целью снижения частоты тромбоэмболических осложнений и одновременно такая терапия может иметь противорецидивный и антиметастатический характер. Наблюдались 125 больных, которым проведена в раннем послеоперационном периоде антитромботическая терапия клексан при РМЖ с II-III A стадией заболевания (I группа). Контролем служила группа больных РМЖ у 20 лиц

Результаты лечения: Общая пятилетняя выживаемость 81,0 %. В показателях свертывающей и противосвертывающей системы крови наибольшие динамические различия наблюдаются на 7 сутки послеоперационного периода: - снижается тромбиновое время (сек.):

- тромбиновое время - 40,1, 35,6, 31,1 (сек) соответственно. Возрастает содержание свободного гепарина - 6,7, 7,1, 7,9 и - фибринолитическая активность (%) - 20,1, 20,5, 26,7 соответственно

Выводы: Применение антикоагулянта клексана в послеоперационном периоде снижает активность коагулирующего потенциала крови и послеоперационная химиоантикоагулянтная терапия приводит к улучшению показателей выживаемости.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ.

Тулеутеев М.Е., Оразбеков Б.С., Жанабекова Ж.Ж.

Онкологический диспансер г.Астана

Введение: У большинства женщин после установления диагноза развивается тяжелый психологический стресс: здесь и страх перед калечащей операцией (удаление груди), и необходимость пройти через трудное лечение и непереносимость нового знания о себе как онкологической больной. Бывает и так, что перед выбором делать операцию (удалять грудь) или не делать (оставлять опухоль и жить с ней) некоторые женщины могут сделать выбор в пользу последнего, так как боятся потерять женскую привлекательность, сексуальность, а значит, есть вероятность распада семьи, если она была, или невозможность создать ее. На этом фоне после удаления груди многие женщины испытывают чувство неполноценности, ущербности, тревожные состояния, которые могут доходить до депрессии. Профилактика подобных состояний, включающая оказание своевременной психологической помощи до операции и психологическое сопровождение после мастэктомии, является актуальной проблемой в лечении женщин с раком молочной железы.

Цель работы: выявить состояние тревожности и депрессии, обусловленные удалением молочной железы.

Материалы и методы: было опрошено 56 женщин от 30 до 60 лет средний возраст которых составил $47 \pm 2,3$ лет, перенесших операцию по удалению груди, проходящих комбинированное или комплексное лечение в онкологическом диспансере г.Астаны по экспресс-методике «Тид» (тревожность и депрессия) для оценки психического состояния женщин.

Результаты: большинство женщин 42 (75%) по итогам диагностики набрали алгебраическую сумму коэффициентов,

свидетельствующей о выраженной психической напряженности, тревожности, депрессии. Ее пограничные значения характеризуют 9 (16%) женщин. Промежуточные значения (говорящие о неопределенности данных) имели 5 (9%) пациенток. Никто из тестируемых женщин (0%) не набрал сумму коэффициентов, свидетельствующую о хорошем психическом состоянии.

Закключение: таким образом, многие женщины после радикальной мастэктомии находятся в состоянии тревожности и депрессии, проявляющихся в ослаблении тонуса жизни и энергии, в снижении фона настроения, сужении и ограничении контактов с окружающими, наличии чувства безрадостности и одиночества. Поэтому так важна реабилитация женщины после оперативного вмешательства. Нужно поддержать и уверить ее, что это не конец жизни, а один из ее новых этапов. Конечно, при этом качество жизни меняется, нужно привыкать к новому телу, к новому образу жизни. Большое значение здесь имеет поддержка мужа, семьи, друзей, принимающих ее такой, какая она есть, групп поддержки (пациентов со сходным диагнозом).

ПЕРВИЧНОЕ ДВОЙНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Чорманова Р.Р., Харламов В.В.,

Жунусова А.Ж., Садыков М.С.

РГП ЦКБ УД ПРК г.Алматы

Рост заболеваний толстой кишки у лиц пожилого и старческого возраста, омоложение колоректального рака, требует совершенствования диагностических методик

В этой связи особенно актуальна предложенная в 1961г. Wellin методика рентгенологического исследования толстой кишки, названная автором одномоментным двойным контрастированием. Внедрение в практику фиброколоноскопии значительно расширило возможности диагностики заболеваний толстой кишки. Однако, сужения просвета кишки опухолью, резкие изгибы в некоторых отделах и другие факторы ограничивают возможность эндоскопического метода в изучении состояния ободочной кишки на всем ее протяжении. При локализации опухоли в правой половине толстой кишки провести фиброколоноскоп до участка поражения удастся не всегда.

В то же время наличие сопутствующих заболеваний, снижение функциональных и компенсаторных возможностей у пациентов ограничивают возможности рентгенологического метода исследования толстой кишки. У пожилых ослабленных больных ирригоскопию по общепринятой 3-х фазной методике (тугое заполнение, опорожнение, раздувание) выполнить зачастую затруднительно. Выбор вида оперативного лечения зависит от точных представлений о местной распространенности процесса, состояния других отделов толстой кишки, характере роста опухоли и других факторов.

Материалы и методы исследования

Усовершенствование методики ирригоскопии с первичным двойным контрастированием предполагает разработку устройства для выполнения ирригоскопии по усовершенствованной методике.

Техническое устройство для выполнения ирригоскопии состоит из аппарата Боброва емкостью 1 литр и дополнительного сосуда для эвакуации избыточной взвеси. Емкость с бариевой взвесью находится в горизонтальном положении в узкой коробке. При положении отогнутой трубки «вниз» (при погружении ее в контрастное вещество) нагнетается бариевая взвесь, при положении загнутой трубки «вверх» (конец трубки находится над уровнем контрастного вещества) нагнетается воздух.

Аппарат Боброва соединен с сосудом для эвакуации избыточной взвеси. и одноразовым наконечником эластичными резиновыми шлангами через тройник. Во время исследования сосуд для эвакуации взвеси бария находится ниже трохо-

скопа. Для прекращения продвижения взвеси или воздуха используются зажимы.

Рентгенологическое исследование толстой кишки по усовершенствованной методике проводилось нами в условиях стационара и поликлиники. Особенности методики являются порционное попеременное введение бариевой взвеси и воздуха. Введение вышеперечисленных контрастных сред чередуется в процессе исследования с периодической их эвакуацией. Подготовка толстого кишечника к исследованию осуществляется в два этапа: вечером в 21 час выполняется две очистительные клизмы теплой водой (1-1,5 литра) с интервалом в один час. Утром за два часа до исследования выполняется так же две клизмы в выше обозначенном режиме.

После введения наконечника, в положении больного на левом боку, снимается зажим со шланга от нагнетающего устройства. Под минимальным давлением вводят 100-150 мл бариевой взвеси и воздуха до заполнения прямой кишки. И дистального сегмента сигмовидной кишки. Производится рентгенография указанных отделов в прямой, косых, боковой проекциях в условиях дозированного заполнения, частичного опорожнения и двойном контрастировании. Затем попеременно вводится бариевая взвесь и воздух до заполнения всех отделов толстой кишки под контролем просвечивания. При равномерном контрастировании всех отделов толстой кишки больного поворачивают на правый бок и выполняют снимок в латеропозиции на пленке 30×40, затем эвакуируют контрастное вещество из прямой кишки в сосуд для сбора избыточного контраста и вынимают наконечник. Больного поворачивают на левый бок и выполняют второй снимок в латеропозиции. Третью рентгенограмму выполняют в вертикальном положении больного у стойки. На этом исследование заканчивается и больной идет в туалет. После проявления рентгенограмм при необходимости выполняются прицельные и обзорные снимки. Время просвечивания занимает не более 2-х минут, все исследование занимает не более 10 минут. На одно исследование необходимо до 400 мл бариевой взвеси.

Нами выполнено 25 исследований методом первичного двойного контрастирования. Были обследованы пациенты в возрасте от 25 до 80 лет и старше. Преобладали пациенты старше 70 лет. В возрастной группе от 25 до 47 лет у 4 пациентов патологических изменений со стороны толстого кишечника выявлено не было. Дивертикулы сигмовидной кишки выявлены у 4 пациентов. Удлинение сигмовидной кишки у 3 пациентов. Баугинит – 2 пациента. Полип нисходящего отдела толстой кишки – 1 пациент. У 10 пациентов дискинезия левых отделов, колит. Рак ректосигмоидного отдела – 1 пациентка.

Результаты. Таким образом, разработка новых и совершенствование известных рентгенологических методик ирригоскопии, к которым относится методика первичного двойного контрастирования, с целью повышения информативности, облегчения переносимости процедуры пожилым и ослабленным больным, является весьма актуальной. Основным достоинством предложенной методики является сочетание «тугого» наполнения и двойного контрастирования, позволяющего фиксировать внутрисстеночную инфильтрацию кишки в ее начальных проявлениях с помощью определения состояния контура кишки и толщины стенки. Двойное контрастирование позволяет получить исчерпывающую информацию о слизистой кишки, которая при отсутствии в ней изменений (небольших полиповидных образований, изъязвлений) должна быть полностью разглажена и лишена складчатости. При эндофитном росте опухоли в просвет кишки совершенно отчетливо визуализируется дополнительная тень. Отчетливо видны ее контуры. При внутрисстеночном поражении опухолью дифференцируется сужение просвета кишки и соответственно этому неровность контура на небольшом протяжении. При двойном контрастировании на

этом уровне выявляется утолщение стенки. При наличии изъязвления в инфильтративно измененном участке стенки, отчетливо дифференцируется «краевой дефект».

Основная цель предложенной методики состоит в улучшении рентгенологической диагностики рака прямой и ободочной кишки.

На основе рентгеноанатомических сопоставлений открывается возможность визуализации рентгенологических признаков заболеваний толстой кишки, выделение рентгенологических симптомокомплексов, косвенно свидетельствующих о состоянии стенки кишки. Открывается возможность высокой информативности усовершенствованной методики ирригоскопии в изучении состояния всех отделов толстой кишки. Применение предложенной усовершенствованной методики позволяет экономить материальные средства (контрастное вещество), сокращает время исследования, снижает лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.

Выводы. Усовершенствованная методика рентгенологического исследования толстой кишки проста в исполнении, легко переносится больными и может с успехом применяться как в стационаре, так и в поликлинических условиях.

Одномоментное двойное контрастирование – один из оптимальных методов традиционной рентгенологии в диагностике ее опухолевых поражений.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

Шелякина Т.В., Гагагажеева З.М.,

Канторова А.А., Евлаева М.И.

РНИОИ г. Ростова-на-Дону, Ингушский РОД

Актуальность: Онкогинекологическая патология характеризуется опасной тенденцией – ростом заболеваемости раком молочной железы (РМЖ), яичников (РЯ), шейки (РШМ) и тела матки (РТМ), у женщин моложе 50-ти лет, причем треть больных на этапе морфологической верификации имеет распространенные формы.

Общепринятые профосмотры дают низкую выявляемость, а наиболее важный фактор в лечении данного рака – своевременная диагностика.

Цель работы: Разработка наиболее эффективных организационных форм для скрининга рака репродуктивных органов.

Материалы и методы: Ретроспективное эпидемиологическое исследование в группе больных РШМ, РТМ, РЯ, РМЖ и здоровых лиц, социальные (анкетирование), организационные (Открытый прием (ОП) женского населения), клинические (дообследование), математико-статистические.

Результаты: На основе полученного информационного веса каждого признака (с помощью χ^2) установлены факторы онкологического риска (для каждой локализации и общие). Разработаны диагностические карты для каждой локализации и внедрены на ОП в Ингушском РОД.

При обследовании 332 женщин – 250 (78%) были включены в группы онкологического риска. Изучена мотивация обращения женщин на ОП. Основным ориентиром в формировании этих групп явились карты диагностических коэффициентов.

В целом выявлено 17 случаев рака: 4 - РШМ (II-III st. – 2; III-IV st. – 2, 2 - suspicio), 6 - РТМ (II st. – 2; II-III st. – 2; III-IV st. – 2 и 3 - suspicio), 3 - РЯ, 4 - РМЖ (II st. – 2), составляя: 7,0% к группе риска и 5,0% ко всем женщинам, обратившимся на ОП. В целом был выявлен рак у 10 пациенток - II-III st, 7 - III-IV st.

Также выявлено 63 случая доброкачественных опухолей, которые ранее не подвергались лечению (30% к группе риска и 21,6% к женщинам, обратившимся на ОП), и 120 случаев с хроническими воспалительными заболеваниями.

Выводы: Организация ОП населения позволила женщинам беспрепятственно обращаться к высококвалифицированному специалисту, а диагностические карты - более организованно и точно определить женщин, которым необходимо дальнейшее наблюдение и обследование в онкодиспансере.

ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ РЕНТГЕН СНИМКОВ

*Чорманова Р.Р., Харламов В.В.,
Садыков М.С., Жунусова А.Ж.
ЦКБ УДП РК, г. Алматы*

Цель работы: Получение высококачественных рентгенологических изображений в цифровом виде, компьютерной обработкой с классических рентгеновских аппаратов.

Материалы и методы: Обследования проводились на аппаратах SIEMENS R100, «Полиомобиль плюс» и цифровой приставке CR-30X, с различными локализациями, в различных положениях и проекциях.

За короткий промежуток времени было проведено 558 исследований на цифровой приставке, при этом рентгенография органов грудной клетки - составила 105 исследований, рентгеноскопия желудка - 71, рентгенография костей - 262, мочевого выделительной системы - 66 (обзорная и экскреторная урография, восходящая цистография) и прочие - 54 исследования. К прочим исследованиям мы отнесли такие исследования, как придаточные пазухи носа, метросальпингография и фистулография.

Результаты: Цифровое рентгеновское изображение позволяет рентгенологам проводить более точную и детальную дифференциальную диагностику заболеваний, например, один снимок органов грудной клетки позволяет увидеть почти все ткани разной плотности: от мягких тканей до костной структуры. При этом возможно увеличивать отдельные интересующие участки рентген снимка (зона интереса), вносить надписи и комментарии, делать всевозможные замеры, расстояния, углы. Резко снижается расход рентгеновской пленки. Обработанные снимки хранятся в цифровом виде и при необходимости могут быть распечатаны. Цифровые рентгенограммы могут пересылаться по сети в архив, другое отделение, другую больницу и по Интернету, а так же записаны на любой цифровой носитель.

CR – система, устанавливается в любом амбулаторном и стационарном рентгенологическом кабинете, где она может оцифровать любой снимок сделанный с любого имеющегося аналогового рентген аппарата, палатного и переносного. При этом для установки CR – системы не требуются дополнительные изменения уже работающих рентгеновских аппаратов, столов и помещений, более того, внедрения этого комплекса позволяет полностью отказаться от темной комнаты и мокрой проявки. Тем самым улучшая условия работы среднего медицинского персонала.

Выводы: Цифровая обработка рентген-снимка незаменима в условиях поликлиники, реанимации и неотложной скорой помощи, так как многократно уменьшается время, затраченное на получение готового изображения и нет бракованных снимков связанных с неправильным выбором режима съемки.

Современные технологии с математическим модулированием рентген снимка уменьшают лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.

Изменение яркости, контрастности, размеров теней в негативном и позитивном рентген изображении улучшают качество снимка, увеличивают диагностические возможности, облегчают интерпретацию рентген-снимков, что повышает эффективность лечения.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

*Харламов В.В., Чорманова Р.Р.,
Жунусова А.Ж., Садыков М.С.
РГП ЦКБ УД ПРК г.Алматы*

Опухоли тонкой кишки встречаются с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Встречаются достаточно редко – 1,364% (В.И.Ягудина 1972г) всех опухолей пищеварительной системы. При этом на злокачественные опухоли приходится примерно 70%, доброкачественные – 30%.

Цель исследования: сообщить о редкой патологии.

В диагностике опухолей тонкой кишки особое место занимает рентгенологический метод исследования. При контрастировании бариевой взвесью обнаруживается сама опухоль, ее размеры, уровень и размеры пораженного участка кишки. По данным Ю.Н.Соколова и В.Б.Антоновича доброкачественные опухоли локализуются равномерно с одинаковой частотой по всему желудочнокишечному тракту, при локализации в тонкой кишке чаще единичные, реже множественные. Могут быть с эндофитным ростом, исходящим из слизистой оболочки, подслизистого слоя. С экзофитным ростом, исходящим из мышечного и серозного слоев. Для доброкачественных опухолей характерен рост в виде одиночного узла, могут иметь широкое основание или быть «на ножке». Нередко экзофитные опухоли достигают больших размеров, нежели эндофитные.

Материалы и методы. Нами представлено наблюдение фибромы луковицы двенадцатиперстной кишки. Эти опухоли возникают в подслизистом слое из фибробластов и коллагеновой ткани, локализуются в начальном или конечном отделе кишечника.

Пациентка (Е. 1947г.р.) обратилась с жалобами на дискомфорт после приема пищи, отрыжку, потери веса не отмечала. Перешла на дробное питание малыми порциями. В анамнезе - холецистэктомия, свои жалобы связывала с перенесенной операцией.

При рентгенологическом исследовании желудка в луковице двенадцатиперстной кишки выявлен дефект наполнения овальной формы, размером 2,0×2,5 см., при этом бариевая взвесь дугообразно обтекала данное образование, имеющее ровные, четкие контуры, без дополнительных включений. Выход контраста в двенадцатиперстную кишку сохранен.

Пациентка направлена на эндоскопическое исследование с заключением «доброкачественная опухоль луковицы двенадцатиперстной кишки». При эндоскопическом исследовании выявлено подслизистое образование луковицы двенадцатиперстной кишки (фиброма). Биопсия: полиповидное разрастание с участками умеренной дисплазии в подслизистом слое, фиброзирование с лимфоидной инфильтрацией. От предложенного оперативного лечения пациентка отказалась.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ KI-67 ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ.

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

При раковой трансформации ткани эндометрия в структурных изменениях участвуют все элементы обмена клетки, что позволяет учесть все количественные и качественные сдвиги на молекулярном уровне. Одним из таких маркеров является антиген Ki-67, характеризующий активность или агрессивность пролиферативного процесса в раковой ткани.

Экспрессия антигена Ki-67 была определена в опухолях 131 больных раком тела матки: 119 эндометриоидных и 12 неэндометриоидных.

Индекс Ki-67 в неэндометриоидных опухолях тела матки

находился в интервале от 19% до 62%, среднее значение Ki-67 в неэндометриоидных опухолях тела матки составило $36,2 \pm 6,6\%$. В эндометриоидных аденокарциномах минимальное значение индекса Ki-67 равнялось 15%, а максимальное - 70%, составив в среднем $41,37 \pm 1,8\%$. При сравнении средних значений индекса Ki-67 в эндометриоидных и неэндометриоидных опухолях матки при помощи статистически значимых различий не обнаружено ($p > 0,05$). Не выявлено статистически достоверных различий в уровне индекса Ki-67 в железистых и железисто-плоскоклеточных раках тела матки ($40,9 \pm 1,7\%$ против $44 \pm 3,8\%$, $p > 0,05$).

Сравнение средних значений Ki-67 показывает, что наименьшее значение этого маркера наблюдается в неэндометриоидном раке - $36,25 \pm 6,6\%$ наибольшее - при железисто - плоскоклеточном $44 \pm 3,8\%$. Среднее значение Ki-67 для всех видов РЭ составил $40,7 \pm 3,8\%$. Таким образом, железисто-плоскоклеточная форма рака эндометрия отнесена в группу с неблагоприятным исходом.

Индекс пролиферации зависел от возраста больных раком эндометрия. У больных моложе 50 лет высокая пролиферативная активность Ki-67 имела место у 16,7%, в группе 51-60 лет отмечалась наиболее высокая частота пролиферативной активности Ki-67 - 67,3%, а у больных старше 60 лет показатель Ki-67 > 42% составил 44,9%.

Проллиферативная активность является ведущим фактором как в механизме злокачественной трансформации клеток, так и в биологическом поведении уже возникших опухолей. Ki-67 прямо коррелирует с возрастом больных, степенью гистологической злокачественности опухоли. Кроме того, пролиферативный индекс служит независимым прогностическим показателем 5-летней выживаемости пациентов.

РОЛЬ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ

Эшонов А.К., Джурарев Ф.М.

*Онкологический научный центр Узбекистана,
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент*

Цель: Улучшить непосредственные результаты хирургического лечения рака желудка.

Материалы и методы: Изучено значение раннего зондового питания после операции гастрэктомии (ГЭ) у 64 больных раком желудка III-IV стадии. Всем больным во время операции проведен назоюноанальный зонд с внутренним диаметром 5 мм через эзофагоюноанастомоз и установлен на 30-35 см ниже Браунского анастомоза. Питание через назоюноанальный зонд начали на 3 сутки после. С 3 суток капельно вводились различные жидкие питательные смеси в объеме до 500 мл в течение 4-5 часов. На 4 сутки количество вводимой смеси довели до 800 до 1000 мл, а начиная с 5 суток в среднем 1,5 литра. Данная процедура продолжалась до 8 суток после операции. Контрольную группу составили 78 больных после ГЭ, которым энтеральное питание проводилось с 7-8 суток после рентгенологического контроля состояния пищеводно-кишечного анастомоза. Непосредственные результаты энтерального зондового питания в обеих группах изучали по критериям:

1) По уровню белковой, липидной фракции и иммунного статуса в послеоперационном периоде.

2) По частоте гнойно-септических осложнений.

3) По сроку ранней активизации больных после ГЭ.

Результаты: В основной группе явления гипопротеинемии, которые обычно снижаются, начиная с 2-3 суток, держались весь послеоперационный период стабильно на уровне 66-74 г/л. Холестерин на уровне 3,70-5,82 м. А в контрольной группе отмечалось угнетение общего белка гипопротеинемии и гипохолестеринемии на уровне 60,2 - 65,2 г/л и 2,82 - 3,75 соответственно. Изучение восстановления иммунной системы в основной группе показало, что она происходит в

ближайшее время после операции и на 9-11 дней раньше, чем в контрольной группе. В основной группе с учетом общего состояния больных физическая активизация начата на 4 сутки, а в контрольной группе на 7-8 сутки, что отрицательно сказывается на общем состоянии пожилых больных с нарушением сердечно-сосудистой и легочной системы. Частота гнойно-септических осложнений в целом по основной группе встречалась у 7 (10,9%) больных, а в контрольной группе у 13 (16,6%) больных ($P < 0,05$).

Вывод: Раннее энтеральное питание после операции достоверно улучшает белковую и липидную фракции организма, восстанавливает иммунную систему, способствует ранней физической активности и уменьшает частоту гнойно-септических осложнений.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИФЕРИЛИН 11,25 МГ ПРИ РПЖ.

Шатковская О.В.

Городской онкологический диспансер город Алматы.

Рак предстательной железы (РПЖ) относится к наиболее часто выявляемым опухолям среди онкологических заболеваний у мужчин, диагностируется у пожилых пациентов, реже - у мужчин до 40 лет. В г. Алматы доля рака простаты в структуре заболеваемости мужского населения растет. В структуре онкологической заболеваемости на долю урологических локализаций приходится 9,4%, из них - 32% - рак предстательной железы (РПЖ) - 2009г.

Прирост абсолютного числа заболевших в 2003-2009 годах по РПЖ составил 104%.

На стадии генерализованного опухолевого процесса гормонотерапия является ведущим и эффективным вариантом лечения. При локализованном (II стадия) и местнораспространенном (III стадия) раке предстательной железы гормональная терапия также может применяться. Основной целью проведения неoadъювантной и адъювантной гормонотерапии является увеличение общей и безрецидивной выживаемости больных РПЖ, но в различных клинических ситуациях гормонотерапия решает различные задачи.

Одним из ключевых звеньев в гормональной терапии РПЖ являются агонисты ЛГРГ - трипторелин, гозерелин.

В Городском Онкологическом Диспансере (ГОД) г Алматы при лечении распространенного рака предстательной железы применяется представитель агонистов ЛГРГ - Диферилин 3,75 мг (трипторелин). Это синтетический декапептид, аналог природного гонадотропин-рилизинг-гормона. Механизм его действия основан на подавлении секреции гонадотропина и функции гонад.

В течение 2009 года на базе ГОД г.Алматы применялась новая - трехмесячная форма Диферилин 11,25 мг, препарат вводился 1 раз в 3 месяца, что позволяло снизить количество посещений пациентов врачом, при этом качество их жизни улучшилось, а течение самого заболевания оставалось под контролем специалистов.

Диферилин 11,25 мг употреблялся у 35 пациентов с распространенным раком предстательной железы (РПЖ). Все пациенты были с впервые установленными диагнозами. Возраст - от 65 до 75 лет. Каждый пациент получил по несколько инъекций. Наблюдение за больными проводилось в амбулаторном порядке.

В результате применения Диферилин 11,25 мг у пациентов с РПЖ к концу первого месяца наблюдения были достигнуты кастрационные значения уровней тестостерона и ПСА в крови, снижение костного болевого синдрома и дизурических явлений. Эти эффекты сохранялись в течение всего временного промежутка.

Клинически значимых побочных явлений за период наблюдения у больных, получавших Диферилин 11,25 мг, не

отмечалось.

В целом применение препарата было надежным и эффективным. У пациентов наблюдался стойкий кастрационный эффект на фоне хорошей переносимости терапии. Данная форма лекарственного средства была удобна как для больного, так и для врача.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕМОДАЛА (ТЕМОЗОЛОМИД) В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы

Актуальность. В республике Казахстан ежегодно регистрируется до 50 первичных случаев заболевания опухолей головного мозга (ОГМ) у детей, что составляет 20-25% среди всех солидных новообразований. Злокачественные глиомы (ЗГ) – анапластическая астроцитома (АА) и мультиформная глиобластома (МГБ) составляют от 7 до 11% среди всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей. Отмечается рост заболеваемости с опухолями ЦНС у детей. Так в 2000 году заболеваемость с ОГМ составила 18,2%, в 2009 году – 20,2%.

Общепринятым лечением ЗГ является максимальное удаление опухоли, проведение постоперационной лучевой терапии (ЛТ) и применение различных схем химиотерапии.

Неудовлетворительные результаты и высокая токсичность применяемой химиотерапии явились причиной создания нового препарата с улучшенной переносимостью и простотой применения, который может быть использован в комбинации с другими препаратами или с ЛТ. Темодал – новое алкилирующее цитотоксическое соединение группы имидазотетразинов, проявляет высокую противоопухолевую активность *in vitro* и *in vivo* в отношении АА и МГБ [1-7]. В клинических исследованиях он показал 100% биодоступность при пероральном применении и хорошую проникающую способность через гематоэнцефалический барьер в ЦНС [2,3,8,9].

В мультицентровых исследованиях у взрослых пациентов с рецидивирующими глиомами была продемонстрирована эффективность темодала. У пациентов с рецидивом АА объективный ответ отмечался в 35% случаев. Годичная выживаемость составила 56%. В рандомизированном исследовании у больных с МГБ при сравнении темодала и прокарбазина, темодал по всем показателям оказался более эффективным. Полученные результаты свидетельствуют о несомненной активности темодала по отношению к ЗГ [10, 11, 12]. В последние годы наиболее хорошо зарекомендовала себя схема лечения, сочетающая лучевую терапию с применением темодала. Эффективность данной схемы была доказана в ряде исследований. По данным С.Сурго с соавт. применение темодала у взрослых больных после нерадикальных операций по поводу остаточной опухоли или рецидива глиом высокой степени злокачественности в сочетании с лучевой терапией, оказалось более чем в 3 раза эффективнее по сравнению с монотерапией темодалом [13,14, 15].

О.Г.Желудкова с соавт. демонстрируют эффективность темодала в лечении детей с АА и МГБ и при прогрессировании заболевания после предшествующего лечения [16].

Цель: изучение эффективности Темодала в лечении злокачественных глиом головного мозга у детей.

Объект и методы исследования: в отделении детской онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии с 2005 по 2009 гг. в исследование были включены 31 детей с ЗГТМ в возрасте от 3 до 17 лет, первым этапом, которым, проведены хирургическое лечение в отделении нейрохирургии №7 ГКБ г.Алматы и ННЦ нейрохирургии г.Астана. Характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Объем хирургических вмешательств- 8 больным произ-

Таблица 1. Характеристика больных

Характеристика больных (n=31)	Число больных
Возраст, годы:	
разброс	3–17
медиана	8,9
Гистологический вид опухоли:	
анапластическая астроцитома	20 (64,5%)
мультиформная глиобластома	11 (35,5%)
Пол:	
мальчики	18 (58,1%)
девочки	13 (41,9%)
Объем хирургического лечения:	
«тотальное»	8
субтотальное	19
Биопсия опухоли	4

ведено «тотальное», 19 пациентам субтотальное удаление опухоли и 4 больным – биопсия опухоли. Диагноз у всех подтвержден морфологический. Гистологическая структура опухоли: анапластическая астроцитома – 20, глиобластома – 11 больных.

До начала терапии качества жизни больных по шкале Карновского от 40 до 60%.

Перед началом лечения и после каждого этапа терапии, а так же после завершения лечения в сроки 6, 12 и 18 мес. проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с контрастным усилением. Исследование показателей периферической крови проводилось еженедельно и в динамике после каждого курса химиотерапии. При оценке ответа на терапию использовали стандартные критерии: полный ответ (CR) – полное отсутствие опухоли, частичный ответ (PR) – уменьшение размера опухоли более 50%, стабилизация процесса (SD) – уменьшение размера опухоли менее 50%, прогрессирование процесса (PD) – увеличение размеров опухоли более 25% или появление новых очагов. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии выполнялись клинический, неврологический и офтальмологический осмотры.

Лечение: Операция → ЛТ + ХТ (темозоломид + ломустин = 1 цикл) → 6 циклов ПХТ (темозоломид + ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе, на 14-21 дни после операции, до СД= 50- 55 Гр., РД= 1,8 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился цикл ХТ: темозоломид- 150 мг/м² - 1-5 дни; Ломустин – 120 мг/м² - 1 день + гормональная терапия. В дальнейшем 6 циклов ХТ по выше указанной схеме с интервалами в 6 нед. + сопроводительная терапия.

Результаты: 26 больным проведены и завершены все этапы терапии. В процессе и после завершения химиолучевого этапа терапии у 29 (93,5%) больных значительно купированы патологические неврологические симптомы, отмечены улучшение качества жизни: по шкале Карновского от 50-100%. У 2 (6,5%) пациентов с МГБ в процессе ХЛЛ отмечены ухудшение состояния и были исключены из исследования. Общие токсические проявления: головная боль, общая слабость, кратковременная гипертермия, а так же тошнота, рвота отмечена у всех пациентов, в основном II-III ст., и на фоне сопроводительной терапии были легко купируемые.

Гематологическая токсичность: лейкопения II-III ст. наблюдалась у 12 (38,7%) больных, тромбоцитопения II степени – у 8 (25,8%) пациентов, в основном после первого этапа терапии. Показатели периферической крови к началу цикловой ХТ нормализовались. Признаков органной и кумулятивной токсичности не наблюдалось.

По данным контрольного МРТ головного мозга с контрастным усилением, после ХЛЛ у 3 (10,3%) больных отмечены увеличение размеров опухоли, а у 26 детей (89,6%) достигнуто объективный ответ: CR- 7 (24,1%), PR- 14 (48,3%) SD- 5 (17,3%). В процессе цикловой ХТ 3 больных из-за прогрессирования заболевания переведены на симптоматическую терапию. После завершения протокола лечения по данным

контрольного МРТ головного мозга с контрастным усилением у 7 (26,9%) пациентов достигнута – CR, PR- у 9 (34,6%) SD – у 6 (23,1%) и у 4 (15,4%) больных – CR. Одногодичная выживаемость составила $83,9 \pm 6,6\%$, безрецидивная – $71 \pm 8,3\%$. 3-летняя выживаемость составила $57,7 \pm 9,9\%$, безрецидивная – $46,2 \pm 9,9\%$. 5-летняя выживаемость – $42,3 \pm 9,9\%$, безрецидивная – $34,6 \pm 9,5\%$.

Выводы: Применение темодала и ломустина на фоне и после ЛТ в лечении ЗГГМ у детей показало удовлетворительную эффективность без выраженных токсических симптомов и достигнуто улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Онгарбаев Б. Т.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Рак мочевого пузыря является достаточно частой патологией: среди злокачественных заболеваний органов мочеполовой системы после опухолей почек находится на втором месте. Его встречаемость составляет 3,8 на 100 тыс населения нашей страны. На сегодняшний день, стандартом лечения инвазивного рака мочевого пузыря, признанного во всем мире, является радикальная цистэктомия.

Целью нашего исследования явилось определение тактики оперативного лечения при выявлении инвазивной формы рака мочевого пузыря.

Материал и методы. С 2006 по 2009 годы и первое полугодие 2010 г в отделении онкоурологии КазНИИОиР находилось на лечении 560 больных раком мочевого пузыря, из них 121 больной прооперирован по поводу инвазивного рака мочевого пузыря: 29 больным проведена резекция мочевого пузыря, 125 больным – радикальная цистпростатэктомия. Характеристика больных представлена в таблице 1.

Средний возраст больных, которым произведена резекция мочевого пузыря составил лет, пациентов с цистэктомией – 60 лет.

В зависимости от местного распространения опухоли больные распределены следующим образом. У пациентов с резекцией мочевого пузыря – у 24 пациентов заболевание было ограничено стенкой мочевого пузыря (T2a-b), у 4 имела микроинвазия в перивезикальную клетчатку, у 1 больного опухоль распространялась на перивезикальную клетчатку. Для пациентов с радикальной цистэктомией у 61 больных отмечено прорастание мышечной оболочки, у 26 – прорастание в перивезикальную клетчатку и у 5 – опухоль распространялась на предстательную железу.

Во всех случаях гистологически был верифицирован переходно-клеточная рак.

Обращает на себя внимание уменьшение количества больных, которым проведена резекция мочевого пузыря (14 больных в 2006 году и 3 больных в 2009 году), и наоборот возрастание числа больных, которым произведена радикальная цистэктомия (в 2005 – 3, в 2006 году – 11, в 2009 – 33).

Больные, которым произведена резекция мочевого пузыря, были первичными, т.е. ранее специализированное лечение не получали. У% больных которым проведена радикальная цистэктомия, госпитализированы по поводу рецидива или прогрессирования заболевания на фоне ранее проводимого лечения.

Всем больным после резекции мочевого пузыря назначалась комбинированная (дистанционная лучевая) и/или комплексная терапия (системная полихимиотерапия – ПХТ по схеме гемзар-цисплатин).

Больным после радикальной цистэктомии, у которых опухоль ограничена мышечной стенкой (T2) и высокодифференцированными опухолями -G1 в после операционном периоде лечение не назначалось, всем остальным пациентам (T $\geq$ 2, G2-4, N+) назначались курсы ПХТ.

Результаты. Больные, которым мы провели резекцию мочевого пузыря, это люди пожилые, с массой сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, анемией тяжелой степени, которым проведение оперативного лечения в объеме радикальной цистэктомии было сопряжено с высоким риском. У всех этих пациентов опухоль располагалась на подвижных

Таблица-1 Характеристика больных

Показатель	Резекция мочевого пузыря (по годам)					Радикальная цистэктомия (по годам)				
	2006	2007	2008	2009	Всего	2006	2007	2008	2009	Всего
Количество больных	14	9	3	3	29	11	15	33	33	92
Средний возраст, лет	62	68	75	72	69,2	59	64	65	64	63
Стадия										
T2a	0	2			5	2	2	4	3	11
T2b	10		1	2	19	8	5	19	18	50
T3a	3	6		1	4	0	5	5	7	17
T3b		1	2		4	1	1	3	4	9
T4a	1				1	1	2	2	1	5
Степень дифференцировки опухоли										
G1										
G2	7	5		1	13	3	2	3	6	14
G3-4	5	2	3	2	12	7	10	21	22	60
	2	2			4	1	3	9	5	18
Первичные пациенты	14	9	3	3	29	5	7	21	23	56
В анамнезе										
1. резекция мочевого пузыря						4	5	4	3	16
2. ТУР+в/пузырная ИТ*/ХТ**							1	5	2	8
3. Комбинированное лечение (резекция+ДЛТ***, ХТ)						2	2	3	5	12

ИТ* - иммунотерапия; ХТ** - химиотерапия; ДЛТ*** - дистанционная лучевая терапия

стенках, не превышала 5см в диаметре и была ограничена мышечной стенкой мочевого пузыря. Также этим пациентам проводилась регионарная лимфодиссекция с односторонней стороны с диагностической целью. В 8 случаях опухоль закрывала устье мочеточника с нарушением эвакуаторной функции почки и была произведена резекция с уретероцистостомией. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под наблюдением. На фоне проведенного лечения у 5 больных выявлен рецидив заболевания и 2 больных умерли от прогрессирования процесса.

В послеоперационном периоде у пациентов после радикальной цистэктомии по различным причинам умерло 12 человек, из них в раннем послеоперационном периоде 3 больных. Анализ летальности в двух случаях выявил разлитой перитонит вследствие несостоятельности тонко-тонкокишечного анастомоза, в одном – развитие тромбоза легочной артерии.

Выводы. Таким образом, при инвазивном раке мочевого пузыря на сегодняшний день стандартом лечения является проведение радикальной цистэктомии.

THE BIOLOGICAL CHARACTERISATION OF EARLY BREAST CANCER

Gábor CSERNI, MD, PhD, DSc

Department of Pathology, Bács-Kiskun County Teaching Hospital

Breast cancer is a heterogeneous disease that can be characterized according to several criteria. Of the multiple ways of classifying the disease, the best options also take into consideration the risk of relapse and/or the options of treatment.

1. Histological grade is a composite parameter which reflects the aggressivity of the tumor. However, grade 2 carcinomas seem to encompass a mixture of more and less aggressive cancers, therefore several initiatives have been made to separate grade 2 tumors into biologically significant subsets.

2. Although the assessment of proliferation is part of grading breast cancers, proliferation is also a marker of prognosis on its own. The use of Ki-67 antibodies on paraffin embedded breast cancer specimens is an attractive and seemingly easy way of quantifying proliferation, and tumors with a high proliferative activity generally have worse outcome. However, there are a number of issues requiring standardization before the Ki-67 could uniformly be used as a prognostic or predictive factor (highly proliferating tumors reacting better to chemotherapy).

3. A factor of obvious relevance is the estrogen receptor (ER) status of the tumor, which is often assessed in parallel with its progesterone receptor (PR) status. Good quality immunohistochemistry is required for this, and care should be taken to avoid false-positive and false-negative results. The ASCO 2010 guidelines stress on this later issue and have accepted 1% as the lowest rate of nuclear staining for ER positivity.

4. HER-2 is both a prognostic and a predictive marker of breast cancer. Its overexpression is assessed by immunohistochemistry, whereas gene amplification is generally assessed with different

techniques of in situ hybridisation, including fluorescent, chromogenic and one based on the conversion of ionic silver to metallic silver. Although there is good concordance between these assays, the match is not perfect. Dual immunostaining may offer some advantage over the use of a single anti-HER-2 antibody, and some results on such dual staining will be presented along with a comparison of chromogenic in situ hybridization with immunostaining.

5. Urokinase plasminogen activator (uPA) and its inhibitor (PAI-1) seem to be differentially expressed in aggressive breast cancers (high levels) versus less aggressive tumors (low levels). However, testing for these proteins is not readily available, therefore they are not widely recommended despite high level of evidence of their prognostic relevance.

6. Gene expression profiling is a novel way of characterizing breast carcinomas. These tests are still under investigation, and the relevant studies already initiated are still in their recruitment phase. Nevertheless, the 21 gene assay (Oncotype Dx) is commercially available and rather widely used in North America. Its use is restricted to ER-positive carcinomas, and its recurrence score takes into account many of the previously mentioned factors (ER-related genes, HER-2, proliferation).

7. Despite our increasing knowledge of cancer biology, the better outcome of screen detected breast carcinomas (compared to symptomatic carcinomas) can only partially be explained by the differences in stage and known (easily testable) biological markers.

Whatever the method of classification used, there will be outliers. The majority of the cases can currently be classified according to treatment tailoring needs on the basis of anatomical factors (size, nodal status) and biological factors (grade, ER, PR, HER-2), and some further adjustment can be made on the basis of proliferation or other methods under intensive investigation such as uPA-PAI-1 or gene expression profiling.

Содержание

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА ПО Г. АЛМАТЫ (3)
- ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В Г.АЛМАТЫ ЗА 2005-2009 ГГ. (3)
- ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЛЕГКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. (3)
- ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (4)
- ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ (4)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (5)
- ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ (5)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛ. (6)
- ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2000-2009 ГГ. (6)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПИЩЕВОДА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-2009 ГОДЫ) (7)
- О ГЕНЕЗЕ РАКА КОЖИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА (7)
- СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РАЙОНАХ СЕВ.-КАЗ. ОБЛАСТИ (7)
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ПИЩЕВОДА В КАЗАХСТАНЕ (8)
- ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 50 ЛЕТ (8)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В Г.АСТАНА (9)
- ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕРМЕН КҮРЕСУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ (9)
- ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ҚЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ (10)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ (10)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2009Г. В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (11)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЖЕЛУДКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2003-2007 ГГ. (11)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ (12)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (12)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА (12)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (13)
- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (13)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (14)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (14)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В ВОСТОЧНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА (15)
- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА (15)

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

- ИММУНОКОМПЕТЕНТТІ ЖАСУШАЛАРДЫҢ (ИЖЖ) ЖӘНЕ ЦИТОКИНДЕРДІҢ МӨЛШЕРІН ИММУНОМІНЕН КЕЙІН ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІМЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІНДЕГІ РЕГРЕССИОНДЫҚ АНАЛИЗІ (17)
- ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ТЕКСЕРІЛГЕН ИММУНИТЕТ ПЕН ЦИТОКИНДЕР КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУДЫҢ АҒЫНУ БОЛЖАМЫМЕН АУТОЦИТОКИН ЕМІНІҢ ӨСЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ АНАЛИЗ БЕРУ (17)
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ РЕВЕРТАНТОВ SALMONELLA TYPHIMURIUM (18)
- РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА (18)
- ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНЕН КЕЙІНГІ ИММУНОЕМИ, ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ ҚАРСЫ ИММУНИТЕТ ЖӘНЕ ЖАСУШАНЫҢ ІШІНДЕГІ ЦИТОКИН-ДЕР. (19)
- ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ХИМИО-ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ (19)
- ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОМ. (19)
- СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (20)
- ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (20)
- ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОНОСКОПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ (21)
- ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЗС. (21)
- ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПРОЦЕССАХ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (22)
- РОЛЬ МАРКЕРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (23)
- ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РМЖ (23)
- РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (24)
- МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКСОМ СЕРДЦА (25)
- ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ (25)
- О НАРУШЕНИЯХ В СИСТЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА И ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕВОГО ФЕНОТИПА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО (26)
- МУТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ГЕНАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ЭКСПРЕССИИ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЛЕГКОГО (26)
- УЗ-ДИАГНОСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА (27)
- ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (27)
- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ РЕТРОГРАДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (28)
- ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЛИМОНИДИНА В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ (28)
- ИЗУЧЕНИЕ ЛИМОНИДИНА КАК ПРОТЕКТОРА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ (29)
- СОЧЕТАННАЯ ИММУНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (29)
- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЯИЧНИКОВ (30)
- КЛЕТЧАНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (30)
- КОРРЕКЦИЯ ИММУНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕОАДЪВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (31)
- ПЭТ-КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ (31)
- К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (31)
- ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ. (32)
- ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУТАЙНЕРОВ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ. (32)
- ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ (33)
- ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ (33)
- ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И МОРФОЛОГИИ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ. (34)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ И КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА. (34)
- ИЗУЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА РАКА ЭНДОМЕТРИЯ. (34)
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. (35)
- ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. (35)
- ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ФИБРОМИОМЫ МАТКИ (35)
- ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ (36)
- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ В-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМ (36)
- МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ (37)
- ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМОЙ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ. (37)
- СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРОВИ ПРИ НЕИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ (38)
- К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (38)
- ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ ОТ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА (38)
- РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА (39)
- АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ (39)
- ГИПОТЕЗЫ О РОЛИ МИТОХОНДРИЙ В РАЗВИТИИ И РЕГУЛЯЦИИ УРОВНЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В НОРМЕ И ПРИ КЛЕТОЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ (40)
- ОНКОЛОГИЯДАҒЫ ИММУНОМОДУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕМ. (40)
- РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОУРОЛОГИИ (41)
- МЕТИЛИРОВАНИЕ CpG-ОСТРОВКОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ УЧАСТКОВ ГЕНА CHK2 В НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА. (41)
- СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНА BRCA1 У БОЛЬНЫХ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА. (42)
- ТИП ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ (42)

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ В ОНКОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ РАДИО-ИММУННОГО АНАЛИЗА (43)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (43)

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (44)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (44)

ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (45)

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (45)

ПРИЧИНЫ НЕТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (46)

СОСТАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (46)

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ (46)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОНКОМАММОЛОГИИ (47)

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (47)

ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (48)

РОЛЬ СА-125 В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ (48)

СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (49)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ (49)

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ РОТОГЛОТКИ (50)

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (50)

ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОВ. (50)

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (51)

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (52)

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА. (52)

ПОВЫШЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ (52)

МАММОГРАФИЧЕСКОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (53)

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ. (53)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. (54)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ. (54)

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. (55)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ. (55)

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА (56)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. (56)

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА. ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (56)

ЧРЕСКОЖНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. (57)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ (57)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА (59)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОЛОГИИ (59)

ХИРУРГИЧ. ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (60)

ӨКПЕ ІСІГІ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН РЕКОНСТРУКТИВТІ- ПЛАСТИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ. (60)

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА (61)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДА (61)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА (61)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО (62)

USE OF BRACHYTHERAPY IN CERVIX CANCER (62)

ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ У БОЛЬНЫХ, РАДИКАЛЬНО ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА (62)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (63)

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЛЬЮИ-СА. (63)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА 3-й СТАДИИ (64)

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (64)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БҮЙРЕК РАҒЫН ЕМДЕУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ (64)

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. (65)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА. (65)

СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА (ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) (66)

ЦИРКУЛЯРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕГКОГО И ТРАХЕИ (66)

РАСШИРЕННЫЕ И РАСШИРЕННО-КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА. (66)

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА. (66)

ВЫБОР ОБЪЕМА ЛИМФОДИССЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА (67)

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТГАСТРЭТОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ (67)

РОЛЬ HELICOBACTER PULORI В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ (68)

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ (68)

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПАДАЮЩЕГОСЯ И ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (68)

МЯГКОТКАННЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНО-ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (69)

БРОНХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (69)

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ (70)

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ. (71)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ РАННИХ, МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И ДИСSEMINИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (71)

ОРГАНОСОХРАННЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ВЕК. (72)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ РЕКТО-АБДОМИНАЛЬНОГО ЛОСКУТА ПРИ ОДНОМОЕНТОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (72)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (72)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНО ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ (73)

КОМБИНИРОВАННОЕ ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА (73)

РАННЕЕ ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ В ОНКОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ОПЕРИРОВАННЫХ НА ОРГАНАХ ЖКТ. (73)

ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ ПРИ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ОНКОХИРУРГИИ (74)

РОЛЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ НЕФРЭКТОМИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ (74)

ПОКАЗАНИЯ К СИМУЛЬТАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ (75)

ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА (75)

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ (75)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С КОЛОСТОМАМИ (76)

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (76)

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ (76)

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ (77)

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ. (77)

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОРТАНИ (78)

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ (78)

РАК ПОЧКИ. ОСЛОЖНЕННЫЙ ТРОМБОЗОМ КРУПНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ. (79)

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ (79)

МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ (80)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (80)

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ (81)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САРКОМ КОСТЕЙ ТАЗА (81)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (82)

СЦИНТИГРАФИЯ СКЕЛЕТА И РАДИОИММУННЫЕ АНАЛИЗЫ ПРИ МЕТАСТАЗАХ БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА (82)

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА. (82)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ (83)

ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА (83)

ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. (83)

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВОГО АНГИОГЕНЕЗА И ВАСКУЛЯРНОЙ ИНВАЗИИ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ (84)

ЗЗОФАГЕАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА (84)

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (85)

ОТДАЛЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ФЕНОТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (85)

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. (86)

УШИВАНИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ СОБСТВЕННЫМИ ТКАНЯМИ С РАЗДЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ ДРЕНИРОВАНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ ПО MADDEN (86)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ. (87)

ЭВИСЦЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. (87)

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БОЛЬНЫМ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА. (87)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ (88)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ НИЗКОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПОСЛЕ СФИНКТЕРОСБЕРЕГАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ (88)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ (88)

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАКЕ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ (89)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. (89)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА (89)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. (90)

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ (90)

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. (90)

ХИМИОТЕРАПИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (92)

РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ (92)

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОИНФУЗИЯ В ЧРЕВНЫЙ СТОЛ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА (92)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (93)

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧРЕСКАТЕРНЫХ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ (93)

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ РАКА ПОЧКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ (93)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЛИМОНИДИН В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ (94)

ИЗУЧЕНИЕ ЛИМОНИДИНА КАК ПРОТЕКТОРА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ (94)

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (95)

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСТРАКТОР. ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ В КАЧЕСТВЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ (96)

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ТЕРАПИИ ГЕМЦИТАБИНОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. (96)

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ОПУХОЛИ ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (96)

ХИМИОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ДИФУЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ НХЛ (97)

ХИМИОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ДИФУЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ НХЛ (97)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАКЕ КОЖИ ВЕК НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭДЖОЦИН (97)

ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРАФУРА В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (98)

РЕЗУЛЬТАТЫ «LOW STADING» ТЕРАПИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ И МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫХ ФОРМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (98)

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЦЕТАКСЕЛА В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННОГО И ДИССЕМИНИРОВАННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКОГО (99)

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЩАДЯЩАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ (99)

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АРГЛАБИН В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА (100)

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРГЛАБИНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ (100)

ОКСАЛИПЛАТИН В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО, МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА (МКРР) (101)

ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ ИММУНОТЕРАПИИ (101)

ВКЛАД ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА КАЗАХСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ (101)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕНИЕМ ОПУХОЛЕВЫХ ЭМБОЛОВ И СТЕПЕНЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧ. УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА (102)

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ РАКА ЖЕЛУДКА С ВКЛЮЧЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ХИМИОПРЕПАРАТОВ (102)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ КАПЕЦИТАБИНА ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) С УЧЕТОМ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (102)

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОСТАТИКОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ (103)

ОКСАЛИПЛАТИН В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО, МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА (103)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ХОРИОНКАРЦИНОМЫ МАТКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ (104)

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ORIGINAL PREPARATION ARGLABIN IN TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED CANCER OF UTERINE CERVIX (104)

PHARMACOKINETICS AND BIOTRANSFORMATION OF ARGLABIN IN EXPERIMENT (104)

PLANTS – POTENTIAL SOURCES OF NEW COMPOUNDS, POSSESSING ANTITUMOR ACTIVITY (105)

CYTOTOXIC ACTIVITY OF SESQUITERPENE LACTONES ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES (105)

ESTIMATION OF CYTOTOXIC ACTION OF HYDROCHLORIDE HARMINE WITH APPLICATION OF METHOD MTT (106)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ АРГЛАБИНА НА СОСТОЯНИЕ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕР. КРОВИ УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ (106)

ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА АРГЛАБИНА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФАГОЦИТОВ (107)

ИЗУЧЕНИЕ ФИТОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО ПРЕПАРАТА – ГЛИАМИН (107)

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ САНТОНИНА КАК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИИ (108)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СЕСКВИТЕРПЕНОИДА ПОЛЫНИ ЦИТВАРНОЙ (108)

СИНТЕЗ НОВОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРОИЗВОДНОГО САНТОНИНА С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ (109)

ИММУНОФАРМАКОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ПРОТИВООПУХОЛ. СОЕДИНЕНИЙ (109)

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ АЛХИДИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (110)

НОВЫЙ ФИТОПРЕПАРАТ ИЗ EUROTIA CERATOIDES (L.) И ЕГО АКТИВНОСТЬ (110)

ПЕРСПЕКТИВЫ СУБСТАНЦИИ «ТОНБИОЛ», ОБЛАДАЮЩЕЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ (110)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕНОСИМОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИТИОЛАТНОГО СОЕДИНЕНИЯ РТУТИ (111)

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛАЗА И ОРБИТЫ (112)

45-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В КАЗНИИОИР (112)

ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛАЗА И ОРБИТЫ (113)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ (113)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОГО И ХИМИОЛУЧЕВОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ III – IV СТАДИЙ (114)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (114)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАММОГРАФИИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (114)

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВОВ РАКА ЖЕЛУДКА (115)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОЛУЧЕВОГО И ЛУЧЕВОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ II – III СТАДИИ (116)

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (116)

ПЕРЕХОД ОТ 2-Х МЕРНОЙ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ К 3-Х МЕРНОМУ КОНФОРМНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА. (116)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА ЛУЧЕВЫХ АППАРАТОВ В ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (117)

КОМПЛЕКСНОЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ И ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА (118)

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА. (118)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОИНФУЗИИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА. (119)

ЗНАЧЕНИЕ МЕМБРАННОГО ГЛИКОПРОТЕИНА В РАЗВИТИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА (119)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (119)

ТРЕХМЕРНЫЕ 3-D ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ К КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (120)

ВОЗМОЖНОСТИ КАЛУМИДА В ПОВЫШЕНИИ ГОРМОНОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (120)

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОМУСТИНА И ТЕМОДАЛА В ХИМИО- И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МУЛЬТИФОРМНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ (121)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ (121)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ (122)

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (122)

ЯДРОЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ КЛАСТЕР ҚҰРУ (123)

СИСТЕМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАДИОЭПИТЕЛИТА (123)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ. (124)

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК ПРИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (124)

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ И КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (124)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (125)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГЛАБИНА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА (126)

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО. (126)

ЦИТОЛОГИЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО (127)

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИИ КОЖИ (127)

АСПИРАЦИОННАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ОНКОЛОГИИ (128)

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОИГЛЬНЫХ ПУНКТАТОВ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (128)

МОРФОЛОГИЯ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (129)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 2006-2009 ГГ. ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ ВКО (129)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЬНИЦ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (130)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПАПАНИКОЛАУ ПРИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ (130)

DETECTION OF ACTIVITY IN NUCLEOLUS ORGANIZERS (NO) IN COMBINED TREATMENT OF THE BLADDER CANCER (131)

ИММУНОГИСТОХИМИЧ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА И ПРОГЕСТЕРОНА И HER2(NEU) ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (131)

ЭКСПРЕССИЯ HER2(NEU) РЕЦЕПТОРОВ И СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН ГАКТОБЕ (132)

ВИМЕНТИН-ПОЗИТИВНЫЕ МАКРОФАГИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОЛИТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ (132)

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЭКСПРЕССИИ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И ЛИЗОЦИМА В МАКРОФАГАХ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ И РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ (132)

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Фолликулярной аденомы и фолликулярного рака щитовидной железы у детей и подростков. (133)

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЛЬТРАТИВН. ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА (133)

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (134)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБОВ С КОЖИ В УСЛОВИЯХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (134)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ДНК-ЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО (135)

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ ЯДЕР КЛЕТОК БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В НОРМЕ И ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО (135)

ТРУДНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛИЗИСТЫХ РАКОВ ЖЕЛУДКА (136)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. (136)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ HER-2 NEU ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЭНДОМЕТРИЯ. (137)

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ (137)

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (137)

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TP53 КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭПИТЕЛИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПОПУЛЯЦИИ КАЗАХСТАНА (138)

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-РЕГУЛЯТОРОВ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА CCND1 И TP53 КАК ФАКТОР ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ (138)

ГЛУТАТИОН И ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗА В ПРОГНОЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (НХЛ). (139)

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ARG399GLN ГЕНА XRCC1 И THR241MET ГЕНА XRCC3 В РАЗВИТИИ РАКА ПИЩЕВОДА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ (139)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОТИНГЕМСКОГО ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА (NPI) В РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РМЖ. (140)

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА (140)

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАДИРОВАНИЯ НЕФРОБЛАСТОМЫ В ПРОТОКОЛАХ COG (CHILDREN'S ONCOLOGY GROUP) И SIOP (INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY). (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) (141)

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТАТОВ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ (141)

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧ. МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АБЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОЖИ (142)

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУРПУРЫ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА (143)

АУТОИММУНДЫ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯНЫҢ ЕМІНДЕ ТИМОДЕПРЕССИНДІ ҚОЛДАНУ (143)

СЛУЧАЙ ТРУДНОКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ ФОРМЫ В-КЛЕТОЧНОГО ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (144)

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ ЦИТОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С (144)

ОСОБЕННОСТИ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ МЕЛКОКЛЕТОЧНЫХ САРКОМАХ У ДЕТЕЙ. (145)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМА VCAP У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВНЫМИ И РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ (145)

СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ (CD 34+) КЛЕТОК КРОВИ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ. (145)

В-ЛИНЕЙНЫЕ ОСТРЫЕ ЛИМФОБЛАСТНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ У ДЕТЕЙ. ИММУНОДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ОСТАТОЧНОЙ РЕЗИДУАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ. (146)

GR130 КАК МИШЕНЬ ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОНКОЛОГИИ (147)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАСТОВ ПРИ ОЛЛ ВЗРОСЛЫХ. (147)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ БОРТЕЗОМИБА, ДОКСОРУБИЦИНА, ДЕКСАМЕТАЗОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ (147)

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕСНА ШТАДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛИМФОМАМИ И САРКОМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КАЗНИИОИР (148)

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (148)

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОГО СТИМУЛИРОВАННОГО КОСТНОГО МОЗГА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ГЕМОПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (149)

РАЗНОЕ

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ (150)

ОПТИМИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (150)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ (151)

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (151)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ (152)

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В РАДИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ (152)

СЛУЧАЙ АЛЬВЕОКОККА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ, ИМИТИРУЮЩИЙ ОПУХОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ (153)

АНАЛИЗ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ IV СТАДИИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО (153)

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА ЛЕГКОГО В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2009 ГОДАХ. (154)

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ ПРИ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬ-

НЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ИСХОД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (154)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОФЛЮРАНА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ В ОНКОХИРУРГИИ (ТВВА) (155)

РОЛЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. (155)

ПРОБЛЕМА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКИХ. (156)

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ (156)

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. (157)

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО III СТАДИИ (157)

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СЛУЧАЙНО ВЫЯВЛЕННЫХ ОПУХОЛЯХ НАДПОЧЕЧНИКОВ (158)

БАСТАПҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК (БМСК) ДЕНГЕЙІНДЕГІ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ИНОВАЦИЯЛАУ. (158)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАД В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕН. МИЕЛОМЫ (159)

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (159)

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АС-БОЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (159)

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. (160)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (160)

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. (161)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ С ИСПОЛЬЗ. РЕКОФОЛА И ТРАМАДОЛА ОНКОХИРУРГИИ. (161)

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (162)

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА В ОНКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА (162)

НЕНАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК КАК КОМПОНЕНТ КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ (163)

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ (163)

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ (164)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГАДОВИСТ» И «МАГНЕВИСТ» В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОАДЕНОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (164)

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (165)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ (165)

ИНДОЛ- 3 КАРБИНОЛ В ЛЕЧЕНИИ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (166)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г.СЕМЕЙ. (166)

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕКСАНА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (167)

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ. (167)

ПЕРВИЧНОЕ ДВОЙНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ (167)

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА РЕПРОДУКТ. ОРГАНОВ (168)

ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ РЕНТГЕН СНИМКОВ (169)

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТ. КИШКИ (169)

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ KI-67 ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИИ. (169)

РОЛЬ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ (170)

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИФЕРИЛИН 11,25 МГ ПРИ РГЖ. (170)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕМОДАЛА (ТЕМОЗОЛОМИД) В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ (171)

THE BIOLOGICAL CHARACTERISATION OF EARLY BREAST CANCER (173)

Индекс авторов (кириллица)

- Абдиганиева С.Р. 139
 Абдиганиева С.Р. 145
 Абдикаримов М.Г. 87
 Абдикаримов Х.Г. 88
 Абдрахманов А.Б. 165
 Абдрахманов Р.З. 59
 Абдрахманова Л.А. 150
 Абдрахманова М.М. 63
 Абдрахманова М.М. 63
 Абдулаханова Р.Р. 166
 Абдулаханова Р.Р. 49
 Абдулаханова Р.Р. 84
 Абдурахимов О.Н. 64
 Абдурахимов О.Н. 89
 Абдурахимов О.Н. 90
 Абдурахманов Б.А. 93
 Абдурахманов Д.А. 145
 Абдурахмонов Д.А. 139
 Абдурахмонов Д.К. 87
 Абдурахмонов Д.К. 87
 Абдусаламов С.Н. 148
 Абдусаламов С.Н. 149
 Абенова М.Т. 101
 Абетов Д.А. 138
 Абетов Д.А. 139
 Абисатов Х.А. 122
 Абисатов Х.А. 157
 Абисатов Х.А. 33
 Абисатов Х.А. 77
 Абишев Б.К. 101
 Абугалиева Г.С. 150
 Абылкасымова К.А. 136
 Адиев М. М. 52
 Адиев М.М. 88
 Адиев М.М. 88
 Адильбаев Г.Б. 99
 Адильгиреева Л. Х. 25
 Адильгиреева Л. Х. 25
 Адильгиреева Л.Х. 69
 Адылханов Т.А. 160
 Адылханов Т.А. 64
 Ажигалиев Н.А. 112
 Ажигалиев Н.А. 112
 Ажигалиев Н.А. 113
 Ажигалиев Н.А. 120
 Ажигалиев Н.А. 121
 Ажигалиева М.Н. 112
 Ажигалиева М.Н. 113
 Ажмагамбетова А.Е. 101
 Ажмагамбетова А.Е. 12
 Ажмагамбетова А.Е. 12
 Ажмагамбетова А.Е. 13
 Ажмагамбетова А.Е. 15
 Айсарова А.М. 133
 Айсарова А.М. 134
 Айсарова А.М. 136
 Айтуганова К.Г. 137
 Айтуганова К.Г. 134
 Айтуганова К.К. 128
 Актаева Н.М. 114
 Акшолоаков Е.Ж. 19
 Акшолоаков Е.Ж. 20
 Акшолоаков Е.Ж. 20
 Акшолоаков Е.Ж. 50
 Акшолоаков Е.Ж. 51
 Акшолоаков Е.Ж. 52
 Акшулаков С.К. 121
 Алдынгуров Д.К. 161
 Алимгазиева К.Т. 143
 Алимходжаева Л.Т. 22
 Алимходжаева Л.Т. 23
 Алимходжаева Л.Т. 23
 Алмабекова А.Т. 112
 Алмабекова А.Т. 120
 Алмабекова А.Т. 120
 Алмагамбетова К.А. 24
 Алмагамбетова К.А. 45
 Алмардонов Р.Б. 75
 Алпеисова Ш.Т. 82
 Альгожин Т.Б. 115
 Альгожин Т.Б. 62
 Альгожин Т.Б. 151
 Аманбеков Н.А. 40
 Аманбеков Н.А. 64
 Амангалиев Ж.А. 126
 Аманов Т.Т. 128
 Аманов Т.Т. 128
 Аманов Т.Т. 134
 Аманов Т.Т. 137
 Антропова Т.Ю. 112
 Антропова Т.Ю. 116
 Антропова Т.Ю. 120
 Антропова Т.Ю. 116
 Арзыкулов Ж.А. 28
 Арзыкулов Ж.А. 101
 Арзыкулов Ж.А. 102
 Арзыкулов Ж.А. 102
 Арзыкулов Ж.А. 102
 Арзыкулов Ж.А. 117
 Арзыкулов Ж.А. 59
 Арзыкулов Ж.А. 92
 Арифходжаева М.Т. 23
 Артыкбаева Н.Т. 129
 Арыбжанов Д.Т. 93
 Арыбжанов Д.Т. 92
 Арыбжанов Д.Т. 93
 Арыстанова Т.А. 108
 Арыстанова Т.А. 109
 Асанов А.А. 148
 Асанова К.К. 5
 Асанова Н.У. 31
 Ассесорова Ю.Ю. 11
 Астапкевич Л.А. 159
 Астапкевич Л.А. 144
 Астапкевич С.Г. 18
 Астапкевич С.Г. 39
 Аубакирова А.Т. 19
 Аубакирова А.Т. 17
 Аубакирова А.Т. 17
 Ахматуллина С.К. 144
 Ахмедов О.М. 96
 Ахмедов О.М. 104
 Ахметкалиева Г.Р. 128
 Ахметов Д.Н. 99
 Ахметова Г.С. 121
 Ахметова Н.С. 101
 Аюпов Ф.Т. 138
 Аязбаев Н.Б. 17
 Аялбергенова Г.О. 29
 Аялбергенова Г.О. 94
 Бабаева Н.Г. 118
 Базарбаев Н.А. 123
 Байдилбеков С.А. 83
 Байжанов Ш.К. 118
 Байзаков Б.Т. 31
 Байкадамов А.Х. 45
 Баймаханов Б.Б. 45
 Баймаханов Б.Б. 65
 Баймаханов Б.Б. 68
 Баймаханов Б.Б. 87
 Баймаханов Ж.Б. 87
 Баймухамедова М.Х. 18
 Баймухаметов К.К. 52
 Баймухаметов К.К. 88
 Баймухаметов К.К. 88
 Баймухаметов Э.Т. 17
 Байназарова А.А. 90
 Байпеисов Д.М. 129
 Байтилеуов Т.А. 84
 Байтурпин Ж.Г. 164
 Баишева С.А. 17
 Баишева С.А. 19
 Балтабеков Н.Т. 122
 Балтабеков Н.Т. 157
 Балтабеков Н.Т. 33
 Балтабеков Н.Т. 40
 Балтабеков Н.Т. 64
 Балтабеков Н.Т. 77
 Балтаев Н.А. 52
 Балтаев Н.А. 73
 Балтаев Н.А. 88
 Балтаев Н.А. 88
 Бань Т.П. 129
 Баспаева М.Б. 19
 Баспаева М.Б. 48
 Баспаева М.Б. 66
 Баталова К.С. 25
 Бегатарова Қ.Н. 156
 Бегимбаева Р.С. 3
 Бегунов В.В. 66
 Бегунов В.В. 75
 Бейсебаев А. А. 66
 Бейсебаев А.А. 19
 Бекетова Б.Б. 166
 Бекмухамбетов Е.Ж. 158
 Бекмухамбетов Е.Ж. 3
 Бекмухамбетов Е.Ж. 4
 Бекмухамбетов Е.Ж. 66
 Бектурсынов С.М. 167
 Беламанова Л.Ж. 135
 Беламанова Л.Ж. 127
 Беламанова Л.Ж. 127
 Беламанова Л.Ж. 138
 Беламанова Л.Ж. 142
 Бердикулов Д.И. 75
 Берсимбай Р.И. 138
 Берсимбай Р.И. 138
 Берсимбай Р.И. 139
 Беседин Б.В. 93
 Бестембеков С.Т. 99
 Бимаганбетова Н.Б. 5
 Бимаганбетова Н.Б. 71
 Бобко И. Н. 48
 Бобко Ю.И. 48
 Божьева М.Г. 146
 Бойко Н.И. 129
 Болсынбекова С.О. 131
 Болтаев М.И. 87
 Боромбаев И.У. 153
 Боромбаев У.Т. 61
 Бочкова Н. В. 100
 Бочкова Н.В. 100
 Буkenов А.М. 66
 Буkenов А.М. 82
 Булатова А. Б. 99
 Бурашева Г.Ш. 110
 Бутабаева К.Ж. 110
 Бутырская И.Г. 52
 Бутырская И.Г. 118
 Бутырская И.Г. 56
 Буть Л.Г. 154
 Ванесян А.С. 72
 Ванесян А.С. 72
 Ванесян А.С. 73
 Вахобов О.У. 87
 Вершинина С.Ф. 96
 Воротников В.В. 75
 Габбасова С.Т. 147
 Габбасова С.Т. 148
 Габбасова Э.З. 143
 Габбасова Э.З. 143
 Гаерипова Е.А. 142
 Галушкин М.А. 120
 Галушкин М.А. 121
 Ганцев Ш.Х. 92
 Гатагажева З.М. 168
 Гафур-Ахунов М.А. 37
 Гафур-Ахунов М.А. 86
 Гафур-Ахунов М.А. 88
 Гафур-Ахунов М.А. 90
 Гельдиева М.С. 37
 Гершанович М.Л. 96
 Гимадиева Г.М. 153
 Гимранов А.М. 73
 Горбунова Т.В. 145
 Гофур-Ахунов М.А. 159
 Гривцова Л.Ю. 145
 Гривцова Л.Ю. 146
 Гривцова Л.Ю. 147
 Гривцова Л.Ю. 148
 Гривцова Л.Ю. 149
 Гринберг В.В. 87
 Дарменов Е.О. 44
 Дарменов О.К. 44
 Дарменов О.К. 59

- Дауренов Б.Б. 159
 Джакипбаева А.К. 126
 Жансугурова Л.Б. 138
 Жансугурова Л.Б. 138
 Жансугурова Л.Б. 139
 Джарылкасымова Ж.К. 3
 Джахангирова М.О. 23
 Джаханова Л.А. 5
 Джумабеков А.Т. 83
 Джумагалиев Д.З. 69
 Джумагалиев Д.Д. 5
 Джураев М.Д. 119
 Джураев М.Д. 119
 Джураев М.Д. 67
 Джураев М.Д. 67
 Джураев Ф.М. 170
 Джураев Ф.М. 68
 Джураев Ф.М. 89
 Дигай А.К. 119
 Дигай Л.К. 119
 Досаханов А. Х. 100
 Доскеева Р.А. 18
 Дробкова О.М. 151
 Дуненова Г.А. 93
 Дюсембеков Е.К. 121
 Дюсембеков С.Т. 158
 Дюсембеков С.Т. 27
 Дюсембеков С.Т. 66
 Дюсембеков С.Т. 66
 Дюсембеков С.Т. 75
 Евлаева М.И. 168
 Елемесов Н.Н. 81
 Елеубаева Ж.Б. 25
 Елеубаева Ж.Б. 25
 Елеубаева Ж.Б. 69
 Енин Е. А. 25
 Енин Е.А. 25
 Енин Е.А. 69
 Ербошаев С.Е. 45
 Ержанова Т.З. 54
 Ержанова Т.З. 55
 Ержанова Т.З. 57
 Еркатов Б.К. 52
 Ермаханова Г.А. 165
 Еркекова С.А. 26
 Еркекова С.А. 26
 Еркекова С.А. 41
 Еркекова С.А. 42
 Ерубайев С.Ж. 10
 Есболатов Д.А. 163
 Есеналиева Д.Б. 143
 Есенкулов А.Е. 46
 Есенкулов А.Е. 46
 Есенкулов А.Е. 46
 Есенкулов А.Е. 47
 Есенкулов А.Е. 47
 Есенкулов А.Е. 8
 Есенкулова С.А.
 Есенкулова С.А. 46
 Есенкулова С.А. 46
 Есенкулова С.А. 46
 Есенкулова С.А. 47
 Есентаева С.Е. 102
 Есентаева С.Е. 59
- Есентаева С.Е. 121
 Есентаева С.Е. 166
 Есентаева С.Е. 49
 Есентаева С.Е. 84
 Есмамбетова А.Г. 27
 Ешимов С.А. 158
 Жакенова Ж.К. 28
 Жакенова Ж.К. 53
 Жакупов Р.К. 163
 Жанабекова Ж.Ж. 167
 Жандосова Э.У. 124
 Жандосова Э.У. 125
 Жансагимова З. С. 116
 Жансагимова З.С. 114
 Жанталинова Н.А. 83
 Жапарова Д.Д. 13
 Жапарова Д.Д. 13
 Жарихина Т.А. 133
 Жарихина Т.А. 134
 Жарихина Т.А. 136
 Жарков Н.В. 132
 Жарков Н.В. 132
 Жаркова И.М. 132
 Жаркова И.М. 132
 Жарова З.Д. 147
 Жетибаева Г.К. 71
 Жетписбаев Б.А. 39
 Жолдыбай Ж.Ж. 53
 Жолмухамедова Д.А. 66
 Жолмухамедова Д.А. 66
 Жораяев Т.С. 83
 Жуков Ю.В. 9
 Жумагазин Ж.Д. 101
 Жумагазин Ж.Д. 165
 Жумагазин Ж.Д. 9
 Жумадуллаев Б.М. 148
 Жумадуллаев Б.М. 171
 Жумадуллаев Б.М. 6
 Жумадуллаев Б.М. 70
 Жуматаев Ж.Ж. 93
 Жумашева А.В. 27
 Жумашева А.В. 132
 Жунусов Г.А. 161
 Жунусова А.Ж. 167
 Жунусова А.Ж. 169
 Жунусова А.Ж. 169
 Жураев Ш.Ш. 84
 Жусупова Г.Е. 29
 Жусупова Г.Е. 94
 Жусупова Ж.Т. 119
 Жұмағалиев Д.Ж. 158
 Жұмағалиев Д.Ж. 4
 Жұмағалиев Д.Ж. 5
 Жұмықбаева Н.К. 156
 Жұмықбаева Н.К. 81
 Зайнидинов Р.Р. 83
 Зайцева Л.С. 48
 Зайцева Л.С. 75
 Зейнелова Л.Т. 123
 Зейнелова Л.Т. 156
 Зейнелова Л.Т. 157
 Зейнелова Л.Т. 160
 Зейнелова Л.Т. 81
 Зейтын М.К. 165
- Ибекенов О.Т. 68
 Ибрагимов Ж.М. 97
 Ибрагимов Ж.М. 97
 Ибрагимова Д.Д. 101
 Ибраев К.К. 31
 Ибраев К.К. 31
 Ибраев К.К. 38
 Ибраев К.К. 47
 Ибраимова М.А. 112
 Ибраимова М.А. 120
 Ибраимова М.А. 120
 Ибраимова М.А. 121
 Иванив Н.Д. 52
 Иванова Н.В. 133
 Иванченко Е.В. 161
 Игисинов С.И. 3
 Игисинов С.И. 14
 Игисинов С.И. 14
 Игисинов С.И. 8
 Игликов М.К. 71
 Иембергенов А.И. 24
 Иембергенов А.И. 45
 Ижанов Е.Б. 102
 Ижанов Е.Б. 102
 Ижанов Е.Б. 59
 Ижанов М.Т. 71
 Ижанов М.Т. 71
 Избагамбетов Н.А. 92
 Избасаров Р.Ж. 59
 Избасаров Р.Ж. 44
 Ильин Ю.Н. 31
 Ильин Ю.Н. 31
 Ильин Ю.Н. 38
 Ильин Ю.Н. 47
 Имамове О.А. 75
 Имамове О.А. 75
 Имангалиева Н.Т. 14
 Имангалиева Н.Т. 14
 Иманкулов А.Ж. 3
 Ирменов К.М. 134
 Ирменов К.М. 137
 Исбамбетов А.С. 68
 Исакова Д.Е. 143
 Исакова С.Х. 100
 Исакова С.Х. 126
 Исламов З.С. 152
 Исламов З.С. 72
 Исмагилов А.Х. 72
 Исмагилов А.Х. 72
 Исмагилов А.Х. 73
 Исмаилов Б.И. 40
 Исмаилов С.Б. 40
 Исмаилова Г.Н. 165
 Исмаилова Г.Н. 41
 Ишкинин Е.И. 76
 Кабиева А.О. 135
 Кабиева А.О. 26
 Кабиева А.О. 28
 Кабиева А.О. 29
 Кабиева А.О. 94
 Кабиева А.О. 94
 Кабылов А.Б. 5
 Кайбаров М.Е. 99
 Кайдаров Б.К. 73
- Кайдаров Б.К. 8
 Кайдаров Б.К. 88
 Кайдаров Б.К. 88
 Кайдарова А.Б. 73
 Кайдарова Д.Р. 3
 Кайдарова Р.К. 143
 Кайназаров Ч. 120
 Кайназаров Ч. 121
 Кайназаров Ч. 162
 Кайназаров Ч. 41
 Кайназаров Ч. 112
 Кайназарова М.А. 112
 Кайназарова М.А. 113
 Кайрашева С.Е. 73
 Кайрашева С.Е. 74
 Калиева Ж.Ж. 3
 Камышов С.В. 95
 Камышов С.В. 96
 Камышов С.В. 96
 Канафин Г.К. 31
 Канафин Г.К. 31
 Канафин Г.К. 38
 Канафин Г.К. 47
 Канторова А.А. 168
 Карагужиев М.М. 101
 Каракулов Р.К. 147
 Каракулов Р.К. 148
 Карасаев М.И. 17
 Каргабаев С.Х. 24
 Каргабаев С.Х. 45
 Каримов М.А. 7
 Каримова Г.А. 152
 Каримова Н.М. 159
 Каххаров Ж.Н. 118
 Каххаров Ж.Н. 98
 Кашаков Б.С. 124
 Кашаков Б.С. 45
 Кенбаева Д.К. 29
 Кенбаева Д.К. 30
 Кенбаева Д.К. 30
 Кенжебаев Б.Ж. 76
 Кенжебаев Б.Ж. 80
 Кереева Н.М. 31
 Ким А.В. 73
 Ким В.Б. 124
 Ким В.Б. 112
 Ким В.Б. 112
 Ким В.Б. 117
 Ким В.Б. 120
 Ким В.Б. 120
 Ким В.Б. 121
 Ким В.Б. 125
 Ким В.Б. 133
 Ким В.Б. 59
 Ким В.Б. 116
 Ким Г.Г. 99
 Ким С.И. 112
 Киреев Г.В. 11
 Кирсанова Н.Р. 52
 Кирсанова Н.Р. 56
 Кленин В.В. (ст) 73
 Кленин В.В. 21
 Кожобекова З.А. 101
 Кожамбетов Б.Ш. 166

- Кожаметов Б.Ш. 49
 Кожаметов Б.Ш. 84
 Козловская Н.А. 103
 Койшекенова А.А. 18
 Койшыбаев А. К. 74
 Койшыбаев А.К. 158
 Койшыбаев А.К. 48
 Койшыбаев А.К. 75
 Койшыбаев А.К.4
 Колбацкая О.П. 147
 Конурбаев Т.Р. 31
 Конурбаев Т.Р. 31
 Конурбаев Т.Р. 38
 Конурбаев Т.Р. 47
 Коровников А.Г. 160
 Коровников А.Г. 64
 Коростелева О.В. 28
 Косаев А.К. 81
 Косаев А.К. 82
 Косенко Н.Ю. 147
 Кострова Е. В. 100
 Костюкова М.Н. 147
 Кравчук В.А. 153
 Кравчук В.А. 153
 Кравчук В.А. 154
 Кравчук В.А. 7
 Крискус Л.К. 119
 Кротов Н.Ф. 75
 Кротов Н.Ф. 75
 Кротова А.Г. 166
 Крук В.А. 100
 Кубенова Г.И. 28
 Кубенова К.И. 19
 Кузденбаев М.С. 3
 Кузикеев М.А. 92
 Кузнецова Т.В. 166
 Кулакеев О.К. 92
 Кулакеев О.К. 93
 Кулишов В.А. 85
 Кулишов В.А. 85
 Кулмаганбетова А. А. 60
 Купрышина Н.А. 147
 Курбанов Ш.А. 59
 Куркебаева Г.Б. 17
 Куркебаева Г.М. 32
 Куркебаева Г.М. 38
 Куркебаева Г.М. 32
 Куркебаева Г.М. 34
 Курманов Б.К. 138
 Курманов Б.К. 139
 Курышбаев Ж.Ж. 46
 Курышбаев Ж.Ж. 46
 Курышбаев Ж.Ж. 46
 Курышбаев Ж.Ж. 47
 Курышбаев Ж.Ж. 47
 Кусаинов Е. Т. 76
 Кусаинова Б. Т. 135
 Кусакина Г.К. 136
 Кусакина Г.К. 133
 Кыдырбаева Г.Ж. 76
 Кыдырбаева Г.Ж. 99
 Кыдырбаева Ж.Н. 129
 Қарасаев М.И. 60
 Латипова Д.Х. 96
- Лашкул С.В. 164
 Лашкул С.В. 28
 Лашкул С.В. 92
 Лебедева Н.Б. 147
 Лозовой В.В. 154
 Лозовой В.В. 155
 Лю М.Б. 40
 Мадалиходжаев Р.С. 68
 Мадалиходжаев Р.С. 69
 Мадияров Б.Т. 75
 Мадыкенов Р. О. 66
 Мадыкенов Р. О. 82
 Майер К.М. 162
 Майер К.М. 49
 Макишев А.К. 29
 Макишев А.К. 30
 Макишев А.К. 30
 Малгельдиев Н.Н. 79
 Малышев Н.В. 85
 Малькова М.А. 52
 Мамбетова Г.К. 129
 Мамедов У.С. 86
 Мамедов У.С. 90
 Мамедова Л.Г. 126
 Маметова Т.А. 84
 Манамбаева З.А. 29
 Манамбаева З.А. 30
 Манамбаева З.А. 30
 Манамбаева З.А. 35
 Манамбаева З.А. 38
 Манамбаева З.А. 39
 Манамбаева З.А. 131
 Мансурова Г.Б. 98
 Маншарипова Б.Т. 41
 Маншарипова Б.Т. 42
 Мартынова М.А. 103
 Махкамов У. У. 136
 Махкамов У. У. 35
 Махкамов У.У. 137
 Махкамов У.У. 34
 Махметова Н.И. 134
 Махметова Н.И. 133
 Махмудова Н.Э. 23
 Махмудова Н.Э. 22
 Медеубаев Р.К. 165
 Мелкова К.Н. 148
 Мелкова К.Н. 149
 Меньшикова И.Л. 28
 Миржакыпов А.Т. 87
 Мирзаева Н.Т. 23
 Мирманова Г.Ж. 142
 Мирманова Г.Ж. 77
 Мирманова Г.Ж. 127
 Молдашева А.М. 122
 Муканов М.К. 3
 Муканова Ж.М. 131
 Мукашева С.А. 42
 Мукашева С.А. 35
 Мукушева А.Х. 11
 Муравлева Л.Е. 100
 Муратханова М.М. 134
 Мусина Г.С. 130
 Муслим М.М. 165
- Мустафина Б.К. 119
 Мустафина Б.К. 52
 Мустафина Б.К. 9
 Мусулманбеков К. Ж. 100
 Мухамеджанов К.Х. 19
 Мухамеджанов К.Х. 20
 Мухамеджанов К.Х. 20
 Мухамеджанов К.Х. 50
 Мухамеджанов К.Х. 52
 Мухамеджанов К.Х. 51
 Мухаметгалиев Н.А. 135
 Мухаметгалиев Н.А. 135
 Мухаметгалиев Н.А. 127
 Мухидинова И.Н. 78
 Мухитдинова И.Н. 121
 Набиев А.К. 78
 Наврузова В.С. 104
 Наврузова В.С. 96
 Наинбаева М.С. 45
 Наинбаева М.С. 24
 Наржанов Б.А. 68
 Наржанов Б.А. 87
 Насипов Б.А. 148
 Насипов Б.А. 147
 Насипов Б.А. 21
 Нематов О.Н. 119
 Нематов О.Н. 119
 Нигманова Н.А. 23
 Нигманова Н.А. 23
 Нигманова Н.А. 22
 Ниетбаева О.В. 147
 Ниетпаева О.В. 17
 Ниетпаева О.В. 32
 Ниетпаева О.В. 33
 Ниетпаева О.В. 34
 Ниетпаева О.В. 34
 Ниетпаева О.В. 38
 Нишанов Д. А. 136
 Нишанов Д. А. 34
 Нишанов Д. А. 35
 Нишонов Д.А. 137
 Нишонов Д.А. 159
 Нсанов Ж.К. 157
 Нукубаева Г.Б. 126
 Нургалиев Н.С. 76
 Нургалиев Н.С. 80
 Нургалиев Н.С. 120
 Нургалиев Н.С. 79
 Нургалиева А.Т. 35
 Нуркенов С.А. 31
 Нуркенов С.А. 31
 Нуркенов С.А. 38
 Нуркенов С.А. 47
 Нурсулейменова М.А. 102
 Нурсулейменова М.А. 141
 Нуртазин С. Т. 132
 Нуртазин С. Т. 132
 Овчинникова И.В. 73
 Олжаев С.Т. 83
 Олжатаева Г.О. 126
 Олимова З.А. 97
 Олимова З.А. 97
 Омарова И.М. 85
 Онгарбаев Б.Т. 76
- Онгарбаев Б.Т. 79
 Онгарбаев Б.Т. 80
 Онгарбаев Б.Т. 172
 Онгарбаев Б.Т. 65
 Оразбеков Б.С. 165
 Оразбеков Б.С. 167
 Оразбеков Н.И. 44
 Оразбеков Н.И. 59
 Орманов Н.К. 5
 Орманов Н.К. 78
 Орманов Н.К. 92
 Орманов Н.К. 93
 Орманов Н.К. 93
 Оспанов М.А. 12
 Оспанов М.А. 15
 Оспанов Ш.Е. 61
 Оспанов Ш.Е. 45
 Оспанов Ш.Е. 65
 Оспанов Ш.Е. 61
 Оспанов Ш.Е. 62
 Оспанова А.О. 143
 Оспанова Г.А. 5
 Павловская А.И. 133
 Перминов В.С. 85
 Перфильева А.В. 138
 Петухов А.В. 13
 Петухов А.В. 14
 Петухов А.В. 14
 Пироженов О.Л. 36
 Пироженов О.Л. 36
 Пироженов О.Л. 78
 Погребицкая Т.В. 136
 Полатова Д.Ш. 37
 Полатова Д.Ш. 159
 Полатова Д.Ш. 37
 Полатова Д.Ш. 80
 Полвонов А.Ч. 90
 Полешко В.Н. 8
 Поляков В.Г. 133
 Поляков В.Г. 145
 Поляков В.И. 19
 Попа А.В. 146
 Примкулова Р.З. 82
 Пулатов Д.А. 139
 Пулатов Д.А. 145
 Пулатов Д.А. 97
 Пулатов Д.А. 97
 Путырский Л.А. 103
 Пюрова Л.П. 69
 Раев Г.Б. 161
 Раев Г.Б. 38
 Разаков А.Р. 98
 Рамазанов М.Е. 68
 Расулов А.Э. 75
 Расулов А.Э. 75
 Рахимжанова Г.С. 131
 Рахимжанова Р.И. 162
 Рахимжанова Р.И. 164
 Рахимжанова Р.И. 49
 Рахимов К.Д. 106
 Рахимов К.Д. 107
 Рахимов К.Д. 108
 Рахимов К.Д. 108
 Рахимов К.Д. 109

- Рахимова А.К. 110
 Рахманова Б. А. 66
 Рахманова Б. А.82
 Рахматуллаева Д.Т. 97
 Рахматуллаева Д.Э. 118
 Решетина Н.В. 25
 Решетина Н.В. 25
 Решетина Н.В. 69
 Рыскулова Г.О. 31
 Рыскулова Г.О. 31
 Рыскулова Г.О. 38
 Рыскулова Г.О.47
 Сабирова Ф.А. 93
 Сабуров А.Р. 92
 Сабыр К.К. 3
 Сабырбаева Г.А. 143
 Сабырбаева Г.А. 143
 Савицкий С.Э. 48
 Савхатов Д.Х. 77
 Савхатов Д.Х. 81
 Савхатов Д.Х. 82
 Савхатова А.Д. 112
 Савхатова А.Д. 122
 Савхатова А.Д. 99
 Сагиндыков Г.А. 147
 Сагиндыков Г.А. 148
 Сагиндыков Г.А. 21
 Садуакасова М.Б. 126
 Садуакасова А.Б. 164
 Садык М. 14
 Садыков М.С. 167
 Садыков М.С. 169
 Садыков М.С. 169
 Садыков Н.К. 84
 Садыков С.С. 112
 Садыков С.С. 120
 Садыков С.С. 126
 Садыков С.С. 99
 Садыкова Н.Ф.98
 Сайдахметов А.С. 38
 Сайдахметов А.С.39
 Саидова К.А. 98
 Салимова Л.Р. 95
 Салимова Л.Р. 96
 Сандыбаев М.Н. 123
 Сандыбаев М.Н. 156
 Сандыбаев М.Н. 157
 Сандыбаев М.Н. 160
 Сандыбаев М.Н. 160
 Сандыбаев М.Н. 161
 Сандыбаев М.Н. 163
 Сандыбаев М.Н. 30
 Сандыбаев М.Н. 39
 Сандыбаев М.Н. 81
 Сарбасов К.К. 52
 Сарсебеков Е.К. 43
 Сарсебеков Е.К. 44
 Сарсембаев А.А.71
 Сарсембаева С.А. 53
 Сарсембаева С.А. 56
 Сарсембаева С.А. 57
 Сарсенбаев А.У 68
 Сарсенбаева Г.Е.122
 Сатабаев М.Т. 155
- Сатенова Ж.К. 48
 Сатыбалдина Р.М. 45
 Сатыбалдина Р.М. 24
 Сахипов М.М. 68
 Сахипов М.М. 87
 Сейдуалиева Б.С. 43
 Сейдуалиева Б.С. 44
 Сейкетов А.Ж. 134
 Сейсембаев М.А. 68
 Сейсембаев М.А. 87
 Сейсенбаева Г.Т. 14
 Сейсенбаева Г.Т. 15
 Сейсенбаева Г.Т.15
 Сейтказина Г.Д. 15
 Сейтказина Г.Д.15
 Семглазова Т.Ю. 96
 Серебрякова И.Н. 146
 Серебрякова И.Н. 145
 Середа Е.Н. 140
 Серикбаев Г.А. 81
 Серикбаев Г.А. 82
 Серикбаев Г.А.82
 Серикбаева А.Д. 108
 Серикбаева А.Д. 109
 Симбатов Т.К. 158
 Симбатов Т.К.4
 Сирота В.Б. 126
 Сирота В.Б. 100
 Сирота В.Б.100
 Сиченко В.Н. 113
 Сиченко В.Н. 114
 Скакова Г.А. 31
 Скакова Г.А. 31
 Скакова Г.А. 38
 Скакова Г.А. 47
 Смагулова К.К. 102
 Смагулова К.К. 29
 Смагулова К.К. 92
 Смагулова К.К. 94
 Соколенко Е.Г. 102
 Струцкий Л.П. 89
 Стуков А.Н. 96
 Сулейменов М.К. 154
 Сулейменов М.К. 156
 Сулейменова Ж.А. 114
 Султаналиев Т.А.83
 Султангазиева С.Е. 148
 Султангазиева С.Е. 147
 Султанова Ш.Ш. 72
 Султонов Б.Б. 87
 Суров М.Ю. 161
 Суттибаева Р.С. 93
 Сыздыков К.З. 68
 Сыздыков К.З. 69
 Сырымбеткызы Ж. 112
 Сырымбеткызы Ж. 120
 Сырымбеткызы Ж. 120
 Сырымбеткызы Ж. 121
 Сырымбеткызы Ж. 124
 Сырымбеткызы Ж. 125
 Тажединов А.И. 133
 Тажединов И. 162
 Тажединов И.Т. 41
- Тажединов И.Т. 82
 Тажединов И.Т. 43
 Тажибаева К.Н. 5
 Тажибаева С.Д. 126
 Тайлаков Б.Б. 52
 Талаева Ш.Ж. 124
 Талаева Ш.Ж. 125
 Танатаров С.З. 163
 Танатаров С.З. 163
 Танжарыков Е.С. 86
 Тасбулатов З.О. 73
 Тасбулатов З.О. 88
 Тельгозин Е.Т. 83
 Темиргалиев Г.А. 6
 Темиргалиева Э.М. 107
 Темиргалиева Э.М. 108
 Темиргалиева Э.М. 108
 Тиллашайхов М.Н. 87
 Тилляшайхов М.Н. 87
 Тимошенко В.В. 145
 Тлеугабилова Г.А. 166
 Тлеугабилова Г.А. 49
 Тлеугабилова Г.А. 84
 Тогандыков Т.Ж. 111
 Тогандыков Т.Ж.110
 Тожибоев А.А. 88
 Токсанбаев Д.С. 68
 Токсанбаев Д.С. 87
 Толеутай У.К. 10
 Толеутай У.К. 45
 Толеутайұлы К. 45
 Толеутайұлы К. 9
 Тохеев З.В. 102
 Туйджанова Х.Х. 139
 Туйджанова Х.Х. 145
 Туйджанова Х.Х. 98
 Туйжанова Х.Х. 22
 Тулеева Л.Н. 41
 Тулеева Л.Н. 42
 Тулеуова Д.А. 81
 Тулеуова Д.А. 82
 Тулеуова Д.А. 82
 Тулеутаев М.Е. 160
 Тулеутаев М.Е. 165
 Тулеутаев М.Е. 167
 Тулеутаев М.Е. 9
 Тулеутаева С.Ж.
 Тулеутаева С.Ж. 54
 Тулеутаева С.Ж. 55
 Тулеутаева С.Ж. 56
 Тулеутайұлы К. 65
 Тумабаева Х.Т. 73
 Туманова А.К. 102
 Тупицын Н.Н. 148
 Тупицын Н.Н. 145
 Тупицын Н.Н. 146
 Тупицын Н.Н. 147
 Тупицын Н.Н. 149
 Тупицын Н.Н.145
 Тургунов М.Б.85
 Турешева А.О. 59
 Турешова А.О. 99
 Туржанов К.Т. 19
 Туржанов К.Т. 3
- Туржанов К.Т. 31
 Турмуханов Т.Ж. 135
 Тусуп А.Ж. 114
 Убайдуллаев У.Э. 118
 Уйсин А.Х. 85
 Умарова К.Р. 93
 Умарова Н.А. 104
 Умарова Н.А. 96
 Умбетбаева Э.Н. 33
 Умбетбаева Э.Н. 34
 Умбетбаева Э.Н. 34
 Умерзаков М.С. 123
 Умерзакова Б.Г. 101
 Умерзакова Б.Г. 103
 Уморов М.Х. 136
 Уморов М.Х. 34
 Уморов М.Х. 35
 Уморов М.Х.137
 Уразаев О.Н. 4
 Уразаев О.Н. 75
 Уразбаева Н.И.4
 Усманов Р.Х. 97
 Утельбаева А.Е. 101
 Утельбаева А.Е. 102
 Утельбаева А.Е. 102
 Филатова Л.В. 96
 Филиппенко В.И. 117
 Филиппенко В.И. 120
 Филиппенко В.И. 122
 Френкель М.А. 147
 Хажиакбер Айса 110
 Хаитов Ф.Э. 159
 Халимов Д.Ж. 23
 Хамзабаев Ж.Х. 124
 Хамзин А.Х. 53
 Хамидуллина Г.А. 102
 Хамидуллина Г.А. 132
 Хамидуллина Г.А. 132
 Хамидуллина Г.А. 140
 Хамитова Д.А. 166
 Хан О.Г. 162
 Хан О.Г. 43
 Хан О.Г. 82
 Хан О.Р. 21
 Харламов В.В. 169
 Харламов В.В. 167
 Харламов В.В. 169
 Хатамов Ш.Н. 89
 Ходжаев А.В. 22
 Ходжаев А.В. 23
 Ходжаев А.В. 23
 Ходжаева Х.В. 22
 Хожаев А.А. 52
 Хожаев А.А. 73
 Хожаев А.А. 88
 Хожаев А.А. 88
 Худояров С.С. 67
 Хуснутдинова Г.И. 56
 Целикова Н.Л. 100
 Цой И.Г. 106
 Цой И.Г. 107
 Чайжунусова Н.Ж. 64
 Чакенова Б.К. 114
 Челдыбаева Т.И. 157

Челдыбаева Т.И. 160	Чорманова Р.Р. 167	Шибанова А.И. 139	Югай Т.А. 50
Чернышева Т.В. 75	Шайхиев Е.У. 84	Шибанова А.И. 135	Юлдашева Н.Ш. 104
Чернявская Т.З. 148	Шалаганова К.Б. 129	Шипилова В.В. 99	Юлдашева Н.Ш. 95
Чернявская Т.З. 149	Шалахметова Т.М. 140	Шишков Р.В. 133	Юлдашева Н.Ш. 96
Черняков С.С. 130	Шапаева У.К. 73	Шокебаев А.А. 84	Юлдашева Н.Ш. 96
Чимишкян К.Л. 148	Шапаева У.К. 88	Шуканова Н.А. 103	Юсупов А.М. 93
Чимишкян К.Л. 149	Шатковская О.В. 170	Шукруллаев Ш.А. 87	Юсупов Б.Ю. 64
Чингисова Ж.К. 101	Шатковская О.В. 3	Шукуров З.И. 89	Юсупов Б.Ю. 89
Чингисова Ж.К. 15	Шатковская О.В. 73	Эгамбердиев Д.М. 67	Юсупов Б.Ю. 89
Чингисова Ж.К. 15	Шатковская О.В. 50	Эгамбердиев Д.М. 89	Юсупов Б.Ю. 90
Чичуа Н.А. 101	Шведова Т.В. 145	Эгамбердиев Д.М. 119	Якубова М.Б. 90
Чичуа Н.А. 102	Шелякина Т.В. 168	Эгамбердиев Д.М. 119	Якупова Л.М. 128
Чичуа Н.А. 102	Шерияздан Ж.С. 143	Эргашев О.Н. 87	Якупова Л.М. 134
Чичуа Н.А. 102	Шерияздан Ж.С. 143	Эшонов А.К. 170	Якупова Л.М. 137
Чичуа Н.А. 29	Шерланова Ш.А. 52	Эшонов А.К. 67	Якупова Л.М. 137
Чичуа Н.А. 94	Шибанова А.И. 127	Югай К.В. 90	Якупова Л.М. 140
Чорманов А.Т. 87	Шибанова А.И. 135	Югай Т.А. 12	Якупова Л.М. 128
Чорманова Р.Р. 169	Шибанова А.И. 138	Югай Т.А. 169	Якупова Л.М. 141
Чорманова Р.Р. 169	Шибанова А.И. 138	Югай Т.А. 3	

Индекс авторов (латиница)

Abdyldaev T.A. 104	Adekenov S.M. 105	Mustaphina B.K. 131	Saidova K. O. 62
Abenova M.T. 131	Akhmetova S.B. 105	Naizabekova S.Sh. 104	Sariev A.K. 104
Adekenov S.M. 104	Baryshnikov A.Yu. 106	Nurmaganbetov Zh.S. 106	Seidakhmetova R.B. 105
Adekenov S.M. 105	Gábor CSERNI 173	Ogorodnikova M.V. 106	Shulgau Z.T. 106
Adekenov S.M. 106	Mansurova G. B. 62	Sabirdjanova Z. R. 62	Turmukhambetov A.Zh. 106

Для заметок